Título del trabajo *

TITULO DE PRUEBA CARTELES SISTEMAS

Nombre del Autor (a/es)*

AUTORES PRUEBA CARTELES SISTEMAS

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Correo Electrónico *

jcmoas@hotmail.com

Institución *

INSTUTICIÃ“N PRUEBA CARTELES SISTEMAS

Introducción y Objetivos *

INTRODUCCIÃ“N PRUEBAS CARTELES SISTEMAS

Descripción del Caso *

DESCRIPCIÃ“N PRUEBAS CARTELES SISTEMAS

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS PRUEBAS CARTELES SISTEMAS

Bibliografía *

BIBLIOGRAFÃ AS PRUEBAS CARTELES

Título del trabajo *

REGENERACIÃ“N TISULAR GUIADA, UNA ALTERNATIVA PARA MEJORAR EL PRONÃ“STICO: REPORTE DE CASO CLÃ□NICO

Nombre del Autor (a/es)*

Alesa Morales DomÃ-nguez

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Ã□lvaro Daniel Villegas CÃ¡rdenas, Gabriela GaytÃ¡n Tejeda, RocÃ-o Karina CÃ¡rdenas Delgado, , , , , , .

Correo Electrónico *

alesa.morales@edu.uag.mx

Institución *

UNIVERSIDAD AUTÃ“NOMA DE GUADALAJARA

Introducción y Objetivos *

LA REGENERACIÃ“N TISULAR GUIADA (RTG) HA MOSTRADO EFICACIA EN EL TRATAMIENTO DE DEFECTOS INTRAÃ“SEOS PERIODONTALES, INCLUSO EN PRESENCIA DE LESIONES ENDODÃ“NTICAS. SIN EMBARGO, SE RESERVA EN SU APLICACIÃ“N EN PACIENTES GERIÃ?TRICOS POR PRESUNTAS LIMITACIONES BIOLÃ“GICAS. EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO ES PRESENTAR EL ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO EXITOSO DE UNA LESIÃ“N ENDO-PERIODONTAL EN UNA PACIENTE DE 78 AÃ‘OS, MEDIANTE TRATAMIENTO ENDODÃ“NTICO Y RTG.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINA DE 78 AÃ‘OS, SIN DATOS PERSONALES PATOLÃ“GICOS, ACUDIÃ“ POR MOVILIDAD SEVERA DEL DIENTE 11. AL EXAMEN CLÃ□NICO PRESENTÃ“ SANGRADO Y SUPURACIÃ“N AL SONDEO, PROFUNDIDAD ?7 MM Y MOVILIDAD GRADO III. RADIOGRÃ□FICAMENTE SE OBSERVÃ“ UNA LESIÃ“N PERIAPICAL DIFUSA Y UN DEFECTO INTRAÃ“SEO VERTICAL PROFUNDO. SE DIAGNOSTICÃ“ UNA LESIÃ“N ENDO-PERIODONTAL COMBINADA CON PRONÃ“STICO RESERVADO.

SE INICIÃ“ CON FASE NO QUIRÃšRGICA: INSTRUCCIÃ“N DE HIGIENE ORAL, TÃ‰CNICA DE BASS MODIFICADA, USO DE ADITAMENTOS INTERPROXIMALES, RASPADO Y ALISADO RADICULAR. POSTERIORMENTE, SE REALIZÃ“ TRATAMIENTO ENDODÃ“NTICO DEL DIENTE 11. SE COLOCÃ“ FÃ‰RULA DE ESTABILIZACIÃ“N EN DIENTES 12 A 21. LA CIRUGÃ□A PERIODONTAL CONSISTIÃ“ EN COLGAJO DE ESPESOR TOTAL, DESBRIDAMIENTO, COLOCACIÃ“N DE XENOINJERTO Ã“SEO BOVINO Y MEMBRANA DE COLÃ□GENO REABSORBIBLE. EL CIERRE SE REALIZÃ“ CON SUTURA DE NYLON 5-0. SE PRESCRIBIÃ“ ANTIBIÃ“TICO, ANALGÃ‰SICOS Y ENJUAGUE CON CLORHEXIDINA.

Resultados y Conclusiones *

A LAS CUATRO SEMANAS SE OBSERVÃ“ CICATRIZACIÃ“N FAVORABLE SIN SIGNOS DE INFECCIÃ“N. A LOS 12 MESES, LA MOVILIDAD SE REDUJO DE GRADO III A I Y LAS PROFUNDIDADES DE SONDAJE A 3â€“4 MM, CON DESAPARICIÃ“N DEL SANGRADO AL SONDEO. RADIOGRÃ FICAMENTE SE EVIDENCIÃ“ NEOFORMACIÃ“N Ã“SEA Y REDUCCIÃ“N DE LA RADIOLUCIDEZ PERIAPICAL. LA PACIENTE REFIRIÃ“ MEJORÃ A FUNCIONAL Y ESTÃ‰TICA, LO QUE IMPACTÃ“ POSITIVAMENTE EN SU CALIDAD DE VIDA.

LA COMBINACIÃ“N DE TERAPIA ENDODÃ“NTICA CON RTG PERMITIÃ“ CONSERVAR UN DIENTE CON DIAGNÃ“STICO INICIALMENTE DESFAVORABLE EN UNA PACIENTE ADULTA MAYOR. EL USO DE BIOMATERIALES ADECUADOS, LA PLANIFICACIÃ“N INTERDISCIPLINARIA Y EL SEGUIMIENTO RIGUROSO FUERON CLAVES PARA EL Ã‰XITO TERAPÃ‰UTICO. ESTE CASO REFUERZA QUE LA EDAD AVANZADA NO ES UNA CONTRAINDICACIÃ“N PARA LA APLICACIÃ“N DE TÃ‰CNICAS REGENERATIVAS COMPLEJAS CUANDO SE SIGUEN LOS PRINCIPIOS BIOLÃ“GICOS Y CLÃ NICOS ESTABLECIDOS.

Bibliografía *

MELCHER AH. REPAIR OF WOUNDS IN THE PERIODONTIUM OF THE RAT. ARCH ORAL BIOL. 1970;15(11):1183â€“204.

GOTTLOW J, NYMAN S, KARRING T, LINDHE J. NEW ATTACHMENT FORMATION AS THE RESULT OF CONTROLLED TISSUE REGENERATION. J CLIN PERIODONTOL. 1984;11(8):494â€“503.

MELLONIG JT. BONE ALLOGRAFTS IN PERIODONTAL THERAPY. CLIN ORTHOP RELAT RES. 1996;(324):116â€“25.

SCULEAN A, GRUBER R, BOSSHARDT DD. CLINICAL CONCEPTS FOR REGENERATIVE THERAPY IN INTRABONY DEFECTS. PERIODONTOL 2000. 2019;79(1):139â€“53.

TROMBELLI L, FARINA R, SILVA CO, TATAKIS DN. EFFICACY OF BIOLOGICS IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL INTRAOSSEOUS DEFECTS. J CLIN PERIODONTOL. 2022;49(SUPPL 24):22â€“39.

Título del trabajo *

EXTRUSIÃ“N QUIRÃšRGICA UNA ALTERNATIVA AL ALARGAMIENTO CORONARIO CONVENCIONAL

Nombre del Autor (a/es)*

C.D AYLIN ORIANA DEL ANGEL CANO

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

MCO: SHANNON WEAVER AVALOS, DCF: MARTHA MARGARITA AGUADO ARZOLA, DCF: VICTOR HUGO CASTILLO ALVAREZ, DCF: DORA MARIA LOPEZ TRUJILLO, , , , , .

Correo Electrónico *

oriana.cano@uadec.edu.mx

Institución *

UNIVERSIDAD AUTÃ“NOMA DE COAHUILA UNIDAD LAGUNA

Introducción y Objetivos *

CUANDO SE PIERDE UNA GRAN CANTIDAD DE ESTRUCTURA DENTARIA DEBIDO A CARIES EXTENSAS, FRACTURAS U OTRAS CAUSAS, A MENUDO SE NECESITAN TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS PRELIMINARES PARA RESTAURAR EL DIENTE. ES NECESARIO RESTABLECER EL ESPESOR BIOLÃ“GICO PARA ALCANZAR Y MANTENER TEJIDOS PERIODONTALES SALUDABLES DESPUÃ‰S DE LA REHABILITACIÃ“N RESTAURADORA O PROTÃ‰SICA. (1)

EL ALARGAMIENTO DE CORONA QUIRÃšRGICO ES LA OPCIÃ“N MÃS UTILIZADA PARA FACILITAR LA REHABILITACIÃ“N EN CASOS CON PÃ‰RDIDA SIGNIFICATIVA DE ESTRUCTURA DENTARIA Y CUANDO ES NECESARIO EXPONER TEJIDO SANO PARA LOGRAR UN ENTORNO PERIODONTAL ESTABLE. (2) NO OBSTANTE, ESTA TÃ‰CNICA PUEDE IMPLICAR LA RESECCIÃ“N Ã“SEA EN LOS DIENTES ADYACENTES, LO QUE PODRÃA COMPROMETER EL SOPORTE PERIODONTAL Y ALTERAR LA PROPORCIÃ“N CORONA-RAÃZ, UN FACTOR CLAVE PARA LA LONGEVIDAD DEL TRATAMIENTO. COMO ALTERNATIVA, LA EXTRUSIÃ“N QUIRÃšRGICA PARTICULARMENTE INDICADA EN DIENTES CON MORFOLOGÃA RADICULAR RECTA HA DEMOSTRADO SER UNA SOLUCIÃ“N EFICAZ, YA QUE PERMITE PRESERVAR EL HUESO CIRCUNDANTE Y MANTENER UNA RELACIÃ“N CORONA-RAÃZ MÃS FAVORABLE. CON EL TIEMPO, ESTA TÃ‰CNICA HA EVOLUCIONADO HACIA UN ENFOQUE MENOS INVASIVO Y MÃS PREDECIBLE. (3)

OBJETIVO: REEL SEGUIMIENTO POSTQUIRÃšRGICO SE REALIZÃ“ MEDIANTE CONTROLES CLÃNICOS Y RADIOGRÃFICOS, INICIALMENTE A LOS 7, 30 Y 60 DÃAS.

CLÃNICAMENTE, SE OBSERVÃ“ UNA ADECUADA INTEGRACIÃ“N DE LOS TEJIDOS DUROS Y BLANDOS, MANTENIENDO LA FUNCIONALIDAD Y ESTÃ‰TICA DEL Ã“RGANO DENTARIO. RADIOGRÃFICAMENTE, NO SE EVIDENCIAN SIGNOS DE PATOLOGÃA PERIAPICAL NI DE ANQUILOSIS, OBSERVÃNDOSE UNA ADECUADA CONSERVACIÃ“N DEL ESPACIO DEL LIGAMENTO PERIODONTAL Y LLENADO Ã“SEO, LO QUE SUGIERE UN PROCESO DE REINTEGRACIÃ“N FISIOLÃ“GICA FAVORABLE.

PORTAR UN CASO EN EL QUE SE PRESERVARON LOS TEJIDOS PERIODONTALES DE UN SEGUNDO PREMOLAR SUPERIOR CON COMPROMISO ESTRUCTURAL MEDIANTE LA TÃ‰CNICA DE EXTRUSIÃ“N QUIRÃšRGICAEL SEGUIMIENTO POSTQUIRÃšRGICO SE REALIZÃ“ MEDIANTE CONTROLES CLÃNICOS Y RADIOGRÃFICOS, INICIALMENTE A LOS 7, 30 Y 60 DÃAS.

CLÃNICAMENTE, SE OBSERVÃ“ UNA ADECUADA INTEGRACIÃ“N DE LOS TEJIDOS DUROS Y BLANDOS, MANTENIENDO LA FUNCIONALIDAD Y ESTÃ‰TICA DEL Ã“RGANO DENTARIO. RADIOGRÃFICAMENTE, NO SE EVIDENCIAN SIGNOS DE PATOLOGÃA PERIAPICAL NI DE ANQUILOSIS, OBSERVÃNDOSE UNA ADECUADA CONSERVACIÃ“N DEL ESPACIO DEL LIGAMENTO PERIODONTAL Y LLENADO Ã“SEO, LO QUE SUGIERE UN PROCESO DE REINTEGRACIÃ“N FISIOLÃ“GICA FAVORABLE.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINA ASA I, DE 26 AÃ‘OS REFERIDA POR EL POSGRADO DE ENDODONCIA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÃ□A DE LA UNIVERSIDAD AUTÃ“NOMA DE COAHUILA UNIDAD LAGUNA (FOUAC UL) PARA REALIZAR ALARGAMIENTO DE CORONA DEL Ã“RGANO DENTAL #25 CON FRACTURA CONFINADA AL ESMALTE Y LA DENTINA SIN EXPOSICIÃ“N PULPAR. (4)

A LA EXPLORACIÃ“N CLÃ□NICA Y RADIOGRÃ□FICA SE OBSERVA GRAN PÃ‰RDIDA DE ESTRUCTURA DENTARIA PROPORCIÃ“N CORONA RAÃ□Z (PCR) 1:2, UNIRRADICULAR SIN PRESENCIA DE DILACERACIONES. LOS DIENTES ADYACENTES NO PRESENTAN PERDIDA Ã“SEA. RADIOGRÃ□FICAMENTE SE OBSERVA UNA FRACTURA A NIVEL CRESTAL. POR LO CUAL SE OPTA POR REALIZAR EL TRATAMIENTO DE EXTRUSIÃ“N QUIRÃšRGICA COMO ALTERNATIVA AL ALARGAMIENTO DE CORONA CONVENCIONAL

PREVIO AL TRATAMIENTO, SE LLEVÃ“ A CABO EL PROTOCOLO DE ASEPSIA Y ANTISEPSIA CORRESPONDIENTE. SE PROCEDIÃ“ CON LA TÃ‰CNICA ANESTÃ‰SICA CON LIDOCAÃ□NA AL 2% CON EPINEFRINA AL 1:100.000 MEDIANTE BLOQUEO ALVEOLAR SUPERIOR MEDIO Y PALATINO POSTERIORMENTE LAS FIBRAS GINGIVALES FUERON SEPARADAS CON BISTURÃ□ NO. 15C. POSTERIORMENTE, SE EFECTUÃ“ LA LUXACIÃ“N DEL Ã“RGANO DENTARIO CON PERIOSTÃ“TOMOS RECTOS Y MARTILLO, SEGUIDA DE UNA EXTRUSIÃ“N (SIN RETIRARLO DE SU ALVEÃ“LO) CON FÃ“RCEPS #150 DE 4MM PARA FAVORECER EL EFECTO FÃ‰RULA.

SE REALIZÃ“ AJUSTE OCLUSAL Y ESTABILIZACIÃ“N DEL DIENTE MEDIANTE UNA FÃ‰RULA SEMIRRÃ□GIDA INACTIVA, CONFECCIONADA CON ALAMBRE DE ORTODONCIA DE 0.36 MM Y RESINA COMPUESTA, FIJADA A LOS DIENTES ADYACENTES. EL TIEMPO DE FERULIZACIÃ“N INDICADO FUE DE TRES SEMANAS. (5)

LAS INDICACIONES POSTOPERATORIAS INCLUYERON ANTIBIOTICOTERAPIA, ANALGÃ‰SICOS, DIETA BLANDA Y EVITAR EL CEPILLADO DIRECTO EN LA ZONA INTERVENIDA.

Resultados y Conclusiones *

EL SEGUIMIENTO POSTQUIRÃšRGICO SE REALIZÃ“ MEDIANTE CONTROLES CLÃ□NICOS Y RADIOGRÃ□FICOS, INICIALMENTE A LOS 7, 30 Y 60 DÃ□AS.

CLÃ□NICAMENTE, SE OBSERVÃ“ UNA ADECUADA INTEGRACIÃ“N DE LOS TEJIDOS DUROS Y BLANDOS, MANTENIENDO LA FUNCIONALIDAD Y ESTÃ‰TICA DEL Ã“RGANO DENTARIO. RADIOGRÃ□FICAMENTE, NO SE EVIDENCIAN SIGNOS DE PATOLOGÃ□A PERIAPICAL NI DE ANQUILOSIS, OBSERVÃ□NDOSE UNA ADECUADA CONSERVACIÃ“N DEL ESPACIO DEL LIGAMENTO PERIODONTAL Y LLENADO Ã“SEO, LO QUE SUGIERE UN PROCESO DE REINTEGRACIÃ“N FISIOLÃ“GICA FAVORABLE.

CONCLUSIONES: A LOS 2 MESES DEL PROCEDIMIENTO, EL Ã“RGANO DENTARIO SE MANTIENE ASINTOMÃ□TICO, SIN SIGNOS DE MOVILIDAD Y EN ADECUADA FUNCIÃ“N BIOLÃ“GICA Y ESTÃ‰TICA AL MANTENER UNA ADECUADA UBICACIÃ“N DEL CENIT EN RELACIÃ“N CON LOS DIENTES ADYACENTES. ESTOS HALLAZGOS CLÃ□NICOS CONFIRMAN LA EFICACIA DE LA TÃ‰CNICA EMPLEADA Y LA ESTABILIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

Bibliografía *

1. MARZADORI M, STEFANINI M, SANGIORGI M, MOUNSSIF I, MONACO C, ZUCCHELLI G. CROWN LENGTHENING AND RESTORATIVE PROCEDURES IN THE ESTHETIC ZONE. VOL. 77, PERIODONTOLOGY 2000. 2018.

2. KELLY RD, ADDISON O, TOMSON PL, KRASTL G, DIETRICH T. ATRAUMATIC SURGICAL EXTRUSION TO IMPROVE TOOTH RESTORABILITY: A CLINICAL REPORT. JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY. 2016;115(6).

3. KRUG R, CONNERT T, SOLIMAN S, SYFRIG B, DIETRICH T, KRASTL G. SURGICAL EXTRUSION WITH AN ATRAUMATIC EXTRACTION SYSTEM: A CLINICAL STUDY. JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY. 2018;120(6).

4. LEVIN, L., DAY, P. F., HICKS, L., Oâ€™CONNELL, A., FOUAD, A. F., BOURGUIGNON, C., & ABBOTT, P. V. (2020). INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DENTAL TRAUMATOLOGY GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF TRAUMATIC DENTAL INJURIES: GENERAL INTRODUCTION. DENTAL TRAUMATOLOGY: OFFICIAL PUBLICATION OF INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR DENTAL TRAUMATOLOGY, 36(4), 309â€“313.

Título del trabajo *

MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS CON INJERTO GINGIVAL LIBRE TRAS LA COLOCACIÃ“N DEL PILAR DE CICATRIZACIÃ“N: REPORTE DE UN CASO

Nombre del Autor (a/es)*

CARLOS FERNANDO LOPEZ ORTEGA

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

ISRAEL GUARDADO LUEVANOS, , LISETT TERAN CERVANTES, , ROCIO KARINA CARDENAS, , , , .

Correo Electrónico *

fernando_lopez1000@hotmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA

Introducción y Objetivos *

LA PRESENCIA DE UNA BANDA ADECUADA DE ENCÃ A QUERATINIZADA (EQ) ALREDEDOR DE IMPLANTES DENTALES DESEMPEÃ‘A UN PAPEL CRUCIAL EN LA PRESERVACIÃ“N DE LA SALUD PERIIMPLANTARIA. DIVERSOS ESTUDIOS HAN DEMOSTRADO QUE UNA FRANJA MÃ NIMA DE 2 MM FACILITA LA HIGIENE ORAL, REDUCE LA INFLAMACIÃ“N DE LOS TEJIDOS BLANDOS Y DISMINUYE EL RIESGO DE PÃ‰RDIDA Ã“SEA MARGINAL. LA AUSENCIA DE EQ PUEDE GENERAR COMPLICACIONES CLÃ NICAS COMO MUCOSITIS, RECESIÃ“N, DOLOR Y PROBLEMAS DURANTE EL MANTENIMIENTO PROTÃ‰SICO. ANTE ESTAS CIRCUNSTANCIAS, EL INJERTO GINGIVAL LIBRE (IGL) SE PRESENTA COMO UNA TÃ‰CNICA QUIRÃšRGICA PREDECIBLE, CAPAZ DE AUMENTAR EL VOLUMEN Y LA CALIDAD DE TEJIDO QUERATINIZADO. EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO ES DESCRIBIR EL MANEJO CLÃ NICO DE UN CASO DE DEFICIENCIA DE EQ PERIIMPLANTARIA EN UN SITIO POSTERIOR MANDIBULAR, MEDIANTE LA APLICACIÃ“N DE UN IGL TRAS LA COLOCACIÃ“N DEL PILAR DE CICATRIZACIÃ“N, CON Ã‰NFASIS EN LA PLANIFICACIÃ“N, TÃ‰CNICA QUIRÃšRGICA Y RESULTADOS CLÃ NICOS OBTENIDOS.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINA DE 54 AÃ‘OS, ATENDIDA EN LA CLÃ□NICA DE POSGRADO EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGIA DE LA UAG, CON REHABILITACIÃ“N IMPLANTOSOPORTADA EN EL CUADRANTE POSTERIOR MANDIBULAR DERECHO (IMPLANTES EN 45 Y 46). TRAS SEIS MESES DE OSTEOINTEGRACIÃ“N, SE COLOCARON LOS PILARES DE CICATRIZACIÃ“N. DURANTE LA EVALUACIÃ“N CLÃ□NICA SE OBSERVÃ“ AUSENCIA DE ENCÃ□A QUERATINIZADA VESTIBULAR EN EL IMPLANTE MÃ□S DISTAL (46), IDENTIFICÃ□NDOSE SOLO MUCOSA MÃ“VIL. DEBIDO AL BIOTIPO GINGIVAL DELGADO Y LA FALTA DE EQ, SE OPTÃ“ POR REALIZAR UN INJERTO GINGIVAL LIBRE, OBTENIENDO UN FRAGMENTO DEL PALADAR Y TRASPLANTÃ□NDOLO AL SITIO RECEPTOR TRAS LA PREPARACIÃ“N QUIRÃšRGICA DEL LECHO MEDIANTE DESPLAZAMIENTO APICAL DEL PERIOSTIO. EL INJERTO FUE FIJADO CON SUTURA EN â€œXâ€□ Y SE REALIZARON CONTROLES CLÃ□NICOS A LOS 7, 14 Y 21 DÃ□AS. EL MANEJO POSTOPERATORIO FUE RIGUROSO, OBSERVÃ□NDOSE INTEGRACIÃ“N PROGRESIVA DEL INJERTO Y FORMACIÃ“N DE TEJIDO QUERATINIZADO FUNCIONAL.

Resultados y Conclusiones *

DESDE LA PRIMERA SEMANA POSTOPERATORIA, SE OBSERVÃ“ CICATRIZACIÃ“N PRIMARIA ESTABLE, SIN DEHISCENCIA NI SIGNOS DE ISQUEMIA. A LOS 14 DÃ AS, EL INJERTO PRESENTABA SIGNOS INICIALES DE QUERATINIZACIÃ“N, Y A LOS 21 DÃ AS, SE CONSOLIDÃ“ UNA FRANJA CONTINUA DE ENCÃ A QUERATINIZADA, CON TEXTURA FIRME Y LÃ MITES DEFINIDOS. A LOS TRES MESES, SE REPORTÃ“ UNA ARQUITECTURA TISULAR ESTABLE, CONTORNOS ARMÃ“NICOS Y AUSENCIA DE INFLAMACIÃ“N, FACILITANDO EL ACCESO A LA HIGIENE ORAL. A LOS SEIS MESES, EL VOLUMEN DE TEJIDO BLANDO SE MANTENÃ A ESTABLE, SIN RECESIONES NI COLAPSO, PERMITIENDO LA TRANSICIÃ“N A LA FASE PROTÃ‰SICA. ESTE CASO EVIDENCIA LA EFICACIA DEL IGL COMO TÃ‰CNICA QUIRÃšRGICA PARA MEJORAR EL ENTORNO PERIIMPLANTARIO, ESPECIALMENTE EN ZONAS POSTERIORES CON BIOTIPO FINO Y ESCASA ENCÃ A QUERATINIZADA. LA CORRECTA PLANIFICACIÃ“N, EJECUCIÃ“N TÃ‰CNICA, SEGUIMIENTO POSTOPERATORIO Y COLABORACIÃ“N INTERDISCIPLINARIA FUERON DETERMINANTES PARA EL Ã‰XITO CLÃ NICO. EL IGL SIGUE SIENDO UNA OPCIÃ“N CONFIABLE Y PREDECIBLE CUANDO SE REALIZA EN CONDICIONES CLÃ NICAS FAVORABLES Y SIGUIENDO PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.

Bibliografía *

MARIN DOM, ET AL. (2017). FREE GINGIVAL GRAFT TO INCREASE KERATINIZED MUCOSA AFTER PLACING OF MANDIBULAR FIXED IMPLANT-SUPPORTED PROSTHESIS. CASE REPORTS IN DENTISTRY, 2017, 1â€“5. HTTPS://DOI.ORG/10.1155/2017/5796768

ADIBRAD M, ET AL. (2009). SIGNIFICANCE OF THE WIDTH OF KERATINIZED MUCOSA ON THE HEALTH STATUS OF THE SUPPORTING TISSUE AROUND IMPLANTS. J ORAL IMPLANTOL, 35(5), 232â€“237.

WU Q, ET AL. (2015). EVALUATION OF THE EFFICACY OF KERATINIZED MUCOSA AUGMENTATION TECHNIQUES AROUND DENTAL IMPLANTS: A SYSTEMATIC REVIEW. J PROSTHET DENT, 113(5), 383â€“390.

BOURI A JR, ET AL. (2008). WIDTH OF KERATINIZED GINGIVA AND THE HEALTH STATUS OF THE SUPPORTING TISSUES AROUND DENTAL IMPLANTS. INT J ORAL MAXILLOFAC IMPLANTS, 23(2), 323â€“326.

Título del trabajo *

AUMENTO DE TEJIDOS BLANDOS EN ZONA ANTERIOR CON TÃ‰CNICA DE PLATAFORMA DE TEJIDO CONECTIVO

Nombre del Autor (a/es)*

Beatriz Ontiveros Canceco

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Israel Guardado Luevanos, RocÃ-o Karina CÃ¡rdenas Delgado, , , , , , , .

Correo Electrónico *

bettyontiverosc@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA

Introducción y Objetivos *

LOS DEFECTOS DE CRESTA ALVEOLAR CLASE III (SEIBERT 1983), QUE IMPLICAN UNA PÃ‰RDIDA SIMULTÃ□NEA EN SENTIDO VERTICAL Y HORIZONTAL DEL REBORDE ALVEOLAR, PRESENTAN UN DESAFÃ□O CONSIDERABLE PARA LOGRAR UNA REHABILITACIÃ“N ESTÃ‰TICA ADECUADA, ESPECIALMENTE EN LA REGIÃ“N ANTERIOR DEL MAXILAR (STUDER, 1997). LA RECONSTRUCCIÃ“N QUIRÃšRGICA DE ESTOS DEFECTOS MEDIANTE TÃ‰CNICAS DE AUMENTO DE TEJIDOS BLANDOS, COMO LA TÃ‰CNICA DE PLATAFORMA DE TEJIDO CONECTIVO (ZUCCHELLI, 2012) HA DEMOSTRADO SER EFICAZ AL PERMITIR LA ESTABILIZACIÃ“N DEL INJERTO, FAVORECIENDO LA RECUPERACIÃ“N DE CONTORNO Y VOLUMEN TISULAR EN UN SOLO PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO (BLASI, 2025).

EL OBJETIVO DE ESTE CASO ES DESCRIBIR EL ABORDAJE QUIRÃšRGICO Y SUS RESULTADOS PARA EL AUMENTO DE TEJIDO BLANDO DE UN DEFECTO DE CRESTA CLASE III EN UN PACIENTE CON PERIODONTITIS Y CONDICIONES SISTÃ‰MICAS CONTROLADAS.

Descripción del Caso *

PACIENTE MASCULINO DE 53 AÃ‘OS QUE ACUDE A LA CLÃ□NICA DE LA ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÃ□A DE LA UAG TRAS LA PÃ‰RDIDA DEL OD 11, LO CUAL PROVOCÃ“ UN COLAPSO TANTO DEL TEJIDO Ã“SEO COMO DE LOS TEJIDOS BLANDOS. PRESENTA DIAGNÃ“STICO DE PERIODONTITIS ESTADIO III GENERALIZADA GRADO B, ENTRE SUS ANTECEDENTES MÃ‰DICOS SE REPORTAN DM TIPO 2 CONTROLADA CON HBA1C DE 6.5% E HIPERTENSIÃ“N ARTERIAL BAJO TRATAMIENTO FARMACOLÃ“GICO. EL MOTIVO DE CONSULTA FUE REHABILITACIÃ“N DEL DIENTE AUSENTE, REPORTANDO MOVILIDAD DENTARIA Y CAMBIOS EN SU ENCÃ□A. TRAS COMPLETAR LA FASE I PERIODONTAL, SE INDICÃ“ INTERVENCIÃ“N QUIRÃšRGICA PARA AUMENTAR EL VOLUMEN DE TEJIDOS BLANDOS EN LA REGIÃ“N EDÃ‰NTULA CORRESPONDIENTE AL OD 21, DONDE SE DIAGNOSTICÃ“ UN DEFECTO DE CRESTA CLASE III DE SEIBERT. EL PROCEDIMIENTO CONSISTIÃ“ EN LA REALIZACIÃ“N DE INCISIONES HORIZONTALES PARALELAS A NIVEL DE LA CRESTA EDÃ‰NTULA, SEPARADAS ENTRE SÃ□ POR 3MM, PARA CONFIGURAR LA PLATAFORMA. SEGUIDAS DE LA ELEVACIÃ“N DE UN COLGAJO TIPO SOBRE DE ESPESOR PARCIAL, TOTAL Y PARCIAL, PARA PERMITIR EL AVANCE CORONAL PASIVO. SE DESEPITELIZÃ“ LA PLATAFORMA, SE COLOCÃ“ UN XENOINJERTO Ã“SEO Y SE COLOCÃ“ UN INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO PALATINO PREVIAMENTE DESEPITELIZADO, EL CUAL FUE ESTABILIZADO MEDIANTE SUTURAS CON Ã□CIDO POLIGLICÃ“LICO 6-0. EL CIERRE PRIMARIO SE LOGRÃ“ CON AVANCE CORONAL DEL COLGAJO VESTIBULAR Y SUTURAS ADICIONALES DE NYLON 5-0.

Resultados y Conclusiones *

A UN MES DEL POSTOPERATORIO, LA EVALUACIÃ“N CLÃ NICA MOSTRÃ“ UNA GANANCIA HORIZONTAL DE VOLUMEN TISULAR DE 7 MM, LA CUAL SE MANTUVO ESTABLE DURANTE ESE PERIODO, REPRESENTANDO UN RESULTADO CLÃ NICAMENTE SIGNIFICATIVO.

EL ABORDAJE QUIRÃšRGICO MEDIANTE LA TÃ‰CNICA DE PLATAFORMA DEMOSTRÃ“ SER CLÃ NICAMENTE VIABLE Y PREDECIBLE EN EL MANEJO DE UN DEFECTO DE CRESTA CLASE III EN PACIENTE CON ANTECEDENTES SISTÃ‰MICOS CONTROLADOS. LA INTERVENCIÃ“N PERMITIÃ“ LOGRAR UNA GANANCIA INICIAL DE VOLUMEN TISULAR CON CIERRE PRIMARIO ADECUADO. A PESAR DE LAS COMPLICACIONES EN EL PERIODO POSTOPERATORIO TEMPRANO, NO SE OBSERVARON SIGNOS DE INFECCIÃ“N, LO QUE SUGIERE UNA INTEGRACIÃ“N FAVORABLE DEL TEJIDO INJERTADO. EL SEGUIMIENTO CLÃ NICO CONTINUO SERÃ DETERMINANTE PARA EVALUAR LA MADURACIÃ“N DEL TEJIDO BLANDO, LA ESTABILIDAD DEL INJERTO Y LA POSIBILIDAD DE UNA REHABILITACIÃ“N PROTÃ‰SICA ESTÃ‰TICA EXITOSA EN EL MEDIANO PLAZO.

Bibliografía *

â€¢ ZUCCHELLI, G., MAZZOTTI, C., BENTIVOGLI, V., MOUNSSIF, I., MARZADORI, M., & MONACO, C. (2012). THE CONNECTIVE TISSUE PLATFORM TECHNIQUE FOR SOFT TISSUE AUGMENTATION. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF PERIODONTICS & RESTORATIVE DENTISTRY, 32(6), 665â€“675.

â€¢ SEIBERT, J.?S. â€œRECONSTRUCTION OF DEFORMED, PARTIALLY EDENTULOUS RIDGES, USING FULL THICKNESS ONLAY GRAFTS: PART I â€“ TECHNIQUE AND WOUND HEALING.â€ COMPENDIUM OF CONTINUING EDUCATION IN DENTISTRY, 1983; VOLUMEN 4, PÃ GINAS 437â€“453

â€¢ BLASI, G., ABRAHAMIAN, L., & BLASI, A. (2025). THE DISTALLY ANCHORED CONNECTIVE TISSUE GRAFT PLATFORM FOR PAPILLA ENHANCEMENT: A CASE REPORT. CLINICAL ADVANCES IN PERIODONTICS, 15(2), 150â€“159. HTTPS://DOI.ORG/10.1002/CAP.10299

â€¢ STUDER, S., NAEF, R., & SCHÃ„RER, P. (1997). ADJUSTMENT OF LOCALIZED ALVEOLAR RIDGE DEFECTS BY SOFT TISSUE TRANSPLANTATION TO IMPROVE MUCOGINGIVAL ESTHETICS: A PROPOSAL FOR CLINICAL CLASSIFICATION AND AN EVALUATION OF PROCEDURES. QUINTESSENCE INTERNATIONAL (BERLIN, GERMANY : 1985), 28(12), 785â€“805.

Título del trabajo *

MANEJO QUIRÃšRGICO DE RECESIONES TIPO RT1 ASOCIADAS A HENDIDURA DE STILLMAN MEDIANTE COLGAJO CORONALMENTE AVANZADO: UN REPORTE DE CASO CLÃ□NICO

Nombre del Autor (a/es)*

Jimmy Orlando Zuniga Ponce

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Vilma Bonilla Umanzor, Sarahi Ã□vila Alvarado, , , , , , , .

Correo Electrónico *

jimo_zunigap12@unicah.edu

Institución *

UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS

Introducción y Objetivos *

INTRODUCCIÃ“N Y OBJETIVO: LA RECESIÃ“N GINGIVAL (RG) SE DEFINE COMO LA MIGRACIÃ“N APICAL DEL MARGEN GINGIVAL MÃ S ALLÃ DE LA UNIÃ“N CEMENTO-ESMALTE (UCE), EXPONIENDO LA SUPERFICIE RADICULAR AL MEDIO BUCAL.(1) SU PREVALENCIA ES ALTA Y AUMENTA CON LA EDAD, AFECTANDO LA ESTÃ‰TICA Y PROVOCANDO SENSIBILIDAD DENTAL.(2) DIVERSOS FACTORES ETIOPATOGÃ‰NICOS, COMO EL TRAUMA MECÃ NICO POR CEPILLADO, FENOTIPO PERIODONTAL DELGADO, FRENILLOS CON INSERCIÃ“N ANÃ“MALA(1)(3) Y COMO HALLAZGOS MENOS REPORTADOS, PERO CLÃ NICAMENTE IMPORTANTES, TAMBIÃ‰N SON LAS â€œHENDIDURAS DE STILLMAN SON DEFECTOS DEL TEJIDO GINGIVAL, ORIGINADOS POR TRAUMA MECÃ NICO CRÃ“NICO Y CONSIDERADOS PRECURSORES DE RECESIÃ“N GINGIVALâ€ (6). SU DETECCIÃ“N TEMPRANA PERMITE UNA INTERVENCIÃ“N QUIRÃšRGICA PREVENTIVA. ESTE TRABAJO TIENE COMO OBJETIVO RELATAR UN CASO CLÃ NICO DE RECESIÃ“N GINGIVAL TIPO RT1 ASOCIADO A HENDIDURA DE STILLMAN TRATADO MEDIANTE LA TÃ‰CNICA DE COLGAJO CORONALMENTE AVANZADO (CAF) MODIFICADO SIN USO DE INJERTO AUTÃ“LOGO O SUSTITUTO.

Descripción del Caso *

DESCRIPCIÃ“N DEL CASO: PACIENTE FEMENINA DE 23 AÃ‘OS ACUDIÃ“ AL SERVICIO DE PERIODONCIA DEL HOSPITAL ODONTOLÃ“GICO MONSEÃ‘OR AGUSTÃ□N HOMBACH (UNICAH) POR SENSIBILIDAD DENTAL. CLÃ□NICAMENTE SE OBSERVARON LESIONES EN FORMA DE "V" EN PREMOLARES SUPERIORES DERECHOS (1.4 Y 1.5), COMPATIBLES CON HENDIDURA DE STILLMAN QUE EVOLUCIONARON A RECESIONES DE TIPO RT1 SEGÃšN LA CLASIFICACIÃ“N DE CAIRO. SE REALIZÃ“ LA TÃ‰CNICA QUIRÃšRGICA DE COLGAJO CORONALMENTE AVANZADO MODIFICADO, CON INCISIONES INTRASURCALES Y OBLICUAS REALIZADAS CON BISTURÃ□ HOJA #15C, SEGUIDA DE DISECCIÃ“N PARCIALâ€“TOTALâ€“PARCIAL SEGÃšN ZUCCHELLI Y DE SANCTIS (2016), SIN EMPLEO DE INJERTOS. SE DESEPITELIZARON LAS PAPILAS ANATÃ“MICAS Y SE LIBERÃ“ EL COLGAJO HASTA OBTENER DESPLAZAMIENTO PASIVO, FIJÃ□NDOLO MEDIANTE SUTURAS SIMPLES Y SUSPENSORIAS CON MONOFILAMENTO DE NYLON 5-0. SE INDICARON PROTOCOLOS POSTOPERATORIOS DE ANALGESIA Y ANTISEPSIA. EL SEGUIMIENTO CLÃ□NICO FUE A LOS 3, 7 Y 15 DÃ□AS Y POSTERIORMENTE AL PRIMER Y TERCER MES.

FIG 1, 2, 3, 4, 5

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: LA CICATRIZACIÃ“N FUE EXITOSA SIN COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS, INFLAMACIÃ“N NI SIGNOS DE INFECCIÃ“N. SE LOGRÃ“ COBERTURA RADICULAR DEL 100% EN AMBAS PIEZAS TRATADAS. NO SE OBSERVÃ“ RECIDIVA DURANTE LOS CONTROLES CLÃ NICOS HASTA EL TERCER MES DE SEGUIMIENTO. ESTE RESULTADO RESPALDA LA EFICACIA DEL CAF MODIFICADO COMO ALTERNATIVA PREDECIBLE Y MENOS INVASIVA, EVITANDO EL USO DE INJERTOS ADICIONALES. FIG. 6

CONCLUSIÃ“N: LAS HENDIDURAS DE STILLMAN DEBEN CONSIDERARSE MARCADORES CLÃ NICOS TEMPRANOS DE RIESGO PARA RECESIONES RT1, ESPECIALMENTE EN PACIENTES JÃ“VENES CON FENOTIPO PERIODONTAL DELGADO, LA DETECCION TEMPRANA PERMITE UN TRATAMIENTO MÃ S CONSERVADOR Y EFECTIVO.

EL COLGAJO CORONALMENTE AVANZADO CON MODIFICACIÃ“N TRIANGULAR SIN USO DE INJERTOS ES UNA TÃ‰CNICA CONFIABLE Y REPRODUCIBLE, CON ALTO Ã‰XITO CLÃ NICO EN COBERTURA RADICULAR.

Bibliografía *

1. TOLEDANO-OSORIO , MUÃ‘OZ-SOTO , TOLEDANO , VALLECILLO-RIVAS , VALLECILLO , RAMOS-GARCÃ A , ET AL. TREATING

GINGIVAL RECESSIONS USING CORONALLY ADVANCED FLAP OR TUNNEL TECHNIQUES WITH AUTOGRAFTS OR POLYMERIC

SUBSTITUTES: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS. POLYMERS. 2022; 14(7).

2. TONETTI , SANZ , CAIRO F, NART , CHAPPLE , AIMETTI , ET AL. AESTHETICS AND PATIENT- REPORTED OUTCOMES IN.

PERIODONTOLOGY AND IMPLANT DENTISTRY: CONSENSUS REPORT. 2025 .

3. ROMITTI , V. FAGUNDES , M. ANGST PD, S. GOMES , C. GOMES , RUI V. OPPERMANN. THE USE OF MEDIUM BRISTLE

TOOTHBRUSHES IS ASSOCIATED WITH THE INCIDENCE OF GINGIVAL FISSURES. CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS. 2021; 26.

4. ZUCCHELLI G, STEFANINI , GANZ , MAZZOTTI , MOUNSSIF I, MARZADORI. CORONALLY ADVANCED FLAP WITH

Título del trabajo *

RECUBRIMIENTO RADICULAR POR MEDIO DE TÃ‰CNICAS COMBINADO DE TÃšNEL Y COLGAJO DE AVANCE CORONAL CON INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO

Nombre del Autor (a/es)*

WENDY KARLA LAÃ□NEZ PAZ

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

VILMA BONILLA UMANZOR, SARAHÃ□ AVÃ□LA, , , , , , , .

Correo Electrónico *

wendytalainez85@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD CATÃ“LICA DE HONDURAS

Introducción y Objetivos *

INTRODUCCIÃ“N

LA RECESIÃ“N GINGIVAL SE DEFINE COMO UNA MIGRACIÃ“N APICAL DEL MARGEN GINGIVAL RESPECTO A LA UNIÃ“N CEMENTOESMALTE CON EXPOSICIÃ“N DE LA SUPERFICIE RADICULAR (1). LA ESTÃ‰TICA, HIPERSENSIBILIDAD RADICULAR Y LESIONES CERVICALES NO CARIOSAS ESTAN ASOCIADAS A CON LAS RECESIONES GINGIVALES SE CONSIDERAN LAS PRINCIPALES INDICACIONES PARA EL TRATAMIENTO (2). LA ETIOLOGÃ?A DE LA RECESIÃ“N GINGIVAL COMPRENDE FACTORES CONTRIBUYENTES COMO FUERZA EXCESIVA AL CEPILLARSE LOS DIENTES, TABAQUISMO, HIGIENE BUCAL INADECUADA. (3) LA MALPOSICIÃ“N DENTARIA, INSERCIÃ“N ALTA DEL FRENILLO Y LA DEHISCENCIA DEL HUESO BUCAL SE CONSIDERAN FACTORES PREDISPONENTES PARA LAS RECESIONES. (4)

LA PREVISIBILIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECUBRIMIENTO RADICULAR PARA EL TRATAMIENTO DE RECESIONES GINGIVALES ÃšNICAS Y MÃšLTIPLES SE HA DEMOSTRADO AMPLIAMENTE CONSIDERADO COMO EL TRATAMIENTO ESTÃ?NDAR DE ORO PARA RECESIONES INDIVIDUALES O MÃšLTIPLES QUE PROPORCIONA UNA EXCELENTE ESTABILIDAD DEL MARGEN GINGIVAL. (5)

EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA CIRUGÃ?A MUCOGINGIVAL MEDIANTE TÃ‰CNICA TÃšNEL COMBINADA CON COLGAJO DE AVANCE CORONAL E INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO AUTÃ“LOGO ES LOGRAR LA COBERTURA RADICULAR DE LAS RECESIONES GINGIVALES PRESENTES EN LOS DIENTES 1.6 1.4 1.3 MEJORANDO EL ESPESOR DEL TEJIDO BLANDO, FAVORECER LA INTEGRACIÃ“N ESTÃ‰TICA Y ALCANZAR UNA ESTABILIDAD A LARGO PLAZO.

Descripción del Caso *

DESCRIPCIÃ“N DEL CASO

PACIENTE FEMENINA DE 45 AÃ‘OS DE EDAD SE PRESENTÃ“ AL HOSPITAL ODONTOLÃ“GICO AGUSTÃ□N HOMBACH DE LA UNIVERSIDAD CATÃ“LICA DE HONDURAS, EL MOTIVO DE LA CONSULTA FUE HIPERSENSIBILIDAD ASOCIADA A UNA MOLESTIA DURANTE EL CEPILLADO EN LA ZONA ANTERIOR SUPERIOR DERECHA. AL EXAMEN CLÃ□NICO SE EVIDENCIÃ“ RECESIONES GINGIVALES EN LOS DIENTES 1.6 1.4 1.3 (FIG.1) CLASIFICADAS COMO RT1 Y RT2 SEGÃšN CAIRO. DADO EL COMPROMISO ESTÃ‰TICO Y FUNCIONAL SE INDICÃ“ REALIZAR UNA CIRUGÃ□A MUCOGINGIVAL MEDIANTE LA TÃ‰CNICA DE TÃšNEL COMBINADA CON COLGAJO DE AVANCE CORONAL E INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO OBTENIDO DEL PALADAR CON EL PROPOSITO DE LOGRAR COBERTURA RADICULAR Y MEJORAR EL ESPESOR TISULAR. DIENTE 1.6 ANESTESIA LOCAL ARTICAÃ□NA 4% HOJA DE MICROBISTURÃ□ INCISIÃ“N VERTICAL EN DISTAL PARA ACCESO, INCISIONES INTRASULCULAR EN VESTIBULAR, ELEVACIÃ“N DEL COLGAJO SIN DESPRENDIMIENTO DE LOS TEJIDOS PAPILARES A ESPESOR PARCIAL, LIBERANDO TENSIÃ“N MUSCULAR DEL PERIOSTIO Y EL COLGAJO AVANZA CORONAL, SUTURAS SUSPENSORIAS DE NYLON MONOFLLAMENT NON-ABSORBABLE 5/0. DIENTES 1.4 1.3 ANESTESIA LOCAL ARTICAÃ□NA AL 4% BISTURÃ□ NÂ°15, INCISIONES OBLICUAS PERPENDICULAR A LA UNIÃ“N CEMENTOESMALTE DEL DIENTE, INCISIONES INTRASULCULAR, SE LEVANTÃ“ COLGAJO A ESPESOR TOTAL -PARCIAL LIBERANDO LO SUFICIENTE, SE DESEPITELIZAR LAS PAPILAS, SE PROCEDIÃ“ A LA PRESENTACION DEL INJERTO TEJIDO CONECTIVO (FIG.2) SE FIJO CON SUTURAS SUSPENSORIAS MONOFAST REABSORBIBLE 6/0 (FIG. 3). INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS DE ANALGESIA Y ANTISEPSIA. RETIRO DE SUTURAS 14 DIAS. (FIG.4)

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

EN EL SEGUIMIENTO FOTOGRÃ□FICO Y CLÃ□NICO POSTOPERATORIO SE REALIZÃ“ RETIRO DE SUTURAS A LOS 14 DIAS CICATRIZANDO SIN ALTERACIÃ“N EN EL QUE LOGRA UNA EVOLUCIÃ“N FAVORABLE EN LOS DIENTES TRATADOS. ADEMÃ□S SE OBSERVÃ“ AUMENTO DEL VOLUMEN DEL TEJIDO BLANDO TRATADO, EN DIENTE 1.6 SE OBTUVO COBERTURA RADICULAR 70%, DIENTE 1.4 SE OBTUVO COBERTURA RADICULAR 87.5%, DIENTE 1.3 SE OBTUVO COBERTURA RDICULAR COMPLETA 100% EN LAS RECESIONES TRATADAS MEDIANTE LA TÃ‰CNICA DE TÃšNEL CON COLGAJO DE AVANCE CORONAL E INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO.

LA PACIENTE MANISFESTÃ“ SATISFACCIÃ“N FUNCIONAL Y ESTÃ‰TICA Y SE LE INDICÃ“ CONTROL PERIODONTAL PERIÃ“DICO PARA MANTENIMIENTO A LARGO PLAZO. LA TÃ‰CNICA QUIRÃšRGICA MOSTRÃ“ UNA EVOLUCION FAVORABLE SIN COMPLICACIONES QUE RESPALDAN LA TÃ‰CNICA EN SU ETAPA.

LA TÃ‰CNICA DE TÃšNEL COMBINADA COLGAJO DE AVANCE CORONAL E INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO DEMOSTRÃ“ SER EFICAZ Y MÃ□NIMAMENTE INVASIVA PARA EL TRATAMIENTO DE RECESIONES GINGIVALES MÃšLTIPLES.

Bibliografía *

REFERENCIAS BIBLIOGRÃ□FICAS

1.CHAMBRONE , Ã□VILA-ORTIZ. AN EVIDENCE-BASED SYSTEM FOR THE CLASSIFICATION AND CLINICAL MANAGEMENT OF NON-PROXIMAL GINGIVAL RECESSION DEFECTS. JOURNAL OF PERIODONTOLOGY. 2020 MAY.

2.MAZZOTTI C, MOUNSSIF I, RENDÃ“N A. COMPLICATIONS AND TREATMENT ERRORS IN ROOT COVERAGE PROCEDURES. PERIODONTOLOGY 2000. 2022 JULY.

3.GKANTIDIS N, DRITSAS K, GHAMRIE M. METHODS FOR 3D EVALUATION AND QUANTIFICATION OF GINGIVAL RECESSIONS AND GINGIVAL MARGIN CHANGES: ADVANCES COMPARED TO CONVENTIONAL TECHNIQUES. PERIODONTOLOGY 2000. 2024 OCTOBER.

4. MASCARDO KC, TOMACK J, CHEN CY. RISK INDICATORS FOR GINGIVAL RECESSION IN

Título del trabajo *

ALARGAMIENTO DE CORONA CLÃ NICO EN PACIENTE CON ERUPCIÃ“N PASIVA ALTERADA

Nombre del Autor (a/es)*

Juan Antonio Vasquez Lozano

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Vilma Umanzor Bonilla, Angelica SarahÃ- Avila, , , , , , , .

Correo Electrónico *

antoniolozano2989@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS

Introducción y Objetivos *

INTRODUCCION

LA ERUPCIÃ“N PASIVA ALTERA ES UNA SITUACIÃ“N CLÃ NICA EN LA CUAL LOS TEJIDOS GINGIVALES SE ENCUENTRAN COLOCADOS EN UNA POSICIÃ“N CORONAL RESPECTO A LA UNION AMELOCEMENTARIA, DANDO COMO RESULTADO UNA APARIENCIA DE LAS CORONAS DENTALES MÃ S PEQUEÃ‘AS. (1)

COSLET CLASIFICÃ“ 2 TIPOS DE ACUERDO A LA LÃ NEA MUCOGINGIVAL EN RELACIÃ“N CON LA CRESTA Ã“SEA Y 2 SUBTIPOS DE ACUERDO A LA LONGITUD DE LA CRESTA Ã“SEA CON RELACIÃ“N A LA UNIÃ“N CEMENTO ESMALTE. (2)

OBJETIVO

EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO ES DESCRIBIR EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE UNA PACIENTE DE 36 AÃ‘OS CON EXCESO GINGIVAL Y CORONAS CLINICAS CORTAS EN EL SECTOR ANTERIOR.

Descripción del Caso *

PACIENTE DE 36 AÃ‘OS EN TRATAMIENTO ORTODONTICO EN EL POSGRADO DE ORTODONCIA DE LA UNIVERSIDAD CATÃ“LICA DE HONDURAS, ES REFERIDA AL Ã REA DE ESPECIALIDAD DE PERIODONCIA POR AGRANDAMIENTO GINGIVAL.

A EL EXAMEN CLÃ NICO SE OBSERVA INFLAMACIÃ“N DEL MARGEN GINGIVAL, APARENTE EXCESO GINGIVAL Y CORONAS DENTALES CORTAS. SE REALIZA INSTRUMENTACIÃ“N SUPRAGINGIVAL, INSTRUCCIONES DE HIGIENE ORAL Y SE LE SOLICITA CONE BEAM BIMAXILAR PARA ANÃ LISIS TOMOGRÃ FICO.

A LOS 2 MESES, SE HAN RETIRADOS LOS APARATOS DE ORTODONCIA Y SE PUEDE OBSERVAR COMO LA INFLAMACIÃ“N GINGIVAL HA DESAPARECIDO, PERO AÃšN SE MANTIENE UN MARGEN GINGIVAL DESPLAZADO HACIA CORONAL EN RELACIÃ“N CON SU POSICIÃ“N NORMAL.

EN EL ANÃ LISIS TOMOGRÃ FICO, PODEMOS OBSERVAR, QUE LA DISTANCIA DE LA CRESTA Ã“SEA CON RELACIÃ“N A LA UNIÃ“N CEMENTO-ESMALTE ES MENOR DE 1MM PARA TODOS LOS DIENTES DEL SECTOR SUPERIOR ANTERIOR. DIAGNOSTICO: SALUD PERIODONTAL EN UN PERIODONTO INTACTO. (3)

ERUPCIÃ“N PASIVA ALTERADA TIPO 1 SUBTIPO B SEGÃšN LA CLASIFICACIÃ“N DE COSLET. (4)

UTILIZANDO TÃ‰CNICA DE ANESTESIA INFILTRATIVA SUBMUCOSA SE APLICÃ“ ANESTÃ‰SICO LOCAL ARTICAÃ NA 4% CON EPINEFRINA 1:100:00 , SEGUIDAMENTE SE REALIZÃ“ INCISIÃ“N SUBMARGINAL A BISEL EXTERNO CON HOJA DE BISTURÃ 15C.

CON BISTURÃ DE KIRCKLAND SE REALIZÃ“ GINGIVOPLASTIA.

SE LEVANTO COLGAJO DE ESPESOR TOTAL CON ELEVADOR DE PERIOSTIO BUSER. SEGUIDAMENTE SE REALIZO OSTEOTOMÃ A BAJO IRRIGACIÃ“N CON SUERO FISIOLÃ“GICO, UTILIZANDO FRESA DE CARBURO CILÃ NDRICA PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD Y FRESA N-CUT PUNTA DE DIAMANTE PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD. UBICANDO LA CRESTA Ã“SEA VESTIBULAR A 3 MM DE LA UCE.

SE REALIZO OSTEOPLASTIA BAJO IRRIGACIÃ“N CON SUERO FISIOLÃ“GICO CON FRESA REDONDA DE CARBURO PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD.

FINALMENTE SE REPOSICIONO EL COLGAJO Y SE FIJÃ“ CON PUNTOS COLCHONEROS VERTICALES CON SUTURA DE NYLON 5/0.

Resultados y Conclusiones *

EN LAS FOTOGRAFÃ□AS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÃ“N POSOPERATORIA SE PUEDE OBSERVAR CÃ“MO SE MEJORÃ“ LA LONGITUD DE LAS CORONAS DENTALES Y TAMBIÃ‰N COMO EL CONTORNO GINGIVAL SE VA ADAPTANDO A SU NUEVA INSERCIÃ“N, ESTO DEBIDO NO TANTO A LA GINGIVECTOMÃ□A SINO A LA OSTEOTOMÃ□A, MOSTRANDO LA ESTABILIZACIÃ“N DE LOS MÃ□RGENES GINGIVALES.

TAMBIÃ‰N SE PUDO CONSTATAR LA SATISFACCIÃ“N DE LA PACIENTE RECONOCIENDO LA MEJORA ESTÃ‰TICA EN SU SONRISA Y SE MOSTRO SATISFECHA CON LOS RESULTADOS EN RELACIÃ“N A LA EXPECTATIVA CON LA CIRUGÃ□A, SIENDO ESTE UN PUNTO IMPORTANTE QUE LA LITERATURA MENCIONA CON RESPECTO A LA INDICACIÃ“N Y LOS RESULTADOS DE LA CIRUGÃ□A DE ALARGAMIENTO DE CORONA.

AUNQUE EN LA LITERATURA SE DESCRIBEN DIFERENTES TÃ‰CNICAS PARA LA CIRUGÃ□A DE ALARGAMIENTO DE CORONA, EL MÃ‰TODO CONVENCIONAL MUESTRA RESULTADOS PREDECIBLES PARA EL MANEJO DE LA ERUPCIÃ“N PASIVA ALTERA TIPO1 SUBTIPO B SEGÃšN LA CLASIFICACIÃ“N DE COLSET. (5)

Bibliografía *

1. KALSI HJ, BOMFIM DI, HUSSAIN Z, RODRIGUEZ JM. CROWN LENGTHENING SURGERY: ON A REVIEW. PRIMARY DENTAL JOURNAL. 2019;: P. 48-53.

2. QALI , ALSAEGH HA, ALSARAF S. CLINICAL CONSIDERATIONS FOR CROWN LENGTHENING: A COMPREHENSIVE REVIEW. CUREUS. 2024.

3. CATON JG, ARMITAGE , BERGLUNDH T, CHAPPLE ILC, JEPSEN S, KORNMAN KS, ET AL. A NEW CLASSIFICATION SCHEME FOR PERIODONTAL AND PERI-IMPLANT DISEASES AND CONDITIONS â€“ INTRODUCTION AND KEY CHANGES FROM THE 1999 CLASSIFICATION. JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY. 2018.

4. TATAKIS DN, O. SILVA C. CONTEMPORARY TREATMENT TECHNIQUES FOR EXCESSIVE GINGIVAL DISPLAY CAUSED BY ALTERED PASSIVE ERUPTION OR LIP HYPERMOBILITY: REVIEW ARTICLE. JOURNAL OF DENTISTRY. 2023.

5. GONZÃ□LEZ-MARTÃ□N , CARBAJO G, RODRIGO M, MONTERO , SANZ M. ONE- VERSUS TWO-STAGE CROWN LENGTHENING SURGICAL PROCEDURE FOR AESTHETIC RESTORATIVE PURPOSES: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY. 2020.

Título del trabajo *

INTEGRACIÃ“N DE INJERTO Ã“SEO E INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO EN LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTE DEL SECTOR ANTERIOR: MANEJO MULTIDISCIPLINARIO.

Nombre del Autor (a/es)*

Ana Karen LÃ³pez Rosas

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Luis Angel SÃ¡nchez ChÃ¡idez, Rocio Karina CÃ¡rdenas Delgado, Israel Guardado Luevano, , , , , , .

Correo Electrónico *

akarenlr24@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA

Introducción y Objetivos *

LA COLOCACIÃ“N INMEDIATA DE IMPLANTES POSTEXTRACCIÃ“N EN LA ZONA ESTÃ‰TICA REPRESENTA UN ENFOQUE PREDECIBLE CUANDO SE SELECCIONA ADECUADAMENTE EL CASO, Y SE COMBINA CON TÃ‰CNICAS DE PRESERVACIÃ“N Y AUMENTO DE TEJIDOS. LA PÃ‰RDIDA Ã“SEA Y DE TEJIDO BLANDO TRAS LA EXTRACCIÃ“N DENTAL ES UN FENÃ“MENO BIEN DOCUMENTADO Y CLÃ NICAMENTE RELEVANTE, PARTICULARMENTE EN EL SECTOR ANTERIOR MAXILAR, DONDE LAS EXIGENCIAS ESTÃ‰TICAS SON ALTAS (CHAPPUIS ET AL., 2017). PARA MINIMIZAR ESTOS EFECTOS, SE HAN DESARROLLADO TÃ‰CNICAS QUE INCLUYEN COLOCACIÃ“N DE HUESO PARTICULADO Y EL USO DE INJERTOS DE TEJIDO CONECTIVO (ZUIDERVELD ET AL., 2024; ZUHR ET AL., 2014).

EL OBJETIVO DE ESTE CASO CLÃ NICO FUE DESCRIBIR UN ABORDAJE INTEGRAL EN UN PACIENTE CON ALTA DEMANDA ESTÃ‰TICA, MEDIANTE LA COLOCACIÃ“N INMEDIATA DE UN IMPLANTE POSTEXTRACCIÃ“N EN EL SECTOR ANTERIOR MAXILAR, COMPLEMENTADO CON INJERTO Ã“SEO Y DE TEJIDO CONECTIVO, CON LA FINALIDAD DE EVALUAR SU EFICACIA CLÃ NICA Y ANALIZAR LA ESTABILIDAD DE LOS TEJIDOS PERIIMPLANTARIOS A LOS 4 MESES DE SEGUIMIENTO.

Descripción del Caso *

PACIENTE MASCULINO DE 36 AÃ‘OS, SISTÃ‰MICAMENTE SANO, ES REMITIDO AL POSGRADO EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÃ A U.A.G. POR MOVILIDAD EN EL INCISIVO CENTRAL SUPERIOR DERECHO (OD #11). A LA INSPECCIÃ“N RADIOGRÃ FICA SE OBSERVA SOMBRA RADIOLÃšCIDA APICAL A LA UCE DE FORMA HORIZONTAL DE MESIAL A DISTAL COMPATIBLE CON FRACTURA HORIZONTAL, A LA INSPECCIÃ“N CLÃ NICA PRESENTA MOVILIDAD GRADO II. SE COLOCA FÃ‰RULIZA PROVISIONAL Y SE REMITE A POSGRADO DE PROSTODONCIA E IMPLANTOLOGÃ A PARA TOMA DE MODELOS, ENCERADO DIAGNÃ“STICO Y PLANIFICACIÃ“N Y DISEÃ‘O DE GUÃ A QUIRÃšRGICA PARA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTE. UNA VEZ OBTENIDA LA GUÃ A QUIRÃšRGICA IMPRESA SE PROCEDE A REALIZAR PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO. SE REALIZA EXTRACCIÃ“N DENTAL SIN ELEVACIÃ“N DE COLGAJO, REALIZANDO ODONTOSECCIÃ“N EN SENTIDO VESTÃ BULO-PALATINO PARA EXTRAER EN SECCIONES CON LA INTENCIÃ“N DE NO DAÃ‘AR LA TABLA VESTIBULAR, SE PROCEDE A COLOCAR IMPLANTE DENTAL. SE COLOCÃ“ XENOINJERTO PARTICULADO EN EL GAP ENTRE EL IMPLANTE Y EL ALVEOLO PARA EVITAR EL COLAPSO DE LAS PAREDES DEL ALVEOLO Y SE AÃ‘ADIÃ“ INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO OBTENIDO DEL PALADAR, REALIZANDO TUNELIZACIÃ“N EN VESTIBULAR Y PALATINO DE LA ZONA DE LA EXTRACCIÃ“N PARA MANTENER EL VOLUMEN DE TEJIDOS BLANDOS Y AYUDAR A LA CONTENCIÃ“N DEL INJERTO Ã“SEO, FIJÃ NDOLO CON PUNTOS COLCHONEROS HORIZONTALES EN AMBAS CARAS. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO, SE PROCEDE A UTILIZAR CORONA DEL DIENTE COMO PROVISIONAL, AGREGANDO RESINA FLUIDA EN PORCIÃ“N CERVICAL PARA INICIAR LA CONFORMACIÃ“N DE LOS TEJIDOS BLANDOS. EL SEGUIMIENTO INCLUYÃ“ CONTROLES A 7 DÃ AS, 2 SEMANAS, 6 SEMANAS, 3 Y 4 MESES, DOCUMENTANDO LA CICATRIZACIÃ“N DE TEJIDOS BLANDOS, IMÃ GENES RADIOGRÃ FICAS Y MANTENIMIENTO DEL PERFIL DE EMERGENCIA.

Resultados y Conclusiones *

A LOS 4 MESES SE OBSERVÃ“ INTEGRACIÃ“N EXITOSA DEL IMPLANTE, SIN SIGNOS DE INFLAMACIÃ“N NI PÃ‰RDIDA Ã“SEA MARGINAL. CLÃ NICAMENTE, SE MANTUVO LA PAPILA INTERDENTAL Y EL CONTORNO GINGIVAL, SIN RECESIONES, LO CUAL FAVORECIÃ“ UNA ESTÃ‰TICA NATURAL. RADIOGRÃ FICAMENTE, NO SE EVIDENCIÃ“ PÃ‰RDIDA Ã“SEA PERIIMPLANTARIA, EN CONSONANCIA CON LOS CONCEPTOS DE â€œZERO BONE LOSSâ€ (LINKEVI?IUS ET AL., 2020). LA APLICACIÃ“N CONJUNTA DE INJERTO DE HUESO PARTICULADO E INJERTO CONECTIVO PERMITIÃ“ PRESERVAR LA ARQUITECTURA TISULAR, LO CUAL ESTÃ RESPALDADO POR MÃšLTIPLES ESTUDIOS CLÃ NICOS (ZUIDERVELD ET AL., 2024). ESTE ABORDAJE TAMBIÃ‰N REDUCE EL NÃšMERO DE PROCEDIMIENTOS QUIRÃšRGICOS Y ACORTA EL TIEMPO TOTAL DE TRATAMIENTO. EL Ã‰XITO DE ESTE CASO CONFIRMA QUE UNA ADECUADA PLANEACIÃ“N, SELECCIÃ“N DE BIOMATERIALES Y TÃ‰CNICA QUIRÃšRGICA SON FUNDAMENTALES PARA LOGRAR RESULTADOS ESTÃ‰TICOS Y FUNCIONALES DURADEROS.

Bibliografía *

CHAPPUIS, V., ARAÃšJO, M. G., & BUSER, D. (2017). DIMENSIONAL BONE AND SOFT TISSUE ALTERATIONS POST?EXTRACTION IN ESTHETIC SITES. PERIODONTOLOGY 2000, 73(1), 73â€“83.

LINKEVI?IUS, T., PUIÅ YS, A., & ANDRIJAUSKAS, R. (2020). ZERO BONE LOSS CONCEPTS. QUINTESSENCE PUBLISHING.

RESNIK, R. R. (2020). MISCHS CONTEMPORARY IMPLANT DENTISTRY (4TH ED.). ELSEVIER HEALTH SCIENCES.

ZUIDERVELD, E. G., ET AL. (2024). SINGLE IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT IN THE MAXILLARY AESTHETIC ZONE WITH AND WITHOUT CONNECTIVE TISSUE GRAFTING: 5?YEAR RCT. JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, 51(4), 487â€“498.

ZUHR, O., BÃ„UMER, D., & HÃœRZELER, M. (2014). SOFT TISSUE GRAFTS IN IMPLANT SURGERY. JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, 41(S15), S123â€“S142.

Título del trabajo *

CIRUGÃ A PLÃSTICA PERIODONTAL EN ZONA ESTÃ‰TICA: COBERTURA DE RECESIONES GINGIVALES MÃšLTIPLES MEDIANTE TÃ‰CNICA MODIFICADA DE COLGAJO DE AVANCE CORONAL Y TÃšNEL CON INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO

Nombre del Autor (a/es)*

Villars ZÃºniga Amelia MarÃ-a

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Umanzor Bonilla Vilma Alejandra, Ãvila Alvarado AngÃ©lica SarahÃ-, SabillÃ³n Ellner Karen, , , , , , .

Correo Electrónico *

ameliavillarszuniga@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD CATÃ“LICA DE HONDURAS

Introducción y Objetivos *

INTRODUCCION

LAS RECESIONES GINGIVALES, SEGÃšN LA ASOCIACIÃ“N AMERICANA DE PERIODONCIA (APP)(1)ES EL DESPLAZAMIENTO DEL MARGEN GINGIVAL APICAL A LA UNIÃ“N CEMENTO-ESMALTE, QUE EXPONE LA SUPERFICIE RADICULAR DEL DIENTE AL AMBIENTE ORAL. ESTA CONDICIÃ“N PUEDE ESTAR ASOCIADA CON PÃ‰RDIDA DE INSERCIÃ“N PERIODONTAL, EXPOSICIÃ“N DE LAS RAÃ CES DENTALES, SENSIBILIDAD, CARIES RADICULAR Y PROBLEMAS ESTÃ‰TICOS.

LA CLASIFICACIÃ“N DE LAS RECESIONES HA IDO EVOLUCIONANDO Y ACTUALMENTE SE UTILIZA EL SISTEMA PROPUESTO POR CAIRO (2011) (2), QUE SE BASA EN LA PRESENCIA O AUSENCIA DE PÃ‰RDIDA DE INSERCIÃ“N INTERPROXIMAL PARA GUIAR, TANTO EL DIAGNÃ“STICO COMO EL PRONÃ“STICO DEL TRATAMIENTO.

OBJETIVO

LOGRAR UNA COBERTURA MÃ XIMA DE LAS RECESIONES GINGIVALES Y POSICIÃ“N IDEAL EN REFERENCIA A LA UNIÃ“N CEMENTO ESMALTE PARA DEVOLVER LA SALUD ORAL Y ARMONÃ A ESTÃ‰TICA.

Descripción del Caso *

REPORTE DE CASO

PACIENTE FEMENINO DE 43 AÃ‘OS DE EDAD CON HIPERTENSIÃ“N ARTERIAL CONTROLADA, SE PRESENTÃ“ AL HOSPITAL ODONTOLÃ“GICO MONSEÃ‘OR AGUSTÃN HOMBACH PARA TRATAR LAS RECESIONES GINGIVALES. LA PACIENTE NO REFIERE PRESENTAR SINTOMATOLOGÃA, SIN EMBARGO, SU MOTIVO PRINCIPAL DE CONSULTA SE DEBE AL COMPROMISO ESTÃ‰TICO. TODAS LAS RECESIONES FUERON CLASIFICADAS COMO RT1, SEGÃšN LA CLASIFICACIÃ“N DE CAIRO (2011) (2).

NINGUNA DE LAS RECESIONES PRESENTÃ“ PROFUNDIDADES AL SONDAJE O SANGRADO. EL ÃNDICE DE PLACA PRESENTE EN UN 3%

PROCEDIMIENTO

SE REALIZÃ“ LA CIRUGÃA BAJO ANESTESIA LOCAL CON ARTICAÃNA AL 4%. SE DISEÃ‘Ã“ EL COLGAJO DE AVANCE CORONAL DE ZUCCHELLI (2000), TOMANDO COMO RECESIÃ“N DE REFERENCIA LOS OD 1.1 Y 2.1. POSTERIOR A LAS INCISIONES Y PARCIALIZACIÃ“N DEL COLGAJO, SE PROCEDIÃ“ A REALIZAR EL TÃšNEL EN LOS OD 1.1 Y 2.1 PARA LOGRAR DESPLAZAR EL COLGAJO Y ALCANZAR LA COBERTURA DESEADA.

SEGUIDAMENTE SE TOMÃ“ EL TEJIDO CONECTIVO DEL PALADAR (5) PARA LUEGO COLOCARLO EN LOS Ã“RGANOS DENTALES 1.3 Y 2.3, SE FIJÃ“ UTILIZANDO SUTURAS DE ÃCIDO POLOGLICÃ“LICO 6.0. EN PALADAR, SE COLOCÃ“ ESPONJA DE COLÃGENO Y SUTURAS EN X DE NYLON 5.0. FINALMENTE SE POSICIONÃ“ EL COLGAJO CON PUNTOS SUPENSORIOS CON SUTURAS DE NYLON 6.0.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

EN EL CONTROL POSOPERATORIO SE LOGRÃ“ OBSERVAR EL TEJIDO TOTALMENTE SANO, SIN SIGNOS DE INFECCIÃ“N, EN LA POSICIÃ“N DESEADA. LA PACIENTE NO REFIRIÃ“ NINGÃšN TIPO DE MOLESTIAS POSQUIRÃšRGICAS, MÃ?S QUE UNA LEVE INFLAMACIÃ“N.

LA TÃ‰CNICA COMBINADA QUE SE UTILIZÃ“, DEMOSTRÃ“ SER UNA OPCIÃ“N EFICAZ Y PREDECIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE RECESIONES GINGIVALES MÃšLTIPLES EN ZONA ESTÃ‰TICA.

LA INTERVENCIÃ“N RESULTÃ“ EN UNA COBERTURA RADICULAR EN UN 100%, AUMENTO DE GROSOR GINGIVAL Y SATISFACCIÃ“N DEL PACIENTE

Bibliografía *

IMBER, J.-C., & KASAJ, A. (2021). TREATMENT OF GINGIVAL RECESSION: WHEN AND HOW? INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL, 71(3), 178â€“187. DOI:10.1111/IDJ.12617Â

CAIRO F. PERIODONTAL PLASTIC SURGERY OF GINGIVAL RECESSIONS AT SINGLE AND MULTIPLE TEETH. PERIODONTOL 2000. 2017;75(1):296â€“316. DOI:10.1111/PRD.12181.

ZUCCHELLI G, TESTORI T, DE SANCTIS M. CLINICAL AND ANATOMICAL FACTORS LIMITING TREATMENT OUTCOMES OF GINGIVAL RECESSION: A NEW METHOD TO PREDETERMINE THE LINE OF ROOT COVERAGE. J PERIODONTOL. 2006 APR;77(4):714-21. DOI: 10.1902/JOP.2006.050038.

ZUCCHELLI G, DE SANCTIS M. TREATMENT OF MULTIPLE RECESSION-TYPE DEFECTS IN PATIENTS WITH ESTHETIC DEMANDS. J PERIODONTOL. 2000 SEP;71(9):1506-14. DOI: 10.1902/JOP.2000.71.9.1506.

TAVELLI L, BAROOTCHI S, NAMAZI SS, WANG CW, RAVIDÃ€ A, OH TJ, WANG HL. WHAT IS THE SAFETY ZONE FOR PALATAL SOFT TISSUE GRAFT HARVESTING BASED ON THE LOCATIONS OF THE GREATER PALATINE ARTERY AND FORAMEN? A SYSTEMATIC REVIEW. CLIN ORAL INVESTIG. 2019;23(7):2927â€“40.

Título del trabajo *

"COBERTURA RADICULAR EN PACIENTE DIABÃ‰TICO TIPO I CON INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO: SUTURA DOUBLE CROSS DE ZUHR"

Nombre del Autor (a/es)*

C.D QUINTANA CHÃ□VEZ ZONNIA DUNETSCHKA

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

D.C.F AGUADO ARZOLA MARTHA MARGARITA, D.C.F CASTILLO Ã□LVAREZ VÃ□CTOR HUGO, D.C.F PIETSCHMANN SANTAMARÃ□A MARÃ□A DE LOS Ã□NGELES, M.S HERNÃ□NDEZ TERRAZAS CARLOS ALBERTO, , , , , .

Correo Electrónico *

dunequintana@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD AUTÃ“NOMA DE COAHUILA, UNIDAD LAGUNA

Introducción y Objetivos *

EL PROCEDIMIENTO DE TÃšNEL PARA LA COBERTURA RADICULAR SE INTRODUJO EN 1994 Y SE DENOMINÃ“ TÃ‰CNICA DE ENVOLTURA SUPRAPERIÃ“STICA. LA CARACTERÃ STICA DE ESTE PROCEDIMIENTO ES QUE LAS PAPILAS INTERDENTALES SE DEJAN INTACTAS.

LAS RECESIONES GINGIVALES SON EL DESPLAZAMIENTO APICAL DEL MARGEN GINGIVAL CON RESPECTO A LA UNIÃ“N CEMENTO-ESMALTE POR DIFERENTES CONDICIONES Y/O PATOLOGÃ AS. SE ASOCIAN PRINCIPALMENTE CON PÃ‰RDIDA DE INSERCIÃ“N CLÃ NICA Y EXPOSICIÃ“N DE LA SUPERFICIE RADICULAR AL MEDIO ORAL LO QUE PUEDE CAUSAR HIPERSENSIBILIDAD DENTARIA, PROBLEMAS ESTÃ‰TICOS Y MAYOR RIESGO DE CARIES/LESIONES CERVICALES NO CARIOSAS. LAS CAUSAS COMUNES INCLUYEN CEPILLADO DENTAL TRAUMÃ TICO, ENFERMEDAD PERIODONTAL, MAL POSICIÃ“N DENTARIA Y FACTORES ANATÃ“MICOS COMO UN BIOTIPO GINGIVAL DELGADO. Â[1]

LA CIRUGÃ A MUCOGINGIVAL ES UNA TÃ‰CNICA QUIRÃšRGICA UTILIZADA PARA CUBRIR SUPERFICIES RADICULARES QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTAS Y AUMENTAR EL GROSOR DE ENCÃ A. LA TÃ‰CNICA CONSISTE EN TOMAR UN FRAGMENTO DE TEJIDO CONECTIVO TOMADO DEL PALADAR Y COLOCARLO EN LA ZONA DE RECESIÃ“N. EXISTEN DIFERENTES TÃ‰CNICAS QUIRÃšRGICAS PARA LLEGAR AL RESULTADO. SE CONSIDERA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS MÃ S EFECTIVOS PARA LOGRAR COBERTURA RADICULAR Y MEJORAR LA ESTÃ‰TICA Y SALUD GINGIVAL. Â[2]-Â[3]

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINA CON LAS SIGLAS AFSM, 61 AÃ‘OS DE EDAD, AMA DE CASA, ESTADO CIVIL CASADA, PERSONALIDAD COOPERADORA. EL MOTIVO DE LA CONSULTA FUE â€œTENGO SENSIBILIDAD EN MIS DIENTESâ€. ESTADO FÃSICO CORRESPONDE A UN ASA II (DIABÃ‰TICA TIPO I) CONTROLADA, CON INSULINA LISPRO. SUS ANTECEDENTES PERIODONTALES Y TRAS SU EVALUACIÃ“N CLÃNICA SE LLEGÃ“ AL DIAGNÃ“STICO DE: PERIODONTITIS ESTADIO III, GRADO B LOCALIZADA, CON CONDICIONES Y DEFORMIDADES MUCOGINGIVALES RT 1 Y RT 2 SEGÃšN LA CLASIFICACIÃ“N DE CAIRO. Â¹

SE ANESTESIÃ“ CON TÃ‰CNICA DE BLOQUEO DEL NERVIO ALVEOLAR SUPERIOR POSTERIOR Y ANTERIOR CON LIDOCAÃNA Y EPINEFRINA AL 2%, SE REALIZARON INCISIONES INTRASULCULARES CON UNA HOJA DE BISTURÃ 15C DEL Ã“RGANO DENTAL 15 A 11. SE REALIZÃ“ UNA TUNELIZACIÃ“N SUBPERIÃ“STICA APICALMENTE DE DISTAL A MESIAL DE LOS Ã“RGANOS DENTALES MENCIONADOS, LIMITANDO LA BASE DE LA PAPILA, LIBERANDO Y DESPLAZANDO LOS TEJIDOS CORONALMENTE. SE DEBE TENER CUIDADO DE DESPEJAR EL TEJIDO MÃS ALLÃ DE LA LÃNEA MUCOGINGIVAL PARA OBTENER UN TÃšNEL SIN TENSIÃ“N QUE PERMITA LA INSERCIÃ“N DEL TEJIDO. SE TOMÃ“ EL INJERTO LIBRE DEL PALADAR QUE SE EXTENDIÃ“ DESDE EL ÃREA DEL CANINO HASTA LA TUBEROSIDAD PARA OBTENER UN INJERTO SUFICIENTEMENTE LARGO COMO PARA LOGRAR LA COBERTURA RADICULAR DE LOS Ã“RGANOS DENTALES INVOLUCRADOS, CON UN GROSOR DE 1 A 1.5 MM Y UN LARGO DE 17 MM.? EL INJERTO SE INSERTÃ“ EN EL TÃšNEL MEDIANTE UNA TÃ‰CNICA ESPECÃFICA DE SUTURAS SUSPENSORIAS Y DOUBLE CROSS?. LA PRIMERA SUTURA SE COLOCÃ“ EN LA PARTE MÃS DISTAL DE LA RECESIÃ“N Y LA AGUJA SALIÃ“ POR LA PARTE MÃS MEDIAL DE LA RECESIÃ“N. LA SEGUNDA SUTURA SE COLOCÃ“ EN EL LADO OPUESTO Y SALIÃ“ EN LA MISMA PARTE MEDIAL DE LA RECESIÃ“N.

EL INJERTO SOSTENIDO POR AMBAS SUTURAS (MESIAL Y DISTAL) SE MOVIÃ“ SUAVEMENTE HACIA EL TÃšNEL, DESLIZÃNDOLO DEBAJO DE LAS PAPILAS INTERDENTALES CON INSTRUMENTOS ESPECÃFICOS PARA ADAPTAR EL INJERTO. AMBAS SUTURAS SE CERRARON CON NUDOS PARA ESTABILIZAR EL INJERTO INSERTADO CUANDO EL INJERTO ALCANZÃ“ LA POSICIÃ“N DESEADA.

SE COLOCARON PUNTOS EN CRUZ EN LA ZONA DE LA TOMA DEL INJERTO CON NYLON 5-0. SE PASA LA SUTURA DESDE EL EXTREMO DISTAL EN LA PORCIÃ“N EXTERNA DEL COLGAJO DEL Ã“RGANO DENTAL 14. LA SUTURA SE VA PASANDO A TRAVÃ‰S DEL TÃšNEL, POR DEBAJO DE LAS PAPILAS INTERDENTARIAS HASTA EL Ã“RGANO DENTAL 13. SE ATRAVESÃ“ EL INJERTO EN MODO DE COLCHONERO HORIZONTAL Y SE DEVOLVIÃ“ LA SUTURA POR DEBAJO DE LAS PAPILAS, SUTURANDO CON PUNTO SIMPLE. SE REPITIÃ“ DESDE EL OTRO EXTREMO. SE COLOCARON PUNTOS SUSPENSORIOS EN Ã“RGANOS DENTALES 15 Y 11, DOUBLE CROSS EN Ã“RGANOS DENTALES 14, 13, 12 EN SUS DOS EXTREMOS MESIAL Y DISTAL, IGUALMENTE CON SUTURA NYLON 5-0. SE DIERON INDICACIONES POSTOPERATORIAS Y REVISIONES A LOS 3, 7, 15 Y 21 DÃAS.

Resultados y Conclusiones *

LA TÃ‰CNICA DE TÃšNEL SUBEPITELIAL CON INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO Y EL USO COMBINADO DE SUTURAS SUSPENSORIAS Y DOUBLE CROSS DE ZUHR DEMOSTRÃ“ SER UNA OPCIÃ“N EFECTIVA PARA EL TRATAMIENTO DE RECESIONES GINGIVALES MÃšLTIPLES EN UN PACIENTE CON DIABETES TIPO 1 CONTROLADA. LA CUIDADOSA MANIPULACIÃ“N DE LOS TEJIDOS JUNTO CON LA ELECCIÃ“N DE UNA TÃ‰CNICA MÃ NIMAMENTE INVASIVA Y DE ALTA PRECISIÃ“N, PERMITIÃ“ LOGRAR UNA ADECUADA ESTABILIZACIÃ“N DEL INJERTO. ESTÃ TÃ‰CNICA FAVORECIÃ“ UNA CICATRIZACIÃ“N PREDECIBLE SIN COMPROMETER LA VASCULARIZACIÃ“N. DICHO ENFOQUE QUIRÃšRGICO NO SOLO MEJORÃ“ LA COBERTURA RADICULAR, SINO LA ESTÃ‰TICA Y EL CONFORT DEL PACIENTE DE LA CUAL PODEMOS DESTACAR SU APLICABILIDAD INCLUSO EN PACIENTES SISTÃ‰MICAMENTE COMPROMETIDOS.

Bibliografía *

1. CAIRO F. PERIODONTAL PLASTIC SURGERY OF GINGIVAL RECESSIONS AT SINGLE AND MULTIPLE TEETH. PERIODONTOL 2000. 2017;75(1):296â€“316

2. ZUCCHELLI G, MOUNSSIF I. PERIODONTAL PLASTIC SURGERY. PERIODONTOLOGY 2000. 2015;68(1):333â€“368. HTTPS://DOI.ORG/10.1111/PRD.12059

3. CORTELLINI P, BISSADA NF. MUCOGINGIVAL CONDITIONS IN THE NATURAL DENTITION: NARRATIVE REVIEW, CASE DEFINITIONS, AND DIAGNOSTIC CONSIDERATIONS. J PERIODONTOL. 2018;89(SUPPL 1):S204â€“S213. HTTPS://DOI.ORG/10.1002/JPER.16-0671

4. TAVELLI L, BAROOTCHI S, RAVIDÃ€ A, OH TJ, WANG HL. WHAT IS THE SAFETY ZONE FOR PALATAL SOFT TISSUE GRAFT HARVESTING BASED ON THE LOCATIONS OF THE GREATER PALATINE ARTERY AND FORAMEN? A SYSTEMATIC REVIEW. J ORAL MAXILLOFAC SURG. 2019;77(2):271.E1â€“271.E9. HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.JOMS.2018.10.002

5. ZUHR O, REBELE SF, THALMAIR T, FICKL S, HÃœRZELER MB. A MODIFIED SUTURE TECHNIQUE FOR PLASTIC PERIODONTAL AND IMPLANT SURGERY--THE DOUBLE-CROSSED SUTURE. EUR J ESTHET DENT. 2009 WINTER;4(4):338-47. PMID: 20111759.

Título del trabajo *

COBERTURA RADICULAR MEDIANTE TÃ‰CNICA DE TÃšNEL Y COLGAJO CORONALMENTE AVANZADO MODIFICADO CON INCISIONES TRAPEZOIDALES E INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO

Nombre del Autor (a/es)*

NÃºÃ±ez RodrÃ-guez Jessy SofÃ-a

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Umanzor Vilma Alejandra, Ã□vila Alvarado SarahÃ-, SabillÃ³n Ellner Karen, , , , , , .

Correo Electrónico *

jessysofian97@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD CATÃ“LICA DE HONDURAS

Introducción y Objetivos *

LAS RECESIONES GINGIVALES SE DEFINEN COMO LA EXPOSICIÃ“N DE LA SUPERFICIE RADICULAR DEBIDO A LA MIGRACIÃ“N APICAL DEL MARGEN GINGIVAL CON RELACIÃ“N A LA UNIÃ“N CEMENTO ESMALTE. LA TÃ‰CNICA DE COLGAJO AVANZADO CORONAL TIPO TÃšNEL (TCAF) EN COMBINACIÃ“N CON UN INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO AUTÃ“LOGO (CTG), PERMITE LOGRAR UNA COBERTURA RADICULAR EFICAZ MÃ NIMAMENTE INVASIVA. LA INCORPORACION DE INCISIONES TRAPEZOIDALES PERMITE MEJORAR EL ACCESO QUIRÃšRGICO Y LA LIBERACIÃ“N DEL COLGAJO SIN COMPROMETER LA VASCULARIZACIÃ“N, ESPECIALMENTE ÃšTIL EN FENOTIPOS DELGADOS O RECESIONES EXTENSAS.

OBJETIVO:

DESCRIBIR LA APLICACIÃ“N DE UNA TÃ‰CNICA COMBINADA QUE INTEGRA TÃšNEL, COLGAJO CORONALMENTE AVANZADO MODIFICADO CON INCISIONES TRAPEZOIDALES E INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO, APLICADA EN UN PACIENTE CON RECESIONES MÃšLTIPLES EN EL SECTOR ANTEROINFERIOR.

Descripción del Caso *

PACIENTE MASCULINO DE 44 AÃ‘OS ACUDE AL SERVICIO DE PERIODONCIA DEL HOSPITAL ODONTOLÃ“GICO DE LA UNIVERSIDAD CATÃ“LICA DE HONDURAS, SIN ANTECEDENTES SISTÃ‰MICOS.

A LA EXPLORACIÃ“N CLÃ?NICA SE IDENTIFICA ENCÃ?A QUERATINIZADA REDUCIDA Y RECESIONES GINGIVALES MÃšLTIPLES LOCALIZADAS EN LAS PIEZAS 31 Y 41 CLASIFICADAS COMO RT2 Y EN LAS PIEZAS 34 - 44 COMO RT1 SEGÃšN LA CLASIFICACIÃ“N DE CAIRO. DIAGNOSTICADO CON SALUD PERIODONTAL EN PERIODONTO REDUCIDO.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS:

EL CONTROL POSTOPERATORIO INMEDIATO PRESENTÃ“ COBERTURA RADICULAR COMPLETA Y ADAPTACIÃ“N PRECISA DE LOS MÃ RGENES, SIN EXPOSICIÃ“N DEL INJERTO. A LOS 15 DÃ AS, SE OBSERVÃ“ PERSISTENCIA DE EDEMA Y ERITEMA MARGINAL, CON ADECUADA ESTABILIDAD DEL COLGAJO Y MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA RADICULAR. LA PERSISTENCIA DEL EDEMA SE ATRIBUYÃ“, ADEMÃ S DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA PROPIA DE LA FASE TEMPRANA DE CICATRIZACIÃ“N, A LA POSIBLE INFLUENCIA DE FACTORES MECÃ NICOS NO CONTROLADOS QUE INCIDIERON SOBRE EL Ã REA INTERVENIDA DURANTE EL PERIODO POSTOPERATORIO.

CONCLUSIONES: LA TÃ‰CNICA TCAF FUE ADAPTADA EXITOSAMENTE A UN CONTEXTO MÃ S COMPLEJO, RESPETANDO LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA TERAPIA MUCOGINGIVAL: PRESERVACIÃ“N DE PAPILAS, COBERTURA COMPLETA DEL INJERTO Y AVANCE CORONAL SIN TENSIÃ“N.

Bibliografía *

1. CAIRO F. PERIODONTAL PLASTIC SURGERY OF GINGIVAL RECESSIONS AT SINGLE AND MULTIPLE TEETH.Â PERIODONTOL 2000. 2017;75(1):296â€“316.

2. ZUCCHELLI G, MOUNSSIF I. PERIODONTAL PLASTIC SURGERY.Â PERIODONTOL 2000. 2015;68(1):333â€“68.

3. BAROOTCHI S, TAVELLI L. TUNNELED CORONALLY ADVANCED FLAP FOR THE TREATMENT OF ISOLATED GINGIVAL RECESSIONS WITH DEFICIENT PAPILLA.Â INT J ESTHET DENT. 2022;17(1):14â€“26.

4. MAZZOTTI C, MOUNSSIF I, RENDÃ“N A, ET AL. COMPLICATIONS AND TREATMENT ERRORS IN ROOT COVERAGE PROCEDURES. PERIODONTOL 2000. 2023;92:62-89.

5. STEFANINI M, MARZADORI M, AROCA S, FELICE P, SANGIORGI M, ZUCCHELLI G. DECISION MAKING IN ROOT-COVERAGE PROCEDURES FOR THE ESTHETIC OUTCOME.Â PERIODONTOL 2000. 2018;77(1):54â€“64.

Título del trabajo *

ALARGAMIENTO DE CORONA ESTÃ‰TICO EN UNA PACIENTE CON DIAGNÃ“STICO DE ERUPCIÃ“N PASIVA ALTERADA

Nombre del Autor (a/es)*

CortÃ©s Castro Ana Raquel

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Dra.Umanzor Vilma Alejandra, Dra. Sabillon Ellner Karen, , , , , , , .

Correo Electrónico *

nitacortes03@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD CATÃ“LICA DE HONDURAS "NUESTRA SEÃ‘ORA R

Introducción y Objetivos *

INTRODUCCIÃ“N: EL ALARGAMIENTO DE CORONA ES UN PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO COMÃšN, QUE SE REALIZA CON EL PROPÃ“SITO DE MEJORAR LAS EXIGENCIAS ESTÃ‰TICAS DEL PACIENTE, POR EJEMPLO: CUANDO HAY UNA EXPOSICIÃ“N GINGIVAL EXCESIVA AL SONREÃ R O CUANDO EL AUMENTO DE LA ENCÃ A IMPIDE UNA HIGIENE BUCAL ADECUADA, O CUANDO ES NECESARIO FACILITAR LA ODONTOLOGÃ A RESTAURADORA. (1)

LA EXPOSICIÃ“N GINGIVAL EXCESIVA TAMBIÃ‰N, CONOCIDA COMO â€œSONRISA GINGIVALâ€ , SE HA DEFINIDO USUALMENTE COMO UNA EXPOSICIÃ“N GINGIVAL DE 4 O MAS MM DURANTE LA SONRISA. ESTA PUEDE ESTAR ASOCIADA A FACTORES COMO SER UNA SONRISA ALTA, HIPERMOVILIDAD DEL LABIO SUPERIOR, DIFERENCIAS RACIALES, SEXO; SIENDO ESTE MÃ S COMÃšN EN LAS MUJERES, ERUPCIÃ“N PASIVA ALTERADA, LABIO SUPERIOR CORTO, AGRANDAMIENTO GINGIVAL PRODUCIDO POR MEDICAMENTOS, EXTRUSIÃ“N DENTOALVEOLAR SUPERIOR O EXCESO VERTICAL MAXILAR. (2)(3)(4).

LA ERUPCIÃ“N DENTAL CONSTA DE DOS PARTES: EN LA ERUPCIÃ“N ACTIVA SE DA LA ERUPCIÃ“N CLÃ NICA DE LOS DIENTES HASTA ALCANZAR SU POSICIÃ“N EN CAVIDAD ORAL, POR OTRO LADO, EN LA ERUPCIÃ“N PASIVA LA UNIÃ“N EPITELIAL LOCALIZADA ALREDEDOR DE LOS DIENTES MIGRA EN DIRECCIÃ“N APICAL DESDE LA CORONA HASTA CONSEGUIR UNA POSICIÃ“N ESTABLE UN TANTO CORONAL A LA UNIÃ“N CEMENTO-ESMALTE (UCE). UN SIGNO CLÃ NICO COMÃšN DE LA ERUPCIÃ“N PASIVA ALTERADA ES UNA CORONA CLÃ NICA CORTA CONSECUENCIA DE LA UBICACIÃ“N DEL TEJIDO GINGIVAL CON RELACIÃ“N A LA UNIÃ“N CEMENTO-ESMALTE (UCE). (5).

EL DIAGNOSTICO SE PUEDE REALIZAR POR MEDIO DE CALIBRES ESTÃ‰TICOS CHU, TOMA DE RADIOGRAFÃ AS PERIAPICALES, USO DE TOMOGRAFÃ A COMPUTARIZADA DE HAZ CÃ“NICO, MIDIENDO EL ANCHO DE LA ENCÃ A QUERATINIZADA A TRAVÃ‰S DE SONDAS MILIMETRADAS UNC 15 Y MIDIENDO LAS CORONAS CLÃ NICAS DE LOS DIENTES.

OBJETIVO: OBTENER UNA CORRECTA INSERCIÃ“N DE LOS TEJIDOS SUPRACRESTALES Y CREAR ARMONÃ A Y ESTÃ‰TICA EN LOS TEJIDOS PERIODONTALES.

Descripción del Caso *

SE PRESENTA AL HOSPITAL ODONTOLÃ“GICO â€œMONSEÃ‘OR AGUSTÃ□N HOMBACHâ€□ DE LA UNIVERSIDAD CATÃ“LICA DE HONDURAS, PACIENTE FEMENINA DE 21 AÃ‘OS, REFERIDA DE LA ESPECIALIDAD DE ORTODONCIA POR PRESENCIA DE LONGITUD INADECUADA DE CORONA CLÃ□NICA PARA COLOCACIÃ“N DE APARATOLOGÃ□A. DESPUÃ‰S DE ANALIZAR LA HISTORIA CLÃ□NICA Y REALIZAR ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS COMO SER CBCT SE LLEGÃ“ AL DIAGNOSTICO DE ERUPCIÃ“N PASIVA ALTERADA TIPO 1 SUBGRUPO B SEGÃšN LA CLASIFICACIÃ“N DE COSLET ET AL, ADEMAS DE PRESENTAR UN FRENILLO LABIAL SUPERIOR CON INSERCIÃ“N PAPILAR SEGÃšN LA CLASIFICACIÃ“N DE PLACEK FORMANDO UN DIASTEMA ENTRE LOS INCISIVOS CENTRALES SUPERIORES. LA PACIENTE REFIERE UN PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO PREVIO, REALIZADO EN UNA CLÃ□NICA PRIVADA, EN EL CUAL NO SE OBTUVIERON LOS RESULTADOS DESEADOS.

Resultados y Conclusiones *

PROCEDIMIENTO:

DESPUÃ‰S DE LA EVALUACIÃ“N CLÃ□NICA COMPETENTE Y DE OBTENER EL DIAGNÃ“STICO, LA PACIENTE SE SOMETIÃ“ A CONTROL DE PLACA BACTERIANA E INSTRUCCIONES DE HIGIENE ORAL. EL DIAGNÃ“STICO DE ERUPCIÃ“N PASIVA ALTERADA LLEVÃ“ A LA DECISIÃ“N DE REALIZAR UN ALARGAMIENTO DE CORONA ESTÃ‰TICO EN LAS PIEZAS DENTALES AFECTADOS OD. 15-25 Y 33-43 ASÃ□ COMO A REALIZAR UNA FRENECTOMÃ□A PARA FUTURO CIERRE DE DIASTEMA POR MEDIO DE TRATAMIENTO DE ORTODONCIA.

EL PROCEDIMIENTO SE LLEVÃ“ A CABO BAJO ANESTESIA LOCAL (ARTICAÃ□NA AL 0.4%), POSTERIOR A LA ASEPSIA CON ENJUAGUE DE CLORHEXIDINA AL 0.12% SE MARCARON LOS PUNTOS SANGRANTES. CON AYUDA DE BISTURÃ□ 15C SE REALIZÃ“ UNA INCISIÃ“N A BISEL INTERNO, LUEGO CAMBIANDO LA HOJA DE BISTURÃ□ A UNA CON FILO SE CONTINUÃ“ CON LA INCISIÃ“N INTRASURCAL EN TODOS LOS DIENTES A TRATAR.

EN ESTE CASO SE REMOVIERON CUIDADOSAMENTE APROXIMADAMENTE 2 MM DE TEJIDO GINGIVAL DE CADA DIENTE IMPLICADO, INICIANDO EN EL CUADRANTE I Y TERMINANDO EN EL CUADRANTE II EN LA PRIMERA CITA Y EN LA SEGUNDA CITA CONTINUANDO CON LOS CUADRANTES III Y IV.

UNA VEZ LLEGADO AL RESULTADO ESPERADO SE REFLEJÃ“ UN COLGAJO DE ESPESOR TOTAL Y SE PROCEDIÃ“ CON LA OSTEOTOMÃ□A Y OSTEOPLASTÃ□A HASTA LLEGAR A LOS 3MM ENTRE LA CRESTA Ã“SEA Y LA UNIÃ“N CEMENTO-ESMALTE.

SE REALIZARON SUTURAS SIMPLES CON HILO NYLON 5-0 Y A CONTINUACIÃ“N, LE FUERON BRINDADAS LAS INDICACIONES POSOPERATORIAS ADECUADAS. SE EVALUÃ“ A LA PACIENTE A LOS 7, 14 Y 21 DÃ□AS SIGUIENTES Y SE RETIRARON LOS PUNTOS A LOS 7 DÃ□AS DE LA CIRUGÃ□A.

RESULTADOS:

LOS RESULTADOS POSOPERATORIOS DE LA CIRUGÃ□A FUERON FAVORABLES: SE LOGRÃ“ ESTABILIDAD DE LOS TEJIDOS, Y LA PACIENTE REFIERE MAYOR CONFIANZA AL MOMENTO DE SONREÃ□R Y SENTIRSE SATISFECHA CON LA CIRUGÃ□A.

PACIENTE A LA ESPERA DE LA COLOCACIÃ“N DE SU APARATOLOGÃ□A DE ORTODONCIA.

Bibliografía *

1. GONZÃ□LEZ-MARTÃ□N O, CARBAJO G, RODRIGO M, MONTERO E, SANZ M. ONE- VERSUS TWO-STAGE CROWN LENGTHENING SURGICAL PROCEDURE FOR AESTHETIC RESTORATIVE PURPOSES: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. J CLIN PERIODONTOL 2020;47:1511â€“21. HTTPS://DOI.ORG/10.1111/JCPE.13375.

2. TATAKIS DN, SILVA CO. CONTEMPORARY TREATMENT TECHNIQUES FOR EXCESSIVE GINGIVAL DISPLAY CAUSED BY ALTERED PASSIVE ERUPTION OR LIP HYPERMOBILITY. J DENT 2023;138:104711. HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.JDENT.2023.104711.

3. ANDIJANI RI, TATAKIS DN. HYPERMOBILE UPPER LIP IS HIGHLY PREVALENT AMONG PATIENTS SEEKING TREATMENT FOR GUMMY SMILE. J PERIODONTOL 2019;90:256â€“62. HTTPS://DOI.ORG/10.1002/JPER.18-0468.

4. TATAKIS DN, PARAMITHA V, LU W-E, GUO X. UPPER LIP CHARACTERISTICS AND ASSOCIATED EXCESSIVE GINGIVAL DISPLAY ETIOLOGIES IN ADULTS: RACE AND SEX DIFFERENCES. J PERIODONTOL 2024;95:74â€“83. HTTPS://DOI.ORG/10.1002/JPER.23-0291.

5. OBIECHINA N. ESTHETIC CROWN LENGTHENING: A REVIEW. JOURNAL OF DENTAL HEALTH AND ORAL RESEARCH 2024:1â€“3. HTTPS://DOI.ORG/10.46889/JDHOR.2024.5106.

Título del trabajo *

AGENESIA DE CANINOS Y RIZÃ“LISIS SEVERA: ENFOQUE INTEGRAL

Nombre del Autor (a/es)*

Martha Elena Herrera Real

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

D.C.F Dora MarÃ-a LÃ³pez Trujillo, D.C.F Lizeth Alejandra Reyes Alvarado, D.C.F Sergio Favela Flores, M.C.O Marco Antonio MartÃ-nez MartÃ-nez, , , , , .

Correo Electrónico *

martha.herrera@uadec.edu.mx

Institución *

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA UNIDAD TORREON

Introducción y Objetivos *

LA AGENESIA DE CANINOS PERMANENTES SUPERIORES ES UNA ANOMALÃ□A DEL DESARROLLO POCO FRECUENTE QUE PUEDE COMPROMETER LA ESTÃ‰TICA, FUNCIÃ“N Y ESTABILIDAD DE LA OCLUSIÃ“N. CUANDO ESTA CONDICIÃ“N SE ENCUENTRA PRESENTE PUEDE OCASIONAR REABSORCIÃ“N RADICULAR EXTERNA DE LOS DIENTES LATERALES, CONDICIÃ“N ASOCIADA CON UN PROCESO FISIOLO?GICO O PATOLO?GICO QUE RESULTA DE UN PROCESO ACTIVO Y DESTRUCTIVO DE LOS TEJIDOS DUROS DEL DIENTE, PRODUCIDO POR ODONTOCLASTOS Y CEMENTOCLASTOS, CUYO RESULTADO ES LA PE?RDIDA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE DICHOS TEJIDOS EN UNA PE?RDIDA DE DENTINA O CEMENTO, EN INCISIVOS SUPERIORES REPRESENTA UN DESAFÃ□O CLÃ□NICO COMPLEJO.

EL OBJETIVO DE LA DIFUSIÃ“N DE ESTE TIPO DE CASO CLÃ□NICO ES PRESENTAR UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO PARA EL TRATAMIENTO DE ESTA CONDICIÃ“N MEDIANTE LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES DENTALES EN LA ZONA ANTEROSUPERIOR, CON ENFOQUE QUIRÃšRGICO Y PERIODONTAL.

Descripción del Caso *

PACIENTE MASCULINO DE 43 AÃ‘OS, SISTEMÃ□TICAMENTE SANO, ACUDE POR MOTIVO ESTÃ‰TICO Y FUNCIONAL. EL EXAMEN CLÃ□NICO-RADIOGRÃ□FICO REVELÃ“ AGENESIA BILATERAL DE CANINOS PERMANENTES MAXILARES, CON PRESENCIA DE REABSORCIÃ“N RADICULAR EXTERNA SEVERA EN INCISIVOS CENTRALES Y LATERALES DE GRADO 4 LA CUAL SE EXTIENDE MÃ□S ALLÃ□ DE 1/3 DE LA LONGITUD ORIGINAL DE LA RAI?Z SEGU?N LEVANDER Y MALMGREN (1988) Y TRACTO SINUOSO EN EL Ã“RGANO DENTARIO 2.2. EL DIAGNÃ“STICO SE COMPLEMENTÃ“ MEDIANTE ORTOPANTOMOGRAFÃ□A Y TOMOGRAFÃ□A DEL MAXILAR. SE DIAGNOSTICÃ“: CASO DE AGENESIA DENTAL CON COMPROMISO ESTRUCTURAL SEVERO DE LOS DIENTES LATERALES ANTERIORES.

SE REALIZÃ“ LA EXODONCIA ATRAUMÃ□TICA DE LATERAL IZQUIERDO CON REABSORCIÃ“N RADICULAR EXTERNA GRADO 4, DESINFECCIÃ“N DEL ALVEOLO CON METRONIDAZOL 5 MG, CON COLOCACIÃ“N INMEDIATA DE IMPLANTE CON GUÃ□A QUIRÃšRGICA PERSONALIZADA DE 3.5 X 11.5 MM Y COMBINÃ□NDOLO CON UN INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO CON TÃ‰CNICA DE TUNELIZACIÃ“N Y PROVISIONALIZACIO?N INMEDIATA. DURANTE LA CIRUGÃ□A SE REALIZÃ“ DE PRESERVACIÃ“N ALVEOLAR Y MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS. POSTERIOR A 10 MESES SE HIZO EXODONCIA ATRAUMÃ□TICA DE LATERAL DERECHO SUPERIOR CON REABSORCIÃ“N RADICULAR EXTERNA GRADO 4, CON COLOCACIÃ“N INMEDIATA DE IMPLANTE CON GUÃ□A QUIRÃšRGICA PERSONALIZADA DE 3.5 X 13 MM, RELLENANDO EL ESPACIO PERIIMPLANTARIO VESTIBULAR CON ALOINJERTO Ã“SEO Y COMBINÃ□NDOLO CON UN INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO Y PROVISIONALIZACIO?N INMEDIATA. DESPUÃ‰S DE 9 MESES SE REALIZA LA EXODONCIA DE LOS CENTRALES SUPERIORES Y SE COLOCA PRF EN ZONA DE ALVEOLOS CON INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO PEDICULADO.

SE CONFECCIONÃ“ UN PROVISIONAL DE ACRÃ□LICO TIPO MARYLAND EN ZONA DE CENTRALES SUPERIORES UNA SEMANA POSTERIOR A LA CIRUGÃ□A PASADOS LOS VEINTE DÃ□AS SE REALIZÃ“ EL PUENTE PROVISIONAL DE LAS CUATRO UNIDADES Y A LOS SESENTA DÃ□AS SE CEMENTA LA PRÃ“TESIS DEFINITIVA SOBRE IMPLANTES DE 4 UNIDADES.

LA FASE PROTÃ‰SICA CONSISTIÃ“ EN REHABILITACIÃ“N CON CORONAS ATORNILLADAS EN ZIRCONIA. EL MANEJO POSTOPERATORIO INCLUYÃ“ CONTROL PERIODONTAL Y SEGUIMIENTO MEDIANTE TOMOGRAFÃ□A.

Resultados y Conclusiones *

LA AGENESIA DE CANINOS SUPERIORES ASOCIADA A RESORCIÃ“N RADICULAR SEVERA EN DIENTES ANTERIORES REQUIERE UN ENFOQUE DIAGNÃ“STICO PRECISO Y UNA PLANIFICACIÃ“N QUIRÃšRGICO-PROTÃ‰SICA DETALLADA. EL TRATAMIENTO CON IMPLANTES DENTALES, CON ABORDAJE PERIODONTAL INTEGRAL, PERMITE UNA REHABILITACIÃ“N PREDECIBLE, FUNCIONAL Y ESTÃ‰TICA EN PACIENTES JÃ“VENES-ADULTOS. EL PAPEL DEL PERIODONCISTA ES CLAVE EN EL MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS Y LA INTEGRACIÃ“N BIOLÃ“GICA A LARGO PLAZO.

LOS AUTORES DECLARAN NO TENER NINGÃšN CONFLICTO DE INTERÃ‰S.

Bibliografía *

1. MURAKAMI S, , MEALEY, BL, MARIOTTI, A, CHAPPLE, ILC. DENTAL PLAQUEâ€“INDUCED GINGIVAL CONDITIONS. J CLIN PERIODONTOL. 2018; 45(SUPPL20): S17â€“ S27. HTTPS://DOI.ORG/10.1111/JCPE.12937

2. MISCH, C. E. (2015). IMPLANTOLOGÃ□A CONTEMPORÃ□NEA (3.Âª ED.). ELSEVIER ESPAÃ‘A.

3. GUARDADO PAE, CASTRO SGY, ROCHA LA, ET AL. REABSORCIÃ“N RADICULAR EN Ã“RGANOS DENTALES CON ANTECEDENTES DE TRAUMATISMO. REV TAME. 2020;8.9(26):1060-1062.

4. CLASIFICACIÃ“N DEL Ã□LVEOLO POST EXTRACCIÃ’N. BALTAZAR A; RODRIGUEZ J; GARZA M; MARTINEZ G; NAKAGOSHI M; NAKAGOSHI S. IMPLANTOLOGÃ□A ACTUAL. NO. 37, 2020

5. COUNIHAN, K., AL-AWADHI, E. A., & BUTLER, J. (2013). GUIDELINES FOR THE ASSESSMENT OF THE IMPACTED MAXILLARY CANINE. DENTAL UPDATE, 40(9), 770â€“777.

6. MEHTA H, SHAH S. MANAGEMENT OF BUCCAL GAP AND RESORPTION OF BUCCAL PLATE IN IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT: A CLINICAL CASE REPORT. J INT ORAL HEALTH. 2015;7(SUPPL 1):72-5. PMID: 26225110; PMCID: PMC4516068.

Título del trabajo *

MANEJO QUIRÃšRGICO MUCOGINGIVAL MEDIANTE PROFUNDIZACIÃ“N VESTIBULAR E INJERTO GINGIVAL LIBRE EN PACIENTE CON RECESIÃ“N TIPO RT1 Y RT2

Nombre del Autor (a/es)*

LARA ROQUE, LILIAM LARISSA

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

AVILA ALVARADO, ANGELICA SARAHI, BONILLA UMANZOR, VILMA ALEJANDRA, , , , , , , .

Correo Electrónico *

larissalara.lllr@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS "NUESTRA SEÃ‘ORA R

Introducción y Objetivos *

LA PRESENCIA DE UNA INSERCIÃ“N MUCOGINGIVAL DESFAVORABLE EN LA REGIÃ“N ANTERIOR MANDIBULAR PUEDE REPRESENTAR UN DESAFÃ□O CLÃ□NICO SIGNIFICATIVO, ESPECIALMENTE CUANDO SE ACOMPAÃ‘A DE SINTOMATOLOGÃ□A DOLOROSA, RECESIONES GINGIVALES Y ESCASA ENCÃ□A QUERATINIZADA. ESTAS CONDICIONES COMPROMETEN LA ESTABILIDAD PERIODONTAL, DIFICULTAN LA HIGIENE ORAL Y PUEDEN INTERFERIR EN TRATAMIENTOS ORTODÃ“NTICOS FUTUROS.

LA LITERATURA ACTUAL, RESPALDADA POR ENSAYOS CLÃ□NICOS ALEATORIZADOS, APOYA EL USO COMBINADO DE VESTIBULOPLASTIA E INJERTO GINGIVAL LIBRE (FGG) COMO UNA ESTRATEGIA QUIRÃšRGICA EFECTIVA PARA RESTABLECER LA ARQUITECTURA MUCOGINGIVAL (1,2,3), AUMENTAR LA PROFUNDIDAD DEL VESTÃ□BULO Y MEJORAR EL FENOTIPO GINGIVAL. LA TÃ‰CNICA, ESPECIALMENTE EN LA ZONA ANTEROINFERIOR, PERMITE CREAR CONDICIONES FAVORABLES PARA LA PREVENCIÃ“N DE RECESIONES PROGRESIVAS Y MEJORA EL CONFORT FUNCIONAL DEL PACIENTE (4,5).

OBJETIVO: PRESENTAR EL ABORDAJE QUIRÃšRGICO MUCOGINGIVAL EN UNA PACIENTE CON RECESIÃ“N GINGIVAL TIPO RT1 Y RT2, MEDIANTE PROFUNDIZACIÃ“N VESTIBULAR E INJERTO GINGIVAL LIBRE, COMO PARTE DE UN MANEJO INTEGRAL PREVIO A ORTODONCIA.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINA DE 35 AÃ‘OS, PROCEDENTE DE TEGUCIGALPA, DOCENTE, SIN ANTECEDENTES SISTÃ‰MICOS RELEVANTES. CONSULTÃ“ POR MOVILIDAD EN EL DIENTE 4.1, ACOMPAÃ‘ADA DE DOLOR AL CEPILLARSE. A LA EVALUACIÃ“N CLÃ□NICA SE OBSERVÃ“ INSERCIÃ“N ALTA DEL FRENILLO, ENCÃ□A DELGADA Y QUERATINIZADA INSUFICIENTE EN REGIÃ“N ANTEROINFERIOR, ADEMÃ□S DE UNA REDUCIDA PROFUNDIDAD VESTIBULAR.

EL PERIODONTOGRAMA Y LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS REVELARON RECESIÃ“N TIPO RT2 EN EL DIENTE 3.1 (-4 MM) Y RT1 EN EL 4.1 (-5 MM), CON SANGRADO AL SONDAJE Y PÃ‰RDIDA LEVE DE INSERCIÃ“N SIN PRESENCIA DE BOLSAS ACTIVAS. SE ESTABLECIÃ“ EL DIAGNÃ“STICO DE GINGIVITIS INDUCIDA POR BIOPELÃ□CULA LOCALIZADA, CON CONDICIONES Y DEFORMIDADES MUCOGINGIVALES ASOCIADAS.

Resultados y Conclusiones *

EL CONTROL CLÃ?NICO A CORTO PLAZO DEMOSTRÃ“ UNA ADECUADA CICATRIZACIÃ“N, CON GANANCIA SIGNIFICATIVA DE ENCÃ?A QUERATINIZADA (1,3,5) (>3 MM) Y UNA PROFUNDIDAD VESTIBULAR FUNCIONAL. LA PACIENTE REFIRIÃ“ ALIVIO DEL DOLOR, DISMINUCIÃ“N DE LA MOVILIDAD EN EL DIENTE 4.1 Y MAYOR COMODIDAD AL REALIZAR LA HIGIENE ORAL.

CONCLUSIONES:

EL MANEJO QUIRÃšRGICO MEDIANTE VESTIBULOPLASTIA COMBINADA CON INJERTO GINGIVAL LIBRE REPRESENTÃ“ UNA OPCIÃ“N SEGURA Y EFICAZ EN ESTE CONTEXTO CLÃ?NICO, PERMITIENDO RESTABLECER CONDICIONES PERIODONTALES ESTABLES EN UNA ZONA DE ALTA EXIGENCIA FUNCIONAL. ESTA INTERVENCIÃ“N OFRECE UNA BASE PREDECIBLE PARA LA FUTURA REHABILITACIÃ“N ORTODÃ“NTICA Y REFUERZA LA IMPORTANCIA DE UN ENFOQUE PREVENTIVO-INTEGRAL EN PERIODONCIA.

Bibliografía *

1. CARCUAC O, ET AL. MODIFIED FREE GINGIVAL GRAFT VS CONVENTIONAL FGG IN RT2 RECESSIONS OF MANDIBULAR INCISORS: 12?MONTH RCT. J PERIODONTOL. 2023;94(6):722â€“730.

2. WYR?BEK B, ET AL. PROSPECTIVE STUDY OF KAZANJIAN VESTIBULOPLASTY IN MANDIBULAR INCISORS. ADV CLIN EXP MED. 2021;30(7):681â€“690.

3. FU X, ET AL. VESTIBULOPLASTY WITH FGG VS COLLAGEN MATRIX: PATIENT PERCEPTION & GAIN OF KTW. INT J IMPLANT DENT. 2021;7(1):76.

4. CHETANA, SIDHARTHAN S, DHARMARAJAN G, KALE S, DHARMADHIKARI S, CHORDIA D. COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF GINGIVAL UNIT TRANSFER AND FREE GINGIVAL GRAFT IN THE MANAGEMENT OF LOCALIZED GINGIVAL RECESSION â€“ A SYSTEMATIC REVIEW. J ORAL BIOL CRANIOFAC RES. 2023 MAR APR;13(2):130â€“137. DOI:10.1016/J.JOBCR.2022.11.007.

5. RAMANAUSKAITE A, ET AL. LONG-TERM OUTCOMES OF FGG VS COLLAGEN MATRIX FOR KERATINIZED TISSUE. CLIN ORAL INVESTIG. 2023;27(2):419â€“430

Título del trabajo *

ALARGAMIENTO DE CORONA EN ZONA ESTÃ‰TICA POR ERUPCIÃ“N PASIVA ALTERADA TIPO IB.

Nombre del Autor (a/es)*

Ortiz Roque Josue Mauricio

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Umanzor Vilma Alejandra, Ã vila Alvarado Angelica Sarahi, Rodriguez VÃ¡squez Ana Gabriela, , , , , , .

Correo Electrónico *

josueortizroque89@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD CATÃ“LICA DE HONDURAS"NUESTRA SEÃ‘ORA RE

Introducción y Objetivos *

INTRODUCCION

EL EXCESO GINGIVAL HA SIDO RECONOCIDO POR LA ACADEMIA AMERICANA DE PERIODONCIA COMO UNA DEFORMIDAD MUCOGINGIVAL ALREDEDOR DE LOS DIENTES. VARIAS CONDICIONES PUEDEN RESULTAR EN LA EXHIBICIÃ“N EXCESIVA DE ENCÃ?AS, INCLUYENDO PSEUDO-BOLSAS CAUSADAS POR GINGIVITIS, AGRANDAMIENTO GINGIVAL INDUCIDO POR MEDICAMENTOS Y ERUPCIÃ“N PASIVA ALTERADA DE LOS DIENTES. ESTAS PRESENTACIONES CLÃ?NICAS PUEDEN LLEVAR A LOS PACIENTES A BUSCAR TRATAMIENTO PARA ABORDAR PROBLEMAS ESTÃ‰TICOS Y/O FUNCIONALES: GOLDMAN Y COHEN DEFINIERON LA ERUPCIÃ“N PASIVA ALTERADA O RETARDADA COMO UNA SITUACIÃ“N EN LA QUE EL MARGEN GINGIVAL EN EL ADULTO SE LOCALIZA INCISAL A LA CONVEXIDAD CERVICAL DE LA CORONA Y SE ALEJA DE LA UNIÃ“N CEMENTO-ESMALTE DEL DIENTE GENERANDO UNA EXPOSICIÃ“N GINGIVAL ?4 MM DESDE EL LABIO SUPERIOR AL MARGEN GINGIVAL.

OBJETIVO

REPOSICIÃ“N DE LOS TEJIDOS GINGIVALES Y Ã“SEOS EN POSICIONES ANATÃ“MICAS CORRECTOS PARA UNA ARMONÃ?A ESTÃ‰TICA DENTAL Y FACIAL.

Descripción del Caso *

PACIENTE DE FEMENINO DE 18 AÃ‘OS DE EDAD SIN COMPROMISOS SISTÃ‰MICOS PRESENTO AL HOSPITAL ODONTOLOGÃ□A MONSEÃ‘OR AGUSTÃ□N HOMBACH DIFERIDO DEL Ã□REA DE ORTODONCIA PARA LA COLOCACIÃ“N DE ALINEADORES REMOVIBLES CON REFERENCIA EN QUE LAS CORONAS CLÃ□NICAS NO SON LAS ADECUADAS PARA DICHOS APARATOS Y COMO DATO ADHERIDO LA PACIENTE REFIERE QUE AL SONREÃ□R MUESTRA MUCHO LA ENCÃ□A SUPERIOR GENERANDO UNA INSEGURIDAD PERSONAL DONDE SE PROCEDIÃ“ AL DIAGNÃ“STICO DE LA SONRISA GINGIVAL.

Resultados y Conclusiones *

PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS

EL DIAGNÃ“STICO DE LA SONRISA GINGIVAL SE TOMA DESDE EL LABIO SUPERIOR AL MARGEN GINGIVAL SE REALIZA UN HONDEO PARA SABER DÃ“NDE SE ENCUENTRA LA CORTICAL ALVEOLAR AL MARGEN GINGIVAL, SE TOMA LA ALTURA DE LA ENCÃ□A QUERATINIZADA Y COMO HERRAMIENTA OPCIONAL LA TOMOGRAFÃ□A CBCT SE PUEDE CORROBORAR EL TAMAÃ‘O DE LAS CORONAS CLÃ□NICAS Y FENOTIPO Ã“SEO OBTENIENDO UN DIAGNÃ“STICO MÃ□S PRECISO.

CON LOS PRESENTES DATOS CLÃ□NICOS SE DIAGNOSTICÃ“ A LA PACIENTE CON ERUPCIÃ“N PASIVA ALTERADA IB, POR LO QUE SE PROCEDIÃ“ A LA MODIFICACIÃ“N DEL FENOTIPO GINGIVAL UTILIZANDO EN EL PROCESO QUIRÃšRGICO LA SONDA CHU COMO PRUEBA OBJETIVA DE LAS CORONAS CLÃ□NICAS UTILIZANDO SUS PUNTOS EN COLORES PARA OBTENER LAS DIMENSIONES DESEADAS, SE REALIZARON INCISIONES A BISEL EXTERNO SUB MARGINALES CON BISTURÃ□ 15C DE MANERA FESTONEADA SIN TOCAR LAS PAPILAS DENTALES E INCISIONES SULCULARES PARA OBTENER EL COLLARÃ□N GINGIVAL CON UNA CURETA GRACEY 3-4 COMO CONTINUACIÃ“N PARA LA MODIFICACIÃ“N DEL FENOTIPO GINGIVAL SE DESEPITELIZARON CON UNA TIJERA DE TEJIDOS GOLDMAN FOX Y LA ENCÃ□A ADHERIDA CON UN BISTURÃ□ DE KIRKLAND SE DESPLAZO UN COLGAJO DE ESPESOR TOTAL CON UN MOLT , SE PROCEDIÃ“ A LA OSTE OTOMÃ□A CON UNA FRESA DE CARBURO NÃšMERO 6 A BAJA VELOCIDAD CON IRRIGACIÃ“N DE SOLUCIÃ“N SALINA AL 0.12% DEJANDO 3 MM DEL UCE A LA CORTICAL ALVEOLAR PARA EL ESPACIO DE LOS TEJIDOS SUPRA CRESTALES CONCOMITANTEMENTE SE MODIFICÃ“ EL GROSOR VESTIBULAR CON OSTEOPLASTIA PARA EL CIERRE PRIMARIO SE UTILIZARON PUNTOS DE COLCHONERO VERTICAL CON NYLON 5/0 COMENZANDO POR LA PAPILA CENTRAL EXTENDIÃ‰NDOSE HACIA LAS PARTES LATERALES , LOS CONTROLES DE HIGIENE Y CICATRIZACIÃ“N SE LLEVARON A LOS 9 DÃ□AS Y A LOS 15 DÃ□AS DONDE SE RETIRARON LOS PUNTOS DE SUTURA FINALIZANDO LOS CONTROLES A LOS 3 MESES.

CONCLUSIONES

â€¢ EL TRATAMIENTO DE LA ERUPCIÃ“N PASIVA ALTERADA ES DE SUMA NECESIDAD PARA PACIENTES QUE ESTÃ‰N INTERESADOS HOY EN MEJORAR LA ESTÃ‰TICA DENTAL Y FACIAL.

â€¢ EL CONOCIMIENTO DE LA POSICIÃ“N FISIOLÃ“GICA DE LOS TEJIDOS SUPRA CRESTALES ES BÃ□SICO PARA LA REPOSICIÃ“N DE LOS TEJIDOS PERIODONTALES Y LA OBTENCIÃ“N DE RESULTADOS ESTÃ‰TICOS DESEADOS.

Bibliografía *

CORTELLINI P, BISSADA NF. MUCOGINGIVAL CONDITIONS IN THE NATURAL DENTITION: NARRATIVE REVIEW, CASE DEFINITIONS, AND DIAGNOSTIC CONSIDERATIONS. J PERIODONTOL [INTERNET]. 2018;89 SUPPL 1:S204â€“13. DISPONIBLE EN: HTTP://DX.DOI.ORG/10.1002/JPER.16-0671

MARZADORI M, STEFANINI M, SANGIORGI M, MOUNSSIF I, MONACO C, ZUCCHELLI G. CROWN LENGTHENING AND RESTORATIVE PROCEDURES IN THE ESTHETIC ZONE. PERIODONTOL 2000 [INTERNET]. 2018;77(1):84â€“92. DISPONIBLE EN: HTTP://DX.DOI.ORG/10.1111/PRD.12208

MELE M, FELICE P, SHARMA P, MAZZOTTI C, BELLONE P, ZUCCHELLI G. ESTHETIC TREATMENT OF ALTERED PASSIVE ERUPTION. PERIODONTOL 2000 [INTERNET]. 2018;77(1):65â€“83. DISPONIBLE EN: HTTP://DX.DOI.ORG/10.1111/PRD.12206

ACADEMIA.EDU. [CITADO EL 27 DE JULIO DE 2025]. DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.ACADEMIA.EDU/114970901/ESTHETIC_CROWN_LENGTHENING_A_REVIEW

ANDIJANI RI, TATAKIS DN. HYPERMOBILE UPPER LIP IS HIGHLY PREVALENT AMONG PATIENTS SEEKING TREATMENT FOR GUMMY SMILE. J PERIODONTOL [INTERNET]. 2019;90(3):256â€“62. DISPONIBLE EN:

Título del trabajo *

COLOCACIÃ“N DE IMPLANTE Y AUMENTO DE TEJIDO BLANDO MEDIANTE TÃ‰CNICA DE COLGAJO ENROLLADO MODIFICADO PARA RECONSTRUCCIÃ“N DE MUCOSA PERIIMPLANTARIA

Nombre del Autor (a/es)*

C.D. Luz Elena SÃ¡nchez VÃ¡zquez

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

M.C.O. Olaf Morones Machado, M.C.O. Marina GarcÃ-a ChÃ¡vez, M.C.O. Cristina BermÃºdez RenterÃ-a, M.C. Carlos HernÃ¡ndez Terrazas, , , , , .

Correo Electrónico *

luz-vazquez@uadec.edu.mx

Institución *

UNIVERSIDAD AUTÃ“NOMA DE COAHUILA

Introducción y Objetivos *

EL EDENTULISMO A LARGO PLAZO PUEDE GENERAR DEFICIENCIAS EN LA CONFIGURACIÃ“N DE LOS TEJIDOS BLANDOS Y DUROS DE LA CRESTA ALVEOLAR. LAS ESTRATEGIAS PROTÃ‰SICAS (POR EJEMPLO: PRÃ“TESIS PARCIALES FIJAS, PORCELANA ROSA, PRÃ“TESIS PARCIALES REMOVIBLES, CORONAS LARGAS, CONTACTOS AMPLIOS) SUELEN EMPLEARSE PARA ENMASCARAR DEFECTOS LOCALIZADOS DE LA CRESTA; SIN EMBARGO, REPRESENTAN UN COMPROMISO FRENTE A LOS MÃ‰TODOS QUIRÃšRGICOS DE AUMENTO DE TEJIDO BLANDO Y DURO. (1, 2)

LOS IMPLANTES DENTALES JUNTO CON LAS TÃ‰CNICAS DE INJERTO DE TEJIDO BLANDO SON UN PROCEDIMIENTO PROMETEDOR PARA LA REHABILITACIÃ“N DE PIEZAS DENTALES FALTANTES. (3) LA ESTÃ‰TICA PERIIMPLANTARIA PUEDE OPTIMIZARSE MEDIANTE LA MANIPULACIÃ“N O EL AUMENTO DE LOS TEJIDOS BLANDOS A TRAVÃ‰S DE CIRUGÃ□A PLÃ□STICA PERIODONTAL, ESPECIALMENTE ÃšTIL EN LA ZONA ANTERIOR DEL MAXILAR Y EN PACIENTES CON BIOTIPO GINGIVAL DELGADO PARA ENMASCARAR LA VISIBILIDAD DE LAS FIJACIONES DE TITANIO. (1)

LA TÃ‰CNICA DE COLGAJO EN ROLLO, DESCRITA ORIGINALMENTE POR ABRAMS EN 1980 CONSISTE EN MOVILIZAR TEJIDO PALATINO DESEPITELIZADO HACIA LA CARA VESTIBULAR PARA AUMENTAR SU VOLUMEN (4,5). DIVERSOS AUTORES HAN PROPUESTO MODIFICACIONES CON EL FIN DE PRESERVAR ESTRUCTURAS, MINIMIZAR MORBILIDAD Y OPTIMIZAR RESULTADOS ESTÃ‰TICOS (1,2)

EL OBJETIVO DE ESTE REPORTE ES PRESENTAR UN CASO CLÃ□NICO EN EL QUE SE COLOCÃ“ UN IMPLANTE Y SE EMPLEÃ“ UNA TÃ‰CNICA MODIFICADA DE COLGAJO ENROLLADO PARA AUMENTAR EL TEJIDO BLANDO BUCAL, OBTENIENDO RESULTADOS FAVORABLES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO SIN NECESIDAD DE UNA SEGUNDA INTERVENCIÃ“N QUIRÃšRGICA.

Descripción del Caso *

PACIENTE MASCULINO DE 64 AÃ‘OS, ASA II, ACUDIÃ“ A LA CLÃ?NICA DE LA MAESTRÃ?A EN CIENCIAS ODONTOLÃ“GICAS CON ACENTUACIÃ“N EN PERIODONCIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÃ“NOMA DE COAHUILA, UT, REFERIDO POR UN ALUMNO DE LA CLÃ?NICA INTEGRAL DE 4Â° Y 5Â° AÃ‘O PARA REHABILITACIÃ“N INTEGRAL DE LA CAVIDAD ORAL, INCLUYENDO REEMPLAZO DE Ã“RGANOS DENTARIOS AUSENTES.

EN LA ZONA BUCAL DEL ESPACIO EDÃ‰NTULO CORRESPONDIENTE AL O.D. 14, SE OBSERVÃ“ UNA DEFICIENCIA DE TEJIDOS BLANDOS Y DUROS DEBIDO A REABSORCIÃ“N Ã“SEA Y PÃ‰RDIDA DE VOLUMEN ASOCIADA A LA AUSENCIA PROLONGADA DEL DIENTE. TRAS DISCUTIR LAS OPCIONES TERAPÃ‰UTICAS, EL PACIENTE ELIGIÃ“ LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTE, ACEPTANDO LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL VOLUMEN DE TEJIDO BLANDO BUCAL PARA CORREGIR EL DEFECTO HORIZONTAL Y MEJORAR EL PERFIL GINGIVAL.

SE REALIZÃ“ BLOQUEO SUPRAPERIÃ“STICO A NIVEL DEL ESPACIO EDÃ‰NTULO DEL O.D. 14 CON LIDOCAÃ?NA AL 2% CON EPINEFRINA 1:100,000. EL TEJIDO BLANDO DEL ESPACIO EDÃ‰NTULO FUE DESEPITELIZADO CON PIEZA DE ALTA VELOCIDAD Y FRESA ABRASIVA DE DIAMANTE. POSTERIORMENTE, SE EFECTUÃ“ INCISIÃ“N CRESTAL HORIZONTAL CON LIGERA INCLINACIÃ“N HACIA PALATINO E INCISIÃ“N INTRASULCULAR, EMPLEANDO HOJA 15C Y MANGO #3. SE ELEVÃ“ COLGAJO DE ESPESOR TOTAL EN LA ZONA EDÃ‰NTULA Y DE ESPESOR PARCIAL EN VESTIBULAR, UTILIZANDO ELEVADORES BUSER Y PRICHARD.

SE PLANIFICÃ“ DIGITALMENTE Y COLOCÃ“ UN IMPLANTE STRAUMANN BL ROXOLID SLACTIVE 3.3 Ã— 12 MM SIGUIENDO EL PROTOCOLO DE FRESADO DEL FABRICANTE. SE INSTALÃ“ UN ADITAMENTO DE BOTELLA SOBRE EL IMPLANTE Y SE PROCEDIÃ“ A ENROLLAR EL COLGAJO DESEPITELIZADO, UBICÃ?NDOLO DENTRO DEL COLGAJO DE ESPESOR PARCIAL VESTIBULAR. LA MUCOSA DESEPITELIZADA SE ENCONTRÃ“ CON EL TEJIDO CONECTIVO SUBYACENTE, LOGRANDO EL AUMENTO DE VOLUMEN BUCAL. SE FIJÃ“ CON SUTURA COLCHONERO HORIZONTAL INTERNA PARA MANTENER LA POSICIÃ“N DEL COLGAJO, ADEMÃ?S DE SUTURA EN LAUREL Y PUNTOS SIMPLES CON VICRYL 5-0.

SE INDICARON CUIDADOS POSTOPERATORIOS (REPOSO RELATIVO, DIETA BLANDA, EVITAR ESFUERZOS FÃ?SICOS), ENJUAGUE CON CLORHEXIDINA AL 0.12% DOS VECES AL DÃ?A DURANTE 2 SEMANAS Y ANALGÃ‰SICO (IBUPROFENO) SEGÃšN NECESIDAD.

Resultados y Conclusiones *

LA EVOLUCIÃ“N FUE REVISADA A LOS 3 DÃ AS (FASE INICIAL DE CICATRIZACIÃ“N), 7 DÃ AS (FASE DE REVASCULARIZACIÃ“N DEL INJERTO) Y 14 DÃ AS (RETIRO DE SUTURAS), OBSERVÃ NDOSE AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL VOLUMEN DE TEJIDO BLANDO BUCAL. A LOS 21 DÃ AS, EN LA FASE DE MADURACIÃ“N, SE EVIDENCIARON PUENTES EPITELIALES FORMADOS Y UNA ADECUADA RESPUESTA CLÃ NICA. POSTERIORMENTE, SE INICIÃ“ LA REHABILITACIÃ“N PROTÃ‰SICA MEDIANTE UNA CORONA DE ZIRCONIA.

LA TÃ‰CNICA MODIFICADA DE COLGAJO ENROLLADO HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA Y PREDECIBLE PARA LOGRAR UN AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LOS TEJIDOS BLANDOS. SU PRINCIPAL OBJETIVO ES CORREGIR DEFECTOS HORIZONTALES LEVES Y MEJORAR EL PERFIL GINGIVAL BUCAL, AUMENTANDO EL GROSOR Y REMODELANDO EL CONTORNO DE LOS TEJIDOS BLANDOS EN Ã REAS ESTÃ‰TICAS. AL SER MENOS INVASIVA, REPRESENTA UNA EXCELENTE ALTERNATIVA EN ZONAS CON DISMINUCIÃ“N DE TEJIDO BLANDO, ELIMINANDO LA NECESIDAD DE UNA SEGUNDA ZONA QUIRÃšRGICA. ESTO REDUCE EL RIESGO DE COMPLICACIONES Y FAVORECE UNA CICATRIZACIÃ“N Y RECUPERACIÃ“N MÃ S RÃ PIDA. EN CONJUNTO, ESTA TÃ‰CNICA CONTRIBUYE A LA SALUD PERIODONTAL, OFRECIENDO RESULTADOS FUNCIONALES ESTABLES Y ESTÃ‰TICAMENTE SATISFACTORIOS.

Bibliografía *

1. KULKARNI MR, BAKSHI PV, KAVLEKAR AS, THAKUR SL. APPLICATIONS OF A MODIFIED PALATAL ROLL FLAP IN PERI-IMPLANT SOFT-TISSUE AUGMENTATION - A CASE SERIES. J INDIAN SOC PERIODONTOL. 2017 JUL-AUG;21(4):333-336. DOI: 10.4103/JISP.JISP_87_17. PMID: 29456310; PMCID: PMC5813350

2. KINAIA BM, ZIMMERMAN D, KOUTRACH M. IMPROVING PERI-IMPLANT SOFT TISSUE USING A MODIFIED ROLLED CONNECTIVE TISSUE TECHNIQUE: CASE SERIES. JOURNAL OF ADVANCED ORAL RESEARCH. 2018;7(2):45-50. DOI:10.1177/2229411220160208

3. SOUSA LL DE, JUNIOR JCV DE B, MORAIS DS, SILVA MP DE L, SILVA YC DE L, MARTINS SCR, ET AL. MODIFIED ROLL FLAP TECHNIQUE FOR HORIZONTAL RIDGE AUGMENTATION - A CASE REPORT. 2023 MAR 13;4(2). AVAILABLE FROM: HTTPS://DOI.ORG/10.58624/SVOADE.2023.04.0123

Título del trabajo *

RECONSTRUCCION Ã“SEA DE UN REBORDE KNIFE-EDGE EN ZONA ANTEROSUPERIOR MEDIANTE SAUSAGE TECHNIQUE, REPORTE DE CASO CLI?NICO.

Nombre del Autor (a/es)*

Alanis Audrey Buenrostro Palma

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Abel EscÃ¡rcega Ochoa, Pollyanna del Consuelo Gil martÃ-nez, , , , , , , .

Correo Electrónico *

buenrostrop1@gmail.com

Institución *

CENTRO EDUCATIVO MULTIDISCIPLINARIO EN REHABILITAC

Introducción y Objetivos *

LA PÃ‰RDIDA DE PIEZAS DENTARIAS GENERA REABSORCIÃ“N Ã“SEA DANDO COMO CONSECUENCIA UNA SERIE DE CAMBIOS DIMENSIONALES OCASIONANDO FRECUENTEMENTE DEFECTOS EN EL REBORDE ALVEOLAR (1). SEGU?N LA CLASIFICACIO?N DE CAWOOD Y HOWELL (1988) EL REBORDE ALVEOLAR TIPO IV ES EN FILO DE CUCHILLO O KNIFE-EDGE, SE PUEDE PRESENTAR HASTA EN UN 56%, CARACTERIZADO POR UNA CRESTA ESTRECHA, AFILADA Y CON ESCASO VOLUMEN HORIZONTAL MENOR A 3.8 MM, SIENDO UN PRONÃ“STICO POBRE PARA LA COLOCACIO?N DE IMPLANTES DENTALES EN UNA POSICIÃ“N PROTÃ‰SICAMENTE GUIADA (2). LA REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA (ROG) ES EL USO DE UNA MEMBRANA PARA CREAR UNA BARRERA, EVITANDO LA COLONIZACIÃ“N DE TEJIDOS NO OSTEOGÃ‰NICOS Y MANTENIENDO EL ESPACIO PARA FACILITAR LAS CONDICIONES Ã“PTIMAS PARA EL AUMENTO Ã“SEO; EXITEN VARIAS TÃ‰CNICAS QUE POSIBILITAN LA RECONSTRUCCIÃ“N Ã“SEA, UNA DE ELLAS ES LA SAUSAGE TECHNIQUE, ESTA TÃ‰CNICA PERMITE LOGRAR MAYOR ESTABILIDAD DEL MATERIAL INJERTADO Y AUMENTAR EL VOLUMEN DE FORMAS COMPLEJAS, COMO EL HUESO VESTIBULAR CRESTAL; UNA DE SUS GRANDES VENTAJAS NO REQUIERE UNA SEGUNDA ETAPA QUIRÃšRGICA PARA RETIRAR LA MEMBRANA (3).

EL OBJETIVO DE ESTE CASO CLÃ?NICO ES EVALUAR LA RESOLUCIÃ“N DE UN REBORDE ALVEOLAR TIPO IV EN EL SECTOR ANTEROSUPERIOR MEDIANTE LA TÃ‰CNICA SAUSAGE TECHNIQUE.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINO 54 AN?OS, SE PRESENTÃ“ A CLÃ?NICA POSGRADO DE PERIODONCIA CEMRO. SIN ANTECEDENTES PATOLÃ“GICOS PERSONALES. MOTIVO DE CONSULTA â€œDESDE MUY CHICA HE TENIDO PROBLEMAS CON MIS DIENTES QUISIERA PODER VERLOS BONITOSâ€?. EL EXÃ?MEN PERIODONTAL ARROJÃ“ BOLSAS PERIODONTALES AL SONDEO (PBS) HASTA 5 MM, UNIÃ“N CEMENTO ESMALTE (UCE) DE -2 A 1 MM Y NIVEL DE INSERCIÃ“N AL SONDEO (NIS) 0-2 MM EN 54%; SANGRADO AL SONDEO (SAS) 1%, SIN SUPURACIÃ“N, 0% DE CÃ?LCULO DENTAL, 12% DE Ã?NDICE DE BIOFILM BACTERIANO (IBB). LA TOMOGRAFÃ?A DE HAZ CÃ“NICO (CBCT) ZONA EDÃ‰NTULA 12 CORTE SAGITAL PRESENTÃ“ ANCHURA DE 3.03 MM Y ALTURA Ã“SEA 19.21 MM, MIENTRAS QUÃ‰, ZONA 11 FUE 3.33 MM Y 18.82 MM RESPECTIVAMENTE. EL DIAGNÃ“STICO PERIODONTITIS ESTADÃ?O I GRADO A Y EN MAXILAR ANTERIOR REBORDE ALVEOLAR TIPO IV DE CAWOOD Y HOWELL. PRONÃ“STICO FAVORABLE, POR BUENA CALIDAD Ã“SEA, SIN ENFERMEDAD PERIODONTAL ACTIVA Y SIN TRATAMIENTO. SE PLANIFICÃ“ FASE I HIGIÃ‰NICA MEDIANTE IBB E INSTRUCCIÃ“N DE HIGIENE ORAL. FASE II QUIRÃšRGICA ROG REALIZANDO SAUSAGE TECHNIQUE. A 6 MESES SEGUNDO TIEMPO QUIRÃšRGICO INSERCIÃ“N DE 2 IMPLANTES DENTALES ENDOÃ“SEOS. FASE III PROTÃ‰SICA IMPLANTAR COLOCACIÃ“N PRÃ“TESIS FIJA E-MAX ATORNILLADA. FINALMENTE, FASE IV TERAPIA IMPLANTAR DE SOPORTE, REVALORACIÃ“N 6 Y 12 MESES DESPUÃ‰S DE CARGAR IMPLANTES DENTALES. PREVIO CONSENTIMIENTO INFORMADO SE LLEVÃ“ A CABO EL TRATAMIENTO. INICIANDO CON ASEPSIA Y ANTISEPSIA EXTRAORAL E INTRAORAL, COLOCACIÃ“N DE ANESTÃ‰SICO MEDIANTE TÃ‰CNICA SUPRAPERIÃ“STICA; SE REALIZÃ“ INCISIÃ“N CRESTAL, POSTERIORMENTE CON LEGRA PRICHARD FUE LEVANTADO COLGAJO MUCOPERIO?STICO, SE CRIBÃ“ EL REBORDE RESIDUAL PARA RECIBIR UN MIX DE HUESO AUTO?LOGO CON XENOINJERTO A-OSS HIOSSENÂ®, CUBRIENDOLO CON MEMBRANA DE COLÃ?GENO DE PERICARDIO PORCINO STRAUMANNÂ® JASONÂ® Y ESTABILIZANDOLA CON TACHUELAS AUTOTACÂ® BIOHORIZONSÂ®, LOGRANDO EXPANSIO?N CONTROLADA DE DICHA MEMBRANA SOBRE SITIO QUIRU?RGICO, PERMITIENDO MANTENER MATERIAL REGENERATIVO EN EL ESPACIO. EL CIERRE DEL COLGAJO FUERON PUNTOS AISLADOS UTILIZANDO NYLON 6-0. SE OTORGARON CUIDADOS POSTOPERATORIOS.

Resultados y Conclusiones *

CLÃ□NICAMENTE A LOS 6 MESES LA ENCÃ□A SE OBSERVÃ“ ROSA CORAL, DURANTE ESTE PERIODO NO SE PRESENTARON COMPLICACIONES COMO EXPOSICIO?N DE MEMBRANA, NI SIGNOS DE INFECCIO?N. PARA EL SEGUNDO TIEMPO QUIRÃšRGICO DONDE SE REALIZÃ“ LA INSERCIÃ“N DE 2 IMPLANTES DENTALES ENDOÃ“SEOS DE 3.5 X 10 MM ETSA HIOSSENÂ®, SE OBSERVÃ“ UNA ANCHURA HORIZONTAL DE 8 MM, COMPARANDO LA MEDICIÃ“N CLÃ□NICA INICIAL DE 3.3 MM, EL INCREMENTO EN LA ANCHURA HORIZONTAL A NIVEL CORONAL FUE DE 4.7 MM, SUFICIENTE PARA LA COLOCACIO?N DE DICHOS IMPLANTES DENTALES EN POSICIO?N FUNCIONAL Y ESTE?TICA. SE COMPARÃ“ EL CBCT A 6 MESES, EN CORTE SAGITAL PRESENTANDO PARA LA ZONA 12 UNA ANCHURA Ã“SEA DE 7.18 MM Y ALTURA Ã“SEA 19.21 MM, COMPARADA CON LA MEDICIÃ“N INICIAL QUE FUE 3.03 MM Y 19.21 MM RESPECTIVAMENTE, DANDO UN INCREMENTO HORIZONTAL DE 4.15 MM Y MANTENIÃ‰NDOSE LA ALTURA; MIENTRAS QUÃ‰, PARA LA ZONA 11 PRESENTÃ“ UN GROSOR Ã“SEO DE 8.67 MM Y ALTURA Ã“SEA 18.82 MM, AL RELACIONAR LA MEDICIÃ“N INICIAL QUE FUE 3.33 MM Y 18.82 MM RESPECTIVAMENTE, DIÃ“ UN AUMENTO Ã“SEO HORIZONTAL DE 5.34 MM Y ALTURA 18.82 MM. EL CBCT A UN AÃ‘O Y 5 MESES EN CORTE AXIAL PRESENTA UNA ANCHURA HORIZONTAL DE 7.11 MM Y ALTURA Ã“SEA 19.21 MM EN ZONA 12, MIENTRAS QUE LA ZONA 11 PRESENTÃ“ UN GROSOR Ã“SEO DE 8.50 MM Y ALTURA Ã“SEA 18.82 MM, DONDE LA PÃ‰RDIDA HORIZONTAL FUE DE 0.17 MM. EL PRESENTE CASO CLÃ□NICO TIENE UN SEGUIMIENTO A CORTO PLAZO, SIN EMBARGO, SE CONCLUYE QUE LA SAUSAGE TECHNIQUE ES UNA TE?CNICA EFECTIVA Y PREDECIBLE PARA LA RESOLUCIÃ“N DE REBORDES ATRO?FICOS TIPO IV (KNIFE-EDGE) EN LA ZONA ANTEROSUPERIOR, PERMITIENDO LA REGENERACIO?N Ã“SEA Y CREANDO LECHOS IMPLANTOLO?GICOS ADECUADO CON ALTA PREDICTIBILIDAD ESTE?TICA Y FUNCIONAL. ASÃ□ MISMO, CONSIDERANDO LOS CRITERIOS DE Ã‰XITO(4) EN EL TRATAMIENTO CON IMPLANTES DENTALES, LA PÃ‰RDIDA DE HUESO QUE SE PRESENTA EN ESTE CASO CLÃ□NICO ES CONSIDERADO Ã‰XITO CON SALUD Ã“PTIMA SIENDO MENOR A 0.2 MM ANUALMENTE DESPUÃ‰S DEL PRIMER AÃ‘O DE LA CARGA FUNCIONAL.

Bibliografía *

1. VAN DER WEIJDEN, F., DELLâ€™ACQUA, F. & SLOT, D. E. ALVEOLAR BONE DIMENSIONAL CHANGES OF POST-EXTRACTION SOCKETS IN HUMANS: A SYSTEMATIC REVIEW. J. CLIN. PERIODONTOL. 2009 DEC; 36(12):1048-58. DOI: 10.1111/J.1600-051X.2009.01482.X.

2. GARCÃ□A GARGALLO M., YASSIN GARCÃ□A S., BASCONES MARTÃ□NEZ A. RIDGE PRESERVATION AND RIDGE AUGMENTATION PROCEDURES: A LITERATURE REVIEW. AV PERIODON IMPLANTOL [INTERNET]. 2016 AGO [CITADO 2025 AGO 11] ; 28(2): 71-81. DISPONIBLE EN: HTTP://SCIELO.ISCIII.ES/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S1699-65852016000200003&LNG=ES.

3.URBAN I.A., NAGURSKY H., LOZADA J.L. HORIZONTAL RIDGE AUGMENTATION WITH A COLLAGEN MEMBRANE AND A COMBINATION OF PARTICULATED AUTOGENOUS BONE AND ANORGANIC BOVINE BONE-DERIVED MINERAL: A PROSPECTIVE CASE SERIES IN 25 PATIENTS. INT. J. ORAL MAXILLOFAC. IMPLANT. 2013 MAY-JUN;33(3):299-307.

DOI: 10.11607/PRD.1407

4. E. VELASCO ORTEGA, A. JIMENEZ GUERRA, J.MORENO MUN?OZ, I. ORTIZ GARCI?A, J.L. RONDO?N ROMERO, E. NU?N?EZ MA?ROUEZ. N. MATOS GARRIDO. L. MONSALVE GUIL. INVESTIGACIO?N CLI?NICA A LARGO PLAZO DEL

Título del trabajo *

MANEJO INTERDISCIPLINARIO ENDODONCIA-PERIODONCIA: TRATAMIENTO DE CONDUCTOS Y CIRUGÃ A CON INJERTO GINGIVAL LIBRE EN UN CASO DE RECESIÃ“N Y LESIÃ“N PERIAPICAL

Nombre del Autor (a/es)*

C.D. Belmares GonzÃ¡lez Aylin Alejandra

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Dra. Furrer Franco Elsa Patricia, D.C.F LÃ³pez Trujillo Dora MarÃ-a, M.C.O Weaver Ã valos Shannon, M.C.O DÃ-az Palomares Enrique, , , , , .

Correo Electrónico *

abelmares@uadec.edu.mx

Institución *

MAESTRÃ A EN CIENCIAS ODONTOLÃ“GICAS CON ACENTUACIÃ“N

Introducción y Objetivos *

EL TRAUMA OCLUSAL PUEDE PROVOCAR UNA ALTERACIÃ“N EN LA ARMONÃ□A DE LAS FUERZAS MUSCULARES, RESULTANDO EN UNA DESALINEACIÃ“N DE LO QUE NORMALMENTE SERÃ□A UNA OCLUSIÃ“N IDEAL. (1) ESTE TIPO DE TRAUMA AFECTA TANTO A LOS DIENTES COMO A LOS TEJIDOS GINGIVALES Y PERIAPICALES.(2) LAS FUERZAS RESULTANTES DE CONTACTOS PREMATUROS O INTERFERENCIAS EN LOS DIENTES PUEDEN IMPEDIR UNA RELACIÃ“N OCLUSAL ESTABLE(3) GENERANDO PATOLOGÃ□AS EN EL COMPLEJO DENTINO-PULPAR Y EN EL TEJIDO GINGIVAL ADYACENTE. POR LO TANTO, ES IMPORTANTE QUE SE TENGA EN CUENTA LA MALOCLUSIÃ“N Y OTROS HÃ□BITOS COMO CAUSAS DE PROBLEMAS PULPARES Y GINGIVALES ALREDEDOR DE LAS PIEZAS AFECTADAS. LA AUSENCIA O DEFICIENCIA DE TEJIDO QUERATINIZADO PUEDE TRAER DIVERSAS COMPLICACIONES A LARGO PLAZO COMO ACUMULACIÃ“N DE PLACA, REABSORCIÃ“N DEL HUESO MARGINAL Y RECESIONES GINGIVALES, SIENDO MÃ□S EVIDENTE ALREDEDOR DE LOS CANINOS DEBIDO A QUE PRESENTAN UN FENOTIPO GINGIVAL MÃ□S DELGADO POR SU POSICIÃ“N EN EL ARCO DENTAL4. SE EVIDENCIÃ“ QUE TENER AL MENOS 2 MM DE MUCOSA QUERATINIZADA TIENE UN EFECTO PROTECTOR SOBRE LA SALUD PERIODONTAL.

OBJETIVO: DESCRIBIR EL MANEJO INTERDISCIPLINARIO ENDODÃ“NTICO-PERIODONTAL EN UN CASO CLÃ□NICO CON RECESIÃ“N GINGIVAL Y LESIÃ“N PERIAPICAL, ABORDADO MEDIANTE TRATAMIENTO DE CONDUCTOS Y CIRUGÃ□A MUCOGINGIVAL CON INJERTO GINGIVAL LIBRE, DESTACANDO LA IMPORTANCIA DEL CONTROL DE LA INFLAMACIÃ“N, EL GROSOR DEL TEJIDO QUERATINIZADO Y LA PREPARACIÃ“N PERIODONTAL PREVIA A MOVIMIENTOS ORTODÃ“NTICOS.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINA DE 33 AÃ‘OS, ASA I, REFERIDA DEL POSGRADO DE ORTODONCIA POR UNA LESIÃ“N RADIOLÃšCIDA EN O.D. 43. CLÃ□NICAMENTE PRESENTABA MALOCLUSIÃ“N, APIÃ‘AMIENTO, RECESIONES GINGIVALES CLASE II Y III SEGÃšN MILLER EN O.D. 31 Y 43, PÃ‰RDIDA DE TEJIDO QUERATINIZADO, FENOTIPO GINGIVAL DELGADO EN EL ARCO INFERIOR, INFLAMACIÃ“N GINGIVAL, ZONAS ERITEMATOSAS, MÃšLTIPLES CARIES, ATRICIÃ“N Y CONTACTOS ABIERTOS. EL SONDAJE PERIODONTAL FUE DE 4-3-3 MM VESTIBULAR Y 3-3-3 MM LINGUAL. LAS PRUEBAS DE VITALIDAD FUERON NEGATIVAS, Y RADIOGRÃ□FICAMENTE SE EVIDENCIÃ“ UNA LESIÃ“N PERIAPICAL EN O.D. 43, DIAGNOSTICADA COMO NECROSIS PULPAR CON PERIODONTITIS APICAL ASINTOMÃ□TICA ATRIBUIDA A TRAUMA OCLUSAL.

EL TRATAMIENTO ENDODÃ“NTICO SE REALIZÃ“ EN DOS CITAS CON INSTRUMENTACIÃ“N MANUAL Y SE COLOCÃ“ MEDICACIÃ“N INTRA CONDUCTO CON HIDRÃ“XIDO DE CALCIO. UNA SEMANA DESPUÃ‰S, SE REALIZÃ“ PROTOCOLO DE IRRIGACIÃ“N FINAL CON ACTIVADOR SÃ“NICO. LA TÃ‰CNICA DE OBTURACIÃ“N FUE CONDENSACIÃ“N LATERAL MODIFICADA Y SELLADOR SEALAPEX.

POSTERIORMENTE, SE LLEVÃ“ A CABO EL MANEJO INTERDISCIPLINARIO CON EL POSGRADO DE PERIODONCIA. SE ABORDÃ“ EL CASO CON UNA CIRUGÃ□A PARA COLOCACIÃ“N DE IGL EN EL OD. 43 DEBIDO AL DEFICIENTE TEJIDO QUERATINIZADO Y LA HIGIENE BUCAL INADECUADA EN LA ZONA A TRATAR. SE COLOCÃ“ ANESTESIA LOCAL CON LIDOCAÃ□NA Y EPINEFRINA, SE TRAZARON INCISIONES HORIZONTALES Y VERTICALES A ESPESOR PARCIAL SIGUIENDO EL CONTORNO DE LA LÃ□NEA MUCOGINGIVAL. SE ELEVÃ“ EL COLGAJO, SE ESTABILIZÃ“ LA MUCOSA CON PUNTOS SIMPLES HACIA APICAL PARA PREVENIR EL DESPLAZAMIENTO DEL COLGAJO. EL INJERTO SE OBTUVO DEL PALADAR, DE 10 X 5 MM, SE DESEPITELIZÃ“ Y SE COLOCÃ“ EN LA ZONA RECEPTORA MEDIANTE PUNTOS EN X CON SUTURA NO REABSORBIBLE 4-0.SE PRESCRIBIÃ“ MANEJO FARMACOLÃ“GICO CON ANTIBIÃ“TICO, ANALGÃ‰SICO, ANTIINFLAMATORIO Y ENJUAGUE DE CLORHEXIDINA AL 0.12%. SE REALIZARON CONTROLES POSTOPERATORIOS A LOS 3, 7, 12 Y 30 DÃ□AS, CON EVOLUCIÃ“N CLÃ□NICA FAVORABLE. LA PACIENTE FUE REFERIDA NUEVAMENTE A ORTODONCIA PARA SEGUIMIENTO INTEGRAL.

Resultados y Conclusiones *

SE OBTUVO UNA BANDA DE ENCÃ⍰A QUERATINIZADA ? A 2MM, QUE GARANTIZA LA ESTABILIDAD Y FIRMEZA DE LOS TEJIDOS BLANDOS. LOS RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL INCREMENTO DE MUCOSA QUERATINIZADA FUERON ACEPTABLES, PERMITIENDO MANTENER LA CORRECTA HIGIENE DEL SECTOR Y LA SALUD DE LOS TEJIDOS ALREDEDOR DE LOS DIENTES, TAMBIÃ‰N SE OBSERVÃ“ QUE EL AUMENTO DE TEJIDO QUERATINIZADA SE ASOCIÃ“ CON UNA REDUCCIÃ“N DE LA RECESIÃ“N DE TEJIDO BLANDO Y EL Ã⍰NDICE DE PLACA EN COMPARACIÃ“N CON LOS SITIOS NO AUMENTADOS.

CONCLUSIÃ“N

VILCHEZ J.1 REPORTÃ“ UNA ALTA INCIDENCIA DE PATOLOGÃ⍰A PULPAR POR TRAUMA OCLUSAL EN DIENTES ANTERIORES, COINCIDIENDO CON LA LOCALIZACIÃ“N DE LA LESIÃ“N. DE FORMA SIMILAR, MENDIBURU ET AL.2 HALLARON AUSENCIA DE DOLOR EN MÃ⍰S DE LA MITAD DE LOS CASOS ANALIZADOS, LO CUAL TAMBIÃ‰N SE PRESENTÃ“ EN ESTE CASO, DONDE NO HUBO SINTOMATOLOGÃ⍰A DOLOROSA. ES NECESARIO DESTACAR LA IMPORTANCIA DE UN DIAGNÃ“STICO INTEGRAL BASADO EN ANTECEDENTES, PRUEBAS CLÃ⍰NICAS Y RADIOGRÃ⍰FICAS PARA ESTABLECER UN TRATAMIENTO EFICAZ Y PRONÃ“STICO FAVORABLE, ENFOQUE QUE FUE APLICADO EN NUESTRO DIAGNÃ“STICO.

LA RECESIÃ“N GINGIVAL SE ASOCIA CON LA PÃ‰RDIDA DE INSERCIÃ“N Y A LA EXPOSICIÃ“N DE LA SUPERFICIE RADICULAR AL ENTORNO ORAL, POR LO TANTO, EL INJERTO GINGIVAL LIBRE ES LA TÃ‰CNICA Ã“PTIMA PARA AUMENTAR LA EXTENSIÃ“N DEL VESTÃ⍰BULO Y EL ANCHO DEL TEJIDO QUERATINIZADO, POR SU GRAN EFECTIVIDAD Y PREDICTIBILIDAD CLÃ⍰NICA, EL DEFICIENTE TEJIDO QUERATINIZADO ALREDEDOR DE LOS DIENTES SE ASOCIA CON UNA MAYOR ACUMULACIÃ“N DE BIOFILM E INFLAMACIÃ“N TISULAR

LANG Y COL., DESTACARON QUE UNA CANTIDAD MÃ⍰NIMA DE MUCOSA QUERATINIZADA PODRÃ⍰A SER NECESARIA PARA LA ESTABILIDAD PERIODONTAL, OBSERVANDO QUE LA AUSENCIA DE MQ SE ASOCIABA A LA PRESENCIA DE RECESIÃ“N GINGIVAL Y PERIODONTO INFLAMADO 5. INCLUSO CON HIGIENE BUCAL SUPERVISADA, TODOS LOS SITIOS SIN 2 MM DE MQ MOSTRARON SIGNOS CLÃ⍰NICOS DE INFLAMACIÃ“N Y EL 80 % DE LOS SITIOS CON > 2 MM DE MQ PERMANECIERON SALUDABLE; POR LO TANTO, CONCLUYERON QUE SE NECESITAN 2 MM DE MQ PARA MANTENER LA SALUD DE LOS TEJIDOS PERIODONTALES MEDIANTE UN ADECUADO CONTROL DE LA INFLAMACIÃ“N

Bibliografía *

1. VILCHEZ ZAPATA, J. G. ABORDAJE CLÃ⍰NICO EN PACIENTE CON PATOLOGÃ⍰A PULPAR, GENERADO POR TRAUMATISMO OCLUSAL EN PIEZAS DENTARIAS ANTERIORES. [INTERNET]. CHIMBOTE; 2021. DISPONIBLE EN: HTTPS://REPOSITORIO.ULADECH.EDU.PE/HANDLE/20.500.13032/30834

2. YÃ⍰Ã‘EZ OCAMPO, B. R., & VARGAS CASILLAS, A. P. CLASIFICACIÃ“N DE ENFERMEDADES Y CONDICIONES PERIODONTALES Y PERIIMPLANTARIAS 2018. SEGUNDA PARTE. [INTERNET]. REVISTA ODONTOLÃ“GICA MEXICANA Ã“RGANO OFICIAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÃ⍰A UNAM, 25(4). MÃ‰XICO; 2022. DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.REVISTAS.UNAM.MX/INDEX.PHP/ROM/ARTICLE/VIEW/84056

3. GONZALES MOTTA, C. F. S. AUMENTO DE MUCOSA QUERATINIZADA Y FRENOTOMÃ⍰A CON INJERTO GINGIVAL LIBRE ALREDEDOR DE IMPLANTE POSTERIOR.

4.CORTELLINI, P., & BISSADA, N. F. (2018). MUCOGINGIVAL CONDITIONS IN THE NATURAL DENTITION: NARRATIVE REVIEW, CASE DEFINITIONS, AND DIAGNOSTIC CONSIDERATIONS. JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, 89, S204-S213.

5. LANG NP, BARTOLD PM. PERIODONTAL HEALTH. JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY. 2018, 45, S9S16.29.

Título del trabajo *

MANEJO QUIRÃšRGICO DE MAXILAR SUPERIOR ATRÃ“FICO PARA REHABILITACIÃ“N PROTÃ‰SICA: PRESENTACIÃ“N DE CASO CLÃ NICO.

Nombre del Autor (a/es)*

AcuÃ±a Molina Andrea

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Ruiz Estrada Jorge, , , , , , , , .

Correo Electrónico *

acu.na12@hotmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ

Introducción y Objetivos *

EL EDENTULISMO COMPLETO O PARCIAL ES COMÃšN EN LA POBLACIÃ“N ADULTA, AUMENTANDO LA COMPLEJIDAD DE SU REHABILITACIÃ“N. SU MANEJO QUIRÃšRGICO REQUIERE UNA EVALUACIÃ“N PREOPERATORIA PROFUNDA PARA OPTIMIZAR Y REDUCIR EL RIESGO DEL TRATAMIENTO.1

LA PÃ‰RDIDA DENTAL ACTIVA UNA RESPUESTA FISIOLÃ“GICA QUE RESULTA EN UNA REMODELACIÃ“N DEL REBORDE ALVEOLAR, SIN IMPORTAR LA POSICIÃ“N DENTRO DEL ARCO.2 UNA EVALUACIÃ“N CLÃ NICA POSTERIOR DEBE ENFOCARSE EN PROYECCIONES DE HUESO, TORUS MAXILARES O MANDIBULARES, ANORMALIDADES DEL PROCESO ALVEOLAR, PATOLOGÃ AS O CONDICIONES QUE PUEDAN COMPLICAR EL CURSO DEL TRATAMIENTO PROTÃ‰SICO.3 LA EXTRACCIÃ“N DE PIEZAS DENTALES CERCA DEL PISO DEL SENO MAXILAR, JUNTO CON UNA ATROFIA DEL HUESO ALVEOLAR, LA CAVIDAD ANTRAL DE LOS SENOS SE PUEDE EXPANDIR EN SENTIDO INFERIOR (CORONALMENTE) Y LATERAL, PROCESO CONOCIDO COMO NEUMATIZACIÃ“N DEL SENO MAXILAR.2

EL MANEJO QUIRÃšRGICO PREPROTESICO ABARCA DESDE EXTRACCIONES DENTALES, REGULARIZACIONES DE REBORDE, ELIMINACIÃ“N DE PATOLÃ“GICAS, INCLUSO ELEVACIONES DEL PISO DEL SENO MAXILAR. DONDE ESTA ÃšLTIMA SE REALIZA CON EL OBJETIVO DE AUMENTAR EL VOLUMEN Ã“SEO FACILITANDO LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES,2 AUNQUE ES UNA MODALIDAD GENERALMENTE EFECTIVA Y PREDECIBLE LA AMPLIA VARIABILIDAD ANATÃ“MICA DEL SENO MAXILAR Y SUS ESTRUCTURAS RELACIONADAS, LA PLANIFICACIÃ“N Y SELECCIÃ“N DE CASOS SON CRUCIALES PARA LOGRAR UN Ã‰XITO TERAPÃ‰UTICO.4

OBJETIVO

DESCRIBIR EL MANEJO QUIRÃšRGICO PREPROTESICO DE UN MAXILAR ATRÃ“FICO, DESTACANDO SUS COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS.

Descripción del Caso *

PRESENTACIÃ“N DE CASO Y DIAGNOSTICO

PACIENTE MASCULINO DE 65 AÃ‘OS QUE SE PRESENTA AL POSGRADO DE PERIODONCIA DE LA UACJ POR DESEO DE REHABILITACIÃ“N IMPLANTOLÃ“GICA EN SUS ANTECEDENTES MÃ‰DICOS REFIERE PADECER DIABETES, HIPERTENSIÃ“N Y HERPES ZOSTER. EN LA REVISIÃ“N INTRAORAL, SE OBSERVA REHABILITACIÃ“N TOTAL EN AMBOS MAXILARES. EL MAXILAR SUPERIOR PRESENTA PUENTE DESAJUSTADO DE 1R MOLAR A 1R MOLAR, EL CUAL ERA SOPORTADO ÃšNICAMENTE POR 7 DIENTES (1.7, 1.6, 1.5, 1.3, 1.2, 1.1 Y 2.4). EL DIENTE 2.4 TIENE QUE SER EXTRAÃ□DO POR FRACTURA DENTAL, LOS DIENTES 1.3, 1.2 Y 1.1 PRESENTABAN TRATAMIENTO DE CONDUCTOS PREVIO Y LESIONES PERIAPICALES CON SUPURACIÃ“N POR EL MARGEN GINGIVAL, DESPUÃ‰S DE UNA EVALUACIÃ“N ENDODÃ“NTICA Y PERIODONTAL SE TOMA LA DECISIÃ“N DE EXTRAER DICHAS PIEZAS. LAS PIEZAS REMANENTES 1.7, 1.6 Y 1.5 SE DECIDEN EXTRAER POR INDICACIÃ“N PROTÃ‰SICA.

PROCEDIMIENTOS

LA PRIMERA CIRUGÃ□A PROGRAMADA CONSISTÃ□A EN EXTRACCIONES MÃšLTIPLES Y REGULARIZACIÃ“N DE REBORDE ALVEOLAR, POSTERIOR A LAS EXTRACCIONES SE ELEVÃ“ UN COLGAJO A ESPESOR TOTAL Y SE REALIZÃ“ UNA REGULARIZACIÃ“N Ã“SEA CON UNA FRESA DE BOLA Y SE CERRÃ“ EL COLGAJO CON PUNTOS SIMPLES PGA 5-0. 1 MES DESPUÃ‰S SE REALIZA LA ELEVACIÃ“N DEL SENO MAXILAR DERECHO CON TÃ‰CNICA DE VENTANA LATERAL, SE ELEVÃ“ UN COLGAJO A ESPESOR TOTAL EN LA PARED LATERAL DEL SENO Y SE ELEVÃ“ LA MEMBRANA DE SCHNEIDER CON ELEVADORES DEL SENO, DURANTE EL PROCEDIMIENTO SE PRESENTÃ“ COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA CONDICIÃ“N DE LA MEMBRANA, DIFICULTANDO SU ELEVACIÃ“N. SE UTILIZO UNA MEZCLA DE AUTOINJERTO RECOLECTADO DE LA ZONA Y XENOINJERTO, QUE AL FINAL FUE RECUBIERTO POR UNA MEMBRANA DE COLÃ□GENO Y SE CERRÃ“ LA HERIDA CON PUNTOS SIMPLES PGA-5-0. 3 DÃ□AS POSTERIOR A LA CIRUGÃ□A EL PACIENTE REFERÃ□A SENSACIÃ“N DE SANGRE CORRER POR LA GARGANTA AL ACOSTARSE, 7 DÃ□AS POSTERIOR A LA CIRUGÃ□A SE OBSERVÃ“ UNA RUPTURA DE LAS SUTURAS Y UNA DEHISCENCIA DE LA HERIDA, PACIENTE REFERÃ□A QUE AL TOMAR AGUA ESTA SALÃ□A POR SU NARIZ CON PARTÃ□CULAS DE HUESO. SE MANTUVO EN OBSERVACIÃ“N POR 2 SEMANAS, DONDE EVOLUCIONO DE MANERA FAVORABLE. 1 MES DESPUÃ‰S SE REALIZÃ“ LA ELEVACIÃ“N DEL PISO DEL SENO IZQUIERDO UTILIZANDO LA MISMA TÃ‰CNICA PREVIAMENTE DESCRITA. 6 MESES DESPUÃ‰S SE REALIZÃ“ LA COLOCACIÃ“N GUIADA DE 6 IMPLANTES POR MEDIO DE GUÃ□AS APILABLES SOBRE HUESO, SE ELEVÃ“ UN COLGAJO A ESPESOR TOTAL DESDE ZONA RETROMOLAR IZQUIERDA A ZONA RETROMOLAR DERECHA Y AMBOS COLGAJOS PALATINOS SE FIJARON CON UN PUNTO DE SUTURA PARA PERMITIR EL ASENTAMIENTO DE LA GUÃ□A QUIRÃšRGICA. EL COLGAJO SE CERRÃ“ CON PUNTOS CON PUNTOS CONTINUOS Y SUTURA PGA 5-0. 5 MESES DESPUÃ‰S DE LA ÃšLTIMA CIRUGÃ□A, SE DESCUBRIERON LOS IMPLANTES Y EL PACIENTE SE ENCUENTRA USANDO UNA PLACA TRANSICIONAL CARGADA A LOS IMPLANTES.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS

TRAS LAS MÃšLTIPLES CIRUGÃ AS PREPROTESICAS, INCLUYENDO MÃšLTIPLES EXTRACCIONES, REGULARIZACIÃ“N DEL REBORDE ALVEOLAR Y ELEVACIÃ“N DEL SENO MAXILAR BILATERAL, SE LOGRÃ“ UNA BASE Ã“SEA ADECUADA PARA LA COLOCACIÃ“N DE 6 IMPLANTES PARA LA POSTERIOR REHABILITACIÃ“N PROTÃ‰SICA. EXISTIERON COMPLICACIONES POSTQUIRÃšRGICAS QUE, GRACIAS A LA DETECCIÃ“N OPORTUNA, ESTAS NO INFLUYERON EN EL Ã‰XITO DE LA CIRUGÃ A. ACTUALMENTE EL PACIENTE UTILIZA UNA PRÃ“TESIS TRANSICIONAL CARGADA A LOS IMPLANTES EN ESPERA DE LA REHABILITACIÃ“N DEFINITIVA.

CONCLUSIONES

EL TRATAMIENTO QUIRÃšRGICO PREPROTESICO EN PACIENTES CON MAXILARES ATRÃ“FICOS Y CONDICIONES SISTÃ‰MICAS COMO DIABETES, HIPERTENSIÃ“N REQUIERE UNA PLANIFICACIÃ“N INTEGRAL Y CENTRADA EN LAS NECESIDADES DEL PACIENTE. A PESAR DE LAS COMPLICACIONES PRESENTADAS, LA EVOLUCIÃ“N DEL CASO FUE FAVORABLE, LOGRANDO UN SOPORTE Ã“SEO ADECUADO PARA LA REHABILITACIÃ“N IMPLANTOLÃ“GICA.

Bibliografía *

1. TERHEYDEN H, RAGHOEBAR GM, SJÃ–STRÃ–M M, STARCH-JENSEN T, CAWOOD J. PREPROSTHETIC SURGERY-NARRATIVE REVIEW AND CURRENT DEBATE. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. 2023 NOV 23;12(23):7262.

2. AVILA?ORTIZ G, VEGH D, KHALED MUKADDAM, GALINDO?MORENO P, BJARNI PJETURSSON, PAYER M. TREATMENT ALTERNATIVES FOR THE REHABILITATION OF THE POSTERIOR EDENTULOUS MAXILLA. PERIODONTOLOGY 2000. 2023 JUL 24;93(1):183â€“204.

3. EPHROS H, KLEIN R, SALLUSTIO A. PREPROSTHETIC SURGERY. ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY CLINICS OF NORTH AMERICA. 2015 AUG 1;27(3):459â€“72.

4. AVILA-ORTIZ G, PJETURSSON BE, LANG NP. MAXILLARY SINUS FLOOR AUG-MENTATION. IN: BERGLUNDH T, GIANNOBILE WV, LANG NP, SANZ M, EDS. LINDHE S CLINICAL PERIODONTOLOGY AND IMPLANT DENTISTRY. 7TH ED. 2021

Título del trabajo *

MANEJO DE RECESIONES GINGIVALES CON TÃ‰CNICA TÃšNEL CON CIERRE LATERAL

Nombre del Autor (a/es)*

C.D. GÃ³mez Martnez Tania

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

D.C.F. Pietschmann SantamarÃ-a MarÃ-a de los Ãngeles, C.D. Furrer Franco Elsa Patricia, M.C.O. Morones Machado Olaf, C.D. BermÃºdez Machado Cristina, , , , , .

Correo Electrónico *

Tania.gomez@uadec.edu.mx

Institución *

UNIVERSIDAD AUTÃ“NOMA DE COAHUILA

Introducción y Objetivos *

LA RECESIÃ“N GINGIVAL ES EL DESPLAZAMIENTO APICAL DEL MARGEN GINGIVAL RESPECTO A LA UNIÃ“N CEMENTO-ESMALTE (CEJ) EN DIENTES O A LA PLATAFORMA DE IMPLANTES, ASOCIADA CON LA PÃ‰RDIDA DE TEJIDOS PERIODONTALES Y PERIIMPLANTARIOS. LAS INDICACIONES CLÃ NICAS PARA SU TRATAMIENTO INCLUYEN SENSIBILIDAD DENTINARIA, PROGRESIÃ“N DE LA RECESIÃ“N, CARIES RADICULARES, LESIONES CERVICALES NO CARIOSAS Y DEMANDAS ESTÃ‰TICAS. EN ZONAS VISIBLES, SE BUSCA NO SOLO LA COBERTURA RADICULAR, SINO TAMBIÃ‰N PRESERVAR LA ARMONÃ A DEL CONTORNO GINGIVAL. LA TÃ‰CNICA DE TÃšNEL CON CIERRE LATERAL PERMITE TRATAR RECESIONES MÃšLTIPLES DE FORMA MÃ NIMAMENTE INVASIVA, FAVORECIENDO LA CICATRIZACIÃ“N AL CONSERVAR LA VASCULARIZACIÃ“N PAPILAR. ESTE CASO CLÃ NICO PRESENTA LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS REALIZAR UNA

Descripción del Caso *

PACIENTE MASCULINO DE 18 AÃ‘OS, SISTÃ‰MICAMENTE SANO (ASA I), ACUDIÃ“ A LA CLÃ NICA DE LA MAESTRÃ A EN PERIODONCIA DE LA FOUAC UL REFIRIENDO SENSIBILIDAD DENTAL. EL EXAMEN CLÃ NICO REVELÃ“ RECESIONES GINGIVALES MÃšLTIPLES EN LOS CUADRANTES 2 (OD 22 AL 26) Y 3 (OD 34 AL 35), CLASIFICADAS COMO RT1 SEGÃšN LA CLASIFICACIÃ“N DE CAIRO (2011). SE INDICÃ“ TRATAMIENTO QUIRÃšRGICO DE COBERTURA RADICULAR MEDIANTE LA TÃ‰CNICA DE TÃšNEL CON CIERRE LATERAL, EMPLEANDO UN INJERTO GINGIVAL LIBRE EN BLOQUE, DESEPITELIZADO EXTRAORALMENTE.

Resultados y Conclusiones *

LAS CITAS DE SEGUIMIENTO DURANTE LOS PRIMEROS DÃ□AS (5, 14 Y 21) EVIDENCIARON UNA COBERTURA RADICULAR INICIAL FAVORABLE Y UNA ADECUADA CICATRIZACIÃ“N DEL Ã□REA QUIRÃšRGICA. EL CONTROL A LOS 2 AÃ‘OS MOSTRÃ“ UNA COBERTURA RADICULAR ESTABLE Y ALTAMENTE SATISFACTORIA (95-100%), ASÃ□ COMO UN ASPECTO CLÃ□NICO SALUDABLE DE LOS TEJIDOS. EL PACIENTE REPORTÃ“ DESAPARICIÃ“N COMPLETA DE LA SENSIBILIDAD DENTAL Y MANIFESTÃ“ SATISFACCIÃ“N CON LOS RESULTADOS ESTÃ‰TICOS OBTENIDOS.

Bibliografía *

1. IMBER JC, KASAJ A. TREATMENT OF GINGIVAL RECESSION: WHEN AND HOW? VOL. 71, INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL. ELSEVIER INC.; 2021. P. 178â€“87.

2. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD O. 9 AVANCES EN PERIODONCIA/ RECESIÃ“N GINGIVAL. DIAGNÃ“STICO Y TRATAMIENTO GINGIVAL RECESSION. DIAGNOSIS AND TREATMENT GARCÃ□A-RUBIO A* BUJALDÃ“N-DAZA AL** RODRÃ□GUEZ-ARCHILLA A***.

3. NART J, VALLES C. SUBEPITHELIAL CONNECTIVE TISSUE GRAFT IN COMBINATION WITH A TUNNEL TECHNIQUE FOR THE TREATMENT OF MILLER CLASS II AND III GINGIVAL RECESSIONS IN MANDIBULAR INCISORS: CLINICAL AND ESTHETIC RESULTS. INT J PERIODONTICS RESTORATIVE DENT. 2016 JUL;36(4):591â€“8.

4. SCULEAN A, ALLEN E. THE LATERALLY CLOSED TUNNEL FOR THE TREATMENT OF DEEP ISOLATED MANDIBULAR RECESSIONS: SURGICAL TECHNIQUE AND A REPORT OF 24 CASES. INT J PERIODONTICS RESTORATIVE DENT. 2018 JUL;38(4).

5. REBELE SF, THALMAIR PRAXIS THALMAIR T, FICKL S. ARTICLE IN EUROPEAN JOURNAL OF ESTHETIC DENTISTRY?: OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF ESTHETIC DENTISTRY [INTERNET]. 2009.

Título del trabajo *

ELEVACIÃ“N INTRACRESTAL DE PISO DE SENO MAXILAR MEDIANTE SISTEMA VERSAH. REPORTE DE CASO CLÃ NICO

Nombre del Autor (a/es)*

C.D. Laura Aguilar Pineda

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

C.D.E.P e I. JosÃ© Guadalupe Figueroa, C.D.E.P e I. Pollyanna del Consuelo Gil MartÃ-nez, , , , , , , .

Correo Electrónico *

laura.aguilar@cemro.edu.mx

Institución *

CENTRO EDUCATIVO MULTIDISCIPLINARIO EN REHABILITAC

Introducción y Objetivos *

LA ATROFIA DEL REBORDE POSTERIOR DEL MAXILAR ES UNA CONDICIÃ“N COMÃšN TRAS LA PÃ‰RDIDA DENTARIA, DIFICULTA LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES DENTALES POR ESCASA ALTURA Ã“SEA, EL PISO DE SENO MAXILAR ES DE CONSISTENCIA FRA?GIL Y DELGADA (1). MISH (1984) PRESENTA CLASIFICACIÃ“N DEL REBORDE ALVEOLAR RESIDUAL, SEGÃšN EL ESPACIO DISPONIBLE EN SENTIDO VERTICAL, UN GRADO III ES CUANDO LA ALTURA Ã“SEA ESTÃ COMPRENDIDA ENTRE 4 Y 8 MM(2). LA TÃ‰CNICA DE ELEVACIO?N ATRAUMA?TICA LLAMADA TRANSALVEOLAR, TRANSCRESTAL, O INDIRECTA DE PISO DE SENO MAXILAR CON OSTEOTÃ“MOS ES TE?CNICA DESCRITA POR DR. SUMMERS Y ESTÃ BASADA EN LA APLICACIO?N DE DICHO INSTRUMENTAL PARA COMPACTAR, ENSANCHAR, TRANSPORTAR Y ELEVAR EL HUESO, TANTO EN ZONA ANTERIOR COMO POSTERIOR DE LA MAXILA, SU DESVENTAJA TÃ‰CNICA TRAUMÃTICA(3). EN ÃšLTIMOS AÃ‘OS, SE HAN DESARROLLADO TÃ‰CNICAS MÃNIMAMENTE INVASIVAS; HUWAIS & MEYER (2017) PRESENTAN EL SISTEMA VERSHAÂ® QUE UTILIZA FRESAS DENSAHÂ®, PERMITE MEJORAR LOS RESULTADOS CLÃNICOS, REDUCIR TRAUMA QUIRÃšRGICO Y ACELERAR LA RECUPERACIÃ“N, ESTE ABORDAJE SE BASA EN EL PRINCIPIO DE PRESERVACIÃ“N Y DENSIFICACIÃ“N DEL HUESO EN LUGAR DE REMOCIÃ“N Ã“SEA, HA DEMOSTRADO ALTOS ÃNDICES DE Ã‰XITO ESPECIALMENTE EN REBORDES CON ALTURAS Ã“SEAS RESIDUALES ENTRE 4 Y 8 MM, DONDE LA COLOCACIÃ“N DIRECTA DE IMPLANTES DENTALES NO SERÃA POSIBLE SIN UNA INTERVENCIÃ“N ADICIONAL, LA OSEODENSIFICACIÃ“N PERMITE OBTENER GANANCIAS Ã“SEAS VERTICALES DE HASTA 2 MM SIN LA NECESIDAD DE INJERTOS ADICIONALES (4). EL SISTEMA UTILIZA FRESAS EN ROTACIÃ“N REVERSA O ANTIHORARIO, PERMITE PREPARAR EL LECHO IMPLANTARIO SIN EXTRAER TEJIDO Ã“SEO, LOGRANDO COMPACTACIÃ“N LATERAL Y APICAL DEL HUESO, ASÃ COMO, UN AUTOINJERTO SIMULTÃNEO DENTRO DE LA OSTEOTOMÃA, ESTE ENFOQUE FACILITA ELEVACIÃ“N CONTROLADA Y SEGURA DE LA MEMBRANA SINUSAL, DISMINUYENDO EL RIESGO DE PERFORARLA Y MEJORAR LA ESTABILIDAD PRIMARIA DEL IMPLANTE(5). EL OBJETIVO ES DEMOSTRAR, LA EFICACIA DEL SISTEMA VERSHAÂ® COMO ALTERNATIVA MÃNIMAMENTE INVASIVA EN LA ELEVACIÃ“N DE PISO DE SENO MAXILAR.

Descripción del Caso *

SE PRESENTÃ“ A CLÃ?NICA DEL POSGRADO DE PERIODONCIA CEMRO, PACIENTE FEMENINO DE 46 AÃ‘OS. AHF PADRES Y ABUELOS DIABÃ‰TICOS, PADRE HIPERTENSO. APP DM2; CLASIFICACIÃ“N ASA II. MEDICAMENTOS QUE TOMA SITAGLIPTINA CON METFORMINA 50/850 MG 1C/12HRS. MOTIVO DE CONSULTA â€œSE MUEVE MI PUENTE LADO DERECHO Y DUELEâ€?. CLÃ?NICAMENTE PRESENTÃ“ PUENTE FIJO 2.4 A 2.6 DESAJUSTADO CON MOVILIDAD 2. EXPLORACIÃ“N PERIODONTAL MUESTRA PBS HASTA 5 MM, UCE 6 MM, Y NIS 3 A 4 MM 49.16%; SAS DE 20.83%, SIN SUPURACIÃ“N, Y 40.78% DE IBB. RADIOGRÃ?FÃ?A PERIAPICAL 2.4 CORONA DEGOLLADA EN CERVICAL. T. A. C. CORTE SAGITAL 2.5 ALTURA DE CRESTA Ã“SEA A PISO DE SENO MAXILAR 6.64 MM Y GROSOR Ã“SEO 3.50 MM. SE DIAGNOSTICÃ“ PERIODONTITIS ESTADIO IV GENERALIZADA GRADO A, ATROFIA TIPO III DE MISH. PLAN DE TRATAMIENTO: FASE I HIGIÃ‰NICA IBB, MODIFICACIÃ“N HÃ?BITOS DE HIGIENE BUCAL, DETARTRAJE SELECTIVO, PULIDO DENTAL Y REVALORACIÃ“N; FASE II ELEVACIÃ“N DE PISO DE SENO MAXILAR IZQUIERDO INTRACRESTAL CON COLOCACIÃ“N INMEDIATA DE IMPLANTE DENTAL; FASE III PROTÃ‰SICA IMPLANTAR PUENTE TRES UNIDADES ATORNILLADO E-MAX Y FASE IV TERAPIA PERIO-IMPLANTAR DE SOPORTE PROTOCOLO SANZ Y BASCONES (2017). PRONÃ“STICO FAVORABLE NO PRESENTA PATOLOGÃ?A SINUSAL. OBTENIDO CONSENTIMIENTO INFORMADO COMENZÃ“ TRATAMIENTO. FASE I HIGIÃ‰NICA ARROJÃ“ 12% DE IBB. QUIRÃšRGICAMENTE SE ANESTESIA TE?CNICA INFRAORBITARIA, TE?CNICA INFILTRATIVA PALATINA ANTERIOR CON ARTIKAINA AL 4%; INCISIÃ“N CRESTAL REALIZADA, PARA POSTERIOR ELEVAR COLGAJO TRAPEZOIDAL A ESPESOR TOTAL; MARCACIÃ“N INICIAL FRESA LANZA SISTEMA VERSHAÂ®, PROFUNDIDAD 2 MM ANTES DE SUELO SINUSAL; LA OSTEOTOMÃ?A INICIÃ“ CON FRESAS DENSAHÂ®, USANDO OSEODENSIFICACIÃ“N ROTACIÃ“N ANTIHORARIA A 800 RPM IRRIGACIÃ“N ABUNDANTE; EXPANSIÃ“N SECUENCIAL PROGRESIVA; INTRODUCCIÃ“N XENOINJERTO A-OSS HIOSSENÂ® REUTILIZANDO ÃšLTIMA FRESA DENSAHÂ® A 150 RPM MANTIENDO ANTIHORARIO, MOVIMIENTO BOMBEO SUAVE COMPACTANDO HUESO APICAL Y ELEVANDO SUAVEMENTE LA MEMBRANA SCHNEIDER. COLOCACIÃ“N IMPLANTE DENTAL DIOÂ® UF II 3.8 X 8.5. SE SUTURÃ“ MEDIANTE PUNTOS SIMPLES CON NYLON 5-0. SE DIERON CUIDADOS POSTOPERATORIOS.

Resultados y Conclusiones *

EN ESTE CASO CLÃ□NICO EL INCREMENTO DE ALTURA Ã“SEA QUE SE OBTUVO EN LA VISTA SAGITAL DE LA T. A. C. DESPUÃ‰S DE 9 MESES DE LA ELEVACIÃ“N TRANSCRESTAL DE PISO DE SENO MAXILAR IZQUIERDO FUE DE 11.1 MM, MEDIANTE LA COMPACTACIÃ“N Ã“SEA APICAL ASISTIDA CON EL USO DE FRESAS DENSAHÂ® DEL SISTEMA VERSHAÂ® Y USO DE XENOINJERTO A-OSS HIOSSENÂ® PERMITIENDO UNA ELEVACIÃ“N CONTROLADA DE LA MEMBRANA DE SCHNEIDER. AL MEDIR DE LA BASE DE PISO DE SENO MAXILAR A LA CRESTA Ã“SEA DEL REBORDE RESIDUAL EN LAS ZONA MENCIONADA SE OBSERVÃ“ LOS 8.5 MM DE LONGITUD DEL IMPLANTE DENTAL, ASÃ□ COMO, LA DISTANCIA DE 2.6 MM QUE EXISTEN DE PISO DE SENO MAXILAR A LA PARTE MÃ□S APICAL DEL IMPLANTE DENTAL, DANDO EL INCREMENTO TOTAL MENCIONADO. POR LO QUE SE CONCLUYE QUE LA EFICACIA DEL SISTEMA VERSHAÂ® COMO ALTERNATIVA MÃ□NIMAMENTE INVASIVA EN LA ELEVACIÃ“N DE PISO DE SENO MAXILAR PERMITE UNA ELEVACIÃ“N CONTROLADA DE LA MEMBRANA DE SCHNEIDER MEDIANTE COMPACTACIÃ“N Ã“SEA APICAL TRANSCRESTAL ASISTIDA CON EL USO DE FRESAS DENSAHÂ® DEL SISTEMA VERSHAÂ® Y XENOINJERTO A-OSS HIOSSENÂ® DANDO COMO VENTAJAS QUE NO EXISTA PERFORACIÃ“N DE LA MEMBRANA, SANGRADO O COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS, SIENDO UNA INTERVENCIÃ“N ATRAUMÃ□TICA, PREDECIBLE Y EFICIENTE PARA REBORDE MAXILAR POSTERIOR ATRÃ“FICO.

Bibliografía *

1. MACÃ□AS-LLORET A, PARRA-ROGEL C. MAXILLARY SINUS LIFT SURGERY: â€œUSEFULNESS OF DIFFERENT TECHNIQUES.â€□ CLINICAL CASE OF SINUS LIFT AND PLACEMENT PHIBO TSH AND TSA IMPLANTS. AV ODONTOESTOMATOL [INTERNET].2023 [CITADO 2025 AGO 12]; 39(4): 191-200. DISPONIBLE EN: HTTP://SCIELO.ISCIII.ES/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S021312852023000400006&LNG=ES. EPUB 18-DIC-2023.

2. GONZA?LEZ MENDOZA E, HERNA?NDEZ CALVA A. TECHNICAL CONSIDERATIONS IN ACTIVE MAXILLARY SINUS LIFTS: A REVIEW OF LITERATURE. REVISTA ADM 2015; 72 (1): 14-20. HTTPS://WWW.MEDIGRAPHIC.COM/PDFS/ADM/OD-2015/OD151D.PDF

3. BLASE DV, DRICOT RG, LASSERRE JF, TOMA S, BRECX MC. COMBINATION OF A HYDRAULIC DEVICE AND NANOHYDROXYLAPATITE PASTE FOR MINIMALLY INVASIVE TRANSCRESTAL SINUS FLOOR ELEVATION: PROCEDURE AND 4-YEAR RESULTS. INT J ORAL MAXILLOFAC IMPLANTS. 2021;36(3):587-597. DOI:10.11607/JOMI.6092

4. CISTERNAS-COVARRUBIAS SEBASTIÃ□N, SÃ□NCHEZ-VARELA MARTÃ□N, BRENNER-AGOSÃ□N CLAUDIO. EVALUATION OF DIMENSIONAL CHANGES IN WIDTH AND HEIGHT OF THE ALVEOLAR BONE RIDGE USING THE

Título del trabajo *

ALARGAMIENTO DE CORONA ESTÃ‰TICO EN EL TRATAMIENTO DE ERUPCIÃ“N PASIVA ALTERADA: REPORTE DE CASO CLÃ□NICO

Nombre del Autor (a/es)*

C.D. Sarai Garcia Quezada

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Mtra. Dalia GuzmÃ¡n, Mtro. Eligio Valera Gonzalez, CD. Daniel Coronado, CD. Jorge Ruiz, , , , , .

Correo Electrónico *

garciaquezadasarai23@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUÃ□REZ

Introducción y Objetivos *

INTRODUCCION

LA ERUPCIÃ“N PASIVA ALTERADA ES UNA CONDICIÃ“N CLÃ NICA RELACIONADA CON UNA ALTERACIÃ“N FISIOLÃ“GICA EN LA FASE FINAL DEL PROCESO DE ERUPCIÃ“N DENTAL, QUE POR DISTINTAS RAZONES PROVOCA ALGUNA INTERFERENCIA EN EL REPOSICIONAMIENTO DE LA CRESTA Ã“SEA ALVEOLAR (COA) Y/O DEL MARGEN GINGIVAL. LA CARACTERÃ STICA CLÃ NICA MÃ S EVIDENTE DE ESTA ALTERACIÃ“N SON LAS CORONAS CLÃ NICAS CORTAS, Y DEBE ENTENDERSE COMO UNA VARIACIÃ“N DE LA NORMALIDAD Y NO COMO UNA PATOLOGÃ A.

DE ETIOLOGÃ A DESCONOCIDA, PERO PUEDE ESTAR RELACIONADO CON UN BIOTIPO GRUESO/ FIBROSO O ALTERACIONES OCLUSALES CON UN ALTO COMPONENTE MUSCULAR DURANTE LA FASE DE CRECIMIENTO.

EL TRATAMIENTO PARA LA ERUPCIÃ“N PASIVA ALTERADA ES EL ALARGAMIENTO DE CORONA ESTÃ‰TICO, EL CUAL ES UNA TÃ‰CNICA QUIRÃšRGICA QUE TIENE COMO OBJETIVO EXPONER LA CORONA ANATÃ“MICA PARA MEJORAR EL ASPECTO DE LA SONRISA GINGIVAL.

OBJETIVO

PRESENTAR EL TRATAMIENTO DE ERUPCIÃ“N PASIVA ALTERADA MEDIANTE CIRUGÃ A PERIODONTAL PARA CORREGIR LAS DIMENSIONES DE LA CORONA CLÃ NICA Y DEVOLVER LA ESTÃ‰TICA.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINO DE 64 AÃ‘OS DE EDAD ACUDE A CONSULTA A LA UNIVERSIDAD AUTÃ“NOMA DE CIUDAD JUÃ REZ BUSCANDO MEJORAR EL ASPECTO DE SU SONRISA, AL INTERROGATORIO COMENTA PADECER EPILEPSIA DESDE HACE 30 AÃ‘OS, Y ESTAR MEDICADA CON FENITOÃ NA DESDE ENTONCES. SU DIAGNÃ“STICO FUE SALUD PERIODONTAL Y PRESENCIA DE ERUPCIÃ“N PASIVA ALTERADA EN EL SECTOR ANTERIOR SUPERIOR.

SE LE REALIZO EL EXAMEN PERIODONTAL INCLUYENDO SONDAJE PERIODONTAL, LOCALIZACIÃ“N DE LA LÃ NEA AMELOCEMENTARIA Y EL ANCHO DEL TEJIDO QUERATINIZADO, CON UNA EVALUACIÃ“N RADIOGRÃ FICA Y TOMA DE CBCT. ASÃ MISMO, SE TOMARON IMPRESIONES PARA CREAR UN ENCERADO DIAGNÃ“STICO ESTÃ‰TICO QUE PERMITA FABRICAR UN MOCK UP. ALGO A DESTACAR FUE QUE NO SE REALIZÃ“ ALARGAMIENTO ESTÃ‰TICO EN OD 21 Y 11 YA QUE PRESENTABAN RAÃ CES ENANAS Y LA PROPORCIÃ“N CORONA RAÃ Z NO ERA LA IDEAL PARA REALIZAR DICHO TRATAMIENTO. SE COMENZÃ“ MIDIENDO CON UNA SONDA PERIODONTAL CAROLINA DEL NORTE LAS CORONAS CLÃ NICAS, Y MARCANDO LA LONGITUD DESEADA A REALIZAR LA PREVIA GINGIVECTOMIA EN CADA UNA DE LAS CORONAS, UNA VEZ MARCADA LOS PUNTOS DE REFERENCIA, SE REALIZÃ“ UNA INCISIÃ“N A BISEL INTERNO CON UNA HOJA DE BISTURÃ 15 C, FORMANDO EL CENIT Y LA NUEVA LONGITUD DESEADA Y RETIRANDO EL CUELLO DE TEJIDO CON UNA CURETA. SE REALIZÃ“ INCISIÃ“N PARCIAL EN PAPILAS Y DESPUÃ‰S TOTAL, PARA GARANTIZAR LA PRESERVACIÃ“N DE LA PAPILA INTERDENTAL, CREANDO UN COLGAJO DE OD 14 AL OD 24, AL LEVANTAR EL COLGAJO A ESPESOR PARCIAL EN PAPILAS Y TOTAL EN Ã REA VESTIBULAR PROCEDIMOS A REALIZAR LAS MEDICIONES DE LA UNIÃ“N CEMENTO ESMALTE A NUESTRA CRESTA PRÃ“XIMA, RETIRANDO ÃšNICAMENTE POR MEDIO DE UNA OSTEOTOMÃ A. UNA VEZ REALIZADA LA OSTEOPLASTIA NECESARIA, REPOSICIONAMOS COLGAJO DESEPITELIZANDO EL Ã REA DE PAPILAS PARA CONFRONTAR DE NUEVO EL COLGAJO CON SUS PAPILAS. SE REALIZÃ“ TÃ‰CNICA DE SUTURA COLCHONERO VERTICAL CON NYLON 5-0 AGUJA DE 12 MM, ENTRE CADA PAPILA CREANDO UN CIERRE COMPLETO DEL COLGAJO, POSTERIOR A ESTO SE LE DA INDICACIONES A LA PACIENTE.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS

SE REALIZÃ“ SEGUIMIENTO POSTOPERATORIO A LAS 2 SEMANAS PARA EL RETIRO DE SUTURAS Y SE OBSERVÃ“ UN Ã“PTIMO RESULTADO, CON BUENA ARQUITECTURA DE LOS TEJIDOS PERIODONTALES Y UN AUMENTO EN SUS CORONAS CLÃ?NICAS EN EL CUAL OBSERVAMOS UNA MEJORÃ?A ESTÃ‰TICA.

CONCLUSIONES

PARA CONSEGUIR UN MEJOR RESULTADO EN LA CIRUGÃ?A ESTÃ‰TICA PERIODONTAL, SE RECOMIENDA OBTENER UN DIAGNÃ“STICO CORRECTO, DETERMINAR EL FENOTIPO DEL PACIENTE Y APOYARNOS CON IMAGENOLOGÃ?A. DE ESTA MANERA, ES POSIBLE MEJORAR LA ESTÃ‰TICA Y LOS RESULTADOS EN LA CIRUGÃ?A PERIODONTAL.

Bibliografía *

1. LEE 2004; CHAMBRONE Y AVILA-ORTIZ 2022.
2. COSLET Y COLS. 1977; NART Y COLS. 2014.

Título del trabajo *

COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES DENTALES TRAS EXTRACCIÃ“N INJUSTIFICADA POR DIAGNÃ“STICO ERRÃ“NEO DE NEURALGIA DEL TRIGÃ‰MINO: REPORTE DE CASO

Nombre del Autor (a/es)*

Leal Barrera Eva Margarita, Santiago Meza Osmara

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

GÃ³mez Franco CÃ©sar Paul, Montoya Salcedo Juan Carlos, , , , , , , .

Correo Electrónico *

evaleal1703@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Introducción y Objetivos *

LA EXTRACCIÃ“N DENTAL ES UN PROCEDIMIENTO INVASIVO QUE DEBE REALIZARSE ÃšNICAMENTE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE EL DIENTE NO PUEDE SER PRESERVADO. SIN EMBARGO, LAS EXTRACCIONES INJUSTIFICADAS SON RELATIVAMENTE FRECUENTES. SE HA REPORTADO QUE, EN MUCHOS CASOS, ESTAS SE DEBEN A ERRORES DIAGNÃ“STICOS, SIENDO LA NEURALGIA DEL NERVIO TRIGÃ‰MINO (NT) UNA DE LAS AFECCIONES MÃS COMÃšNMENTE INVOLUCRADAS.

LA NT ES UN PROBLEMA DE SALUD GRAVE, SE CARACTERIZA POR DOLORES BREVES UNILATERALES RECURRENTES, QUE SE DESENCADENAN POR ESTÃMULOS INOCUOS.

CABE DESTACAR QUE LA NT ES LA NEURALGIA CRANEAL MÃS FRECUENTE, NO OBSTANTE, ES UNA ENTIDAD INUSUAL CON INCIDENCIAS REPORTADAS DE 4,5 CASOS POR CADA 100,000 PERSONAS, CON MAYOR PREVALENCIA EN MUJERES ENTRE LOS 50 Y 70 AÃ‘OS.

LOS IMPLANTES DENTALES REPRESENTAN UNA ALTERNATIVA PARA SUSTITUIR A LOS DIENTES FALTANTES, SU UTILIZACIÃ“N SE HA CONVERTIDO EN UNA MODALIDAD INTERGRAL EN LA PRÃCTICA ODONTOLÃ“GICA. LOS IMPLANTES DENTALES PRESENTAN DIVERSAS VENTAJAS EN COMPARACIÃ“N CON LAS PRÃ“TESIS PARCIALES FIJAS CONVENCIONALES.

EL OBJETIVO ES PRESENTAR UNA ALTERNATIVA DE REHABILITACIÃ“N MEDIANTE LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES DENTALES TRAS UNA EXTRACCIONES INJUSTIFICADAS POR DIAGNÃ“STICO INCORRECTO DE NEURALGIA DEL TRIGÃ‰MINO.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINA DE 40 AÃ‘OS ACUDE A CONSULTA CON EL MOTIVO: â€œQUIERO HACER CAMBIO DE DIENTES Y VER LA POSIBILIDAD DE COLOCAR IMPLANTESâ€. PRESENTA ANTECEDENTES MÃ‰DICOS DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 E HIPOTIROIDISMO, POR LO QUE TOMA LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS: METFORMINA 850 MG (1 CADA 24 H), LINAGLIPTINA 5 MG (1 CADA 24 H) Y LEVOTIROXINA SÃ“DICA 100 MCG (1 CADA 24 H).

FUE CLASIFICADA COMO ASA II.

LA PACIENTE RECIBIÃ“ TRATAMIENTO DE ORTODONCIA DURANTE TRES AÃ‘OS Y TUVO MÃšLTIPLES EXTRACCIONES DENTALES (11, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 46, 47 Y 48), DERIVADAS DE DIAGNÃ“STICOS IMPRECISOS.

PREVIO AL PROCEDIMIENTO, SE REALIZÃ“ ASEPSIA INTRAORAL MEDIANTE ENJUAGUE CON CLORHEXIDINA AL 0.12%.

BAJO ANESTESIA LOCAL, SE REALIZARON INCISIONES HORIZONTALES PARA LEVANTAR COLGAJOS TANTO EN LA REGIÃ“N DE PREMOLAR A MOLAR DEL CUADRANTE SUPERIOR IZQUIERDO COMO EN LA ZONA ANTERIOR, CON EL FIN DE EXPONER LAS ÃREAS QUIRÃšRGICAS

CON LA AYUDA DE UNA GUÃA QUIRÃšRGICA SEMI RESTRICTIVA, SE IDENTIFICARON LAS POSICIONES PARA LA COLOCACIÃ“N DE LOS IMPLANTES. POSTERIORMENTE, SE INICIÃ“ EL PROTOCOLO DE FRESADO UTILIZANDO EL KIT STRAUMANN, Y SE COLOCARON LOS SIGUIENTES IMPLANTES CON PLATAFORMA SLACTIVE:

-EN LA REGIÃ“N DE PRIMER PREMOLAR Y PRIMER MOLAR (CUADRANTE SUPERIOR IZQUIERDO), SE COLOCARON DOS IMPLANTES BLT DE 4.1 MM DE DIÃMETRO POR 8 MM DE LONGITUD (RC).

-EN LA REGIÃ“N ANTERIOR (POSICIÃ“N 11), SE COLOCÃ“ UN IMPLANTE BLX DE 3.5 MM DE DIÃMETRO POR 10 MM DE LONGITUD (RB).

SE OBTUVO UN TORQUE DE 30 NCM EN TODOS LOS IMPLANTES. LOS COLGAJOS FUERON SUTURADOS CON PUNTOS SIMPLES. EN LA ZONA ANTERIOR SE REALIZÃ“ UNA PROVISIONALIZACIÃ“N SIN CARGA.

Resultados y Conclusiones *

DESPUÃ‰S DE LA PÃ‰RDIDA DENTAL CAUSADA POR UN DIAGNÃ“STICO INCORRECTO DE NEURALGIA DEL TRIGÃ‰MINO, SE REALIZÃ“ LA REHABILITACIÃ“N MEDIANTE LA COLOCACIÃ“N DE TRES IMPLANTES STRAUMANN. LA PLANIFICACIÃ“N DIGITAL PERMITIÃ“ UNA COLOCACIÃ“N PRECISA EN POSICIÃ“N, ANGULACIÃ“N Y PROFUNDIDAD.

LA PROVISIONALIZACIÃ“N SIN CARGA EN LA ZONA ANTERIOR, LOGRÃ“ MANTENER LA ESTÃ‰TICA DURANTE EL PROCESO DE CICATRIZACIÃ“N. TRANSCURRIDAS DOS SEMANAS, SE OBSERVÃ“ UNA ADECUADA CICATRIZACIÃ“N.

ESTE CASO DESTACA LO IMPORTANTE QUE ES UN DIAGNÃ“STICO PRECISO Y MULTIDISCIPLINARIO ANTES DE REALIZAR EXTRACCIONES DENTALES, EN ESPECIAL EN PACIENTES QUE MANIFIESTAN DOLOR OROFACIAL. LA NT, AUNQUE SE MANIFIESTA CON DOLOR INTENSO, NO ES JUSTIFICANTE PARA LA EXTRACCIÃ“N DE DIENTES SANOS.

POR OTRO LADO, LA REHABILITACIÃ“N CON IMPLANTES UTILIZANDO EL FLUJO DIGITAL Y SIENDO GUIADOS QUIRÃšRGICAMENTE, REPRESENTA UNA OPCIÃ“N EFICAZ Y SEGURA PARA RECUPERAR FUNCIÃ“N Y ESTÃ‰TICA TRAS LA PÃ‰RDIDA DENTAL INJUSTIFICADA.

Bibliografía *

-HASSAN AF, AL SHEAKH A, BADRAN SA, MAHMOOD AA, ALHAMDANI FY. MISDIAGNOSIS-DRIVEN DENTAL EXTRACTIONS IN PATIENTS WITH TRIGEMINAL NEURALGIA: A RETROSPECTIVE STUDY. J MULTIDISCIP HEALTHC [INTERNET]. 2025;18:1999â€“2005. DISPONIBLE EN: HTTP://DX.DOI.ORG/10.2147/JMDH.S518948

-TRIPATHI M, SADASHIVA N, GUPTA A, JANI P, PULICKAL SJ, DEORA H, ETÂ AL. PLEASE SPARE MY TEETH! DENTAL PROCEDURES AND TRIGEMINAL NEURALGIA. SURG NEUROL INT [INTERNET]. 2020;11(455):455. DISPONIBLE EN: HTTP://DX.DOI.ORG/10.25259/SNI_729_2020

-GUPTA R, GUPTA N, WEBER DKK. DENTAL IMPLANTS. EN: STATPEARLS. TREASURE ISLAND (FL): STATPEARLS PUBLISHING; 2025.

-HENDRIX JM, GARMON EH. AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS PHYSICAL STATUS CLASSIFICATION

Título del trabajo *

GUÃ?A QUIRÃšRGICA ESTACABLE EN TÃ‰CNICA ALL-ON-FOUR Y REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA.

Nombre del Autor (a/es)*

C.D Castellanos Ortiz Alexa Valeria

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

MCO Aguado Arzola Alfredo, D.C.F. Pietschmann SantamarÃ-a MarÃ-a de los Ã?ngeles, D.C.F. Aguado Arzola Martha Margarita,, D.C.F. Reyes Alvarado Lizeth Alejandra., , , , , .

Correo Electrónico *

castellanos-a@uadec.edu.mx

Institución *

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA UNIDAD TORREÃ“N

Introducción y Objetivos *

INTRODUCCIÃ“N: EL FLUJO DIGITAL EN IMPLANTOLOGÃ□A CONSTITUYE UN AVANCE IMPORTANTE EN LA PLANIFICACIÃ“N Y EJECUCIÃ“N DE LOS PROCEDIMIENTOS, FAVORECIENDO UNA MAYOR PRECISIÃ“N Y PREDICTIBILIDAD EN LOS RESULTADOS CLÃ□NICOS. LAS GUÃ□AS QUIRÃšRGICAS ESTACABLES REPRESENTAN UNA INNOVACIÃ“N EN LA CIRUGÃ□A IMPLANTOLÃ“GICA ASISTIDA DIGITALMENTE, AL PERMITIR LA EJECUCIÃ“N SECUENCIAL Y PRECISA DE DISTINTAS FASES QUIRÃšRGICAS, COMO LA REDUCCIÃ“N Ã“SEA, LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES Y LA ADAPTACIÃ“N PROTÃ‰SICA. ESTAS GUÃ□AS, DISEÃ‘ADAS DIGITALMENTE E IMPRESAS EN 3D, OFRECEN MAYOR PRECISIÃ“N, REDUCEN EL TIEMPO QUIRÃšRGICO Y MEJORAN LA PREDICTIBILIDAD EN TRATAMIENTOS COMO EL PROTOCOLO ALL-ON-FOUR.

EL OBJETIVO DE ESE CASO CLÃ□NICO ES PRESENTAR UN REPORTE DE CASO CLÃ□NICO QUE DEMUESTRE LA APLICACIÃ“N DE LA IMPLANTOLOGÃ□A GUIADA POR FLUJO DIGITAL MEDIANTE EL USO DE GUÃ□A QUIRÃšRGICA ESTACABLE EN LA REHABILITACIÃ“N TOTAL DEL MAXILAR INFERIOR CON TÃ‰CNICA ALL-ON-FOUR Y REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA, DESTACANDO LA PLANIFICACIÃ“N DIGITAL, LA EJECUCIÃ“N PRECISA DE LAS FASES QUIRÃšRGICAS Y LOS RESULTADOS FUNCIONALES OBTENIDOS.

Descripción del Caso *

PACIENTE MASCULINO DE 62 AÃ‘OS, ASA I, SE PRESENTÃ“ A CONSULTA PARA VALORAR LOS Ã“RGANOS DENTALES 33 Y 43. A LA EXPLORACIÃ“N CLÃ□NICA Y RADIOGRÃ□FICA SE OBSERVÃ“ PÃ‰RDIDA Ã“SEA SEVERA Y MOVILIDAD GRADO 3. EL PRONÃ“STICO ES POBRE, POR LO QUE SE DETERMINÃ“ LA NECESIDAD DE UNA REHABILITACIÃ“N TOTAL DEL MAXILAR INFERIOR.

LA CIRUGÃ□A SE LLEVÃ“ A CABO UTILIZANDO UNA GUÃ□A QUIRÃšRGICA ESTACABLE DISEÃ‘ADA DIGITALMENTE, COMPUESTA POR TRES FASES PRINCIPALES QUE ASEGURAN LA PRECISIÃ“N Y EL CONTROL EN CADA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO.

LA PRIMERA FUE LA GUÃ□A DE FIJACIÃ“N, DISEÃ‘ADA PARA ASENTARSE DIRECTAMENTE SOBRE EL HUESO CORTICAL TRAS LA ELEVACIÃ“N DEL COLGAJO Y ES FIJADA CON PINES DE FIJACIÃ“N. ESTA GUÃ□A PROPORCIONA ESTABILIDAD Y UNA REFERENCIA ANATÃ“MICA EXACTA PARA LAS FASES SIGUIENTES.

POSTERIORMENTE, SE COLOCÃ“ LA GUÃ□A DE REDUCCIÃ“N Ã“SEA, LA CUAL PERMITIÃ“ REALIZAR UNA OSTEOTOMÃ□A CONTROLADA CON EL PIEZOELÃ‰CTRICO. ESTA FASE ES FUNDAMENTAL PARA ESTABLECER UNA PLATAFORMA Ã“SEA UNIFORME Y ADECUADA QUE GARANTICE LA CORRECTA EMERGENCIA DE LOS PILARES PROTÃ‰SICOS.

SEGUIDAMENTE, SE POSICIONÃ“ LA GUÃ□A DE FRESADO E INSERCIÃ“N DE IMPLANTES STRAUMANN BLX. ESTA GUÃ□A ASEGURÃ“ EL PARALELISMO DE LOS IMPLANTES Y SU UBICACIÃ“N EN RELACIÃ“N DIRECTA CON EL DISEÃ‘O DE LA PRÃ“TESIS INMEDIATA.

TRAS LA COLOCACIÃ“N DE LOS IMPLANTES, SE REALIZÃ“ REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA EN EL IMPLANTE UBICADO EN LA POSICIÃ“N 33, UTILIZANDO UNA COMBINACIÃ“N DE ALOINJERTO Y AUTOINJERTO TOMADO DEL TORUS LINGUAL DEL PACIENTE Y SE COLOCÃ“ MEMBRANA REABSORBIBLE OSSIX VOLUMAX.

EL COLGAJO SE CERRÃ“ CON PUNTOS SIMPLES Y COLCHONEROS HORIZONTALES CON NYLON 5-0. FINALMENTE, SE COLOCÃ“ LA PRÃ“TESIS INMEDIATA AJUSTADA SOBRE LOS PILARES PROTÃ‰SICOS.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS

LA PLANIFICACIÃ“N Y EJECUCIÃ“N QUIRÃšRGICA MEDIANTE EL FLUJO DIGITAL Y LA UTILIZACIÃ“N DE LA GUÃ□A QUIRÃšRGICA ESTACABLE PERMITIERON REALIZAR EL PROCEDIMIENTO CON ALTA PRECISIÃ“N Y CONTROL EN CADA ETAPA. LA OSTEOTOMÃ□A GUIADA CON PIEZOELÃ‰CTRICO FACILITÃ“ UNA REDUCCIÃ“N Ã“SEA UNIFORME Y SEGURA. LA COLOCACIÃ“N DE LOS IMPLANTES STRAUMANN BLX FUE EXACTA Y PARALELA, ACORDE AL DISEÃ‘O PROTÃ‰SICO DIGITAL, ASEGURANDO UNA ADECUADA DISTRIBUCIÃ“N DE CARGAS.

LA PRÃ“TESIS INMEDIATA FUE ADAPTADA CON Ã‰XITO, LOGRANDO UNA REHABILITACIÃ“N FUNCIONAL Y ESTÃ‰TICA TEMPRANA PARA EL PACIENTE.

CONCLUSIONES

EL USO DE LA IMPLANTOLOGÃ□A GUIADA POR FLUJO DIGITAL CON GUÃ□AS QUIRÃšRGICAS ESTACABLES ES UNA HERRAMIENTA EFECTIVA PARA LA PLANIFICACIÃ“N Y REALIZACIÃ“N PRECISA DE PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS COMO LA REHABILITACIÃ“N TOTAL DEL MAXILAR INFERIOR CON TÃ‰CNICA ALL-ON-FOUR. LA INTEGRACIÃ“N DE LA REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA CONTRIBUYE A LA ESTABILIDAD Y Ã‰XITO A LARGO PLAZO DE LOS IMPLANTES, ESPECIALMENTE EN SITIOS CON PÃ‰RDIDA Ã“SEA SEVERA.

ESTE ENFOQUE DIGITAL MEJORA LA PREDICTIBILIDAD, REDUCE TIEMPOS QUIRÃšRGICOS Y FACILITA LA COLOCACIÃ“N DE PRÃ“TESIS INMEDIATAS FUNCIONALES, OPTIMIZANDO LOS RESULTADOS CLÃ□NICOS Y LA SATISFACCIÃ“N DEL PACIENTE.

Bibliografía *

1. KIM MJ, JEONG JY, RYU J, JUNG S, PARK HJ, OH HK, ET AL. ACCURACY OF DIGITAL SURGICAL GUIDES FOR DENTAL IMPLANTS. MAXILLOFAC PLAST RECONSTR SURG. 2022;44(1).

2. DEBORTOLI C, AFOTA F, LATRECHE S, ZAMMILLO F, BOUJENAH O, SAVOLDELLI C. STACKABLE GUIDE IN IMPLANTOLOGY: A TECHNICAL NOTE. J STOMATOL ORAL MAXILLOFAC SURG. 2023;124(6).

3. ABDELAZIZ MS, TELLA EAESAEM. DIGITAL DESIGN AND MANUFACTURE OF A STACKABLE IMPLANT SURGICAL GUIDE FOR IMMEDIATE LOADING IN COMPLETELY EDENTULOUS FULL-ARCH CASES: A DENTAL TECHNIQUE. QUINTESSENCE INT (BERL). 2023;54(9).

4. YANG JW, LIU Q, YUE ZG, HOU JX, AFRASHTEHFAR KI. DIGITAL WORKFLOW FOR FULL-ARCH IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT USING A STACKABLE SURGICAL GUIDE FABRICATED USING SLM TECHNOLOGY. JOURNAL OF PROSTHODONTICS. 2021;30(8).

5. LU J, YU J, XIE C, GAO J, YU H. IMMEDIATE PRECISION OF THE DIGITAL OSTEOTOMY TEMPLATE IN THE DIGITAL STACKABLE TEMPLATE: A CLINICAL STUDY. HUA XI KOU QIANG YI XUE ZA ZHI / WEST CHINA JOURNAL OF STOMATOLOGY. 2021;39(6).

Título del trabajo *

TRATAMIENTO DE MELANOSIS FISIOLÃ“GICA MEDIANTE LÃ SER DE DIODO: REPORTE DE CASO CLÃ NICO

Nombre del Autor (a/es)*

Citlalli Ma. JosÃ© PÃ©rez Novoa, Martha Patricia Ram

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Alondra del Carmen Ruiz GutiÃ©rrez., , Martha Patricia Ramos Reyes, , , , , , .

Correo Electrónico *

citlalli.perez7328@alumnos.udg.mx

Institución *

ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA. DEPARTAMENTO DE CLÃ NI

Introducción y Objetivos *

LA CAVIDAD BUCAL ESTÃ REVESTIDA POR MUCOSA, QUE SE CLASIFICA EN MUCOSA DE REVESTIMIENTO, MASTICATORIA Y ESPECIALIZADA. LA MUCOSA MASTICATORIA INCLUYE LA ENCÃA ADHERIDA, QUE RODEA CIRCUNFERENCIALMENTE LOS Ã“RGANOS DENTALES Y CONSTITUYE UNO DE LOS CUATRO TEJIDOS QUE FORMAN EL PERIODONTO. CLÃNICAMENTE, LA ENCÃA ADHERIDA SE CARACTERIZA POR SU COLOR ROSADO CORAL, QUE PUEDE VARIAR SEGÃšN EL GRADO DE QUERATINIZACIÃ“N, LA VASCULARIZACIÃ“N, EL ESPESOR EPITELIAL Y LA PRESENCIA DE MELANINA.

LA MELANINA ES UN PIGMENTO ENDÃ“GENO QUE SE CLASIFICA SEGÃšN SU TONALIDAD EN EUMELANINA (NEGRO-MARRÃ“N) Y FEOMELANINA (ROJO-AMARILLENTO), SINTETIZADAS Y ALMACENADAS EN LOS MELANOSOMAS DE LOS MELANOCITOS. EL INCREMENTO EN LA SÃNTESIS DE MELANINA PUEDE MANIFESTARSE COMO MELANOSIS FISIOLÃ“GICA, CARACTERIZADA POR PIGMENTACIONES BILATERALES DIFUSAS, MARRONES O PÃšRPURA INTENSO, PRINCIPALMENTE EN LA MUCOSA MASTICATORIA (60%), Y FRECUENTE EN PERSONAS DE PIEL MORENA, SIN PREDILECCIÃ“N DE GÃ‰NERO O EDAD. AUNQUE ESTA HIPERPIGMENTACIÃ“N SE CONSIDERA UNA VARIANTE NORMAL, SU IMPACTO ESTÃ‰TICO PUEDE GENERAR PREOCUPACIÃ“N EN LOS PACIENTES.

DIVERSAS TÃ‰CNICAS SE HAN DESARROLLADO PARA REDUCIR O ELIMINAR LA HIPERPIGMENTACIÃ“N GINGIVAL, DESTACANDO LA TERAPIA LÃSER POR SU EFICACIA. EL LÃSER PERMITE LA DESPIGMENTACIÃ“N CON MÃNIMA PERCEPCIÃ“N DE DOLOR Y EXCELENTE CONTROL HEMOSTÃTICO. EN PARTICULAR, EL LÃSER DE DIODO PRESENTA MENOR RECURRENCIA PIGMENTARIA EN COMPARACIÃ“N CON OTROS TIPOS DE LÃSER, FAVORECIENDO UNA MAYOR ESTABILIDAD CROMÃTICA DE LA ENCÃA A LARGO PLAZO.

OBJETIVO: REPORTAR EL MANEJO DE MELANOSIS FISIOLÃ“GICA CON TERAPIA LÃSER BIOLASE EPICâ„¢

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINA DE 45 AÃ‘OS DE EDAD ACUDE A LA ESPECIALIDAD DE PERIODONCIA CON MOTIVO DE CONSULTA â€œNO ME GUSTAN MIS ENCÃ□ASâ€□, A LA REVISIÃ“N INTRA-ORAL SE OBSERVÃ“ INFLAMACIÃ“N GINGIVAL GENERALIZADA, PIGMENTACIONES MARRONES BIEN DELIMITADAS EN Ã□REA DE MUCOSA MASTICATORIA EN EL SEXTANTE ANTERIOR, MÃšLTIPLES AUSENCIAS DENTALES, DIASTEMA ENTRE Ã“RGANO DENTAL (O.D.) 11,12 Y 21, RESTAURACIONES INDIRECTAS, PROFUNDIDADES AL SONDEO (PS) MAYORES A 4 MM EN LOS O.D. 11, 23, 47 Y 35, SANGRADO AL SONDEO DE 35% Y PLACA Y CALCULO DE 40%, RADIOGRÃ□FICAMENTE SE OBSERVÃ“ PÃ‰RDIDA Ã“SEA HORIZONTAL GENERALIZADA, POR LO QUE SE DIAGNOSTICÃ“ CON PERIODONTITIS ESTADIOS II GRADO B, A SU VEZ LA MUCOSA MASTICATORIA REVELÃ“ UN PATRÃ“N MORFOLÃ“GICO HABITUAL DE MELANOSIS FISIOLÃ“GICA. EL PLAN DE TRATAMIENTO CONSISTIÃ“ EN LA: 1) FASE HIGIÃ‰NICA, CORRECTIVA Y DE MANTENIMIENTO. EN LA FASE HIGIENICA; SE INDICÃ“ TÃ‰CNICA DE HIGIENE, RASPADO Y ALISADO RADICULAR, 2) FASE CORRECTIVA; LA MELANOSIS FISIOLÃ“GICA SE TRATÃ“ CON LÃ□SER DE ALTA POTENCIA DE 940NM (BIOLASE EPICâ„¢ 10). SE ANESTESIÃ“ EL SECTOR ANTERIOR DE AMBAS ARCADAS, SE UTILIZÃ“ UNA PUNTA QUIRÃšRGICA ACTIVADA DE 400 MICRAS, EN CONTACTO CON LOS TEJIDOS BLANDOS DE LAS Ã□REAS PIGMENTADAS CON UN MOVIMIENTO DE BARRIDO LENTO DE MESIAL A DISTAL/CORONAL HACIA APICAL EN INTERVALOS MÃ□XIMOS DE 10 SEGUNDOS ABLACIONANDO LA PRIMERA CAPA DEL EPITELIO HASTA OBSERVAR LA ELIMINACIÃ“N DE LA PIGMENTACIÃ“N, SE HUMEDECIÃ“ CUIDADOSAMENTE TODA LA SUPERFICIE DEL EPITELIO PARA REHIDRATAR LA ZONA Y ELIMINAR DETRITOS DE TEJIDO ABLACIONADO. POSTERIORMENTE SE REALIZÃ“ FOTOBIOMODULACIÃ“N CON LÃ□SER DE BAJA POTENCIA [AR1] [CN2] DE 810NM (DMC THERAPY) CON APLICACIÃ“N PUNTUAL DE 2J CON UN INTERVALO DE SEPARACIÃ“N 1CM APROXIMADAMENTE ENTRE CADA PUNTO A LO LARGO DE TODA LA EXTENSIÃ“N QUIRÃšRGICA PARA ESTIMULAR LOS FIBROBLASTOS Y QUERATINOCITOS, FINALMENTE SE INDICÃ“ SPRAY CON CLORHEXIDINA 0.2% Y Ã□CIDO HIALURÃ“NICO 1% DURANTE 15 DÃ□AS ASÃ□ COMO ESQUEMA ANALGÃ‰SICO. SE CITÃ“ A LA PACIENTE A LOS 7, 21 DÃ□AS Y 1 MES PARA EL SEGUIMIENTO FOTOGRÃ□FICO

Resultados y Conclusiones *

A LOS 7 DÃ□AS POSTOPERATORIOS SE OBSERVÃ“ EPITELIZACIÃ“N PARCIAL DE LAS Ã□REAS INTERVENIDAS, CON AUSENCIA DE SIGNOS INFLAMATORIOS AGUDOS Y UNA ADECUADA TOLERANCIA AL PROCEDIMIENTO POR PARTE DE LA PACIENTE. A LOS 21 DÃ□AS, LA ENCÃ□A PRESENTÃ“ UN ASPECTO CLÃ□NICO HOMOGÃ‰NEO, COLOR ROSADO CORAL CARACTERÃ□STICO, SIN EVIDENCIA DE RECIDIVA PIGMENTARIA. AL MES, SE EVIDENCIÃ“ UNA COMPLETA EPITELIZACIÃ“N, ESTABILIDAD EN LA TONALIDAD DE LA ENCÃ□A Y MEJORÃ□A ESTÃ‰TICA PERCIBIDA Y REFERIDA POR LA PACIENTE, SIN COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS. NO SE DETECTARON SIGNOS DE HIPERSENSIBILIDAD O MOLESTIAS DURANTE EL SEGUIMIENTO.

CONCLUSIÃ“N: LA DESPIGMENTACIÃ“N GINGIVAL MEDIANTE LÃ□SER DE DIODO DE ALTA POTENCIA COMPLEMENTADA CON FOTOBIOMODULACIÃ“N DE BAJA POTENCIA DEMOSTRÃ“ SER UN PROCEDIMIENTO SEGURO, MÃ□NIMAMENTE INVASIVO Y EFICAZ PARA EL MANEJO DE LA MELANOSIS FISIOLÃ“GICA, PROPORCIONANDO UNA RECUPERACIÃ“N RÃ□PIDA, ESTABILIDAD Y ALTA SATISFACCIÃ“N ESTÃ‰TICA.

EL PROTOCOLO UTILIZADO FAVORECIÃ“ UN CONTROL HEMOSTÃ□TICO Ã“PTIMO, AUSENCIA DE RECIDIVA TEMPRANA, LO QUE RESPALDA SU INDICACIÃ“N EN CASOS DONDE LA ESTÃ‰TICA GINGIVAL ES UNA PRIORIDAD PARA EL PACIENTE.

ESTE CASO REFUERZA LA UTILIDAD DEL LÃ□SER COMO ALTERNATIVA DE ELECCIÃ“N FRENTE A OTRAS TÃ‰CNICAS QUIRÃšRGICAS, DEBIDO A SU PRECISIÃ“N, CONFORT POSTOPERATORIO Y PREVISIBILIDAD EN LOS RESULTADOS.

Bibliografía *

AZZEH, M. M. (2007). TREATMENT OF GINGIVAL HYPERPIGMENTATION FOR ESTHETIC PURPOSES BY ERBIUM-DOPED: YTTRIUM, ALUMINUM, AND GARNET LASER FOR ESTHETIC PURPOSES [GINGIVAL HYPERPIGMENTATION TREATMENT WITH ER:YAG LASER]. JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, 78(1), 177â€“184.

ABDULJABBAR, T., VOHRA, F., AKRAM, Z., AB GHANI, S. M., AL-HAMOUDI, N., & JAVED, F. (2017). EFFICACY OF SURGICAL LASER THERAPY IN THE MANAGEMENT OF ORAL PIGMENTED LESIONS: A SYSTEMATIC REVIEW. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B: BIOLOGY, 173, 353â€“359.

YAMAGUCHI, Y., & HEARING, V. J. (2014). MELANOCYTES AND THEIR DISEASES. COLD SPRING HARBOR PERSPECTIVES IN MEDICINE, 4(5), A017046.

LAMBERTINI, M., PATRIZI, A., RAVAIOLI, G. M., & DIKA, E. (2018). ORAL PIGMENTATION IN PHYSIOLOGIC CONDITIONS, POST-INFLAMMATORY AFFECTIONS AND SYSTEMIC DISEASES. GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA : ORGANO UFFICIALE, SOCIETA ITALIANA DI DERMATOLOGIA E SIFILOGRAFIA, 153(5), 666â€“671.

WOLK, R., MASSI, D., & TROCHESSET, D. (2025). PIGMENTED LESIONS OF THE ORAL MUCOSA: CLINICAL PRESENTATION. HISTOLOGY. AND RECOMMENDATIONS FOR MANAGEMENT. AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL

Título del trabajo *

â€œREGENERACIÃ“N OSEA GUIADA CON COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES EN EL SECTOR ESTETICO MEDIANTE FLUJOS DIJITALESâ€

Nombre del Autor (a/es)*

JosÃ© Antonio Cerda DÃ-az, Cheysy AnahÃ- Ãlvarez Puen

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Paul ObregÃ³n Godina, Juan Antonio Cepeda Bravo, Everardo Ruiz Cruz, , , , , , .

Correo Electrónico *

antoniodiaz.1095@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

Introducción y Objetivos *

LA IMPLANTOLOGÃ A HA EVOLUCIONADO DESDE UN TRATAMIENTO EXPERIMENTAL HASTA UNA OPCIÃ“N ALTAMENTE PREDECIBLE PARA REEMPLAZAR LOS DIENTES PERDIDOS. LA SIMPLIFICACION DEL TIEMPO EN EL ABORDAGE QUIRURGICO ES UN PUNTO CRITICO CONSIDERABLE EN EL Ã‰XITO DE LA REGENERACIÃ“N OSEA GUIADA (ROG) ASI COMO TAMBIEN OTROS FACTORES A CONSIDERAR PREVIOS A LA COLOCACION DE IMPLANTES COMO LO SON LA CALIDAD Y EL VOLUMEN DEL HUESO ALVEOLAR YA QUE ESTOS PUEDEN COMPROMETER LA POSICION DEL IMPLANTE, LA ESTABILIDAD PRIMARIA Y LA RECUPERACION DEL TEJIDO BLANDO. LA ROG TIENE COMO FINALIDAD PREVENIR SELECTIVAMENTE LAS CÃ‰LULAS EPITELIALES Y LAS CÃ‰LULAS DEL TEJIDO CONECTIVO DEL Ã REA DEL DEFECTO Ã“SEO A TRAVÃ‰S DE UNA MEMBRANA DE BARRERA. LA APLICACIÃ“N DE MALLAS DE TITANIO SE DEBE A SUS PROPIEDADES MECÃ NICAS, SU ALTA RESISTENCIA Y RIGIDEZ, LA CUAL PERMITE UN SOPORTE ESPACIAL PARA LA OSTEOGÃ‰NESIS Y UNA GRAN ESTABILIDAD PARA MANTENER EL VOLUMEN DEL INJERTO Ã“SEO DURANTE LA CICATRIZACIÃ“N DE LA HERIDA. DEBIDO A SU BUENA PLASTICIDAD , LA MALLA DE TITANIO PUEDE ADAPTARSE A DIVERSOS DEFECTOS Ã“SEOS. ESTAS CARACTERÃ STICAS PERMITEN QUE LA ROG CON MALLA DE TITANIO MUESTRE UN EFECTO DE OSTEOGÃ‰NESIS ALTAMENTE ESTABLE Y LOGRE UN AUMENTO Ã“SEO INSTANTÃ NEO EN DIRECCIONES HORIZONTALES Y VERTICALES. GERNERANDO ASI UN LECHO QUIRURGICO IDEAL PARA LA COLOCACION DE LOS IMPLANTES Y SU POSTERIOR REHABILITACIÃ“N.

OBJETIVO: OBTENER UNA REGENERACION OSEA GUIADA EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL PERMITIENDO LA COLOCACION DE IMPLANTES DENTALES MEDIANTE CIRUGIA GUIADA.

Descripción del Caso *

FEMENINA DE 54 AÃ‘OS SIN ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS. EN EL EXAMEN CLÃ□NICO SE OBSERVA SEVERA ATROFIA DEL REBORDE ALVEOLAR SUPERIOR EN EL SECTOR ANTERIOR, EL CUAL ES CLASIFICADO COMO UN DEFECTO COMBINADO MEDIANO DE ACUERDO CON WANG Y AL-SHAMMARI. AL SONDAJE SE OBSERVA SANGRADO, MOVILIDAD (OD.13,12,47) ASI COMO BOLSAS PERIODONTALES EN LOS CUATRO CUADRANTES. SE DA UN DIAGNÃ“STICO PERIODONTAL DE PERIODONTITIS ESTADIO III, GRADO C, GENERALIZADA. SE REALIZA LA REGENERACIÃ“N OSEA GUIADA DEL SECTOR ANTERIOR SUPERIOR: INICIANDO CON UNA INCISIÃ“N CRESTAL A PARTIR DEL O.D. 14 AL O.D. 24 Y SE REALIZA UNA LIBERATRIZ HACIA DISTAL DE LA INCISIÃ“N CRESTAL DE AMBOS LADOS. SE ELEVA UN COLGAJO DE ESPESO TOTAL, DEJANDO VISIBLE EL DEFECTO. POSTERIORMENTE SE REALIZA LA LATERIZACIÃ“N DEL NERVIO NASOPALATINO Y SE COLOCA LA MALLA DE TITANIO PREVIAMENTE CONFORMADA EN EL MODELO 3D, LA CUAL ES FIJADA CON TORNILLOS DE TITANIO DE 6MM. UNA VEZ FIJADA LA MALLA SE PROCEDE A COLOCAR LA COMBINACION DE LOS INJERTOS OSEOS SOBRE EL DEFECTO, SE POCISIONA LA MALLA SOBRE LE INJERTO OSEO Y SE FIJA POR LA ZONA VESTIBULAR CON 4 TORNILLOS DE TITANIO DE 6MM, POSTERIORMENTE SE COLOCA UNA MEMBRANA DE COLAGENO SOBRE LA MALLA Y SE REPOSICIONA EL COLGAJO. SE SUTURA CON NYLON 5-0, CON 2 COLCHONEROS HORIZONTALES PARA LIBERAR LA TENCIÃ“N DEL COLGAJO Y PUNTOS SIMPLES EN LA INCISIÃ“N CRESTAL Y LIBERATRIZ. LAS SUTURAS SE RETIRARON EN 2 SEMANAS, LA CICATRIZACIÃ“N TRANSCURRIÃ“ SIN INCIDENTES. POSTERIORMENTE A LOS 12 MESES SE RETIRO LA MALLA DE TITANIO Y SE COLOCARON IMPLANTES DE 3.3 X 10 MM EN LA ZONA PERTENECIENTE A LOS OD.13,11,21,23., MEDIANTE CIRUGIA GUIADA EN LA ZONA REGENERADA.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS

LA UTILIZACIÃ“N DE FLUJOS DIGITALES EN LA CIRUGÃ□A PERIODONTAL DISMINUYE SIGNIFICATIVAMENTE EL ABORDAJE QUIRÃšRGICO Y SIMPLIFICA LOS PROCEDIMIENTOS DE REGENERACIÃ“N Ã“SEA E IMPLANTOLOGÃ□A. DE ACUERDO A DIVERSAS REVISIONES SISTEMÃ□TICAS REALIZADAS SE ESTABLECE UNA GANANCIA Ã“SEA EN SENTIDO VERTICAL (5,4 Â± 3,4 MM) Y EN SENTIDO HORIZONTAL (3,7 Â± 2,0 MM) CON LA UTILIZACIÃ“N DE MALLAS DE TITANIO. LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN NUESTRO CASO FUERON UNA GANANCIA Ã“SEA VERTICAL (5.64MM) Y UNA GANANCIA Ã“SEA HORIZONTAL (2.71MM) POR LO CUAL ESTOS RESULTADOS SON COMPARABLES CON LOS REPORTADOS EN LA LITERATURA, YA QUE EN SENTIDO VERTICAL SE CUMPLIÃ“ SATISFACTORIAMENTE CON LA TASA DE REGENERACIÃ“N Ã“SEA REPORTADA, MIENTRAS QUE EN SENTIDO HORIZONTAL NOS MANTUVIMOS CON UNA TASA DE RENEGACIÃ“N Ã“SEA POR ENCIMA DE LA MEDIA, ASÃ□ MISMO SE MANTUVO UNA ESTABILIDAD DE LOS TEJIDOS BLANDOS Y MEJORAS EN EL FENOTIPO GINGIVAL A TRAVÃ‰S DE LA UTILIZACIÃ“N DE MEMBRANAS DE COLÃ□GENO, EVITANDO LA EXPOSICIÃ“N DE LA MALLA DE TITANIO Y LOGRANDO UNA ROG SIN COMPLICACIONES, GENERANDO CONDICIONES FAVORABLES PARA EL POSICIONAMIENTO IDEAL DE LOS IMPLANTES DENTALES.

CONCLUSION

LA APLICACIÃ“N DE FLUJOS DIGITALES EN LA ROG Y EN COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES GENERA DOS PRINCIPALES BENEFICIOS, EL PRIMERO DE ELLOS SERÃ□ UNA REDUCCIÃ“N EN EL TIEMPO QUIRÃšRGICO Y EL SEGUNDO LA FACILIDAD DEL MANEJO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS. LA APLICACIÃ“N DE MALLAS DE TITANIO EN ROG EN COMPARACIÃ“N CON MEMBRANAS DE COLÃ□GENO O MEMBRANAS DE PTFE GENERA UNA

Bibliografía *

â€¢ JEPSEN, S., SCHWARZ, F., CORDARO, L., DERKS, J., HÃ„MMERLE, C. H. F., HEITZ-MAYFIELD, L. J., HERNÃ□NDEZ-ALFARO, F., MEIJER, H. J. A., NAENNI, N., ORTIZ-VIGÃ“N, A., PJETURSSON, B., RAGHOEBAR, G. M., RENVERT, S., ROCCHIETTA, I., ROCCUZZO, M., SANZ-SÃ□NCHEZ, I., SIMION, M., TOMASI, C., TROMBELLI, L., & URBAN, I. (2019). REGENERATION OF ALVEOLAR RIDGE DEFECTS. CONSENSUS REPORT OF GROUP 4 OF THE 15TH EUROPEAN WORKSHOP ON PERIODONTOLOGY ON BONE REGENERATION. JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, 46 SUPPL 21, 277â€“286.

â€¢ BUSER, D., SENNERBY, L., & DE BRUYN, H. (2017). MODERN IMPLANT DENTISTRY BASED ON OSSEOINTEGRATION: 50 YEARS OF PROGRESS, CURRENT TRENDS AND OPEN QUESTIONS. PERIODONTOLOGY 2000, 73(1), 7â€“21.

â€¢ XIE, Y., LI, S., ZHANG, T., WANG, C., & CAI, X. (2020). TITANIUM MESH FOR BONE AUGMENTATION

Título del trabajo *

MANEJO SISTÃ‰MICO E INTERDISCIPLINARIO DE PERIODONTITIS ESTADIO IV GENERALIZADA GRADO C: DE LA ESTABILIZACIÃ“N PERIODONTAL A LA REHABILITACIÃ“N FUNCIONAL. REPORTE DE CASO.

Nombre del Autor (a/es)*

Miguel Francisco GonzÃ¡lez Tapia

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Juan Antonio Cepeda Bravo, , Paul IvÃ¡n ObregÃ³n Godina, , , , , , .

Correo Electrónico *

miguelglz3258@gmail.com

Institución *

ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÃ“

Introducción y Objetivos *

LA PERIODONTITIS ES UNA ENFERMEDAD INFLAMATORIA CRÃ“NICA MULTIFACTORIAL ASOCIADA A BIOPELÃ CULAS DE PLACA DISBIÃ“TICA, CARACTERIZADA POR LA DESTRUCCIÃ“N PROGRESIVA DE LOS TEJIDOS DE SOPORTE DENTARIO. SUS PRINCIPALES MANIFESTACIONES INCLUYEN PÃ‰RDIDA TANTO DE INSERCIÃ“N CLÃ NICA COMO Ã“SEA ALVEOLAR RADIOGRÃ FICAMENTE DETECTABLE, BOLSAS PERIODONTALES Y SANGRADO GINGIVAL. CONSTITUYE UN EJEMPLO DE INTERACCIÃ“N DESEQUILIBRADA ENTRE EL MICROBIOMA LOCAL Y LA RESPUESTA INFLAMATORIA DEL HUÃ‰SPED. EN LAS ÃšLTIMAS DÃ‰CADAS, LA EVIDENCIA CIENTÃ FICA HA CONSOLIDADO LA RELACIÃ“N ENTRE LA PERIODONTITIS Y DIVERSAS AFECCIONES SISTÃ‰MICAS CRÃ“NICAS. EL TRATAMIENTO DE LA PERIODONTITIS ESTADIO IV NO SOLO REQUIERE EL CONTROL DE LA INFLAMACIÃ“N, SINO TAMBIÃ‰N LA RECUPERACIÃ“N DE UNA DENTICIÃ“N FUNCIONAL Y LA IMPLEMENTACIÃ“N DE UN PROGRAMA RIGUROSO DE TERAPIA DE SOPORTE ANTES, DURANTE Y DESPUÃ‰S DE LA REHABILITACIÃ“N. EL OBJETIVO DEL CASO ES LOGRAR UNA ESTABILIZACIÃ“N PERIODONTAL Y EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS TEJIDOS PARA PERMITIR UNA REHABILITACIÃ“N FUNCIONAL Y ESTÃ‰TICA MEDIANTE UN ABORDAJE SISTÃ‰MICO E INTERDISCIPLINARIO.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINA DE 47 AÃ‘OS CON ANTECEDENTES DE ESTEATOSOSIS HEPÃ□TICA NO ALCOHÃ“LICA Y MIOMATOSIS UTERINA QUE ACUDIÃ“ A LA CLÃ□NICA DE LA ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA DE LA UASLP, CON ACUMULACIÃ“N DE BIOPELÃ□CULA, MOVILIDAD DENTARIA, AUSENCIAS DENTALES, INFLAMACIÃ“N SEVERA, BOLSAS PERIODONTALES PROFUNDAS Y PÃ‰RDIDA DE INSERCIÃ“N GENERALIZADA. EL DIAGNÃ“STICO DE PERIODONTITIS ESTADIO IV GENERALIZADA GRADO C SE ESTABLECIÃ“ MEDIANTE EXAMEN CLÃ□NICO, SONDAJE PERIODONTAL COMPLETO Y EVALUACIÃ“N RADIOGRÃ□FICA. EL PLAN DE TRATAMIENTO SE BASÃ“ EN LAS GUÃ□AS DE PRÃ□CTICA CLÃ□NICA DE LA FEDERACIÃ“N EUROPEA DE PERIODONTOLOGÃ□A E INCLUYÃ“ UNA FASE SISTÃ‰MICA QUE CONSTÃ“ DE INTERCONSULTAS MÃ‰DICAS Y CAMBIO EN LOS HÃ□BITOS DE ALIMENTACIÃ“N DE LA PACIENTE PARA MEJORAR EL CONTROL METABÃ“LICO; UNA FASE INICIAL DE CONTROL DE LA BIOPELÃ□CULA (INSTRUCCIONES DE HIGIENE ORAL, RASPADO Y ALISADO RADICULAR, EXTRACCIONES), SEGUIDA DE TERAPIA QUIRÃšRGICA REGENERATIVA Y RESECTIVA EN SITIOS SELECCIONADOS Y TERAPIA MUCOGINGIVAL PARA LOGRAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS TEJIDOS PARA LA POSTERIOR REHABILITACIÃ“N. SE REALIZARON AJUSTES OCLUSALES PARA ESTABILIZAR LAS PIEZAS DENTARIAS CON PRONÃ“STICO FAVORABLE. LA REHABILITACIÃ“N PROTÃ‰SICA SE COORDINÃ“ CON LA ESPECIALIDAD EN ODONTOLOGÃ□A ESTÃ‰TICA, COSMÃ‰TICA, RESTAURADORA E IMPLANTOLOGÃ□A PARA RESTABLECER FUNCIÃ“N Y ESTÃ‰TICA.

Resultados y Conclusiones *

TRAS 12 MESES DE SEGUIMIENTO, LA PACIENTE MOSTRÃ“ ESTABILIDAD CLÃ NICA CON UNA DISMINUCIÃ“N DE 2.45 MM DE PROFUNDIDAD AL SONDAJE Y UNA GANANCIA DE INSERCIÃ“N CLÃ NICA DE 1.2 MM, AUSENCIA DE SANGRADO AL SONDAJE Y MEJORÃ A EN LA FUNCIÃ“N MASTICATORIA. EL MANEJO SISTÃ‰MICO E INTERDISCIPLINARIO PERMITIÃ“ ALCANZAR LA ESTABILIZACIÃ“N PERIODONTAL Y EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS TEJIDOS EN UNA PACIENTE CON PERIODONTITIS ESTADIO IV GENERALIZADA GRADO C, CREANDO CONDICIONES Ã“PTIMAS PARA SU REHABILITACIÃ“N FUNCIONAL Y ESTÃ‰TICA. LA AUSENCIA DE SANGRADO AL SONDAJE Y LA MEJORÃ A EN LA FUNCIÃ“N MASTICATORIA TRAS 12 MESES DE SEGUIMIENTO CONFIRMAN LA EFICACIA DEL PLAN DE TRATAMIENTO Y SUBRAYAN LA IMPORTANCIA DE UN ABORDAJE INTEGRAL, INDIVIDUALIZADO Y BASADO EN GUÃ AS DE PRÃ CTICA CLÃ NICA PARA PRESERVAR LA DENTICIÃ“N EN ESTADIOS AVANZADOS DE PERIODONTITIS.

Bibliografía *

PAPAPANOU PN, SANZ M, BUDUNELI N, DIETRICH T, FERES M, FINE DH, ET AL. PERIODONTITIS: CONSENSUS REPORT OF WORKGROUP 2 OF THE 2017 WORLD WORKSHOP ON THE CLASSIFICATION OF PERIODONTAL AND PERI-IMPLANT DISEASES AND CONDITIONS: CLASSIFICATION AND CASE DEFINITIONS FOR PERIODONTITIS. J PERIODONTOL [INTERNET]. 2018;89 SUPPL 1:S173â€“82. SANZ M, HERRERA D, KEBSCHULL M, CHAPPLE I, JEPSEN S, BEGLUNDH T, ET AL. TREATMENT OF STAGE I-III PERIODONTITIS-THE EFP S3 LEVEL CLINICAL PRACTICE GUIDELINE. J CLIN PERIODONTOL [INTERNET]. 2020;47 SUPPL 22(S22):4â€“60.

HERRERA D, SANZ M, KEBSCHULL M, JEPSEN S, SCULEAN A, BERGLUNDH T, ET AL. TREATMENT OF STAGE IV PERIODONTITIS: THE EFP S3 LEVEL CLINICAL PRACTICE GUIDELINE. J CLIN PERIODONTOL [INTERNET]. 2022;49 SUPPL 24(S24):4â€“71.

TRINDADE D, CARVALHO R, MACHADO V, CHAMBRONE L, MENDES JJ, BOTELHO J. PREVALENCE OF PERIODONTITIS IN DENTATE PEOPLE BETWEEN 2011 AND 2020: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF EPIDEMIOLOGICAL STUDIES. J CLIN PERIODONTOL [INTERNET]. 2023;50(5):604â€“26.

HAJISHENGALLIS G, CHAVAKIS T. LOCAL AND SYSTEMIC MECHANISMS LINKING PERIODONTAL DISEASE AND

Título del trabajo *

MODIFICACIÃ“N PREVENTIVA DEL FENOTIPO GINGIVAL CON TÃ‰CNICA VISTA: REPORTE DE CASO CLÃ NICO

Nombre del Autor (a/es)*

Gilberto Reyes Martinez

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Daniel Cerrillo Lara, Francisco Javier de Leon Vigil, , , , , , , .

Correo Electrónico *

gilberto.reyes.martinez@uabc.edu.mx

Institución *

UNIVERSIDAD AUTÃ“NOMA DE BAJA CALIFORNIA, FACULTAD

Introducción y Objetivos *

EL CONCEPTO DE FENOTIPO PERIODONTAL FUE INCORPORADO EN LA CLASIFICACIÃ“N DE 2017 DE ENFERMEDADES Y CONDICIONES PERIODONTALES Y PERIIMPLANTARIAS. ESTE CONCEPTO INCLUYE LAS CARACTERÃ STICAS DEL TEJIDO BLANDO, GROSOR GINGIVAL Y ANCHO DE ENCÃ A QUERATINIZADA Y DEL TEJIDO DURO LA MORFOLOGÃ A DE LA CORTICAL BUCAL. SU EVALUACIÃ“N ES ESENCIAL, YA QUE UN FENOTIPO PERIODONTAL DELGADO SE HA ASOCIADO CON UN MAYOR RIESGO DE RECESIÃ“N GINGIVAL, ESPECIALMENTE EN TRATAMIENTOS ORTODÃ“NTICOS, RESTAURADORES O QUIRÃšRGICOS, ASÃ COMO POR TRAUMA DURANTE EL CEPILLADO.Â[1]

ESTUDIOS HAN REPORTADO UN 20 % A 35 % DE LOS PACIENTES PUEDEN PRESENTAR RECESIÃ“N GINGIVAL ENTRE 2 Y 5 AÃ‘OS DESPUÃ‰S DEL TRATAMIENTO ORTODÃ“NTICO, PARTICULARMENTE CUANDO HAY MOVIMIENTOS DENTALES FUERA DEL PROCESO ALVEOLAR. LA PRESENCIA DE DEHISCENCIAS Ã“SEAS Y UN TEJIDO GINGIVAL DELGADO AUMENTAN SIGNIFICATIVAMENTE ESTE RIESGO.Â[1] Â[2] Â[3]

EN ESTE CONTEXTO, LA MODIFICACIÃ“N DEL FENOTIPO MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE INJERTO DE TEJIDO BLANDO HA SIDO PROPUESTA COMO UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA PARA REDUCIR COMPLICACIONES, AUNQUE LA EVIDENCIA CLÃ NICA SIGUE EN DESARROLLO.Â[1]

LA TOMOGRAFÃ A COMPUTARIZADA DE HAZ CÃ“NICO HA GENERADO UN CAMBIO DE PARADIGMA AL MEJORAR LA COMPRENSIÃ“N DE LA ANATOMÃ A REGIONAL Y AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE TRATAMIENTO PARA ABORDAR LOS DIAGNÃ“STICOS.?

EL OBJETIVO ES ANALIZAR LA EFECTIVIDAD CLÃ NICA DE UNA TERAPIA PREVENTIVA DE MODIFICACIÃ“N DEL FENOTIPO PERIODONTAL, BASADA EN TOMOGRAFÃ A COMPUTARIZADA DE HAZ CÃ“NICO, MEDIANTE INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO SUBEPITELIAL CON TÃ‰CNICA (VISTA) VESTIBULAR INCISION SUBPERIOSTEAL TUNNEL ACCESS POR SUS SIGLAS EN INGLÃ‰S Y FRENILECTOMÃ A LABIAL INFERIOR, EN UN PACIENTE CON FENOTIPO PERIODONTAL DELGADO Y ESCASA ENCÃ A QUERATINIZADA, CON EL PROPÃ“SITO DE ANALIZAR SU IMPACTO EN LA PREVENCIÃ“N DE LA RECESIÃ“N GINGIVAL POSTMOVIMIENTO DENTARIO, LA CORRECCIÃ“N FUNCIONAL DE LA INSERCIÃ“N DEL FRENILLO Y MEJORAR LA SENSACIÃ“N DE IRRITACIÃ“N AL CEPILLADO.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINA DE 21 AÃ‘OS ACUDIÃ“ A LA CLÃ NICA DE PERIODONCIA DE LA UABC, CAMPUS TIJUANA, POR IRRITACIÃ“N AL CEPILLADO EN LOS INCISIVOS INFERIORES. NO SE REPORTARON ANTECEDENTES PATOLÃ“GICOS; LA PACIENTE REFIERE HABER RECIBIDO TRATAMIENTO ORTODÃ“NCICO DURANTE CINCO AÃ‘OS.

EN LA EXPLORACIÃ“N CLÃ NICA SE OBSERVARON APIÃ‘AMIENTO DENTAL, ESCASA ENCÃ A QUERATINIZADA, INSERCIÃ“N ALTA DEL FRENILLO LABIAL INFERIOR Y FENOTIPO GINGIVAL DELGADO. SE SOLICITÃ“ TOMOGRAFÃ A COMPUTARIZADA DE HAZ CÃ“NICO PARA EVALUAR EL GROSOR Y MORFOLOGÃ A DE LAS CORTICALES Ã“SEAS. SE REALIZÃ“ PERIODONTOGRAMA Y FASE HIGIÃ‰NICA, DIAGNOSTICÃ NDOSE SALUD PERIODONTAL Y PRESENCIA DE INSERCIÃ“N FRENILAR ABERRANTE.

PARA LA FASE QUIRÃšRGICA SE PLANIFICÃ“ UNA MODIFICACIÃ“N DEL FENOTIPO GINGIVAL MEDIANTE INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO SUBEPITELIAL Y FRENILECTOMÃ A INTERNA, UTILIZANDO LA TÃ‰CNICA VISTA (VESTIBULAR INCISION SUBPERIOSTEAL TUNNEL ACCESS). LA SUTURA SE LLEVÃ“ A CABO CON POLIAMIDA 5-0 EMPLEANDO PUNTOS SUSPENSORIOS Y SHANELEC. SE INDICARON CUIDADOS POSTOPERATORIOS, INCLUYENDO LA ABSTENCIÃ“N DE CEPILLADO EN LA ZONA INTERVENIDA, Y SE PROGRAMÃ“ UNA CITA DE CONTROL A LAS DOS SEMANAS PARA LA REMOCIÃ“N DE BIOFILM Y RETIRO DE SUTURAS.

DURANTE LA CIRUGÃ A SE REALIZARON TRES INCISIONES VISTA EN MUCOSA ALVEOLAR A ESPESOR TOTAL, LOCALIZADAS DISTAL A LOS CANINOS INFERIORES Y LATERAL AL FRENILLO LABIAL INFERIOR. SE TÃšNELIZÃ“ DESDE LA MUCOSA ALVEOLAR HACIA LA ENCÃ A INSERTADA, COMPLETANDO LA FRENILECTOMÃ A INTERNA HASTA LA ENCÃ A MARGINAL. EL INJERTO GINGIVAL LIBRE, DE 25 X 10 MM, FUE DESEPITELIALIZADO FUERA DE BOCA, DIVIDIDO EN DOS FRAGMENTOS Y UNIDO MEDIANTE SUTURA DE Ã CIDO POLIGLICÃ“LICO 5-0 PARA FORMAR UN INJERTO DE 50 X 5 MM.

EL INJERTO SE POSICIONÃ“ MEDIANTE SUTURAS DE POLIAMIDA 5-0 Y PUNTOS SUSPENSORIOS, FIJÃ NDOSE CON LA TÃ‰CNICA VISTA Y PUNTOS DE SHANELEC. EL SITIO DONANTE FUE TRATADO CON RTM FOAM CYTOPLAST Y SUTURADO CON Ã CIDO POLIGLICÃ“LICO 5-0.

Resultados y Conclusiones *

A LAS DOS SEMANAS POSTOPERATORIAS, SE OBSERVÃ“ UNA INTEGRACIÃ“N ADECUADA DEL INJERTO, CON AUMENTO DEL GROSOR GINGIVAL, SIGNOS DE VASCULARIZACIÃ“N, UNA CORRECTA CICATRIZACIÃ“N TRAS LA FRENILECTOMÃ⍰A Y AL RETOMAR EL CEPILLADO LA SENSACIÃ“N DE IRRITACIÃ“N. NO SE REPORTARON COMPLICACIONES.

LA INCORPORACIÃ“N DE LA TOMOGRAFÃ⍰A COMPUTARIZADA DE HAZ CÃ“NICO (CBCT) HA REPRESENTADO UN CAMBIO DE PARADIGMA EN LA COMPRENSIÃ“N DE LA ANATOMÃ⍰A REGIONAL, PERMITIENDO DIAGNÃ“STICOS MÃ⍰S PRECISOS Y TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS. ESTA HERRAMIENTA HA EVIDENCIADO QUE EL GROSOR DEL HUESO FACIAL ES, EN PROMEDIO, MENOR A 1 MM, LO CUAL, SUMADO A QUE ENTRE EL 66 % Y 75 % DE LOS ADULTOS PRESENTAN ALGÃšN GRADO DE MALOCLUSIÃ“N, SUBRAYA LA IMPORTANCIA DE UNA EVALUACIÃ“N DETALLADA PREVIA A TRATAMIENTOS ORTODÃ“NTICOS O PERIODONTALES.?

EN PACIENTES CON FENOTIPO GINGIVAL DELGADO, O CON BANDAS ANGOSTAS DE ENCÃ⍰A QUERATINIZADA Y MENOS DE 2 MM DE ENCÃ⍰A ADHERIDA, EXISTE UN MAYOR RIESGO DE RECESIÃ“N GINGIVAL. EN ESTOS CASOS, SE RECOMIENDA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE AUMENTO GINGIVAL ANTES DE INICIAR LA TERAPIA ORTODÃ“NTICA.Â[2] ADEMÃ⍰S, ESTOS PACIENTES DEBEN SER CUIDADOSAMENTE MONITOREADOS Y PUEDEN SER CANDIDATOS A CIRUGÃ⍰A MUCOGINGIVAL PROFILÃ⍰CTICA.Â[1]

LA TERAPIA DE MODIFICACIÃ“N DEL FENOTIPO, MEDIANTE EL USO DE INJERTOS AUTÃ“GENOS O SUSTITUTOS, HA DEMOSTRADO MEJORAR EL GROSOR DEL TEJIDO GINGIVAL, DISMINUIR LA PREDISPOSICIÃ“N A LA RECESIÃ“N Y ACTUAR COMO UN FACTOR PREDICTIVO PARA LA ESTABILIDAD DEL MARGEN GINGIVAL A LARGO PLAZO.Â[3] UN TEJIDO GINGIVAL MÃ⍰S GRUESO TAMBIÃ‰N OFRECE MEJOR RESISTENCIA AL TRAUMA, MAYOR FACILIDAD DE MANEJO QUIRÃšRGICO, MENOR INFLAMACIÃ“N CLÃ⍰NICA Y MEJORES RESULTADOS POSTOPERATORIOS. Â[1]

LA TERAPIA ORTODÃ“NTICA FACILITADA QUIRÃšRGICAMENTE (SFOT) DEBE CONSIDERARSE CUANDO EXISTE LA NECESIDAD DE AUMENTO Ã“SEO DENTOALVEOLAR, SIENDO POSIBLE INTEGRARLA CON INJERTO Ã“SEO COMO PARTE DE LA TERAPIA DE MODIFICACIÃ“N DEL FENOTIPO POSTERIOR AL TRATAMIENTO ORTODÃ“NTICO.?

INCLUSO EN AUSENCIA DE RECESIÃ“N GINGIVAL, LA CONVERSIÃ“N DE UN FENOTIPO DELGADO A UNO MÃ⍰S GRUESO HA MOSTRADO BENEFICIOS CLÃ⍰NICOS EN LA PRESERVACIÃ“N DE LA SALUD PERIODONTAL. EL USO DE TÃ‰CNICAS COMO EL COLGAJO POSICIONADO APICALMENTE COMBINADO CON INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO

Bibliografía *

1. KIM, D. M., BASSIR, S. H., & NGUYEN, T. T. (2020). EFFECT OF GINGIVAL PHENOTYPE ON THE MAINTENANCE OF PERIODONTAL HEALTH: AN AMERICAN ACADEMY OF PERIODONTOLOGY BEST EVIDENCE REVIEW. JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, 91(3), 311â€“338. HTTPS://DOI.ORG/10.1002/JPER.19-0337

2. WANG, C.-W., YU, S.-H., MANDELARIS, G. A., & WANG, H.-L. (2020). IS PERIODONTAL PHENOTYPE MODIFICATION THERAPY BENEFICIAL FOR PATIENTS RECEIVING ORTHODONTIC TREATMENT? AN AMERICAN ACADEMY OF PERIODONTOLOGY BEST EVIDENCE REVIEW. JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, 91(3), 299â€“310. HTTPS://DOI.ORG/10.1002/JPER.19-0037

3. BAROOTCHI, S., TAVELLI, L., ZUCCHELLI, G., GIANNOBILE, W. V., & WANG, H.-L. (2020). GINGIVAL PHENOTYPE MODIFICATION THERAPIES ON NATURAL TEETH: A NETWORK META-ANALYSIS. JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, 91(11), 1386â€“1399. HTTPS://DOI.ORG/10.1002/JPER.19-0715

4. MANDELARIS, G. A., HUANG, I., RELLE, R., VENCE, B. S., & DEGROOT, B. S. (2020). SURGICALLY FACILITATED ORTHODONTIC THERAPY (SFOT): DIAGNOSIS AND INDICATIONS IN INTERDISCIPLINARY DENTOFACIAL THERAPY INVOLVING TOOTH MOVEMENT. CLINICAL ADVANCES IN PERIODONTICS, 10(4), 204â€“212.

Título del trabajo *

ORTODONCIA OSTEOGÃ‰NICA ACELERADA PERIODONTALMENTE

Nombre del Autor (a/es)*

Jorge Enrique Orozco Parra

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Monica MagaÃ±a Perez, , , , , , , , .

Correo Electrónico *

jorgeorozco30@hotmail.com

Institución *

UNITEC

Introducción y Objetivos *

ANTECEDENTES

LA CORTICOTOMÃ A CORRESPONDE A UN PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO, BASADO EN EL FENÃ“MENO DE ACELERACIÃ“N REGIONAL. LA ORTODONCIA OSTEOGÃ‰NICA ACELERADA PERIODONTAL ES UN PROCEDIMIENTO QUE COMBINA LA CORTICOTOMÃ A ALVEOLAR SELECTIVA, LA REGENERACIÃ“N Ã“SEA Y LOS MOVIMIENTOS ORTODÃ“NTICOS, PRINCIPALMENTE USADO EN PACIENTES CON DEFECTOS Ã“SEOS.

OBJETIVOS.

AUMENTO DE LA CORTICAL VESTIBULAR, DISMINUIR EL TIEMPO DEL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA, MAYOR ESTABILIDAD POST TRATAMIENTO Y DISMINUIR LA REABSORCIÃ“N RADICULAR APICAL.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINA DE 15 AÃ‘OS SIN ANTECEDENTES PATOLÃ“GICOS SE PRESENTA A CONSULTA POR REFERENCIA DE ORTODONCIA PARA VALORACIÃ“N DEL ESTADO PERIODONTAL, EN TOMOGRAFÃ A SE OBSERVAN DEHISCENCIAS EN Ã“RGANOS DENTALES ANTERIORES INFERIORES Y SUPERIORES.

SE REALIZA CORTICOTOMÃ A MEDIANTE UN COLGAJO A ESPESOR TOTAL CON LA COLOCACIÃ“N DE INJERTO Ã“SEO (XENOINJERTO) Y MEMBRANA DE PERICARDIO FIJADA A PERIOSTIO POSTERIORES A LA CIRUGÃ A LAS CITAS DE LA PACIENTE EN ORTODONCIA FUERON CADA 15 DÃ AS POR 4 MESES.

Resultados y Conclusiones *

SE VALORA PACIENTE A LOS 3 Y 6 MESES POSTERIORES A LA CIRUGÃ A EN LOS CUALES SE OBSERVA UN RÃ PIDO AVANCE EN LOS MOVIMIENTOS DE ORTODONCIA.

A LOS 6 MESES SE SOLICITA UNA TOMOGRAFÃ A DE AMBOS MAXILARES Y SE OBSERVA UN AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA CORTICAL VESTIBULAR EN COMPARACIÃ“N CON LA TOMOGRAFÃ A INICIAL Y EN ORTODONCIA REFIEREN QUE SE LOGRO ACORTAR HASTA EN UN TERCIO EL TRATAMIENTO.

Bibliografía *

LIU X, FAN B, ABDELREHEM A, MA Z, YANG C. MEMBRANE FIXATION FOR OSSEOUS GRAFT STABILIZATION IN PERIODONTALLY ACCELERATED OSTEOGENIC ORTHODONTICS: A COMPARATIVE STUDY. BMC ORAL HEALTH. 2020;20(1):22.

SILVA-STRANGE C, ROJAS-BUSTOS P, SOTO-LAGUNAS F. INFLUENCIA DEL USO DE INJERTOS Ã“SEOS ASOCIADOS A CORTICOTOMÃ A. REVISIÃ“N SISTEMÃ TICA. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY DENTISTRY. 2022;15(3):203â€“6.

BRUGNAMI F, CAIAZZO A, MEHRA P. CAN CORTICOTOMY (WITH OR WITHOUT BONE GRAFTING) EXPAND THE LIMITS OF SAFE ORTHODONTIC THERAPY? J ORAL BIOL CRANIOFAC RES. 2018;8(1):1â€“6.

KAMAL AT, MALIK DES, FIDA M, SUKHIA RH. DOES PERIODONTALLY ACCELERATED OSTEOGENIC ORTHODONTICS

Título del trabajo *

REHABILITACIÃ“N MANDIBULAR CON TÃ‰CNICA ALL-ON-4 CON CIRUGÃ A GUIADA Y PRÃ“TESIS PROVISIONAL IMPRESA: REPORTE DE CASOâ€

Nombre del Autor (a/es)*

Valenzuela Rangel Ana Leticia

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

LÃ³pez Vega JesÃºs Felipe, Peinado Rochin Francisco Javier, Alvarado Torres Emerik, , , , , , .

Correo Electrónico *

ana-lety@outlook.com

Institución *

ESPECIALIDAD DE PERIODONCIA A EN DENTAL CARE CENTR

Introducción y Objetivos *

INTRODUCCIÃ“N

LA TÃ‰CNICA ALL-ON-4 ES UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITE REEMPLAZAR TODOS LOS DIENTES DE UNA ARCADA USANDO SOLO CUATRO IMPLANTES DENTALES. SE COLOCAN DOS IMPLANTES FRONTALES DE FORMA RECTA Y DOS IMPLANTES POSTERIORES EN UN ÃNGULO DE 45 GRADOS. ESTA ANGULACIÃ“N ESTRATÃ‰GICA AYUDA A APROVECHAR AL MÃXIMO EL HUESO DISPONIBLE Y, A MENUDO, ELIMINA LA NECESIDAD DE INJERTOS Ã“SEOS ADICIONALES.

EN LA ÃšLTIMA DÃ‰CADA, LA COMBINACIÃ“N DE CIRUGÃA GUIADA Y REHABILITACIÃ“N IMPLANTOSOPORTADA HA OPTIMIZADO LA PRECISIÃ“N EN LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES, REDUCIDO EL TIEMPO QUIRÃšRGICO Y MEJORADO LA PREDICTIBILIDAD DE LOS RESULTADOS.

LA CIRUGÃA GUIADA, APOYADA EN TOMOGRAFÃA COMPUTARIZADA DE HAZ CÃ“NICO (CBCT) Y ESCANEO INTRAORAL O DE PRÃ“TESIS, PERMITE PLANIFICAR VIRTUALMENTE LA POSICIÃ“N, ANGULACIÃ“N Y PROFUNDIDAD DE LOS IMPLANTES, GARANTIZANDO UN AJUSTE Ã“PTIMO PARA LA FUTURA REHABILITACIÃ“N.

EL USO DE PRÃ“TESIS PROVISIONALES TRAS LA FASE QUIRÃšRGICA OFRECE RESTAURACIÃ“N FUNCIONAL INMEDIATA Y FACILITA LA EVALUACIÃ“N ESTÃ‰TICA Y FONÃ‰TICA ANTES DE LA PRÃ“TESIS DEFINITIVA. ADEMÃS, MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE DURANTE LA OSTEOINTEGRACIÃ“N.

ESTE REPORTE PRESENTA LA REHABILITACIÃ“N DE UN PACIENTE MASCULINO DE 61 AÃ‘OS, EDÃ‰NTULO MANDIBULAR, MEDIANTE LA COLOCACIÃ“N DE CUATRO IMPLANTES MIS SEVEN DOS RECTOS Y DOS ANGULADOS CON GUÃA QUIRÃšRGICA, SEGUIDO DE UNA PRÃ“TESIS HÃBRIDA PROVISIONAL DE RESINA IMPRESA SENERTEK COMO PARTE DEL PROTOCOLO INTEGRAL.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

â€¢ PRESENTAR UN CASO DE REHABILITACIÃ“N MANDIBULAR DE TÃ‰CNICA ALL-ON-4 CON CIRUGÃA GUIADA Y PRÃ“TESIS PROVISIONAL, DESTACANDO LA PLANIFICACIÃ“N DIGITAL Y LA TÃ‰CNICA QUIRÃšRGICA.

OBJETIVOS ESPECÃFICOS:

1. DESCRIBIR EL PROTOCOLO DIAGNÃ“STICO Y DE PLANIFICACIÃ“N DIGITAL PARA IMPLANTES EN PACIENTE EDÃ‰NTULO.

2. EXPLICAR LA SECUENCIA QUIRÃšRGICA CON GUÃA Y COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES ANGULADOS.

3. DETALLAR LA PROVISIONALIZACIÃ“N CON PRÃ“TESIS IMPRESA Y SU IMPACTO FUNCIONAL Y ESTÃ‰TICO.

4. ANALIZAR BENEFICIOS Y CONSIDERACIONES CLÃNICAS DEL ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO.

Descripción del Caso *

PACIENTE MASCULINO DE 61 AÃ‘OS, EDÃ‰NTULO MANDIBULAR, ACUDIÃ“ A CONSULTA REFIRIENDO DIFICULTAD PARA MASTICAR Y AUSENCIA DE USO DE LA PRÃ“TESIS INFERIOR DEBIDO A INESTABILIDAD Y POBRE RETENCIÃ“N. EL EXAMEN CLÃ□NICO REVELÃ“ REBORDE MANDIBULAR ATRÃ“FICO.

SE SOLICITÃ“ TOMOGRAFÃ□A COMPUTARIZADA DE HAZ CÃ“NICO (CBCT) Y FOTOGRAFÃ□AS CLÃ□NICAS. PARA EL ESCANEO DIGITAL, SE UTILIZÃ“ LA PRÃ“TESIS INFERIOR DEL PACIENTE, A LA CUAL SE LE REALIZARON ORIFICIOS EN EL FONDO DE SACO, RELLENÃ□NDOLOS CON RESINA FLUIDA PARA SU DETECCIÃ“N EN EL ESCÃ□NER. LOS DATOS OBTENIDOS SE INTEGRARON CON LA CBCT MEDIANTE SOFTWARE DE PLANIFICACIÃ“N, DETERMINANDO LA POSICIÃ“N IDEAL DE CUATRO IMPLANTES: DOS MIS SEVEN 3.75 Ã— 11.5 MM (ANTERIORES) Y DOS MIS SEVEN 4.20 Ã— 13 MM ANGULADOS (POSTERIORES).

SE CONFECCIONÃ“ UNA GUÃ□A QUIRÃšRGICA PERSONALIZADA. EN EL ACTO OPERATORIO, BAJO ANESTESIA LOCAL, SE VERIFICÃ“ EL AJUSTE DE LA GUÃ□A Y SE REALIZARON LAS OSTEOTOMÃ□AS SEGÃšN EL PLAN VIRTUAL. LOS IMPLANTES SE COLOCARON CON EL TORQUE INDICADO, MANTENIENDO LA ANGULACIÃ“N PLANEADA PARA OPTIMIZAR EL SOPORTE PROTÃ‰SICO. LA ZONA FUE SUTURADA CON MONOFILAMENTO DE NYLON 4-0, PROGRAMANDO LA RETIRADA DE SUTURAS A LAS DOS SEMANAS. SE TOMÃ“ RADIOGRAFÃ□A PANORÃ□MICA POSTOPERATORIA Y SE INDICÃ“ UN PERIODO DE OSTEOINTEGRACIÃ“N DE TRES MESES CON LOS IMPLANTES SUMERGIDOS.

TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO, SE REALIZÃ“ LA SEGUNDA FASE QUIRÃšRGICA: DESTAPE DE LOS IMPLANTES Y COLOCACIÃ“N DE ADITAMENTOS MULTI-UNIT, MANTENIENDO ANGULACIÃ“N EN LOS POSTERIORES. A LAS TRES SEMANAS, SE INSTALÃ“ UNA PRÃ“TESIS PROVISIONAL CONFECCIONADA EN RESINA IMPRESA SENERTEK, ATORNILLADA, QUE PERMITIÃ“ RESTAURAR FUNCIÃ“N Y ESTÃ‰TICA MIENTRAS SE ELABORABA LA REHABILITACIÃ“N DEFINITIVA.

EL PACIENTE REPORTÃ“ MEJORÃ□A INMEDIATA EN ESTABILIDAD, MASTICACIÃ“N Y COMODIDAD. ESTE ABORDAJE PERMITIÃ“ UN TRATAMIENTO PREDECIBLE Y MÃ□NIMAMENTE INVASIVO, OPTIMIZANDO LA PRECISIÃ“N QUIRÃšRGICA Y LA ADAPTACIÃ“N PROTÃ‰SICA.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS

TRAS LA COLOCACIÃ“N DE LOS CUATRO IMPLANTES MANDIBULARES MEDIANTE CIRUGÃ A GUIADA, SE OBTUVO UNA INSERCIÃ“N PRIMARIA ADECUADA, CON TORQUE SATISFACTORIO EN TODAS LAS UNIDADES. LA UTILIZACIÃ“N DE LA GUÃ A QUIRÃšRGICA PERMITIÃ“ RESPETAR LAS POSICIONES Y ANGULACIONES PLANIFICADAS, OPTIMIZANDO LA DISTRIBUCIÃ“N BIOMECÃ NICA PARA LA FUTURA PRÃ“TESIS. NO SE PRESENTARON COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS NI POSTOPERATORIAS INMEDIATAS.

DURANTE EL PERIODO DE OSTEOINTEGRACIÃ“N DE TRES MESES, NO SE EVIDENCIÃ“ PÃ‰RDIDA Ã“SEA MARGINAL SIGNIFICATIVA NI SIGNOS DE MOVILIDAD O FRACASO DE LOS IMPLANTES. EN LA SEGUNDA FASE QUIRÃšRGICA, LA COLOCACIÃ“N DE ADITAMENTOS MULTI-UNIT FACILITÃ“ EL PARALELISMO Y LA ADAPTACIÃ“N PROTÃ‰SICA, ESPECIALMENTE EN LOS IMPLANTES POSTERIORES ANGULADOS.

LA INSTALACIÃ“N DE LA PRÃ“TESIS PROVISIONAL EN RESINA IMPRESA SENERTEK MEJORÃ“ LA ESTÃ‰TICA Y FUNCIÃ“N DE MANERA INMEDIATA, PERMITIENDO AL PACIENTE RECUPERAR LA MASTICACIÃ“N Y FONÃ‰TICA. EL AJUSTE PASIVO FUE SATISFACTORIO, Y NO SE DETECTARON FRACTURAS NI AFLOJAMIENTOS DURANTE EL PERIODO PROVISIONAL. EL PACIENTE REFIRIÃ“ ALTA SATISFACCIÃ“N EN TÃ‰RMINOS DE ESTABILIDAD, COMODIDAD Y APARIENCIA, ASÃ COMO UNA NOTABLE MEJORA EN SU CALIDAD DE VIDA.

CONCLUSIONES

ESTE CASO CLÃ NICO DEMUESTRA QUE LA REHABILITACIÃ“N MANDIBULAR TIPO ALL-ON-4 MEDIANTE CIRUGÃ A GUIADA Y PRÃ“TESIS PROVISIONAL IMPRESA ES UNA ALTERNATIVA EFICAZ Y PREDECIBLE PARA PACIENTES EDÃ‰NTULOS. ENTRE LAS VENTAJAS OBSERVADAS DESTACAN:

1. PRECISIÃ“N QUIRÃšRGICA: LA INTEGRACIÃ“N DE DATOS CBCT CON ESCANEO INTRAORAL Y PLANIFICACIÃ“N DIGITAL PERMITIÃ“ UNA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES CON MÃ NIMA DESVIACIÃ“N RESPECTO AL PLAN INICIAL, REDUCIENDO EL RIESGO DE DAÃ‘O A ESTRUCTURAS ANATÃ“MICAS Y OPTIMIZANDO LA EMERGENCIA PROTÃ‰SICA.

2. MENOR MORBILIDAD: LA CIRUGÃ A GUIADA DISMINUYÃ“ EL TIEMPO OPERATORIO Y EL TRAUMA QUIRÃšRGICO, FAVORECIENDO UNA RECUPERACIÃ“N MÃ S RÃ PIDA Y CONFORTABLE.

3. OPTIMIZACIÃ“N PROTÃ‰SICA: EL USO DE ADITAMENTOS MULTI-UNIT, JUNTO CON LA CORRECTA

Bibliografía *

REFERENCIAS

1. GOMES JML, LEMOS CAA, SANTIAGO JUNIOR JF, MORAES SLD, GOIATO MC, PELLIZZER EP. OPTIMAL NUMBER OF IMPLANTS FOR COMPLETE-ARCH IMPLANT-SUPPORTED PROSTHESES WITH A FOLLOW-UP OF AT LEAST 5 YEARS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS. J PROSTHET DENT. 2018;[EPUB AHEAD OF PRINT]. DOI:10.1016/J.PROSDENT.2018.10.016

2. POLIDO WD, AGHALOO T, EMMETT TW, TAYLOR TD, MORTON D. NUMBER OF IMPLANTS PLACED FOR COMPLETE-ARCH FIXED PROSTHESES: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS. CLIN ORAL IMPLANTS RES. 2018;29(SUPPL 16):154-183. DOI:10.1111/CLR.13312.

3. WANG Q, ZHANG ZZ, BAI SZ, ZHANG SF. BIOMECHANICAL ANALYSIS OF STRESS AROUND THE TILTED IMPLANTS WITH DIFFERENT CANTILEVER LENGTHS IN ALL-ON-4 CONCEPT. BMC ORAL HEALTH. 2022;22:469. DOI:10.1186/S12903-022-02520-8.

4. MALEVEZ C, DAELEMANS P, ADRIAENSSENS P, DURDU F. USE OF ZYGOMATIC IMPLANTS TO DEAL WITH RESORBED POSTERIOR MAXILLAE. PERIODONTOL 2000. 2000;22:92-9.

Título del trabajo *

APLICACIÃ“N DE LA TERAPIA FOTODINÃ□MICA PARA LA OPTIMIZACIÃ“N DE LA CIRUGIA PERIODONTAL: SERIE DE CASOS CLÃ□NICOS.

Nombre del Autor (a/es)*

Mariana DÃ-az Ruan, Vicente Aurelio Barocio Guerrer

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

RocÃ-o Karina CÃ¡rdenas, Israel Guardado Luevanos, , , , , , , .

Correo Electrónico *

mariana.diaz@edu.uag.mx

Institución *

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA

Introducción y Objetivos *

LA CIRUGÃ□A PERIODONTAL ES UN CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS QUIRÃšRGICOS REALIZADOS PARA TRATAR ENFERMEDADES QUE AFECTAN LOS TEJIDOS DE SOPORTE DE LOS DIENTES. DENTRO DE SUS OBJETIVOS SE INCLUYE LA REGENERACIÃ“N DE LOS TEJIDOS BLANDOS POR MEDIO DE COLOCACIÃ“N DE INJERTOS PARA GENERAR EL ENGROSAMIENTO DEL FENOTIPO GINGIVAL, RECUBRIMIENTO DE RECESIONES GINGIVALES, PROFUNDIZACIÃ“N DE VESTÃ□BULO Y OTRO TIPO DE PROCEDIMIENTOS. (1)

PARA ESTOS PROCEDIMIENTOS, EL PALADAR ES EL SITIO DONANTE MÃ□S FRECUENTEMENTE UTILIZADO DEBIDO A LA SIMILITUD HISTOLÃ“GICA ENTRE LA MUCOSA PALATINA Y LA MUCOSA QUERATINIZADA Y SU ANATOMÃ□A ACCESIBLE FAVORECE TÃ‰CNICAS QUIRÃšRGICAS CONTROLADAS. ADEMÃ□S, SU BUENA VASCULARIZACIÃ“N Y ALTA BIOCOMPATIBILIDAD CONTRIBUYEN A RESULTADOS CLÃ□NICOS ESTABLES EN EL SITIO RECEPTOR. (2)

EXISTEN VARIAS TÃ‰CNICAS PARA LA TOMA DE UN INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO DEL PALADAR UNA ELLAS ES EL INJERTO GINGIVAL LIBRE. LOS DESAFÃ□OS A LOS CUALES NOS PODEMOS ENFRENTAR EN LA TOMA DE UN INJERTO GINGIVAL LIBRE DEL PALADAR ES UN POSOPERATORIO MÃ□S INCÃ“MODO, ESTO DEBIDO A LA ALTA INERVACIÃ“N DE ESTA ZONA (3)

ESTUDIOS HAN DEMOSTRADO EL Ã‰XITO DE LA TERAPIA FOTODINÃ□MICA DURANTE EL PROCESO DE CICATRIZACIÃ“N DE HERIDAS, ESTE TENDRÃ□ UN EFECTO EN LA PRODUCCIÃ“N DE COLÃ□GENO (4), PROLIFERACIÃ“N DE FIBROBLASTOS, FORMACIÃ“N DE TEJIDO DE GRANULACIÃ“N Y EN UN ESTUDIO SE DEMOSTRÃ“ QUE DESACTIVA LA RESPUESTA DE CITOQUINAS FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ALFA E IL-1 BETA LAS CUALES SE HAN ASOCIADO A UNA INFLAMACIÃ“N DESTRUCTIVA (5).

EL OBJETIVO DE ESTA SERIE DE CASOS ES DESCRIBIR LOS CAMBIOS CLÃ□NICOS DE MANERA PROSPECTIVA AL UTILIZAR LA TERAPIA FOTODINÃ□MICA EN ZONA DONADORA POSTERIOR A LA TOMA DE UN INJERTO MEDIANTE EL ANÃ□LISIS DIGITAL DE IMÃ□GENES.

Descripción del Caso *

LA SERIE DE CASOS ESTUVO CONFORMADA POR 9 PACIENTES DEL POSGRADO EN PERIODONCIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÃ“NOMA DE GUADALAJARA CON INDICACIÃ“N DE TOMA DE INJERTO AUTÃ“LOGO DEL PALADAR, EN TOTAL 10 SITIOS DONADORES FUERON DESCRITOS. LOS SITIOS DONADORES FUERON DIVIDIDOS ALEATORIAMENTE EN 2 GRUPOS: 5 SITIOS DONADORES EN EL GRUPO EXPERIMENTAL QUIENES RECIBIERON TERAPIA FOTODINÃ?MICA AL TÃ‰RMINO DEL PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO Y UNA SEMANA DESPUÃ‰S; Y EL GRUPO CONTROL TAMBIÃ‰N CONFORMADO POR 5 SITIOS DONADORES SIN APLICAR LA TERAPIA FOTODINÃ?MICA. EL SITIO DONADOR EN AMBOS CASOS FUE OBTENIDO DE LA REGIÃ“N DEL PALADAR ENTRE PREMOLARES Y PRIMER MOLAR. EL GRUPO EXPERIMENTAL RECIBIÃ“ TERAPIA FOTODINÃ?MICA CON LUZ ROJA COLOCADA POR PUNTOS, 6 J/CM2 CON UN TIEMPO DE APLICACIÃ“N DE 1 MIN, LA FRECUENCIA FUE DE 9000 HZ Y UNA POTENCIA DE 100 MW.

Resultados y Conclusiones *

SE TOMARON FOTOGRAFÃ□AS A LA SEMANA DESPUÃ‰S DEL PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO Y 2 SEMANAS POSTERIOR AL PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO. OBTENIENDO 20 FOTOGRAFÃ□AS UTILIZADAS COMO MUESTRA PARA DETERMINAR LOS CAMBIOS GENERADOS SOBRE LA EPITELIZACIÃ“N DEL SITIO DONADOR AL APLICAR TERAPIA FOTODINÃ□MICA. SE UTILIZÃ“ LA FÃ“RMULA DELTA E (?E) LA CUAL ES UNA FORMA DE MEDIR LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE 2 COLORES; SE REALIZA LA EVALUACIÃ“N UTILIZANDO EL PROGRAMA IMAGE J PARA LA OBTENCIÃ“N DE ESTOS VALORES. ESTE ES UN PROGRAMA DE PROCESAMIENTO DIGITAL PARA IMÃ□GENES DE DOMINIO PÃšBLICO POR JAVA, EL CUAL FUE DESARROLLADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE ESTADOS UNIDOS (6,7) Y APLICA LA SIGUIENTE ESCALA PARA DETERMINAR LA EPITELIZACIÃ“N: NO EPITELIZADO, PARCIALMENTE EPITELIZADO Y COMPLETAMENTE EPITELIZADO, DE ACUERDO AL DE COLORACIÃ“N EN COMPARACIÃ“N CON LA REFERENCIA CIELAB.

SE ANALIZARON 20 FOTOGRAFIAS; 10 CORRESPONDIENTES AL GRUPO EXPERIMENTAL, A LOS CUALES SE LE APLICÃ“ TERAPIA FOTODINÃ□MICA : 5 FOTOGRAFÃ□AS A 1 SEMANA DEL PROCEDIMIENTO Y 5 FOTOGRAFIAS A 2 SEMANAS DEL PROCEDIMIENTO; Y 10 FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES AL GRUPO CONTROL, CON LA MISMA SECUENCIA QUE EL GRUPO EXPERIMENTAL; 5 FOTOGRAFIAS A 1 SEMANA DEL PROCEDIMIENTO Y 5 FOTOGRAFIAS A 2 SEMANAS DEL PROCEDIMIENTO. EL GRUPO EXPERIMENTAL A 1 SEMANA DEL PROCEDIMIENTO MOSTRÃ“ 5 SITIOS PARCIALMENTE EPITELIZADOS EN SU EVALUACIÃ“N A 1 SEMANA DEL PROCEDIMIENTO, MISMOS DATOS SE OBTUVIERON AL ANALIZAR EL GRUPO CONTROL. SIN EMBARGO A LAS 2 SEMANAS, EL GRUPO EXPERIMENTAL MUESTRA 3 SITIOS COMPLETAMENTE EPITELIZADOS Y 2 SITIOS PARCIALMENTE EPITELIZADOS CONTRA 3 SITIOS PARCIALMENTE EPITELIZADOS Y 2 EPITELIZADOS QUE SE OBTIENEN EN EL GRUPO CONTROL. BASADO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y LOS ESTUDIOS ANALIZADOS EN ESTA INVESTIGACIÃ“N, LA UTILIDAD DE LA TERAPIA LÃ□SER DE BAJA INTENSIDAD ES UNA BUENA HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA EFICAZ EN EL MANEJO POSTOPERATORIO DE ZONAS DONADORAS DE INJERTOS GINGIVALES. SU APLICACIÃ“N NO SOLO FAVORECE LA CICATRIZACIÃ“N MÃ□S RÃ□PIDA, SINO QUE TAMBIÃ‰N CONTRIBUYE A UNA DISMINUCIÃ“N SIGNIFICATIVA DEL DOLOR POSOPERATORIO, LO CUAL SE TRADUCE EN MAYOR CONFORT Y SATISFACCIÃ“N PARA EL PACIENTE DURANTE EL PROCESO DE RECUPERACIÃ“N.

Bibliografía *

1. CHAMBRONE, L., & ORTIZ, G. A. (2022). TISSUES: CRITICAL ISSUES IN PERIODONTAL AND IMPLANT-RELATED PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY. QUINTESSENCE PUBLISHING.

2. PURI K, KUMAR A, KHATRI M, BANSAL M, REHAN M, SIDDESHAPPA ST. 44-YEAR JOURNEY OF PALATAL CONNECTIVE TISSUE GRAFT HARVEST: A NARRATIVE REVIEW. J INDIAN SOC PERIODONTOL [INTERNET]. 2019;23(5):395â€“408. AVAILABLE FROM: HTTP://DX.DOI.ORG/10.4103/JISP.JISP_288_18

3. ZUHR, O., & HÃœRZELER, M. B. (2012). PLASTIC-ESTHETIC PERIODONTAL AND IMPLANT SURGERY. QUINTESSENCE PUBLISHING.

4. P. BRAHAM, C. HERRON, C. STREET, R. DARVEAU ANTIMICROBIAL PHOTODYNAMIC THERAPY MAY PROMOTE PERIODONTAL HEALING THROUGH MULTIPLE MECHANISMS J. PERIODONTOL., 80 (2009), PP. 1790-1798, 10.1902/JOP.2009.090214

5. YAGHOBEE, S., POURHAJIBAGHER, M., BAHRAMI, R., & ISAABADI, M. (2024). NANOEMODIN MEDIATED PHOTODYNAMIC THERAPY FOR WOUND HEALING OF DONOR SITE AFTER FREE GINGIVAL GRAFT: A PARALLEL CLINICAL TRIAL. PHOTODIAGNOSIS AND PHOTODYNAMIC THERAPY. 45. 103958.

Título del trabajo *

PRESERVACIÃ“N DE ALVEOLO POR MEDIO DEL â€œSTICKY BONEâ€ EN PACIENTE CON RIESGO A OSTEONECROSIS POR PREVIO TRATAMIENTO CON BIFOSFONATOS

Nombre del Autor (a/es)*

Paulina RodrÃ-guez RenterÃ-a

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Juan Antonio Cepeda Bravo, Paul IvÃ¡n ObregÃ³n Godina, , , , , , , .

Correo Electrónico *

paulinaro99@outlook.com

Institución *

ESPECIALIDAD DE PERIODONCIA DE LA UNIVERSIDAD AUTO

Introducción y Objetivos *

EL AGLUTINADO Ã“SEO O "STICKY BONE", PROPUESTO POR SOHN ET AL. EN 2010, ES UN INJERTO Ã“SEO SÃ“LIDO RODEADO POR UNA RED DE FIBRINA, DISEÃ‘ADO PARA REGENERACIÃ“N Ã“SEA. COMBINA PARTÃ⍰CULAS DE SUSTITUTO Ã“SEO COMO ALOINJERTOS O XENOINJERTOS CON AGREGADOS PLAQUETARIOS AUTÃ“LOGOS COMO PRF (PLASMA RICO EN FIBRINA) Y FACTORES DE CRECIMIENTO (CGFS). ESTA MEZCLA ESTABILIZA EL INJERTO, EVITA SU DESPLAZAMIENTO, PRESERVA EL VOLUMEN Ã“SEO Y DIFICULTA LA INVASIÃ“N DE TEJIDOS BLANDOS, LO QUE MEJORA LA CURACIÃ“N.

EL PRF Y SUS DERIVADOS HAN DEMOSTRADO MÃšLTIPLES BENEFICIOS EN CIRUGÃ⍰A ORAL. ESTIMULAN LA REGENERACIÃ“N DEL TEJIDO GINGIVAL, ACELERAN LA CICATRIZACIÃ“N, PROMUEVEN EL CIERRE DE HERIDAS Y FAVORECEN LA ANGIOGÃ‰NESIS Y LA PROLIFERACIÃ“N CELULAR.

LA OSTEONECROSIS ES UNA CONDICIÃ“N CARACTERIZADA POR LA PRESENCIA DE HUESO NECRÃ“TICO QUE NO CICATRIZA ADECUADAMENTE, FRECUENTEMENTE ASOCIADA AL USO DE BIFOSFONATOS (BPS). ESTOS MEDICAMENTOS INHIBEN LA FUNCIÃ“N DE LOS OSTEOCLASTOS, AFECTANDO LA REMODELACIÃ“N Ã“SEA. EN CASOS DE OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES RELACIONADA CON BIFOSFONATOS (BRONJ), EL USO DE PRF HA MOSTRADO RESULTADOS POSITIVOS EN LA COBERTURA DE HUESO EXPUESTO Y MEJORA DE LA CICATRIZACIÃ“N, OFRECIENDO UNA OPCIÃ“N TERAPÃ‰UTICA ÃšTIL EN ESTOS ESCENARIOS COMPLEJOS.

EL OBJETIVO ES LA PRESERVACIÃ“N DE ALVEOLO POR MEDIO DEL â€œSTICKY BONEâ€⍰, EN UNA PACIENTE CON RIESGO A OSTEONECROSIS POR PREVIO TRATAMIENTO CON BIFOSFONATOS INTRAVENOSOS, PARA LA COLOCACIÃ“N DE UN IMPLANTE.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINA DE 62 AÃ‘OS DE EDAD, COMO ANTECEDENTES PATOLÃ“GICOS REFIERE OSTEOPOROSIS, FIBROMIALGIA Y ARTRITIS REUMATOIDE CONTROLADAS. ACUDE A LA CLÃ NICA DE POSGRADO EN PERIODONCIA DE LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGÃ A EN LA UASLP, LA PACIENTE NIEGA TOXICOMANÃ AS Y HÃ BITOS PERNICIOSOS, A LA EXPLORACIÃ“N INTRAORAL SE OBSERVÃ“ PERDIDA Ã“SEA A NIVEL DE LOS OD 17, 27, 36 Y 46 CON BOLSAS PERIODONTALES LOCALIZADAS DE 6 Y 7 MM, AUSENCIA DE SANGRADO E INFLAMACIÃ“N, PRESENTABA DOLOR LEVE A NIVEL DE OD 17. SE REALIZO SERIE PERIAPICAL RADIOGRÃ FICA Y TOMOGRAFÃ A DEL MAXILAR SUPERIOR PARA OBSERVAR LA PERDIDA. SE DIAGNOSTICO A LA PACIENTE CON PERIODONTITIS ESTADIO III GRADO B LOCALIZADA. SE DECIDIÃ“ REALIZAR EXTRACCIÃ“N DE FORMA ATRAUMÃ TICA Y PRESERVAR EL ALVEOLO DE OD 17 DEBIDO A POBRE DIAGNOSTICO PERIODONTAL Y COMPLICACIÃ“N ENDODÃ“NTICA SECUNDARIA, POR PRESENCIA DE LESIÃ“N PERIAPICAL EXTENSA. POR EL RIESGO DE OSTEONECROSIS SE DECIDE HACER LA PRESERVACIÃ“N DEL ALVEOLO POR MEDIO DEL â€œSTICKY BONEâ€ . SE REALIZA EXTRACCIÃ“N CON PRESERVACIÃ“N DEL ALVEOLO POR MEDIO DEL â€œSTICKY BONEâ€ PREPARADO CON PRF EN COMBINACIÃ“N CON ALOINJERTO (OROGRAFT FDBA). SE TOMARON ALREDEDOR DE 20 CC DE SANGRE VENOSA DE LA VENA CUBITAL Y SE CENTRIFUGARON A 2400-2700 REVOLUCIONES POR MINUTO UTILIZANDO UNA CENTRIFUGA ESPECIFICA (REMI R4C) DURANTE 2 MIN, SE LE COLOCO EL COAGULANTE EN ESTE CASO FUE CITRATO DE CALCIO PARA OBTENER EL PLASMA RICO EN FACTORES DE CRECIMIENTO, FUE MEZCLADO CON EL ALOINJERTO Ã“SEO PARTICULADO Y SE COLOCÃ“ UN TAPÃ“N DE COLÃ GENO (COLLACONE) PARA MANTENER EL COAGULO Y EL â€œSTICKY BONEâ€ EN SU LUGAR; SE SUTURO CON UN PUNTO EN X. SE TUVO UN CONTROL A LA 1, 2, 3 Y 12 SEMANAS PARA OBSERVAR LA CICATRIZACIÃ“N DE LOS TEJIDOS BLANDOS Y DEL TEJIDO Ã“SEO.

Resultados y Conclusiones *

SE REALIZO UN SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO DEL PACIENTE, DURANTE EL CUAL SE OBSERVÃ“ UN CORRECTO RELLENO DEL ALVEOLO, ADEMÃ S, SE LOGRÃ“ LA COBERTURA TOTAL DEL HUESO CON FORMACIÃ“N DE NUEVA ENCÃ A. SE COMPROBÃ“ QUE UNA DE LAS VENTAJAS DE USAR COMO COADYUVANTE EL â€œSTICKY BONEâ€ , PRF O DERIVADOS DE ESTE, SON UN MÃ‰TODO EFECTIVO Y PREDECIBLE EN LOS DIVERSOS TRATAMIENTOS DE LA OSTEONECROSIS, ADEMÃ S DE DISMINUIR LA MORBILIDAD DEL PACIENTE Y BENEFICIAR A LA CICATRIZACIÃ“N EN TEJIDOS BLANDOS Y DUROS. COMO CONCLUSIÃ“N SE COMPROBÃ“ QUE UNA DE LAS VENTAJAS DE USAR COMO COADYUVANTE EL â€œSTICKY BONEâ€ , PRF O DERIVADOS DE ESTE, SON UN MÃ‰TODO EFECTIVO Y PREDECIBLE EN LOS DIVERSOS TRATAMIENTOS DE LA OSTEONECROSIS, ADEMÃ S DE DISMINUIR LA MORBILIDAD DEL PACIENTE Y BENEFICIAR A LA CICATRIZACIÃ“N EN TEJIDOS BLANDOS Y DUROS. SE SUGIERE QUE EL PRF PUEDE SER UNA HERRAMIENTA EFECTIVA PARA CERRAR HUESO EXPUESTO Y PROMOVER LA CICATRIZACIÃ“N DE TEJIDOS EN PACIENTES CON RIESGO A BRONJ. SIN EMBARGO, EL Ã‰XITO TERAPÃ‰UTICO DEPENDE DE VARIOS FACTORES COMO LA LOCALIZACIÃ“N DE LA LESIÃ“N, EL TAMAÃ‘O DE ESTA O EL MOMENTO DEL DIAGNÃ“STICO, POR LO QUE, A PESAR DE QUE SON RESULTADOS BASTANTE ALENTADORES Y ABREN UNA NUEVA VÃ A EN EL TRATAMIENTO DE ESTA PATOLOGÃ A, SON NECESARIOS MÃ S ESTUDIOS QUE DEMUESTREN LA VERDADERA EFICACIA DE LA TERAPIA.

Bibliografía *

1. RUPAWALA TA, PATEL SM, SHAH NH, SANGHVI KB, MAKWANA SV, BHIMANI KK. EFFICACY OF STICKY BONE AS A NOVEL AUTOLOGOUS GRAFT FOR MANDIBULAR THIRD MOLAR EXTRACTION SOCKET HEALING - AN EVALUATIVE STUDY. ANN MAXILLOFAC SURG. 2020 JUL-DEC;10(2):335-343. DOI: 10.4103/AMS.AMS_40_20. EPUB 2020 DEC 23. PMID: 33708577; PMCID: PMC7943984.

2. SAREEN V, K S, SAXENA I, SELVARAJ U, P V, CHAUHAN S, M G. ROLE OF STICKY BONE IN THE MANAGEMENT OF VARIOUS ALVEOLAR BONE DEFECTS: A SYSTEMATIC REVIEW. CUREUS. 2024 JUL 1;16(7):E63561. DOI: 10.7759/CUREUS.63561. PMID: 39087152; PMCID: PMC11290384.

3. EGIERSKA D, PERSZKE M, MAZUR M, DU?-ILNICKA I. PLATELET-RICH PLASMA AND PLATELET-RICH FIBRIN IN ORAL SURGERY: A NARRATIVE REVIEW. DENT MED PROBL. 2023 JAN-MAR;60(1):177-186. DOI: 10.17219/DMP/147298. PMID: 37023345.

4. SARKARAT F, KALANTAR MOTAMEDI MH, JAHANBANI J, SEPEHRI D, KAHALI R, NEMATOLLAHI Z. PLATELET-RICH PLASMA IN TREATMENT OF ZOLEDRONIC ACID-INDUCED BISPHOSPHONATE-RELATED OSTEONECROSIS OF THE JAWS. TRAUMA MON. 2014 APR;19(2):E17196. DOI: 10.5812/TRAUMAMON.17196. EPUB 2014 MAR 18. PMID:

Título del trabajo *

â€œCOLGAJO DESPLAZADO LATERAL PREVIO A TÃ‰CNICA TCAF PARA LA CORRECCIÃ“N DE RECESIÃ“N GINGIVAL EN ZONA ESTÃ‰TICAâ€

Nombre del Autor (a/es)*

Javier Alonso Delgado LujÃ¡n.

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

D.C.F. Lizeth Alejandra Reyes Alvarado, M.C.O. Gilberto Zatarain HernÃ¡ndez, Dra. Cristina BermÃºdez RenterÃ-a, D.C.F. Sergio Favela Flores, , , , , .

Correo Electrónico *

javierdelgadolujan@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA.

Introducción y Objetivos *

LA RECESIÃ“N GINGIVAL, DEFINIDA COMO EL DESPLAZAMIENTO APICAL DEL MARGEN GINGIVAL RESPECTO A LA UNIÃ“N CEMENTO-ESMALTE (UCE) DE UN DIENTE O A LA PLATAFORMA DE UN IMPLANTE DENTAL, IMPLICA LA PÃ‰RDIDA DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE PERIODONTAL, INCLUYENDO ENCÃ□A, LIGAMENTO PERIODONTAL, CEMENTO RADICULAR Y HUESO ALVEOLAR.

ENTRE LAS TÃ‰CNICAS QUIRÃšRGICAS PARA EL MANEJO DE RECESIONES, LA COMBINACIÃ“N DE COLGAJO DESPLAZADO LATERAL CON LA TÃ‰CNICA TCAF (TUNELIZACIÃ“N CON COLGAJO AVANZADO CORONAL) REPRESENTA UNA ALTERNATIVA EFICAZ Y CONSERVADORA. ESTA ESTRATEGIA PERMITE UN ABORDAJE ESTÃ‰TICO EN RECESIONES UNITARIAS Y MÃšLTIPLES, MAXIMIZANDO LA COBERTURA RADICULAR Y LA ESTABILIDAD DE LOS TEJIDOS BLANDOS, SIN COMPROMETER LA IRRIGACIÃ“N DEL TEJIDO BLANDO NI DEL INJERTO.

EL OBJETIVO DEL PRESENTE CASO CLÃ□NICO ES MOSTRAR LOS RESULTADOS CLÃ□NICOS POSTERIORES AL TRATAMIENTO QUIRÃšRGICO MUCOGINGIVAL MEDIANTE COLGAJO DESPLAZADO LATERAL SEGUIDO DE TÃ‰CNICA TCAF EN UN PACIENTE CON RECESIÃ“N GINGIVAL RT2 EN EL Ã“RGANO DENTAL 11.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINO ASA II, 70 AÃ‘OS, ACUDIÃ“ A CONSULTA EN CLÃ NICA PERIODONCIA DE UADEC UNIDAD LAGUNA, REFIRIENDO COMO MOTIVO DE CONSULTA: â€œMI DIENTE SE VE RAROâ€ . EN EXPLORACIÃ“N INTRAORAL SE IDENTIFICÃ“ RECESIÃ“N GINGIVAL RT2 EN Ã“RGANO DENTAL 11 SEGÃšN CAIRO (2011), ADEMÃ S DE UNA CORONA METAL-PORCELANA GENERANDO TRAUMA OCLUSAL EN EL MISMO DIENTE.

SE DECIDIÃ“ REALIZAR COBERTURA RADICULAR MEDIANTE INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO CON UNA TÃ‰CNICA QUIRÃšRGICA COMBINADA: COLGAJO DESPLAZADO LATERAL COMO PRIMER ABORDAJE Y TÃ‰CNICA TCAF EN SITIOS ADYACENTES CON RECESIONES MÃšLTIPLES.

PREVIO A CIRUGÃ A, SE REALIZÃ“ PROFILAXIS DENTAL Y CONFECCIÃ“N DE RESTAURACIONES PROVISIONALES ACRÃ LICAS EN Ã“RGANOS DENTALES 11 Y 21.

DURANTE EL PRIMER PROCEDIMIENTO, SE APLICARON PROTOCOLOS DE ASEPSIA Y ANTISEPSIA, SE ADMINISTRÃ“ ANESTESIA LOCAL CON LIDOCAÃ NA 2% Y EPINEFRINA 1:100,000 MEDIANTE BLOQUEO DEL NERVIO ALVEOLAR SUPERIOR ANTERIOR Y BLOQUEO DEL NERVIO PALATINO MAYOR EN ZONA DONADORA.

SE DISEÃ‘Ã“ Y PARCIALIZÃ“ COLGAJO CON BISTURÃ HOJA 15C PARA DESPLAZAMIENTO LATERAL, REALIZANDO RASPADO Y ALISADO RADICULAR CON APLICACIÃ“N DE PREFGELÂ®. SE OBTUVO INJERTO GINGIVAL LIBRE DE ZONA PALATINA (10Ã—7Ã—1.5 MM), DESEPITELIZADO Y SUTURADO EN EXTREMOS MESIAL Y DISTAL CON VYCRIL 5/0. EL COLGAJO FUE REPOSICIONADO Y SUTURADO CON PUNTOS SIMPLES Y SUSPENSORIOS EN NYLON 5/0. LA ZONA DONANTE FUE CERRADA CON PUNTOS EN â€œXâ€ CON NYLON 5/0. SE INDICARON TRATAMIENTO FARMACOLÃ“GICO E INSTRUCCIONES POSOPERATORIAS.

TRAS 4 MESES DE CICATRIZACIÃ“N, SE REALIZÃ“ EL SEGUNDO PROCEDIMIENTO CON LA TÃ‰CNICA TCAF. NUEVAMENTE SE APLICARON ASEPSIA, ANTISEPSIA Y ANESTESIA LOCAL, SE DISEÃ‘Ã“ Y PARCIALIZÃ“ COLGAJO CON BISTURÃ 15C PARA PERMITIR DESPLAZAMIENTO CORONAL PRESERVANDO LA PAPILA MESIAL DE O.D. 11, REALIZANDO TUNELIZACIÃ“N HASTA O.D. 21. SE REALIZÃ“ RASPADO Y ALISADO RADICULAR CON APLICACIÃ“N DE PREFGELÂ®.

SE TOMÃ“ UN INJERTO GINGIVAL LIBRE PALATINO (13Ã—4Ã—1 MM), DESEPITELIZADO Y FIJADO EN LAS ZONAS MESIAL Y DISTAL CON VYCRIL 5/0. EL COLGAJO FUE REPOSICIONADO Y ESTABILIZADO MEDIANTE PUNTOS DOUBLE CROSS, SUSPENSORIOS Y LIBERATRIZ CON SUTURAS SHANELEC (POLIPROPILENO 6/0) Y NYLON 5/0. LA ZONA DONANTE SE CERRÃ“ CON PUNTOS â€œXâ€ USANDO NYLON 5/0. SE INDICARON TRATAMIENTO FARMACOLÃ“GICO E INSTRUCCIONES POSOPERATORIAS.

Resultados y Conclusiones *

DESPUÃ‰S DE AMBOS PROCEDIMIENTOS, SE LOGRÃ“ APROXIMADAMENTE UN 80% DE COBERTURA RADICULAR, RESTAURANDO LA ESTÃ‰TICA Y POSICIONANDO EL MARGEN GINGIVAL EN UNA POSICIÃ“N ADECUADA PARA LA PREPARACIÃ“N Y COLOCACIÃ“N DE CORONAS DEFINITIVAS. EL TEJIDO GINGIVAL MOSTRÃ“ CONDICIONES DE SALUD Ã“PTIMAS Y SE CORRIGIÃ“ EL TRAUMA OCLUSAL, PREVINIENDO RECIDIVAS FUTURAS. A LOS 4 MESES POSTRATAMIENTO, SE OBSERVAN TEJIDOS BLANDOS SALUDABLES Y MÃ RGENES GINGIVALES ARMONIZADOS CON LAS RESTAURACIONES PROVISIONALES.

LA COMBINACIÃ“N DE COLGAJO DESPLAZADO LATERAL SEGUIDO DE TÃ‰CNICA TCAF CONSTITUYE UNA OPCIÃ“N QUIRÃšRGICA EFICAZ, CONSERVADORA Y ALTAMENTE ESTÃ‰TICA PARA EL TRATAMIENTO DE RECESIONES GINGIVALES. ESTA SECUENCIA PERMITE ABORDAR INICIALMENTE RECESIONES LOCALIZADAS CON COLGAJO PEDICULADO Y EXTENDER LA COBERTURA MEDIANTE TUNELIZACIÃ“N, PRESERVANDO LA IRRIGACIÃ“N DE LAS PAPILAS Y FAVORECIENDO LA CICATRIZACIÃ“N POR PRIMERA INTENCIÃ“N.

EL USO DE INJERTO SUBEPITELIAL JUNTO CON TÃ‰CNICAS MÃ NIMAMENTE INVASIVAS MEJORA LA ESTABILIDAD DE LOS TEJIDOS BLANDOS, REDUCE EL TRAUMA QUIRÃšRGICO Y OFRECE RESULTADOS CLÃ NICOS PREDECIBLES Y DURADEROS CON ALTA ACEPTACIÃ“N POR PARTE DEL PACIENTE

Bibliografía *

-BAROOTCHI S, TAVELLI L. TUNNELED CORONALLY ADVANCED FLAP FOR THE TREATMENT OF ISOLATED GINGIVAL RECESSIONS WITH DEFICIENT PAPILLA. INT J ESTHET DENT. 2022 FEB 17;17(1):14-26. PMID: 35175005.

-ZUCCHELLI, G., & MOUNSSIF, I. (2015). PERIODONTAL PLASTIC SURGERY. PERIODONTOLOGY 2000, 68(1), 333â€“368. HTTPS://DOI.ORG/10.1111/PRD.12059

-ZUHR, O., REBELE, S. F., THALMAIR, T., FICKL, S., & HÃœRZELER, M. B. (2009). A MODIFIED SUTURE TECHNIQUE FOR PLASTIC PERIODONTAL AND IMPLANT SURGERY--THE DOUBLE-CROSSED SUTURE. THE EUROPEAN JOURNAL OF ESTHETIC DENTISTRY : OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF ESTHETIC DENTISTRY, 4(4), 338â€“347.

-CAIRO, F., NIERI, M., CINCINELLI, S., MERVELT, J., & PAGLIARO, U. (2011). THE INTERPROXIMAL CLINICAL ATTACHMENT LEVEL TO CLASSIFY GINGIVAL RECESSIONS AND PREDICT ROOT COVERAGE OUTCOMES: AN EXPLORATIVE AND RELIABILITY STUDY. JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, 38(7), 661â€“666. HTTPS://DOI.ORG/10.1111/J.1600-051X.2011.01732.X

Título del trabajo *

MANEJO PERIODONTAL EN PACIENTE CON ANTECEDENTES DE CONSUMO CRÃ“NICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: REPORTE DE CASO

Nombre del Autor (a/es)*

M.E Ramos Ortiz Laura Julissa

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Mtra. Mayemi Pamela Santiago MartÃ-nez, , Esp. CalderÃ³n Aguado Alejandro, , , , , , .

Correo Electrónico *

julissaortiz9@gmail.com

Institución *

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LE

Introducción y Objetivos *

LA ENFERMEDAD PERIODONTAL ESTÃ INFLUENCIADA POR MÃšLTIPLES FACTORES SISTÃ‰MICOS Y CONDUCTUALES QUE PUEDEN ACELERAR SU PROGRESIÃ“N Y DIFICULTAR SU CONTROL(1).EL CONSUMO CRÃ“NICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS COMO EL TABACO, EL ALCOHOL, EL CANNABIS Y, PARTICULARMENTE, LA METANFETAMINA (MA), SE HA RELACIONADO CON UNA MAYOR SEVERIDAD DE LA PERIODONTITIS Y UN PEOR PRONÃ“STICO A LARGO PLAZO.

EL CANNABIS, PUEDE AFECTAR SIGNIFICATIVAMENTE LA SALUD ORAL. SU CONSUMO ESTÃ RELACIONADO CON XEROSTOMÃA, ALTERACIÃ“N DEL GUSTO, AUMENTO EN LA ACUMULACIÃ“N DE PLACA BACTERIANA Y MAYOR RIESGO DE CARIES. ADEMÃS, SU EFECTO INMUNOMODULADOR PUEDE COMPROMETER LA RESPUESTA DEL HUÃ‰SPED FRENTE A LA ENFERMEDAD PERIODONTAL.(2)

POR OTRA PARTE, LA METANFETAMINA ES UN POTENTE ESTIMULANTE DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL QUE INCREMENTA LOS NIVELES DE DOPAMINA, SEROTONINA Y NORADRENALINA, GENERANDO EFECTOS DE EUFORIA, HIPERACTIVIDAD Y DISMINUCIÃ“N DEL APETITO. SU USO PROLONGADO PROVOCA XEROSTOMÃA SEVERA, DISMINUCIÃ“N DEL PH SALIVAL, LESIONES CARIOSAS EXTENSAS, PÃ‰RDIDA DENTAL, DISGEUSIA, EROSIÃ“N DEL ESMALTE Y ENFERMEDAD PERIODONTAL AVANZADA.(3) LA ASOCIACIÃ“N DENTAL AMERICANA HA PROPUESTO EL TÃ‰RMINO "BOCA DE METANFETAMINA" PARA DESCRIBIR EL PATRÃ“N CARACTERÃSTICO DE DESTRUCCIÃ“N DENTAL AGRESIVA, CON CARIES CERVICALES Y DIENTES ENNEGRECIDOS, DESMORONADOS O AUSENTES.

EN MÃ‰XICO, SEGÃšN LA ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO (ENCODAT) 2016â€“2017, EL 5.3% DE LA POBLACIÃ“N HA CONSUMIDO ALGUNA DROGA ILÃCITA, SIENDO EL CANNABIS LA MÃS PREVALENTE, SEGUIDA DE LAS METANFETAMINAS Y ANFETAMINAS.(4)

LOS CONSUMIDORES CRÃ“NICOS DE ESTAS SUSTANCIAS PRESENTAN CON FRECUENCIA NIVELES ELEVADOS DE PLACA, GINGIVITIS SEVERA, PÃ‰RDIDA DE INSERCIÃ“N CLÃNICA Y POBRE HIGIENE ORAL, LO CUAL REPRESENTA UN RETO CLÃNICO IMPORTANTE PARA EL MANEJO PERIODONTAL, DEMANDANDO UN ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO Y ESTRATEGIAS PERSONALIZADAS PARA PRESERVAR LA SALUD BUCAL.

OBJETIVO

DESCRIBIR EL MANEJO CLÃNICO-PERIODONTAL DE UN PACIENTE CON PERIODONTITIS CON ANTECEDENTES DE CONSUMO CRÃ“NICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

Descripción del Caso *

SE REPORTA PACIENTE MASCULINO DE 38 AÃ‘OS, CON ANTECEDENTES DE CONSUMO CRÃ“NICO DE METANFETAMINAS, TABAQUISMO Y ETILISMO PROLONGADO. EL MOTIVO DE CONSULTA FUE: â€œDESEO ARREGLARME LOS DIENTESâ€. EL PACIENTE FUE REFERIDO DEL POSGRADO DE PATOLOGÃA BUCAL Y MAXILOFACIAL, DONDE SE OBSERVARON LESIONES PAPULARES EN EL BORDE LATERAL IZQUIERDO DE LA LENGUA, UNA ÃšLCERA TRAUMÃTICA EN MUCOSA LABIAL INFERIOR Y LESIONES EROSIVAS COMPATIBLES CON IMPÃ‰TIGO EN REMISIÃ“N EN LA PIEL DEL LABIO INFERIOR. EL DIAGNÃ“STICO FUE ÃšLCERA TRAUMÃTICA POR BORDES CORTANTES.

DURANTE LA VALORACIÃ“N INICIAL EN EL POSGRADO DE PERIODONCIA, SE OBSERVÃ“ PRESENCIA DE BIOPELÃCULA, CÃLCULO SUPRAGINGIVAL, MÃšLTIPLES LESIONES CARIOSAS, TEJIDOS GINGIVALES CON ERITEMA, EDEMA, SANGRADO ESPONTÃNEO Y AGRANDAMIENTO GINGIVAL LOCALIZADO EN DIENTES ANTEROINFERIORES. SE REALIZÃ“ EL LLENADO DE FICHA PERIODONTAL, REGISTRANDO PROFUNDIDADES DE SONDAJE ENTRE 2 Y 7 MM, PÃ‰RDIDA DE INSERCIÃ“N DE 4MM Y SANGRADO AL SONDAJE DE 78%. EL ÃNDICE DE CONTROL DE BIOPELÃCULA PERSONAL FUE DE 69%.

DIAGNÃ“STICO

CON BASE EN LOS HALLAZGOS SISTÃ‰MICOS, CLÃNICOS, RADIOGRÃFICOS SE ESTABLECIÃ“ EL DIAGNÃ“STICO DE PERIODONTITIS ESTADIO III GENERALIZADA GRADO C.

PROCEDIMIENTOS

EL PLAN DE TRATAMIENTO PERIODONTAL SE ESTRUCTURÃ“ SIGUIENDO LA GUÃA PRÃCTICA CLÃNICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA PERIODONTITIS EN SUS ESTADIOS I, II Y III.

EL PRIMER PASO DE LA TERAPIA TUVO COMO OBJETIVO MOTIVAR Y MODIFICAR EL COMPORTAMIENTO DEL PACIENTE, EL CUAL CONSISTIO EN MOTIVACIÃ“N DEL PACIENTE E INSTRUCCIÃ“N EN TÃ‰CNICAS DE HIGIENE ORAL Y REMOCIÃ“N MECÃNICA PROFESIONAL DE CÃLCULO Y BIOPELÃCULA, SE IMPLEMENTÃ“ UN PROTOCOLO DE CONTROL DE BIOPELÃCULA, CON SEGUIMIENTO EN SEIS CITAS CONSECUTIVAS, PARA ASEGURAR LA EFICACIA DE LAS INTERVENCIONES Y LA ADHERENCIA DEL PACIENTE AL TRATAMIENTO.

EL SEGUNDO PASO DE LA TERAPIA DE LA PERIODONTITIS CONSISTIÃ“ EN LA INSTRUMENTACIÃ“N SUBGINGIVAL DE LOS CUATRO CUADRANTES CON EL OBJETIVO DE REDUCIR/ELIMINAR LA BIOPELÃCULA SUBGINGIVAL Y EL CÃLCULO, REALIZADA EN DOS CITAS (DOS CUADRANTES POR SESIÃ“N) Y COMPLEMENTADA CON EL USO DE CLORHEXIDINA COMO TERAPIA COADYUVANTE.

EL TERCER PASO DE LA TERAPIA PERIODONTAL ABORDÃ“ ÃREAS SIN RESPUESTA AL TRATAMIENTO PREVIO, BUSCANDO MEJORAR EL ACCESO SUBGINGIVAL. SE REALIZÃ“ GINGIVECTOMÃA EN EL SECTOR ANTERIOR MANDIBULAR (33-43) PARA ELIMINAR AGRANDAMIENTO GINGIVAL PERSISTENTE, OPTIMIZAR LA HIGIENE Y RESOLVER BOLSAS PERIODONTALES.

COMO PARTE DEL MANEJO INTEGRAL DEL CASO, SE REALIZARON INTERCONSULTAS CON LA CLÃNICA DE ENDODONCIA PARA LA EVALUACIÃ“N DE PIEZAS CON COMPROMISO PULPAR, ASÃ COMO CON EL POSGRADO DE REHABILITACIÃ“N ORAL E IMPLANTOLOGÃA CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER UN PLAN RESTAURATIVO Y PROTÃ‰SICO A LARGO PLAZO.

Resultados y Conclusiones *

CON LA IMPLEMENTACIÃ“N DEL TRATAMIENTO PERIODONTAL, EL PACIENTE LOGRÃ“ UN ADECUADO CONTROL DE LA BIOPELÃ□CULA. EN LA PRIMERA CITA SE REGISTRÃ“ UN 69%, MIENTRAS QUE EN LA ÃšLTIMA VISITA DE CONTROL ESTE VALOR DISMINUYÃ“ AL 20%, EVIDENCIANDO UNA MEJORA SIGNIFICATIVA EN SUS HÃ□BITOS DE HIGIENE ORAL.

DURANTE LAS SESIONES DE SEGUIMIENTO, SE OBSERVÃ“ UNA MEJORA SIGNIFICATIVA EN LA TÃ‰CNICA DE CEPILLADO, ACOMPAÃ‘ADA DE UNA DISMINUCIÃ“N DEL SANGRADO AL SONDAJE, QUE PASÃ“ DE UN 89.43% EN LA EVALUACIÃ“N INICIAL A UN 5% EN LA CITA DE REVALORACIÃ“N. EN LA FICHA PERIODONTAL DE REVALORACIÃ“N SE REGISTRARON PROFUNDIDADES DE SONDAJE ENTRE 1 Y 3 MM, EVIDENCIANDO UNA RESPUESTA CLÃ□NICA FAVORABLE AL TRATAMIENTO NO QUIRÃšRGICO.

POSTERIOR A LA GINGIVECTOMÃ□A EN EL SECTOR ANTEROINFERIOR, LOS TEJIDOS GINGIVALES PRESENTARON UN ASPECTO SALUDABLE, CON REDUCCIÃ“N DEL VOLUMEN GINGIVAL, MÃ□RGENES BIEN CONTORNEADOS Y UNA CICATRIZACIÃ“N ADECUADA. ESTA INTERVENCIÃ“N QUIRÃšRGICA PERMITIÃ“ UNA MEJORA EN LA ANATOMÃ□A GINGIVAL, FAVORECIENDO EL ACCESO PARA EL CONTROL MECÃ□NICO DE BIOPELÃ□CULA Y FACILITANDO LA HIGIENE ORAL POR PARTE DEL PACIENTE.

EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS REPRESENTA UN RETO PARA LA SALUD BUCODENTAL Y EL TRATAMIENTO PERIODONTAL, ESPECIALMENTE POR LA PRESENCIA DE FACTORES CONCOMITANTES COMO POLICONSUMO, TABAQUISMO Y CONDICIONES PSICOSOCIALES QUE COMPLICAN EL MANEJO CLÃ□NICO.

EL MANEJO EXITOSO DE PACIENTES CON ANTECEDENTES DE CONSUMO O ADICCIÃ“N REQUIERE UN ABORDAJE INTEGRAL Y MULTIDISCIPLINARIO ES CLAVE PARA EL Ã‰XITO TERAPÃ‰UTICO. EN ESTE CONTEXTO, EL TRATAMIENTO PERIODONTAL ES FUNDAMENTAL PARA CONTROLAR LA ENFERMEDAD, MEJORAR LA SALUD ORAL Y PREVENIR COMPLICACIONES MAYORES. LA TERAPIA PERIODONTAL CONTRIBUYE A LA RESTAURACIÃ“N DE TEJIDOS GINGIVALES SANOS, MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE Y FACILITA LA ADHERENCIA A LAS MEDIDAS DE AUTOCUIDADO.

LA DIFUSIÃ“N DE CASOS CLÃ□NICOS COMO ESTE CONTRIBUYE A AUMENTAR LA CONCIENCIA PROFESIONAL SOBRE LAS COMPLICACIONES Y PARTICULARIDADES QUE PRESENTA EL TRATAMIENTO ODONTOLÃ“GICO EN PACIENTES CON CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, PROMOVIENDO MEJORES ESTRATEGIAS PREVENTIVAS, COMO REALIZAR CAMPAÃ‘AS DE CONCIENTIZACIÃ“N EN CLÃ□NICAS Y ENTORNOS COMUNITARIOS SOBRE LOS EFECTOS

Bibliografía *

1. PAPAPANOU PN, SANZ M, BUDUNELI N, DIETRICH T, FERES M, FINE DH, ET AL. PERIODONTITIS: CONSENSUS REPORT OF WORKGROUP 2 OF THE 2017 WORLD WORKSHOP ON THE CLASSIFICATION OF PERIODONTAL AND PERI-IMPLANT DISEASES AND CONDITIONS. J PERIODONTOL. 2018;89(SUPPL 1):S173â€“82. DOI:10.1002/JPER.17-0721

2. TEOH L, MOSES G, MCCULLOUGH MJ. ORAL MANIFESTATIONS OF ILLICIT DRUG USE. AUST DENT J. 2019 SEP;64(3):213â€“22. DOI:10.1111/ADJ.12709.

3. ALQARNI H, ALDGHIM A, ALKAHTANI R, ALSHAHRANI N, ALTOMAN MS, ALFAIFI MA, ET AL. CRYSTAL METHAMPHETAMINE AND ITS EFFECTS ON MENTAL AND ORAL HEALTH: A NARRATIVE REVIEW. SAUDI DENT J. 2024;36(5):665â€“73. DOI:10.1016/J.SDENTJ.2024.02.011.

4. SECRETARÃ□A DE SALUD, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÃšBLICA. ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO 2016-2017 [INTERNET]. MÃ‰XICO: SECRETARÃ□A DE SALUD; 2017 [CITADO 2018 JUN 28]. DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.GOB.MX/CMS/UPLOADS/ATTACHMENT/FILE/234856/CONSUMO_DE_DROGAS.PDF

Título del trabajo *

TRATAMIENTO EN RECESIONES MÃšLTIPLES RT1 CON FISURAS DE STILLMAN EN MAXILAR MEDIANTE TÃ‰CNICA VISTA E INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO SUBEPITELIAL.

Nombre del Autor (a/es)*

Garcia BojÃ³rquez Jessica Alejandra 1, Rosales Luvi

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Correo Electrónico *

jessica.garcia@uabc.edu.mx

Institución *

UNIVERSIDAD AUTÃ“NOMA DE BAJA CALIFORNIA, FACULTAD

Introducción y Objetivos *

LA RECESIÃ“N GINGIVAL SE DEFINE COMO LA MIGRACIÃ“N APICAL DEL MARGEN CON RESPECTO A LA UNIÃ“N CEMENTO-ESMALTE.Â[1] EN CUANTO A SU ETIOLOGÃ□A, LAS RECESIONES GINGIVALES SON DE ORIGEN MULTIFACTORIAL E INCLUYE FACTORES COMO LA OCLUSIÃ“N, EL CEPILLADO DENTAL TRAUMÃ□TICO, EL USO INCORRECTO DEL HILO DENTAL, ENTRE OTRAS.3 DENTRO DE LOS DEFECTOS ASOCIADOS A LAS RECESIONES GINGIVALES SE ENCUENTRA LA FISURA DE STILLMAN, DE FORMA TRIANGULAR Y CON UNA LONGITUD DE HASTA 5-6MM.2,3 CON LA FINALIDAD DE ESTANDARIZAR LA EVALUACIÃ“N Y PREDECIR LOS RESULTADOS DE DICHOS DEFECTOS, CAIRO Y COLABORADORES EN 2011 PROPUSIERON UNA CLASIFICACIÃ“N QUE LAS SEPARAN EN RT1, RECESIÃ“N SIN PÃ‰RDIDA DE INSERCIÃ“N INTERPROXIMAL; RT2, RECESIÃ“N CON PÃ‰RDIDA DE INSERCIÃ“N INTERPROXIMAL MENOR O IGUAL QUE LA DEL SITIO VESTIBULAR; Y RT3 PÃ‰RDIDA DE INSERCIÃ“N INTERPROXIMAL MAYOR QUE LA DEL SITIO VESTIBULAR.2

CON EL OBJETIVO DE TRATAR ESTE TIPO DE DEFECTOS MUCOGINGIVALES, MÃšLTIPLES ABORDAJES SE HAN DESCRITO, DESDE AQUELLOS QUE TIENEN ENFOQUE EN RECESIONES UNITARIAS HASTA LOS QUE SE ESPECIALIZAN EN RECESIONES MÃšLTIPLES. ESTÃ□S ÃšLTIMAS REPRESENTAN UN RETO FUNCIONAL Y ESTÃ‰TICO, Y DEBIDO A ESTO SE DESARROLLÃ“ LA TÃ‰CNICA VISTA (ACCESO MEDIANTE TÃšNEL SUBPERIÃ“STICO POR INCISIÃ“N VESTIBULAR), LA CUAL MEDIANTE UNA INCISIÃ“N VESTIBULAR PERMITE UN ACCESO MÃ□S AMPLIO Y CONTROLADO A LA ZONA QUIRÃšRGICA, MINIMIZA EL RIESGO DE DAÃ‘O A LOS TEJIDOS SULCULARES, PRESERVA LA INTEGRIDAD PAPILAR, PERMITE EL TRATAMIENTO DE RECESIONES MÃšLTIPLES CONTIGUAS Y FAVORECE CONDICIONES Ã“PTIMAS PARA LA CICATRIZACIÃ“N.1

EL INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO SUBEPITELIAL, COMBINADO CON OTRAS TÃ‰CNICAS QUIRÃšRGICAS, OPTIMIZA LA PREDICTIBILIDAD Y ESTABILIDAD A LARGO PLAZO, MANTENIÃ‰NDOSE COMO EL ESTÃ□NDAR DE ORO EN COBERTURA RADICULAR.1,2,

OBJETIVO

EVALUAR LA EFECTIVIDAD CLÃ□NICA Y ESTÃ‰TICA DE LA TÃ‰CNICA VISTA COMBINADA CON INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO SUBEPITELIAL EN EL TRATAMIENTO DE RECESIONES MÃšLTIPLES MAXILARES RT1 DE CAIRO CON FISURAS DE STILLMAN.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINA DE 36 AÃ‘OS, ACUDE A LA CLÃ NICA DE LA ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÃ“NOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS TIJUANA, REFIRIENDO â€œSENSIBILIDAD DENTAL Y DIENTES LARGOSâ€ . A LA EXPLORACIÃ“N CLÃ NICA SE OBSERVAN MÃšLTIPLES RECESIONES RADICULARES RT1 EN MAXILAR CON FISURAS DE STILLMAN LOCALIZADAS. POR LO QUE SE INDICA TRATAMIENTO PLÃ STICO-PERIODONTAL MEDIANTE TÃ‰CNICA VISTA CON INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO SUBEPITELIAL.

PARA INICIAR EL TRATAMIENTO SE LLEVÃ“ A CABO RASPADO Y ALISADO RADICULAR CON CURETAS GRACEY Y SE ACONDICIONAMIENTO CON EDTA 24% POR 2 MINUTOS PARA ELIMINACIÃ“N DE BARRILLO DENTINARIO. POSTERIOR A ESTO, SE REALIZARON TRES 3 INCISIONES VISTA EN MUCOSA ALVEOLAR: UNA DISTAL AL FRENILLO LABIAL Y 2 DISTALES A CANINOS, SEGUIDAS DE TUNELIZACIÃ“N DEL OD 16 AL 25 EXTENDIÃ‰NDOSE A LA LÃ NEA MUCOGINGIVAL CON DESINSERCIONES DE FIBRAS MUSCULARES INTERNAS Y EN SENTIDO CORONAL SE ELEVÃ“ LA ENCÃ A ADHERIDA HASTA EL SURCO GINGIVAL, PRESERVANDO LA BASE DE LAS PAPILAS INTERPROXIMALES, PERMITIENDO UN AVANCE CORONAL PASIVO DEL COLGAJO.

A CONTINUACIÃ“N, SE OBTUVO UN INJERTO GINGIVAL LIBRE DEL PALADAR SEGÃšN LO DESCRITO POR ZUCCHELLI CON DIMENSIONES DE 25X12MM, SE DESEPITELIALIZÃ“ CON UNA HOJA 15C, DEJANDO UN ESPESOR UNIFORME DE 1 MM Y SE DIVIDIÃ“ EN 3 PORCIONES DE 25X4MM. EN LA ZONA DONADORA SE PROTEGIÃ“ CON MEMBRANA DE COLÃ GENO Y RESINA FLUIDA.

UNA VEZ OBTENIDO, EL INJERTO SUBEPITELIAL DE TEJIDO CONECTIVO SE INTRODUJO POR LAS INCISIONES VISTA, Y SE FIJÃ“ POR DISTAL Y MESIAL. UNA VEZ FIJADO, EL COLGAJO SE SUTURÃ“ CON PUNTOS SUSPENSORIOS Y EN LAS INCISIONES VISTA SE REALIZÃ“ TÃ‰CNICA DE PUNTOS SIMPLES Y SHANELEC. SE INDICO EVITAR EL CEPILLADO EN EL Ã REA TRATADA, SE RECETO AMOXICILINA 500 MG 1 CÃ PSULA CADA 8 HORAS POR 7 DÃ AS, IBUPROFENO 600 MG 1 TABLETA CADA 8 HORAS POR 5 DÃ AS Y ENJUAGUES DE CLORHEXIDINA AL 0.12% DOS VECES AL DÃ A POR DOS SEMANAS. SE REALIZÃ“ RETIRO DE SUTURAS A LAS DOS SEMANAS Y SE DIO SEGUIMIENTO A LAS CUATRO SEMANAS.

Resultados y Conclusiones *

EL PROCEDIMIENTO PERMITIÃ“ COBERTURA RADICULAR COMPLETA Y AUMENTO DEL GROSOR DEL TEJIDO BLANDO EN LAS RECESIONES TRATADAS, CON CICATRIZACIÃ“N ADECUADA Y SIN SIGNOS INFLAMATORIOS. EL INJERTO SE INTEGRÃ“ COMPLETAMENTE Y EL MARGEN GINGIVAL SE MANTUVO ESTABLE EN POSICIÃ“N CORONAL DURANTE EL SEGUIMIENTO.

LA PACIENTE REFIRIÃ“ RESOLUCIÃ“N DE LA HIPERSENSIBILIDAD Y ALTA SATISFACCIÃ“N ESTÃ‰TICA. LA AUSENCIA DE COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS Y LA ESTABILIDAD CLÃ NICA OBSERVADA RESPALDAN LA PREDICTIBILIDAD DE LA TÃ‰CNICA VISTA COMBINADA CON INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO SUBEPITELIAL, INCLUSO EN PRESENCIA DE FISURAS DE STILLMAN.

LA EVALUACIÃ“N CLÃ NICA DE LA TÃ‰CNICA VISTA COMBINADA CON INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO SUBEPITELIAL EN RECESIONES MÃšLTIPLES MAXILARES RT1 DE CAIRO CON FISURAS DE STILLMAN, CONFIRMÃ“ LA ALTA EFECTIVIDAD DEL PROCEDIMIENTO Y SE LOGRÃ“ EL OBJETIVO PLANTEADO.

ESTE ABORDAJE QUIRÃšRGICO, AL PROPORCIONAR ACCESO AMPLIO Y PRESERVAR LA INTEGRIDAD DE LOS TEJIDOS PAPILARES, OPTIMIZA LA ADAPTACIÃ“N DEL INJERTO Y FAVORECE LA CICATRIZACIÃ“N, CONSTITUYENDO UNA ALTERNATIVA EFICAZ FRENTE A TÃ‰CNICAS CONVENCIONALES PARA EL TRATAMIENTO DE RECESIONES MÃšLTIPLES.

Bibliografía *

1. ZADEH HH. MINIMALLY INVASIVE TREATMENT OF MAXILLARY ANTERIOR GINGIVAL RECESSION DEFECTS BY VESTIBULAR INCISION SUBPERIOSTEAL TUNNEL ACCESS AND PLATELET DERIVED GROWTH FACTOR BB. INT J PERIODONTICS RESTOR DENTISTRY. 2011;31(6):653.

2. ZUCCHELLI G, MOUNSSIF I. PERIODONTAL PLASTIC SURGERY. PERIODONTOL 2000. 2015;68(1):333â€“68.

3. CASSINI MA, CERRONI L, FERLOSIO A, ORLANDI A, PILLONI A. THE GINGIVAL STILLMANâ€™S CLEFTS: HISTOPATHOLOGY AND CELLULAR CHARACTERISTICS. ANN STOMATOL (ROMA). 2016; 6(3-4): 100-103.

Título del trabajo *

MANEJO CLÃ□NICO PERIODONTAL DE PRESERVACIÃ“N DE REBORDE ALVEOLAR ASOCIADO A HALLAZGO TOMOGRÃ□FICO

Nombre del Autor (a/es)*

VÃ¡zquez Ojeda Aransazu

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Mtra. Santiago MartÃ-nez Mayemi Pamela, Mtra. HernÃ¡ndez GÃ³mez Gabriela, , , , , , , .

Correo Electrónico *

aransa.vazquez@gmail.com

Institución *

ENES UNAM UNIDAD LEÃ“N

Introducción y Objetivos *

LA PRESERVACIÃ“N DE REBORDE ALVEOLAR CONSISTE EN REDUCIR LA REABSORCIÃ“N POST EXTRACCIÃ“N MEDIANTE EL RELLENO DEL ALVEOLO CON PARTÃCULAS DE INJERTO Ã“SEO, EL CUAL, PUEDE SER CUBIERTO O NO CON MATERIALES ABSORBIBLES O NO ABSORBIBLES, PARA EVITAR LA MIGRACIÃ“N DEL TEJIDO GINGIVAL. LA FINALIDAD DE ESTE PROCEDIMIENTO ES CONSERVAR EL CONTORNO Y ALTURA Ã“SEA FAVORECIENDO LA ESTABILIDAD DE TEJIDOS BLANDOS.

LOS QUISTES DE RETENCIÃ“N MUCOSA SON LESIONES BENIGNAS Y AUTOLIMITANTES, POCO FRECUENTES, QUE SE ORIGINAN POR LA OBSTRUCCIÃ“N DE DUCTOS NASOANTRALES O DE LAS GLÃNDULAS MUCOSAS, PROVOCANDO LA POSTERIOR ACUMULACIÃ“N DE FLUIDO MUCOSO. EXISTEN MÃšLTIPLES FACTORES ETIOLÃ“GICOS, DENTRO DE LOS CUALES DESTACAN, ALERGIAS, ALTERACIONES ANATÃ“MICAS EN EL COMPLEJO OSTEO-MEATAL, TRAUMATISMOS E INFECCIONES PERIAPICALES Y PERIODONTALES.

POR LO GENERAL, LAS LESIONES SON DE CRECIMIENTO LENTO Y ASINTOMÃTICAS, SIN EMBARGO, EN CASOS SINTOMÃTICOS SE PRESENTAN CEFALEAS, DOLOR FACIAL, DOLOR PERI-ORBITAL, INFECCIONES FRECUENTES EN SENOS PARANASALES Y OBSTRUCCIÃ“N NASAL. SE HA REPORTADO EN LA LITERATURA QUE PUEDEN PROVOCAR REABSORCIÃ“N Ã“SEA. DICHAS CONDICIONES PUEDEN SUGERIR LA NECESIDAD DE TRATAMIENTO QUIRÃšRGICO.

RADIOGRÃFICAMENTE EL QUISTE SE OBSERVA COMO UNA FIGURA REDONDEADA, RADIOPACA Y GENERALMENTE SE SITÃšA EN EL PISO DEL SENO.

EL OBJETIVO DEL PRESENTE CARTEL ES, EXPONER EL MANEJO DE UNA PRESERVACIÃ“N DE REBORDE TRAS EL HALLAZGO TOMOGRÃFICO DE UN QUISTE DE RETENCIÃ“N MUCOSO.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINO DE 47 AÃ‘OS, ASA I, EN ESTADO ASINTOMÃ□TICO, REFERIDA DEL POSGRADO DE ENDODONCIA POR HALLAZGO DE FISURAS RADICULARES PALATINA Y MESIAL QUE COMUNICAN CON PISO PULPAR DE DIENTE 26, CON TRATAMIENTO PREVIO DE CONDUCTOS CON ENDOPOSTE Y PRONÃ“STICO NO FAVORABLE PARA REHABILITACIÃ“N.

EN LA INSPECCIÃ“N CLÃ□NICA SE OBSERVA FENOTIPO GINGIVAL GRUESO, ERITEMA GINGIVAL PAPILAR LOCALIZADO, HIPERPLASIA GINGIVAL EN DISTAL DE DIENTE 37, MÃšLTIPLES FISURAS EN CORONAS CLÃ□NICAS, RESTAURACIONES DESAJUSTADAS Y FRACTURADAS, DISCROMÃ□A Y REDUCCIÃ“N CONSIDERABLE DE LONGITUD CERVICO-OCLUSAL DE CORONA CLÃ□NICA DE DIENTE 26.

EN LA RADIOGRAFÃ□A PERIAPICAL, SE OBSERVA LESIÃ“N REDONDEADA RADIOLÃšCIDA CON BORDES BIEN DEFINIDOS LOCALIZADA ALREDEDOR DE TERCIO APICAL DE RAÃ□Z MEVE Y ENSANCHAMIENTO DEL LIGAMENTO PERIODONTAL. EN IMAGEN PANORÃ□MICA, SE OBSERVA RADIOPACIDAD DIFUSA EN SENO MAXILAR IZQUIERDO.

EN TOMOGRAFÃ□A SE OBSERVA ENGROSAMIENTO HIPERDENSO A NIVEL DE PISO DE SENO MAXILAR EN RELACIÃ“N CON LESIÃ“N HIPODENSA QUE INVOLUCRA LA RAÃ□Z MEVE. AMBAS CORTICALES ESTÃ□N INTACTAS.

SE DIAGNOSTICA LESIÃ“N ENDOPERIODONTAL CON DAÃ‘O RADICULAR EN DIENTE 26 EN PACIENTE SIN PERIODONTITIS. CON APOYO DE POSGRADO DE REHABILITACIÃ“N SE REALIZA PLAN DE TRATAMIENTO DONDE SE SUGIERE ODONTECTOMÃ□A CON PRESERVACIÃ“N DE REBORDE Y REHABILITACIÃ“N CON IMPLANTE DIFERIDO A 8 MESES TRAS CONFECCIÃ“N DE FÃ‰RULA DE DESPROGRAMACIÃ“N Y REHABILITACIÃ“N DE SECTOR POSTERIOR CON TABLE TOPS PARA AUMENTAR DIMENSIÃ“N VERTICAL.

LA INTERCONSULTA CON OTORRINOLARINGOLOGÃ□A ESTABLECE DIAGNÃ“STICO DE QUISTE DE RETENCIÃ“N MUCOSO TRAS EVALUACIÃ“N POR ENDOSCOPÃ□A NASAL. LA SUGERENCIA DEL ESPECIALISTA ES QUE NO SE REQUIERE NINGUNA INTERVENCIÃ“N PREVIA O POSTERIOR AL PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO PLANIFICADO.

Resultados y Conclusiones *

SE EMPLEÃ“ ARTICAÃ NA AL 4% CON EPINEFRINA 1:100,000 COMO ANESTÃ‰SICO. SE REALIZÃ“ SINDESMOTOMÃ A CON PERIOTOMO PT1 Y ODONTOSECCIÃ“N CON FRESA DE BAJA VELOCIDAD 702. TRAS REMOCIÃ“N DE TEJIDO GRANULOMATOSO, SE CONDENSÃ“ 1 CC DE XENOINJERTO, DE GRÃ NULOS DE 0.25-1.0MM. SE CONFORMA TAPÃ“N DE COLÃ GENO 1CM X 2 CM A LA MORFOLOGÃ A DEL ALVEOLO. SE REALIZA SUTURA EN CRUZ CON VICRYL 5-0, Y 3 PUNTOS SIMPLES. SE CONTINUÃ“ PLAN TERAPÃ‰UTICO CON COBERTURA ANTIBIÃ“TICA, ANALGÃ‰SICA Y CONTROL INFLAMATORIO.

A LAS 6 SEMANAS POSTERIORES AL PROCEDIMIENTO LA CICATRIZACIÃ“N DE LAS HERIDAS FUE EVALUADA UTILIZANDO EL ÃNDICE DE CICATRIZACIÃ“N DE LANDRY, TURNBULL Y HOWLEY. LA PUNTUACIÃ“N OBTENIDA FUE 4 PUNTOS, LO QUE CORRESPONDA A UNA CATEGORÃ A BUENA. EL CONTORNO DEL REBORDE ALVEOLAR CON CONDICIONES QUE FAVORECEN UNA FUTURA REHABILITACIÃ“N PROTÃ‰SICA IMPLANTOSOPORTADA.

EN EL PRESENTE CASO, LA PACIENTE SE ENCONTRABA ASINTOMÃ TICA, SIN OBSTRUCCIONES NASALES, ASIMETRÃ A FACIAL O DATOS DE EXPANSIÃ“N O RESORCIÃ“N Ã“SEA. EL MAYOR RIESGO ERA LA POSIBLE COMUNICACIÃ“N BUCO SINUSAL DURANTE LA EXTRACCIÃ“N. POR OTRO LADO, CONSIDERANDO LAS DIMENSIONES DEL REBORDE Y LA EJECUCIÃ“N DE LA PRESERVACIÃ“N DEL MISMO, SE ESPERA EVITAR LA NECESIDAD DE UNA ELEVACIÃ“N DE SENO MAXILAR PARA LA FUTURA REHABILITACIÃ“N EN LA ZONA. BASADO EN LA INFORMACIÃ“N ACTUAL DE LA LITERATURA Y DEL CASO, EN CONJUNTO CON LA INTERCONSULTA CON OTORRINOLARINGOLOGÃ A, SE OPTÃ“ POR MANTENER SEGUIMIENTO SIN TRATAMIENTO.

VARIOS AUTORES RECOMIENDAN LA REMOCIÃ“N DE LOS QUISTES DE RETENCIÃ“N MUCOSA PREVIO A LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES Y, SOBRE TODO, EN CASOS QUE INVOLUCREN ELEVACIÃ“N DE SENO MAXILAR PARA EVITAR COMPLICACIONES POSTERIORES. SIN EMBARGO, SE HA DESCRITO TAMBIÃ‰N QUE, EN CASOS ASINTOMÃ TICOS, DONDE NO SE REALIZA LA REMOCIÃ“N DE Ã‰STOS, NO SE REPORTA UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA EN EL PRONÃ“STICO DE LOS IMPLANTES COLOCADOS. POR OTRO LADO, LOS ESTUDIOS INCLUIDOS EN REVISIONES SISTEMÃ TICAS SON EN GENERAL REPORTES DE CASOS EXTREMADAMENTE HETEROGÃ‰NEOS Y NO PROPORCIONAN INFORMACIÃ“N CONSECUTIVA DE LA EVOLUCIÃ“N, REQUIRIÃ‰NDOSE INVESTIGACIONES CON ENSAYOS CLÃ NICOS ALEATORIZADOS PARA UNA EVIDENCIA CONCRETA.

LA DECISIÃ“N DE MANTENER O REMOVER LOS QUISTES DE RETENCIÃ“N MUCOSA DEBE DE SER PLANIFICADA DE ACUERDO CON LOS SIGNOS Y SÃ NTOMAS DEL PACIENTE, DIMENSIONES DEL REBORDE, NECESIDADES

Bibliografía *

1.ATIEH MA, ALSABEEHA NH, PAYNE AG, ALI S, FAGGION CM JR, ESPOSITO M. INTERVENTIONS FOR REPLACING MISSING TEETH: ALVEOLAR RIDGE PRESERVATION TECHNIQUES FOR DENTAL IMPLANT SITE DEVELOPMENT. COCHRANE DATABASE SYST REV [INTERNET]. 2021;4(4):CD010176. DISPONIBLE EN: HTTP://DX.DOI.ORG/10.1002/14651858.CD010176.PUB3

2.AVILA-ORTIZ G, ELANGOVAN S, KRAMER KWO, BLANCHETTE D, DAWSON DV. EFFECT OF ALVEOLAR RIDGE PRESERVATION AFTER TOOTH EXTRACTION: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS. J DENT RES [INTERNET]. 2014;93(10):950â€“8. DISPONIBLE EN: HTTP://DX.DOI.ORG/10.1177/0022034514541127

3.AGHAEE F, MOUDI E, VAHDANI N, BIJANI A, HAGHANIFAR S. EVALUATION OF ANATOMICAL VARIATIONS OF THE MAXILLARY SINUS IN PATIENTS WITH AND WITHOUT MUCOUS RETENTION CYST. EAR NOSE THROAT J [INTERNET]. 2023;1455613231206284. DISPONIBLE EN: HTTP://DX.DOI.ORG/10.1177/01455613231206284

4. GAJUL M, BHATE K, AWATE S, KAKODKAR P, SHAH S. COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFICACY OF WOUND HEALING WITH AND WITHOUT DEHYDRATED HUMAN AMNIOTIC/CHORIONIC MEMBRANE IN ALVEOLOPLASTY: A

Título del trabajo *

ABORDAJE QUIRÃšRGICO DE ENFERMEDAD PERIODONTAL AVANZADA: REPORTE DE CASO

Nombre del Autor (a/es)*

ROCHA CORONEL VICTORIA CATALINA

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

SANTIAGO MARTÃ□NEZ MAYEMI PAMELA, LEÃ“N GÃ“MEZ ADRIÃ□N, , , , , , , .

Correo Electrónico *

vicroc39@gmail.com

Institución *

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD LEÃ“

Introducción y Objetivos *

LA PERIODONTITIS EN ESTADIO IV SE DEFINE POR LA GRAVEDAD DE LA ENFERMEDAD CON BASE EN VARIABLES PERIODONTALES IGUALES A LAS DEL ESTADIO III, PERO CON UNA PÃ‰RDIDA DENTAL DE UN MÃ□NIMO DE CINCO PIEZAS Y LA NECESIDAD DE UNA REHABILITACIÃ“N COMPLEJA. ESTA CONDICIÃ“N A MENUDO REQUIERE UNA REHABILITACIÃ“N COMPLEJA DEBIDO A LA PRESENCIA DE DISFUNCIÃ“N MASTICATORIA; LA PÃ‰RDIDA DENTAL SE RECONOCE COMO UNA CAUSA PRINCIPAL DE DETERIORO FUNCIONAL DE LAS FUNCIONES ORALES.

ENTRE LAS CONSECUENCIAS RELACIONADAS CON LA PÃ‰RDIDA DENTAL SE ENCUENTRAN RESTRICCIONES DIETÃ‰TICAS, DIFICULTADES EN EL HABLA, PÃ‰RDIDA DE SOPORTE PARA LA MUSCULATURA FACIAL Y UNA REDUCCIÃ“N EN LA ALTURA FACIAL VERTICAL, LO QUE REPRESENTA CONDICIONES QUE COMPROMETEN LA FISIOLOGÃ□A ORAL NORMAL.

EL EDENTULISMO, YA SEA PARCIAL O TOTAL, PARECE ESTAR ASOCIADO CON RESULTADOS ESTÃ‰TICOS Y PSICOLÃ“GICOS DESFAVORABLES EN LOS PACIENTES, EL IMPACTO DE TODA REHABILITACIÃ“N TAMBIÃ‰N DEBE CONSIDERARSE EN EL CONTEXTO DE SU EFECTO EN LA VIDA DEL PACIENTE, LA REHABILITACIÃ“N ORAL ESTÃ□ ASOCIADA CON UNA MEJORA SIGNIFICATIVA EN LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD ORAL.

OBJETIVO: PRESENTAR EL ABORDAJE INTEGRAL EN UN PACIENTE CON PERIODONTITIS ESTADIO IV GENERALIZADA GRABO B RECUPERANDO LA FUNCIÃ“N, ESTÃ‰TICA Y MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA.

Descripción del Caso *

PACIENTE MASCULINO DE 59 AÃ‘OS, ASA I, A LA INSPECCIÃ“N CLÃ□NICA SE OBSERVÃ“ UN FENOTIPO GINGIVAL GRUESO, EDENTULISMO PARCIAL, REBORDES ATRÃ“FICOS, DEPÃ“SITOS PESADOS DE CÃ□LCULO, MOVILIDAD DENTAL, FRAGMENTOS RADICULARES, DISFUNCIÃ“N MASTICATORIA, DIENTES CON PRONÃ“STICO SIN ESPERANZA, A CAUSA DE LO CUAL SE DIAGNOSTICÃ“ ENFERMEDAD PERIODONTAL ESTADIO IV GENERALIZADA GRADO B.

SE REALIZÃ“ ANAMNESIS, EXPLORACIÃ“N CLÃ□NICA Y RADIOGRÃ□FICA, A SU VEZ SE SOLICITARON ESTUDIOS DE LABORATORIO INCLUYENDO BIOMETRÃ□A HEMÃ□TICA, QUÃ□MICA SANGUÃ□NEA, TIEMPOS DE COAGULACIÃ“N Y HEMOGLOBINA GLUCOSILADA; SE SOLICITÃ“ INTERCONSULTA CON EL POSGRADO DE REHABILITACIÃ“N ORAL E IMPLANTOLOGÃ□A DE LA ENES UNAM, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LAS CONDICIONES PREQUIRÃšRGICAS DE LA CAVIDAD ORAL, SE LLEVÃ“ ACABO LA ELIMINACIÃ“N DE CÃ□LCULO SUPRAGINGIVAL, ORIENTACIÃ“N MOTIVACIONAL AL PACIENTE, DURANTE ESTE PROCEDIMIENTO TAMBIÃ‰N SE EXTRAJERON LAS PIEZAS CON MOVILIDAD SEVERA, EN UNA SEGUNDA CITA SE LLEVÃ“ A CABO LAS EXTRACCIONES MÃšLTIPLES SIMULTÃ□NEO A REGULARIZACIÃ“N DE REBORDE SUPERIOR E INFERIOR, POSTERIORMENTE EL POSGRADO DE REHABILITACIÃ“N ORAL REALIZÃ“ LA COLOCACIÃ“N INMEDIATA DE PRÃ“TESIS BIMAXILAR.

Resultados y Conclusiones *

SE CONSIGUIÃ“ CONFORMAR UN REBORDE ALVEOLAR UNIFORME, MÃ RGENES Ã NTEGROS, SE CREÃ“ UNA NUEVA DIMENSIÃ“N VERTICAL, MEJORANDO EL SOPORTE FACIAL Y A SU VEZ LA ESTÃ‰TICA FACIAL DEL PACIENTE.

A SU VEZ, SE OBTUVO LA RECUPERACIÃ“N DE LA FUNCIÃ“N MASTICATORIA DE MANERA PROGRESIVA, MEJORAR LA FONACIÃ“N ASÃ COMO LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE.

CONCLUSIÃ“N: EL MANEJO INTEGRAL DE LOS PACIENTES PARCIALMENTE DESDENTADOS QUE NECESITAN SER RESTAURADOS MEDIANTE REHABILITACIONES DE ARCADA COMPLETA REQUIERE UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO, ESTE TIPO DE TRATAMIENTOS OFRECE RESULTADOS CLÃNICOS, FUNCIONALES Y ESTÃ‰TICOS FAVORABLES PARA LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD PERIODONTAL SEVERA Y EDENTULISMO INMINENTE MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA.

Bibliografía *

PAPAPANOU PN, SANZ M, BUDUNELI N, DIETRICH T, FERES M, FINE DH, FLEMMIG TF, GARCIA R, GIANNOBILE WV, GRAZIANI F, GREENWELL H, HERRERA D, KAO RT, KEBSCHULL M, KINANE DF, KIRKWOOD KL, KOCHER T, KORNMAN KS, KUMAR PS, TONETTI MS. PERIODONTITIS: CONSENSUS REPORT OF WORKGROUP 2 OF THE 2017 WORLD WORKSHOP ON THE CLASSIFICATION OF PERIODONTAL AND PERI-IMPLANT DISEASES AND CONDITIONS: CLASSIFICATION AND CASE DEFINITIONS FOR PERIODONTITIS. J CLIN PERIODONTOL. 2018;45(SUPPL 20):S162â€“S170. HTTPS://DOI.ORG/10.1111/JCPE.12946

ARAÃšJO MG, SILVA CO, MISAWA M, SUKEKAVA F. ALVEOLAR SOCKET HEALING: WHAT CAN WE LEARN? PERIODONTOL 2000. 2015;68(1):122â€“134. HTTPS://DOI.ORG/10.1111/PRD.12082

CRADDOCK HL. CONSEQUENCES OF TOOTH LOSS: 1. THE PATIENT PERSPECTIVE â€“ AESTHETIC AND FUNCTIONAL IMPLICATIONS. DENT UPDATE. 2009;36(10):616â€“619. HTTPS://DOI.ORG/10.12968/DENU.2009.36.10.616

JOHN MT, HUJOEL P, MIGLIORETTI DL, LERESCHE L, KOEPSELL TD, MICHEELIS W. DIMENSIONS OF ORAL-HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE. J DENT RES. 2004;83(12):956â€“960. HTTPS://DOI.ORG/10.1177/154405910408301213

ALI Z. BAKER SR. SHAHRBAF S. MARTIN N. VETTORE MV. ORAL HEALTH-RELATED OUALITY OF LIFE AFTER

Título del trabajo *

TÃ‰CNICA DE COLGAJO DE REPOSICIONADO APICAL

Nombre del Autor (a/es)*

Daniela Santana GonzÃ¡lez

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Sara Edith Medina Palacios, , Juan Antonio Cepeda Bravo, , , , , , .

Correo Electrónico *

dasntgl@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD AUTÃ“NOMA DE SAN LUIS POTOSÃ

Introducción y Objetivos *

LA TÃ‰CNICA DEL COLGAJO DE REPOSICIONADO APICAL MODIFICADO (CRAM) ES UN PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO DISEÃ‘ADO PARA AUMENTAR LA DIMENSIÃ“N ÃPICO-CORONAL DE LA ENCÃA ADHERIDA CON UN TRAUMA MÃNIMO. AUNQUE PREVIAMENTE SE HABÃA UTILIZADO EN ÃREAS CON AL MENOS 0.5 MM DE ENCÃA ADHERIDA PREEXISTENTE, ESTUDIOS RECIENTES DEMUESTRAN SU EFICACIA PARA GENERAR TEJIDO QUERATINIZADO Y ENCÃA ADHERIDA EN SITIOS DONDE NO EXISTÃA PRE-QUIRÃšRGICAMENTE. ESTA TÃ‰CNICA FUE INTRODUCIDA EN LA LITERATURA POR CARNIO Y MILLER EN 1999, Y POSTERIORMENTE CARNIO Y CAMARGO TAMBIÃ‰N PUBLICARON SOBRE ELLA EN 2006. EN 2015, EL TALLER DE REGENERACIÃ“N ORGANIZADO POR LA ACADEMIA AMERICANA DE PERIODONCIA RECONOCIÃ“ AL CRAM COMO UN PROCEDIMIENTO PROMETEDOR.

LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE ESTA TÃ‰CNICA SON:

â€¢ INCREMENTAR LA ZONA DE ENCÃA ADHERIDA Y EL TEJIDO QUERATINIZADO.

â€¢ CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DE UNA ADECUADA SALUD GINGIVAL, YA QUE LA ENCÃA ADHERIDA MEJORA LA RESISTENCIA A LAS LESIONES EXTERNAS, ESTABILIZA LA ENCÃA MARGINAL Y PROTEGE LOS DIENTES DE FUERZAS FISIOLÃ“GICAS Y FRICCIONALES.

â€¢ TRANSFORMAR LA MUCOSA MARGINAL EN TEJIDO QUERATINIZADO NORMAL CON ESTABILIDAD A LARGO PLAZO.

COMO UNA VENTAJA SIGNIFICATIVA DEL CRAM, EN COMPARACIÃ“N CON TÃ‰CNICAS TRADICIONALES COMO EL INJERTO GINGIVAL LIBRE (IGL), ES QUE NO REQUIERE UN SITIO DONANTE PALATINO, LO QUE SE TRADUCE EN MENOR MORBILIDAD POSTOPERATORIO, MENOR POSIBILIDAD DE SANGRADO Y UNA MEJOR COINCIDENCIA DE COLOR CON LOS TEJIDOS ADYACENTES.

Descripción del Caso *

PACIENTE MASCULINO DE 25 AÃ‘OS DE EDAD, QUIEN ACUDIÃ“ AL POSGRADO DE PERIODONCIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÃ“NOMA DE SAN LUIS POTOSÃ, AL REALIZAR SU HISTORIA CLÃNICA NO MANIFESTÃ“ CONTAR CON ALGUNA ENFERMEDAD SISTÃ‰MICA Y REFIRIÃ“ ASISTIR POR INTERCONSULTA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ORTODONCIA DEBIDO A PRESENTAR â€œEXCESO DE ENCÃA EN OD. #22 E IMPEDIR LA COLOCACIÃ“N DE BRACKET EN ESA ZONAâ€. DURANTE LA REVISIÃ“N PERIODONTAL SE OBSERVÃ“ HIPERPLASIA GINGIVAL POR MALPOSICIÃ“N EN OD. #22 CUBRIENDO 2/3 PARTES DE LA CORONA CLÃNICA, ADEMÃS DE INSUFICIENTE TEJIDO QUERATINIZADO. AL NO PRESENTAR ENFERMEDAD PERIODONTAL, LA PRIMERA CITA CONSISTIÃ“ EN REFORZAR HÃBITOS DE HIGIENE ORAL Y REMOCIÃ“N DE BIOFILM SUPRAGINGIVAL. EN LA SEGUNDA CITA ANTES DE INICIAR CON EL PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO, SE DESINFECTÃ“ EL ÃREA INTRABUCAL MEDIANTE COLUTORIOS CON CLORHEXIDINA AL 0.12% DURANTE 1 MINUTO. SE ANESTESIÃ“ CON TÃ‰CNICA LOCAL INFILTRATIVA, (MEPIVACAÃNA AL 3% CON EPINEFRINA 1:100,000), SE EFECTUÃ“ UNA INCISIÃ“N INTRASULCULAR Y EN CADA UNO DE LOS EXTREMOS DE LA INCISIÃ“N SE REALIZARON LIBERATRICES VERTICALES, QUE SE EXTENDIERON HASTA LA MUCOSA ALVEOLAR (SOBREPASANDO LA UNIÃ“N MUCOGINGIVAL). POR MEDIO DE UN PERIOSTOTOMO SE LEVANTÃ“ UN COLGAJO DE ESPESOR TOTAL QUE INCLUYÃ“ ENCÃA VESTIBULAR Y MUCOSA ALVEOLAR; EL COLGAJO SE LLEVÃ“ MÃS ALLÃ DE LA LÃNEA MUCOGINGIVAL. FINALMENTE, EL COLGAJO, POSICIONADO EN â€œACORDEÃ“Nâ€ EN SU PORCIÃ“N APICAL FUE SUTURADO AL CUELLO DEL Ã“RGANO DENTARIO FENESTRADO DEJANDO 2/3 DE CORONA EXPUESTA Y SOBREPASANDO APROXIMADAMENTE 2-3 MM DE LA UNIÃ“N AMELOCEMENTARIA. SE COLOCARON SUTURAS CON PUNTOS SIMPLES PARA LAS LIBERALICES RESPETANDO EL REPOSICIONAMIENTO Y EN LAS PAPILAS CON NYLON 5-0. SE DIERON INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS Y FARMACOTERAPIA.

Resultados y Conclusiones *

COMO RESULTADOS SE DIO CITA DE POSTOPERATORIO A LAS 2 SEMANAS DEL PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO, OBSERVANDO UNA BUENA CICATRIZACIÃ“N E HIGIENE DE LA HERIDA PERMITIENDO EL RETIRO DE LAS SUTURAS. SE LE DIERON AL PACIENTE NUEVAS INSTRUCCIONES DE HIGIENE EN LA ZONA Y SE LE DIO SEGUIMIENTO DE 1, 3 Y 6 MESES DESPUÃ‰S.

SE PUEDE CONCLUIR QUE ESTÃ TÃ‰CNICA TRANSFORMA LA MUCOSA MARGINAL EN TEJIDO QUERATINIZADO NORMAL CON ESTABILIDAD A LARGO PLAZO, INCLUSO EN ÃREAS SIN TEJIDO QUERATINIZADO BASAL, PROPORCIONA BUENA ESTABILIDAD CLÃNICA DE LOS MÃRGENES TISULARES Y LAS PROFUNDIDADES DE SONDAJE, SIN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA RECESIÃ“N GINGIVAL O LA PROFUNDIDAD DE LA BOLSA, OFRECE UNA MEJOR HOMOGENEIDAD CROMÃTICA CON LOS TEJIDOS ADYACENTES, ADEMÃS DE SER UN PROCEDIMIENTO CON MÃNIMO TRAUMA, SIMPLE Y CON ALTA PREDICTIBILIDAD.

EL CRAM REPRESENTA UNA OPCIÃ“N DE TRATAMIENTO VALIOSA PARA EL AUMENTO GINGIVAL, ESPECIALMENTE EN ESCENARIOS CON AUSENCIA TOTAL DE TEJIDO QUERATINIZADO Y ENCÃA ADHERIDA EN EL ÃREA MARGINAL.

Bibliografía *

â€¢ CARNIO J, CAMARGO PM, PIRIH PQ. SURGICAL TECHNIQUES TO INCREASE THE APICOCORONAL DIMENSION OF THE ATTACHED GINGIVA: A 1-YEAR COMPARISON BETWEEN THE FREE GINGIVAL GRAFT AND THE MODIFIED APICALLY REPOSITIONED FLAP. INT J PERIODONTICS RESTORATIVE DENT. 2015 JUL-AUG;35(4):571-8. DOI: 10.11607/PRD.2386. PMID: 26133147.

â€¢ PÃ‰REZ-SALCEDO, L., & BASCONES MARTÃNEZ, A.. (2011). COLGAJO DE REPOSICIÃ“N APICAL. AVANCES EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÃA ORAL, 23(2), 91-96.

â€¢ TORKZABAN P, RABIENEJAD N, CHERAGHI Z, LAHOORPOOR K. EFFECTIVENESS OF USING PLATELET-RICH FIBRIN TO INCREASE KERATINIZED TISSUE AROUND THE TOOTH IN THE MODIFIED APICAL REPOSITION FLAP METHOD: A SPLIT-MOUTH, RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. CLIN EXP DENT RES. 2023 FEB;9(1):36-44. DOI: 10.1002/CRE2.693. EPUB 2022 NOV 24. PMID: 36424485; PMCID: PMC9932240.

â€¢ CARNIO J, CAMARGO PM, PASSANEZI E. INCREASING THE APICO-CORONAL DIMENSION OF ATTACHED GINGIVA USING THE MODIFIED APICALLY REPOSITIONED FLAP TECHNIQUE: A CASE SERIES WITH A 6-MONTH FOLLOW-UP. J PERIODONTOL. 2007 SEP;78(9):1825-30. DOI: 10.1902/JOP.2007.060414. PMID: 17760555.

Título del trabajo *

COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES POST - EXTRACCIÃ“N TÃ‰CNICA ALL - ON - 4 MODIFICADA

Nombre del Autor (a/es)*

C. D. Edgar IvÃ¡n LÃ³pez RamÃ-rez

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

C. D. E. P. e. I. Abel EscÃ¡rcega Ochoa, , , , , , , , .

Correo Electrónico *

edgar.lopez@cermo.edu.mx

Institución *

CENTRO EDUCATIVO MULTIDISCIPLINARIO EN REHABILITAC

Introducción y Objetivos *

LA IMPLANTOLOGIA CUENTA CON BASES CIENTÃFICAS QUE ACTUALMENTE BRINDAN MÃšLTIPLES POSIBILIDADES DE TRATAMIENTO CON ELEVADA PREDICTIBILIDAD EN LOS RESULTADOS. LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÃšRGICOS Y PROTÃ‰SICOS NECESARIOS A TAL FIN, HAN IDO EVOLUCIONANDO EN LA CONSTANTE NECESIDAD DE LOGRAR REHABILITACIONES MÃS EFICACES Y SATISFACTORIAS(1). LA ESTABILIDAD PRIMARIA DEL IMPLANTE ES UN REQUISITO FUNDAMENTAL, SE HAN SUGERIDO VARIOS MÃ‰TODOS PARA MEDIRLA POR TORQUE O ISQ (COEFICIENTE DE ESTABILIDAD DEL IMPLANTE) COMO REQUISITO DE CARGA INMEDIATA, UN TORQUE DE INSERCIÃ“N MÃNIMO DE 32 N/CM PARA RESTAURACIONES DE ARCADAS COMPLETAS SE DEBE CUMPLIR(2). LA TE?CNICA ALL-ON-FOUR DESARROLLADA POR PAOLO MALO? PERMITE REHABILITACION TOTAL DE FORMA FIJA SOBRE IMPLANTES EN MAXILAR Y/O MANDÃBULA, CONSIDERANDO UNA TASA DE SUPERVIVENCIA DE 96,7 % A 98,2%, SU DESVENTAJA REQUIERE ALTA INTERCONEXIÃ“N CON LABORATORIO DENTAL PARA QUE MÃXIMO EN 48 HRS. SE TENGA LA REHABILITACIÃ“N, LO QUE MUCHAS VECES NO RESULTA POSIBLE EN LA PRÃCTICA CLÃNICA DIARIA (3). LA MODIFICACIÃ“N A LA TÃ‰CNICA ALL-ON-FOUR ES PRESCINDIR DEL LABORATORIO DENTAL A FIN DE QUE EL TRATAMIENTO COMPLETO DEPENDA ÃšNICAMENTE DEL CIRUJANO/RESTAURADOR CON COLOCACIÃ“N INMEDIATA DE REHABILITACIÃ“N FIJA DE RESINA ACRÃLICA SIN ARMAZÃ“N METÃLICO; UNO DE LOS PUNTOS MA?S ATRACTIVOS DE ESTA TE?CNICA ES LA APLICACIÃ“N DE IMPLANTES INFERIORES INTERFORAMINALES POR LO QUÃ‰ ES PREDECIBLE SU INSERCIO?N EN SITUACIONES DE REABSORCIO?N EXTREMA, INTERVENCIO?N SENCILLA EN LA QUE SE COLOCAN UN MENOR NU?MERO DE IMPLANTES DE LO HABITUAL, CON LO QUE SE FACILITA LA HIGIENE ORAL Y SE ABARATAN LOS COSTES(4). LA ANGULACIO?N DE LOS IMPLANTES POSTERIORES CON LOS A?PICES DE LOS MISMOS HACIA MESIAL PUEDE SER HASTA DE 30Âº, DE MANERA QUE EL PUNTO DE INSERCIO?N PUEDA SITUARSE EN LA VERTICAL DE LOS MENTONIANOS, O INCLUSO, UN POCO DISTAL A ELLOS, A FIN DE DISMINUIR EL CANTILEVER DISTAL DE LA FUTURA PRO?TESIS (5).

OBJETIVO: DESCRIBIR MEDIANTE UN CASO CLÃNICO LA TÃ‰CNICA ALL-ON-FOUR MODIFICADA EN UN REBORDE MANDIBULAR ATRÃ“FICO, COMO ALTERNATIVA DE REHABILITACIÃ“N COMPLETA.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINO 59 AÃ‘OS, AHF: PADRES Y ABUELOS DIABÃ‰TICOS, PADRE HIPERTENSO, SIN APP, ASA I. MOTIVO DE LA CONSULTA "QUIERO MIS DIENTES FIJOS". EXAMEN PERIODONTAL: BPS HASTA 8 MM, UCE INCLUSIVE 5 MM, NIS 3-4 MM 48%, >5 MM 40%, SAS 18%, CÃ□LCULO DENTARIO 35%, Ã□NDICE DE BIOFILM BACTERIANO (IBB) 100%. LA T. A. C. MOSTRÃ“ ZONA 34 ANCHO 4.52 MM X LONGITUD 7.12 MM AL CANAL DENTARIO, ZONA 44 6.5 MM X 8.78 MM RESPECTIVAMANTE. SE DIAGNOSTICÃ“ PERIODONTITIS ESTADIO IV GENERALIZADA GRADO C. PRONÃ“STICO CUESTIONABLE. SE ELABORÃ“ PLAN DE TRATAMIENTO: FASE I HIGIÃ‰NICA. FASE II QUIRÃšRGICA: EXODONCIA DIENTES ANTERO-INFERIORES, COLOCACIÃ“N INMEDIATA IMPLANTES DENTALES MARCA DIOÂ® UFII 3.5 X 11.5 MM ZONA MEDIA, 3.8 X 10 MM ZONA PREMOLARES. FASE II PROTÃ‰SICA. INSTALACIÃ“N PROTESIS IMPLANTOSOPORTADA INMEDIATA. FASE III TERAPIA IMPLANTAR DE SOPORTE: REVALORACIÃ“N A 6 Y 12 MESES. OBTENIDO CONSENTIMIENTO INFORMADO, SE COMENZÃ“ TRATAMIENTO, INICIANDO ASEPSIA Y ANTISEPSIA EXTRAORAL E INTRAORAL; APLICACIÃ“N ANESTÃ‰SICO AL 2% CON EPINEFRINA-LIDOCAÃ□NA 1:800.000 INFILTRACIÃ“N A INCISIVOS INFERIORES. UNA INCISIÃ“N SOBRE REBORDE ALVEOLAR FUE HECHA, ELEVACIÃ“N DE COLGAJO MUCOPERIOSTICO, SE REALIZARON EXTRACCIONES DENTARIAS, SEGUIDO DE OSTEOTOMÃ□A EN FORMA DE MESETA. COLOCACIÃ“N GUÃ□A QUIRÃšRGICA PARA PROTOCOLO ALL-ON-FOUR, FRESADO Ã“SEO CON PUNTA LANZA DE 2 MM A 1100 RPM, CONTINUANDO MISMAS REVOLUCIONES CON FRESA 2.0 MM, TOMA DE RADIOGRAFÃ□A CON PIN DE PARALELISMO, SE SIGUIÃ“ FRESANDO 2.2 MM, 3.0 MM Y 3.3 MM A 11.5 MM ANTERIORES, 10 MM POSTERIORES; INSERCIÃ“N DE IMPLANTE CON MOTOR A 40 NW Y 35 DE TORQUE, EN ZONA 34 Y 44 LOS IMPLANTES QUEDARON CON INCLINACIÃ“N DE 33Âº, TERMINANDO DE BAJAR CON MATRACA. SE COLOCARON MULTI-UNIT CON LLAVE, POSTERIORES ANGULADOS, ANTERIORES RECTOS Y TAPAS RESPECTIVAS. EL COLGAJO SE SUTURÃ“ CON NYLON 5-0 MEDIANTE PUNTO COLCHONERO CONTÃ□NUO Y PUNTOS SIMPLES; LA PRÃ“TESIS INMEDIATA CON REBASE EN LOS ADITAMENTOS FUE LLEVADA A CABO.

Resultados y Conclusiones *

CLÃ□NICAMENTE SE OBSERVÃ“ BUENA CICATRIZACIÃ“N DE LOS TEJIDOS A LOS 15 DÃ□AS POSTERIORES, NO SE REFIRIÃ“ DOLOR POSTOPERATORIO, NI SIGNOS DE INFLAMACIÃ“N. SE DESCRIBIÃ“ PASO A PASO LA TÃ‰CNICA ALL-ON - 4 MODIFICADA COMPROBANDO UNA ESTABILIDAD PRIMARIA MEDIANTE EL TORQUE, SIENDO PARA ESTE CASO DE 30 NW. PROTÃ‰SICAMENE SE COMPROBÃ“ QUE LA COLOCACIÃ“N DE UNA PRÃ“TESIS CON CARGA INMEDIATA ELIMINA TIEMPO DE ESPERA PARA CON EL LABORATORIO DENTAL, PERMITE COMPROBAR SU FUNCIONAMIENTO, NO MOVILIDAD, NO DOLOR EN EL MISMO DÃ□A DE LA CIRUGÃ□A. RADIOGRÃ□FICAMENTE ARROJÃ“ AUSENCIA DE IMÃ□GENES RADIOLÃšCIDAS PERIIMPLANTARIAS.

LA TÃ‰CNICA ALL-ON-FOUR, DA COMO VENTAJA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA AL PACIENTE AL SER PORTADOR DE UNA PRÃ“TESIS COMPLETA TOTALMENTE FIJA AL MOMENTO DE REALIZAR ALL-ON-FOUR MODIFICADA, ADQUIERIENDO FUNCIÃ“N Y ESTÃ‰TICA AL TÃ‰RMINO DE LA CIRUGÃ□A. LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES DE FORMA INMEDIATA TRAS LA EXTRACCIÃ“N, PUEDE PREVENIR LA PÃ‰RDIDA Ã“SEA, LO QUE CONSTITUYE UNO DE LOS OBJETIVOS ACTUALES. SIN EMBARGO, AL TRATARSE DE UN PROCEDIMIENTO COMBINADO QUIRÃšRGICO-PROTÃ‰SICO EN ESTE PROTOCOLO MODIFICADO LA SESIÃ“N EN SILLÃ“N ES MÃ□S LARGA. HOY EN DÃ□A CON LOS ESCÃ□NERES DENTALES, NO SE DUDA QUE AUMENTARÃ□ LA PREDICTIBILIDAD DE LA TÃ‰CNICA, LA VELOCIDAD DEL FLUJO DE TRABAJO SERÃ□ MÃ□S EXPEDITA, Y QUIZÃ□S LA SESIÃ“N PARA ESTE PROTOCOLO MODIFICADO SEA MENOS LARGA. ESTE CASO DEMOSTRÃ“ QUE LA TÃ‰CNICA DESCRITA ES EFICAZ EN REBORDES ATRÃ“FICOS DE LA MANDÃ□BULA.

Bibliografía *

1.LEMUS CRUZ LETICIA MARÃ□A, ALMAGRO URRUTIA ZORAYA, CLAUDIA LEÃ“N CASTELL ALUMNA. ORIGEN Y EVOLUCION DE LOS IMPLANTES DENTALES. REV HABAN CIENC MÃ‰D [INTERNET]. 2009 NOV [CITADO 2025 AGO 14] ; 8(4): . DISPONIBLE EN: HTTP://SCIELO.SLD.CU/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S1729-519X2009000400030&LNG=ES.

2.MONJE GIL F., MORENO GARCÃ□A C., SERRANO GIL H., MAESTRE O., MORILLO SÃ□NCHEZ A.J., MATEO ARIAS J. ET AL . IMMEDIATE LOADING OF IMPLANTS IN THE MAXILLA. REV ESP CIRUG ORAL Y MAXILOFAC [INTERNET]. 2007 AGO [CITADO 2025 AGO 14] ; 29(4): 215-227. DISPONIBLE EN: HTTP://SCIELO.ISCIII.ES/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S1130-05582007000400001&LNG=ES.

3.MALÃ“ P, RANGERT B, NOBRE M. "ALL-ON-FOUR" IMMEDIATE-FUNCTION CONCEPT WITH BRÃ...NEMARK SYSTEM IMPLANTS FOR COMPLETELY EDENTULOUS MANDIBLES: A RETROSPECTIVE CLINICAL STUDY. CLIN IMPLANT DENT RELAT RES. 2003;5 SUPPL 1:2-9. DOI: 10.1111/J.1708-8208.2003.TB00010.X. PMID: 12691645.

4.DRAGO C. FRECUENCIA Y TIPO DE COMPLICACIONES PROTÃ‰SICAS ASOCIADAS CON PRÃ“TESIS DE ARCO COMPLETO PROVISIONALES E INMEDIATAMENTE CARGADAS: UNA REVISIÃ“N RETROSPECTIVA DE GRÃ□FICOS DE 2

Título del trabajo *

â€œÂ¿SALVAR O EXPLANTAR? MANEJO CLÃ□NICO DE UN IMPLANTE MAL POSICIONADO EN Ã□REA ESTÃ‰TICA: REPORTE DE CASOâ€□

Nombre del Autor (a/es)*

Karen Estefania Arriaga Andrade

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Mariana Guerrero ObregÃ³n, Juan Antonio Cepeda Bravo, , , , , , , .

Correo Electrónico *

estefaniaarrand@hotmail.com

Institución *

ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA, UNIVERSIDAD AUTÃ“NOMA

Introducción y Objetivos *

INTRODUCCIÃ“N: LA DECISIÃ“N DE TRATAMIENTO DE IMPLANTES COLOCADOS EN MALA POSICIÃ“N DEBE BASARSE EN LAS CONDICIONES INDIVIDUALES QUE PRESENTEN, TENIENDO UN ABANICO DE POSIBILIDADES QUE INCLUYEN DESDE PROCEDIMIENTOS DE REGENERACIÃ“N Ã“SEA Y CIRUGÃ A MUCOGINGIVAL, COMO OPCIONES PARA CORREGIR PROBLEMAS ASOCIADOS A LOS TEJIDOS PERIIMPLANTARIOS HASTA LA EXPLANTACIÃ“N EN CASOS MÃ S SEVEROS.

OBJETIVO: MOSTRAR UN CASO EN DONDE FUE POSIBLE CONSERVAR UN IMPLANTE DENTAL COLOCADO EN UNA POSICIÃ“N NO FAVORABLE, UTILIZANDO UN ENFOQUE QUIRÃšRGICO QUE PERMITIÃ“ PRESERVAR LA SALUD DE LOS TEJIDOS PERIIMPLANTARIOS.

Descripción del Caso *

PRESENTACIÃ“N DEL CASO: PACIENTE FEMENINA DE 22 AÃ‘OS, CON ANTECEDENTE DE ENFERMEDAD INDIFERENCIADA DE TEJIDO CONECTIVO ACUDE VALORACIÃ“N A LA CLÃ NICA DE LA ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA, EN MARZO 2025, CON MOTIVO DE CONSULTA â€œMOLESTIA AL TOCAR EN LA ZONA QUE COLOCARON UN IMPLANTE HACE 2 AÃ‘OSâ€ . LA PACIENTE MENCIONA HABER PERDIDO EL Ã“RGANO DENTARIO POR TRAUMA A MUY TEMPRANA EDAD. SE REALIZÃ“ VALORACIÃ“N CLÃ NICA, SE OBSERVA INFLAMACIÃ“N GENERALIZADA EN ENCÃ A DE TODOS LOS Ã“RGANOS DENTARIOS Y EN MUCOSA PERIIMPLANTAR A NIVEL O.D.11. SE REALIZÃ“ PERIODONTOGRAMA Y SE TOMÃ“ RADIOGRAFÃ A DE LA ZONA O.D. 11; SE OBSERVA IMPLANTE DENTAL MAL POSICIONADO, POR LO QUE SE LE SOLICITAN LOS EXÃ MENES COMPLEMENTARIOS PERTINENTES.

DIAGNÃ“STICO: SE DIAGNOSTICA COMO ENFERMEDAD PERIODONTAL ESTADIO II GRADO A LOCALIZADA Y EN LA TOMOGRAFÃ A SE OBSERVA UN IMPLANTE CON SUFICIENTE ESPACIO PROXIMAL A DIENTES ADYACENTES.

PROCEDIMIENTOS: SE DECIDE REALIZAR PROCEDIMIENTO DE AUMENTO DE TEJIDO BLANDO EN ZONA VESTIBULAR AL IMPLANTE, SE LLEVA A CABO EN JUNIO 2025.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS: SE OBTIENEN RESULTADOS FAVORABLES, ELIMINANDO LA SINTOMATOLOGÃ A DE LA PACIENTE Y CONTRIBUYENDO A UNA MEJORA EN LA ZONA ESTÃ‰TICA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PLANEACIÃ“N DE REHABILITACIÃ“N DE DICHO IMPLANTE; SE MANTIENE EN CONTROL CLÃ NICO Y RADIOGRÃ FICO EN DONDE SE OBSERVAN TEJIDOS SANOS Y SIN EVIDENCIA DE DATOS PATOLÃ“GICOS.

CONCLUSIÃ“N: LA CONSERVACIÃ“N DE IMPLANTES DENTALES MAL POSICIONADOS ES POSIBLE SIEMPRE Y CUANDO NO ESTÃ‰ COMPROMETIDA LA SALUD DE LOS TEJIDOS PERIIMPLANTARIOS O SE PUEDAN REALIZAR TRATAMIENTOS, INCLUYENDO LOS DE ENFOQUE QUIRÃšRGICO, QUE PERMITAN LA CORRECCIÃ“N Y PRESERVACIÃ“N DE ESTOS.

Bibliografía *

1. ALRMALI A, STUHR S, SALEH MHA, ET AL. UN Ã RBOL DE TOMA DE DECISIONES PARA EVALUAR UN IMPLANTE DENTAL ÃšNICO ESTÃ‰TICAMENTE COMPROMETIDO. J ESTHET RESTOR DENT. 2023; 35(8):1239-1248.

2. JENSEN SS, AGHALOO T, JUNG RE, ET AL. GROUP 1 ITI CONSENSUS REPORT: THE ROLE OF BONE DIMENSIONS AND SOFT TISSUE AUGMENTATION PROCEDURES ON THE STABILITY OF CLINICAL, RADIOGRAPHIC, AND PATIENT-REPORTED OUTCOMES OF IMPLANT TREATMENT. CLIN ORAL IMPLANTS RES. 2023;34 SUPPL 26:43-49.

3. ZUCCHELLI G, MAZZOTTI C, MOUNSSIF I, MELE M, STEFANINI M, MONTEBUGNOLI L. A NOVEL SURGICAL-PROSTHETIC APPROACH FOR SOFT TISSUE DEHISCENCE COVERAGE AROUND SINGLE IMPLANT. CLIN ORAL IMPLANTS RES. 2013;24(9):957-962.

4. ZUCCHELLI G, MAZZOTTI C, MOUNSSIF I, MARZADORI M, STEFANINI M. ESTHETIC TREATMENT OF PERI-IMPLANT SOFT TISSUE DEFECTS: A CASE REPORT OF A MODIFIED SURGICAL-PROSTHETIC APPROACH. INT J PERIODONTICS RESTORATIVE DENT. 2013;33(3):327-335.

5. GIANNOBILE WV, JUNG RE, SCHWARZ F; GROUPS OF THE 2ND OSTEOLOGY FOUNDATION CONSENSUS MEETING. EVIDENCE-BASED KNOWLEDGE ON THE AESTHETICS AND MAINTENANCE OF PERI-IMPLANT SOFT

Título del trabajo *

TERAPIA IMPLANTOLÃ“GICA EN UN REBORDE CON DEFICIENCIA HORIZONTAL Y MANEJO DEL CONTORNO DE LA RESTAURACIÃ“N PARA OBTENER PERFILES DE EMERGENCIA Ã“PTIMOS. REPORTE DE CASO CLÃ NICO.

Nombre del Autor (a/es)*

Rivera Paniagua Diana

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

GarcÃ-a Amador Braulio AndrÃ©s, De Ã vila Cruz Jacob, Duarte Veloz Ismael, , , , , , .

Correo Electrónico *

diaanariveera@outlook.com

Institución *

FUNIVERSIDAD JUÃREZ DEL ESTADO DE DURANGO, ESPECIA

Introducción y Objetivos *

LA CORRECCIÃ“N DE LA APARIENCIA DE UN PROCESO ALVEOLAR REABSORBIDO REQUIERE UNA PREPARACIÃ“N ADECUADA DEL SITIO MEDIANTE UN AUMENTO DE LA CRESTA. ESTE AUMENTO PUEDE COMPRENDER TEJIDO DURO, TEJIDO BLANDO O UNA COMBINACIÃ“N DE AMBOS. SIN EMBARGO, LOS DEFECTOS MENORES PUEDEN ABORDARSE SOBRECONTORNEANDO EL CONTORNO SUBCRÃ⍰TICO FACIAL DENTRO DE UN RANGO FISIOLÃ“GICAMENTE ACEPTABLE, BRINDANDO SOPORTE PARA EL TEJIDO BLANDO SIN ALTERAR LA POSICIÃ“N DEL MARGEN GINGIVAL. SE PUEDEN UTILIZAR MODIFICACIONES DEL CONTORNO CRÃ⍰TICO Y SUBCRÃ⍰TICO PARA MEJORAR LA ESTÃ‰TICA DEL TEJIDO BLANDO PERIIMPLANTARIO.1

EL CONCEPTO DE CONTORNOS CRÃ⍰TICOS Y SUBCRÃ⍰TICOS DEL PERFIL DE EMERGENCIA DEL IMPLANTE FUE DESCRITO POR SU H. Y COLS. QUIENES RECONOCEN LA IMPORTANCIA DE DOS Ã⍰REAS DIFERENTES DEL PERFIL DE EMERGENCIA PARA LOGRAR EL RESULTADO DESEADO EN LOS TEJIDOS PERIIMPLANTARIOS. EL DESARROLLO DE UN PERFIL DE EMERGENCIA ADECUADO MEDIANTE LA MANIPULACIÃ“N DE LOS TEJIDOS PERIIMPLANTARIOS DEBE REALIZARSE DURANTE LA ETAPA DE PROVISIONALIZACION.3

UN PILAR DE CICATRIZACIÃ“N PERSONALIZADO SE DISEÃ‘A MODIFICANDO EL TAMAÃ‘O Y LA FORMA TRANSMUCOSA DEL PILAR DE CICATRIZACIÃ“N PARA IMITAR EL PERFIL NATURAL DE UN DIENTE EMERGENTE. LUEGO, SE CONECTA AL IMPLANTE EL DÃ⍰A DE LA CIRUGÃ⍰A Y SE DEJA INTACTO HASTA QUE SE LOGRA LA OSTEOINTEGRACIÃ“N Y LA MADURACIÃ“N DEL TEJIDO. LOS PILARES DE CICATRIZACIÃ“N PERSONALIZADOS SE PUEDEN FABRICAR CON DIFERENTES MATERIALES Y TÃ‰CNICAS, SEGÃšN SUS APLICACIONES CLÃ⍰NICAS. SIN EMBARGO, LA PROVISIONALIZACION INMEDIATA DEBE RESTRINGIRSE EN CASOS EN LOS QUE NO SE PERMITE CARGA OCLUSAL.2

EL MANEJO ADECUADO DE LAS RESTAURACIONES IMPLANTOSOPORTADAS SE HA CONVERTIDO EN UNA TAREA IMPORTANTE CUANDO SE TRATA DE OBTENER RESULTADOS ESTÃ‰TICOS Ã“PTIMOS.4

EL OBJETIVO DE ESTE CASO FUE PRESENTAR LA ALTERNATIVA A LAS TÃ‰CNICAS CONVENCIONALES DE INJERTOS AUTÃ“LOGOS, UTILIZANDO PROTOCOLOS PROTÃ‰SICOS PARA REDUCIR MORBILIDAD INTRAOPERATORIA Y POSQUIRÃšRGICA DEL PACIENTE, ASI MISMO, MEJORAR LA DEFICIENCIA HORIZONTAL DE TEJIDOS CICATRIZADOS.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINO DE 34 AÃ‘OS DE EDAD, ACUDE A LA CLINICA DE PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÃ□A DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD JUÃ□REZ DEL ESTADO DE DURANGO. SISTÃ‰MICAMENTE SANA Y NIEGA ALERGIAS. DIAGNÃ“STICO PERIODONTAL ESTADIO II GRADO A GENERALIZADA SEGÃšN PAPAPANOU Y COLS. 2017. RECIBE TRATAMIENTO PERIODONTAL NO QUIRÃšRGICO, REVALORACIÃ“N Y FINALMENTE LA EXTRACCIÃ“N Y PRESERVACIÃ“N DEL DIENTE #36 QUE SE ENCONTRABA AFECTADO POR CARIES CERVICAL Y RADICULAR. EL PRONÃ“STICO INDIVIDUAL DEL DIENTE EXTRAÃ□DO FUE DESTINADO IMPOSIBLE SEGÃšN MCGUIRE Y NUNN 1996, KWOK Y CATÃ“N 2007. LA PRESERVACIÃ“N SE REALIZÃ“ CON SUSTITUTO Ã“SEO XENOINJERTO BOVINO, TAPE DE COLÃ□GENO PARA ESTABILIZACIÃ“N DEL COÃ□GULO Y SE COLOCÃ“ UN PUNTO DE SUTURA EN X CON NYLON 5-0. LA EXTRACCIÃ“N DENTAL TUVO DIFICULTADES QUE EN TÃ‰RMINOS DE CICATRIZACIÃ“N DE LOS TEJIDOS BLANDOS GENERÃ“ UN COLAPSO VESTIBULAR PRONUNCIADO EVIDENTE A LARGO PLAZO. LA PACIENTE SOLICITÃ“ TERAPIA IMPLANTOLÃ“GICA Y SE EVALUARON LAS CONDICIONES EN TÃ‰RMINOS DE SALUD PERIODONTAL Y DE LOS FACTORES LOCALES QUE PERMITIERAN SU COLOCACIÃ“N.

SE SOLICITÃ“ CBCT Y ESCANEO INTRAORAL PARA EVALUAR EL SITIO DE INTERÃ‰S. SE OBTUVO UNA SIMULACIÃ“N DIGITAL PARA LA COLOCACIÃ“N DEL IMPLANTE Y SE ELABORÃ“ UNA GUÃ□A SEMIRRESTRICTIVA. SE REALIZÃ“ UNA INCISIÃ“N EN LA CRESTA MEDIA, QUE SE CONTINUA CON INCISIONES SULCULARES CON BISTURÃ□ 15C Y CON LEGRA P20 SE EXPONE EL COLGAJO. PREVIAMENTE SE IDENTIFICÃ“ EL PROTOCOLO DE FRESADO DE NEODENTÂ® PARA HUESO TIPO III. LA VELOCIDAD DE FRESADO OSCILÃ“ ENTRE 500-800 RPM. SE UTILIZÃ“ FRESA INICIAL, 2.0, 3.5 Y 4.3. EL IMPLANTE UTILIZADO CORRESPONDE A 4.3X10MM HÃ‰LIX AQUA. LA VELOCIDAD DE INSERCIÃ“N FUE DE 30 RPM, Y SE OBTUVO UN TORQUE DE 40N/CM, LA POSICIÃ“N CORRESPONDE A TIPO SUBCRESTAL A 2MM Y FINALMENTE SE COLOCÃ“ UNA TAPA CIERRE 2.0. SE REPOSICIONÃ“ EL COLGAJO CON PUNTOS COLCHONEROS Y SIMPLES CON NYLON 5-0.

POR PARTE DEL Ã□REA DE REHABILITACIÃ“N, SE REALIZÃ“ UN ESCANEO INTRAORAL QUE PERMITE EMPATAR TEJIDOS BLANDOS Y REALIZAR LAS MEDICIONES CORRESPONDIENTES PARA LA ELABORACIÃ“N DE UN PROVISIONAL PERSONALIZADO. SE RETIRÃ“ TAPA CIERRE DEL SITIO QUIRÃšRGICO Y EL MISMO DÃ□A SE COLOCÃ“ EL PROVISIONAL PERSONALIZADO. SE REALIZÃ“ SEGUIMIENTO DEL REBORDE EN SENTIDO HORIZONTAL Y EN LA MODIFICACIÃ“N PROGRESIVA DE LOS CONTORNOS CRÃ□TICOS Y SUBCRÃ□TICOS EN LA SEMANA 4 Y 16. SE COLOCÃ“ PROTESIS DEFINITIVA.

Resultados y Conclusiones *

SE OBTUVIERON MODIFICACIONES EN SENTIDO HORIZONTAL DE LOS CONTORNOS CRÃ TICOS Y SUBCRÃ TICOS DEL PERFIL DE EMERGENCIA RESTAURADOR, OPTIMIZANDO LA ARQUITECTURA DEL TEJIDO BLANDO PERIIMPLANTARIO. EL PROVISIONAL PERSONALIZADO FUE CAPAZ DE GUIAR LA CICATRIZACIÃ“N Y LA MADURACIÃ“N DE LOS TEJIDOS SIN INTERFERIR CON EL PROCESO DE OSTEOINTEGRACIÃ“N. EL MANEJO DE LOS TEJIDOS LOGRÃ“ BENEFICIAR EN ESTÃ‰TICA Y ARMONÃ A A LA CORONA DEFINITIVA.

EL USO DE ESTOS PROTOCOLOS PROTÃ‰SICOS EN SITIOS CON DEFICIENCIAS DE TEJIDOS BLANDOS PERMITE OBTENER RESULTADOS ESTÃ‰TICOS Y BIOLÃ“GICOS SÃ“LIDOS TANTO CON RESTAURACIONES PROVISIONALES COMO CON PILARES DEFINITIVOS. ADEMÃ S DE REDUCIR EL NÃšMERO DE CIRUGÃ AS, MORBILIDAD RELACIONADA CON LA TÃ‰CNICA Y REDUCIR EL TIEMPO TOTAL DEL TRATAMIENTO, TAMBIÃ‰N REDUCE EL TIEMPO NECESARIO PARA ACONDICIONAR LOS TEJIDOS BLANDOS PERIIMPLANTARIOS Y ES UN PROTOCOLO MÃ NIMAMENTE INVASIVO.

LA COMPRENSIÃ“N DE LAS DIFERENTES ZONAS PERMITE DISEÃ‘AR Y FABRICAR PERFILES DE EMERGENCIA DE ASPECTO NATURAL QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS FUNCIONALES, BIOLÃ“GICOS Y ESTÃ‰TICOS DE LA TERAPIA CON IMPLANTES MODERNA. ESTOS RESULTADOS SON POSIBLES CUANDO EXISTE UN MANEJO INTERDISCIPLINAR QUE PERMITE INTERACTUAR Y COMBINAR SUS ENFOQUES COLABORANDO PARA GENERAR NUEVAS IDEAS Y SOLUCIONES.

Bibliografía *

1. SU H, GONZALEZ-MARTIN O, WEISGOLD A, LEE E. CONSIDERATIONS OF IMPLANT ABUTMENT AND CROWN CONTOUR: CRITICAL CONTOUR AND SUBCRITICAL CONTOUR. INT J PERIODONTICS RESTORATIVE DENT. 2010;30(4):335â€“43.

2. CHOKAREE P, POOVARODOM P, CHAIJAREENONT P, YAVIRACH A, RUNGSIYAKULL P. BIOMATERIALS AND CLINICAL APPLICATIONS OF CUSTOMIZED HEALING ABUTMENTâ€”A NARRATIVE REVIEW. J FUNCT BIOMATER. 2022;13(4):291. DOI:10.3390/JFB13040291.

3. GOMEZ-MEDA R, ESQUIVEL J, BLATZ MB. THE ESTHETIC BIOLOGICAL CONTOUR CONCEPT FOR IMPLANT RESTORATION EMERGENCE PROFILE DESIGN. J ESTHET RESTOR DENT. 2021;33(1):173â€“84. DOI:10.1111/JERD.12714.

Título del trabajo *

TEST GENÃ‰TICO BACTERIOLÃ“GICO PERIODONTAL, EN UNA PERIODONTITIS ESTADIO IV, GRADO C.

Nombre del Autor (a/es)*

C.D. JazmÃ-n LÃ³pez LÃ³pez.

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

C.D.E.P. e I. Abel EscÃ¡rcega Ochoa, C.D.E.P. e I. Pollyanna del Consuelo Gil MartÃ-nez., , , , , , , .

Correo Electrónico *

jazminjl9@hotmail.es

Institución *

CENTRO EDUCATIVO MULTIDISCIPLINARIO EN REHABILITAC

Introducción y Objetivos *

LA PERIODONTITIS SE CARACTERIZA POR LA DESTRUCCIÃ“N PROGRESIVA DEL APARATO DE INSERCIÃ“N DE LOS TEJIDOS PERIODONTALES, SIENDO LAS CARACTERÃ STICAS PRINCIPALES: PRESENCIA DE BOLSAS PERIODONTALES AL SONDEO, PÃ‰RDIDA DE INSERCIÃ“N CLÃ NICA, SANGRADO AL SONDEO, SUPURACIÃ“N, PRESENCIA DE CÃ LCULO DENTAL SIENDO ESTOS LOS PARÃ METROS CLÃ NICOS PERIODONTALES Y PÃ‰RDIDA Ã“SEA RADIOGRÃ FICA; LA PERIODONTITIS ES ENFERMEDAD INFLAMATORIA CRO?NICA NO TRANSMISIBLE MA?S COMU?N EN LOS SERES HUMANOS(1). LA ENFERMEDAD PERIODONTAL SE INICIA POR ACUMULACIÃ“N DE BIOPELÃ CULA BACTERIANA EN Y DEBAJO DEL MARGEN GINGIVAL, QUE SE VUELVE CADA VEZ MÃ S DISBIÃ“TICA, EXISTEN FACTORES PREDISPONENTES DEL HOSPEDERO QUE LO HACEN SUCEPTIBLE Y MICROBIANOS QUE INFLUYEN EN LA PATOGÃ‰NESIS DE LA ENFERMEDAD(2). LA DESREGULACIÃ“N DE LA RESPUESTA INMUNOINFLAMATORIA DEL HUÃ‰SPED, IMPULSA AÃšN MÃ S LA DISBIOSIS Y RESULTA EN LA DESTRUCCIÃ“N DE LOS TEJIDOS PERIODONTALES, LOS COMPLEJOS MICROBIANOS FUERON IDENTIFICADOS EN LA PLACA SUBGINGIVAL POR SOCRANSKY, ENTRE ESTOS SE ENCUENTRA T. FORSYTHIA, P. GINGIVALIS Y T. DENTICOLA QUE PERTENECEN AL COMPLEJO ROJO(3). EXISTEN VARIAS PRUEBAS PARA IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES BACTERIAS PERIODONTO-PATO?GENAS RESPONSABLES DE ENFERMEDAD PERIODONTAL PRESENTES EN EL SURCO GINGIVAL COMO ES TOMA DE SALIVA, FLUIDO GINGIVAL, TENIENDO DESVENTAJAS EN TIEMPO DE ENTREGA DEL RESULTADO Y A VECES CON SESGO(4). ACTUALMENTE A SURGIDO EL TEST GENÃ‰TICO BACTERIOLÃ“GICO PERIODONTAL PRUEBA NO INVASIVA E INDOLORA QUE DETECTA LA PRESENCIA DE LAS BACTERIAS PERIODONTALES MÃ S FRECUENTES, EL TEST SE REALIZA MEDIANTE UNA SIMPLE MUESTRA DE LA PLACA DENTAL DEL PACIENTE SOBRE UNA PUNTA ABSORBENTE, LA MUESTRA SE ENVÃ A AL LABORATORIO, DONDE SE ANALIZA MEDIANTE PCR ESTA TÃ‰CNICA DE BIOLOGÃ A MOLECULAR PERMITE AMPLIFICAR EL ADN DE LAS BACTERIAS(5).

OBJETIVO, EVALUAR LOS PARÃ METROS CLÃ NICOS PERIODONTALES, AL TÃ‰RMINO DE TPNQ UTILIZANDO ANTIBIOTERAPIA ADYUVANTE, BASADO EN UN TEST GENÃ‰TICO BACTERIOLÃ“GICO PERIODONTAL.

Descripción del Caso *

FEMENINO DE 47 AÃ‘OS, SIN ANTECEDENTES PATOLÃ“GICOS PERSONALES, TOXICOMANÃ AS Y TOMA DE MEDICAMENTOS NEGADOS. MOTIVO DE CONSULTA â€œSE ME AFLOJARON MUCHO 2 DIENTES Y YA NO PUEDO COMER Y QUIERO SALVAR LOS DEMÃ Sâ€ . EXÃ MENES DE LABORATORIOS NORMALES. A LA EXPLORACIÃ“N CLÃ NICA INTRAORAL PRESENTA DIVERSOS AUMENTOS DE VOLUMEN, ERITEMA EN TEJIDO BLANDO PREDOMINANTE EN ZONAS INTERPROXIMALES, EN COMPARACIÃ“N DE OTRAS ZONAS CON PRESENCIA DE ESPACIOS NEGROS, MIGRACIÃ“N PATOLÃ“GICA DENTARIA, ABANICAMIENTO DENTAL EN SECTOR ANTERIOR, PÃ‰RDIDA DE PIEZAS DENTALES. PARÃ METROS CLÃ NICOS PERIODONTALES, PBS MÃ XIMA 7 MM, UCE HASTA 5 MM, IBB 24.4%, SAS 48.3%, SUPURACIÃ“N 0%, CÃ LCULO DENTAL 18.6%, NIS 1-2 MM CON 7.9%, 3-4 MM UN 43.7% Y >5 MM 48.7%. RADIOGRÃ FICAMENTE, PERDIDA Ã“SEA GENERALIZADA, CON DEFECTOS Ã“SEOS ANGULADOS. SE DIAGNOSTICÃ“ PERIODONTITIS ESTADIO IV GRADO C, FENOTIPO PLANO GRUESO, TRAUMA OCLUSAL SECUNDARIO. SE ELABORÃ“ PLAN DE TRATAMIENTO MEDIANTE GUÃ A EFP S3. FASE I: FISIOTERAPIA ORAL, PROTOCOLO DE BOCA COMPLETA CON 2 CITAS EN MENOS DE 24HR, COMBINANDO ANTIBIOTICOTERAPIA AMOXICILINA CON Ã CIDO CLAVULÃ NICO DE 875/125 MG, 1 DÃ“SIS/12 HORAS/7DIAS Y METRONIDAZOL DE 500MG, 1 DÃ“SIS /8 HORAS/7 DÃ AS. A 6 MESES SE REALIZÃ“ TPS, LOS PARÃ METROS CLÃ NICOS PERIODONTALES FUERON: PBS MÃ XIMA 7 MM, UCE HASTA 5 MM, IBB 14.5%, SAS 13.8%, SUPURACIÃ“N 0%, CÃ LCULO DENTAL 1.23%, NIS 1-2 MM CON 16.9%, 3-4 MM UN 44.7% Y >5 MM 38.33%. SE TOMÃ“ TEST GENÃ‰TICO BACTERIOLÃ“GICO PERIODONTAL CON PUNTAS DE PAPEL, EL RESULTADO FUE POSITIVO A TREPONEMA DENTICOLA POR PCR. SE RE-INICA FASE I YA DESCRITA, SOLAMENTE CAMBIA ANTIBIOTERAPIA: AZITROMICINA DE 500 MG, 1 DÃ“SIS /24 HRS/3 DÃ AS, EN COMBINACIÃ“N METRONIDAZOL 500 MG, 1 DÃ“SIS /8 HRS POR 7 DIAS. ENJUAGAR CADA 2 HORAS CON SOLUCIÃ“N QUE CONTENGA PARTES IGUALES PERÃ“XIDO DE HIDROGENO AL 3% Y AGUA TIBIA POR 7 DÃ AS. SE TOMA TEST GENÃ‰TICO BACTERIOLÃ“GICO PERIODONTAL, DANDO RESULTADO NEGATIVO A PANEL BACTERIOLÃ“GICO PERIODONTAL.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS, SE EVALUARON LOS PARÃ METROS CLÃ NICOS QUE SE TOMARONA AL INICIO DE TPNQX, A 6 MESES EN TPS, Y AL REINICIO DE UNA SEGUNDA TPNQX, AL HACER EL ANÃ LISIS DE ESTOS SE ENCONTRÃ“ QUE EN ALGUNOS SITIOS LA PBS MÃ XIMA SE MANTUVO EN 7 MM, MIENTRAS QUE LA UCE DE 4 MM DISMINUYÃ“ 1 MM; EL SAS DE UN 48.3% DISMINUYÃ“ A 2.1% DANDO UN 46.2% DE SITIOS SIN SANGRADO; SUPURACIÃ“N 0%; CÃ LCULO DENTAL 0%; NIS 1-2 MM CON 25% DANDO UN AUMENTO DEL 17.1% DE SITIOS EN SALUD; LOS SITIOS ENTRE 3-4 MM AUMENTO A 53.3% DANDO UN 9.6% DE SITIOS QUE PASARON A ESTAR EN SALUD Y SITIOS CON >5 MM QUE EN UN PRINCIPIO FUE 21.3% DISMINUYERON EN UN 10.37%. SE OBSERVÃ“ QUE IBB EN LA TPNQ INICIAL FUE 24.4% A LOS 6 MESES CAMBIÃ“ A 14.5%, Y EN LA SEGUNDA TPNQ DISMINUYENDO A 5.7% POR LO QUÃ‰ EL BIOFILM BACTERIANO FUE CONTROLADO O ELIMINADO EN UN 94.3%.

CONCLUSIONES, EL TEST GENÃ‰TICO BACTERIOLÃ“GICO PERIODONTAL OFRECE UNA SERIE DE BENEFICIOS COMO ES: MAYOR PROBABILIDAD DE Ã‰XITO AL TRATAMIENTO AL USAR EL ANTIBIOTICO ADECUADO COMO ADYUVANTE EN LA TPNQX, COMO FUE OBSERVADO EN ESTE CASO CLÃ NICO. EL SABER LA BACTERIA QUE SE ENCUENTRA POSITIVA PERMITIRÃ REALIZAR UN DIAGNÃ“STICO TEMPRANO Y PRECISO PARA ENFERMEDAD PERIODONTAL SIENDO MÃ S FÃ CIL EL TRATAMIENTO Y LA ELECCIÃ“N DEL MEDICAMENTO. POR LO QUÃ‰, EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÃ A EN ESTOS MOMENTOS COMPLEMENTA UN DIAGNÃ“STICO MAS CERTERO, UTILIZAR EL TEST GENÃ‰TICO BACTERIOLÃ“GICO PERMITE REALIZAR PLANES DE TRATAMIENTO EXITOSOS. EL USO DE ANTIBIÃ“TICOS SISTÃ‰MICOS COMO COADYUVANTE A LA TPNQ, PRODUCEN REDUCCIÃ“N DEL BIOFILM BACTERIANO DISBIÃ“TICO, DANDO RESULTADO EXITOSO, AL HACER LA ELECCÃ Ã“N ADECUADA DEL MEDICAMENTO PARA LA BACTERIA QUE SALGA POSITIVA EN EL TEST GENÃ‰TICO BACTERIOLÃ“GICO.

Bibliografía *

1. HERRERA D, SANZ M, KEBSCHULL M, JEPSEN S, SCULEAN A, BERGLUNDH T, ET AL. TREATMENT OF STAGE IV PERIODONTITIS: THE EFP S3 LEVEL CLINICAL PRACTICE GUIDELINE. J CLIN PERIODONTOL [INTERNET]. 2022;49 SUPPL 24(S24):4â€“71. AVAILABLE FROM: HTTP://DX.DOI.ORG/10.1111/JCPE.13639

2. MEYLE J, Y CHAPPLE I. ASPECTOS MOLECULARES DE LA PATOGÃ‰NESIS DE PERIODONTITIS. PERIODONCIA. 2015; 69(1), 7-17. DISPONIBLE EN: HTTPS://DOI.ORG/10. 1111/ PRD.12104

3. HAJISHENGALLIS G. Y CHAVAKIS T. MECANISMOS LOCALES Y SISTÃ‰MICOS QUE VINCULAN LA ENFERMEDAD PERIODONTAL Y LAS COMORBILIDADES INFLAMATORIAS. RESEÃ‘AS DE LA NATURALEZA INMUNOLOGÃ A. 2021; 21 (7), 426â€“440. HTTPS://DOI.ORG/10.1038/

4. CORDERO-SOBERANES, H. PRUEBAS MICROBIOLÃ“GICAS EN DL DIAGNÃ“STICO DE ENFERMEDAD PERIODONTAL. VERTIENTES. REVISTA ESPECIALIZADA EN CIENCIAS DE LA SALUD. 2013; 3 (1-2). RECUPERADO A PARTIR DE HTTPS://WWW.REVISTAS.UNAM.MX/INDEX.PHP/VERTIENTES/ARTICLE/VIEW/33059

5. VITALDENTE. 2024. HTTPS://WWW.VITALDENT.COM/ES/TEST-GENETICO-BACTERIOLOGICO/?UTM SOURCE=GOOGLE&UTM MEDIUM=ORGANIC#:~:TEXT=EL%20TEST%20GENÃ‰TICO%20BA

Título del trabajo *

AGRANDAMIENTO GINGIVAL: Â¿CORTE FRÃ□O O TÃ‰RMICO? COMPARATIVA CLÃ□NICA ENTRE BISTURÃ□ CONVENCIONAL Y LÃ□SER. REPORTE DE CASO

Nombre del Autor (a/es)*

ALVAREZ BARRETO ISRAEL

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

NIETO RAMIREZ JAIME ALEJANDRO, , JIMÃ‰NEZ AGUIRRE KARLA, , , , , , .

Correo Electrónico *

israel.alvarez.ba@gmail.com

Institución *

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD LEÃ“

Introducción y Objetivos *

EL AGRANDAMIENTO GINGIVAL (A.G.) ES EL CRECIMIENTO EXCESIVO DE LA ENCÃ⍰A COMO UNA RESPUESTA INFLAMATORIA A LA MICROBIOTA DE LA PLACA Y PRODUCTOS RELACIONADOS, PUEDE IR ACOMPAÃ‘ADA DE ENROJECIMIENTO, EDEMA Y SANGRADO AL SONDEO. HISTOLÃ“GICAMENTE SE UNA PROLIFERACIÃ“N FIBROBLÃ⍰STICA (1).

LA GINGIVECTOMÃ⍰A ES LA INTERVENCIÃ“N QUIRÃšRGICA PARA LA ELIMINACIÃ“N DE AGRANDAMIENTO GINGIVAL, BOLSAS SUPRAÃ“SEAS Y EN CONJUNTO CON LA GINGIVOPLASTÃ⍰A PRODUCE UN MODELADO GINGIVAL (1-5).

EN ESTE CONTEXTO, SE HAN DESARROLLADO DOS ENFOQUES PRINCIPALES: LA GINGIVECTOMÃ⍰A CONVENCIONAL MEDIANTE BISTURÃ⍰/ TIJERAS Y LA GINGIVECTOMÃ⍰A ASISTIDA POR LÃ⍰SER. AMBOS MÃ‰TODOS PRESENTAN VENTAJAS Y LIMITACIONES QUE HAN SIDO EVALUADAS, LOS LÃ⍰SERES DENTALES HAN DEMOSTRADO VARIAS VENTAJAS SOBRE LOS MÃ‰TODOS QUIRÃšRGICOS CONVENCIONALES COMO UNA OPCIÃ“N DE TRATAMIENTO PROMETEDORA (2)

EL LÃ⍰SER DIODO TIENE ALTA AFINIDAD POR LA HEMOGLOBINA Y MELANINA CON UNA LONGITUD DE ONDA DE 810-980 NM Y MUY POCA ABSORCIÃ“N EN TEJIDO DURO DENTAL (6), EL LÃ⍰SER HA GANADO RELEVANCIA DEBIDO A SUS VENTAJAS, ENTRE LAS QUE DESTACAN (7,8)

PARÃ⍰METROS:

â€¢ CONTROL DEL SANGRADO

â€¢ PRECISIÃ“N

â€¢ TIEMPO OPERATORIO

â€¢ RESULTADOS ESTÃ‰TICOS

â€¢ MENOR DOLOR POSTOPERATORIO

â€¢ MENOR RIESGO A INFECCIÃ“N

â€¢ APLICACIONES CLÃ⍰NICAS

OBJETIVO: PRESENTAR UN REPORTE DE CASO SOBRE EL AGRANDAMIENTO GINGIVAL MEDIANTE LA COMPARATIVA ENTRE BISTURÃ⍰ CONVENCIONAL Y LÃ⍰SER DIODO.

Descripción del Caso *

PRESENTACIÃ“N DEL CASO Y DIAGNÃ“STICO:

DIAGNÃ“STICO: AGRANDAMIENTO GINGIVAL ASOCIADO A FACTORES DE RETENCIÃ“N, BIOPELÃ□CULA DENTAL.

SE PRESENTA EL CASO DE UN PACIENTE MASCULINO DE 20 AÃ‘OS, REFERIDO POR CLÃ□NICA DE PREVENTIVA TRAS DOS AÃ‘OS DE TRATAMIENTO ORTODÃ“NCICO, DURANTE LOS CUALES DESARROLLÃ“ A.G. DESARROLLADO A FACTORES DE RETENCIÃ“N DE BIOPELÃ□CULA. EL PACIENTE REPORTÃ“ SANGRANDO EN ENCÃ□A, INFLAMACIÃ“N, MAL ALIENTO Y MOLESTIAS AL SONREÃ□R. PACIENTE ASA I. AL EXAMEN PERIODONTAL EXHAUSTIVO NO MOSTRÃ“ ALTERACIONES Ã“SEAS RADIOGRÃ□FICAS NI PÃ‰RDIDA DE INSERCIÃ“N CLÃ□NICA, AUNQUE SE IDENTIFICARON PSEUDOBOLSAS RELACIONADAS CON EL AGRANDAMIENTO GINGIVAL. CLÃ□NICAMENTE, SE OBSERVÃ“ SANGRADO AL SONDAJE Y COBERTURA GINGIVAL DE UN TERCIO DE LA CORONA DE LA MAYORÃ□A DE LOS DIENTES ANTERIORES SUPERIORES E INFERIORES.

PROCEDIMIENTO:

EL PROCEDIMIENTO SE REALIZA CON TÃ‰CNICA DE BISTURÃ□ CONVENCIONAL EN ARCADA INFERIOR Y CON LÃ□SER EN ARCADA SUPERIOR. SE INFILTRA ANESTESIA REGIONAL Y EN INFERIOR LOCALIZADA, INCISIONES MEDIANTE EL USO DE LÃ□SER DE DIODO EPIC10 (BIOLASE) A UNA POTENCIA DE 810-980 NM(SUPERIOR) Y BISTURÃ□, MODELADO GINGIVAL CON TIJERAS TIPO LAGRANGE Y PLASTIA CON BISTURÃ□ GINGIVAL (INFERIOR), CONTROL DEL SANGRADO BAJO COMPRESIÃ“N.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS:

SE PUEDE OBSERVAR A LA SEMANA DE LA INTERVENCIÃ“N LOS MÃ RGENES GINGIVALES CON UN MEJOR CONTORNO Y MAYOR EXPOSICIÃ“N DE LA CORONA DENTAL, LIGERO EDEMA EN ARCADA SUPERIOR, ERITEMA Y EDEMA MAYOR EN ARCADA INFERIOR. PACIENTE NO REFIERE PRESENTAR DOLOR POSTOPERATORIO, SE INDICA SEGUIR CON SU HIGIENE ORAL.

CONCLUSIONES:

EN ESTE REPORTE DE CASO SE MUESTRA PARTE DE LA VERSATILIDAD DE LAS TÃ‰CNICAS, LA GINGIVECTOMÃ A CON LÃ SER OFRECE MAYOR PRECISIÃ“N EN EL CONTORNO GINGIVAL, UN CONTROL HEMOSTÃ TICO SUPERIOR (MENOR SANGRADO), Y UN MENOR TIEMPO DE CICATRIZACIÃ“N CON MENOS INFLAMACIÃ“N Y DOLOR POSTOPERATORIO. EL PROCEDIMIENTO FUE SEGURO, LA TÃ‰CNICA FUE SENCILLA Y DE UN TIEMPO CLÃ NICO REDUCIDO, TAL COMO SE MENCIONA EN LA LITERATURA. LA GINGIVECTOMÃ A CONVENCIONAL SIGUE SIENDO UNA OPCIÃ“N CONFIABLE, ACCESIBLE Y AMPLIAMENTE UTILIZADA.

LA ELECCIÃ“N DEBE BASARSE EN LAS NECESIDADES DEL PACIENTE, HABILIDADES DEL PROFESIONAL Y DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÃ A.

Bibliografía *

1-KEVIN CZB. GINGIVECTOMÃ A LÃ SER PARA MANTENER LA SALUD PERIODONTAL EN PACIENTES CON ORTODONCIA FIJA: UNA REVISIÃ“N SISTEMÃ TICA. INTERNET. 2025.

2- JAUREGUI MUÃ‘OZ MDC, RUDAS RAMIREZ VR. EL USO DE ELECTROBISTURÃ EN GINGIVOPLASTÃ A Y GINGIVECTOMÃ A: ANÃ LISIS BIBLIOMÃ‰TRICO (2019â€“2024). 2025. DISPONIBLE EN: HTTPS://REPOSITORIO.USS.EDU.PE/HANDLE/20.500.12802/15179

3- CAPODIFERRO S, FAVIA G, DE FRENZA G, LIMONGELLI L, TEMPESTA A, MAIORANO E. ASSESSMENT OF HEALING AFTER DIODE LASER GINGIVECTOMY PRIOR TO PROSTHETIC PROCEDURES. APPL SCI. 2023;13(9):5527. DOI:10.3390/APP13095527

4- LEVRINI L, CAPRIOGLIO C, NIERI M, MARELLI B, TENCONI C, PILLONI A. CONVENTIONAL VERSUS LASER GINGIVECTOMY IN THE MANAGEMENT OF GINGIVAL ENLARGEMENT DURING ORTHODONTIC TREATMENT: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. EUR J ORTHOD. 2020;42(1):78-85. DOI:10.1093/EJO/CJZ032.

5- KAUR BR, ARORA AA, RAJPUT CP. EFFECT OF LOW-LEVEL LASER THERAPY ON WOUND HEALING AND PATIENTSâ€™ RESPONSE AFTER SCALPEL GINGIVECTOMY: A RANDOMIZED CLINICAL SPLIT-MOUTH STUDY. J INDIAN SOC

Título del trabajo *

OPTIMIZACIÃ“N DE RESULTADOS CLÃ NICOS Y ESTÃ‰TICOS MEDIANTE LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTE INMEDIATO CON PROVISIONALIZACIÃ“N EN EL SECTOR ANTERIOR Y USO DE INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO EN GAP PEQUEÃ‘O SIN INJERT

Nombre del Autor (a/es)*

Marco Antonio PÃ©rez VÃ¡zquez

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Manuel Salvador Delgado Mendoza, HÃ©ctor Iram RodrÃ-guez Guerra, Francisco Javier de LeÃ³n Vigil, , , , , , .

Correo Electrónico *

mperez56@uabc.edu.mx

Institución *

UNIVERSIDAD AUTÃ“NOMA DE BAJA CALIFORNIA

Introducción y Objetivos *

ANTECEDENTES

LA COLOCACIÃ“N INMEDIATA DE IMPLANTES POSTEXTRACCIÃ“N EN EL SECTOR ANTERIOR ES UNA ALTERNATIVA PREDECIBLE CUANDO SE CUMPLEN CRITERIOS QUIRÃšRGICOS Y PROTÃ‰SICOS ADECUADOS. ESTE ENFOQUE ACORTA LOS TIEMPOS DE TRATAMIENTO Y CONTRIBUYE A PRESERVAR LA ARQUITECTURA DE LOS TEJIDOS DUROS Y BLANDOS. ESTUDIOS COMO EL DE CARDAROPOLI ET AL. (2006) HAN DEMOSTRADO QUE, TRAS LA EXTRACCIÃ“N, LA CRESTA VESTIBULAR SUFRE UNA REMODELACIÃ“N SIGNIFICATIVA QUE INFLUYE DIRECTAMENTE EN EL RESULTADO ESTÃ‰TICO Y FUNCIONAL DEL TRATAMIENTO.

EL POSICIONAMIENTO DEL IMPLANTE PUEDE PLANIFICARSE SEGÃšN LA CLASIFICACIÃ“N SAGITAL DE LA RAÃ□Z PROPUESTA POR KAN ET AL. (2011), QUE AYUDA A DETERMINAR LA UBICACIÃ“N IDEAL DENTRO DEL ALOJAMIENTO Ã“SEO PARA OPTIMIZAR SOPORTE Y ESTABILIDAD PRIMARIA. NO OBSTANTE, INCLUSO CON TÃ‰CNICAS DE REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA, LANG ET AL. (2012) DOCUMENTARON UNA MIGRACIÃ“N VESTIBULAR PROMEDIO DE 0.51â€“0.52 MM AL AÃ‘O, LO QUE JUSTIFICA LA COLOCACIÃ“N SUBCRESTAL DEL IMPLANTE ?0.5 MM PARA COMPENSAR ESTA REABSORCIÃ“N PREDECIBLE Y FAVORECER LA ESTABILIDAD A LARGO PLAZO.

CUANDO EL OBJETIVO PRINCIPAL ES MAXIMIZAR LA ESTÃ‰TICA DE LOS TEJIDOS BLANDOS Y MEJORAR LA ESTÃ‰TICA ROSA, EL USO DE INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO (ITC) DURANTE LA COLOCACIÃ“N INMEDIATA â€”SIN INJERTO Ã“SEO EN UN GAP PEQUEÃ‘Oâ€” HA DEMOSTRADO ALTA EFICACIA EN MANTENER LA ESTABILIDAD DE LOS TEJIDOS GINGIVALES Y LA ARMONÃ□A ESTÃ‰TICA. SEYSSENS ET AL. (2021) REPORTARON QUE EL ITC MEJORA LA POSICIÃ“N Y ESTABILIDAD DEL MARGEN MUCOSO TERCIO MEDIO, REDUCIENDO EL RIESGO DE RECESIÃ“N. ZUIDERVELD ET AL. (2024), EN UN SEGUIMIENTO A 5 AÃ‘OS, CONFIRMARON QUE ESTA TÃ‰CNICA PUEDE PRESERVAR DE MANERA CONSISTENTE LOS RESULTADOS ESTÃ‰TICOS SIN NECESIDAD DE INJERTO Ã“SEO ADICIONAL, CONSOLIDÃ□NDOSE COMO UNA OPCIÃ“N TERAPÃ‰UTICA FIABLE EN CASOS SELECCIONADOS.

OBJETIVO

EVALUAR LOS BENEFICIOS CLÃ□NICOS Y ESTÃ‰TICOS DE LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTE INMEDIATO EN EL SECTOR ANTERIOR CON PROVISIONALIZACIÃ“N INMEDIATA, UTILIZANDO UN INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO EN UN GAP PEQUEÃ‘O SIN INJERTO Ã“SEO.

Descripción del Caso *

PRESENTACIÃ“N DEL CASO Y DIAGNÃ“STICO D

PACIENTE FEMENINA DE 53 AÃ‘OS ACUDE A LA CLÃ NICA DEL POSGRADO DE PERIODONCIA UABC TIJUANA POR FRACTURA DEL INCISIVO CENTRAL SUPERIOR DERECHO. A LA EVALUACIÃ“N DE LA TOMOGRAFÃ A DENTAL SE CONFIRMÃ“ EL DIAGNÃ“STICO DE FRACTURA HORIZONTAL A NIVEL DE LA UNIÃ“N AMELOCEMENTARIA. SEGÃšN LA CLASIFICACIÃ“N DE POSICIÃ“N SAGITAL DE LA RAÃ Z DE KAN ET AL. (2011), SE IDENTIFICÃ“ UNA CLASE I, POR LO QUE SE DECIDIÃ“ REALIZAR LA EXTRACCIÃ“N DEL Ã“RGANO DENTAL #11 CON COLOCACIÃ“N INMEDIATA DE IMPLANTE Y PROVISIONALIZACIÃ“N.

PROCEDIMIENTOS

SE REALIZÃ“ LA EXTRACCIÃ“N ATRAUMÃ TICA DE LA PIEZA DENTARIA #11 UTILIZANDO PERIOTOMOS, ELEVADORES Y FÃ“RCEPS. POSTERIORMENTE, SE PREPARÃ“ EL LECHO IMPLANTARIO SIGUIENDO EL PROTOCOLO QUIRÃšRGICO DE LA MARCA HIOSSEN. SE COLOCÃ“ UN IMPLANTE CÃ“NICO TS IV CON CONEXIÃ“N INTERNA (3.5 Ã— 13 MM), OBTENIENDO UN TORQUE DE INSERCIÃ“N DE 35 NCM, VALOR SUPERIOR AL MÃ NIMO RECOMENDADO POR OTTONI ET AL. (32 NCM) PARA CARGA INMEDIATA.

SE OBTUVO UN INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO MEDIANTE TÃ‰CNICA DE INJERTO GINGIVAL LIBRE, CON DESEPITELIZACIÃ“N EXTRAORAL, FIJÃ NDOSE AL COLGAJO PARA AUMENTAR EL VOLUMEN EN EL SECTOR ANTERIOR MEDIANTE SUTURAS COLCHONERAS VERTICALES Y SUSPENSORIAS. EL INJERTO SE EMPLEÃ“ SIN INJERTO Ã“SEO COMPLEMENTARIO, DADO EL TAMAÃ‘O REDUCIDO DEL GAP.

FINALMENTE, SE ADAPTÃ“ UN PROVISIONAL SOBRE UN ADITAMENTO TEMPORAL DE PEEK, REALIZANDO AJUSTES PARA MANTENERLO FUERA DE OCLUSIÃ“N EN CÃ‰NTRICA Y EXCÃ‰NTRICAS.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADO

LA COLOCACIÃ“N INMEDIATA DEL IMPLANTE SIGUIENDO EL PROTOCOLO ESTABLECIDO PERMITIÃ“ ALCANZAR LA ESTABILIDAD PRIMARIA NECESARIA PARA REALIZAR LA CARGA INMEDIATA. A LOS 4 MESES DE SEGUIMIENTO, SE OBSERVÃ“ UNA OSTEOINTEGRACIÃ“N SATISFACTORIA Y UNA ADECUADA INTEGRACIÃ“N DEL PROVISIONAL, LO QUE FAVORECIÃ“ LA FORMACIÃ“N DE UN PERFIL DE EMERGENCIA ARMÃ“NICO.

LA INCORPORACIÃ“N DE UN INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO, SIN USO DE INJERTO Ã“SEO EN UN GAP PEQUEÃ‘O, CONTRIBUYÃ“ DE FORMA SIGNIFICATIVA A LA ESTABILIDAD DEL MARGEN GINGIVAL EN VESTIBULAR Y A LA PRESERVACIÃ“N DEL VOLUMEN GINGIVAL EN LA ZONA ESTÃ‰TICA. ESTOS HALLAZGOS COINCIDEN CON LO REPORTADO EN LA LITERATURA, DONDE EL INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO SE CONSIDERA UNA ESTRATEGIA EFICAZ PARA REDUCIR EL RIESGO DE RECESIÃ“N EN FENOTIPOS FINOS Y OPTIMIZAR EL RESULTADO ESTÃ‰TICO A LARGO PLAZO.

CONCLUSIÃ“N

UNA PLANEACIÃ“N PRECISA PERMITE PREDECIR LA ESTABILIDAD DEL IMPLANTE Y EJECUTAR UN PROTOCOLO DE CARGA INMEDIATA DE MANERA SEGURA, GRACIAS A UN ADECUADO MANEJO DE LOS TEJIDOS BLANDOS Y DUROS, FAVORECIENDO ASÃ LA OBTENCIÃ“N DE UN PERFIL DE EMERGENCIA Ã“PTIMO PARA LA RESTAURACIÃ“N FINAL.

Bibliografía *

CARDAROPOLI, G., ARAÃšJO, M., & LINDHE, J. (2006). DYNAMICS OF BONE TISSUE FORMATION IN TOOTH EXTRACTION SITES: AN EXPERIMENTAL STUDY IN THE DOG. JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, 33(9), 841â€“848. HTTPS://DOI.ORG/10.1111/J.1600-051X.2006.00901.X

KAN, J. Y. K., RUNGCHARASSAENG, K., ROE, P., & LOZADA, J. (2011). CLASSIFICATION OF SAGITTAL ROOT POSITION IN RELATION TO THE ANTERIOR MAXILLARY OSSEOUS HOUSING: A CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY STUDY. INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS, 26(4), 873â€“876.

LANG, N. P., PUN, L., LAU, K. Y., LI, K. Y., & WONG, M. C. M. (2012). A SYSTEMATIC REVIEW ON SURVIVAL AND SUCCESS RATES OF IMPLANTS PLACED IMMEDIATELY INTO FRESH EXTRACTION SOCKETS AFTER AT LEAST 1 YEAR. CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH, 23(SUPPL 5), 39â€“66. HTTPS://DOI.ORG/10.1111/J.1600-0501.2011.02372.X

SEYSSENS, L., DE LAT, L., COSYN, J., & EGHBALI, A. (2021). IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT WITH OR WITHOUT CONNECTIVE TISSUE GRAFT: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS. JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, 48(2), 284â€“301. HTTPS://DOI.ORG/10.1111/JCPE.13415

ZUIDERVELD. E. G.. ET AL. (2024). FIVE?YEAR FOLLOW?UP STUDY ON IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT IN THE

Título del trabajo *

"MANEJO INTEGRAL DE RECESIONES GINGIVALES CON LESIONES CERVICALES NO CARIOSAS MEDIANTE TÃ‰CNICA TCAF Y RESTAURACIÃ“N PREVIA: UN ENFOQUE COMBINADO PARA OPTIMIZAR ESTÃ‰TICA Y FUNCIÃ“N"

Nombre del Autor (a/es)*

Itza Anahein Castro Bojorquez.

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Betsabe De La Cruz Corona, De LeÃ³n Vigil Francisco Javier, , , , , , , .

Correo Electrónico *

itza.castro@uabc.edu.mx

Institución *

ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA, FACULTAD DE ODONTOLOG

Introducción y Objetivos *

LAS LESIONES CERVICALES NO CARIOSAS (LCNC) SON DEFECTOS DEL TERCIO CERVICAL QUE NO DERIVAN DE CARIES, SINO DE ABRASIÃ“N, EROSIÃ“N O ABFRACCIÃ“N. CUANDO COEXISTEN CON RECESIONES GINGIVALES MÃšLTIPLES, EL IMPACTO CLÃ□NICO AUMENTA AL COMPROMETER ESTÃ‰TICA Y FUNCIÃ“N; POR ELLO SE REQUIERE UN ABORDAJE RESTAURADORâ€“PERIODONTAL INTEGRADO PARA RECUPERAR ANATOMÃ□A Y PRESERVAR LA SALUD DE LOS TEJIDOS.Â[1]

AUNQUE LA ABRASIÃ“N SUELE VINCULARSE A LA HIGIENE TRAUMÃ□TICA, LA ETIOLOGÃ□A DE LAS LCNC ES MULTIFACTORIAL. LA EVIDENCIA SEÃ‘ALA UNA INTERACCIÃ“N SINÃ‰RGICA ENTRE EROSIÃ“N, ABRASIÃ“N Y ABFRACCIÃ“N; POR TANTO, EL DIAGNÃ“STICO Y EL PLAN TERAPÃ‰UTICO DEBEN IDENTIFICAR Y CONTROLAR SIMULTÃ□NEAMENTE LOS FACTORES CAUSALES SISTÃ‰MICOS, ASÃ□ COMO HÃ□BITOS RELEVANTES Y SOBRECARGAS OCLUSALES.Â[2]

LA RECESIÃ“N GINGIVAL (RG) ES EL DESPLAZAMIENTO DEL MARGEN APICAL A LA UNIÃ“N CEMENTO-ESMALTE (UCE). LA RG TIPO 1 (RT1) SE CARACTERIZA POR AUSENCIA DE PÃ‰RDIDA DE INSERCIÃ“N INTERPROXIMAL Y SE CONFIRMA COMPARANDO LA INSERCIÃ“N BUCAL E INTERPROXIMAL; SUELE ASOCIARSE A CEPILLADO TRAUMÃ□TICO EN TEJIDOS PERIODONTALMENTE SANOS.Â[3]

EN EL TRATAMIENTO DE RG EL COLGAJO AVANZADO CORONAL (CAF) Y LA TÃ‰CNICA DE TÃšNEL (TUN) SON ABORDAJES QUIRÃšRGICOS HABITUALES. TRADICIONALMENTE SE ELEGÃ□AN POR SEPARADO; NO OBSTANTE, SU COMBINACIÃ“N, DENOMINADA TÃšNEL CON COLGAJO DE AVANCE CORONAL (TCAF), POTENCIA LOS RESULTADOS POR OFRECER GRANDES VENTAJAS COMO PRESERVAR LAS PAPILAS INTERDENTALES, FAVORECE LA VASCULARIZACIÃ“N DEL INJERTO Y ESTABILIZA EL COLGAJO, FACTORES QUE CONTRIBUYEN A OPTIMIZAR LOS RESULTADOS CLÃ□NICOS Y ESTÃ‰TICOS.?

FINALMENTE, LA PLANIFICACIÃ“N DEBE ANCLARSE EN EL MÃ□XIMO DE COBERTURA RADICULAR (MCR), LA LÃ□NEA QUE PREDICE LA POSICIÃ“N FINAL DEL MARGEN GINGIVAL TRAS LA CIRUGÃ□A. LA CLASIFICACIÃ“N MCRâ€“LCNC CONTEMPLA CINCO TIPOS; EN EL TIPO 3, EL MCR COINCIDE CON LA PORCIÃ“N MÃ□S PROFUNDA DE LA LESIÃ“N.?

OBJETIVO:

EVALUAR LA EFICACIA CLÃ□NICA Y ESTÃ‰TICA DE LA TÃ‰CNICA TCAF COMBINADA CON LA RESTAURACIÃ“N DE LCNC, EN EL MANEJO DE RECESIONES GINGIVALES.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINA DE 58 AÃ‘OS ASA II, ACUDE A CONSULTA REFERIDA POR ENDODONCIA POR HIPERSENSIBILIDAD DENTARIA. ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES: PADRE CON HIPERTENSIÃ“N ARTERIAL Y MADRE CON DIABETES MELLITUS; NIEGA ALERGIAS. A LA EXPLORACIÃ“N CLÃ NICA SE OBSERVARON RECESIONES GINGIVALES MÃšLTIPLES ASOCIADAS A LCNC EN PIEZAS DENTARIAS 22,23,24, Y 25.

DIAGNÃ“STICO

SALUD GINGIVAL Y PERIODONTAL CON CONDICIONES Y DEFORMIDADES MUCOGINGIVALES. RECESIONES GINGIVALES RT1 (CLASIFICACIÃ“N DE CAIRO) EN PIEZAS DENTARIAS 22 A 25, ASOCIADAS A LESIONES CERVICALES NO CARIOSAS TIPO 3 (ZUCCHELLI).

PROCEDIMIENTOS

PREVIO A LA CIRUGÃ A, SE REALIZÃ“ FASE HIGIÃ‰NICA CON INSTRUCCIÃ“N DE CEPILLADO, ELIMINACIÃ“N DE HÃ BITOS NOCIVOS Y AJUSTE OCLUSAL. SE PRACTICARON ODONTOPLASTIAS EN DIENTES 24 Y 25 Y SE RESTAURARON LAS LCNC CON RESINA FLUIDA RESPETANDO LA MCR. LA INTERVENCIÃ“N, BAJO ANESTESIA LOCAL CON ARTICAÃ NA POR INFILTRACIONES SUPRAPERIÃ“STICAS ,SE SIGUIÃ“ LA TÃ‰CNICA TCAF: CON HOJA 15C SE EFECTUÃ“ UNA INCISIÃ“N HORIZONTAL EN LA PAPILA DE DIENTE 22â€“21, PRESERVANDO 1 MM APICAL PARA CONFORMAR UNA PAPILA QUIRÃšRGICA TRAPEZOIDAL, Y UNA INCISIÃ“N VERTICAL ÃšNICA EN DIENTE 21. LA PAPILA QUIRÃšRGICA Y EL COLGAJO SE ELEVARON A ESPESOR PARCIAL; SE TUNELIZÃ“ EL SECTOR QUIRÃšRGICO HASTA DIENTE 26 PARA PERMITIR UN AVANCE SIN TENSIÃ“N (2 MM CORONAL A LA UNIÃ“N AMELO-CEMENTARIA), Y SE REALIZÃ“ RASPADO Y ALISADO RADICULAR. DEL PALADAR SE OBTUVO UN INJERTO GINGIVAL LIBRE, DESEPITELIZADO PARA OBTENER UN INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO SUBEPITELIAL (ITCS); SE DESEPITELIZÃ“ LA PAPILA ANATÃ“MICA Y SE MOVILIZÃ“ LA OPUESTA CON TUNELIZADOR. EL ITCS SE INSERTÃ“ EN EL TÃšNEL Y SE FIJÃ“ A LA PAPILA DESEPITELIZADA CON SUTURAS SIMPLES INTERRUMPIDAS (PGA 5/0). FINALMENTE, SE COLOCARON SUTURAS SUSPENSORIAS (NYLON 5/0) ALREDEDOR DE CADA DIENTE PARA ESTABILIZAR INJERTO Y COLGAJO, LOGRANDO UN ADECUADO AVANCE CORONAL Y Ã“PTIMA ADAPTACIÃ“N TISULAR.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS:

DURANTE EL POSOPERATORIO SE OBSERVÃ“ UNA CICATRIZACIÃ“N SIN INCIDENTES, NI EXPOSICIÃ“N DEL INJERTO. EL MARGEN GINGIVAL SE POSICIONÃ“ CONFORME AL MCR PLANIFICADO, ADAPTÃ□NDOSE CON PRECISIÃ“N SOBRE LAS RESTAURACIONES CERVICALES.

EN LOS CONTROLES SUCESIVOS SE OBSERVÃ“ ENGROSAMIENTO DEL FENOTIPO Y AUMENTO DEL TEJIDO QUERATINIZADO. LA PACIENTE REFIRIÃ“ DISMINUCIÃ“N DE LA HIPERSENSIBILIDAD A ESTÃ□MULOS TÃ‰RMICOS Y TÃ□CTILES, CON MEJOR TOLERANCIA AL CEPILLADO. DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTÃ‰TICO, SE EVIDENCIÃ“ UNA MEJORA TANTO DE LA ESTÃ‰TICA ROSA (COLOR, TEXTURA Y ARQUITECTURA PAPILAR PRESERVADA).EL SITIO DONADOR PALATINO CICATRIZÃ“ ADECUADAMENTE, SIN SANGRADO TARDÃ□O Y CON DOLOR CONTROLADO POR ANALGÃ‰SICOS CONVENCIONALES. EN CONJUNTO, EL ABORDAJE TCAF + ITCS, APLICADO SOBRE SUPERFICIES RESTAURADAS SEGÃšN MCR, PROPORCIONÃ“ COBERTURA RADICULAR ESTABLE, MEJORA DEL FENOTIPO Y ALIVIO SINTOMÃ□TICO, CUMPLIENDO LOS OBJETIVOS CLÃ□NICOS Y ESTÃ‰TICOS PREVISTOS Y ELEVANDO LA SATISFACCIÃ“N Y EL CONFORT FUNCIONAL DE LA PACIENTE.

CONCLUSIONES:

LA INTEGRACIÃ“N RESTAURADORAâ€“PERIODONTAL GUIADA POR EL MCR DEMOSTRÃ“ SER UNA ESTRATEGIA PREDECIBLE Y ESTÃ‰TICAMENTE FAVORABLE PARA EL MANEJO DE LCNC TIPO 3 ASOCIADAS A RECESIONES RT1.

EL EMPLEO DE LA TÃ‰CNICA TCAF JUNTO CON LA RESTAURACIÃ“N PREVIA DE LCNC PERMITIÃ“ OBTENER RESULTADOS FAVORABLES LOGRANDO COBERTURA RADICULAR COMPLETA, AUMENTO DEL GROSOR GINGIVAL Y UNA ADECUADA ESTABILIDAD DEL INJERTO, SIN EVIDENCIA DE RECIDIVAS NI INFLAMACIÃ“N DURANTE EL SEGUIMIENTO.

ESTE ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO, QUE COMBINA PERIODONCIA Y ODONTOLOGÃ□A RESTAURADORA, PROPORCIONÃ“ UNA SOLUCIÃ“N INTEGRAL AL CASO, FAVORECIENDO LA FUNCIÃ“N Y LA ESTÃ‰TICA PERIODONTAL. FINALMENTE, EL Ã XITO CLÃ□NICO DEPENDE DE LA ELIMINACIÃ“N DE FACTORES ETIOLÃ“GICOS Y

Bibliografía *

1.ALLEGRI MA, LANDI L, ZUCCHELLI G. NON-CARIOUS CERVICAL LESIONS ASSOCIATED WITH MULTIPLE GINGIVAL RECESSIONS IN THE MAXILLARY ARCH: A RESTORATIVE-PERIODONTAL EFFORT FOR ESTHETIC SUCCESS. A 12-MONTH CASE REPORT. EUR J ESTHET DENT. 2010;5(1):10-27

2.BARTLETT DW, SHAH P. A CRITICAL REVIEW OF NON-CARIOUS CERVICAL (WEAR) LESIONS AND THE ROLE OF ABFRACTION, EROSION, AND ABRASION. J DENT RES. 2006;85(4):306-12.

3.CAIRO F, NIERI M, CINCINELLI S, MERVELT J, PAGLIARO U. THE INTERPROXIMAL CLINICAL ATTACHMENT LEVEL TO CLASSIFY GINGIVAL RECESSIONS AND PREDICT ROOT COVERAGE OUTCOMES: AN EXPLORATIVE AND RELIABILITY STUDY. J CLIN PERIODONTOL. 2011;38:661â€“666.

4.BAROOTCHI S, TAVELLI L. TUNNELED CORONALLY ADVANCED FLAP FOR THE TREATMENT OF ISOLATED GINGIVAL RECESSIONS WITH DEFICIENT PAPILLA. INT J ESTHET DENT. 2022;17(1):14-26.

5.ZUCCHELLI G, GORI G, MELE M, STEFANINI M, MAZZOTTI C, MARZADORI M, ET AL. NON-CARIOUS CERVICAL LESIONS ASSOCIATED WITH GINGIVAL RECESSIONS: A DECISION-MAKING PROCESS. J PERIODONTOL. 2011;82(12):1713â€“1724

Título del trabajo *

RECUBRIMIENTO RADICULAR CON TÃ‰CNICA T-CAF

Nombre del Autor (a/es)*

SALVADOR BAÃ‘UELOS FLORES

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

DCF MARTHA MARGARITA AGUADO ARZOLA, DCF MARIA DE LOS ANGELES PIETSCHMANN SANTAMARIA, MCO GILBERTO ZATARAIN HERNANDEZ, MCO MARCO ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ, , , , , .

Correo Electrónico *

salvadorbaf@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA UNIDAD TORREON

Introducción y Objetivos *

LA CIRUGÃ A MUCOGINGIVAL IMPLICA PROCEDIMIENTOS PARA LA CORRECCIÃ“N DE DEFECTOS EN LA MORFOLOGÃ A, POSICIÃ“N Y/O CANTIDAD DE TEJIDO BLANDO Y SOPORTE Ã“SEO SUBYACENTE ALREDEDOR DE LOS DIENTES E IMPLANTES, INTRODUCIDA POR FRIEDMAN (1957) (1)

LA RECESIÃ“N GINGIVAL ES UN DESPLAZAMIENTO APICAL DEL MARGEN GINGIVAL CON EXPOSICIÃ“N DE LA SUPERFICIE RADICULAR A LA CAVIDAD ORAL, PUEDE ESTAR ASOCIADA CON LA POSICIÃ“N DE LOS DIENTES EN EL ARCO, SI ESTOS ERUPCIONAN CERCA DE LA LÃ NEA MUCOGINGIVAL PUEDE HABER MUY POCO O NULO TEJIDO QUERATINIZADO LABIALMENTE Y PUEDE OCURRIR UNA RECESIÃ“N LOCALIZADA, UN FACTOR ETIOLÃ“GICO QUE PUEDE ESTAR ASOCIADO CON LA RECESIÃ“N GINGIVAL ES UNA FALTA PREEXISTENTE DE HUESO BUCAL ALVEOLAR EN EL SITIO. (2,3)

LA PRESERVACIÃ“N DE LA INTEGRIDAD DE UNA PAPILA QUE PRESENTA UNA PÃ‰RDIDA DE INSERCIÃ“N SIGNIFICATIVA O QUE TIENE DIMENSIONES ESTRECHAS/POCO PROFUNDAS TIENE COMO OBJETIVO PREVENIR EL DESPRENDIMIENTO DEL COLGAJO EN ESA REGIÃ“N. DE HECHO, UNA PAPILA ESTRECHA/POCO PROFUNDA PUEDE NO PROPORCIONAR UN BUEN LECHO RECEPTOR PARA LA SUPERVIVENCIA DE UN CORONALLY ADVANCED FLAP (CAF). (1,4)

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINA DE 49 AÃ‘OS, ACUDE A LA FACULTAD DE ODONTOLOGÃ A UADEC A LA CLÃ NICA DE LA MAESTRÃ A DE PERIODONCIA, A LA EXPLORACIÃ“N CLÃ NICA SE OBSERVA LA PRESENCIA DE RECESIONES GINGIVALES RT1 Y RT2 EN ZONA DE CUADRANTE 1. LA PRIMERA FASE DEL TRATAMIENTO CONSTITUYÃ“ EN LA FASE HIGIÃ‰NICA, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE COBERTURA RADICULAR. POR LO TANTO, SE REALIZA LA PLANIFICACIÃ“N DE COBERTURA RADICULAR CON LA TÃ‰CNICA TUNELLED CORONALLY ADVANCED FLAP (T-CAF) CON INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO. SE COMENZÃ“ ANESTESIANDO LOCALMENTE UTILIZANDO LIDOCAÃ NA CON EPINEFRINA (1:100,000), SE PROCEDE A REALIZAR EL DISEÃ‘O DEL COLGAJO, EN DONDE SE TOMA COMO REFERENCIA EL CANINO PARA GUIAR LAS INCISIONES, SE REALIZAN LAS INCISIONES DE MANERA PARCIAL-TOTAL-PARCIAL PARA ELEVAR EL COLGAJO MUCOPERIÃ“STICO. POSTERIORMENTE A TENER EL COLGAJO LIBRE DE TENSIÃ“N, SE PROCEDE A DESEPTIELIZAR LAS PAPILAS, SE OBTUVO UN INJERTO DE LA ZONA DEL PALADAR EN BLOQUE, QUE SE DESEPITELIZÃ“ EXTRA ORALMENTE CON UNAS MEDIDAS DE 5 X 20 MM Y 1.5 MM DE GROSOR Y SE RETIRÃ“ TEJIDO ADIPOSO. SE PROCEDIÃ“ A FIJAR EL INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO EN LA ZONA RECEPTORA CON PUNTOS SIMPLES CON VICRYL 5-0, POSTERIORMENTE SE REALIZARON PUNTOS SUSPENSORIOS PARA SUTURAR EL COLGAJO CON NYLON 5-0. SE DIERON INDICACIONES POSTOPERATORIAS Y FARMACOLÃ“GICAS AL PACIENTE.

Resultados y Conclusiones *

EL OBJETIVO DE ESTOS PROCEDIMIENTOS ES LOGRAR UNA COBERTURA RADICULAR COMPLETA DEL DEFECTO DE LA RECESIÃ“N CON UNA BUENA APARIENCIA RELACIONADA CON LOS TEJIDOS BLANDOS ADYACENTES Y UNA PROFUNDIDAD DE SONDAJE MÃ NIMA DESPUÃ‰S DE LA CICATRIZACIÃ“N. LA TÃ‰CNICA DE T-CAF HA DEMOSTRADO SER UNA TÃ‰CNICA EFECTIVA PARA LA COBERTURA RADICULAR COMO SE OBSERVA EN LOS RESULTADOS A PARTIR DE 2 SEMANAS DE CICATRIZACIÃ“N

SE OBTUVO UNA COBERTURA RADICULAR AL 90 %, LOS RESULTADOS CLÃ NICOS FUERON EXCELENTES, HUBO UN AUMENTO DEL TEJIDO QUERATINIZADO Y EN CUANTO A LA ESTÃ‰TICA TAMBIÃ‰N SE OBTUVIERON EXCELENTES RESULTADOS.

EL ENFOQUE RECIENTEMENTE INTRODUCIDO PUEDE TENER EL POTENCIAL DE MEJORAR EL SUMINISTRO DE SANGRE DEL COLGAJO Y LA VASCULARIZACIÃ“N DEL INJERTO, Y MEJORAR LOS RESULTADOS CLÃ NICOS, ESTÃ‰TICOS EN COMPARACIÃ“N CON LAS TÃ‰CNICAS QUIRÃšRGICAS CONVENCIONALES.

POR OTRO LADO, SE HA SUGERIDO QUE LA TÃ‰CNICA DE TÃšNEL (TUN) ES MENOS INVASIVA QUE PUEDE MEJORAR EL SUMINISTRO DE SANGRE DEL INJERTO Y DEL COLGAJO, ASÃ COMO LOS RESULTADOS ESTÃ‰TICOS, AL TIEMPO QUE REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LA MORBILIDAD DEL PACIENTE. SIN EMBARGO, LAS LIMITACIONES DE LA TUN TAMBIÃ‰N PUEDEN INCLUIR UN ACCESO REDUCIDO Y UNA ESTABILIZACIÃ“N LIMITADA DEL INJERTO, EN COMPARACIÃ“N CON LA CAF. DEBIDO A ESTO LA COMBINACIÃ“N DE AMBAS TÃ‰CNICAS NOS AYUDA A TENER UN BUEN DISEÃ‘O DEL COLGAJO Y QUE SEA MAS PREDECIBLE A LA HORA DE REALIZAR LA TÃ‰CNICA, PARA QUE EL COLGAJO Y EL INJERTO TENGAN LA SUFICIENTE VASCULARIZACIÃ“N Y SE MEJOREN LOS RESULTADOS CLÃ NICOS.

?

Bibliografía *

ZUCCHELLI, G., & MOUNSSIF, I. (2015). PERIODONTAL PLASTIC SURGERY. PERIODONTOLOGY 2000, 68(1), 333â€“368. DOI:10.1111/PRD.12059

CAIRO F. PERIODONTAL PLASTIC SURGERY OF GINGIVAL RECESSIONS AT SINGLE AND MULTIPLE TEETH. PERIODONTOL 2000. 2017;75(1):296â€“316

CORTELLINI P, BISSADA NF. MUCOGINGIVAL CONDITIONS IN THE NATURAL DENTITION: NARRATIVE REVIEW, CASE DEFINITIONS, AND DIAGNOSTIC CONSIDERATIONS. J PERIODONTOL. 2018;89(SUPPL 1):S204â€“S213.

BAROOTCHI, S., & TAVELLI, L. (2022). TUNNELED CORONALLY ADVANCED FLAP FOR THE TREATMENT OF ISOLATED GINGIVAL RECESSIONS WITH DEFICIENT PAPILLA. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ESTHETIC DENTISTRY, 17(1), 14â€“26.

Título del trabajo *

REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA EN DEFECTO CLASE I DE SEIBERT CON SAUSAGE TECHNIQUE

Nombre del Autor (a/es)*

M.C.D. Judith Andrea PiÃ±era PÃ©rez

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

L.O.E.P. Olga MarÃ-a MartÃ-nez Bernal, , L.O.E.P. Elizabeth de la Luz Aguilar, , , , , , .

Correo Electrónico *

dra.andreapinera@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD QUETZALCÃ“ATL EN IRAPUATO

Introducción y Objetivos *

LA REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA ES UN PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO EL CUAL AUMENTA EL VOLUMEN Ã“SEO ALVEOLAR EN SITIOS DONDE LA ARQUITECTURA Ã“SEA SE HA COMPROMETIDO COMO CONSECUENCIA DE LA PÃ‰RDIDA DE Ã“RGANOS DENTARIOS PARA LA COLOCACIÃ“N TARDÃ□A DE IMPLANTES DENTALES. LA ROG HA DEMOSTRADO SER UNA ALTERNATIVA PREDECIBLE PARA RECUPERAR VOLUMEN, SIEMPRE QUE SE OBTENGA EL CIERRE PRIMARIO DE LA HERIDA, ANGIOGÃ‰NESIS, CREACIÃ“N Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO Y LA ESTABILIDAD DEL COAGULO.

LA PÃ‰RDIDA DENTARIA EN EL SECTOR ANTERIOR SUELE ACOMPAÃ‘ARSE DE REABSORCIÃ“N DEL REBORDE ALVEOLAR, CON PREDOMINIO HORIZONTAL (CLASE I DE SEIBERT). ESTE COLAPSO COMPROMETE EL ESPACIO PARA UN IMPLANTE DE DIÃ□METRO ESTÃ□NDAR, ALTERA EL PERFIL DE EMERGENCIA Y DIFICULTA RESULTADOS ESTÃ‰TICOS ESTABLES.

LA SAUSAGE TECHNIQUE, DESCRITA POR EL DR. ISTVAN URBAN, ENFATIZA LA CONTENCIÃ“N TRIDIMENSIONAL DEL INJERTO PARTICULADO MEDIANTE UNA MEMBRANA DE COLÃ□GENO TENSADA Y FIJADA CON TACHUELAS, GENERANDO UN â€œEFECTO SALCHICHAâ€□ QUE MANTIENE EL MATERIAL EN POSICIÃ“N Y RESISTE LAS FUERZAS DE LOS TEJIDOS BLANDOS DURANTE LA CICATRIZACIÃ“N. PROPUSO FIJAR LAS MEMBRANAS REABSORBIBLES CON TACHUELAS PARA LOGRAR UNA MAYOR ESTABILIDAD DEL MATERIAL INJERTADO Y AUMENTAR LA ESTABILIDAD DEL VOLUMEN. ESTA TÃ‰CNICA NO REQUIERE UN SEGUNDO TIEMPO QUIRÃšRGICO PARA RETIRAR LA MEMBRANA NI LAS TACHUELAS, Y SE ASOCIA A UNA MENOR TASA DE COMPLICACIONES. SARAVANAN Y COLS. EVALUARON LA TÃ‰CNICA URBAN, OBTUVO UNA GANANCIA Ã“SEA DE 3,9 MM?5,6 MM. SE REPORTAN TASAS DE Ã‰XITO ALTAS EN LA LITERATURA, ENTRE EL 85% Y EL 95% PARA PROCEDIMIENTOS BIEN EJECUTADOS EN CONDICIONES FAVORABLES.

OBJETIVOS:

â€¢ PRESENTAR UN CASO CLÃ□NICO DE REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA EN UN DEFECTO CLASE I DE SEIBERT EMPLEANDO LA TÃ‰CNICA SAUSAGE TECHNIQUE.

â€¢ DESCRIBIR LA TÃ‰CNICA SAUSAGE TECHNIQUE COMO OPCIÃ“N PREDECIBLE PARA AUMENTAR EL VOLUMEN Ã“SEO HORIZONTAL PREVIO A LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES.

â€¢ MOSTRAR EL MANEJO QUIRÃšRGICO DE DEFECTOS HORIZONTALES EN ZONA ESTÃ‰TICA MEDIANTE ROG CON MEMBRANA REABSORBIBLE DE COLÃ□GENO.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINO DE 52 AÃ‘OS, ASA II PADECE HIPOTIROIDISMO CONTROLADO CON LEVOTIROXINA 100 MG VO CADA 24 HORAS, CON ANTECEDENTE DE PÃ‰RDIDA DENTARIA 11 Y 12 Y COLAPSO VESTIBULAR DEL REBORDE Y COMPROMISO ESTÃ‰TICO. A LA EXPLORACIÃ“N SE OBSERVÃ“ REBORDE ATRÃ“FICO CON DISMINUCIÃ“N DEL ESPESOR HORIZONTAL Y MUCOSA QUERATINIZADA CONSERVADA. EN EL ANÃ□LISIS TOMOGRÃ□FICO SE CONFIRMÃ“ DEFECTO HORIZONTAL CLASE I DE SEIBERT, CON PÃ‰RDIDA DE CORTICAL VESTIBULAR. NO SE IDENTIFICARON HÃ□BITOS PARAFUNCIONALES, NI TABAQUISMO QUE AFECTEN EL PROCEDIMIENTO. SE OPTÃ“ POR ROG CON TÃ‰CNICA SAUSAGE POR SU MENOR MORBILIDAD Y ADECUADA EVIDENCIA CLÃ□NICA DE GANANCIA VOLUMÃ‰TRICA.

PROCEDIMIENTOS

BAJO ANESTESIA LOCAL, SE REALIZÃ“ UN COLGAJO TRAPEZOIDAL A ESPESOR TOTAL, ENSEGUIDA SE REALIZÃ“ EL DESBRIDAMIENTO DEL TEJIDO REMANENTE A LA EXODOCIA DEL OD 11. SE REALIZO UNA INCISIÃ“N HORIZONTAL DE LIBERACIÃ“N PERIÃ“STICA SOBRE EL COLGAJO PARA LIBERARLO Y DESPLAZARLO. POSTERIORMENTE SEPARAMOS LAS FIBRAS ELÃ□STICAS CON INSTRUMENTO ROMO Y CON MOVIMIENTOS HACIA CORONAL. SE CONTINUÃ“ CON LA DECORTICACIÃ“N CON FRESA DE BOLA Y PIEZA DE BAJA CON ABUNDANTE IRRIGACIÃ“N PARA FAVORECER LA ANGIOGÃ‰NESIS Y LA INCORPORACIÃ“N DEL INJERTO. SE PREPARÃ“ UN MIX DE INJERTO Ã“SEO PARTICULADO XENÃ“GENO Y ALÃ“GENO 1:1 (MEZCLA QUE COMBINA ESTABILIDAD VOLUMÃ‰TRICA DEL XENOINJERTO Y REMODELACIÃ“N DEL ALOINJERTO). AL PREPARAR LA MEMBRANA REABSORBIBLE DE COLÃ□GENO, SE FIJÃ“ POR PALATINO CON KIT GBR DE HIOSSEN Y TACHUELAS DE TITANIO, UNA EN CADA EXTREMO. POSTERIORMENTE SE COLOCÃ“ EL INJERTO DE MANERA INCREMENTAL, COMPACTÃ□NDOLO SUAVEMENTE PARA OBTENER CONTORNO ARMONIOSO; SE EVITÃ“ LA SOBRE COMPRESIÃ“N QUE PUDIERA COMPROMETER LA REVASCULARIZACIÃ“N. POSTERIORMENTE, SE TRACCIONÃ“ LA MEMBRANA SOBRE EL INJERTO HACIA VESTIBULAR Y SE FIJÃ“ CON DOS TACHUELAS EN CADA EXTREMO, LOGRANDO LA TENSIÃ“N CARACTERÃ□STICA DE LA TÃ‰CNICA QUE ESTABILIZA EL VOLUMEN Y RESISTE LA PRESIÃ“N DEL COLGAJO DURANTE LA CICATRIZACIÃ“N. SE DESPLAZO EL COLGAJO Y SE CORROBORO QUE HUBIERA CIERRE SIN TENSIÃ“N. SE SUTURÃ“ EN PAPILAS CON COLCHONEROS VERTICALES Y COLCHONEROS HORIZONTALES PARA SELLADO HERMÃ‰TICO DE LA INCISIÃ“N CON NYLON 3-0.

SE PROGRAMARON CONTROLES PERIÃ“DICOS PARA VIGILAR INTEGRIDAD DE TEJIDOS Y DETECTAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER EXPOSICIÃ“N O DEHISCENCIA.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS

LA EVOLUCIÃ“N POSTOPERATORIA CURSÃ“ SIN COMPLICACIONES: NO HUBO EXPOSICIÃ“N TEMPRANA DE MEMBRANA NI DEHISCENCIAS, EL EDEMA FUE AUTOLIMITADO Y EL DOLOR CONTROLABLE CON ANALGÃ‰SICOS HABITUALES. A LA PRIMERA SEMANA, SE OBSERVÃ“ CIERRE COMPLETO DEL COLGAJO, MÃ NIMA INFLAMACIÃ“N Y AUSENCIA DE SANGRADO O SIGNOS DE INFECCIÃ“N. A LAS 2 SEMANAS, LA INTEGRACIÃ“N DE LOS TEJIDOS BLANDOS ERA EVIDENTE, CON LÃ NEA DE INCISIÃ“N ESTABLE, COLORACIÃ“N Y CONSISTENCIA DE ENCÃ A ADYACENTE NORMALES. LA ESTABILIDAD VOLUMÃ‰TRICA CLÃ NICA DURANTE TODO EL PERIODO DE CICATRIZACIÃ“N FUE ATRIBUIBLE A LA CONTENCIÃ“N RÃ GIDO-ELÃ STICA DE LA MEMBRANA TENSADA, SU FIJACIÃ“N CON TACHUELAS Y EL CIERRE PRIMARIO SIN TENSIÃ“N, SUMADO A UN ESTRICTO PROTOCOLO DE HIGIENE ORAL.

LA VASCULARIZACIÃ“N DE LOS TEJIDOS BLANDOS Y LA INMOVILIDAD DEL INJERTO FAVORECIERON LA FORMACIÃ“N DE UN COÃ GULO ESTABLE Y LA GENERACIÃ“N DE TEJIDO Ã“SEO DE CALIDAD. NO SE PRESENTARON EVENTOS ADVERSOS RELEVANTES. EL PLAN CLÃ NICO CONTEMPLA LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTE TRAS UN PERIODO DE MADURACIÃ“N Ã“SEA DE HASTA 9 MESES POSTERIOR A LA ROG, ASEGURANDO UN PERFIL DE EMERGENCIA FAVORABLE Y ADECUADO SOPORTE DE ENCÃ A QUERATINIZADA.

CONCLUSIONES

LA REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA (ROG) CON SAUSAGE TECHNIQUE, REALIZADA POR EL DR. URBAN, DEMUESTRA SER UNA ESTRATEGIA PREDECIBLE Y REPRODUCIBLE PARA EL MANEJO DE DEFECTOS HORIZONTALES CLASE I DE SEIBERT, ESPECIALMENTE EN ZONAS ESTÃ‰TICAS. LA TÃ‰CNICA COMBINA PILARES FUNDAMENTALES COMO LA MEMBRANA DE COLÃ GENO, FIJACIÃ“N CON TACHUELAS Y TENSIÃ“N CONTROLADA DEL INJERTO, ELEMENTOS QUE FAVORECEN LA ESTABILIDAD DEL COÃ GULO Y LA FORMACIÃ“N DE TEJIDO Ã“SEO DE CALIDAD.

LOS FACTORES DETERMINANTES DEL Ã‰XITO EN ESTE CASO INCLUYERON: DIAGNÃ“STICO TRIDIMENSIONAL PRECISO, PREPARACIÃ“N DEL LECHO MEDIANTE DECORTICACIÃ“N PARA ESTIMULAR ANGIOGÃ‰NESIS, SELECCIÃ“N DE UNA MEZCLA DE INJERTO PARTICULADO EQUILIBRANDO MANTENIMIENTO VOLUMÃ‰TRICO Y REMODELACIÃ“N, PASIVACIÃ“N DEL COLGAJO PARA LOGRAR CIERRE SIN TENSIÃ“N Y UN PROTOCOLO POSOPERATORIO ESTRICTO QUE

Bibliografía *

â€¢ TONETTI MS, GREENWELL H, KORNMAN KS. STAGING AND GRADING OF PERIODONTITIS: FRAMEWORK AND PROPOSAL OF A NEW CLASSIFICATION AND CASE DEFINITION. J PERIODONTOL. 2018 JUN;89 SUPPL 1:S159-S172. DOI: 10.1002/JPER.18-0006. ERRATUM IN: J PERIODONTOL. 2018 DEC;89(12):1475. PMID: 29926952.

â€¢ MCGUIRE MK, NUNN ME. PROGNOSIS VERSUS ACTUAL OUTCOME. II. THE EFFECTIVENESS OF CLINICAL PARAMETERS IN DEVELOPING AN ACCURATE PROGNOSIS. J PERIODONTOL. 1996 JUL;67(7):658-65. DOI: 10.1902/JOP.1996.67.7.658. PMID: 8832476.

â€¢ REN, Y., FAN, L., ALKILDANI, S., LIU, L., EMMERT, S., NAJMAN, S., RIMASHEVSKIY, D., SCHNETTLER, R., JUNG, O., XIONG, X., & OTROS. (2022). BARRIER MEMBRANES FOR GUIDED BONE REGENERATION (GBR): A FOCUS ON RECENT ADVANCES IN COLLAGEN MEMBRANES. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 23, 14987. HTTPS://DOI.ORG/10.3390/IJMS232314987

â€¢ BENIC, G. I., & HÃ„MMERLE, C. H. (2014). HORIZONTAL BONE AUGMENTATION BY MEANS OF GUIDED BONE REGENERATION. PERIODONTOL 2000, 66(1), 13-40. DOI: 10.1111/PRD.12039

â€¢ N.: SÃ NCHEZ-LABRADOR. L.: GF TRESGUERRES. F.: MARTÃ NEZGONZÃ LEZ. J.M.: MENIZ-GARCÃ A. C.

Título del trabajo *

MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS EN RTG CON COLGAJO DE PRESERVACIÃ“N DE PAPILA: REPORTE DE CASO

Nombre del Autor (a/es)*

C.D Robles LÃ¡zaro Mario Alberto

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

M en C Claudia Berenice Tinoco Cabral, Dra. en C Vianeth MartÃ-nez Rodriguez, C.D.E.P Moreno Ãlvarez Sandra Carolina, Dra. en C. Soto ChÃ¡vez Alma Alicia, , , , , .

Correo Electrónico *

mario.robles8403@alumnos.udg.mx

Institución *

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Introducción y Objetivos *

EL MANEJO ADECUADO DE LOS TEJIDOS BLANDOS ES FUNDAMENTAL EN EL Ã‰XITO DE LA REGENERACIÃ“N TISULAR GUIADA (RTG). EL COLGAJO DE PRESERVACIÃ“N DE PAPILA SE HA PROPUESTO COMO UNA TÃ‰CNICA EFICAZ PARA MANTENER LA ARQUITECTURA GINGIVAL, MINIMIZAR LA RECESIÃ“N Y MEJORAR LA CICATRIZACIÃ“N POSOPERATORIA. ESTA TÃ‰CNICA PERMITE UN CIERRE PRIMARIO ESTABLE, LO CUAL ES CRUCIAL PARA PROTEGER EL COÃ□GULO Y FAVORECER LA REGENERACIÃ“N PERIODONTAL. (1)

EXISTE SUFICIENTE EVIDENCIA BIBLIOGRÃ□FICA QUE REPORTA MEJORES RESULTADOS CON LA TERAPIA PERIODONTAL REGENERATIVA SOBRE OTRAS TÃ‰CNICAS DE REDUCCIÃ“N DE BOLSAS CONVENCIONALES. (3)

EL OBJETIVO DE ESTE CARTEL ES PRESENTAR UN CASO CLÃ□NICO DONDE SE EMPLEÃ“ LA TÃ‰CNICA DE COLGAJO DE PRESERVACIÃ“N DE PAPILA MODIFICADO PARA EFECTUAR UNA REGENERACIÃ“N TISULAR GUIADA CON RESULTADOS CLÃ□NICOS Y ESTÃ‰TICOS FAVORABLES. EL PROCEDIMIENTO SE EFECTUÃ“ A PARTIR DE UN DIAGNÃ“STICO PRECISO, INTEGRANDO EL CONCEPTO DE MÃ□NIMA INVASIÃ“N, LO QUE PERMITIÃ“ LOGRAR UNA ADECUADA CONTENCIÃ“N, ESTABILIDAD Y CIERRE PRIMARIO DE LA HERIDA.

Descripción del Caso *

SE PRESENTA EL CASO DE UNA PACIENTE FEMENINA DE 49 AÃ‘OS, CLASIFICADA COMO ASA I, QUE ACUDIÃ“ A LA CLÃ NICA DE LA ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA REFIRIENDO â€œINFECCIÃ“N EN LA ENCÃ Aâ€ . EL EXAMEN CLÃ NICO INTRAORAL PRESENTÃ“ MÃšLTIPLES SITIOS CON AUMENTO EN LA PROFUNDIDAD AL SONDEO Y PÃ‰RDIDA DE INSERCIÃ“N CLÃ NICA. LA CORRELACIÃ“N DE ESTOS HALLAZGOS CON LA EVALUACIÃ“N RADIOGRÃ FICA Y TOMOGRÃ FICA PERMITIÃ“ ESTABLECER EL DIAGNÃ“STICO DE PERIODONTITIS ESTADIO III LOCALIZADA, GRADO C ASÃ COMO LA PRESENCIA DE UN DEFECTO INFRAÃ“SEO DE UNA PARED EN LA ZONA MESIAL DEL OD 16 CLASIFICADO SEGÃšN LOS CRITERIOS DE NIBALI Y CORTELLINI (2024) (3)

EL PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO REALIZADO FUE UNA MODIFICACIÃ“N DE LA TÃ‰CNICA DE PRESERVACIÃ“N DE PAPILA DESCRITA POR CORTELLINI ET AL. EN 1995. (5) BAJO ANESTESIA LOCAL DE MEPIVACAINA 2% CON EPINEFRINA 1:100,000, SE REALIZARON INCISIONES INTRASULCULARES EN DIENTES ADYACENTES AL DEFECTO Y SE REALIZÃ“ UNA INCISIÃ“N HORIZONTAL EN LA CARA BUCAL A NIVEL DEL Ã NGULO LÃ NEA DE LA ZONA INTERDENTAL DE LOS DIENTES 15 Y 16; POSTERIORMENTE SE ELEVÃ“ UN COLGAJO DE ESPESOR TOTAL HACIA PALATINO CONSERVANDO LA INTEGRIDAD DE LA PAPILA;4 EL DEFECTO SE DESBRIDÃ“ MEDIANTE ULTRASONIDO, RASPADO Y ALISADO RADICULAR; UNA VEZ EXPUESTA LA SUPERFICIE RADICULAR DEL DIENTE 16, ESTA FUE ACONDICIONADA MEDIANTE LA APLICACIÃ“N EN GEL DE EDTA AL 24% DURANTE 2 MIN PARA ELIMINAR EL BARRIDO DENTINARIO, SE ENJUAGÃ“ CON SOLUCIÃ“N SALINA Y SE APLICÃ“ UNA COMBINACIÃ“N DE SUSTITUTO Ã“SEO DESPROTEINIZADO DE ORIGEN BOVINO, ALOINJERTO Y EMDOGAIN CUIDANDO DE NO SOBRELLENAR EL DEFECTO Y PREVINIENDO A SU VEZ LA CONTAMINACIÃ“N, PARA FINALIZAR, SE REPOSICIONÃ“ EL COLGAJO Y SE SUTURÃ“ MEDIANTE PUNTOS SIMPLES CON NYLON 6-0 PARA LOGRAR EL CIERRE PRIMARIO.

Resultados y Conclusiones *

LA CIRUGÃ A MÃNIMAMENTE INVASIVA DE PRESERVACIÃ“N DE PAPILA FUE DISEÃ‘ADA Y MODIFICADA PARA OBTENER UN ACCESO Ã“PTIMO AL DEFECTO, LIMITANDO SU EXTENSIÃ“N Y PRESERVANDO ASÃ LA ESTABILIDAD (4), ESTOS PRINCIPIOS FACILITAN EL CIERRE PRIMARIO PREVINIENDO LA CONTAMINACIÃ“N DEL SITIO Y FAVORECEN LA PERMANENCIA DEL COAGULO SANGUÃNEO SOBRE LOS BIOMATERIALES, POTENCIANDO LA REGENERACIÃ“N; EL Ã‰XITO DEL TRATAMIENTO PERIODONTAL REGENERATIVO DEPENDE ADEMÃS DE UNA ADECUADA SELECCIÃ“N DEL CASO, EL CONTROL DE FACTORES LOCALES Y LA CORRECTA EJECUCIÃ“N DE LA TÃ‰CNICA QUIRÃšRGICA.

Bibliografía *

1.CORTELLINI, P., & TONETTI, M. S. (2007). A MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TECHNIQUE WITH AN ENAMEL MATRIX DERIVATIVE IN THE REGENERATIVE TREATMENT OF INTRA-BONY DEFECTS: A NOVEL APPROACH TO LIMIT MORBIDITY.JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, 34(1), 87â€“93.

2.ASLAN S, BUDUNELI N, CORTELLINI P. ENTIRE PAPILLA PRESERVATION TECHNIQUE: A NOVEL SURGICAL APPROACH FOR REGENERATIVE TREATMENT OF DEEP AND WIDE INTRABONY DEFECTS. INT J PERIODONTICS RESTORATIVE DENT. 2017 MAR/APR;37(2):227-233. DOI: 10.11607/PRD.2584. PMID: 28196163.

3.NIBALI L, CORTELLINI P. PERIODONTAL OSSEOUS DEFECTS: A TREATMENT-ORIENTED CLASSIFICATION TO GUIDE REGENERATIVE TREATMENT PLANNING. INT J PERIODONTICS RESTORATIVE DENT. 2025 APR 25;45(3):301-315. DOI:10.11607/PRD.7125. PMID: 39058949.

Título del trabajo *

IMPLANTES INMEDIATOS FLAPLESS CON PROVISIONALIZACIÃ“N INMEDIATA Y MANEJO DE ERUPCIÃ“N PASIVA EN ZONA ESTÃ‰TICA: REPORTE DE CASO CLÃ NICO.

Nombre del Autor (a/es)*

NarvÃ¡ez Salazar Itzel AnahÃ-

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

GÃ³mez Thomas David, , , , , , , , .

Correo Electrónico *

itzns94@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD AME

Introducción y Objetivos *

LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES INMEDIATOS CON PROVISIONALIZACIÃ“N INMEDIATA EN LA ZONA DEL MAXILAR REPRESENTA UNA OPCIÃ“N PREDECIBLE Y ESTÃ‰TICA, ESPECIALMENTE CUANDO SE REALIZA UNA PLANEACIÃ“N DIGITAL PRECISA.LA EVALUACIÃ“N TRIDIMENSIONAL DE LA POSICIÃ“N SAGITAL RADICULAR, SEGÃšN LA CLASIFICACIÃ“N DE KAN, PERMITE IDENTIFICAR LOS CASOS CANDIDATOS IDEALES PARA ESTE ABORDAJE. UNA ARQUITECTURA GINGIVAL ARMÃ“NICA ES FUNDAMENTAL PARA LOGRAR RESULTADOS ESTÃ‰TICOS ESTABLES A LARGO PLAZO, PARTICULARMENTE EN LA ZONA ANTERIOR. ALTERACIONES COMO LA ERUPCIÃ“N PASIVA ALTERADA PUEDEN COMPROMETER LA SIMETRÃ□A DE LOS MÃ□RGENES GINGIVALES, AFECTANDO NEGATIVAMENTE EL RESULTADO FINAL. POR ELLO, SU DIAGNÃ“STICO Y TRATAMIENTO DEBEN CONSIDERARSE COMO PARTE INTEGRAL DEL PLAN TERAPÃ‰UTICO. EL USO DE PROVISIONALES INMEDIATOS, ESPECIALMENTE CUANDO ESTÃ□N BIEN ADAPTADOS Y DISEÃ‘ADOS DIGITALMENTE, NO SOLO CONTRIBUYE A LA ESTÃ‰TICA INICIAL DEL TRATAMIENTO, SINO QUE TAMBIÃ‰N FAVORECE LA CONFORMACIÃ“N Y ESTABILIZACIÃ“N DE LOS TEJIDOS BLANDOS PERIIMPLANTARIOS. EN PARTICULAR, ESTOS PROVISIONALES JUEGAN UN PAPEL CLAVE EN LA PRESERVACIÃ“N Y MODELADO DEL MARGEN GINGIVAL, ASÃ□ COMO DE LAS PAPILAS INTERDENTALES, LAS CUALES JUEGAN UN PAPEL PRIMORDIAL PARA MANTENER UNA SONRISA ARMÃ“NICA E IDEAL SOBRE TODO CUANDO LOS REQUERIMIENTOS ESTÃ‰TICOS SON ALTOS.

ACTUALMENTE EVIDENCIA CIENTÃ□FICA RESPALDA EL Ã‰XITO A LARGO PLAZO DE LA PROVISIONALIZACIÃ“N INMEDIATA EN CONJUNTO CON TÃ‰CNICAS REGENERATIVAS Y DE PLÃ□STICA PERIODONTAL PARA LA PRESERVACIÃ“N, MANTENIMIENTO Y MODELADO DE LA ARQUITECTURA GINGIVAL DURANTE EL PROCESO DE CICATRIZACIÃ“N. EN ESTE SENTIDO UNO DE LOS ASPECTOS MAS IMPORTANTES DE ESTA TÃ‰CNICA ES QUE POR MEDIO DE EL MANEJO DE TEJIDOS, PODEMOS REALIZAR MODIFICACIONES DURANTE EL PROCESO DE CICATRIZACIÃ“N DANDO COMO RESULTADO UNA ARQUITECTURA GINGIVAL ESTÃ‰TICAMENTE SATISFACTORIA PARA RECIBIR LAS RESTAURACIONES DEFINITIVAS.

OBJETIVO: PRESENTAR UN CASO CLÃ□NICO DE REHABILITACIÃ“N EN ZONA ESTÃ‰TICA MEDIANTE IMPLANTES INMEDIATOS Y PROVISIONALES DIGITALES EN UN PACIENTE FUMADOR, INCORPORANDO MANEJO GINGIVAL COMPLEMENTARIO PARA CORREGIR ERUPCIÃ“N PASIVA ALTERADA Y TÃ‰CNICA DE PRESERVACIÃ“N DE PROCESO PARA OPTIMIZAR LOS CONTORNOS GINGIVALES.

Descripción del Caso *

PACIENTE MASCULINO DE 34 AÃ‘OS DE EDAD, ASA II, CON DIAGNÃ“STICO DE GINGIVITIS ASOCIADA A BIOPELÃ□CULA. SE PRESENTÃ“ AL DEPARTAMENTO DE PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÃ□A DE LA UNIVERSIDAD AYUDA MUTUA ESENCIAL (AME), REFERIDO DEL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÃ□A RESTAURADORA, CON SOLICITUD DE EXTRACCIÃ“N DE LOS Ã“RGANOS DENTARIOS 12, 11 Y 21 , LOS CUALES PRESENTABAN RESTAURACIONES FILTRADAS E IRREPARABLES.

A LA EXPLORACIÃ“N EXTRAORAL NO SE OBSERVÃ“ NINGÃšN SIGNO PATOLÃ“GICO POR LO QUE SE PROCEDIÃ“ A LA EXPLORACIÃ“N INTRAORAL. EN LA EXPLORACIÃ“N PERIODONTAL PRESENTÃ“ PROFUNDIDADES DE 2 A 4 MM Y ZONAS DE SANGRADO LOCALIZADAS, MIENTRAS QUE EN EL EXÃ□MEN RADIOGRÃ□FICO NO SE OBSERVO PERDIDA DE CONTINUIDAD EN LA LÃ□MINA DURA POR LO QUE SE CLASIFICÃ“ COMO GINGIVITIS INDUCIDA POR BIOPELÃ□CULA. SE EVIDENCIÃ“ UNA PROTUBERANCIA MUCOSA EN EL Ã“RGANO 1.1, RELACIONADA A UN TRATAMIENTO DE CONDUCTOS PREVIO Y SE IDENTIFICÃ“ UN FENOTIPO PERIODONTAL DELGADO.

EN EL ESTUDIO HISTOTOMOGRÃ□FICO SE CONSTATO UN TRABECULADO Ã“SEO TIPO III, PRESENTÃ“ UN ALVEOLO TIPO I DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÃ“N DE KAN EN ALVEOLOS DE Ã“RGANOS DENTARIOS 11 Y 21, MIENTRAS UN TIPO IV EN Ã□REA DEL Ã“RGANO 22, ADEMÃ□S, SE IDENTIFICÃ“ ERUPCIÃ“N PASIVA ALTERADA TIPO 1 SUBTIPO B POR LO QUE SE INDICÃ“ UN RECONTORNEO GINGIVAL PARA LA ARMONIZACIÃ“N DE LOS CONTORNOS.

EL TRATAMIENTO SE INICIÃ“ CON LA ADMINISTRACIÃ“N DE ANESTESIA AL 4% MEDIANTE TÃ‰CNICA SUPRAPERIÃ“STICA. SE PROCEDIÃ“ A UN RECONTORNEO ESTÃ‰TICO EN LAS PIEZAS 14, 12, 11, 22, 23 Y 24, UTILIZANDO INCISIONES A BISEL INTERNO Y UNA TÃ‰CNICA FLAPLESS PARA OPTIMIZAR LA ESTÃ‰TICA Y MINIMIZAR EL TRAUMA QUIRÃšRGICO.SE REALIZARON EXODONCIAS SIMPLES DE LOS DIENTES 12, 11 Y 2.1, CONFIRMANDO LA INTEGRIDAD DE SUS ALVÃ‰OLOS. PARA LA COLOCACIÃ“N DE LOS IMPLANTES, SE UTILIZÃ“ UNA GUÃ□A QUIRÃšRGICA IMPRESA QUE PERMITIÃ“ LA INSERCIÃ“N PRECISA DE IMPLANTES JD EVOLUTION DE 3.7 Ã— 11 MM, EN Ã□REA DE Ã“RGANOS DENTARIOS 1.1 Y 2.1, RESPETANDO EL PROTOCOLO DEL FABRICANTE. LOS ESPACIOS ENTRE IMPLANTE Y CORTICAL VESTIBULAR FUERON RELLENADOS CON SUSTITUTO Ã“SEO INTEROSS, ASÃ□ COMO ALVEOLO DE Ã“RGANO DENTARIO 1.2. LA ESTABILIDAD PRIMARIA DE LOS IMPLANTES ALCANZÃ“ LOS 35 NCM, LO QUE PERMITIÃ“ LA COLOCACIÃ“N INMEDIATA DE PROVISIONALES DE PMMA, LOGRANDO UNA RESTAURACIÃ“N ESTÃ‰TICA Y FUNCIONAL EN UNA SOLA SESIÃ“N.

Resultados y Conclusiones *

TRAS LA CIRUGÃ A, SE OBSERVÃ“ UNA ADECUADA CICATRIZACIÃ“N DE LOS TEJIDOS BLANDOS, SIN PRESENCIA DE COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS. LA ESTABILIDAD PRIMARIA DE LOS IMPLANTES (35 NCM) PERMITIÃ“ EL Ã‰XITO EN LA PROVISIONALIZACIÃ“N INMEDIATA SIN CARGA. LOS PROVISIONALES PMMA MANTUVIERON LA ARQUITECTURA GINGIVAL Y GUIARON FAVORABLEMENTE LA MADURACIÃ“N DE LOS TEJIDOS PERIIMPLANTARIOS.

EL RECONTORNEO GINGIVAL MEDIANTE ABORDAJE FLAPLESS MOSTRÃ“ RESULTADOS SATISFACTORIOS EN LA ARMONIZACIÃ“N DE LOS CONTORNOS GINGIVALES, LOGRANDO UNA MEJORA ESTÃ‰TICA EN LA REGIÃ“N DEL Ã“RGANO DENTAL 1.2, CON UNA LÃNEA DE MARGEN GINGIVAL MÃS SIMÃ‰TRICA RESPECTO AL CONTRALATERAL.

LA PRESERVACIÃ“N ALVEOLAR EN EL SITIO 1.2 PERMITIÃ“ MANTENER EL VOLUMEN DEL REBORDE Y FACILITAR UNA CICATRIZACIÃ“N FAVORABLE, COMPLEMENTADA POR EL PROVISIONAL BIEN ADAPTADO, QUE SIRVIÃ“ COMO GUÃA PARA EL TEJIDO GINGIVAL.?A LOS CONTROLES DE SEGUIMIENTO, SE EVIDENCIÃ“ PRESERVACIÃ“N DE LAS PAPILAS INTERDENTALES, ESTABILIDAD DEL VOLUMEN VESTIBULAR Y ADECUADA INTEGRACIÃ“N DE LOS IMPLANTES, SIN SIGNOS CLÃNICOS DE INFLAMACIÃ“N, EXPOSICIÃ“N DE ROSCAS O RECESIÃ“N GINGIVAL. LA ENCÃA PRESENTABA UNA COLORACIÃ“N ROSADA, FIRME Y SIN SANGRADO AL SONDAJE.?EN CONJUNTO, SE ALCANZÃ“ UN RESULTADO ESTÃ‰TICO Y FUNCIONAL FAVORABLE EN LA ZONA ANTERIOR MAXILAR, CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS PERIODONTALES, PROTÃ‰SICOS E IMPLANTOLÃ“GICOS DEL TRATAMIENTO.

Bibliografía *

1.- KAN JY, RUNGCHARASSAENG K, DEFLORIAN M, ET AL. IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT AND PROVISIONALIZATION OF MAXILLARY ANTERIOR SINGLE IMPLANTS: A TECHNIQUE. INT J ORAL MAXILLOFAC IMPLANTS. 2003;18(1):31â€“9. ?

2.- KAN JY, ROE P, RUNGCHARASSAENG K, PATEL RD, WAKI T, LOZADA JL, ZIMMERMAN G. CLASSIFICATION OF SAGITTAL ROOT POSITION IN RELATION TO THE ANTERIOR MAXILLARY OSSEOUS HOUSING FOR IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT: A CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY STUDY. INT J ORAL MAXILLOFAC IMPLANTS. 2011 JUL-AUG;26(4):873â€“6. PMID: 21841998. ?

3.- DONKER VJJ, RAGHOEBAR GM, VISSINK A, MEIJER HJA. IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT AND PROVISIONALIZATION IN THE AESTHETIC ZONE USING A DIGITAL WORKFLOW: A 1-YEAR PROSPECTIVE CASE SERIES STUDY. CLIN IMPLANT DENT RELAT RES. 2025 AUG;27(4)

4.- GAMBORENA, Y. SASAKI, AND M. B. BLATZ, â€œPREDICTABLE IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT AND RESTORATION IN THE ESTHETIC ZONE.â€ JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY 33. NO. 1 (2021):

Título del trabajo *

TRATAMIENTO DE RECESIONES GINGIVALES MÃšLTIPLES TIPO I Y II DE CAIRO CON TÃ‰CNICA DE TÃšNEL Y COLGAJO DESPLAZADO CORONALMENTE MODIFICADO.

Nombre del Autor (a/es)*

Evelyn IrahÃ- Catalan Lozada

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Evelyn IrahÃ- Catalan Lozada, David Gomez Thomas, Raul Montemayor Martinez, Luis Javier Walle Hernandez, , , , , .

Correo Electrónico *

evelyncatalan97@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD AME

Introducción y Objetivos *

INTRODUCCIÃ“N

LA RECESIÃ“N GINGIVAL (RG) SE DEFINE COMO EL DESPLAZAMIENTO APICAL DEL MARGEN GINGIVAL, CON EXPOSICIÃ“N CONCOMITANTE DE UNA PORCIÃ“N DE LA SUPERFICIE RADICULAR SU INCIDENCIA EN ADULTOS JÃ“VENES ES DEL 54% 26-35 AÃ‘OS Y EL 100% EN ADULTOS DE MEDIANA EDAD 36Â--45 AÃ‘OS. LAS RECESIONES GINGIVALES CON UNA PÃ‰RDIDA DE INSERCIÃ“N INTERPROXIMAL (RT2) ES EL TIPO MÃS COMÃšN DE ELLAS CON UNA PREVALENCIA DEL 88.8%, ESTA PÃ‰RDIDA INTERPROXIMAL ES UN PREDICTOR NEGATIVO PARA LOGRAR UNA COBERTURA RADICULAR COMPLETA. ZUCCHELLI Y DE SANCTIS DESCRIBIERON UN DISEÃ‘O DE COLGAJO DE INCISIONES OBLICUAS QUE FORMAN UNA NUEVA PAPILA, LO QUE FACILITA EL REPOSICIONAMIENTO PRECISO DE LA PAPILA QUIRÃšRGICA SOBRE LAS PAPILAS ANATÃ“MICAS PREVIAMENTE DESEPITELIZADAS, AUN ASI SE HA DEMOSTRADO QUE EL COLGAJO DESPLAZADO CORONALMENTE MODIFICADO TIENE UNA COBERTURA LÃMITADA EN LAS RECESIONES RT2 EN COMPARACIÃ“N CON LA TÃ‰CNICA DE TÃšNEL (TUN) CON INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO LA CUAL SE HA DEMOSTRADO COMO LA IDEAL PARA EL TRATAMIENTO DE RECESIONES MULTIPLES RT2 LA RAZÃ“N DETRÃS DEL USO DE ESTE ENFOQUE SE BASA EN EL HECHO DE QUE EL TUN PUEDE SEPARAR LAS PAPILAS BUCALES DEL HUESO INTERPROXIMAL, LO QUE PERMITE UN REPOSICIONAMIENTO CORONAL DEL TEJIDO BLANDO FACIAL E INTERPROXIMAL.

LA SELECCIÃ“N DE UNA TÃ‰CNICA QUIRÃšRGICA DEPENDE DE VARIOS FACTORES,EN ESTE SENTIDO TÃ‰CNICAS COMO EL COLGAJO DESPLAZADO CORONALMENTE (CAF) Y LA TÃ‰CNICA DE TÃšNEL (TUN) HAN DEMOSTRADO SER UNA EXCELENTE ALTERNATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE RT1 Y RT2, ESTAS PUEDEN COMBINARSE ENTRE SI PARA UN MEJOR ABORDAJE QUIRÃšRGICO Y MEJORES RESULTADOS.

OBJETIVOS

EL OBJETIVO DEL PRESENTE REPORTE DE CASO ES DESCRIBIR EL USO DE AMBAS TÃ‰CNICAS (TUN) Y (CAF) MODIFICADO CON INCISIONES OBLICUAS INSPIRADAS EN EL DISEÃ‘O DE COLGAJO DE ZUCCHELLI, PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LAS PAPILAS Y COMBINAR LOS BENEFICIOS ESTÃ‰TICOS DE AMBAS TÃ‰CNICAS ASOCIADO CON UN INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO SUBEPITELIAL.

Descripción del Caso *

DESCRIPCIÃ“N DEL CASO

PACIENTE FEMENINA DE 25 AÃ‘OS DE EDAD, SIN DATOS CLÃ NICOS PATOLÃ“GICOS, ACUDE A CONSULTA POR PRESENTAR TRIÃ NGULOS NEGROS ENTRE SUS INCISIVOS INFERIORES LOS CUALES LE GENERAN UNA PREOCUPACIÃ“N ESTÃ‰TICA. A LA EXPLORACIÃ“N CLÃ NICA INTRAORAL SE OBSERVA QUE LA PACIENTE SE ENCUENTRA EN TRATAMIENTO ORTODONCICO. A LA EXPLORACIÃ“N PERIODONTAL NO PRESENTÃ“ PROFUNDIDADES AL SONDEO NI NIGUNA ALTERACIÃ“N RADIOGRÃ FICA. SIN EMBARGO SE PUDO OBSERVAR MIGRACIÃ“N APICAL DEL MARGEN GINGIVAL POR LO QUE SE DIAGNOSTICÃ“ CON RECESIONES GINGIVALES MÃšLTIPLES CLASE I Y II DE CAIRO EN Ã“RGANOS DENTARIOS 11, 12, 13, 21,22, Y 23, Y SALUD GINGIVAL Y PERIODONTAL. SE DECIDE COMBINAR TÃ‰CNICAS DE COBERTURA RADICULAR: TUNEL+CAF+ INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO PARA LOGRAR UN MEJOR RESULTADO ESTÃ‰TICO.

PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO

PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO

SE REALIZÃ“ TÃ‰CNICA DE ANESTESIA REGIONAL INFERIOR POSTERIORMENTE SE PROCEDIÃ“ A REALIZAR EL DISEÃ‘O DEL COLGAJO CON INCISIONES INTRASULCULAR EN LAS Ã REAS DE LAS DE RECESIONES, SE ELEVÃ“ EL COLGAJO CON ESPESOR PARCIAL- TOTAL-PARCIAL EN DIRECCIÃ“N CORONO APICAL Y SE CONTINUÃ“ CON LA PREPARACIÃ“N DEL PEDÃ CULO POR MEDIO DE DISECCIÃ“N AGUDA CON EL OBJETIVO DE LOGRAR CUBRIR DE MANERA PASIVA LA UNION CEMENTO ESMALTE DE LOS Ã“RGANOS DENTARIOS CON RECESIÃ“N GINGIVAL.

EN LA ZONA DE 11 Y 21 SE REALIZÃ“ TÃ‰CNICA DE TÃšNEL Y SEPARACIÃ“N DE LAS PAPILAS INTERPROXIMALES. SE SUTURO CON POLIPROPILENO 6-0 POR MEDIO DE SUTURA SUSPENSORIA Y EN LA ZONA INTERPROXIMAL DE 1.1 Y 2.1 DOBLE LAZADO CON AYUDA DE LA ORTODONCIA Y PUNTO DE RESINA PARA MEJOR LA TRACCIÃ“N DEL TEJIDO GINGIVAL EN SENTIDO CORONAL, LA TOMA DE INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO SE REALIZÃ“ CON TÃ‰CNICA DE TRES INCISIONES PARA POSTERIORMENTE INTRODUCIRLO A TRAVÃ‰S DEL Ã REA DONDE SE REALIZARON LAS INCISIONES Y ELEVACIÃ“N DEL COLGAJO, SE FIJO EN LA ZONA DE LOS Ã“RGANOS DENTARIOS 11,12,21,22.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS

UNA SEMANA POSTERIOR A LA CIRUGÃ A SE PUEDE OBSERVAR COBERTURA RADICULAR DE LAS RECESIONES GINGIVALES ADEMÃ S DE MEJORA EN LAS PAPILAS INTERPROXIMALES, NO SE OBSERVÃ“ EXPOSICIÃ“N DEL TEJIDO CONECTIVO. TRES MESES POSTERIOR A LA CIRUGÃ A SE LOGRÃ“ UNA COBERTURA COMPLETA EN TODAS LAS RECESIONES TRATADAS ADEMÃ S DE UNA MEJORA NOTABLE EN LAS PAPILAS INTERPROXIMALES.

CONCLUSIÃ“N

EL COMBINAR LAS TÃ‰CNICAS INDICADAS PARA CADA TIPO DE RECESIÃ“N GINGIVAL PUEDE GENERAR MEJORES RESULTADOS QUE EL USO ÃšNICO DE ELLAS, LA TÃ‰CNICA DE TÃšNEL EN RECESIONES RT2 PRESENTA RESULTADOS ACEPTABLES EN LA MEJORA DE LA ESTÃ‰TICA INTERPROXIMAL, MIENTRAS QUE LAS INCISIONES OBLICUAS PERMITEN UNA MEJOR FIJACIÃ“N Y ACCESO DEL INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO ADEMÃ S DEL DESPLAZAMIENTO DEL COLGAJO.

Bibliografía *

REFERENCIAS

1.- DANI, S., DHAGE, A., & GUNDANNAVAR, G. (2014). THE POUCH AND TUNNEL TECHNIQUE FOR MANAGEMENT OF MULTIPLE GINGIVAL RECESSION DEFECTS. JOURNAL OF INDIAN SOCIETY OF PERIODONTOLOGY, 18(6), 776â€“780.

2.- ZUCCHELLI G, DE SANCTIS M. TREATMENT OF MULTIPLE RECESSION?TYPE DEFECTS IN PATIENTS WITH ESTHETIC DEMANDS. JOURNAL OF PERIODONTOLOGY. 2000;71:1500â€“1514.

3.- CAIRO F, NIERI M, CINCINELLI S, MERVELT J, PINI PRATO GP. CLASSIFICATION OF GINGIVAL RECESSIONS AND PREDICTION OF ROOT COVERAGE OUTCOMES: A SYSTEMATIC REVIEW. JOURNAL OF PERIODONTOLOGY. 2011;82(4):451â€“8.

Título del trabajo *

IMPLANTE GUIADO POST-EXTRACCIÃ“N, INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO Y COLOCACIÃ“N DE UN HEALING PERSONALIZADO EN ZONA ESTÃ‰TICA: REPORTE DE CASO

Nombre del Autor (a/es)*

Elena Darinka Lorelet Caballero PeÃ±a

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

David GÃ³mez Thomas, Raul Montemayor MartÃ-nez, Luis Javier Walle Hernandez, , , , , , .

Correo Electrónico *

elenadarinkacaballero@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD AME

Introducción y Objetivos *

LA COLOCACIÃ“N INMEDIATA DE IMPLANTES DENTALES EN LA ZONA ESTÃ‰TICA ES UN PROCEDIMIENTO DE ALTA EXIGENCIA QUIRÃšRGICA Y RESTAURADORA POR SU IMPACTO DIRECTO EN LA ARMONÃ□A DE LA SONRISA. ES VIABLE Y PREDECIBLE CUANDO SE PRESERVA LA INTEGRIDAD DE LAS TABLAS CORTICALES Y SE OBTIENE UNA ESTABILIDAD PRIMARIA ADECUADA. ASIMISMO, LOS ALVÃ‰OLOS TIPO I â€”CON CORTICALES Ã“SEAS INTACTAS Y UN ENTORNO DE TEJIDOS BLANDOS FAVORABLEâ€” CONSTITUYEN LA INDICACIÃ“N IDEAL PARA ESTA TÃ‰CNICA.

RESULTA DE SUMA IMPORTANCIA CUANDO SE PRETENDE COLOCAR UN IMPLANTE POST EXTRACCIÃ“N EN ZONA ESTÃ‰TICA SEGUIR CIERTOS PROTOCOLOS QUIRÃšRGICOS, COMO: REALIZAR LA EXTRACCIÃ“N DEL Ã“RGANO DENTARIO LO MÃ□S ATRAUMÃ□TICAMENTE POSIBLE, COLOCACIÃ“N DEL IMPLANTE PREFERENTEMENTE CON PROTOCOLOS GUIADOS PARA LA CORRECTA POSICIÃ“N, PROCEDIMIENTOS REGENERATIVOS EN EL GAP DEL ALVEOLO, MANEJO ADECUADO DEL TEJIDO BLANDO, ASÃ□ COMO EL USO DE PILARES DE CICATRIZACIÃ“N PERSONALIZADOS. EN ESTE SENTIDO EVIDENCIA CIENTÃ□FICA RESPALDA EL Ã‰XITO Y MEJORES RESULTADOS ESTÃ‰TICOS EN IMPLANTES COLOCADOS DE MANERA INMEDIATA CON EL USO DE PILARES PERSONALIZADOS E INJERTOS DE TEJIDO CONECTIVO CONTRA IMPLANTES COLOCADOS DE MANERA CONVENCIONAL.

EL PRESENTE REPORTE DE CASO TUVO COMO OBJETIVO REHABILITAR FUNCIONAL Y ESTÃ‰TICAMENTE LA REGIÃ“N DEL INCISIVO CENTRAL SUPERIOR IZQUIERDO (21) MEDIANTE LA COLOCACIÃ“N INMEDIATA DE UN IMPLANTE POST-EXTRACCIÃ“N GUIADO, ACOMPAÃ‘ADO POR REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA E INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO PARA OPTIMIZAR LA ESTÃ‰TICA DE LOS TEJIDOS PERIIMPLANTARIOS.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINA DE 35 AÃ‘OS, ASA I, CON FRACTURA DEL Ã“RGANO DENTARIO 21 SE PRESENTA AL POSGRADO DE PERIODONCIA DE UNIVERSIDAD AME CON UN MOTIVO DE CONSULTA Â¨SE ME QUEBRÃ“ UN DIENTEÂ¨.

A LA EXPLORACIÃ“N EXTRAORAL PRESENTÃ“ UNA LÃ□NEA DE SONRISA ALTA, EN EL ANÃ□LISIS PERIODONTAL PRESENTÃ“ UN RANGO DE PROFUNDIDAD AL SONDEO DE 1 A 3 MM, FENOTIPO GINGIVAL DELGADO. RADIOGRÃ□FICAMENTE NO SE OBSERVÃ“ NINGÃšN SIGNO PATOLÃ“GICO POR LO QUE SE CLASIFICO COMO SALUD PERIODONTAL.

EN EL ANÃ□LISIS HISTOTOMOGRÃ□FICO MOSTRÃ“ UN ALVEOLO TIPO I, LO CUAL PERMITIÃ“ PLANIFICAR LA COLOCACIÃ“N INMEDIATA DEL IMPLANTE.

Resultados y Conclusiones *

PROCEDIMIENTOS

EN LA FASE QUIRÃšRGICA INICIAL SE REALIZÃ“ UNA EXTRACCIÃ“N ATRAUMÃ□TICA CON PERIOTOMOS, SEGUIDA DE LA COLOCACIÃ“N INMEDIATA DE UN IMPLANTE ADIN CLOSEFIT (3.75 X 11.5 MM) MEDIANTE CIRUGÃ□A GUIADA. SE RELLENÃ“ EL GAP VESTIBULAR CON XENOINJERTO, SEGÃšN LO RECOMENDADO POR LIÃ‘ARES ET AL. (2023), PARA PRESERVAR EL VOLUMEN Ã“SEO VESTIBULAR Y PREVENIR COLAPSO DE TEJIDOS BLANDOS. SE COLOCÃ“ UN PILAR DE CICATRIZACIÃ“N PERSONALIZADO, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE CHOKAREE ET AL. (2022), PARA MOLDEAR ADECUADAMENTE EL CONTORNO GINGIVAL DURANTE LA FASE DE CICATRIZACIÃ“N.

EN LA FASE QUIRÃšRGICA INICIAL SE REALIZÃ“ UNA EXTRACCIÃ“N ATRAUMÃ□TICA CON PERIOTOMOS, SEGUIDA DE LA COLOCACIÃ“N INMEDIATA DE UN IMPLANTE ADIN CLOSEFIT 3.75 Ã— 11.5 MM MEDIANTE CIRUGÃ□A GUIADA SE RELLENÃ“ EL GAP VESTIBULAR CON XENOINJERTO PARA PRESERVAR EL VOLUMEN Ã“SEO VESTIBULAR Y PREVENIR EL COLAPSO DE LOS TEJIDOS BLANDOS. FINALMENTE, SE INSTALÃ“ UN PILAR DE CICATRIZACIÃ“N PERSONALIZADO PARA MANTENER Y MOLDEAR EL CONTORNO GINGIVAL DURANTE LA CICATRIZACIÃ“N.

RESULTADOS

LA CICATRIZACIÃ“N POSTOPERATORIA FUE Ã“PTIMA. A LOS TRES MESES SE OBSERVÃ“ INTEGRACIÃ“N EXITOSA DEL IMPLANTE, ESTABILIDAD DEL VOLUMEN GINGIVAL Y UNA ARQUITECTURA DE TEJIDOS BLANDOS ALTAMENTE ESTÃ‰TICA. LA RESTAURACIÃ“N DEFINITIVA MIMETIZÃ“ EL DIENTE NATURAL, MANTENIENDO LA ARMONÃ□A DE LA SONRISA. ESTOS HALLAZGOS SON CONSISTENTES CON LA EVIDENCIA QUE MUESTRA QUE LA COLOCACIÃ“N INMEDIATA, ACOMPAÃ‘ADA DE UN MANEJO ADECUADO DE LOS TEJIDOS BLANDOS, PUEDE OFRECER RESULTADOS ESTÃ‰TICOS SUPERIORES.

CONCLUSIONES

LA COLOCACIÃ“N INMEDIATA DE IMPLANTES EN LA ZONA ANTERIOR, CUANDO ES REALIZADA BAJO UNA PLANIFICACIÃ“N MULTIDISCIPLINARIA BASADA EN EVIDENCIA CIENTÃ□FICA, PERMITE OBTENER RESULTADOS ALTAMENTE SATISFACTORIOS. EL Ã‰XITO DE ESTE CASO SE SUSTENTÃ“ EN LA APLICACIÃ“N RIGUROSA DE PRINCIPIOS QUIRÃšRGICOS DESCRITOS POR BUSER, ELIAN Y KAN, ASÃ□ COMO EN EL USO DE BIOMATERIALES Y TÃ‰CNICAS DE MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS CON RESPALDO EN LA LITERATURA RECIENTE. EL ENFOQUE INTEGRAL QUIRÃšRGICO, PROTÃ‰SICO FUE ESENCIAL PARA LOGRAR UNA REHABILITACIÃ“N ESTÃ‰TICA

Bibliografía *

1. IMPLANT PLACEMENT POST EXTRACTION IN ESTHETIC SINGLE TOOTH SITES: WHEN IMMEDIATE, WHEN EARLY, WHEN LATE? - BUSER - 2017 - PERIODONTOLOGY 2000

2. IMMEDIATE IMPLANT AND CUSTOMIZED HEALING ABUTMENT FOR A PERIODONTALLY COMPROMISED SOCKET: 1-YEAR FOLLOW-UP RETROSPECTIVE EVALUATION.

3. CHANDRAN K R S, GOYAL M, MITTAL N, GEORGE JS. ACCURACY OF FREEHAND VERSUS GUIDED IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. J DENT.

4. LIÃ‘ARES A, DOPICO J, MAGRIN G, BLANCO J. CRITICAL REVIEW ON BONE GRAFTING DURING IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT. PERIODONTOL 2000.

5. JUNG RE, BECKER K, BIENZ SP, DAHLIN C, DONOS N, HAMMÃ„CHER C, ET AL. EFFECT OF PERI-IMPLANT MUCOSAL THICKNESS ON ESTHETIC OUTCOMES AND THE EFFICACY OF SOFT TISSUE AUGMENTATION PROCEDURES: CONSENSUS REPORT OF GROUP 2 OF THE SEPA/DGI/OF WORKSHOP. CLIN ORAL IMPLANTS RES.

6. EFFECT OF CUSTOMIZED AND PREFABRICATED HEALING ABUTMENTS ON PERI-IMPLANT SOFT TISSUE AND

Título del trabajo *

AUMENTO DE TEJIDO QUERATINIZADO CON COLOCACIÃ“N SIMULTÃ□NEA DE IMPLANTES DENTALES EN UN PACIENTE EDÃ‰NTULO TOTAL (REPORTE DE UN CASO)

Nombre del Autor (a/es)*

Raquel Abigail Silva Rocha

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

David Thomas GÃ³mez, RaÃºl Montemayor MartÃ-nez, Eduen Obed Perera Salazar, , , , , , .

Correo Electrónico *

raquelsilva.perio@gmail.com

Institución *

AME UNIVERSIDAD

Introducción y Objetivos *

ANTECEDENTES Y OBJETIVO

LA TERAPIA CON IMPLANTES DENTALES HA DEMOSTRADO SER UNA EXCELENTE ALTERNATIVA PARA LA SUSTITUCIÃ“N DE Ã“RGANOS DENTARIOS PERDIDOS, ACTUALMENTE DICHA TERAPIA ES CONSIDERADA COMO UNA EXCELENTE ALTERNATIVA PARA EL TRATAMIENTO Y REHABILITACIÃ“N EN PACIENTES CON EDENTULISMO TOTAL.

LAS SOBREDENTADURAS SOSTENIDAS POR IMPLANTES DENTALES PROPORCIONAN UNA MEJORA SIGNIFICATIVA EN ESTABILIDAD, RETENCIÃ“N, FUERZA MÃ XIMA DE MORDIDA, SATISFACCIÃ“N DEL PACIENTE Y CALIDAD DE VIDA. LA UNIÃ“N PRIMARIA DE LOS IMPLANTES MEDIANTE EL USO DE SISTEMAS CON BARRAS O DISEÃ‘OS NO UNIDOS, POR EJEMPLO, CONEXIONES BOLA O TIPO LOCATOR, RESULTA EN UNA ALTA SUPERVIVENCIA DE LOS IMPLANTES. 1

EL DESARROLLO DE LA IMPLANTOLOGÃ A ORAL HA HECHO POSIBLE LA REALIZACIÃ“N DE UNA TERAPÃ‰UTICA MÃ S FAVORABLE PARA EL PACIENTE EDÃ‰NTULO TOTAL, EVIDENCIA CIENTÃ FICA ACTUAL HA DEMOSTRADO QUE LA INSERCIÃ“N DE 2 A 4 IMPLANTES DENTALES COLOCADOS EN EL ESPACIO INTERFORAMINAL ANTERIOR, PUEDEN SOPORTAR UNA SOBREDENTADURA EN LA MANDÃ BULA EDÃ‰NTULA CON UN Ã‰XITO SUPERIOR AL 90-95%2, SIEMPRE Y CUANDO LAS CONDICIONES SEAN IDÃ“NEAS, EN ESTE SENTIDO ES DE SUMA IMPORTANCIA EL CORRECTO DIAGNÃ“STICO, ASÃ COMO LA DETECCIÃ“N OPORTUNA DE DEFORMIDADES O DEFICIENCIAS EN LOS TEJIDOS BLANDOS Y DUROS.

EL INJERTO GINGIVAL LIBRE ES EL GOLD STRANDARD PARA AQUELLOS CASOS DONDE EXISTE AUSENCIA DE TEJIDO GINGIVAL QUERATINIZADO Y SE PRETENDE COLOCAR IMPLANTES DENTALES, SE HA DEMOSTRADO QUE AUMENTA LA SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO YA QUE PRESENTA FACTORES COMO IMPERMEABILIDAD Y LA CAPACIDAD DE PROTECCIÃ“N A LA MUCOSA MASTICATORIA, LAS CUALES PROTEGEN AL TEJIDO PERIODONTAL Y PERI-IMPLANTAR, ADEMÃ S BRINDA OTROS BENEFICIOS COMO LA OBTENCIÃ“N UNA MAYOR PROFUNDIDAD DE VESTÃ BULO Y LA ELIMINACIÃ“N DE FRENILLOS ABERRANTES.3

EL OBJETIVO DEL PRESENTE REPORTE DE CASO ES DESCRIBIR EL PROCESO DE PLANEACIÃ“N QUIRÃšRGICO Y PROTÃ‰SICO PARA LA COLOCACIÃ“N DE UNA SOBREDENTADURA SOPORTADA POR DOS IMPLANTES DENTALES, ASÃ COMO LA ADECUACIÃ“N DE LOS TEJIDOS BLANDOS PARA OBTENER UN PERIODONTO ESTABLE.

Descripción del Caso *

PRESENTACIÃ“N DEL CASO Y DIAGNÃ“STICO

PACIENTE FEMENINA DE 57 AÃ‘OS DE EDAD ASA II DIABÃ‰TICA CONTROLADA ACUDE A LAS CLÃ NICAS ODONTOLÃ“GICAS DE AME UNIVERSIDAD CON UN MOTIVO DE CONSULTA Â¨QUIERO CON UNA PRÃ“TESIS DENTALÂ¨ A LA EXAMINACIÃ“N INTRAORAL SE OBSERVAN TEJIDOS BLANDOS COLOR ROSA PÃ LIDO, AUSENCIA TOTAL DE Ã“RGANOS DENTARIOS E IRREGULARIDAD EN EL REBORDE EDÃ‰NTULO CLASE III DE SEIBERT ASÃ COMO FALTA DE ENCÃ A QUERATINIZADA, EN EL ESTUDIO HISTOTOMOGRÃ FICO SE CONSTATÃ“ UN ADECUADLO GROSOR Ã“SEO, LO QUE NOS PERMITIÃ“ OPTAR POR LA TERAPIA CON IMPLANTES DENTALES.

SE DECIDIÃ“ COLOCAR 2 IMPLANTES EN Ã REAS DE Ã“RGANOS DENTALES CORRESPONDIENTES A 33 Y 43, ASÃ COMO INJERTOS GINGIVALES LIBRES EN DICHAS Ã REAS CON EL OBJETIVO DE AUMENTAR EL ANCHO DE ENCÃ A QUERATINIZADA Y LOGRAR UNA MAYOR PROFUNDIDAD DE VESTÃ BULO.

DENTRO DE LA FASE PROTÃ‰SICA SE DECIDIÃ“ COLOCAR UNA PRÃ“TESIS ACRÃ LICA CON SISTEMA LOCATORS.

PROCEDIMIENTOS

SE ANESTESIÃ“ CON ARTICAÃ NA AL 4% CON VASOCONSTRICTOR, POSTERIORMENTE SE PROCEDIÃ“ A PROBAR GUÃ A QUIRÃšRGICA ANALÃ“GICA LA CUAL TUVO UN CORRECTO ASENTAMIENTO, SE REALIZÃ“ UN COLGAJO DE ESPESOR TOTAL Y SE PROCEDIÃ“ A REALIZAR EL PROTOCOLO DE FRESADO QUIRÃšGICO ADIN PARA IMPLANTES 3.5X10MM, DURANTE TODO EL PROCEDIMIENTO SE USÃ“ COMO REFERENCIA LA GUÃ A Y SE FINALIZÃ“ CON LA COLOCACIÃ“N DE PUNTOS SIMPLES CON NYLON 4-0.

EN UN SEGUNDO TIEMPO QUIRÃšRGICO SE REALIZÃ“ FASE II DE AMBOS IMPLANTES BASÃ NDONOS EN LAS INCISIONES ANTERIORES Y SE COLOCARON TORNILLOS DE CICATRIZACIÃ“N, SIMULTÃ NEAMENTE SE DECIDIÃ“ COLOCAR DOS INJERTOS DE TEJIDO GINGIVAL LIBRE EN VESTIBULAR DE AMBOS IMPLANTES PARA CREAR ENCÃ A QUERATINIZADA AUSENTE Y OBTENER UNA MAYOR PROFUNDIDAD DE VESTÃ BULO.

DENTRO DE LA PROTÃ‰SICA SE COLOCÃ“ UNA PRÃ“TESIS TOTAL SUPERIOR ACRÃ LICA Y UNA PRÃ“TESIS TOTAL INFERIOR ACRÃ LICA IMPLANTO MUCOSOPORTADA CON LOCATORS EN ESPACIO DE Ã“RGANOS DENTARIOS 33 Y 43.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS

SE OBTUVIERON RESULTADOS FAVORABLES A LOS DOS MESES DE CICATRIZACIÃ“N, TENIENDO COMO GANANCIA 8 MILÃ METROS AGREGADOS DE ENCÃ A QUERATINIZADA A LOS 2 MILÃ METROS QUE PRESENTABA LA PACIENTE, EN LA ZONA VESTIBULAR, DE LA CRESTA A LA LÃ NEA MUCOGINGIVAL.

CONCLUSIONES

LAS SOBREDENTADURAS SOPORTADAS POR IMPLANTES DENTALES HAN DEMOSTRADO SER UNA EXCELENTE ALTERNATIVA PARA AQUELLOS CASOS DONDE POR INCOMODIDAD O POR MALA ADAPTACIÃ“N DE LAS PRÃ“TESIS EL PACIENTE SE ENCUENTRA RENUENTE A EL USO DE LAS MISMAS, EXISTE SUFICIENTE EVIDENCIA QUE SUSTENTA EL Ã‰XITO A LARGO PLAZO DE DICHO SISTEMA SIEMPRE Y CUANDO LAS CONDICIONES SEAN IDEALES.

LA AUSENCIA DE ENCÃ A QUERATINIZADA ALREDEDOR DEL TEJIDO PERIIMPLANTARIO, PODRÃ A CONDUCIR A UNA HIGIENE BUCAL INADECUADA, ACUMULACIÃ“N DE PLACA, INFLAMACIÃ“N DE LA MUCOSA, SANGRADO AL SONDEO, MIGRACIÃ“N APICAL DE LA MUCOSA Y PÃ‰RDIDA Ã“SEA PERI-IMPLANTAR QUE PODRÃ A INFLUIR NEGATIVAMENTE EN EL MANTENIMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS IMPLANTES DENTALES Y PRÃ“TESIS. SE HA DEMOSTRADO QUE SE NECESITA UNA CANTIDAD ?2 MM DE TEJIDO QUERATINIZADO PARA MANTENER LA SALUD DE LOS TEJIDOS PERIODONTALES Y PERIIMPLANTARIOS.

EL INJERTO GINGIVAL LIBRE ES UNA TÃ‰CNICA EXITOSA Y PREDECIBLE QUE PODRÃ A PREVENIR PROBLEMAS EN LOS TEJIDOS DUROS Y BLANDOS QUE SE DESARROLLAN DESPUÃ‰S DE LA REHABILITACIÃ“N CON IMPLANTES.

PALABRAS CLAVE: IMPLANTES DENTALES, PROFUNDIZACIÃ“N DE VESTÃ BULO, INJERTO LIBRE

Bibliografía *

BIBLIOGRAFÃ A:

1. ELSYAD MA, MAHANNA FF, ELSHAHAT MA, ELSHOUKOUKI AH. LOCATORS VERSUS MAGNETIC ATTACHMENT EFFECT ON PERI-IMPLANT TISSUE HEALTH OF IMMEDIATE LOADED TWO IMPLANTS RETAINING A MANDIBULAR OVERDENTURE: A 1-YEAR RANDOMISED TRIAL. JOURNAL OF ORAL REHABILITATION. 2015 NOV 9;43(4):297â€“305.

2. ORTEGA V, MONSALVE GUIL, L, ORTIZ GARCÃ A, I, GUERRA J, GARRIDO M, EGEA S. SOBREDENTADURAS MANDIBULARES SOBRE DOS IMPLANTES EN PACIENTES EDÃ‰NTULOS TOTALES: UN ESTUDIO A TRES AÃ‘OS. AVANCES EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÃ A ORAL. 2015, 27(3):109â€“16.

3. ZUCCHELLI G, TAVELLI L, MCGUIRE MK, RASPERINI G, FEINBERG SE, WANG H, ET AL. AUTOGENOUS SOFT TISSUE GRAFTING FOR PERIODONTAL AND PERI?IMPLANT PLASTIC SURGICAL RECONSTRUCTION. JOURNAL OF PERIODONTOLOGY. 2019 OCT 6;91(1):9â€“16.

4. KAPPEL S, GIANNAKOPOULOS NN, EBERHARD L, RAMMELSBERG P, EIFFLER C. IMMEDIATE LOADING OF DENTAL IMPLANTS IN EDENTULOUS MANDIBLES BY USE OF LOCATORÂ® ATTACHMENTS OR DOLDERÂ® BARS: TWO-YEAR RESULTS FROM A PROSPECTIVE RANDOMIZED CLINICAL STUDY. CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED

Título del trabajo *

PLANEACIÃ“N DIGITAL QUIRÃšRGICA Y PROTÃ‰SICA SOBRE 4 IMPLANTES DENTALES EN MAXILAR INFERIOR

Nombre del Autor (a/es)*

Joselene Anel Rangel Gaytan

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

David Gomez Thomas Gomez, Raul Montemayor Martinez, Eduen Obed Perea Salazar, , , , , , .

Correo Electrónico *

j.rangel16@hotmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD AME

Introducción y Objetivos *

LA PLANIFICACIÃ“N DIGITAL EN IMPLANTOLOGÃ⍰A PERMITE OPTIMIZAR RESULTADOS FUNCIONALES Y ESTÃ‰TICOS, EN LA PLANIFICACIÃ“N PREOPERATORIA Y LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES, SE HA DEMOSTRADO QUE EL USO DE UN SOFTWARE DE PLANIFICACIÃ“N SEGUIDO DE LA CREACIÃ“N DE GUÃ⍰AS QUIRÃšRGICAS INDIVIDUALES MEJORA LOS RESULTADOS DEL TRATAMIENTO ASÃ⍰ COMO LA PRECISIÃ“N POSICIONAL DEL IMPLANTE EN COMPARACIÃ“N CON LA TÃ‰CNICA ANALÃ“GICA.

EL USO DE GUÃ⍰AS, ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS FLAPLESS, SE ASOCIA CON UNA MENOR INCIDENCIA DE COMPLICACIONES QUIRÃšRGICAS Y POSTOPERATORIAS, COMO DOLOR, EDEMA Y PUEDE MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE EN EL PERIODO INMEDIATO TRAS LA CIRUGÃ⍰A LO QUE FAVORECE LA CICATRIZACIÃ“N, REDUCE EL MALESTAR, FACILITA LA REHABILITACIÃ“N FUNCIONAL Y ESTÃ‰TICA, OPTIMIZA LA CARGA OCLUSAL Y REDUCE LA NECESIDAD DE INTERVENCIONES CORRECTIVAS POSTERIORES.

LA CIRUGÃ⍰A GUIADA OFRECE UNA MAYOR Â PREDICTIBILIDAD EN LA TRANSFERENCIA DEL PLAN QUIRÃšRGICO AL PACIENTE, LO QUE ES ESPECIALMENTE RELEVANTE EN CASOS COMPLEJOS O EN MAXILARES EDÃ‰NTULOS.

LA INDICACIÃ“N DE LAS GUÃ⍰AS QUIRÃšRGICAS DIGITALES EN LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES ES TRANSFERIR CON PRECISIÃ“N EL PLAN DE TRATAMIENTO VIRTUAL AL CAMPO QUIRÃšRGICO, LO QUE PERMITE LA INSERCIÃ“N DEL IMPLANTE EN LA POSICIÃ“N, ANGULACIÃ“N Y PROFUNDIDAD Ã“PTIMAS PREVIAMENTE PLANIFICADAS. ESTO SE TRADUCE EN UNA MAYOR EXACTITUD EN LA UBICACIÃ“N DEL IMPLANTE RESPECTO A LAS ESTRUCTURAS ANATÃ“MICAS CRÃ⍰TICAS, EN ESTE SENTIDO SE DISMINUYEN RIESGOS QUIRÃšRGICOS Y SE MEJORAN LOS RESULTADOS TANTO FUNCIONALES COMO ESTÃ‰TICOS A LARGO PLAZO.

Descripción del Caso *

PACIENTE MASCULINO DE 68 AÃ‘OS DE EDAD, ASA II CON ANTECEDENTES MÃ‰DICOS DE PARKINSON Y DIABETES CONTROLADA, NO FUMADOR Y NO CONSUME ALCOHOL, ACUDE AL POSGRADO DE PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÃ A ORAL EN LA UNIVERSIDAD AME SOLICITANDO TRATAMIENTO DE IMPLANTES DENTALES.

A LA EXPLORACIÃ“N EXTRAORAL NO PRESENTO SIGNOS CLÃ NICOS PATOLÃ“GICOS, A LA EXPLORACIÃ“N INTRAORAL PRESENTÃ“ GUÃ AS CANINAS CLASE I, AUSENCIA DE GUÃ AS MOLARES, A LA EXPLORACIÃ“N PERIODONTAL PRESENTO PROFUNDIDADES AL SONDEO QUE VAN DE LOS 2 A LOS 4 MM Y UN NIVEL DE INSERCIÃ“N CLÃ NICO MÃ XIMO DE 5 MM, TEJIDOS BLANDOS COLOR ROSA PÃ LIDO ASÃ COMO AUSENCIA DE Ã“RGANOS DENTARIOS 3.6,3.7,4.7, REGIÃ“N CORRESPONDIENTE A 4.6 SE IDENTIFICA UN RESTO RADICULAR, RADIOGRAFICAMENTE PERDIDA DE CONTINUIDAD EN LA LAMINA DURA EN ZONAS LOCALIZADAS POR LO QUE SE CLASIFICO COMO PERIODONTITIS ESTADIO I LOCALIZADO GRADO B.

UNA VEZ REALIZADA LA FASE HIGIÃ‰NICA Y REVALUACIÃ“N SE ESTABLECIÃ“ UN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PERIODONTAL Y SE INDICA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES POST EXTRACCIÃ“N MEDIANTE PLANEACIÃ“N DE PROTOCOLO GUIADO Y PLANEACIÃ“N PROTÃ‰SICA.

BAJO ANESTESIA LOCAL EN ZONAS A TRATAR CUADRANTES III Y IV SE PRESENTÃ“ GUÃ A QUIRÃšRGICA DIGITAL PARA IMPLANTES 36,37,46,47, SE PROCEDIÃ“ A LA COLOCACIÃ“N DE LOS IMPLANTES CON TÃ‰CNICA DE TISSUE PUNCH Y SE REALIZÃ“ EL FRESADO QUIRÃšRGICO SIGUIENDO PROTOCOLO DE FRESADO HIOSSEN , SE COLOCARON LOS IMPLANTES SEGUIDO DE TAPAS DE CIERRE.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

EVIDENCIA CIENTÃ FICA ACTUAL MUESTRA QUE LA CIRUGÃ A GUIADA EN CASOS DONDE ESTABA INDICADA Y EL PACIENTE ES CANDIDATO MUESTRA TASAS DE Ã‰XITO ELEVADAS Y BAJA INCIDENCIA DE COMPLICACIONES, SIEMPRE QUE SE REALICE UNA PLANIFICACIÃ“N INDIVIDUALIZADA.

EL USO DE GUÃ AS QUIRÃšRGICAS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS Y ENFERMEDAD DE PARKINSON, TIENE UNA MEJOR PRECISIÃ“N, REDUCE EL TRAUMA QUIRÃšRGICO Y PUEDE CONTRIBUIR A UNA MEJOR EVOLUCIÃ“N POSTOPERATORIA.

ESTE TIPO DE GUÃ AS QUIRÃšRGICAS FACILITA PROCEDIMIENTOS Y LOS HACE MENOS INVASIVOS, REDUCE LA VARIABILIDAD OPERATORIA, Y PUEDE SER ESPECIALMENTE ÃšTIL PARA CLÃ NICOS CON MENOR EXPERIENCIA, YA QUE DISMINUYE LA DESVIACIÃ“N RESPECTO AL PLAN PREOPERATORIO Y CONTRIBUYE A LA PREDICTIBILIDAD DEL TRATAMIENTO.

Bibliografía *

1.GUIDED AND NAVIGATION IMPLANT SURGERY: A SYSTEMATIC REVIEW.?AGHALOO T, HADAYA D, SCHOENBAUM TR, PRATT L, FAVAGEHI M.?THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS. 2023 MAY-JUN;38(SUPPL):7-15. DOI:10.11607/JOMI.10465.

2.THE CLINICAL ACCURACY OF THE IMPLANT DIGITAL SURGICAL GUIDE: A META-ANALYSIS.?ZHANG F, GAO X, YE ZY, XU DQ, DING X. AMERICAN JOURNAL OF DENTISTRY. 2020;33(6):296-304.

3.FULLY GUIDED VERSUS HALF-GUIDED AND FREEHAND IMPLANT PLACEMENT: SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS.?GARGALLO-ALBIOL J, BAROOTCHI S, MARQUÃ‰S-GUASCH J, WANG HL. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS. 2020 NOV/DEC;35(6):1159-1169. DOI:10.11607/JOMI.7942.

4.COMPARISON OF IMPLANT PRECISION WITH ROBOTS, NAVIGATION, OR STATIC GUIDES. SHI JY, WU XY, LV XL, ET AL. JOURNAL OF DENTAL RESEARCH. 2025;104(1):37-44. DOI:10.1177/00220345241285566. LEADING JOURNAL NEW RESEARCH

5.COMPARISON OF IMPLANTATION ACCURACY AMONG DIFFERENT NAVIGATED APPROACHES: A SYSTEMATIC REVIEW AND NETWORK META-ANALYSIS. KANG S. HOU Y. CAO J. ET AL. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL &

Título del trabajo *

TÃ‰CNICA DE TÃšNEL CON MATRIZ DÃ‰RMICA ACELULAR PARA EL TRATAMIENTO DE RECESIONES GINGIVALES MÃšLTIPLES: REPORTE DE UN CASO

Nombre del Autor (a/es)*

Maria Isabel Erro Valdez

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

David GÃ³mez Thomas, RaÃºl Montemayor MartÃ-nez, Eduen Obed Perera Salazar, , , , , , .

Correo Electrónico *

MAISABELERRO@GMAIL.COM

Institución *

UNIVERSIDAD AME

Introducción y Objetivos *

LA RECESIÃ“N GINGIVAL SE DEFINE COMO EL DESPLAZAMIENTO DEL MARGEN GINGIVAL HACIA APICAL, LO QUE DEJA EXPUESTA LA SUPERFICIE RADICULAR AL MEDIO ORAL Y CONLLEVA LA PÃ‰RDIDA DE INSERCIÃ“N. DIVERSOS FACTORES SE HAN RELACIONADO CON SU APARICIÃ“N, COMO UN FENOTIPO GINGIVAL DELGADO, LA AUSENCIA DE ENCÃ□A ADHERIDA Y EL POSICIONAMIENTO ANÃ“MALO DE LOS DIENTES. EN SITUACIONES DONDE EXISTE SENSIBILIDAD DENTAL, AFECTACIÃ“N ESTÃ‰TICA O LESIONES CERVICALES, SE CONSIDERA NECESARIO EL TRATAMIENTO QUIRÃšRGICO PARA LOGRAR LA COBERTURA RADICULAR.

LAS TERAPIAS MUCOGINGIVALES HAN EVOLUCIONADO CON EL TIEMPO, ORIENTÃ□NDOSE HACIA TÃ‰CNICAS MENOS INVASIVAS Y CON MEJORES RESULTADOS ESTÃ‰TICOS Y FUNCIONALES. ENTRE ESTAS, DESTACAN LOS PROCEDIMIENTOS DE TÃšNEL, LOS CUALES PERMITEN PRESERVAR EL RIEGO SANGUÃ□NEO, ASEGURAR LA ESTABILIDAD DEL INJERTO Y MEJORAR LA INTEGRACIÃ“N DE LOS TEJIDOS. ESTAS TÃ‰CNICAS, DESARROLLADAS A PARTIR DE LA TÃ‰CNICA DE â€œENVOLTURAâ€□ DE RAETZKE, BUSCAN MINIMIZAR LA NECESIDAD DE INCISIONES AMPLIAS Y AUMENTAR LA PREDICTIBILIDAD QUIRÃšRGICA.

EL INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO SUBEPITELIAL (CTG) HA SIDO POR AÃ‘OS EL TRATAMIENTO DE REFERENCIA POR SU ALTA EFICACIA EN LA COBERTURA RADICULAR. SIN EMBARGO, SU OBTENCIÃ“N REQUIERE UNA SEGUNDA ZONA QUIRÃšRGICA, LO CUAL INCREMENTA EL TIEMPO OPERATORIO, EL DOLOR POSTOPERATORIO Y LAS COMPLICACIONES POTENCIALES. COMO ALTERNATIVA, SE HAN DESARROLLADO MATRICES DÃ‰RMICAS ACELULARES (ADM) PROCESADAS PARA ELIMINAR CÃ‰LULAS ANTIGÃ‰NICAS, Y PRESERVAR UNA ESTRUCTURA COLÃ□GENA QUE FAVORECE LA INTEGRACIÃ“N CON LOS TEJIDOS DEL PACIENTE. ESTUDIOS CLÃ□NICOS HAN DEMOSTRADO QUE EL ADM ES COMPARABLE AL CTG EN TÃ‰RMINOS DE COBERTURA RADICULAR, ESTABILIDAD Y CICATRIZACIÃ“N, LO QUE CONSTITUYE UNA OPCIÃ“N CONFIABLE Y MENOS INVASIVA.

EVALUAR LA EFECTIVIDAD CLÃ□NICA DE LA TÃ‰CNICA DE TÃšNEL EN COMBINACIÃ“N CON MATRIZ DÃ‰RMICA ACELULAR (ADM) PARA EL RECUBRIMIENTO RADICULAR DE RECESIONES GINGIVALES TIPO RT1 Y RT2 DE CAIRO, EN DIENTES DE LA ARCADA SUPERIOR E INFERIOR.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINO DE 57 AÃ‘OS DE EDAD ACUDE AL DEPARTAMENTO DE PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÃ⍰A DE AME UNIVERSIDAD REFIRIENDO COMO MOTIVO DE CONSULTA: â€œTENGO LA ENCÃ⍰A RETRAÃ⍰DAâ€⍰. DURANTE LA ANAMNESIS, LA PACIENTE NO REPORTA ANTECEDENTES MÃ‰DICOS SISTÃ‰MICOS RELEVANTES NI HÃ⍰BITOS PARAFUNCIONALES, Y PRESENTA UNA HIGIENE BUCAL ADECUADA.

A LA EXPLORACIÃ“N EXTRAORAL NO PRESENTO NINGÃšN SIGNO PATOLÃ“GICO, MIENTRAS QUE EN LA EXAMINACIÃ“N PERIODONTAL SE OBSERVÃ“ MÃšLTIPLES RECESIONES GINGIVALES DISTRIBUIDAS EN LOS CUADRANTES I, II, III Y IV, COMPATIBLES CON RECESIONES TIPO RT1 Y RT2 SEGÃšN LA CLASIFICACIÃ“N DE CAIRO. LA MAYORÃ⍰A DE LOS SITIOS AFECTADOS PRESENTARON INTEGRIDAD EN LA INSERCIÃ“N INTERPROXIMAL, SIN EVIDENCIA DE PÃ‰RDIDA Ã“SEA INTERDENTAL. LAS RECESIONES SE LOCALIZAN PRINCIPALMENTE EN PIEZAS ANTERIORES Y PREMOLARES, CON COMPROMISO ESTÃ‰TICO Y EXPOSICIÃ“N RADICULAR VISIBLE, LO QUE GENERA PREOCUPACIÃ“N EN LA PACIENTE TANTO POR MOTIVOS FUNCIONALES (SENSIBILIDAD DENTINARIA LEVE) COMO ESTÃ‰TICOS.

AL SONDEO PERIODONTAL, NO SE DETECTARON PROFUNDIDADES, NI SANGRADO Y PRESENTÃ“ UN FENOTIPO DELGADO. LAS CONDICIONES CLÃ⍰NICAS REFLEJAN SALUD PERIODONTAL ESTABLE, SIN INFLAMACIÃ“N ACTIVA NI PRESENCIA DE FACTORES IRRITANTES LOCALES. CON BASE EN EL DIAGNÃ“STICO CLÃ⍰NICO, Y TRAS EVALUAR LAS CONDICIONES ANATÃ“MICAS Y ESTÃ‰TICAS DEL CASO, SE DETERMINÃ“ QUE LA PACIENTE ERA CANDIDATA IDEAL PARA UNA TERAPIA DE CIRUGÃ⍰A PLÃ⍰STICA PERIODONTAL.

A LA EXPLORACIÃ“N EXTRAORAL NO PRESENTO NINGÃšN SIGNO PATOLÃ“GICO, MIENTRAS QUE EN LA EXAMINACIÃ“N PERIODONTAL SE OBSERVÃ“ MÃšLTIPLES RECESIONES GINGIVALES DISTRIBUIDAS EN LOS CUADRANTES I, II, III Y IV, COMPATIBLES CON RECESIONES TIPO RT1 Y RT2 SEGÃšN LA CLASIFICACIÃ“N DE CAIRO. LA MAYORÃ⍰A DE LOS SITIOS AFECTADOS PRESENTARON INTEGRIDAD EN LA INSERCIÃ“N INTERPROXIMAL, SIN EVIDENCIA DE PÃ‰RDIDA Ã“SEA INTERDENTAL. LAS RECESIONES SE LOCALIZAN PRINCIPALMENTE EN PIEZAS ANTERIORES Y PREMOLARES, CON COMPROMISO ESTÃ‰TICO Y EXPOSICIÃ“N RADICULAR VISIBLE, LO QUE GENERA PREOCUPACIÃ“N EN LA PACIENTE TANTO POR MOTIVOS FUNCIONALES (SENSIBILIDAD DENTINARIA LEVE) COMO ESTÃ‰TICOS.

AL SONDEO PERIODONTAL, NO SE DETECTARON PROFUNDIDADES, NI SANGRADO Y PRESENTÃ“ UN FENOTIPO DELGADO. LAS CONDICIONES CLÃ⍰NICAS REFLEJAN SALUD PERIODONTAL ESTABLE, SIN INFLAMACIÃ“N ACTIVA NI PRESENCIA DE FACTORES IRRITANTES LOCALES. CON BASE EN EL DIAGNÃ“STICO CLÃ⍰NICO, Y TRAS EVALUAR LAS CONDICIONES ANATÃ“MICAS Y ESTÃ‰TICAS DEL CASO, SE DETERMINÃ“ QUE LA PACIENTE ERA CANDIDATA IDEAL PARA UNA TERAPIA DE CIRUGÃ⍰A PLÃ⍰STICA PERIODONTAL.

SE PLANIFICÃ“ UN PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO DE RECUBRIMIENTO RADICULAR MEDIANTE LA TÃ‰CNICA DE TÃšNEL, UTILIZANDO UNA MATRIZ DÃ‰RMICA ACELULAR (MDA) COMO SUSTITUTO DEL INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO AUTÃ“LOGO. ESTA ELECCIÃ“N SE FUNDAMENTÃ“ EN LA NECESIDAD DE TRATAR MÃšLTIPLES RECESIONES EN AMBOS MAXILARES, REDUCIENDO EL TRAUMA QUIRÃšRGICO Y EVITANDO UNA SEGUNDA ZONA QUIRÃšRGICA DONANTE. LA PACIENTE FUE INFORMADA SOBRE EL TRATAMIENTO, SUS BENEFICIOS Y CUIDADOS POSTOPERATORIOS, ACEPTANDO EL PROCEDIMIENTO DE FORMA VOLUNTARIA MEDIANTE CONSENTIMIENTO INFORMADO.

SE HIDRATÃ“ LA MDA EN SOLUCIÃ“N FISIOLÃ“GICA ESTÃ‰RIL Y SE ADAPTÃ“ AL LECHO QUIRÃšRGICO. POSTERIORMENTE, SE INTRODUJO CUIDADOSAMENTE DENTRO DEL TÃšNEL CREADO, CUBRIENDO LAS SUPERFICIES RADICULARES EXPUESTAS. EL COLGAJO SE ESTABILIZÃ“ CORONALMENTE MEDIANTE SUTURAS SUSPENSORIAS PARA LOGRAR UNA COBERTURA RADICULAR ADECUADA.

Resultados y Conclusiones *

EN LOS CONTROLES POSTOPERATORIOS REALIZADOS AL MES Y A LOS DOS MESES, SE OBSERVÃ“ UNA COBERTURA RADICULAR SATISFACTORIA EN LA MAYORÃ⍰A DE LOS SITIOS TRATADOS, ASÃ⍰ COMO UN AUMENTO EN EL GROSOR DEL TEJIDO BLANDO. NO SE EVIDENCIARON COMPLICACIONES CLÃ⍰NICAS COMO INFLAMACIÃ“N, INFECCIÃ“N O EXPOSICIÃ“N DEL INJERTO, Y SE DOCUMENTÃ“ UNA INTEGRACIÃ“N ADECUADA DE LA MDA.

LA PACIENTE REFIRIÃ“ ALTA SATISFACCIÃ“N CON LOS RESULTADOS, DESTACANDO MEJORAS ESTÃ‰TICAS, DISMINUCIÃ“N DE LA SENSIBILIDAD DENTAL Y UNA RECUPERACIÃ“N CÃ“MODA, SIN DOLOR SIGNIFICATIVO.

LA TÃ‰CNICA DE TÃšNEL CON MATRIZ DÃ‰RMICA ACELULAR REPRESENTA UNA OPCIÃ“N SEGURA Y EFECTIVA PARA EL TRATAMIENTO DE RECESIONES GINGIVALES MÃšLTIPLES SIEMPRE QUE SE REALICE UNA PLANIFICACIÃ“N CUIDADOSA Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

Bibliografía *

MALONEY WJ, WEINBERG MA. IMPLEMENTATION OF THE AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS PHYSICAL STATUS CLASSIFICATION SYSTEM IN PERIODONTAL PRACTICE. J PERIODONTOL. 2008 JUL;79(7):1124-6. DOI: 10.1902/JOP.2008.070625. PMID: 18597592.

CATON JG, ARMITAGE G, BERGLUNDH T, CHAPPLE ILC, JEPSEN S, KORNMAN KS, MEALEY BL, PAPAPANOU PN, SANZ M, TONETTI MS. A NEW CLASSIFICATION SCHEME FOR PERIODONTAL AND PERI-IMPLANT DISEASES AND CONDITIONS - INTRODUCTION AND KEY CHANGES FROM THE 1999 CLASSIFICATION. J CLIN PERIODONTOL. 2018 JUN;45 SUPPL 20:S1-S8. DOI: 10.1111/JCPE.12935. PMID: 29926489.

LANG NP, BARTOLD PM. PERIODONTAL HEALTH. J PERIODONTOL. 2018 JUN;89 SUPPL 1:S9-S16. DOI: 10.1002/JPER.16-0517. PMID: 29926938.

Título del trabajo *

COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES DENTALES, REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA Y MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS EN DOS DEFECTOS CLASE III DE SEIBERT: REPORTE DE CASO.

Nombre del Autor (a/es)*

MELISSA JANETH RODRIGUEZ SEGOVIA

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

DAVID GOMEZ THOMAS, , RAUL MONTEMAYOR MARTINEZ, , EDUEN OBED PERERA SALAZAR, , , , .

Correo Electrónico *

melysegoviaa@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD AME

Introducción y Objetivos *

ANTECEDENTES Y OBJETIVO

LOS DEFECTOS CLASE III DE SEIBERT, REPRESENTAN UNO DE LOS MAYORES RETOS CLÃ□NICOS EN LA REHABILITACIÃ“N ORAL CON IMPLANTES DENTALES, DEBIDO A LA PÃ‰RDIDA COMBINADA DE VOLUMEN Ã“SEO HORIZONTAL Y VERTICAL, ADEMÃ□S DE LA AFECTACIÃ“N ESTÃ‰TICA DE LOS TEJIDOS BLANDOS.

ESTOS CASOS REQUIEREN UN ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO QUE INCLUYE REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA (ROG), MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS Y UNA RESTAURACIÃ“N PROTÃ‰SICA PRECISA.

EL OBJETIVO DE ESTE CASO CLÃ□NICO FUE RECUPERAR LA FUNCIÃ“N Y LA ESTÃ‰TICA EN DOS REBORDES ATRÃ“FICOS CLASE III MEDIANTE COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES, REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA Y MANEJO QUIRÃšRGICO MUCOGINGIVAL.

Descripción del Caso *

PRESENTACIÃ“N DEL CASO Y DIAGNÃ“STICO

PACIENTE FEMENINA DE 29 AÃ‘OS, ASA I, NO FUMADORA, CON ANTECEDENTES DE DOS TRATAMIENTOS ORTODÃ“NCICOS PREVIOS Y AUSENCIA DE Ã“RGANOS DENTALES 36 Y 46.

AL EXAMEN CLÃ□NICO SE OBSERVARON IRREGULARIDADES SEVERAS DEL REBORDE ALVEOLAR, CON PÃ‰RDIDA TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL COMPATIBLE CON DEFECTOS CLASE III DE SEIBERT.

EL ANÃ□LISIS PERIODONTAL PRESENTÃ“ SALUD GINGIVAL, NIC PROMEDIO DE 3 MM, Ã□NDICE DE BIOPELÃ□CULA DE 17% Y SANGRADO AL SONDEO DEL 6%.

SE REALIZÃ“ UNA PLANEACIÃ“N DIGITAL CON CBCT, ENCERADO DIAGNÃ“STICO Y ELABORACIÃ“N DE GUÃ□A QUIRÃšRGICA PARA ASEGURAR UN PROTOCOLO QUIRÃšRGICO PRECISO.

PROCEDIMIENTOS

EN LA FASE QUIRÃšRGICA INICIAL SE COLOCÃ“ UN IMPLANTE 4.5 X 10 MM (HIOSSEN TSIII SA), EN EL SITIO 46, JUNTO CON REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA SE UTILIZÃ“ 1 GRAMO DE XENOINJERTO PORCINO (GEN-OSÂ®) Y MEMBRANA DE COLÃ□GENO REABSORBIBLE 30X30MM (EVOLUTION Â®).

LA TÃ‰CNICA DE SUTURA EMPLEADA FUE COLCHONERO HORIZONTAL INTERNO COMPLEMENTADA CON PUNTOS SIMPLES INTERRUMPIDOS.

AL CABO DE TRES SEMANAS SE REALIZÃ“ EL MISMO PROCEDIMIENTO EN EL SITIO DE 36, DONDE SE COLOCÃ“ UN IMPLANTE 4.5 X 10 MM (HIOSSEN TSIII SA).

POSTERIORMENTE, SE REALIZÃ“ UNA CIRUGÃ□A DE SEGUNDA FASE CON COLGAJO DESPLAZADO APICALMENTE PARA AUMENTAR LA CANTIDAD DE ENCÃ□A QUERATINIZADA ALREDEDOR DE AMBOS IMPLANTES. DURANTE LA FASE RESTAURADORA SE TOMARON IMPRESIONES CON CUCHARILLA ABIERTA, COPINGS METÃ□LICOS Y MATERIAL (ELITE DH). LAS CORONAS DEFINITIVAS DE ZIRCONIA SE CEMENTARON TRAS AJUSTES OCLUSALES Y CONTROL ESTÃ‰TICO.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS

CLÃ?NICAMENTE SE LOGRÃ“ UN PERFIL DE EMERGENCIA ARMÃ“NICO, CON ENCÃ?A QUERATINIZADA ESTABLE, BUENA SALUD PERIIMPLANTARIA Y UN RESULTADO ESTÃ‰TICO Y FUNCIONAL ADECUADO.

A LOS 9 MESES, AMBOS IMPLANTES PRESENTABAN EXCELENTE ESTABILIDAD Y LAS RESTAURACIONES DE ZIRCONIA MOSTRABAN ADECUADA INTEGRACIÃ“N EN LA ARCADA.

LA PACIENTE REPORTÃ“ ALTA SATISFACCIÃ“N FUNCIONAL Y ESTÃ‰TICA.

CONCLUSIONES

EL TRATAMIENTO DE DEFECTOS CLASE III DE SEIBERT, MEDIANTE ROG Y MANEJO MUCOGINGIVAL PUEDE LOGRAR RESULTADOS PREDECIBLES CUANDO SE APLICA UNA PLANEACIÃ“N DIGITAL ADECUADA, BIOMATERIALES CONFIABLES Y UNA SECUENCIA QUIRÃšRGICA ORDENADA.

ESTE CASO DEMUESTRA LA IMPORTANCIA DE UN ABORDAJE INTEGRAL EN IMPLANTOLOGÃ?A AVANZADA PARA REHABILITAR ZONAS ESTÃ‰TICAMENTE COMPROMETIDAS Y FUNCIONALMENTE DESFAVORABLES.

Bibliografía *

REFERENCIAS BIBLIOGRÃ?FICAS:

1. MALONEY WJ, WEINBERG MA. IMPLEMENTATION OF THE AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS PHYSICAL STATUS CLASSIFICATION SYSTEM IN PERIODONTAL PRACTICE. J PERIODONTOL. 2008.

2. AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS (2014). ASA PHYSICAL STATUS CLASSIFICATION SYSTEM. RETRIEVED FROM: HTTPS://WWW.ASAHQ.ORG/RESOURCES/CLINICAL-INFORMATION/ASA-PHYSICAL-STATUS-CLASSIFICATION-SYSTEM

5. CATON JG, ARMITAGE G, BERGLUNDH T, CHAPPLE ILC, JEPSEN S, KORNMAN KS, MEALEY BL, PAPAPANOU PN, SANZ M, TONETTI MS. UN NUEVO ESQUEMA DE CLASIFICACIÃ“N PARA ENFERMEDADES Y AFECCIONES PERIODONTALES Y PERIIMPLANTARIAS: INTRODUCCIÃ“N Y CAMBIOS CLAVE CON RESPECTO A LA CLASIFICACIÃ“N DE 1999. J CLIN PERIODONTOL. 2018 JUN;45 SUPPL 20:S1-S8.

Título del trabajo *

AUMENTO DE TEJIDO QUERATINIZADO CON COLOCACIÃ“N SIMULTÃ□NEA DE IMPLANTES DENTALES EN UN PACIENTE EDÃ‰NTULO TOTAL (REPORTE DE UN CASO)

Nombre del Autor (a/es)*

Raquel Abigail Silva Rocha

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

David Thomas GÃ³mez, RaÃºl Montemayor MartÃ-nez, Eduen Obed Perera Salazar, , , , , , .

Correo Electrónico *

rsilvaa83@gmail.com

Institución *

AME UNIVERSIDAD

Introducción y Objetivos *

ANTECEDENTES Y OBJETIVO

LA TERAPIA CON IMPLANTES DENTALES HA DEMOSTRADO SER UNA EXCELENTE ALTERNATIVA PARA LA SUSTITUCIÃ“N DE Ã“RGANOS DENTARIOS PERDIDOS, ACTUALMENTE DICHA TERAPIA ES CONSIDERADA COMO UNA EXCELENTE ALTERNATIVA PARA EL TRATAMIENTO Y REHABILITACIÃ“N EN PACIENTES CON EDENTULISMO TOTAL.

LAS SOBREDENTADURAS SOSTENIDAS POR IMPLANTES DENTALES PROPORCIONAN UNA MEJORA SIGNIFICATIVA EN ESTABILIDAD, RETENCIÃ“N, FUERZA MÃ XIMA DE MORDIDA, SATISFACCIÃ“N DEL PACIENTE Y CALIDAD DE VIDA. LA UNIÃ“N PRIMARIA DE LOS IMPLANTES MEDIANTE EL USO DE SISTEMAS CON BARRAS O DISEÃ‘OS NO UNIDOS, POR EJEMPLO, CONEXIONES BOLA O TIPO LOCATOR, RESULTA EN UNA ALTA SUPERVIVENCIA DE LOS IMPLANTES. 1

EL DESARROLLO DE LA IMPLANTOLOGÃ A ORAL HA HECHO POSIBLE LA REALIZACIÃ“N DE UNA TERAPÃ‰UTICA MÃ S FAVORABLE PARA EL PACIENTE EDÃ‰NTULO TOTAL, EVIDENCIA CIENTÃ FICA ACTUAL HA DEMOSTRADO QUE LA INSERCIÃ“N DE 2 A 4 IMPLANTES DENTALES COLOCADOS EN EL ESPACIO INTERFORAMINAL ANTERIOR, PUEDEN SOPORTAR UNA SOBREDENTADURA EN LA MANDÃ BULA EDÃ‰NTULA CON UN Ã‰XITO SUPERIOR AL 90-95%2, SIEMPRE Y CUANDO LAS CONDICIONES SEAN IDÃ“NEAS, EN ESTE SENTIDO ES DE SUMA IMPORTANCIA EL CORRECTO DIAGNÃ“STICO, ASÃ COMO LA DETECCIÃ“N OPORTUNA DE DEFORMIDADES O DEFICIENCIAS EN LOS TEJIDOS BLANDOS Y DUROS.

EL INJERTO GINGIVAL LIBRE ES EL GOLD STRANDARD PARA AQUELLOS CASOS DONDE EXISTE AUSENCIA DE TEJIDO GINGIVAL QUERATINIZADO Y SE PRETENDE COLOCAR IMPLANTES DENTALES, SE HA DEMOSTRADO QUE AUMENTA LA SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO YA QUE PRESENTA FACTORES COMO IMPERMEABILIDAD Y LA CAPACIDAD DE PROTECCIÃ“N A LA MUCOSA MASTICATORIA, LAS CUALES PROTEGEN AL TEJIDO PERIODONTAL Y PERI-IMPLANTAR, ADEMÃ S BRINDA OTROS BENEFICIOS COMO LA OBTENCIÃ“N UNA MAYOR PROFUNDIDAD DE VESTÃ BULO Y LA ELIMINACIÃ“N DE FRENILLOS ABERRANTES.3

EL OBJETIVO DEL PRESENTE REPORTE DE CASO ES DESCRIBIR EL PROCESO DE PLANEACIÃ“N QUIRÃšRGICO Y PROTÃ‰SICO PARA LA COLOCACIÃ“N DE UNA SOBREDENTADURA SOPORTADA POR DOS IMPLANTES DENTALES, ASÃ COMO LA ADECUACIÃ“N DE LOS TEJIDOS BLANDOS PARA OBTENER UN PERIODONTO ESTABLE.

Descripción del Caso *

PRESENTACIÃ“N DEL CASO Y DIAGNÃ“STICO

PACIENTE FEMENINA DE 57 AÃ‘OS DE EDAD ASA II DIABÃ‰TICA CONTROLADA ACUDE A LAS CLÃ NICAS ODONTOLÃ“GICAS DE AME UNIVERSIDAD CON UN MOTIVO DE CONSULTA Â¨QUIERO CON UNA PRÃ“TESIS DENTALÂ¨ A LA EXAMINACIÃ“N INTRAORAL SE OBSERVAN TEJIDOS BLANDOS COLOR ROSA PÃ LIDO, AUSENCIA TOTAL DE Ã“RGANOS DENTARIOS E IRREGULARIDAD EN EL REBORDE EDÃ‰NTULO CLASE III DE SEIBERT ASÃ COMO FALTA DE ENCÃ A QUERATINIZADA, EN EL ESTUDIO HISTOTOMOGRÃ FICO SE CONSTATÃ“ UN ADECUADLO GROSOR Ã“SEO, LO QUE NOS PERMITIÃ“ OPTAR POR LA TERAPIA CON IMPLANTES DENTALES.

SE DECIDIÃ“ COLOCAR 2 IMPLANTES EN Ã REAS DE Ã“RGANOS DENTALES CORRESPONDIENTES A 33 Y 43, ASÃ COMO INJERTOS GINGIVALES LIBRES EN DICHAS Ã REAS CON EL OBJETIVO DE AUMENTAR EL ANCHO DE ENCÃ A QUERATINIZADA Y LOGRAR UNA MAYOR PROFUNDIDAD DE VESTÃ BULO.

DENTRO DE LA FASE PROTÃ‰SICA SE DECIDIÃ“ COLOCAR UNA PRÃ“TESIS ACRÃ LICA CON SISTEMA LOCATORS.

PROCEDIMIENTOS

SE ANESTESIÃ“ CON ARTICAÃ NA AL 4% CON VASOCONSTRICTOR, POSTERIORMENTE SE PROCEDIÃ“ A PROBAR GUÃ A QUIRÃšRGICA ANALÃ“GICA LA CUAL TUVO UN CORRECTO ASENTAMIENTO, SE REALIZÃ“ UN COLGAJO DE ESPESOR TOTAL Y SE PROCEDIÃ“ A REALIZAR EL PROTOCOLO DE FRESADO QUIRÃšGICO ADIN PARA IMPLANTES 3.5X10MM, DURANTE TODO EL PROCEDIMIENTO SE USÃ“ COMO REFERENCIA LA GUÃ A Y SE FINALIZÃ“ CON LA COLOCACIÃ“N DE PUNTOS SIMPLES CON NYLON 4-0.

EN UN SEGUNDO TIEMPO QUIRÃšRGICO SE REALIZÃ“ FASE II DE AMBOS IMPLANTES BASÃ NDONOS EN LAS INCISIONES ANTERIORES Y SE COLOCARON TORNILLOS DE CICATRIZACIÃ“N, SIMULTÃ NEAMENTE SE DECIDIÃ“ COLOCAR DOS INJERTOS DE TEJIDO GINGIVAL LIBRE EN VESTIBULAR DE AMBOS IMPLANTES PARA CREAR ENCÃ A QUERATINIZADA AUSENTE Y OBTENER UNA MAYOR PROFUNDIDAD DE VESTÃ BULO.

DENTRO DE LA PROTÃ‰SICA SE COLOCÃ“ UNA PRÃ“TESIS TOTAL SUPERIOR ACRÃ LICA Y UNA PRÃ“TESIS TOTAL INFERIOR ACRÃ LICA IMPLANTO MUCOSOPORTADA CON LOCATORS EN ESPACIO DE Ã“RGANOS DENTARIOS 33 Y 43.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS

SE OBTUVIERON RESULTADOS FAVORABLES A LOS DOS MESES DE CICATRIZACIÃ“N, TENIENDO COMO GANANCIA 8 MILÃ METROS AGREGADOS DE ENCÃ A QUERATINIZADA A LOS 2 MILÃ METROS QUE PRESENTABA LA PACIENTE, EN LA ZONA VESTIBULAR, DE LA CRESTA A LA LÃ NEA MUCOGINGIVAL.

CONCLUSIONES

LAS SOBREDENTADURAS SOPORTADAS POR IMPLANTES DENTALES HAN DEMOSTRADO SER UNA EXCELENTE ALTERNATIVA PARA AQUELLOS CASOS DONDE POR INCOMODIDAD O POR MALA ADAPTACIÃ“N DE LAS PRÃ“TESIS EL PACIENTE SE ENCUENTRA RENUENTE A EL USO DE LAS MISMAS, EXISTE SUFICIENTE EVIDENCIA QUE SUSTENTA EL Ã‰XITO A LARGO PLAZO DE DICHO SISTEMA SIEMPRE Y CUANDO LAS CONDICIONES SEAN IDEALES.

LA AUSENCIA DE ENCÃ A QUERATINIZADA ALREDEDOR DEL TEJIDO PERIIMPLANTARIO, PODRÃ A CONDUCIR A UNA HIGIENE BUCAL INADECUADA, ACUMULACIÃ“N DE PLACA, INFLAMACIÃ“N DE LA MUCOSA, SANGRADO AL SONDEO, MIGRACIÃ“N APICAL DE LA MUCOSA Y PÃ‰RDIDA Ã“SEA PERI-IMPLANTAR QUE PODRÃ A INFLUIR NEGATIVAMENTE EN EL MANTENIMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS IMPLANTES DENTALES Y PRÃ“TESIS. SE HA DEMOSTRADO QUE SE NECESITA UNA CANTIDAD ?2 MM DE TEJIDO QUERATINIZADO PARA MANTENER LA SALUD DE LOS TEJIDOS PERIODONTALES Y PERIIMPLANTARIOS.

EL INJERTO GINGIVAL LIBRE ES UNA TÃ‰CNICA EXITOSA Y PREDECIBLE QUE PODRÃ A PREVENIR PROBLEMAS EN LOS TEJIDOS DUROS Y BLANDOS QUE SE DESARROLLAN DESPUÃ‰S DE LA REHABILITACIÃ“N CON IMPLANTES.

PALABRAS CLAVE: IMPLANTES DENTALES, PROFUNDIZACIÃ“N DE VESTÃ BULO, INJERTO LIBRE

Bibliografía *

BIBLIOGRAFÃ A:

1. ELSYAD MA, MAHANNA FF, ELSHAHAT MA, ELSHOUKOUKI AH. LOCATORS VERSUS MAGNETIC ATTACHMENT EFFECT ON PERI-IMPLANT TISSUE HEALTH OF IMMEDIATE LOADED TWO IMPLANTS RETAINING A MANDIBULAR OVERDENTURE: A 1-YEAR RANDOMISED TRIAL. JOURNAL OF ORAL REHABILITATION. 2015 NOV 9;43(4):297â€“305.

2. ORTEGA V, MONSALVE GUIL, L, ORTIZ GARCÃ A, I, GUERRA J, GARRIDO M, EGEA S. SOBREDENTADURAS MANDIBULARES SOBRE DOS IMPLANTES EN PACIENTES EDÃ‰NTULOS TOTALES: UN ESTUDIO A TRES AÃ‘OS. AVANCES EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÃ A ORAL. 2015, 27(3):109â€“16.

3. ZUCCHELLI G, TAVELLI L, MCGUIRE MK, RASPERINI G, FEINBERG SE, WANG H, ET AL. AUTOGENOUS SOFT TISSUE GRAFTING FOR PERIODONTAL AND PERI?IMPLANT PLASTIC SURGICAL RECONSTRUCTION. JOURNAL OF PERIODONTOLOGY. 2019 OCT 6;91(1):9â€“16.

4. KAPPEL S, GIANNAKOPOULOS NN, EBERHARD L, RAMMELSBERG P, EIFFLER C. IMMEDIATE LOADING OF DENTAL IMPLANTS IN EDENTULOUS MANDIBLES BY USE OF LOCATORÂ® ATTACHMENTS OR DOLDERÂ® BARS: TWO-YEAR RESULTS FROM A PROSPECTIVE RANDOMIZED CLINICAL STUDY. CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED

Título del trabajo *

PLANEACIÃ“N DIGITAL QUIRÃšRGICA Y PROTÃ‰SICA SOBRE 4 IMPLANTES DENTALES EN MAXILAR INFERIOR

Nombre del Autor (a/es)*

Joselene Anel Rangel Gaytan

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

David Gomez Thomas Gomez, Raul Montemayor Martinez, Eduen Obed Perea Salazar, , , , , , .

Correo Electrónico *

joselinerangel26@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD AME

Introducción y Objetivos *

LA PLANIFICACIÃ“N DIGITAL EN IMPLANTOLOGÃ⍰A PERMITE OPTIMIZAR RESULTADOS FUNCIONALES Y ESTÃ‰TICOS, EN LA PLANIFICACIÃ“N PREOPERATORIA Y LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES, SE HA DEMOSTRADO QUE EL USO DE UN SOFTWARE DE PLANIFICACIÃ“N SEGUIDO DE LA CREACIÃ“N DE GUÃ⍰AS QUIRÃšRGICAS INDIVIDUALES MEJORA LOS RESULTADOS DEL TRATAMIENTO ASÃ⍰ COMO LA PRECISIÃ“N POSICIONAL DEL IMPLANTE EN COMPARACIÃ“N CON LA TÃ‰CNICA ANALÃ“GICA.

EL USO DE GUÃ⍰AS, ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS FLAPLESS, SE ASOCIA CON UNA MENOR INCIDENCIA DE COMPLICACIONES QUIRÃšRGICAS Y POSTOPERATORIAS, COMO DOLOR, EDEMA Y PUEDE MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE EN EL PERIODO INMEDIATO TRAS LA CIRUGÃ⍰A LO QUE FAVORECE LA CICATRIZACIÃ“N, REDUCE EL MALESTAR, FACILITA LA REHABILITACIÃ“N FUNCIONAL Y ESTÃ‰TICA, OPTIMIZA LA CARGA OCLUSAL Y REDUCE LA NECESIDAD DE INTERVENCIONES CORRECTIVAS POSTERIORES.

LA CIRUGÃ⍰A GUIADA OFRECE UNA MAYOR Â PREDICTIBILIDAD EN LA TRANSFERENCIA DEL PLAN QUIRÃšRGICO AL PACIENTE, LO QUE ES ESPECIALMENTE RELEVANTE EN CASOS COMPLEJOS O EN MAXILARES EDÃ‰NTULOS.

LA INDICACIÃ“N DE LAS GUÃ⍰AS QUIRÃšRGICAS DIGITALES EN LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES ES TRANSFERIR CON PRECISIÃ“N EL PLAN DE TRATAMIENTO VIRTUAL AL CAMPO QUIRÃšRGICO, LO QUE PERMITE LA INSERCIÃ“N DEL IMPLANTE EN LA POSICIÃ“N, ANGULACIÃ“N Y PROFUNDIDAD Ã“PTIMAS PREVIAMENTE PLANIFICADAS. ESTO SE TRADUCE EN UNA MAYOR EXACTITUD EN LA UBICACIÃ“N DEL IMPLANTE RESPECTO A LAS ESTRUCTURAS ANATÃ“MICAS CRÃ⍰TICAS, EN ESTE SENTIDO SE DISMINUYEN RIESGOS QUIRÃšRGICOS Y SE MEJORAN LOS RESULTADOS TANTO FUNCIONALES COMO ESTÃ‰TICOS A LARGO PLAZO.

Descripción del Caso *

PACIENTE MASCULINO DE 68 AÃ‘OS DE EDAD, ASA II CON ANTECEDENTES MÃ‰DICOS DE PARKINSON Y DIABETES CONTROLADA, NO FUMADOR Y NO CONSUME ALCOHOL, ACUDE AL POSGRADO DE PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÃ A ORAL EN LA UNIVERSIDAD AME SOLICITANDO TRATAMIENTO DE IMPLANTES DENTALES.

A LA EXPLORACIÃ“N EXTRAORAL NO PRESENTO SIGNOS CLÃ NICOS PATOLÃ“GICOS, A LA EXPLORACIÃ“N INTRAORAL PRESENTÃ“ GUÃ AS CANINAS CLASE I, AUSENCIA DE GUÃ AS MOLARES, A LA EXPLORACIÃ“N PERIODONTAL PRESENTO PROFUNDIDADES AL SONDEO QUE VAN DE LOS 2 A LOS 4 MM Y UN NIVEL DE INSERCIÃ“N CLÃ NICO MÃ XIMO DE 5 MM, TEJIDOS BLANDOS COLOR ROSA PÃ LIDO ASÃ COMO AUSENCIA DE Ã“RGANOS DENTARIOS 3.6,3.7,4.7, REGIÃ“N CORRESPONDIENTE A 4.6 SE IDENTIFICA UN RESTO RADICULAR, RADIOGRAFICAMENTE PERDIDA DE CONTINUIDAD EN LA LAMINA DURA EN ZONAS LOCALIZADAS POR LO QUE SE CLASIFICO COMO PERIODONTITIS ESTADIO I LOCALIZADO GRADO B.

UNA VEZ REALIZADA LA FASE HIGIÃ‰NICA Y REVALUACIÃ“N SE ESTABLECIÃ“ UN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PERIODONTAL Y SE INDICA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES POST EXTRACCIÃ“N MEDIANTE PLANEACIÃ“N DE PROTOCOLO GUIADO Y PLANEACIÃ“N PROTÃ‰SICA.

BAJO ANESTESIA LOCAL EN ZONAS A TRATAR CUADRANTES III Y IV SE PRESENTÃ“ GUÃ A QUIRÃšRGICA DIGITAL PARA IMPLANTES 36,37,46,47, SE PROCEDIÃ“ A LA COLOCACIÃ“N DE LOS IMPLANTES CON TÃ‰CNICA DE TISSUE PUNCH Y SE REALIZÃ“ EL FRESADO QUIRÃšRGICO SIGUIENDO PROTOCOLO DE FRESADO HIOSSEN , SE COLOCARON LOS IMPLANTES SEGUIDO DE TAPAS DE CIERRE.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

EVIDENCIA CIENTÃ FICA ACTUAL MUESTRA QUE LA CIRUGÃ A GUIADA EN CASOS DONDE ESTABA INDICADA Y EL PACIENTE ES CANDIDATO MUESTRA TASAS DE Ã‰XITO ELEVADAS Y BAJA INCIDENCIA DE COMPLICACIONES, SIEMPRE QUE SE REALICE UNA PLANIFICACIÃ“N INDIVIDUALIZADA.

EL USO DE GUÃ AS QUIRÃšRGICAS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS Y ENFERMEDAD DE PARKINSON, TIENE UNA MEJOR PRECISIÃ“N, REDUCE EL TRAUMA QUIRÃšRGICO Y PUEDE CONTRIBUIR A UNA MEJOR EVOLUCIÃ“N POSTOPERATORIA.

ESTE TIPO DE GUÃ AS QUIRÃšRGICAS FACILITA PROCEDIMIENTOS Y LOS HACE MENOS INVASIVOS, REDUCE LA VARIABILIDAD OPERATORIA, Y PUEDE SER ESPECIALMENTE ÃšTIL PARA CLÃ NICOS CON MENOR EXPERIENCIA, YA QUE DISMINUYE LA DESVIACIÃ“N RESPECTO AL PLAN PREOPERATORIO Y CONTRIBUYE A LA PREDICTIBILIDAD DEL TRATAMIENTO.

Bibliografía *

1.GUIDED AND NAVIGATION IMPLANT SURGERY: A SYSTEMATIC REVIEW.?AGHALOO T, HADAYA D, SCHOENBAUM TR, PRATT L, FAVAGEHI M.?THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS. 2023 MAY-JUN;38(SUPPL):7-15. DOI:10.11607/JOMI.10465.

2.THE CLINICAL ACCURACY OF THE IMPLANT DIGITAL SURGICAL GUIDE: A META-ANALYSIS.?ZHANG F, GAO X, YE ZY, XU DQ, DING X. AMERICAN JOURNAL OF DENTISTRY. 2020;33(6):296-304.

3.FULLY GUIDED VERSUS HALF-GUIDED AND FREEHAND IMPLANT PLACEMENT: SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS.?GARGALLO-ALBIOL J, BAROOTCHI S, MARQUÃ‰S-GUASCH J, WANG HL. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS. 2020 NOV/DEC;35(6):1159-1169. DOI:10.11607/JOMI.7942.

4.COMPARISON OF IMPLANT PRECISION WITH ROBOTS, NAVIGATION, OR STATIC GUIDES. SHI JY, WU XY, LV XL, ET AL. JOURNAL OF DENTAL RESEARCH. 2025;104(1):37-44. DOI:10.1177/00220345241285566. LEADING JOURNAL NEW RESEARCH

5.COMPARISON OF IMPLANTATION ACCURACY AMONG DIFFERENT NAVIGATED APPROACHES: A SYSTEMATIC REVIEW AND NETWORK META-ANALYSIS. KANG S. HOU Y. CAO J. ET AL. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL &

Título del trabajo *

MODIFICACIÃ“N DEL FENOTIPO PERIODONTAL POR REQUERIMIENTOS ORTODÃ“NCICOS: REPORTE DE CASO.

Nombre del Autor (a/es)*

Jaime Antonio Enriquez Herrera

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

David Gomez Thomas, , , , , , , , .

Correo Electrónico *

jaimenriquezh@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD AME

Introducción y Objetivos *

EL FENOTIPO PERIODONTAL SE DEFINE COMO LOS ATRIBUTOS DISTINTIVOS QUE CARACTERIZAN LA PRESENTACIÃ“N CLÃ NICA DE LOS TEJIDOS INTRAORALES: COLOR, DIMENSIONES, MORFOLOGÃ A Y TOPOGRAFÃ A DE LA MUCOSA, HUESO CIRCUNDANTE Y SOPORTE DENTAL.3 LO ENCONTRAMOS CLÃ NICAMENTE EN 3 PRESENTACIONES: DELGADO FESTONEADO, GRUESO PLANO Y GRUESO FESTONEADO.Â EL FENOTIPO PERIODONTAL SE DETERMINA CON LA MEDIDA DEL ANCHO DEL TEJIDO QUERATINIZADO Y DEL ESPESOR Ã“SEO DE LA CORTICAL VESTIBULAR. EXISTE UNA CORRELACIÃ“N DIRECTA ENTRE EL FENOTIPO Ã“SEO Y GINGIVAL. LOS SITIOS QUE PRESENTAN UN FENOTIPO PERIODONTAL DELGADO CUENTAN CON ALTA INCIDENCIA DE LESIONES CERVICALES NO CARIOSAS, RECESIONES GINGIVALES Y PÃ‰RDIDA DE TEJIDOS PERIODONTALES.

UN MOVIMIENTO DENTAL ORTODÃ“NCICO EXCESIVO EN DIRECCIÃ“N BUCAL PUEDE ORIGINAR UNA INTERRUPCIÃ“N DEL PROCESO ALVEOLAR POR LA RAÃ Z DEL DIENTE, LA PÃ‰RDIDA DE LA CORTICAL Ã“SEA VESTIBULAR Y DEL TEJIDO CONECTIVO MARGINAL ASÃ COMO EL CONSECUENTE DESARROLLO DE RECESIONES GINGIVALES, ESPECIALMENTE EN SITIOS CON UN FENOTIPO DELGADO. DEL 20 AL 35% DE LOS PACIENTES CON ORTODONCIA DESARROLLAN RECESIONES GINGIVALES 2 - 5 AÃ‘OS DESPUÃ‰S DEL TRATAMIENTO.

LA TERAPIA DE MODIFICACIÃ“N DE FENOTIPO, SON TÃ‰CNICAS UTILIZADAS PARA TRANSFORMAR EL FENOTIPO PERIODONTAL DE DELGADO A GRUESO AL INTEGRAR PROCEDIMIENTOS DE AUMENTO DE TEJIDOS DUROS, BLANDOS O AMBOS.

EL USO DE SUSTITUTOS DE INJERTOS DE TEJIDO AUTÃ“LOGO REDUCE MORBILIDAD, RIESGO DE COMPLICACIONES, TIEMPO QUIRÃšRGICO, SITIOS QUIRÃšRGICOSÂ Y CUENTA CON MAYOR ACEPTACIÃ“N DE PARTE DEL PACIENTE, ADEMÃ S SOLUCIONA PROBLEMAS COMO LA LIMITACIÃ“N EN EL VOLUMEN DEL TEJIDO DISPONIBLE PARA LA INTERVENCIÃ“N PLANEADA.

EL OBJETIVO DEL PRESENTE ESCRITO ES DESCRIBIR LA RELEVANCIA DE LA MODIFICACIÃ“N DE FENOTIPO PERIODONTAL EN LOS ESCENARIOS CLÃ NICOS COMPLICADOS, MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, FUNCIÃ“N ORAL, ESTÃ‰TICA, PRONÃ“STICO DE DIENTES AFECTADOS Y PREVENIR LA PROGRESIÃ“N DE DEFORMIDADES PERIODONTALES MEJORANDO LA TERAPIA INTERDISCIPLINARIA.

PALABRAS CLAVE: FENOTIPO PERIODONTAL, INJERTOS DE TEJIDO, MATRIZ DÃ‰RMICA ACELULAR.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINO DE 14 AÃ‘OS, SIN DATO CLÃ□NICO PATOLÃ“GICO, NO ENFERMEDADES SISTÃ‰MICAS Y REFIERE NO TOMAR MEDICAMENTOS, SE PRESENTÃ“ ASINTOMÃ□TICO A LA CLÃ□NICA DE PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÃ□A DE LA UNIVERSIDAD AME REFERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ORTODONCIA, SOLICITANDO VALORAR VESTÃ□BULO ANTEROINFERIOR. A LA EXPLORACIÃ“N INTRAORAL, PRESENTÃ“ APARATOLOGÃ□A ORTODÃ“NCICA, MIENTRAS QUE A LA EXPLORACIÃ“N PERIODONTAL PRESENTÃ“ UN FENOTIPO PERIODONTAL DELGADO FESTONEADO3, UNA BANDA DE ENCÃ□A QUERATINIZADA CON UN PROMEDIO DE 3MM, ASÃ□ COMO BIOFILM GENERALIZADO, SIN PRESENCIA DE BOLSAS PERIODONTALES, CLASIFICADA CON UN PERIODONTO SANO. CON EL ESTUDIO DE IMAGEN CBCT SE CONSTATÃ“ EL GROSOR INSUFICIENTE DE LA CORTICAL Ã“SEA VESTIBULAR EN SECTOR ANTERIOR DEL CUERPO MANDIBULAR.

CON LOS RESULTADOS CLÃ□NICOS Y RADIOGRÃ□FICOS SE DECIDIÃ“ REALIZAR MODIFICACIÃ“N DEL FENOTIPO PERIODONTAL, DADA LA EXTENSIÃ“N DE TEJIDOS A AUMENTAR, SE DECIDE UTILIZAR UN SUSTITUTO ALOGÃ‰NICO.

SIETE DÃ□AS POSTERIOR AL RASPADO CORONAL Y CONTROL DE BIOFILM, SE REALIZÃ“ EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO:

BAJO ANESTESIA LOCAL, SE REALIZÃ“ COLGAJO DE ESPESOR TOTAL DE Ã“RGANO DENTARIO 3.5 A 4.5,Â SE COLOCÃ“ INJERTO Ã“SEO Y DE TEJIDOS BLANDOS CON XENOINJERTO Ã“SEO + MATRIZ DÃ‰RMICA ACELULAR (20X40MM THICK) UTILIZADA COMO MEMBRANA Y FIJADA CON TACHUELAS. SE REFORZÃ“ LA ESTABILIDAD DE LOS BIOMATERIALES CON SUTURAS (VYCRIL 6-0) Y SE REALIZÃ“ UN AVANCE CORONAL Y SUTURA DEL COLGAJO A SU POSICIÃ“N ORIGINAL CON PUNTOS SUSPENSORIOS (NYLON 6-0). (FIG. 3) LAS INDICACIONES POSTOPERATORIAS FUERON EXPLICADAS AL PACIENTE Y TUTORES, LA FARMACOTERAPIA INDICADA FUE AMOXICILINA + Ã□C. CLAVULÃ□NICO 875/125MG E IBUPROFENO 600MG. SE RETIRARON PUNTOS DE SUTURA A LAS 3 SEMANAS.

Resultados y Conclusiones *

SE REALIZÃ“ REVALUACIÃ“N CLÃ NICA Y TOMOGRÃ FICA 6 MESES POSTERIORES AL PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO DONDE SE CONSTATÃ“Â GANANCIA DE TEJIDO Ã“SEO, ASÃ COMO UN EVIDENTE ENGROSAMIENTO DEL FENOTIPO GINGIVAL.

LA MODIFICACIÃ“N DEL FENOTIPO PERIODONTAL A PARTIR DEL AUMENTO Ã“SEO Y GINGIVAL PREVIENE LA APARICIÃ“N Y PROGRESIÃ“N DE DEFECTOS PERIODONTALES Y RETRASA O REVIERTE LOS DAÃ‘OS A LOS TEJIDOS PERIODONTALES POR MOVIMIENTOS ORTODÃ“NCICOS EXCESIVOS, TALES COMO: LA INTERRUPCIÃ“N DEL PROCESO ALVEOLAR POR LA RAÃZ DEL DIENTE, LA PÃ‰RDIDA DE LA CORTICAL Ã“SEA VESTIBULAR Y LA PÃ‰RDIDA DEL TEJIDO CONECTIVO MARGINAL ASÃ COMO EL CONSECUENTE DESARROLLO DE RECESIONES GINGIVALES.

EN EL PRESENTE ESCRITO, SE MUESTRA EL CASO DE UN PACIENTE JOVEN CON ALTO RIESGO DE PADECER COMPLICACIONES RESULTANTES DE MOVIMIENTOS ORTODÃ“NCICOS DEBIDO A SU FENOTIPO PERIODONTAL DELGADO; SE REALIZÃ“ UNA MODIFICACIÃ“N DEL FENOTIPO GINGIVAL CON EL USO DE UNA MATRIZ ACELULAR DÃ‰RMICA Y DEL FENOTIPO Ã“SEO (CORTICAL VESTIBULAR) CON XENOINJERTO.

LOS RESULTADOS DE LA TERAPIA UTILIZADA PARA TRATAR AL PACIENTE FUERON REVALUADOS 6 MESES POSTERIORES A LA CIRUGÃA, DANDO COMO RESULTADO UNA GANANCIA DE TEJIDO Ã“SEO, ASÃ COMO UN EVIDENTE ENGROSAMIENTO DEL FENOTIPO GINGIVAL.

CONCLUSIÃ“N:Â

EN PACIENTES PRÃ“XIMOS, BAJO TRATAMIENTO O QUE HAYAN SIDO PREVIAMENTE SOMETIDOS A ORTODONCIA, SOBRE TODO EN AQUELLOS QUE PRESENTEN UN FENOTIPO PERIODONTAL DELGADO, SE DEBE REALIZAR UN

Bibliografía *

CHAMBRONE, L., & GARCIA-VALENZUELA, F. S. (2023). PERIODONTAL PHENOTYPE MODIFICATION OF COMPLEXES PERIODONTAL-ORTHODONTIC CASE SCENARIOS: A CLINICAL REVIEW ON THE APPLICATIONS OF ALLOGENOUS DERMAL MATRIX AS AN ALTERNATIVE TO SUBEPITHELIAL CONNECTIVE TISSUE GRAFT. JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY : OFFICIAL PUBLICATION OF THE AMERICAN ACADEMY OF ESTHETIC DENTISTRY ... [ET AL.], 35(1), 158â€“167.

MALPARTIDA-CARRILLO, V., TINEDO-LOPEZ, P. L., GUERRERO, M. E., AMAYA-PAJARES, S. P., Ã–ZCAN, M., & RÃ–SING, C. K. (2021). PERIODONTAL PHENOTYPE: A REVIEW OF HISTORICAL AND CURRENT CLASSIFICATIONS EVALUATING DIFFERENT METHODS AND CHARACTERISTICS. JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY : OFFICIAL PUBLICATION OF THE AMERICAN ACADEMY OF ESTHETIC DENTISTRY ... [ET AL.], 33(3), 432â€“445.

COOK DR, MEALEY BL, VERRETT RG, ET AL. RELATIONSHIP BETWEEN CLINICAL PERIODONTAL BIOTYPE AND LABIAL PLATE THICKNESS: AN IN VIVO STUDY. LNT J PERIODONTICS RESTORATIVE DENT 2011;31:345-354.

FROST NA, MEALEY BL, JONES AA, HUYNH-BA G. PERIODONTAL BIOTYPE: GINGIVAL THICKNESS AS IT RELATES TO PROBE VISIBILITY AND BUCCAL PLATE THICKNESS. J PERIODONTOL 2015;86:1141-1149.

Título del trabajo *

COLOCACIÃ“N DE IMPLANTE TARDÃ O GUIADO, HEALING PERSONALIZADO E INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO, REPORTE DE CASO

Nombre del Autor (a/es)*

Mario Alberto Rodriguez Mata

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

David Gomez Thomas, Jaime Antonio Enriquez Herrera, , , , , , , .

Correo Electrónico *

mario-mata@hotmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD AME

Introducción y Objetivos *

LA COLOCACIÃ“N TARDÃ□A DE IMPLANTES DENTALES EN LA REGIÃ“N POSTERIOR MANDIBULAR REQUIERE UNA CUIDADOSA EVALUACIÃ“N DE DIVERSOS FACTORES ANATÃ“MICOS, BIOLÃ“GICOS Y PROTÃ‰SICOS PARA OPTIMIZAR LOS RESULTADOS CLÃ□NICOS.

EN CUANTO AL Ã‰XITO, KIM JK EN 2017 MUESTRA QUE LOS IMPLANTES COLOCADOS DE MANERA DIFERIDA EN LA REGIÃ“N POSTERIOR MANDIBULAR PRESENTAN TASAS DE SUPERVIVENCIA ELEVADAS Y ESTABLES A MEDIANO Y LARGO PLAZO, CON UNA REMODELACIÃ“N Ã“SEA MARGINAL LIMITADA Y ESTABLE DESPUÃ‰S DEL PRIMER AÃ‘O. LA PÃ‰RDIDA Ã“SEA MARGINAL SUELE ESTABILIZARSE TRAS EL PRIMER AÃ‘O, Y SE HA OBSERVADO GANANCIA Ã“SEA EN ALGUNOS CASOS, ESPECIALMENTE CUANDO SE ASEGURA UN GROSOR ADECUADO DE ENCÃ□A QUERATINIZADA Y UNA POSICIÃ“N CORRECTA DEL IMPLANTE.

LA CIRUGÃ□A DE IMPLANTES GUIADA OFRECE VARIAS VENTAJAS CLÃ□NICAS BIEN DOCUMENTADAS EN LITERATURA ACTUAL COMO: MAYOR PRECISIÃ“N Y PREDICTIBILIDAD EN LA COLOCACIÃ“N DEL IMPLANTE, OPTIMIZACIÃ“N DE LA PLANIFICACIÃ“N PROTÃ‰SICA Y ESTÃ‰TICA, MENOR INVASIVIDAD, MEJOR EXPERIENCIA POSTOPERATORIA, REDUCCIÃ“N DE COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS, FACILITA LA CARGA INMEDIATA Y PERMITE ABORDAR CASOS COMPLEJOS DE UNA MANERA MAS SEGURA.

LA COLOCACIÃ“N DE UN HEALING PERSONALIZADO EN CONJUNTO CON INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO DA COMO RESULTADO UNA MEJORA SIGNIFICATIVA EN LA CICATRIZACIÃ“N DE LOS TEJIDOS BLANDOS Y FACILITA LA FASE PROTÃ‰SICA. SU IMPORTANCIA RADICA EN QUE MANTIENE Y MOLDEA EL PERFIL DE EMERGENCIA LO CUAL RESULTA EN UNA ARQUITECTURA GINGIVAL ARMÃ“NICA.

OBJETIVOS

EL OBJETIVO DEL PRESENTE REPORTE DE CASO ES MOSTRAR LA PLANEACIÃ“N Y COLOCACIÃ“N DE UN IMPLANTE GUIADO EN CONJUNTO CON EL USO DE UN PILAR PERSONALIZADO E INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO, ASÃ□ COMO MOSTRAR LAS VENTAJAS DE AMBAS TÃ‰CNICAS QUIRÃšRGICAS CUANDO SE PRETENDE MEJORAR LA CICATRIZACIÃ“N DE LOS TEJIDOS BLANDOS Y REDUCIR LOS TIEMPOS QUIRÃšRGICOS EN COMPARACIÃ“N CON EL USO DE HEALING CONVENCIONALES.

Descripción del Caso *

PACIENTE MASCULINO DE 59 AÃ‘OS, ASA II DIABÃ‰TICO CONTROLADO, ACUDE AL POSGRADO DE PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÃ A DE AME UNIVERSIDAD PARA REPOSICIÃ“N DE LOS Ã“RGANOS DENTARIOS 46 Y 36, AL EXAMEN EXTRAORAL NO PRESENTÃ“ NINGÃšN SIGNO CLÃ NICO PATOLÃ“GICO, A LA EXPLORACIÃ“N PERIODONTAL PRESENTÃ“ PROFUNDIDADES QUE VAN DE DE 2 A 5 MM Y UN NIVEL DE INSERCIÃ“N CLÃ NICA MÃ XIMO DE 6 MM, RADIOGRAFICAMENTE SE OBSERVA PÃ‰RDIDA DE CONTINUIDAD EN LA LAMINA DURA EN ZONAS LOCALIZADAS POR LO QUE SE CLASIFICÃ“ COMO PERIODONTITIS ESTADIO II LOCALIZADA GRADO B, UNA VEZ REALIZADA LA FASE HIGIÃ‰NICA DEL TRATAMIENTO PERIODONTAL Y POSTERIOR REVALUACIÃ“N, SE PROCEDIÃ“ A REALIZAR LA FASE QUIRÃšRGICA.

BAJO ANESTESIA LOCAL, SE POSICIONÃ“ LA GUÃ A QUIRÃšRGICA, MEDIANTE LA TÃ‰CNICA FLAPLESS SE REALIZÃ“ UNA INCISIÃ“N EN TISSUE PUNCH. SE UTILIZÃ“ EL PROTOCOLO DE FRESADO GUIADO PARA IMPLANTES DENTALES HIOSSEN 5X11MM, SE REALIZÃ“ UN FRESADO INICIAL DE 2.0MM X11MM Y FINAL DE 4.0X11MM A 800RPM A 35N. POSTERIORMENTE, SE COLOCÃ“ EL IMPLANTE 3MM SUBCRESTAL CON TORQUE DE 40N.

UN INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO OBTENIDO DE LA TUBEROSIDAD MAXILAR (CHO, 2013) FUE POSICIONADO BAJO LA TÃ‰CNICA DE TÃšNEL SUBPERIÃ“STICO (ZADEH, 2011).

LOS TORNILLOS DE CICATRIZACIÃ“N PERSONALIZADOS (BERETTA M ET AL. 2019) FUERON COLOCADOS. ESTO FACILITA LA FORMACIÃ“N DE UN CONTORNO GINGIVAL NATURAL, MEJORA LA ESTÃ‰TICA Y LA COMODIDAD POSTOPERATORIA, ADEMÃ S SE REDUCE EL DOLOR Y TIEMPO DE ADAPTACIÃ“N DE LOS TEJIDOS BLANDOS PERIIMPLANTARIOS.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS

LA CICATRIZACIÃ“N POSTOPERATORIA FUE SATISFACTORIA. A LOS 2 MESES SE OBSERVÃ“ UNA INTEGRACIÃ“N EXITOSA DEL IMPLANTE, SIN SIGNOS DE INFLAMACIÃ“N NI RECESIÃ“N. EL VOLUMEN GINGIVAL SE MANTUVO ESTABLE GRACIAS A LOS TORNILLOS DE CICATRIZACIÃ“N.

UNA VEZ OSTEOINTEGRADO EL IMPLANTE, SE DISEÃ‘Ã“ UNA RESTAURACIÃ“N DEFINITIVA CON PERFIL DE EMERGENCIA INDIVIDUALIZADO (ESQUIVEL, MEDA Y BLATZ, 2021), ASEGURANDO UNA TRANSICIÃ“N NATURAL DEL IMPLANTE AL TEJIDO GINGIVAL.

CONCLUSIÃ“N

LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES DENTALES EN EL SECTOR POSTERIOR , MEDIANTE UNA PLANIFICACIÃ“N INTERDISCIPLINARIA Y BASADA EN EVIDENCIAS CIENTÃ FICAS , BRINDAN UN RESULTADO FUNCIONAL Y PREDECIBLE.

LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO INCLUYEN: AUMENTO Y ESTABILIZACIÃ“N DEL GROSOR Y LA ANCHURA DE LA MUCOSA QUERATINIZADA, REDUCCIÃ“N DE LA RECESIÃ“N GINGIVAL Y PERIIMPLANTARIA, MEJORA DE LOS RESULTADOS ESTÃ‰TICOS Y FUNCIONALES, MAYOR PREDICTIBILIDAD EN LA RECONSTRUCCIÃ“N DE TEJIDOS BLANDOS ALREDEDOR DE DIENTES E IMPLANTES.

EN CONJUNTO, LA COLOCACIÃ“N DE UN HEALING PERSONALIZADO DURANTE LA CIRUGÃ A DE IMPLANTES DENTALES ES UNA ESTRATEGIA CLAVE PARA OPTIMIZAR LA CICATRIZACIÃ“N DE LOS TEJIDOS BLANDOS, PRESERVAR EL VOLUMEN Y CONTORNO PERIIMPLANTARIO, Y SIMPLIFICAR EL FLUJO CLÃ NICO HACIA LA RESTAURACIÃ“N DEFINITIVA.

Bibliografía *

1. PERI-IMPLANT SOFT TISSUE CONDITIONING BY MEANS OF CUSTOMIZED HEALING ABUTMENT: A RANDOMIZED CONTROLLED CLINICAL TRIAL. BERETTA M, POLI PP, PIERIBONI S, ET AL.

MATERIALS (BASEL, SWITZERLAND). 2019;12(18):E3041.

2. DIGITAL WORKFLOW AND GUIDED SURGERY IN IMPLANT THERAPY-LITERATURE REVIEW AND PRACTICAL TIPS TO OPTIMIZE PRECISION. CHEN CS, HSU H, KUO YW, KUO HY, WANG CW. CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH. 2025;27(3):E70038.

3. THE ACCURACY OF IMPLANT PLACEMENT BY EXPERIENCED SURGEONS: GUIDED VS FREEHAND APPROACH IN A SIMULATED PLASTIC MODEL. VERMEULEN J. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS. 2017 MAR/APR;32(3):617â€“ 624.

4. AUTOGENOUS SOFT TISSUE GRAFTING FOR PERIODONTAL AND PERI-IMPLANT PLASTIC SURGICAL RECONSTRUCTION. ZUCCHELLI G, TAVELLI L, MCGUIRE MK, ET AL.

JOURNAL OF PERIODONTOLOGY. 2020;91(1):9-16.

Título del trabajo *

COBERTURA RADICULAR EN QUINTO SEXTANTE CON TECNICA DE COLGAJO AVANZADO CORONAL E INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO

Nombre del Autor (a/es)*

C.D. Zulma Itzel EchevarrÃ-a FernÃ¡ndez

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

L.O.E.P. Olga MarÃ-a MartÃ-nez Bernal, , , , , , , , .

Correo Electrónico *

zulmaitzel8@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD QUETZALCÃ“ATL EN IRAPUATO

Introducción y Objetivos *

LA RECESIÃ“N GINGIVAL, ES EL DESPLAZAMIENTO DEL MARGEN DE TEJIDO BLANDO APICAL A LA UNIÃ“N CEMENTO-ESMALTE, QUE CONDUCE A LA EXPOSICIÃ“N DE LA SUPERFICIE DE LA RAÃ?Z AL ENTORNO ORAL. CUANDO Ã‰STA NO ES TRATADA SE ASOCIA CON SENSIBILIDAD TÃ‰RMICA Y TÃ?CTIL, QUEJAS ESTÃ‰TICAS Y POSIBLES COMPLICACIONES EN EL MANTENIMIENTO DE UNA HIGIENE BUCAL Ã“PTIMA Y UNA TENDENCIA A UN MAYOR DESPLAZAMIENTO APICAL CON EL TIEMPO. EL COLGAJO CORONAL AVANZADO CON INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO SUBEPITELIAL SIGUE SIENDO EL ESTÃ?NDAR DE ORO, YA QUE OFRECE UNA MAYOR PROBABILIDAD DE LOGRAR UNA COBERTURA RADICULAR COMPLETA EN COMPARACIÃ“N CON OTRAS TÃ‰CNICAS.

EVALUAR LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO DE COBERTURA RADICULAR CON ESTA TÃ‰CNICA EN INCISIVOS INFERIORES, PARA REDUCIR HIPERSENSIBILIDAD DENTAL EN QUINTO SEXTANTE Y MEJORAR ESTÃ‰TICA, ASÃ? COMO REDUCIR LA TENDENCIA A UN MAYOR DESPLAZADO APICAL.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINA DE 54 AÃ‘OS, SIN ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÃ“GICOS. ES REFERIDA A POSGRADO DE PERIODONCIA DE LA UNIVERSIDAD QUETZALCÃ“ATL EN IRAPUATO PORQUE REFIRIÃ“ HIPERSENSIBILIDAD DENTAL EN QUINTO SEXTANTE. A LA EXPLORACIÃ“N CLÃ NICA SE OBSERVÃ“ PLACA DENTOBACTERIANA, ZONA EDÃ‰NTULA Y RECESIONES MÃšLTIPLES. SE REALIZÃ“ FASE I PERIODONTAL PARA CONTINUAR CON EL ABORDAJE QUIRÃšRGICO DE LAS RECESIONES GINGIVALES EN EL Ã“RGANO DENTAL 31 Y 32, DIAGNOSTICADAS COMO RT2. EN EL ABORDAJE QUIRÃšRGICO LUEGO DE COLOCAR ANESTESIA LOCAL, SE REALIZARON INCISIONES SUBMARGINALES OBLICUAS EN Ã REAS INTERDENTALES, QUE CONTINUARON CON INCISIONES INTRASURCALES EN LOS DEFECTOS DE RECESIÃ“N.

CADA PAPILA QUIRÃšRGICA FUE DESPLAZADA CON RESPECTO A LA PAPILA ANATÃ“MICA POR LAS INCISIONES INTERDENTALES SUBMARGINALES OBLICUAS, EL COLGAJO DE SOBRE SE LEVANTÃ“ CON UN ABORDAJE SPLIT-FULL-SPLIT EN DIRECCIÃ“N CORONAL-APICAL. LAS INCISIONES INTERDENTALES OBLICUAS SE REALIZARON MANTENIENDO LA HOJA PARALELA AL EJE LARGO DE LOS DIENTES PARA DISECAR EN FORMA DE ESPESOR PARCIAL LA PAPILA QUIRÃšRGICA. LAS EXPOSICIONES SE ELEVARON EN FORMA DE ESPESOR TOTAL PARA PROPORCIONAR MÃS ESPESOR A LA PORCIÃ“N DEL COLGAJO QUE ES CRÃTICA PARA LA COBERTURA RADICULAR. FINALMENTE, LA PORCIÃ“N MÃS APICAL DEL COLGAJO SE ELEVÃ“ EN FORMA DE ESPESOR PARCIAL PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO CORONAL DEL COLGAJO. LAS SUPERFICIES RADICULARES FUERON TRATADAS MECÃNICAMENTE CON EL USO DE CURETAS. EL TEJIDO RESTANTE DE LA PAPILA INTERDENTAL ANATÃ“MICA FUE DESEPITELIZADO PARA CREAR LECHOS DE TEJIDO CONECTIVO, SE REALIZÃ“ UNA DISECCIÃ“N AGUDA EN LA MUCOSA DEL REVESTIMIENTO VESTIBULAR PARA ELIMINAR LA TENSIÃ“N MUSCULAR, DURANTE EL AVANCE CORONAL, CADA PAPILA QUIRÃšRGICA ROTÃ“ HACIA LOS EXTREMOS DEL COLGAJO Y FINALMENTE SE UBICÃ“ EN EL CENTRO DEL Ã REA INTERPROXIMAL . LA MOVILIZACIÃ“N DEL COLGAJO SE CONSIDERÃ“ â€œADECUADAâ€ CUANDO LA PORCIÃ“N MARGINAL DEL COLGAJO PUDO ALCANZAR PASIVAMENTE UN NIVEL CORONAL A LA UCE EN CADA DIENTE INDIVIDUAL EN EL SITIO QUIRÃšRGICO. EN EL SIGUIENTE PASO, EL INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO SE EXTRAJO DEL PALADAR COMO INJERTO GINGIVAL EPITELIZADO. DESPUÃ‰S DE ELIMINAR EL EPITELIO, EL GROSOR FUE DE 2 MM, SU ANCHO Y LARGO CORRESPONDÃA CON LA LONGITUD DEL Ã REA RECEPTORA DE TAL MANERA QUE SE SUPERPONÃA A LAS RECESIONES GINGIVALES EVALUADAS. SE ESTABILIZÃ“ CON SUTURAS REABSORBIBLES CON PUNTOS SUSPENSORIOS A LAS PAPILAS DESEPITELIZADAS. SE REALIZARON SUTURAS SUSPENSORIAS PARA LOGRAR UNA ADAPTACIÃ“N PRECISA DEL COLGAJO BUCAL EN LAS SUPERFICIES RADICULARES EXPUESTAS Y PARA ESTABILIZAR CADA PAPILA QUIRÃšRGICA.

Resultados y Conclusiones *

SE RETIRARON SUTURAS A LOS 21 DÃ AS Y SE REALIZÃ“ CONTROL DE PLACA BACTERIANA 5 SEMANAS DESPUÃ‰S. SE REALIZÃ“ REVALORACIÃ“N A LOS 3 MESES DE LA CIRUGÃ A. SE OBTUVO UNA COBERTURA RADICULAR COMPLETA DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTADÃ STICO DEL 48 AL 88% DEBIDO A LA ELIMINACIÃ“N DEL TEJIDO SUBMUCOSO LABIAL LIBRE DE TENSIONES.

LAS RECESIONES GINGIVALES PUEDEN ESTAR ASOCIADAS A FACTORES ANATÃ“MICOS, FACTORES FISIOLÃ“GICOS, FACTORES PATOLÃ“GICOS Y PUEDE SER TRATADA MEDIANTE VARIOS PROCEDIMIENTOS QUIRÃšRGICOS. EN LAS RECESIONES GINGIVALES RT2 SE PUEDE LOGRAR UNA COBERTURA RADICULAR COMPLETA > 80%, CON LA TÃ‰CNICA DE COLGAJO AVANZADO CORONAL CON INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO, QUE SE SIGUE CONSIDERANDO EL ESTÃ NDAR DE ORO.

Bibliografía *

WEINBERG E, KOLERMAN R, KATS L, COHEN O, MASRI D, SEBAOUN A, SLUTZKEY G. CORONALLY ADVANCED FLAP WITH CONNECTIVE TISSUE GRAFT FOR TREATING ORTHODONTIC-ASSOCIATED MILLER CLASS III GINGIVAL RECESSION OF THE LOWER INCISORS: A ONE-YEAR RETROSPECTIVE STUDY. J CLIN MED. 2022 JAN 1;11(1):235. DOI: 10.3390/JCM11010235. PMID: 35011976; PMCID: PMC8745991.

BELLVER-FERNÃ NDEZ R, MARTÃ NEZ-RODRIGUEZ AM, GIOIA-PALAVECINO C, CAFFESSE RG, PEÃ‘ARROCHA M. SURGICAL TREATMENT OF LOCALIZED GINGIVAL RECESSIONS USING CORONALLY ADVANCED FLAPS WITH OR WITHOUT SUBEPITHELIAL CONNECTIVE TISSUE GRAFT. MED ORAL PATOL ORAL CIR BUCAL. 2016 MAR 1;21(2):E222-8. DOI: 10.4317/MEDORAL.21043. PMID: 26595836; PMCID: PMC4788803.

CAIRO F, NIERI M, CINCINELLI S, MERVELT J, PAGLIARO U. THE INTERPROXIMAL CLINICAL ATTACHMENT LEVEL TO CLASSIFY GINGIVAL RECESSIONS AND PREDICT ROOT COVERAGE OUTCOMES: AN EXPLORATIVE AND RELIABILITY STUDY. J CLIN PERIODONTOL. 2011 JUL;38(7):661-6. DOI: 10.1111/J.1600-051X.2011.01732.X. EPUB 2011 APR 20. PMID: 21507033.

ZUCCHELLI G, DE SANCTIS M. TREATMENT OF MULTIPLE RECESSION-TYPE DEFECTS IN PATIENTS WITH ESTHETIC

Título del trabajo *

COBERTURA RADICULAR SIN INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO: ALTERNATIVA PREDECIBLE CON COLGAJO DESPLAZADO CORONAL

Nombre del Autor (a/es)*

Pegueros Valencia Paulina

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Nieto RamÃ-rez Jaime Alejandro, , , , , , , , .

Correo Electrónico *

paulinapeguerosv@gmai.com

Institución *

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES LEÃ“N, UNAM

Introducción y Objetivos *

LA RECESIÃ“N GINGIVAL (DESPLAZAMIENTO DEL MARGEN GINGIVAL HACIA APICAL RESPECTO A LA UNIÃ“N CEMENTO-ESMALTE UCE), ES UNA CARACTERÃ STICA COMÃšN EN POBLACIONES CON ALTOS ESTÃ NDARES DE HIGIENE ORAL (SAGNES & GJERMO 1976, LOE ET AL. 1992, SERINO ET AL. 1994) COMO EN POBLACIONES CON POBRE HIGIENE ORAL (BÃ†LUM ET AL. 1986, YONEYAMA Y COLS. 1988, LOE Y COLS 1992).

ALGUNOS FACTORES ASOCIADOS CON RECESIONES GINGIVALES SON MALPOSICIÃ“N DENTAL, DEHISCENCIAS Ã“SEAS ALVEOLARES, DIMENSIONES GINGIVALES INADECUADAS, INSERCIONES MUSCULARES Y TRACCIÃ“N DE FRENILLO Y FACTORES IATROGÃ‰NICOS RELACIONADOS CON TRATAMIENTOS RESTAURATIVOS Y PERIODONTALES. (1)

EL TRATAMIENTO QUIRÃšRGICO PARA RECESIONES GINGIVALES MEDIANTE COLGAJOS PEDICULADOS, COMO EL COLGAJO DESPLAZADO CORONAL O ROTACIONAL, PUEDE LOGRAR COBERTURA RADICULAR, PERO A MENUDO CON TEJIDO BLANDO DELGADO, LO QUE COMPROMETE SU ESTABILIDAD A LARGO PLAZO.

EN LA SELECCIÃ“N DE UN TRATAMIENTO PARA COBERTURAS RADICULARES, RESULTA FUNDAMENTAL MINIMIZAR TANTO EL NÃšMERO DE CIRUGÃ AS Y SITIOS QUIRÃšRGICOS COMO SATISFACER LAS EXPECTATIVAS ESTÃ‰TICAS DEL PACIENTE.

OBJETIVO: PRESENTAR EL MANEJO CLÃ NICO DE RECESIONES GINGIVALES MEDIANTE LA TÃ‰CNICA DE COLGAJO DESPLAZADO CORONALMENTE SIN USO DE UN INJERTO LIBRE DE TEJIDO CONECTIVO EVALUANDO SU IMPACTO EN LA COBERTURA RADICULAR Y LA POSIBILIDAD DE OBTENER RESULTADOS CLÃ NICOS SATISFACTORIOS SIN NECESIDAD DE AUMENTAR EL ESPESOR GINGIVAL.

Descripción del Caso *

ACUDE A LA CLÃ NICA ODONTOLÃ“GICA DE LA ENES LEÃ“N, PACIENTE FEMENINA DE 53 AÃ‘OS SIN ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÃ“GICOS NI NO PATOLÃ“GICOS DE RELEVANCIA SIENDO SU MOTIVO DE CONSULTA: â€œNO ME GUSTA QUE SE VEA LA RAÃ Z DE MIS DIENTESâ€ . A LA EXPLORACIÃ“N INTRAORAL SE OBSERVAN RECESIONES GINGIVALES MÃšLTIPLES. SEGÃšN LA CLASIFICACIÃ“N DE CAIRO, SE DIAGNOSTICAN RECESIONES TIPO RT1 EN DIENTES 23, 24, 25 Y 26. DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÃ“N DE PINI-PRATO, LAS RECESIONES EN DIENTES 23, 24 Y 25 CORRESPONDEN A TIPO Aâ€“, MIENTRAS QUE LA RECESIÃ“N EN EL DIENTE 26 SE CLASIFICA COMO TIPO A+. LA PACIENTE REFIERE LIGERA SENSIBILIDAD AL FRÃ O. LA PROFUNDIDAD AL SONDAJE EN TODOS LOS DIENTES INVOLUCRADOS ES ? 3 MM. LA RECESIÃ“N GINGIVAL MEDIDA ES DE 2 MM EN DIENTES 23, 24, 25 Y 26, Y DE 1 MM EN DIENTE 22. LA ANCHURA DE ENCÃ A QUERATINIZADA VARÃ A ENTRE 2 Y 5 MM EN LAS PIEZAS COMPROMETIDAS. PREVIO A LA CIRUGÃ A, SE INSTRUYÃ“ A LA PACIENTE EN TÃ‰CNICAS DE CEPILLADO, CON EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR LA HIGIENE ORAL Y MINIMIZAR EL TRAUMA MECÃ NICO SOBRE LOS TEJIDOS GINGIVALES. EL TRATAMIENTO CONSISTIÃ“ EN UN COLGAJO DESPLAZADO CORONALMENTE SIN INCISIONES DE DESCARGA, CON UN COLGAJO BUCAL DE GROSOR DIVIDIDO-TOTAL-DIVIDIDO Y CON SUTURAS CORONALES EN ANCLAJE FIJARON CADA PAPILA QUIRÃšRGICA A LA PAPILA ANATÃ“MICA DESEPITELIZADA CORRESPONDIENTE EN LA POSICIÃ“N MÃ S CORONAL POSIBLE.

LOS PACIENTES FUERON CONTROLADOS PARA HIGIENE Y PROFILAXIS PROFESIONAL A LAS 1, 3 Y 5 SEMANAS DESPUÃ‰S DE LA RETIRADA DE SUTURAS Y POSTERIORMENTE CADA 3 MESES. SE LES INSTRUYÃ“ EN LA TÃ‰CNICA DE CEPILLADO CON RODILLO CORONAL PARA MINIMIZAR EL TRAUMA EN EL MARGEN GINGIVAL. DURANTE EL PRIMER AÃ‘O SE RECOMENDÃ“ CEPILLO DE CERDAS SUAVES Y DESPUÃ‰S CEPILLO DE DUREZA MEDIA, TÃ‰CNICA DESCRITA POR ZUCCHELLI Y DE SANCTIS (2000).

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS: A LOS 7, 15 DÃ□AS Y AL MES POSTERIORES A LA CIRUGÃ□A SE OBSERVÃ“ COBERTURA RADICULAR COMPLETA, CON ADECUADA CICATRIZACIÃ“N Y SIN SIGNOS DE INFLAMACIÃ“N. EN LA REVISIÃ“N A LOS 3 MESES, LA COBERTURA SE MANTENÃ□A Ã□NTEGRA Y ESTABLE, SIN RECESIÃ“N RECURRENTE.

DISCUSIÃ“N Y CONCLUSIONES: SE LOGRÃ“ UNA COBERTURA RADICULAR COMPLETA MEDIANTE LA TÃ‰CNICA DE COLGAJO DESPLAZADO CORONAL (CDC) SIN INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO. ESTOS RESULTADOS COINCIDEN CON LO REPORTADO POR WENNSTRÃ–M Y ZUCCHELLI (1996), QUIENES CONCLUYERON QUE LA CANTIDAD DE COBERTURA RADICULAR OBTENIDA CON CDC, CON O SIN INJERTO, NO PRESENTA DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS. ESTO RESPALDA EL USO DE TÃ‰CNICAS MENOS INVASIVAS EN CASOS SELECCIONADOS, SIN COMPROMETER LA EFICACIA CLÃ□NICA A LARGO PLAZO. EL ENFOQUE QUIRÃšRGICO UTILIZADO, BASADO EN ZUCCHELLI Y DE SANCTIS (2000), PERMITIÃ“ TRATAR RECESIONES CONTIGUAS EN UNA SOLA INTERVENCIÃ“N, LOGRANDO BUENOS RESULTADOS ESTÃ‰TICOS Y DE COBERTURA RADICULAR. AL EVITAR INCISIONES DE LIBERACIÃ“N VERTICAL, SE PRESERVÃ“ EL SUMINISTRO SANGUÃ□NEO Y SE REDUJO EL RIESGO DE CICATRICES VISIBLES, MEJORANDO ASÃ□ LA COMODIDAD Y EL RESULTADO ESTÃ‰TICO DEL PACIENTE. EL CEPILLADO TRAUMÃ□TICO ES UN FACTOR EN LA APARICIÃ“N DE RECESIONES GINGIVALES, KHOCHT Y COLS. (1993). EN ESTE CASO CLÃ□NICO, ADEMÃ□S DEL TRATAMIENTO QUIRÃšRGICO, SE MODIFICARON LOS HÃ□BITOS DE CEPILLADO DEL PACIENTE, FUNDAMENTAL PARA PREVENIR LA RECURRENCIA DE LA RECESIÃ“N Y PROTEGER EL TEJIDO BLANDO A LARGO PLAZO.

EL TRATAMIENTO DE RECESIONES GINGIVALES HA GANADO RELEVANCIA POR LAS CRECIENTES DEMANDAS ESTÃ‰TICAS. AUNQUE SE BUSCA UNA COBERTURA TOTAL HASTA LA UCE, EL Ã‰XITO CLÃ□NICO PUEDE NO SER ESTÃ‰TICO SI EL INJERTO, ESPECIALMENTE DEL PALADAR, PRESENTA EXCESO DE GROSOR O MALA INTEGRACIÃ“N. LA TÃ‰CNICA DE CDC SIN INJERTO DEMOSTRÃ“ SER EFICAZ PARA LOGRAR COBERTURA RADICULAR COMPLETA, APOYANDO EL USO DE ENFOQUES MENOS INVASIVOS EN CASOS CLÃ□NICOS SELECCIONADOS. LA MODIFICACIÃ“N DE HÃ□BITOS DE CEPILLADO FUE CLAVE PARA PREVENIR LA RECURRENCIA DE LA RECESIÃ“N, DESTACANDO LA IMPORTANCIA DEL CONTROL DE FACTORES ETIOLÃ“GICOS JUNTO AL TRATAMIENTO QUIRÃšRGICO.

Bibliografía *

WENNSTRÃ–M, J. L., & ZUCCHELLI, G. (1996). INCREASED GINGIVAL DIMENSIONS. A SIGNIFICANT FACTOR FOR SUCCESSFUL OUTCOME OF ROOT COVERAGE PROCEDURES? A 2-YEAR PROSPECTIVE CLINICAL STUDY. JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, 23(8), 770â€“777. HTTPS://DOI.ORG/10.1111/J.1600-051X.1996.TB00608.X

DE SANCTIS, M., & ZUCCHELLI, G. (2007). CORONALLY ADVANCED FLAP: A MODIFIED SURGICAL APPROACH FOR ISOLATED RECESSION-TYPE DEFECTS: THREE-YEAR RESULTS. JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, 34(3), 262â€“268. HTTPS://DOI.ORG/10.1111/J.1600-051X.2006.01039.X

ZUCCHELLI, G., & DE SANCTIS, M. (2000). TREATMENT OF MULTIPLE RECESSION?TYPE DEFECTS IN PATIENTS WITH ESTHETIC DEMANDS. JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, 71(9), 1506-1514. HTTPS://DOI.ORG/10.1902/JOP.2000.71.9.1506

ZUCCHELLI, G., STEFANINI, M., GANZ, S., MAZZOTTI, C., MOUNSSIF, I., & MARZADORI, M. (2016). CORONALLY ADVANCED FLAP WITH DIFFERENT DESIGNS IN THE TREATMENT OF GINGIVAL RECESSION: A COMPARATIVE CONTROLLED RANDOMIZED CLINICAL TRIAL. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF PERIODONTICS & RESTORATIVE DENTISTRY, 36(3), 319-327. HTTPS://DOI.ORG/10.11607/PRD.2698

Título del trabajo *

RECESIÃ“N MANDIBULAR AISLADA TRATADA CON TÃšNEL CERRADO LATERALMENTE, REPORTE DE CASO CLÃ□NICO

Nombre del Autor (a/es)*

Camilla PelÃ¡ez GarcÃ-a

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Juan Carlos GÃ³mez Mireles, Mari Luz Muro JimÃ©nez, , , , , , , .

Correo Electrónico *

camilla.pelaez8410@alumnos.udg.mx

Institución *

ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA, DEPARTAMENTO DE CLÃ□NI

Introducción y Objetivos *

LA RECESIÃ“N GINGIVAL ES LA EXPOSICIÃ“N DE LA LÃ NEA CEMENTO ESMALTE DEBIDO A LA MIGRACIÃ“N APICAL DEL MARGEN GINGIVAL 1. SU PREVALENCIA ES ELEVADA, SE ESTIMA QUE EL 88% DE LAS PERSONAS MAYORES DE 65 AÃ‘OS Y EL 50% DE LA POBLACIÃ“N DE 18-64 AÃ‘OS TIENE POR LO MENOS UN SITIO CON RECESIÃ“N GINGIVAL 2,3. LA PRESENCIA DE RECESIONES COMPROMETE LA ESTÃ‰TICA, FAVORECE LA FORMACIÃ“N DE CARIES RADICULARES, LESIONES CERVICALES NO CARIOSAS, HIPERSENSIBILIDAD DENTAL Y DIFICULTAD PARA MANTENER LA HIGIENE 1.

SUS FACTORES ETIOLÃ“GICOS SON; ANATOMÃ A DENTAL, POSICIÃ“N EN EL ARCO DENTAL, DEHISCENCIAS Ã“SEAS, FENOTIPO DELGADO, INSERCIONES MUSCULARES, CEPILLADO DENTAL TRAUMÃ TICO Y TRATAMIENTO ORTODÃ“NCICO 4. EL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA PUEDE OCASIONAR UNA POSICIÃ“N RADICULAR FUERA DE LA TABLA VESTIBULAR Y POR LO TANTO DEHISCENCIAS Ã“SEAS 2. LA PREVALENCIA DEL DESARROLLO DE RECESIÃ“N GINGIVAL FINALIZADO EL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA ES DE 5-12% Y AUMENTA A 47% EN UN LAPSO DE 5 AÃ‘OS 1. EN PACIENTES CON ORTODONCIA, LOS INCISIVOS MANDIBULARES SON LOS MÃ S PROPENSOS A DESARROLLAR RECESIONES GINGIVALES 1.

EL TRATAMIENTO DE LAS RECESIONES MANDIBULARES ES DE MAYOR COMPLEJIDAD DEBIDO A QUE LA PAPILA ES DELGADA, EL GROSOR GINGIVAL ES DELGADO, EXISTEN INSERCIONES DE FRENILLO Y POCA PROFUNDIDAD DE VESTÃ BULO 1. SE HAN DESCRITO DISTINTOS ABORDAJES QUIRÃšRGICOS, EL INJERTO LIBRE EPITELIZADO PROPORCIONA UNA GANANCIA EN TEJIDO QUERATINIZADO PERO TIENE BAJA PROBABILIDAD DE COBERTURA Y UN RESULTADO POCO ESTÃ‰TICO 4. EL INJERTO CONECTIVO SUBEPITELIAL CON COLGAJO DESPLAZADO CORONALMENTE ES DIFÃ CIL DE REALIZAR EN RECESIONES MANDIBULARES PROFUNDAS 1. POR OTRO LADO, LA TÃ‰CNICA DE TUNEL CON CIERRE LATERAL OFRECE LA VENTAJA DE OBTENER UN CIERRE PASIVO DE LA RECESIÃ“N SIN CAMBIAR LA PROFUNDIDAD DE VESTÃ BULO ASÃ COMO RESULTADOS ESTÃ‰TICOS.

EL OBJETIVO DE ESTE CARTEL ES DESCRIBIR EL TRATAMIENTO DE UNA RECESIÃ“N MANDIBULAR AISLADA OCASIONADA POR VESTIBULARIZACIÃ“N POST-ORTODONCIA CON UN TUNEL CON CIERRE LATERAL.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINO DE 27 AÃ‘OS DE EDAD, ASA I, QUE ACUDIÃ“ POR PROBLEMAS ESTÃ‰TICOS EN EL OD. 31. EN LA ANAMNESIS LA PACIENTE REFIRIÃ“ HABER TENIDO TRATAMIENTO DE ORTODONCIA CON UNA DURACIÃ“N DE 3 AÃ‘OS Y HABER FINALIZADO ESTE TRATAMIENTO DESDE HACE MEDIA DÃ‰CADA.

A LA EXPLORACIÃ“N CLÃ□NICA SE IDENTIFICÃ“ RECESIÃ“N RT2 (CLASIFICACIÃ“N DE CAIRO, 2011) EN OD.31 E INFLAMACIÃ“N DE LOS BORDES MARGINALES DEBIDO A ACÃšMULO DE PLACA, POR LO QUE SE REALIZÃ“ FASE I PERIODONTAL.

3 SEMANAS DESPUÃ‰S DEL RASPADO CORONAL SE ABORDÃ“ EL CASO EMPLEANDO LA TÃ‰CNICA DESCRITA POR A, SCULEAN DE TUNEL CON CIERRE LATERAL. SIN EMBARGO, 4 DÃ□AS DESPUÃ‰S DE LA CIRUGÃ□A SE NECROSÃ“ PARTE DEL INJERTO, POR LO TANTO, LA COBERTURA RADICULAR NO FUE EXITOSA. POR PETICIÃ“N DE LA PACIENTE, SE VOLVIÃ“ A INTERVENIR LA RECESIÃ“N 4 MESES DESPUÃ‰S EMPLEANDO LA MISMA TÃ‰CNICA QUIRÃšRGICA.

1- ANESTESIA: TÃ‰CNICA MANDIBULAR Y MENTONIANA DEL LADO IZQUIERDO Y TÃ‰CNICA MENTONIANA DE LADO DERECHO CON ARTICAÃ□ANA AL 4%.

2- RASPADO Y ALISADO DE LA SUPERFICIE RADICULAR CON CURETAS Y ULTRASONIDO.

3- INCISIONES INTRASULCULARES CON HOJA DE MICROBISTURÃ□ (MJK, SB003) EN OD. 32,31 Y 41.

4- TUNELIZACIÃ“N DE OD. 31 EXTENDIENDOSE HASTA MESIAL DE OD.41 Y DISTAL DE OD.32. SE DESINSERTÃ“ EL FRENILLO LOCALIZADO MESIALMENTE AL OD. 31.

5- OBTENCIÃ“N DE UN INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO DE PALADAR CON LA TÃ‰CNICA LIBRE Y DESEPITELIZACIÃ“N EXTRAORAL.

6- PREPARACIÃ“N DE LA SUPERFICIE RADICULAR CON EDTA AL 24% POR 3 MINUTOS SEGUIDO DE IRRIGACIÃ“N CON SOLUCIÃ“N SALINA ABUNDANTE.

7- SUTURA: FIJACIÃ“N DEL INJERTO EN SU POSICIÃ“N MESIO-DISTAL CON PUNTOS SIMPLES. PUNTO SUSPENSORIO PARA FIJAR EL INJERTO CORONALMENTE. CIERRE DE LOS BORDES LATERALES DE LA RECESIÃ“N CON PUNTOS SIMPLES (NYLON 6-0).

Resultados y Conclusiones *

4 MESES DESPUÃ‰S DE LA PRIMERA CIRUGÃ□A SE CUBRIÃ“ 1MM DE LA RECESIÃ“N, LA INFLAMACIÃ“N DE LOS BORDES MARGINALES CESÃ“ POR COMPLETO Y SE LIBERÃ“ LA INSERCIÃ“N DEL FRENILLO. ADEMÃ□S, SE OBTUVO UN CAMBIO EN EL FENOTIPO GINGIVAL DE LOS Ã“RGANOS DENTARIOS 41,31 Y 32. SIN EMBARGO, LA RECESIÃ“N SE MANTUVO EN RT2 (CLASIFICACIÃ“N DE CAIRO, 2011).

1 MES DESPUÃ‰S DE LA SEGUNDA INTERVENCIÃ“N QUIRÃšRGICA SE OBSERVA UNA COBERTURA RADICULAR DE 3MM CON .5MM DE RECESIÃ“N GINGIVAL RESTANTE. LA RECESIÃ“N PASÃ“ DE SER RT2 A RT1 (CLASIFICACIÃ“N DE CAIRO, 2011). SE APRECIA UN COLOR UNIFORME Y UNA ZONA BIEN VASCULARIZADA, ADEMÃ□S DE RESULTADOS ESTÃ‰TICOS.

EN CONCLUSIÃ“N, LAS RECESIONES GINGIVALES SON UNA CONDICIÃ“N MUCOGINGIVAL CON ALTA PREVALENCIA EN LA POBLACIÃ“N ADULTA Y TIENEN CONSECUENCIAS ESTÃ‰TICAS QUE IMPACTAN LA AUTOESTIMA DE LAS PERSONAS. ESTA CONDICIÃ“N TIENE DISTINTOS FACTORES ETIOLÃ“GICOS, ESPECÃ□FICAMENTE, EL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA PUEDE OCASIONAR RECESIONES GINGIVALES A LARGO PLAZO DESPUÃ‰S DE FINALIZADO EL TRATAMIENTO. POR OTRA PARTE, EL USO DE RETENEDORES FIJOS POST TRATAMIENTO DE ORTODONCIA TAMBIÃ‰N ESTÃ□ ASOCIADO A RECESIONES GINGIVALES DEBIDO A QUE LOS RETENEDORES ACTÃšAN COMO UN FACTOR RETENTIVO DE BIOFILM DENTAL, LO CUAL PUEDE EVOLUCIONAR EN PÃ‰RDIDA DE SOPORTE INTERPROXIMAL 2.

EL TRATAMIENTO DE LAS RECESIONES GINGIVALES DEPENDE DE LAS CONDICIONES ANATÃ“MICAS DE LA ZONA A INTERVENIR. ESPECÃ□FICAMENTE, LAS RECESIONES MANDIBULARES AISLADAS SON DIFÃ□CILES DE TRATAR DEBIDO AL GROSOR GINGIVAL DELGADO, LA POCA PROFUNDIDAD DE VESTÃ□BULO, LA PRESENCIA DE FRENILLO, ENTRE OTRAS 1. LA TÃ‰CNICA DE TUNEL CON CIERRE LATERAL PERMITE LOGRAR UNA COBERTURA RADICULAR SIN LAS IMPLICACIONES QUE LA CIRUGÃ□A DE AVANCE CORONAL TIENE EN ESTA ZONA COMO LA TENSIÃ“N DEL COLGAJO Y LA REDUCCIÃ“N DE LA PROFUNDIDAD DEL VESTÃ□BULO 4. ADEMÃ□S, CON Ã‰STA TÃ‰CNICA SE DISMINUYE LA POSIBILIDAD DE AFECTAR A LOS ORGANOS DENTARIOS ADYACENTES COMO CON LA TÃ‰CNICA DE DESPLAZADO LATERAL Y PERMITE OBTENER RESULTADOS ESTÃ‰TICOS. A DIFERENCIA DEL INJERTO LIBRE EPITELIZADO

Bibliografía *

1- SCULEAN A, ALLEN E. THE LATERALLY CLOSED TUNNEL FOR THE TREATMENT OF DEEP ISOLATED MANDIBULAR RECESSIONS: SURGICAL TECHNIQUE AND A REPORT OF 24 CASES. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF PERIODONTICS & RESTORATIVE DENTISTRY [INTERNET]. 11 DE JUNIO DE 2018;38(4). DISPONIBLE EN: HTTPS://DOI.ORG/10.11607/PRD.3680

2- RENKEMA AM, FUDALEJ PS, RENKEMA A, KIEKENS R, KATSAROS C. DEVELOPMENT OF LABIAL GINGIVAL RECESSIONS IN ORTHODONTICALLY TREATED PATIENTS. AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS [INTERNET]. 30 DE ENERO DE 2013;143(2):206-12. DISPONIBLE EN: HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.AJODO.2012.09.018

3- KASSAB MM, COHEN RE. THE ETIOLOGY AND PREVALENCE OF GINGIVAL RECESSION. J AM DENT ASSOC. 2003;134:220â€“225.

Título del trabajo *

COBERTURA RADICULAR CON TÃ‰CNICA T-CAF

Nombre del Autor (a/es)*

Josmara CasteÃ±eda

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Mari Luz Muro Jimenez, Vianeth MartÃ-nez RodrÃ-guez, Carlos GÃ³mez Mireles, , , , , , .

Correo Electrónico *

yoscastaed@outlook.es

Institución *

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Introducción y Objetivos *

INTRODUCCIÃ“N:

LAS RECESIONES GINGIVALES SON DEFORMIDADES MUCOGINGIVALES QUE PROVOCAN SUPERFICIES RADICULARES EXPUESTAS SUSCEPTIBLES A CARIES DENTAL, HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA Y PROBLEMAS ESTÃ‰TICOS1.

EN EL ÃMBITO DE LAS INTERVENCIONES QUIRÃšRGICAS CORRECTIVAS, LA EVIDENCIA CLÃNICA DE ALTA CALIDAD DISPONIBLE RESPALDA QUE LOS PROCEDIMIENTOS BILAMINARES EMPLEANDO INJERTOS AUTÃ“GENOS DE TEJIDO CONECTIVO SUBEPITELIAL CONSTITUYEN, EN GENERAL, LA ALTERNATIVA CON MAYOR RELACIÃ“N COSTO-BENEFICIO, AL OFRECER RESULTADOS SUPERIORES EN CUANTO A COBERTURA RADICULAR COMPLETA Y MEDIA, INCREMENTO DEL ANCHO DE TEJIDO QUERATINIZADO Y MANTENIMIENTO ESTABLE DE LOS RESULTADOS A LARGO PLAZO2.

Ã‰STAS PUEDEN SER TRATADAS CON DIVERSAS TÃ‰CNICAS DE CIRUGÃA PLÃSTICA PERIODONTAL COMO EL COLGAJO DE AVANCE CORONAL TUNELIZADO (T-CAF). LA COMBINACIÃ“N DE LA TÃ‰CNICA TCAF CON INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO REPRESENTA UNA ALTERNATIVA EFICAZ PARA EL MANEJO DE RECESIONES GINGIVALES AISLADAS TIPO RT2. DICHA TÃ‰CNICA, FAVORECER EL APORTE VASCULAR AL COLGAJO Y LA IRRIGACIÃ“N DEL INJERTO, ADEMÃS OPTIMIZA LOS RESULTADOS CLÃNICOS, ESTÃ‰TICOS Y LA PERCEPCIÃ“N DEL TRATAMIENTO POR PARTE DE LOS PACIENTES EN CASOS DE RECESIONES RT2 CON DEFICIENCIA PAPILAR3.

OBJETIVO:

PRESENTAR EL PROCEDIMIENTO DE COBERTURA RADICULAR QUE CONTRIBUYE A LA REDUCCIÃ“N DE LA HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA, OPTIMIZA LA ESTÃ‰TICA GINGIVAL Y FACILITA LA HIGIENE BUCAL.

Descripción del Caso *

REPORTE CLÃ?NICO:

PACIENTE MASCULINO DE 55 AÃ‘OS, ASA I, CON DIAGNÃ“STICO PERIODONTAL DE SALUD GINGIVAL CLÃ?NICA EN PERIODONTO REDUCIDO ACUDE A CONSULTA REFIRIENDO: SENSIBILIDAD Y DOLOR AL CEPILLADO, OBSERVANDO CLÃ?NICAMENTE RECESIONES GINGIVALES DE LOS OD 33 AL 43, RT1 Y RT2 DE CAIRO, ADEMÃ?S DE UNA BANDA DE ENCÃ?A QUERATINIZADA DE 1 A 5 MM.

TÃ‰CNICA QUIRÃšRGICA:

SE INICIÃ“ CON INCISIONES INTRASULCULARES DE LOS OD 32 A 42 CON ESCLEROTOMO RECTO DE 2.5 MM MARCA GREATLH CONTINUANDO CON UNA DISECCIÃ“N A ESPESOR PARCIAL CON TUNELIZADOR PARA CREAR UNA BOLSA PROFUNDA MÃ?S ALLÃ? DE LA UNIÃ“N MUCOGINGIVAL MANTENIENDO LA PUNTA DE LAS PAPILAS INTERPROXIMALES UNIDAS DEBAJO DEL PUNTO DE CONTACTO.

LOS Ã“RGANOS DENTARIOS 33 Y 43 FUERON TRATADOS BAJO LA TÃ‰CNICA DE COLGAJO DE AVANCE CORONAL DISEÃ‘O DE UN COLGAJO MUCOGINGIVAL DE ESPESOR PARCIAL, DELIMITADO MEDIANTE INCISIONES HORIZONTALES A NIVEL DEL MARGEN GINGIVAL E INCISIONES VERTICALES EN SUS EXTREMOS PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO. UNA VEZ ELEVADO EL COLGAJO, SE PROCEDE A LA LIBERACIÃ“N DE LAS FIBRAS MUSCULARES Y DEL PERIOSTIO PARA PERMITIR UN AVANCE PASIVO Y SIN TENSIÃ“N EN DIRECCIÃ“N CORONAL.

YA PREPARADO EL LECHO RECEPTOR, SE OBTUVO DEL PALADAR UN INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO DE 15 MM, PREVIAMENTE DESEPITELIZADO INTRAORALMENTE MEDIANTE UNA FRESA DE DIAMANTE DE LLANTA, EN EL LADO DERECHO4. EN EL LADO IZQUIERDO, LA OBTENCIÃ“N DEL INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO, TAMBIÃ‰N DE 15 MM, SE REALIZÃ“ EMPLEANDO LA TÃ‰CNICA DE INCISIÃ“N ÃšNICA5.

EL INJERTO DE TEJIDO SE ADAPTÃ“ DENTRO DEL TÃšNEL PREVIAMENTE CONFECCIONADO DESDE EL OD 33 HASTA EL 43, FIJÃ?NDOSE MEDIANTE SUTURAS DE ANCLAJE CON Ã?CIDO POLIGLICÃ“LICO 6-0 PARA MANTENERLO A NIVEL DE LA UNIÃ“N CEMENTO-ESMALTE. SE EMPLEARON SUTURAS SUSPENSORIAS CON NYLON 6-0 PARA DESPLAZAR EL COLGAJO A UNA POSICIÃ“N CORONAL. LAS INCISIONES HORIZONTALES Y VERTICALES SE CERRARON MEDIANTE PUNTOS SIMPLES CON NYLON 6-0.

Resultados y Conclusiones *

CONCLUSIÃ“N:

LAS RECESIONES GINGIVALES SE ASOCIAN CON HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA, INCREMENTO EN EL RIESGO DE CARIES RADICULAR, DIFICULTADES EN EL CONTROL DE PLACA BACTERIANA Y ALTERACIONES ESTÃ‰TICAS. ENTRE LAS TÃ‰CNICAS DE COBERTURA RADICULAR, EL ABORDAJE MEDIANTE LA TÃ‰CNICA T-CAF HA DEMOSTRADO PROPORCIONAR RESULTADOS ESTABLES A LARGO PLAZO TANTO EN COBERTURA COMO EN INTEGRACIÃ“N ESTÃ‰TICA, MANTENIENDO LA INTEGRIDAD DEL APORTE VASCULAR, INTEGRANDO LAS VENTAJAS DE TÃ‰CNICAS AMPLIAMENTE DOCUMENTADAS, COMO EL COLGAJO DESPLAZADO CORONALMENTE (CAF) Y LA TÃ‰CNICA DE TUNELIZACIÃ“N, EL COLGAJO DESPLAZADO CORONALMENTE MEDIANTE TUNELIZACIÃ“N (TCAF) SE DESCRIBE COMO UN ENFOQUE HÃ□BRIDO PARA LA COBERTURA RADICULAR EXPUESTA6. LA DESEPITELIZACIÃ“N INTRAORAL MEDIANTE FRESA DE DIAMANTE OPTIMIZÃ“ LA OBTENCIÃ“N DEL INJERTO Y FAVORECIÃ“ UNA CICATRIZACIÃ“N ACELERADA DEL LECHO RECEPTOR; POR SU PARTE, LA OBTENCIÃ“N DEL INJERTO MEDIANTE UNA ÃšNICA INCISIÃ“N SE ASOCIÃ“ CON UN PROCESO DE CICATRIZACIÃ“N LIBRE DE DOLOR.

Bibliografía *

1. IMBER J-C, KASAJ A. TREATMENT OF GINGIVAL RECESSION: WHEN AND HOW? INT DENT J [INTERNET]. 2021;71(3):178â€“87. AVAILABLE FROM: HTTP://DX.DOI.ORG/10.1111/IDJ.12617

2. CHAMBRONE L, BOTELHO J, MACHADO V, MASCARENHAS P, MENDES JJ, AVILA-ORTIZ G. DOES THE SUBEPITHELIAL CONNECTIVE TISSUE GRAFT IN CONJUNCTION WITH A CORONALLY ADVANCED FLAP REMAIN AS THE GOLD STANDARD THERAPY FOR THE TREATMENT OF SINGLE GINGIVAL RECESSION DEFECTS? A SYSTEMATIC REVIEW AND NETWORK META-ANALYSIS. J PERIODONTOL [INTERNET]. 2022;93(9):1336â€“52. AVAILABLE FROM: HTTP://DX.DOI.ORG/10.1002/JPER.22-0167

3. BAROOTCHI S, TAVELLI L. TUNNELED CORONALLY ADVANCED FLAP FOR THE TREATMENT OF ISOLATED GINGIVAL RECESSIONS WITH DEFICIENT PAPILLA. INT J ESTHET DENT. 2022;17(1):14â€“26.

Título del trabajo *

USO DE TÃ‰CNICA â€œBIO-COLâ€ PARA PRESERVACIÃ“N DE REBORDE CON XENOINJERTO, REPORTE DE CASO

Nombre del Autor (a/es)*

DomÃ-nguez RodrÃ-guez Montserrat

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

HernÃ¡ndez GÃ³mez Gabriela, Guerra Barberena Ana Lilia, , , , , , , .

Correo Electrónico *

montserratdr10@gmail.con

Institución *

ENES UNAM UNIDAD LEON

Introducción y Objetivos *

LA TÃ‰CNICA BIO-COL CONSISTE EN UTILIZAR UN APÃ“SITO DE COLÃ□GENO REABSORBIBLE, EL CUAL ACTUARÃ□ COMO UNA MEMBRANA REABSORBIBLE; ESTA PROMOVERÃ□ LA PROLIFERACIÃ“N CELULAR DURANTE AL MENOS 30 DÃ□AS, FAVORECIENDO ASÃ□ LA CICATRIZACIÃ“N DEL TEJIDO CONECTIVO Y CREANDO UN MICROAMBIENTE PROPICIO PARA LA INTEGRACIÃ“N DE NUEVO TEJIDO. DIVERSOS AUTORES HAN MENCIONADO LA IMPORTANCIA DEL USO DE TÃ‰CNICAS DE PRESERVACIÃ“N DE REBORDE PARA EVITAR LA REABSORCIÃ“N DE LA CRESTA Ã“SEA Y, DE ESTE MODO, MEJORAR LAS CONDICIONES DEL TEJIDO EN EL MOMENTO EN QUE SE REALICE EL TRATAMIENTO PROTÃ‰SICO, INDEPENDIENTEMENTE DE SI SE LLEVARÃ□ A CABO LA COLOCACIÃ“N DE UN IMPLANTE O DE UNA PRÃ“TESIS REMOVIBLE, YA QUE, EN AMBOS CASOS, CONTAR CON UNA BASE Ã“SEA ADECUADA RESULTA DETERMINANTE PARA LA ESTABILIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA REHABILITACIÃ“N.

UNA DE LAS PRINCIPALES VENTAJAS DESCRITAS AL UTILIZAR LA TÃ‰CNICA BIO-COL ES LA PRESERVACIÃ“N DE LA DIMENSIÃ“N HORIZONTAL, DEBIDO A LA GANANCIA EN EL NIVEL DE ENCÃ□A QUERATINIZADA DE LOS PACIENTES AL NO REALIZAR UN COLGAJO Y COLOCAR, EN SU LUGAR, UN TAPÃ“N DE COLÃ□GENO; ESTO PROPICIA LA CREACIÃ“N DE TEJIDO QUERATINIZADO EN LA ZONA DE EXTRACCIÃ“N, LO CUAL, CON EL TIEMPO, CONTRIBUYE A MEJORAR EL PRONÃ“STICO DEL TRATAMIENTO Y OPTIMIZA LA RESPUESTA BIOLÃ“GICA FRENTE A FUTURAS INTERVENCIONES.

EL OBJETIVO DE ESTE REPORTE DE CASO ES MOSTRAR ALGUNAS DE LAS VENTAJAS QUE OFRECE LA TÃ‰CNICA BIO-COL, Y CÃ“MO ESTO PUEDE INFLUIR DE MANERA SIGNIFICATIVA EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS A LARGO PLAZO, NO SOLO EN LA ESTÃ‰TICA Y FUNCIÃ“N, SINO TAMBIÃ‰N EN LA COMODIDAD Y SATISFACCIÃ“N DEL PACIENTE.

Descripción del Caso *

PACIENTE MASCULINO DE 49 AÃ‘OS, SISTÃ‰MICAMENTE SANO, ACUDE A CONSULTA PARA LA EXTRACCIÃ“N DE UN SEGUNDO MOLAR INFERIOR DERECHO, QUE POSTERIORMENTE SERÃ REEMPLAZADO POR UN IMPLANTE DENTAL. EN LA INSPECCIÃ“N CLÃNICA, SE OBSERVA QUE EL O.D. 37 PRESENTA UNA FRACTURA CORONAL EN DIRECCIÃ“N MESIODISTAL, MOVILIDAD GRADO III, Y EN LOS TEJIDOS ADYACENTES SE APRECIA UNA ENCÃA FIRME Y DE COLOR ROSA PÃLIDO. SE REALIZÃ“ UN SONDAJE PERIODONTAL EN LA PERIFERIA DEL DIENTE, OBTENIENDO PROFUNDIDADES DE ENTRE 7 Y 10 MM.

EN LA INSPECCIÃ“N RADIOGRÃFICA SE EVIDENCIA LA PRESENCIA DE UNA LESIÃ“N RADIOLÃšCIDA A NIVEL RADICULAR DEL O.D. 37. DEBIDO A LA DISPOSICIÃ“N DE LA FRACTURA, ESTA NO SE PUEDE OBSERVAR CLARAMENTE TANTO EN LA RADIOGRAFÃA PANORÃMICA COMO EN LA RADIOGRAFÃA PERIAPICAL DE MOLARES.

UNA VEZ ANESTESIADO EL PACIENTE, SE PROCEDE A REALIZAR UNA EXTRACCIÃ“N ATRAUMÃTICA CON AYUDA DE ELEVADORES RECTOS Y FÃ“RCEPS, EVITANDO DAÃ‘AR LAS PAREDES ALVEOLARES Y OBTENIENDO ASÃ UN LECHO RECEPTOR Ã“PTIMO PARA EL XENOINJERTO Y EL TAPÃ“N DE COLÃGENO. AL RETIRAR EL O.D. 37, SE CONFIRMA QUE LA FRACTURA DENTAL SE EXTENDÃA HASTA EL TERCIO APICAL DE LA RAÃZ.

POSTERIORMENTE A LA EXTRACCIÃ“N, SE ELIMINÃ“ EL TEJIDO GRANULOMATOSO PRESENTE EN EL ALVEOLO, CONSECUENCIA DE LAS CONDICIONES GENERADAS POR LA FRACTURA DENTAL Y DEL PERIODO DE TIEMPO PROLONGADO PREVIO AL TRATAMIENTO. SE PROCEDIÃ“ A LA COLOCACIÃ“N DEL XENOINJERTO (0.5 G), PREVIAMENTE HIDRATADO CON SOLUCIÃ“N FISIOLÃ“GICA DURANTE 15 MINUTOS ANTES DE SU USO, LLENANDO TRES CUARTAS PARTES DEL ALVEOLO; EL ÃšLTIMO CUARTO SE OCUPÃ“ CON EL TAPÃ“N DE COLÃGENO. FINALMENTE, SE COLOCÃ“ UN PUNTO DE SUTURA EN CRUZ CON VICRYL 5-0 PARA BRINDAR ESTABILIDAD AL BIOMATERIAL.

Resultados y Conclusiones *

LA PRIMERA REVISIÃ“N SE REALIZÃ“ A LOS 7 DÃ□AS POSTERIORES A LA CIRUGÃ□A. EL PACIENTE REFIRIÃ“ NO HABER PRESENTADO MOLESTIAS DURANTE ESE TIEMPO, POR LO QUE SE PROCEDIÃ“ A LA INSPECCIÃ“N CLÃ□NICA DE LA ZONA INTERVENIDA. SE OBSERVÃ“ EL PUNTO DE SUTURA SIN TENSIÃ“N SOBRE EL TEJIDO Y UNA DEPRESIÃ“N CON CONTORNO LIGERAMENTE ERITEMATOSO EN EL Ã□REA DEL INJERTO Ã“SEO Y EL TAPÃ“N DE COLÃ□GENO, CUBIERTA POR UNA CAPA DE FIBRINA. EL TEJIDO CIRCUNDANTE PRESENTABA UN COLOR ROSA PÃ□LIDO Y TEXTURA HOMOGÃ‰NEA CON RESPECTO AL TEJIDO ADYACENTE. SE RETIRÃ“ EL PUNTO DE SUTURA CON TIJERAS Y PINZAS DE CURACIÃ“N, Y SE REALIZÃ“ UNA LIMPIEZA CON ENJUAGUE DE CLORHEXIDINA AL 0.12%.

POR MOTIVOS DE AGENDA DEL PACIENTE, LA SIGUIENTE REVISIÃ“N SE LLEVÃ“ A CABO UN MES DESPUÃ‰S DEL PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO, EN LA CUAL SE OBSERVÃ“ UN TEJIDO COMPLETAMENTE EPITELIZADO, CON COLOR ROSA PÃ□LIDO QUE COINCIDE CON EL TEJIDO CIRCUNDANTE.

A LOS 6 MESES, SE EFECTUÃ“ OTRA REVISIÃ“N EN LA QUE SE TOMÃ“ UNA RADIOGRAFÃ□A PERIAPICAL, EVIDENCIANDO UNA ALTURA Ã“SEA FAVORABLE Y COINCIDENTE CON LA CRESTA Ã“SEA DE LOS DIENTES ADYACENTES, LO CUAL PERMITIRÃ□A LA COLOCACIÃ“N DE UN IMPLANTE.

EN 2004, FOWLER Y WHICKER MENCIONARON QUE EL USO DE LA TÃ‰CNICA BIO-COL AYUDA A PRESERVAR Y CREAR UNA MEJOR ARQUITECTURA DEL TEJIDO BLANDO PERIODONTAL, YA QUE, AL NO LEVANTAR UN COLGAJO Y PERMITIR QUE LA ZONA CICATRICE POR SEGUNDA INTENCIÃ“N, SE EVITA SACRIFICAR O REDUCIR TEJIDO QUERATINIZADO. SIN EMBARGO, ES COMÃšN QUE EL PACIENTE PRESENTE ERITEMA O EDEMA EN LAS PRIMERAS SEMANAS, COMO SE OBSERVÃ“ EN LA PRIMERA IMAGEN CLÃ□NICA DEL POSTOPERATORIO, DONDE LA ZONA MÃ□S INTERNA MOSTRABA UN TONO ROJIZO EN COMPARACIÃ“N CON EL TEJIDO ADYACENTE.

POR OTRO LADO, FICKL ET AL., EN 2008, REALIZARON UN ENSAYO CLÃ□NICO ALEATORIZADO Y REPORTARON QUE LOS PACIENTES SOMETIDOS A PRESERVACIÃ“N CON UNA TÃ‰CNICA DE USO DE COLGAJO PRESENTABAN MEJOR ESTABILIDAD, AUNQUE CON UNA REDUCCIÃ“N EN LA CANTIDAD DE TEJIDO QUERATINIZADO. ASÃ□ MISMO, EN 2021, ELIZALDE-MOTA ET AL. LLEVARON A CABO UN ESTUDIO HISTOMORFOMÃ‰TRICO SOBRE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS TÃ‰CNICAS BIO-COL Y ELEVACIÃ“N DE COLGAJO, CONCLUYENDO QUE NO EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE AMBAS.

EN CONCLUSIÃ“N, LA TÃ‰CNICA BIO-COL ES UNA EXCELENTE OPCIÃ“N PARA REALIZAR PRESERVACIÃ“N DE

Bibliografía *

1. BARONE, A., TOTI, P., PIATTELLI, A., IEZZI, G., DERCHI, G., & COVANI, U. (2014). EXTRACTION SOCKET HEALING IN HUMANS AFTER RIDGE PRESERVATION TECHNIQUES: COMPARISON BETWEEN FLAPLESS AND FLAPPED PROCEDURES IN A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL. JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, 85(1), 14â€“23. HTTPS://DOI.ORG/10.1902/JOP.2013.120711.

2. GUERRERO, E. A. (2012). PRESERVACIÃ“N DE ALVEOLOS POSTEXTRACCIÃ“N (DOCTORAL DISSERTATION, UNIVERSIDAD DE SEVILLA).

3. FICKL, S., ZUHR, O., WACHTEL, H., STAPPERT, C. F., STEIN, J. M., & HÃœRZELER, M. B. (2008). DIMENSIONAL CHANGES OF THE ALVEOLAR RIDGE CONTOUR AFTER DIFFERENT SOCKET PRESERVATION TECHNIQUES. JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, 35(10), 906-913

4. FOWLER, E. B. & WHICKER, R. MODIFIED APPROACH TO THE BIO-COL RIDGE PRESERVATION TECHNIQUE: A CASE REPORT. J. CONTEMP. DENT. PRACT., 5(3):82-96, 2004.

5. ELIZALDE-MOTA, M. K.; HERNÃ□NDEZ-ROMERO, C.; ROCHA-ROCHA, V. M. & MAYORAL-GARCÃ□A, V. A. DIMENSIONAL CHANGES IN BARTEE AND BIO-COL RIDGE PRESERVATION TECHNIOUE USING XENOGRAFT INTEROSS

Título del trabajo *

MANEJO MULTIDISCIPLINARIO EN PACIENTE CON CONDICIÃ“N SISTÃ‰MICA, ANTECEDENTE DE HEMIMAXILECTOMÃ A Y EVISCERACIÃ“N OCULAR DERECHA POR MUCORMICOSIS; UN ENFOQUE PERIODONTAL.

Nombre del Autor (a/es)*

Oliva Morales Alejandra

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Santiago MartÃ-nez Mayemi Pamela, Rosales Luviano Luis Eduardo, , , , , , , .

Correo Electrónico *

alejandraom123@gmail.com

Institución *

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIOS, UNIDAD LEÃ“N

Introducción y Objetivos *

ANTECEDENTES:

LA DIABETES MELLITUS ES UNA ENFERMEDAD DE ETIOLOGÃ?A MULTIFACTORIAL CARACTERIZADA POR DEFECTOS MOLECULARES, COMO LA INSUFICIENTE PRODUCCIÃ“N DE INSULINA, LO QUE PROVOCA DESEQUILIBRIOS EN EL METABOLISMO DE GRASAS Y PROTEÃ?NAS.

LA MUCORMICOSIS RINO-ORBITO-CEREBRAL ES UNA INFECCIÃ“N FÃšNGICA RARA Y POTENCIALMENTE MORTAL QUE AFECTA PRINCIPALMENTE A PACIENTES CON DIABETES O INMUNOCOMPROMETIDOS. CAUSADA POR HONGOS DE LA FAMILIA MUCORACEAE, ESTOS ORGANISMOS OPORTUNISTAS SE ENCUENTRAN EN SUELO Y FRUTAS. LA INFECCIÃ“N OCURRE GENERALMENTE POR INHALACIÃ“N DE ESPORAS, QUE EN INDIVIDUOS CON FACTORES PREDISPONENTES, COMO DIABETES MAL CONTROLADA O INMUNOSUPRESIÃ“N, PUEDEN TRANSFORMARSE EN HIFAS INVASIVAS.

EL TRATAMIENTO DE LA MUCORMICOSIS INCLUYE EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD SUBYACENTE, COMO LA DIABETES, Y LA DEBRIDACIÃ“N QUIRÃšRGICA RADICAL DEL TEJIDO INFECTADO. ESTA PUEDE REQUERIR PROCEDIMIENTOS EXTENSOS COMO MAXILECTOMÃ?A PARCIAL O TOTAL, ETMOIDECTOMÃ?A Y EVISCERACIÃ“N OCULAR, EN LA CUAL SE REMUEVE EL CONTENIDO INTERNO DEL GLOBO OCULAR DEJANDO INTACTOS LA ESCLERA Y LOS MÃšSCULOS EXTRAOCULARES.

POR OTRO LADO, LA ENFERMEDAD PERIODONTAL ES UN TRASTORNO INFLAMATORIO CRÃ“NICO DE ORIGEN MULTIFACTORIAL QUE SE CARACTERIZA POR LA DESTRUCCIÃ“N PROGRESIVA DEL APARATO DE INSERCIÃ“N DENTAL, CAUSADA POR UNA DISBIOSIS EN LA MICROBIOTA ORAL. EN PACIENTES CON DIABETES Y ANTECEDENTES DE MUCORMICOSIS, EL TRATAMIENTO PERIODONTAL REQUIERE UN MANEJO ESPECIALIZADO, ENFOCADO PRINCIPALMENTE EN LAS FASES INICIALES (PASO 1 Y 2 SEGÃšN LA GUÃ?A SEPA). ESTE TRATAMIENTO TIENE COMO OBJETIVO LA REMOCIÃ“N MECÃ?NICA DE LA BIOPELÃ?CULA Y EL CÃ?LCULO SUPRA Y SUBGINGIVAL PARA REDUCIR LA INFLAMACIÃ“N Y PREVENIR LA RECOLONIZACIÃ“N BACTERIANA, LO QUE ES FUNDAMENTAL PARA EVITAR COMPLICACIONES EN PACIENTES CON CONDICIONES SISTÃ‰MICAS COMPROMETIDAS.

OBJETIVOS:

â€¢ IDENTIFICAR LA RELACIÃ“N ENTRE DIABETES MELLITUS, MUCORMICOSIS Y ENFERMEDAD PERIODONTAL.

â€¢ DESCRIBIR LAS IMPLICACIONES CLÃ?NICAS Y TERAPÃ‰UTICAS DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL EN UN PACIENTE CON HEMIMAXILECTOMÃ?A Y EVISCERACIÃ“N OCULAR.

â€¢ EVALUAR LA IMPORTANCIA DEL PASO 1 Y 2 DEL TRATAMIENTO PERIODONTAL COMO PARTE DE UN ABORDAJE INTEGRAL EN PACIENTES SISTÃ‰MICAMENTE COMPROMETIDOS.

Descripción del Caso *

PRESENTACIÃ“N DEL CASO Y DIAGNÃ“STICO:

PACIENTE MASCULINO DE 61 AÃ‘OS, ASA II, CON DIAGNÃ“STICO PREVIO DE DM2 CONTROLADA (HBA1C 5.5%), ANTECEDENTE DE HEMIMAXILECTOMÃ□A Y EVISCERACIÃ“N OCULAR DERECHA POR MUCORMICOSIS RINO-ORBITO-CEREBRAL HACE SIETE MESES, COMO ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÃ“GICOS, REFIRIÃ“ TABAQUISMO CESADO HACE DIEZ AÃ‘OS. EL PACIENTE PARTICIPA EN EL PROGRAMA â€œKINTSUGI REHABILITANDO ALMASâ€□, DE LA ENES UNAM UNIDAD LEÃ“N Y ES REFERIDO AL POSGRADO DE PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÃ□A ORAL PARA VALORACIÃ“N PERIODONTAL.

EN LA EVALUACIÃ“N EXTRAORAL SE OBSERVÃ“ ASIMETRÃ□A FACIAL CON CANTEAMIENTO DE LA SONRISA Y PARÃ□LISIS FACIAL DEL LADO DERECHO.

INTRAORALMENTE, SE CONSTATÃ“ AUSENCIA DEL REBORDE ALVEOLAR SUPERIOR DERECHO. EL SEGUNDO CUADRANTE CON PRESENCIA DE BIOPELÃ□CULA, CÃ□LCULO, RECESIONES Y LIGERA MALPOSICIÃ“N DENTARIA. EN EL TERCER Y CUARTO CUADRANTE CON DEPÃ“SITOS DE BIOPELÃ□CULA Y CÃ□LCULO; RECESIONES, MALOCLUSIÃ“N, ERITEMA Y FENOTIPO PERIODONTAL GRUESO.

EL DIAGNÃ“STICO FUE PERIODONTITIS ESTADIO II LOCALIZADA, GRADO B.

PROCEDIMIENTOS:

SE REALIZÃ“ UN PLAN DE TRATAMIENTO PERIODONTAL ENFOCADO EN EL PASO 1 Y 2 SEGÃšN SEPA, PRIORIZANDO MEDIDAS CONSERVADORAS Y EVITANDO INTERVENCIONES QUIRÃšRGICAS EN LAS ZONAS PREVIAMENTE AFECTADAS.

EL PROTOCOLO REALIZADO INCLUYÃ“ MOTIVACIÃ“N Y EDUCACIÃ“N PARA LA SALUD ORAL, CON Ã‰NFASIS EN LA RELACIÃ“N BIDIRECCIONAL ENTRE PERIODONTITIS Y DIABETES MELLITUS TIPO 2; CONTROL PERSONAL DE BIOPELÃ□CULA, RASPADO Y ALISADO RADICULAR EN TRES CUADRANTES Y POSTERIORMENTE TERAPIA PERIODONTAL DE SOPORTE.

SE IMPLEMENTARON ADITAMENTOS DE HIGIENE, RECOMENDANDO EL USO DE CEPILLO ELÃ‰CTRICO DEBIDO A LIMITACIONES MOTRICES. LA ATENCIÃ“N SE BRINDÃ“ EN POSICIÃ“N SEDENTE PARA FAVORECER EL CONFORT Y PREVENIR COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA COMUNICACIÃ“N ORO-NASO-ANTRAL. SE EVITÃ“ EL USO DE VASOCONSTRICTORES, DADA LA HISTORIA DE INFECCIÃ“N MICÃ“TICA ANGIOINVASIVA CON COMPROMISO VASCULAR. ADEMÃ□S, SE BRINDÃ“ APOYO EMOCIONAL Y ESCUCHA ACTIVA ANTE LA VOZ HIPERNASAL.

FINALMENTE, SE REALIZÃ“ INTERCONSULTA CON EL Ã□REA DE REHABILITACIÃ“N PARA LA PLANIFICACIÃ“N Y ELABORACIÃ“N DE PRÃ“TESIS OCULAR Y ORAL, CON EL FIN DE MEJORAR LA ESTÃ‰TICA, FUNCIÃ“N Y CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE. TOMANDO SIEMPRE EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE SU MÃ‰DICO INTERNISTA, Y ENDOCRINÃ“LOGO PARA SUS CIFRAS DE GLUCOSA.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS:

TRAS LA EJECUCIÃ“N DEL TRATAMIENTO INICIAL, EL PACIENTE PRESENTÃ“ UNA REDUCCIÃ“N NOTABLE DE LA BIOPELÃ□CULA (DE 80% A UN 20%) Y CÃ□LCULO DENTARIO, ASÃ□ COMO MEJORÃ□A EN LA TÃ‰CNICA DE HIGIENE ORAL. LA INFLAMACIÃ“N GINGIVAL DISMINUYÃ“ UN 50%, EVIDENCIANDO UNA RESPUESTA FAVORABLE AL CONTROL MECÃ□NICO DE LA BIOPELÃ□CULA Y AL MANTENIMIENTO DE LA SALUD PERIODONTAL.

EN LA ZONA DE COMUNICACIÃ“N ORO-NASO-ANTRAL SE OBSERVÃ“ UNA DISMINUCIÃ“N DE LA SECRECIÃ“N MUCOSA, LO QUE SUGIERE UN AMBIENTE TISULAR MÃ□S ESTABLE, MENOS PROPENSO A LA COLONIZACIÃ“N MICROBIANA Y CON MENOR RIESGO DE COMPLICACIONES INFECCIOSAS. LA RESPUESTA INFLAMATORIA LOCAL SE REDUJO DE FORMA SOSTENIDA EN LAS VISITAS DE CONTROL, CONFIRMANDO LA EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA PERIODONTAL Y LA COLABORACIÃ“N ACTIVA DEL PACIENTE.

EL PACIENTE MOSTRÃ“ MAYOR COMPROMISO CON SU AUTOCUIDADO, ADOPTANDO DE FORMA PERMANENTE EL USO DE CEPILLO ELÃ‰CTRICO Y TÃ‰CNICAS DE HIGIENE ADAPTADAS A SUS LIMITACIONES FÃ□SICAS. LA INTERCONSULTA CON REHABILITACIÃ“N PERMITIÃ“ INICIAR LA PLANIFICACIÃ“N DE UNA PRÃ“TESIS OCULAR PARA RECUPERAR LA ESTÃ‰TICA FACIAL Y UNA PRÃ“TESIS ORAL PARA OPTIMIZAR LA MASTICACIÃ“N Y FONACIÃ“N, FORTALECIENDO ASÃ□ LA REHABILITACIÃ“N INTEGRAL.

ESTE ABORDAJE COORDINADO GENERÃ“ UN IMPACTO POSITIVO EN LA AUTOESTIMA Y DISPOSICIÃ“N DEL PACIENTE, QUIEN EXPRESÃ“ SATISFACCIÃ“N CON LA ATENCIÃ“N RECIBIDA Y LA PERCEPCIÃ“N DE MEJORAS TANTO EN SU SALUD BUCAL COMO EN SU BIENESTAR GENERAL.

CONCLUSIONES:

ESTE CASO EVIDENCIA LA NECESIDAD DE PROTOCOLOS PERSONALIZADOS PARA PACIENTES CON ANTECEDENTES DE MUCORMICOSIS, HEMIMAXILECTOMÃ□A Y COMPROMISO SISTÃ‰MICO. LA LITERATURA DISPONIBLE ES LIMITADA

Bibliografía *

CASTRO-JUÃ□REZ CJ, RAMÃ□REZ-GARCÃ□A SA, VILLA-RUANO N, GARCÃ□A-CRUZ D. EPIDEMIOLOGÃ□A GENÃ‰TICA SOBRE LAS TEORÃ□AS CAUSALES Y LA PATOGÃ‰NESIS DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2. GAC MED MEX. 2017;153(7):864-874. DOI: 10.24875/GMM.17003064. PMID: 29414966.

VEISI A, BAGHERI A, ESHAGHI M, RIKHTEHGAR MH, REZAEI KANAVI M, FARJAD R. RHINO-ORBITAL MUCORMYCOSIS DURING STEROID THERAPY IN COVID-19 PATIENTS: A CASE REPORT. EUR J OPHTHALMOL. 2022 JUL;32(4):NP11-NP16. DOI: 10.1177/11206721211009450. EPUB 2021 APR 10. PMID: 33843287; PMCID: PMC9294610.

VEISI A, BAGHERI A, ESHAGHI M, RIKHTEHGAR MH, REZAEI KANAVI M, FARJAD R. RHINO-ORBITAL MUCORMYCOSIS DURING STEROID THERAPY IN COVID-19 PATIENTS: A CASE REPORT. EUR J OPHTHALMOL. 2022 JUL;32(4):NP11-NP16. DOI: 10.1177/11206721211009450. EPUB 2021 APR 10. PMID: 33843287; PMCID: PMC9294610.

VARGAS APÃ□EZ, O. J., MIRANDA VILLASANA, J. E., & BALDOMERO HERNÃ□NDEZ, J. (2022). HEMIMAXILECTOMÃ□A EN MUCORMICOSIS RINOCEREBRAL. CASO CLÃ□NICO. REVISTA ODONTOLÃ“GICA MEXICANA Ã“RGANO OFICIAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÃ□A UNAM, 13(1). VEISI A, BAGHERI A, ESHAGHI M, RIKHTEHGAR MH, REZAEI KANAVI M, FARJAD R. RHINO-ORBITAL MUCORMYCOSIS DURING STEROID THERAPY IN COVID-19 PATIENTS: A CASE REPORT. EUR

Título del trabajo *

RECONSTRUCCIÃ“N ALVEOLAR TARDÃ?A MEDIANTE UTILIZACIÃ“N DE MEMBRANA NO REABSORBIBLE: REPORTE DE CASO

Nombre del Autor (a/es)*

Peyro Corrales Kelly Gissel

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Arrayales Saavedra SaÃºl Hiram, GÃ³ngora Tejeda Karla Gabriela, , , , , , , .

Correo Electrónico *

kellypeyro50@gmail.com

Institución *

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÃ“GICAS DR. RENATO

Introducción y Objetivos *

DENTRO DE LAS PROBLEMÃ□TICAS POSTERIORES A LA EXTRACCIÃ“N DENTAL, SEGÃšN ARAUJO Y COLS. ENCONTRAMOS QUE LA DIMENSIÃ“N DEL HUESO BUCAL SUFRE UNA REABSORCIÃ“N HORIZONTAL QUE ASCIENDE A APROXIMADAMENTE EL 56%, MIENTRAS QUE LA REDUCCIÃ“N CORRESPONDIENTE DE LA PARED Ã“SEA LINGUAL/PALATINA ES DEL 30%, DURANTE UN INTERVALO DE 4 MESES POSTERIORES; ESTA ES LA CONSECUENCIA MAYORMENTE OBSERVADA.

UN EJEMPLO DE ESTO ES EL MAXILAR POSTERIOR, QUE CICATRIZA CON UN PATRÃ“N TRABECULAR, POR LO QUE HOY EN DÃ□A SE BUSCAN ESTRATEGIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA RECONSTRUCCIÃ“N DE LAS ESTRUCTURAS ALVEOLARES POSTEXTRACCIÃ“N. YA QUE SE HA DEMOSTRADO QUE LA COLOCACIÃ“N DE MATERIALES OSTEOCONDUCTIVOS EN ESTOS SITIOS AUMENTA LA DENSIDAD Ã“SEA, MEJORANDO EL RESULTADO PROSTÃ‰TICO AL PRESERVAR EL CONTORNO DE LA CRESTA. TENIENDO COMO OBJETIVOS PRINCIPALES LA MODULACIÃ“N DE LA REABSORCIÃ“N DE LA CRESTA EN ETAPA TEMPRANA, EL AUMENTO DE LA DENSIDAD Ã“SEA Y LA FACILITACIÃ“N DE FUTURAS CIRUGÃ□AS DE IMPLANTES DENTALES.

UNA DE Ã‰STAS ESTRATEGIAS ES LA TÃ‰CNICA DE BARTEE LA CUAL NOS PERMITE MEJORAR LA CICATRIZACIÃ“N DEL ALVEOLO Y PODER MODIFICAR EL PROCESO DE REABSORCIÃ“N. Ã‰STA TÃ‰CNICA QUIRÃšRGICA FACILITA LA PRESERVACIÃ“N DE LA MUCOSA QUERATINIZADA Y LA ARQUITECTURA GINGIVAL DEBIDO A QUE, LA COMBINACIÃ“N DE MATERIALES DE SUSTITUCIÃ“N Ã“SEA EN PARTÃ□CULAS Y, LA MEMBRANA TEXTURIZADA DE POLITETRAFLUOROETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE SE UTILIZA NO REQUIERE UN CIERRE PRIMARIO Y AYUDA A LA PREVENCIÃ“N DEL CRECIMIENTO DE TEJIDOS BLANDOS EN LOS SITIOS DE EXTRACCIÃ“N EN PROCESO DE CURACIÃ“N. YA QUE SE HA DEMOSTRADO QUE EL BLOQUEO DE LA MIGRACIÃ“N EPITELIAL A LOS DEFECTOS Ã“SEOS MEJORA LA REGENERACIÃ“N DEL HUESO MEDIANTE LA REPOBLACIÃ“N CELULAR SELECTIVA DE LA HERIDA POR CÃ‰LULAS OSTEOPROGENITORAS Y LA CONCENTRACIÃ“N LOCAL DE FACTORES DE CRECIMIENTO BIOLÃ“GICOS.

EL OBJETIVO DEL SIGUIENTE REPORTE DE CASO ES EJEMPLIFICAR LA EFECTIVIDAD DE LA TÃ‰CNICA DE BARTEE EN LA RECONSTRUCCIÃ“N ALVEOLAR TARDÃ□A

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINA DE 56 AÃ‘OS, ASA II, ACUDE A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÃ“GICAS DR. RENATO DE TOLEDO LEONARDO, REFIRIENDO MOLESTIA EN PIEZA #15. A INSPECCIÃ“N CLÃ□NICA LA PIEZA PRESENTABA DOLOR IRRADIADO CONSTANTE Y SUPURACIÃ“N, TEJIDO QUERATINIZADO CON ERITEMA Y EDEMA Y GRAN CANTIDAD DE DENTINA REBLANDECIDA; RADIOGRÃ□FICAMENTE SE OBSERVÃ“ LESIÃ“N ENDOPERIODONTAL, QUE SE CLASIFICÃ“ COMO LESIÃ“N ENDODÃ“NTICA PRIMARIA CON AFECTACIÃ“N PERIODONTAL SECUNDARIA.

EL TRATAMIENTO SE ABORDÃ“ EN DOS FASES; EN LA FASE I SE REALIZÃ“ LA EXTRACCIÃ“N DE RESTO RADICULAR Y LA LIMPIEZA DEL ALVEOLO, CON CORRESPONDIENTE FARMACOTERAPIA PARA ELIMINAR EL PROCESO INFECCIÃ“N EXISTENTE. DURANTE EL PROCEDIMIENTO SE ENCONTRÃ“ AUSENCIA DE LA TABLA VESTIBULAR DEBIDO AL TIEMPO QUE SE MANTUVO EL PROCESO INFECCIOSO.

PASADOS DOS MESES, SE INICIÃ“ LA FASE II, DONDE SE REALIZÃ“ UNA RECONSTRUCCIÃ“N ALVEOLAR TARDÃ□A APROVECHANDO EL CIERRE PRIMARIO PREVIO DEL ALVEOLO. SE EFECTUÃ“ UNA INCISIÃ“N CRESTAL EN EL Ã□REA E INTRASULCULAR EN LOS DIENTES ADYACENTES, SE ELEVÃ“ COLGAJO A ESPESOR TOTAL LIMITADO A TEJIDO QUERATINIZADO, SEGUIDO DE DESBRIDAMIENTO ALVEOLAR, Y LA CONFORMACIÃ“N DE UNA MEMBRANA DENSA DE POLITETRAFLUOROETILENO COMO BARRERA PARA CONTENER LAS PARTÃ□CULAS DEL INJERTO Y FACILITAR LA RECONSTRUCCIÃ“N, AYUDADOS DE UNA PLANTILLA DE ALUMINIO ESTÃ‰RIL, PARA SIMULAR LA MEMBRANA. SE TUNELIZÃ“ LA MEMBRANA VESTIBULARMENTE 4 MM MÃ□S ALLÃ□ DE LOS MÃ□RGENES DEL ALVÃ‰OLO HASTA HUESO SANO Y, EN CRESTAL, SE DEJÃ“ 1 MM ALEJADA DE LAS RAÃ□CES ADYACENTES PARA FACILITAR LA REINSERCIÃ“N DE LA PAPILA.

SE RELLENÃ“ EL DEFECTO CON ALOINJERTO CORTICAL 100% MINERALIZADO FDBA, EL CUAL FUE PREVIAMENTE HUMECTADO CON SOLUCIÃ“N SALINA FORMANDO UNA PASTA COHESIVA QUE SE APLICÃ“ Y EMPAQUETÃ“ HASTA LA ZONA APICAL. SE PROCEDIÃ“ A TUNELIZAR LA MEMBRANA EN PALATINO, SE COLOCÃ“ UNA PORCIÃ“N DE CYTOPLAST RTM PLUG, BUSCANDO UN MENOR ACUMULO DE PLACA SOBRE LA MEMBRANA Y FINALMENTE SE SUTURÃ“ EN X CON Ã□CIDO POLIGLICÃ“LICO 4-0.

Resultados y Conclusiones *

LA PACIENTE SE PRESENTA EN LA CLÃ□NICA 21 DÃ□AS DESPUÃ‰S DEL TRATAMIENTO, SIN EXPERIMENTAR NINGUNA INCOMODIDAD, LA MEMBRANA PRESENTABA UN POCO DE MOVILIDAD LO QUE INDICABA QUE YA PODÃ□A SER RETIRADA, LA REMOCIÃ“N DE LA MEMBRANA SE REALIZA SUJETANDO LA MISMA CON UNAS PINZAS Y RETIRÃ□NDOSE SUAVEMENTE DEL LECHO TISULAR. AL RETIRARLA SE PUEDE OBSERVAR UNA CORRECTA FORMACIÃ“N DE EPITELIO, SIN INFECCIÃ“N Y RADIOGRÃ□FICAMENTE SE OBSERVA UN Ã“PTIMO PROCESO DE CICATRIZACIÃ“N Ã“SEA.

LOS RESULTADOS TEMPRANOS OBTENIDOS EN NUESTRO CASO PUEDEN SER COMPARADOS CON EL CASO DESCRITO POR GARCÃ□A Y COLS. 2024, DONDE POSTERIOR AL PROCEDIMIENTO SE RETIRÃ“ LA MEMBRANA A LOS 28 DÃ□AS, Y SE OBTUVO UNA PRESERVACIÃ“N SIGNIFICATIVA DEL VOLUMEN Ã“SEO A LO LARGO DE UN SEGUIMIENTO DE CUATRO MESES, CONFIRMANDO LA EFICACIA DE LA TÃ‰CNICA.

DE IGUAL MANERA, ELIZALDE Y COLS.. MENCIONA, EN UNA REVISIÃ“N SISTEMÃ□TICA DE 32 ESTUDIOS CON UN TOTAL 1,354 PRESERVACIONES DE REBORDE ALVEOLAR USANDO XENOINJERTOS, ALOINJERTOS Y MATERIALES ALOPLÃ□STICOS, QUE LA UTILIZACIÃ“N DEL INJERTO Ã“SEO ALOGÃ‰NICO Y XENOGÃ‰NICO EVIDENCIÃ“ MENOS PÃ‰RDIDA DIMENSIONAL QUE EL ALVÃ‰OLO NO INJERTADO O INJERTADO CON BIOMATERIALES COMO ALOPLÃ□STICO; APOYANDO ASÃ□ LA UTILIZACIÃ“N DE UN SUSTITUTO Ã“SEO ALOGÃ‰NICO PARA EL CORRECTO MANEJO DE LA RECONSTRUCCIÃ“N Y MANTENIMIENTO ALVEOLAR.

ESTE HALLAZGO ES SIMILAR AL ESTUDIO DE OTRO ESTUDIO ABORDADO POR ELIZALDE Y COLS., DONDE SE COMPARÃ“ ALOINJERTO CON XENOINJERTO UTILIZADOS EN LA PRESERVACIÃ“N DEL REBORDE ALVEOLAR ASISTIDA POR UNA MEMBRANA DE COLÃ□GENO REABSORBIBLE, REPORTANDO QUE NO HAY DIFERENCIA ESTADÃ□STICAMENTE SIGNIFICATIVA ENTRE AMBOS GRUPOS A LOS 6 MESES DE CICATRIZACIÃ“N, CONFIRMANDO LA EFICACIA DE UTILIZAR ALOINJERTO COMO EN EL PRESENTE CASO.

EN NUESTRO ABORDAJE UTILIZAMOS UNA MEMBRANA COMO BARRERA PARA EL BLOQUEO DE LA MIGRACIÃ“N

Bibliografía *

1.-ARAUJO MG, LINDHE J. DIMENSIONAL RIDGE ALTERATIONS FOLLOWING TOOTH EXTRACTION. AN EXPERIMENTAL STUDY IN THE DOG. J CLIN PERIODONTOL 2005; 32: 212â€“218.

2.-BARTEE BK. EXTRACTION SITE RECONSTRUCTION FOR ALVEOLAR RIDGE PRESERVATION. PART 1: RATIONALE AND MATERIALS SELECTION. J. ORAL IMPLANTOL. 2001; 27(4):187-93.

3.-BARTEE BK. EXTRACTION SITE RECONSTRUCTION FOR ALVEOLAR RIDGE PRESERVATION. PART 2: MEMBRANE-ASSISTED SURGICAL TECHNIQUE. J ORAL IMPLANTOL. 2001;27(4):194-7.

4.-GARCÃ□A A, SOBERÃ“N D, ARRAYALES S, DE LEÃ“N F. PRESERVACIÃ“N ALVEOLAR EN EL SECTOR POSTERIOR: UN REPORTE DE CASO CLÃ□NICO UTILIZANDO LA TÃ‰CNICA DE BARTEE. REV TAMÃ‰. 2024; 12 (38): 1550-1555.

5.-ELIZALDE-MOTA MK, HERNÃ□NDEZ-ROMERO C, SANCHEZ-SOSA S, ROCHA-ROCHA VM, ESPINOSA-ARREOLA M. HISTOMORPHOMETRIC EVALUATION OF NEW BONE FORMATION, DIMENSIONAL CHANGES, AND RESIDUAL PARTICLES IN ALVEOLAR RIDGE PRESERVATION TECHNIQUES USING INTEROSSÂ® ANORGANIC CANCELLOUS BONE GRAFT: A LONGITUDINAL STUDY. INT J DENT. 2024; 1-13

Título del trabajo *

AUTOTRASPLANTE GUIADO POR IMPRESIÃ“N 3D COMO ALTERNATIVA DE PRESERVACIÃ“N PERIODONTAL Y FUNCIONAL

Nombre del Autor (a/es)*

Xitlaly MartÃ-nez Morga

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Ramos Herrera Yarely Guadalupe, BojÃ³rguez Armeta Hugo Alejandro, Duarte Veloz Ismael, Vela Aguilar Eduardo, Aseff Schietekat Eduardo, 0, 0, 0, .

Correo Electrónico *

xitlaly_martinez@icloud.com

Institución *

DIVISIÃ“N DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE

Introducción y Objetivos *

EL AUTOTRASPLANTE DENTAL (AD) ES UN PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO DESTINADO A REEMPLAZAR DIENTES CON PRONÃ“STICO DESFAVORABLE MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE UN DIENTE ERUPCIONADO O IMPACTADO DESDE UN SITIO DONANTE HACIA UN SITIO RECEPTOR, YA SEA POSTEXTRACCIÃ“N O PREPARADO QUIRÃšRGICAMENTE.Â[1] CONSISTE EN LA REUBICACIÃ“N CONTROLADA DE UN DIENTE DENTRO DE LA MISMA CAVIDAD ORAL DEL PACIENTE.Â[2] ESTA TÃ‰CNICA REPRESENTA UNA ALTERNATIVA TERAPÃ‰UTICA ESPECIALMENTE INDICADA EN PACIENTES EN CRECIMIENTO, EN QUIENES LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES DENTALES O PRÃ“TESIS FIJAS NO RESULTA APROPIADA, Y CUANDO LA PRESERVACIÃ“N DE DIENTES NATURALES CONSTITUYE UNA PRIORIDAD.Â[2]

LA EVIDENCIA DISPONIBLE, RESPALDADA POR DIVERSAS REVISIONES SISTEMÃ□TICAS, REPORTA TASAS DE SUPERVIVENCIA QUE OSCILAN ENTRE EL 75 % Y EL 98 %.Â[2] EN 2017, ANSSARI MOIN ET AL. DESCRIBIERON UN PROTOCOLO DE AUTOTRASPLANTE GUIADO POR PLANTILLA ASISTIDA POR ORDENADOR, EMPLEANDO INSTRUMENTAL QUIRÃšRGICO PERSONALIZADO DISEÃ‘ADO E IMPRESO EN 3D, LO QUE PODRÃ□A OFRECER UN MÃ‰TODO ALTERNATIVO Y MÃ□S PRECISO PARA LA PREPARACIÃ“N DEL ALVEOLO.Â[3] LA IMPLEMENTACIÃ“N DE PROTOCOLOS DIGITALES HA DEMOSTRADO REDUCIR EL TIEMPO QUIRÃšRGICO Y EL TRAUMA SOBRE EL DIENTE DONANTE, CON REPORTES DE SUPERVIVENCIA DE HASTA EL 100 % Y TASAS DE Ã‰XITO DEL 91,7 %.?

Descripción del Caso *

PACIENTE MASCULINO DE 34 AÃ‘OS, SIN ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÃ“GICOS (ASA I) ACUDE A CONSULTA PARA INTENTAR SALVAR SU OD 27 QUE HA REQUERIDO DE UN TRATAMIENTO DE CONDUCTOS DESDE HACE UN AÃ‘O. SE LE REALIZAN LOS RESPECTIVOS ESTUDIOS DE DIAGNÃ“STICO CON DIAGNÃ“STICO PERIODONTAL DE UNA GINGIVITIS INDUCIDA POR PLACA DENTOBACTERIANA EN UN PACIENTE CON PERIODONTO REDUCIDO SIN PERIODONTITIS. SE PIDE UNA CBCT PARA GUIARNOS EN EL DIAGNÃ“STICO Y PLAN DE TRATAMIENTO A REALIZAR, TRAS SU ANÃ□LISIS Y ACEPTACIÃ“N DEL PACIENTE SE REFIERE AL ENDODONCISTA PARA UN TRATAMIENTO DE CONDUCTOS EN EL OD 28 (FIG.1). UNA VEZ TERMINADA LA ENDODONCIA EL FORMATO DICOM SE CONVIERTE EN STL PARA MANDAR A IMPRIMIR EL OD 28 CON RESINA BIOCOMPATIBLE 1:1 (FIG.2). SE ANESTESIA AL PACIENTE CON LIDOCAÃ□NA CON EPINEFRINA AL 2% EL NERVIO ALVEOLAR MEDIO Y POSTERIOR SUPERIOR IZQUIERDO. PROCEDIMOS A LA EXTRACCIÃ“N DEL SITIO RECEPTOR ATRAUMÃ□TICA CON ELEVADORES RECTOS, CON INCISIONES INTRASULCULARES PARA PRESERVAR LA MAYOR CANTIDAD DE LIGAMENTO PERIODONTAL (FIG.3). UNA VEZ HECHA LA EXTRACCIÃ“N, LA REPLICA DEL DIENTE SE COLOCA DE FORMA OPTIMA EN EL LUGAR DEL RECEPTOR SEGÃšN LO PREVISTO DIGITALMENTE. EL ALVEOLO SE PREPARA UN POCO MÃ□S GRANDE QUE EL DIENTE DONANTE UTILIZANDO BARRAS REDONDAS QUIRÃšRGICAS A BAJA VELOCIDAD Y ENFRIANDO CON SOLUCIÃ“N SALINA. EL DIENTE DONANTE SE EXTRAE DE MANERA ATRAUMÃ□TICA, FUERA DE BOCA SE MANTIENE HIDRATADO CON ABUNDANTE SOLUCIÃ“N FISIOLÃ“GICA DONDE SE LE REALIZA APICECTOMÃ□A Y OBTURACIÃ“N RETROGRADA CON MTA SIN EXCEDER UN TIEMPO MÃ□XIMO DE 10 MINUTOS FUERA DE BOCA (FIG.4). INTRODUCIMOS EL OD EN EL LECHO RECEPTOR, FERULIZANDOLO CON UN ALAMBRE 0.15 Y DEJÃ□NDOLO FUERA DE OCLUSIÃ“N (FIG.5). SE SUTURA PUNTO EN X REFORZANDO CON PUNTO SIMPLE, INSTRUCCIONES POSOPERATORIAS Y SU CITA DE 7 DÃ□AS PARA REVISIÃ“N (FIG.6).

Resultados y Conclusiones *

POSTERIOR A LA REALIZACIÃ“N DEL PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO DE AD, EL PACIENTE FUE EVALUADO EN MÃšLTIPLES CONSULTAS DE SEGUIMIENTO. DURANTE LAS REVISIONES INICIALES, SE OBSERVÃ“ UNA MOVILIDAD DENTARIA QUE FUE DISMINUYENDO PROGRESIVAMENTE HASTA SU RESOLUCIÃ“N. NO SE REPORTARON EPISODIOS DE DOLOR EN NINGÃšN MOMENTO DEL PERIODO POSTOPERATORIO. A LOS 4 MESES Y MEDIO DE SEGUIMIENTO, EL PACIENTE NO PRESENTABA FÃ‰RULA DEBIDO A SU DESPRENDIMIENTO ACCIDENTAL; SIN EMBARGO, SE OBSERVÃ“ ESTABILIDAD DENTARIA, AUSENCIA DE MOVILIDAD, SIN SIGNOS DE INFECCIÃ“N O SINTOMATOLOGÃ□A DOLOROSA. LOS TEJIDOS BLANDOS CIRCUNDANTES MOSTRARON UNA ADECUADA CICATRIZACIÃ“N Y RESPUESTA PERIODONTAL FAVORABLE (FIG.7). A PESAR DEL SEGUIMIENTO LIMITADO EN COMPARACIÃ“N A LOS REPORTADOS EN LA LITERATURA, HEMOS LOGRADO UN BUEN AVANCE. ESTO INDICA LA POTENCIAL EFECTIVIDAD EN ESTE CASO, AUNQUE SE REQUIERE DE SEGUIMIENTO ADICIONAL PARA EVALUAR RESULTADOS A LARGO PLAZO.

CONCLUYENDO QUE ESTOS RESULTADOS SUGIEREN QUE, EN CONDICIONES ADECUADAS Y CON SEGUIMIENTO CLÃ□NICO RIGUROSO, EL AD PUEDE SER UNA ALTERNATIVA TERAPÃ‰UTICA PREDECIBLE Y EXITOSA PARA LA REHABILITACIÃ“N FUNCIONAL, ESTÃ‰TICA Y PERIODONTAL DEL PACIENTE. DE IGUAL MANERA QUE LOS PROTOCOLOS DIGITALES NOS PUEDEN AYUDAR DURANTE LA FASE DE DIAGNÃ“STICO, PLAN DE TRATAMIENTO, COMUNICACIÃ“N DEL PACIENTE Y PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO, PARA QUE NUESTROS TRATAMIENTOS SEAN MÃ□S PREDECIBLES; ENTRE MÃ□S PREDECIBLES, MAYOR PORCENTAJE DE Ã‰XITO.

Bibliografía *

1. NATIELLA JR, ARMITAGE JE, GREENE GW. THE REPLANTATION AND TRANSPLANTATION OF TEETH: A REVIEW. ORAL SURG ORAL MED ORAL PATHOL. 1970;29(3):397â€“419. HTTPS://DOI.ORG/10.1016/0030-4220(70)90143-X

2. DOKOVA AF, LEE JY, MASON M, MORETTI A, RESIDE G, CHRISTENSEN J. ADVANCEMENTS IN TOOTH AUTOTRANSPLANTATION. J AM DENT ASSOC. 2024;155(6):475â€“83.

3. ANSSARI MOIN D, VERWEIJ JP, WAARS H, VAN MERKESTEYN R, WISMEIJER D. ACCURACY OF COMPUTER-ASSISTED TEMPLATE-GUIDED AUTOTRANSPLANTATION OF TEETH WITH CUSTOM THREE-DIMENSIONAL DESIGNED/PRINTED SURGICAL TOOLING: A CADAVERIC STUDY. J ORAL MAXILLOFAC SURG. 2017;75(5):925.E1â€“7. HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.JOMS.2016.12.049

4. ABELLA F, RIBAS F, ROIG M, GONZÃ□LEZ-SÃ□NCHEZ JA, DURÃ□N-SINDREU F. OUTCOME OF AUTO-TRANSPLANTATION OF MATURE THIRD MOLARS USING 3-DIMENSIONAL-PRINTED GUIDING TEMPLATES AND DONOR TOOTH REPLICAS. J ENDOD. 2018;44(10):1567â€“74. HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.JOEN.2018.07.007

Título del trabajo *

CIRUGÃ A GUIADA EN IMPLANTES CON INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO Y PROVISIONALIZACIÃ“N EN ZONA ESTÃ‰TICA

Nombre del Autor (a/es)*

C.D. Jose Alfredo Razo Palomares

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

L.O.E.P. Olga MarÃ-a Martinez Bernal, L.O.E.P. Elizabeth de la Luz Aguilar, , , , , , , .

Correo Electrónico *

freddyrazo004@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD QUETZALCÃ“ATL EN IRAPUATO

Introducción y Objetivos *

LA CIRUGÃ A GUIADA EN IMPLANTOLOGÃ A PERMITE LA COLOCACIÃ“N PRECISA DE IMPLANTES DENTALES MEDIANTE PLANIFICACIÃ“N DIGITAL, MINIMIZANDO ERRORES Y OPTIMIZANDO RESULTADOS ESTÃ‰TICOS.

EN LA ZONA ANTERIOR, DONDE LA ESTÃ‰TICA ES PRIORITARIA, LA COMBINACIÃ“N CON INJERTOS DE TEJIDO CONECTIVO MEJORA EL PERFIL DE EMERGENCIA, AUMENTA EL VOLUMEN GINGIVAL Y FAVORECE UNA INTEGRACIÃ“N ARMÃ“NICA CON LOS DIENTES ADYACENTES.

EL OBJETIVO ES PRESENTAR UN CASO CLÃ NICO DE COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES MEDIANTE CIRUGÃ A GUIADA, ACOMPAÃ‘ADO DE INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO Y PROVISIONALIZACIÃ“N INMEDIATA, CON Ã‰NFASIS EN LA PRESERVACIÃ“N Y OPTIMIZACIÃ“N DE LA ESTÃ‰TICA GINGIVAL.

Descripción del Caso *

PACIENTE: MASCULINO DE 63 AÃ‘OS, ASA II, CON DIABETES MELLITUS TIPO II DE 16 AÃ‘OS DE EVOLUCIÃ“N CONTROLADA (TRATADO CON METFORMINA/GLIBENCLAMIDA 500 MG/2.5 MG UNA TABLETA DIARIA CON LOS ALIMENTOS). ACUDE A LA CLÃ□NICA DE POSGRADO DE PERIODONCIA DE LA UNIVERSIDAD QUETZALCÃ“ATL EN IRAPUATO CON EL MOTIVO DE â€œARREGLAR SUS DIENTESâ€□. A LA EXPLORACIÃ“N CLÃ□NICA SE OBSERVÃ“ FENOTIPO GINGIVAL PLANO Y GRUESO, RESTAURACIONES DE RESINA Y CERÃ□MICA, ASÃ□ COMO ZONAS EDÃ‰NTULAS EN OD 11, 21, 36, 37 Y 46, CON DEFECTO CLASE II DE SEIBERT. SE CONSIDERÃ“ VIABLE LA REHABILITACIÃ“N MEDIANTE PRÃ“TESIS FIJA IMPLANTOSOPORTADA EN LA ZONA ESTÃ‰TICA.

PLANEACIÃ“N:

SE REALIZARON FOTOGRAFÃ□AS INTRA Y EXTRAORALES, TOMOGRAFÃ□A CBCT Y ESCANEO INTRAORAL PARA PLANIFICACIÃ“N DIGITAL. EL ESTUDIO 3D MOSTRÃ“ UN REBORDE Ã“SEO DE 6 MM EN SENTIDO VESTÃ□BULO-PALATINO Y 15 MM DE LONGITUD. SE DISEÃ‘Ã“ UNA GUÃ□A QUIRÃšRGICA CONSIDERANDO LA POSICIÃ“N ESPACIAL DEL IMPLANTE, ENCÃ□A QUERATINIZADA (>2 MM) Y ESPACIOS PROTÃ‰SICOS ADECUADOS (10 MM PARA PROVISIONALES).

PROCEDIMIENTO:

1. LA COLOCACIÃ“N DE LOS IMPLANTES HIOSSEN TSIII SA (3.5 Ã— 10 MM) GUIADOS, BAJO ANESTESIA LOCAL CON ARTICAÃ□NA 4% CON EPINEFRINA 1:100,000. SE REALIZÃ“ ABORDAJE TIPO PUNCH Y EL PROTOCOLO DE FRESADO RECOMENDADO POR LA MARCA COMERCIAL, DEJANDO UNA FRESA POR ENCIMA DEL DIÃ□METRO FINAL POR EL HUESO TIPO D2 (850â€“1,250 UH), LOGRANDO UN TORQUE DE INSERCIÃ“N >30 NCM.

2. LA TÃ‰CNICA DE TÃšNEL MODIFICADA CON INSTRUMENTOS TKN1 Y TKN2, ELEVANDO UN COLGAJO A ESPESOR PARCIAL MEDIANTE INCISIONES SURCULARES SIN DESPRENDER LAS PAPILAS.

3. LA OBTENCIÃ“N DEL INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO FUE DEL PALADAR (DISTAL DE CANINO A MESIAL DE SEGUNDO MOLAR) CON TÃ‰CNICA BILAMINAR; DESEPITELIZACIÃ“N EXTRAORAL CON BISTURÃ□ #15C.

4. INSERCIÃ“N DEL INJERTO EN TÃšNEL Y FIJACIÃ“N CON SUTURAS REABSORBIBLES DE Ã□CIDO POLIGLICÃ“LICO 6-0 (ATRAMAT), ESTABILIZADO HORIZONTALMENTE.

5. LA INSTALACIÃ“N DE LOS PROVISIONALES ATORNILLADOS SOBRE PILARES DE TITANIO, CONFORMANDO PERFIL DE EMERGENCIA SIGUIENDO CRITERIOS E, B Y C, EVITANDO EXCESIVA PRESIÃ“N A TEJIDOS. TIEMPO DE CICATRIZACIÃ“N: 3 MESES.

CONTROL POSTOPERATORIO: RETIRO DE SUTURAS A LAS 2 SEMANAS Y REVISIÃ“N CLÃ□NICA Y RADIOGRÃ□FICA A LOS 3 MESES.

Resultados y Conclusiones *

â€¢ INTEGRACIÃ“N ADECUADA DEL IMPLANTE SIN COMPLICACIONES.

â€¢ AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL VOLUMEN GINGIVAL VESTIBULAR.

â€¢ PERFIL DE EMERGENCIA ARMÃ“NICO Y ESTÃ‰TICA ROSA FAVORABLE A LOS 3 MESES.

â€¢ ALTA SATISFACCIÃ“N DEL PACIENTE.

EL INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO FUE CLAVE PARA EL AUMENTO DEL CONTORNO VESTIBULAR Y LA ESTABILIDAD DE LOS TEJIDOS BLANDOS, FAVORECIENDO LA ESTÃ‰TICA ROSA Y LA CONFORMACIÃ“N DEL PERFIL DE EMERGENCIA.

CONCLUSIONES

â€¢ LA CIRUGÃ A GUIADA COMBINADA CON INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO ES UNA TÃ‰CNICA PREDECIBLE Y EFECTIVA PARA OPTIMIZAR ESTÃ‰TICA EN IMPLANTES DE ZONA ANTERIOR.

â€¢ LA PROVISIONALIZACIÃ“N INMEDIATA CONTRIBUYE AL MOLDEADO Y MANTENIMIENTO DEL PERFIL GINGIVAL.

â€¢ LA PLANIFICACIÃ“N DIGITAL PERMITE UN ABORDAJE SEGURO, FUNCIONAL Y ESTÃ‰TICAMENTE EXITOSO.

Bibliografía *

1. BUSER D, ET AL. LONG-TERM STABILITY OF SOFT TISSUE CONTOURS FOLLOWING IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT WITH CONNECTIVE TISSUE GRAFTING. CLIN ORAL IMPLANTS RES. 2020.

2. TARNOW DP, CHU SJ, ET AL. IMMEDIATE PROVISIONALIZATION IN THE ESTHETIC ZONE. INT J PERIODONTICS RESTORATIVE DENT. 2021.

3. ZUCCHELLI G, ET AL. SOFT TISSUE MANAGEMENT FOR DENTAL IMPLANTS. PERIODONTOLOGY 2000. 2022.

Título del trabajo *

TERAPIA DIRIGIDA A LA CAUSA EN PACIENTE JOVEN CON PERIODONTITIS ESTADIO III GENERALIZADA, GRADO C: CONTROL ETIOLOGICO Y PLANIFICACIÃ“N REGENERATIVA

Nombre del Autor (a/es)*

Aguilar Carrillo Jessica Alejandra

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Rosales Luviano Luis Eduardo, Chavez Granados Patricia Alejandra, , , , , , , .

Correo Electrónico *

alee.aguilarc08@gmail.com

Institución *

UNAM, ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNID

Introducción y Objetivos *

LA PERIODONTITIS ES UNA ENFERMEDAD INFLAMATORIA, MULTIFACTORIAL ASOCIADA A UNA DISBIOSIS BACTERIANA QUE PROMUEVE LA ACTIVACIÃ“N DE LA RESPUESTA INMUNE DEL HOSPEDERO Y CON ELLO LA DESTRUCCIÃ“N DE LOS TEJIDOS DE INSERCIÃ“N DEL PERIODONTO. SUS CARACTERÃ STICAS PRIMARIAS INCLUYEN LA PÃ‰RDIDA DE SOPORTE TISULAR PERIODONTAL, QUE SE MANIFIESTA A TRAVÃ‰S DE LA PÃ‰RDIDA DE INSERCIÃ“N CLÃ NICA Y LA PÃ‰RDIDA Ã“SEA ALVEOLAR EVALUADA RADIOGRÃ FICAMENTE, LA PRESENCIA DE BOLSAS PERIODONTALES Y SANGRADO GINGIVAL.

LA CLASIFICACIÃ“N DEL 2018, ABORDA LA PERIODONTITIS MEDIANTE ESTADIOS Y GRADOS. EL ESTADIO DESCRIBE LA ENFERMEDAD EN SU PRESENTACIÃ“N INICIAL Y LA COMPLEJIDAD DEL MANEJO DE LA ENFERMEDAD. POR OTRA PARTE, EL GRADO DESCRIBE LA VELOCIDAD Y EL RIESGO DE PROGRESIÃ“N.

LA PERIODONTITIS EN ADULTOS JÃ“VENES REPRESENTA UN DESAFÃ O TERAPÃ‰UTICO Y DIAGNÃ“STICO DEBIDO A LA RÃ PIDA PROGRESIÃ“N Y EL IMPACTO FUNCIONAL Y ESTÃ‰TICO QUE GENERA. POR OTRO LADO, LA PÃ‰RDIDA Ã“SEA VERTICAL EN ESTE GRUPO DE PACIENTES COMPROMETE EL PRONÃ“STICO A LARGO PLAZO SI NO SE ABORDA DE MANERA INTEGRAL. EN ESTE SENTIDO, ESTOS CASOS EXIGEN UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO QUE COMBINE EL CONTROL ETIOLÃ“GICO, TÃ‰CNICAS REGENERATIVAS Y TRATAMIENTO ORTODÃ“NCICO COORDINADO.

EL PRESENTE REPORTE TIENE COMO OBJETIVO MOSTRAR EL MANEJO PERIODONTAL DE UNA PACIENTE JOVEN DIAGNOSTICADA CON PERIODONTITIS ESTADIO III GENERALIZADA GRADO C, CON DEFECTOS Ã“SEOS VERTICALES Y ANTECEDENTES DE DOS TRATAMIENTOS ORTODÃ“NCICOS PREVIOS, ABORDADO MEDIANTE TERAPIA PERIODONTAL EN FASES, PLANEACIÃ“N QUIRÃšRGICA CON REGENERACIÃ“N TISULAR GUIADA Y COLABORACIÃ“N INTERDISCIPLINARIA CON ORTODONCIA.

SE DESTACA LA IMPORTANCIA DE LA DETECCIÃ“N OPORTUNA, VALORACIÃ“N DE FACTORES ANATÃ“MICOS Y EL USO DE TÃ‰CNICAS REGENERATIVAS PARA MEJORAR EL PRONÃ“STICO PERIODONTAL, ESPECIALMENTE EN PACIENTES JÃ“VENES QUE REQUIEREN CONSERVACIÃ“N FUNCIONAL Y ESTÃ‰TICA A LARGO PLAZO.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINO DE 26 AÃ‘OS, SISTÃ‰MICAMENTE SANA, ACUDE REFERIDA POR CLÃ□NICA DE ORTODONCIA. AL EXAMEN CLÃ□NICO SE IDENTIFICARON BOLSAS PERIODONTALES GENERALIZADAS DE 5-8MM, SANGRADO AL SONDAJE, MIGRACIÃ“N DENTAL, INFLAMACIÃ“N MARGINAL GENERALIZADA Y SUPURACIÃ“N LOCALIZADA EN OD 21. EL PERIODONTOGRAMA REVELÃ“ PÃ‰RDIDA DE INSERCIÃ“N CLÃ□NICA Y LAS RADIOGRAFÃ□AS PERIAPICALES MOSTRARON MÃšLTIPLES DEFECTOS Ã“SEOS VERTICALES, PREDOMINANTES DE 1 Y 2 PAREDES.

SE DIAGNOSTICÃ“ CON PERIODONTITIS ESTADIO III GENERALIZADA, GRADO C, DEBIDO A SU RÃ□PIDA PROGRESIÃ“N Y COMPROMISO GENERALIZADO DE SOPORTE Ã“SEO.

SE ESTABLECIÃ“ UN PLAN DE TRATAMIENTO BASADO EN PASOS:

PASO 1: CONTROL ETIOLÃ“GICO, EXPLICACIÃ“N DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL, TÃ‰CNICAS DE HIGIENE ORAL, CHARLA MOTIVACIONAL, CONTROL PERSONAL DE BIOPELÃ□CULA

PASO 2: INSTRUMENTACIÃ“N SUBGINGIVAL PARA MEJORAR PARÃ□METROS CLÃ□NICOS; REDUCCIÃ“N DE LA INFLAMACIÃ“N, SANGRADO Y PROFUNDIDAD DE SONDAJE.

PASO 3: FASE QUIRÃšRGICA; REGENERACIÃ“N TISULAR GUIADA CON APLICACIÃ“N DE EMDOGAIN, INJERTO DE HUESO Y MEMBRANA EN DEFECTOS SELECCIONADOS

PASO 4: MANTENIMIENTO CADA 4 MESES, CONTROL PERSONAL DE BIOPELÃ□CULA, REFUERZO DE TÃ‰CNICAS DE HIGIENE ORAL, CONTINUAR CON TRATAMIENTO DE ORTODONCIA PARA ESTABILIZACIÃ“N Y CONTROL DE TRAUMA OCLUSAL.

PROCEDIMIENTOS: EN EL PASO 1, SE REALIZARON SESIONES DE INSTRUMENTACIÃ“N SUBGINGIVAL POR CUADRANTE BAJO ANESTESIA LOCAL, ACOMPAÃ‘ADAS DE EDUCACIÃ“N EN HIGIENE ORAL Y CONTROL DE BIOPELÃ□CULA.

LA REEVALUACIÃ“N A LAS 8 SEMANAS MOSTRÃ“ REDUCCIÃ“N EN PROFUNDIDAD DE SONDAJE, DISMINUCIÃ“N DE SANGRADO Y MEJOR CONTROL DE BIOPELÃ□CULA.

POSTERIORMENTE, SE PLANIFICÃ“ LA INTERVENCIÃ“N QUIRÃšRGICA EN ZONAS CON DEFECTOS Ã“SEOS VERTICALES. LA INDICACIÃ“N QUIRÃšRGICA SE ESTABLECIÃ“ CONSIDERANDO FACTORES CLÃ□NICOS CLAVE COMO EL NÃšMERO DE PAREDES REMANENTES, PROFUNDIDAD SONDEABLE TRAS PASO 1 (PPD ?6 MM) Y ANGULACIÃ“N DEL DEFECTO. ESTOS CRITERIOS, DESCRITOS EN LA LITERATURA, SE ASOCIAN CON UNA MAYOR GANANCIA DE INSERCIÃ“N CLÃ□NICA Y RELLENO Ã“SEO RADIOGRÃ□FICO TRAS TERAPIA REGENERATIVA.

PARA LA TERAPIA REGENERATIVA DE LOS CUADRANTES SUPERIORES, LOS CUALES TIENEN 1 PARED, SE OPTÃ“ POR REALIZAR UNA TÃ‰CNICA QUIRÃšRGICA MÃ□NIMAMENTE INVASIVA (MIST) CON PRESERVACIÃ“N DE PAPILA SEGÃšN CORTELLINI, QUE FAVORECE EL ACCESO CONTROLADO AL DEFECTO Y MINIMIZA EL TRAUMA A LOS TEJIDOS BLANDOS. ADEMÃ□S, SE SELECCIONÃ“ EL USO COMBINADO DE EMDOGAINÂ® (PROTEÃ□NAS DERIVADAS DE LA MATRIZ DEL ESMALTE), INJERTO Ã“SEO Y MEMBRANA REABSORBIBLE, CON EL OBJETIVO DE ESTABILIZAR EL COÃ□GULO, MANTENER EL ESPACIO Y FAVORECER UNA REGENERACIÃ“N TISULAR, ESPECIALMENTE EN DEFECTOS NO TOTALMENTE CONTENIDOS.

MIENTRAS QUE EN LOS CUADRANTES INFERIORES, DONDE SE LOCALIZAN DEFECTOS Ã“SEOS DE 2 PAREDES, SE PRESCINDIRÃ□ DE LA MEMBRANA REABSORBIBLE DEBIDO A LA CONTENCIÃ“N QUE BRINDA LA MORFOLOGÃ□A DEL

Resultados y Conclusiones *

TRAS EL PASO 1, SE OBSERVÃ“ MEJORÃ□A CLÃ□NICA CON REDUCCIÃ“N DE LAS BOLSAS PERIODONTALES, MAYOR CONTROL DE BIOPELÃ□CULA Y CAMBIOS DE HÃ□BITOS DE LA PACIENTE, ASÃ□ COMO AUSENCIA DE SIGNOS DE INFLAMACIÃ“N.

LA SELECCIÃ“N DE DEFECTOS CON MORFOLOGÃ□A FAVORABLE Y LA APLICACIÃ“N DE TÃ‰CNICAS MÃ□NIMAMENTE INVASIVAS CON BIOMATERIALES ADECUADOS OPTIMIZAN EL POTENCIAL REGENERATIVO Y EL PRONÃ“STICO A LARGO PLAZO. AUNQUE AL MOMENTO DEL RESUMEN LA CIRUGÃ□A NO HA SIDO REALIZADA, SE ESPERA LOGRAR UNA GANANCIA DE INSERCIÃ“N CLÃ□NICA Y RADIOGRÃ□FICA, CONSERVANDO Ã“RGANOS DENTARIOS ESTRATÃ‰GICOS PARA EL SOPORTE FUNCIONAL Y ORTODÃ“NCICO.

ESTE CASO CLÃ□NICO RESALTA LA IMPORTANCIA DE UNA EVALUACIÃ“N CLÃ□NICA DETALLADA, EL TRATAMIENTO ESCALONADO Y LA COLABORACIÃ“N INTERDISCIPLINARIA. LA PERIODONTITIS AVANZADA EN ADULTOS JÃ“VENES NO SIEMPRE IMPLICA EXTRACCIONES; CON TÃ‰CNICAS REGENERATIVAS ADECUADAS Y SEGUIMIENTO, ES POSIBLE MANTENER DIENTES FUNCIONALES CON PRONÃ“STICO FAVORABLE.

Bibliografía *

1. PAPAPANOU PN, ET AL. PERIODONTITIS: CONSENSUS REPORT OF WORKGROUP 2 OF THE 2017 WORLD WORKSHOP. J CLIN PERIODONTOL. 2018.

2.SOCIEDAD ESPAÃ‘OLA DE PERIODONCIA Y OSTEOINTEGRACIÃ“N. (2021). GUÃ□A DE PRÃ□CTICA CLÃ□NICA EN PERIODONCIA: DIAGNÃ“STICO Y TRATAMIENTO DE LA PERIODONTITIS ESTADIO III Y IV. MADRID: SEPA.

3. CORTELLINI P, TONETTI MS. CLINICAL PERFORMANCE OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TECHNIQUES IN PERIODONTAL REGENERATION: RETROSPECTIVE ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING OUTCOMES. J CLIN PERIODONTOL. 2007;34(4):342â€“350.

Título del trabajo *

COLOCACIÃ“N GUIADA DE IMPLANTES EN SECTOR ESTÃ‰TICO, POSTERIOR A UNA REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA EN DEFECTO CLASE I DE SEIBERT

Nombre del Autor (a/es)*

L.O. Javier SÃ¡mano Ugalde

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

L.O.E.P. Olga MarÃ-a MartÃ-nez Bernal, , L.O.E.P. Elizabeth de la Luz Aguilar, , , , , , .

Correo Electrónico *

perio.javiersamano@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD QUETZALCOATL EN IRAPUATO

Introducción y Objetivos *

PARA QUE UN IMPLANTE DENTAL FUNCIONE DE FORMA Ã“PTIMA, DEBE COLOCARSE EN UNA POSICIÃ“N BIOLÃ“GICA Y PROTÃ‰SICAMENTE ACEPTABLE. SIN EMBARGO, CON LA PÃ‰RDIDA DE DIENTES, EL HUESO ALVEOLAR SE REMODELA Y REDUCE SUS DIMENSIONES EN DISTINTOS GRADOS Y VELOCIDADES. ACTUALMENTE, LA REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA ES UNO DE LOS MÃ‰TODOS MÃS PREVISIBLES PARA AUMENTAR EL VOLUMEN DEL HUESO HUÃ‰SPED EN LAS ZONAS ELEGIDAS PARA UNA FUTURA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES. EN ESTE CONTEXTO, LA CIRUGÃA GUIADA DE IMPLANTES PERMITE PLANIFICAR Y EJECUTAR LA INSERCIÃ“N EN LA POSICIÃ“N TRIDIMENSIONAL IDEAL, OPTIMIZANDO EL RESULTADO FUNCIONAL Y ESTÃ‰TICO, INCLUSO EN CASOS DONDE HA SIDO NECESARIO UN MANEJO PREVIO DEL TEJIDO Ã“SEO.EL OBJETIVO DE ESTE PROCEDIMIENTO FUE EVALUAR LA EFICACIA Y PREVISIBILIDAD DE LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES MEDIANTE UN PROTOCOLO GUIADO, CONSIDERANDO UN CASO CON REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA PREVIA.

Descripción del Caso *

SE PRESENTA UNA PACIENTE DE SEXO FEMENINO, DE 56 AÃ‘OS DE EDAD, CON ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÃ“GICOS RELEVANTES PARA EL CASO, ENTRE LOS QUE DESTACAN ARTRITIS REUMATOIDE Y SÃ□NDROME DE SJÃ–GREN SECUNDARIO.

DURANTE LA EXPLORACIÃ“N CLÃ□NICA INTRAORAL, SE OBSERVA LA PRESENCIA DE UNA PRÃ“TESIS FIJA DE SEIS UNIDADES, EN LA CUAL LOS CANINOS Y LOS INCISIVOS LATERALES SUPERIORES ACTÃšAN COMO DIENTES PILARES. DEBIDO A LA SITUACIÃ“N CLÃ□NICA Y AL ESTADO DE LOS DIENTES INVOLUCRADOS, SE TOMA LA DECISIÃ“N DE RETIRAR DICHA PRÃ“TESIS Y PROCEDER A LA EXTRACCIÃ“N DE AMBOS INCISIVOS LATERALES SUPERIORES.

EL ANÃ□LISIS TOMOGRÃ□FICO REVELA UNA PÃ‰RDIDA Ã“SEA DE TIPO HORIZONTAL, CLASIFICADA COMO CLASE I SEGÃšN SEIBERT, LOCALIZADA EN LA REGIÃ“N CORRESPONDIENTE A LOS INCISIVOS CENTRALES Y LATERALES SUPERIORES. LA CRESTA ALVEOLAR EN ESTA ZONA PRESENTA UN GROSOR APROXIMADO DE 3.11 MM, LO CUAL RESULTA INSUFICIENTE PARA LA COLOCACIÃ“N INMEDIATA DE IMPLANTES DENTALES.

ANTE ESTA LIMITACIÃ“N ANATÃ“MICA, SE PROPONE REALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA (ROG), EMPLEANDO PARA ELLO UNA MEMBRANA DE COLÃ□GENO REABSORBIBLE COMO BARRERA Y UN XENOINJERTO DE ORIGEN BOVINO COMO MATERIAL DE RELLENO Ã“SEO.

EL DIAGNÃ“STICO PERIODONTAL ESTABLECIDO ES: PERIODONTITIS EN ESTADIO III, GRADO B LOCALIZADA.

Resultados y Conclusiones *

8 MESES DESPUÃ‰S DE REALIZAR LA REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA, HUBO UNA GANANCIA DE APROX. 2.43MM DEL GROSOR DE LA CRESTA ALVEOLAR (3.11MM VS. 5.54MM). SE PROCEDIÃ“ A REALIZAR UNA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES MEDIANTE UN PROTOCOLO GUIADO UTILIZANDO EL KIT DE ONEGUIDEÂ® DE HIOSSENÂ® Y UNA GUÃ□A QUIRÃšRGICA FABRICADA PREVIAMENTE, CON IMPLANTES DE 3.5X11.5MM COLOCADOS EN EL Ã□REA CORRESPONDIENTE A LOS INCISIVOS LATERALES. SE OBTUVO UN TORQUE DE 22N EN EL IMPLANTE COLOCADO EN EL OD 12 Y 20N EN EL IMPLANTE COLOCADO EN EL OD 22. SE TOMÃ“ LA DECISIÃ“N DE SUMERGIR LOS IMPLANTES ANTES DE COLOCAR TORNILLOS DE CICATRIZACIÃ“N CON EL FIN DE FAVORECER UN ENTORNO ESTABLE Y LIBRE DE MICRO-MOVIMIENTOS DEBIDO A LAS CONDICIONES Ã“SEAS PRESENTES QUE PUDIERAN COMPROMETER LA UNIÃ“N HUESO-IMPLANTE. SE COLOCÃ“ UNA PRÃ“TESIS PROVISIONAL TIPO MARYLAND, DEJANDO UN ESPACIO DE 1.5MM ENTRE LA LÃ□NEA DE TERMINACIÃ“N Y LA MUCOSA DE LA ZONA INTERVENIDA, CON EL PROPÃ“SITO DE EVITAR LA PRESIÃ“N DIRECTA SOBRE EL SITIO QUIRÃšRGICO, FAVORECIENDO ASÃ□ LA CICATRIZACIÃ“N DE LOS TEJIDOS BLANDOS.

DURANTE LA CIRUGÃ□A GUIADA PARA LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES DENTALES EN EL SECTOR ESTÃ‰TICO EXISTE UNA DEMANDA EN LA PRECISIÃ“N Y UBICACIÃ“N TRIDIMENSIONAL DEL IMPLANTE, ESTO PARA GARANTIZAR RESULTADOS ESTÃ‰TICOS Y MINIMIZAR ERRORES QUIRÃšRGICOS QUE PUEDAN COMPROMETER LA FUNCIÃ“N O LA APARIENCIA DEL Ã□REA TRATADA.

AUTORES COMO Dâ€™HAESE (2017) MENCIONAN QUE LA CIRUGÃ□A GUIADA PERMITE UNA PLANIFICACIÃ“N EXACTA DE LA POSICIÃ“N, LA ANGULACIÃ“N Y LA PROFUNDIDAD DEL IMPLANTE.

COMO CONCLUSIÃ“N, LA CIRUGÃ□A GUIADA SIGUE SIENDO UN PROCEDIMIENTO PREVISIBLE, SIN EMBARGO, ES NECESARIO LLEVAR A CABO UNA PLANEACIÃ“N Y PROTOCOLO ADECUADOS PARA OBTENER LOS RESULTADOS ESPERADOS, SIEMPRE TOMANDO EN CONSIDERACIÃ“N TODOS LOS PARÃ□METROS PRE, TRANS Y POSTQUIRÃšRGICOS.

Bibliografía *

SCHROPP L, WENZEL A, KOSTOPOULOS L, KARRING T. BONE HEALING AND SOFT TISSUE CONTOUR CHANGES FOLLOWING SINGLE-TOOTH EXTRACTION: A CLINICAL AND RADIOGRAPHIC 12-MONTH PROSPECTIVE STUDY. INT J PERIODONTICS RESTORATIVE DENT. 2003;23(4):313â€“23.

TATAKIS DN, CHIEN H-H, PARASHIS AO. GUIDED IMPLANT SURGERY RISKS AND THEIR PREVENTION. PERIODONTOL 2000 [INTERNET]. 2019;81(1):194â€“208. AVAILABLE FROM: HTTP://DX.DOI.ORG/10.1111/PRD.12292

BENIC GI, HÃ„MMERLE CHF. HORIZONTAL BONE AUGMENTATION BY MEANS OF GUIDED BONE REGENERATION. PERIODONTOL 2000 [INTERNET]. 2014;66(1):13â€“40. AVAILABLE FROM: HTTP://DX.DOI.ORG/10.1111/PRD.12039

MELONI SM, JOVANOVIC SA, URBAN I, BALDONI E, PISANO M, TALLARICO M. HORIZONTAL RIDGE AUGMENTATION USING GBR WITH A NATIVE COLLAGEN MEMBRANE AND 1:1 RATIO OF PARTICULATE XENOGRAFT AND AUTOLOGOUS

Título del trabajo *

MODIFICACIÃ“N A CORTO Y MEDIANO PLAZO DEL FENOTIPO PERIIMPLANTARIO CON INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO AUTÃ“LOGO DEL MISMO SITIO QUIRÃšRGICO

Nombre del Autor (a/es)*

Elber Oswaldo Campos Valdes

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Mtro. Jaime Alejandro Nieto Ramirez, Mtra. Ana Lilia Guerra Barberena, , , , , , , .

Correo Electrónico *

elber313@gmail.com

Institución *

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD LEÃ“

Introducción y Objetivos *

EXISTEN DIFERENCIAS ANATÃ“MICAS E HISTOLÃ“GICAS FUNDAMENTALES ENTRE LOS TEJIDOS PERIODONTALES Y PERIIMPLANTARIOS, QUE CONFIEREN A ESTOS ÃšLTIMOS UNA MAYOR SUSCEPTIBILIDAD A PROCESOS INFLAMATORIOS Y A LA PÃ‰RDIDA DE SOPORTE. LA PRESENCIA DE UN VOLUMEN ADECUADO DE TEJIDO BLANDO, ASÃ COMO UN MÃNIMO DE TEJIDO QUERATINIZADO, CONSTITUYE UN FACTOR DETERMINANTE PARA FAVORECER LA SALUD PERIIMPLANTARIA Y ALCANZAR RESULTADOS ESTÃ‰TICOS PREDECIBLES A LARGO PLAZO. EN ESTE CONTEXTO, LA MODIFICACIÃ“N DEL FENOTIPO PERIIMPLANTARIO MEDIANTE INJERTOS DE TEJIDO BLANDO SE HA CONSOLIDADO COMO UNA TÃ‰CNICA COMPLEMENTARIA EFICAZ DENTRO DE LA TERAPIA IMPLANTOLÃ“GICA. SI BIEN EXISTEN DIVERSAS TÃ‰CNICAS Y MOMENTOS QUIRÃšRGICOS EN LOS QUE PUEDE REALIZARSE ESTA MODIFICACIÃ“N, ES IMPRESCINDIBLE VALORAR ASPECTOS COMO LA MORBILIDAD Y LA DURACIÃ“N DEL PROCEDIMIENTO, PROCURANDO NO COMPROMETER EL RESULTADO CLÃNICO.

OBJETIVO: PRESENTAR UN CASO CLÃNICO EN EL QUE SE REALIZA LA MODIFICACIÃ“N DEL FENOTIPO PERIIMPLANTARIO MEDIANTE INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO SUBEPITELIAL OBTENIDO DEL MISMO SITIO QUIRÃšRGICO, EVALUANDO VISUALMENTE SU IMPACTO EN LA ESTABILIDAD DE LOS TEJIDOS BLANDOS, EL GROSOR Y LA CALIDAD DE LA MUCOSA QUERATINIZADA, ASÃ COMO EN LOS RESULTADOS ESTÃ‰TICOS PERIIMPLANTARIOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINA DE 55 AÃ‘OS, SISTÃ‰MICAMENTE SANA, CON AUSENCIA DEL DIENTE 14, ACUDE AL POSGRADO DE PERIODONCIA PARA LA COLOCACIÃ“N DE UN IMPLANTE DENTAL. PREVIO AL PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO, SE REALIZA DIAGNÃ“STICO PERIODONTAL INTEGRAL Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGO. POSTERIORMENTE, SE EFECTÃšA UN ANÃ□LISIS CLÃ□NICO Y RADIOGRÃ□FICO DE LOS TEJIDOS BLANDOS Y DUROS DEL SITIO EDÃ‰NTULO. EN COORDINACIÃ“N CON EL POSGRADO DE REHABILITACIÃ“N ORAL, SE LLEVA A CABO LA PLANEACIÃ“N DIGITAL DEL CASO Y LA CONFECCIÃ“N DE UNA GUÃ□A QUIRÃšRGICA SEMI-RESTRICTIVA PARA LA COLOCACIÃ“N DE UN IMPLANTE NEODENT HELIX GM DE 3.5 MM X 8 MM. BAJO ANESTESIA LOCAL, SE REALIZA INCISIÃ“N MEDIO-CRESTAL EN EL SITIO EDÃ‰NTULO 14, LEVANTANDO COLGAJOS DE ESPESOR TOTAL POR VESTIBULAR Y PALATINO. CON LA GUÃ□A QUIRÃšRGICA SEMI-RESTRICTIVA, SE EJECUTA EL PROTOCOLO DE FRESADO E INSERCIÃ“N DEL IMPLANTE A 2 MM SUBCRESTAL. DEL ASPECTO PALATINO ADYACENTE AL SITIO QUIRÃšRGICO, SE OBTIENE UN INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO SUBEPITELIAL, EL CUAL SE SUTURA AL COLGAJO VESTIBULAR MEDIANTE PUNTOS COLCHONEROS HORIZONTALES (SUPERIOR E INFERIOR) CON SUTURA PGA 6-0. LA COAPTACIÃ“N FINAL DE LOS COLGAJOS SE REALIZA CON UN PUNTO COLCHONERO HORIZONTAL Y DOS PUNTOS SIMPLES (MESIAL Y DISTAL) CON SUTURA NYLON 5-0.

SIGUIENDO UN PROTOCOLO DE CARGA CONVENCIONAL, DURANTE LA SEGUNDA CIRUGÃ□A PARA LA COLOCACIÃ“N DE LA PRÃ“TESIS PROVISIONAL, BAJO ANESTESIA LOCAL SE REALIZÃ“ LA DESEPITELIZACIÃ“N DEL SITIO QUIRÃšRGICO CON MICROBISTURÃ□ POR SU ASPECTO OCLUSAL. POSTERIORMENTE, SE EFECTUÃ“ UNA INCISIÃ“N CRESTAL BISELADA PARA LEVANTAR UN COLGAJO DE ESPESOR PARCIAL, PRESERVANDO EL PERIOSTIO ADYACENTE AL HUESO Y ASÃ□ ROTAR EL COLGAJO PALATINO HACIA EL ASPECTO VESTIBULAR DEL SITIO QUIRÃšRGICO, SE SUTURÃ“ MEDIANTE UN PUNTO COLCHONERO HORIZONTAL CON PGA 6-0, SEGUIDO DE LA COLOCACIÃ“N DE LA PRÃ“TESIS PROVISIONAL.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS:

A LOS 30 DÃ AS POSTERIORES A LA CIRUGÃ A, PREVIO A LA COLOCACIÃ“N DE LA CORONA PROVISIONAL, SE EVIDENCIÃ“ CLÃ NICAMENTE UNA MODIFICACIÃ“N FAVORABLE DEL FENOTIPO PERIIMPLANTARIO, CARACTERIZADA POR UN INCREMENTO EN LAS DIMENSIONES VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS TEJIDOS BLANDOS. DURANTE ESTE PERIODO, LA PACIENTE NO REFIRIÃ“ DOLOR NI INCOMODIDAD EN EL SITIO QUIRÃšRGICO.

A LOS 4 MESES DE SEGUIMIENTO, SE OBSERVA UNA ESTABILIDAD A CORTO PLAZO DE LA MODIFICACIÃ“N DE LOS TEJIDOS PERIIMPLANTARES.

A LOS 5 MESES DE SEGUIMIENTO, SE PRODUJO UN AUMENTO DEL ESPESOR DEL TEJIDO BLANDO VESTIBULAR Y UNA MUCOSA QUERATINIZADA ESTABLE. SE LOGRÃ“ UN PERFIL DE EMERGENCIA FAVORABLE, CON MEJOR CONTORNO MUCOGINGIVAL Y RESULTADOS ESTÃ‰TICOS FAVORABLES.

CONCLUSIONES:

EL SEGUIMIENTO CLÃ NICO EVIDENCIÃ“ CICATRIZACIÃ“N ADECUADA, INTEGRACIÃ“N SATISFACTORIA DEL INJERTO Y FORMACIÃ“N ARMÃ“NICA DE LOS TEJIDOS BLANDOS, LO QUE RESPALDA LA VIABILIDAD DE ESTA TÃ‰CNICA COMO UNA ALTERNATIVA CONFIABLE Y REPRODUCIBLE EN CASOS SELECCIONADOS.

LA TÃ‰CNICA DESCRITA PERMITE OPTIMIZAR EL TIEMPO QUIRÃšRGICO Y REDUCIR LA MORBILIDAD MEDIANTE LA OBTENCIÃ“N DE UN INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO SUBEPITELIAL DEL MISMO SITIO QUIRÃšRGICO. ESTA VARIANTE FAVORECE UNA MODIFICACIÃ“N EFECTIVA DEL FENOTIPO PERIIMPLANTARIO, CONTRIBUYENDO A LA ESTABILIDAD TISULAR A CORTO Y MEDIANO PLAZO ADEMÃ S DE OBTENER RESULTADOS ESTÃ‰TICOS PREDECIBLES.

Bibliografía *

1.MISCH, C. E. (2008).Â CONTEMPORARY IMPLANT DENTISTRY. MOSBY.

2.SILVERMAN, B., & RICHARD JOHN MIRON. (2023).Â MODERN IMPLANT DENTISTRY.

3.MANCINI, L., SIMEONE, D., ROCCUZZO, A., STRAUSS, F. J., & MARCHETTI, E. (2023). TIMING OF SOFT TISSUE AUGMENTATION AROUND IMPLANTS: A CLINICAL REVIEW AND DECISION TREE.Â PUBMED,Â 16(4), 289â€“302.

4.GIANNOBILE, W. V., JUNG, R. E., & SCHWARZ, F. (2018). EVIDENCE-BASED KNOWLEDGE ON THE AESTHETICS AND MAINTENANCE OF PERI-IMPLANT SOFT TISSUES: OSTEOLOGY FOUNDATION CONSENSUS REPORT PART 1 EFFECTS OF SOFT TISSUE AUGMENTATION PROCEDURES ON THE MAINTENANCE OF PERI-IMPLANT SOFT TISSUE HEALTH. CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH, 29, 7â€“10.

5.JENSEN, S. S., AGHALOO, T., JUNG, R. E., BERTL, K., BUSER, D., CHAPPUIS, V., STAVOLA, L. DE, MONJE, A., PISPERO, A., ROCCUZZO, A., SHAKEEL SHAHDAD, STEFANINI, M., TAVELLI, L., WANG, H., & ZUCCHELLI, G. (2023). GROUP 1 ITI CONSENSUS REPORT: THE ROLE OF BONE DIMENSIONS AND SOFT TISSUE AUGMENTATION PROCEDURES ON THE STABILITY OF CLINICAL, RADIOGRAPHIC, AND PATIENT?REPORTED OUTCOMES OF IMPLANT TREATMENT.Â CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH,Â 34(S26), 43â€“49.

Título del trabajo *

EVALUACIÃ“N DE PARÃ METROS CLÃ NICOS Y RADIOGRÃ FICOS TRAS TRATAMIENTO DE PERIIMPLANTITIS CON TERAPIA COMBINADA EN UN IMPLANTE CON 10 AÃ‘OS EN FUNCIÃ“N: CASO CLÃ NICO.

Nombre del Autor (a/es)*

Yolanda Cecilia Retana ValdÃ©s, Xitlaly Martinez Mo

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Alejandra CastrejÃ³n Flores, , Braulio Garcia Amador, , Martin Cavazos Rivera, , , , .

Correo Electrónico *

ceciliaretanavaldes@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD JUÃ REZ DEL ESTADO DE DURANGO

Introducción y Objetivos *

LA PERIIMPLANTITIS ES UNA AFECCIÃ“N INFLAMATORIA QUE AFECTA LOS TEJIDOS ALREDEDOR DE LOS IMPLANTES DENTALES, CARACTERIZÃ□NDOSE POR INFLAMACIÃ“N DE LA MUCOSA PERIIMPLANTARIA Y PÃ‰RDIDA PROGRESIVA DEL HUESO DE SOPORTE. SUS SIGNOS CLÃ□NICOS INCLUYEN ENROJECIMIENTO, EDEMA, SANGRADO AL SONDAJE (BOP+), CON O SIN SUPURACIÃ“N, AUMENTO EN LA PROFUNDIDAD DE SONDAJE Y PÃ‰RDIDA Ã“SEA DETECTABLE RADIOGRÃ□FICAMENTE.

EL OBJETIVO TERAPÃ‰UTICO CONSISTE EN RESTABLECER UN ENTORNO BIOLÃ“GICO FAVORABLE, ORIENTADO HACIA UN ECOSISTEMA AERÃ“BICO QUE PROMUEVA LA SALUD Y ESTABILIDAD DE LOS TEJIDOS PERIIMPLANTARIOS, INTERRUMPIENDO LA FORMACIÃ“N DE BIOPELÃ□CULAS Y CORRIGIENDO FACTORES LOCALES PREDISPONENTES. LA CONFIGURACIÃ“N DEL DEFECTO Ã“SEO DETERMINA EL ABORDAJE TERAPÃ‰UTICO Y PUEDE CLASIFICARSE SEGÃšN LA PRESENCIA Y POSICIÃ“N DE LOS PICOS O PAREDES Ã“SEAS ADYACENTES: CLASE I (INTRAÃ“SEO), CLASE II (SUPRACRESTAL) Y CLASE III (COMBINADO), CON SUBCLASIFICACIÃ“N BASADA EN EL NÃšMERO DE PAREDES RESIDUALES: SUBCLASE A (DEHISCENCIA), SUBCLASE B (2â€“3 PAREDES) Y SUBCLASE C (CIRCUNFERENCIAL).

EL CRITERIO PRINCIPAL DE Ã‰XITO EN EL MANEJO DE LA PERIIMPLANTITIS ES RESTABLECER UN ESTADO DE SALUD CON PROFUNDIDADES DE SONDAJE REDUCIDAS Y UNA POBLACIÃ“N BACTERIANA PREDOMINANTEMENTE AERÃ“BICA. PARA ALCANZAR ESTE OBJETIVO, SE HAN DESARROLLADO DIVERSAS MODALIDADES TERAPÃ‰UTICAS, QUIRÃšRGICAS Y NO QUIRÃšRGICAS. ENTRE LAS OPCIONES QUIRÃšRGICAS SE INCLUYEN EL DESBRIDAMIENTO CON COLGAJO ABIERTO, LOS ABORDAJES RECONSTRUCTIVOS Y RESECTIVOS, CON O SIN ADICIÃ“N DE TEJIDO BLANDO. LA ELECCIÃ“N DE LA TÃ‰CNICA SE BASA PRINCIPALMENTE EN LA CONFIGURACIÃ“N DEL DEFECTO.

UN ASPECTO CLAVE PARA EL Ã‰XITO DEL TRATAMIENTO QUIRÃšRGICO ES LA DESCONTAMINACIÃ“N DE LA SUPERFICIE DEL IMPLANTE, DADO QUE LA PRESENCIA DE BIOPELÃ□CULA, CÃ□LCULO RESIDUAL, ENDOTOXINAS Y COLONIAS BACTERIANAS PUEDE COMPROMETER LOS RESULTADOS Y FAVORECER LA RECURRENCIA DE LA ENFERMEDAD.

EL PRESENTE TRABAJO TIENE COMO OBJETIVO PRESENTAR EL MANEJO DE LA PERIIMPLANTITIS MEDIANTE TERAPIA COMBINADA, ORIENTADO A LA PRESERVACIÃ“N DE UN IMPLANTE FUNCIONAL, CON MÃ□S DE 10 AÃ‘OS DE SUPERVIVENCIA EN BOCA.

Descripción del Caso *

SE PRESENTA UNA PACIENTE FEMENINA DE 64 AÃ‘OS AL ÃREA DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÃA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO, REFIRIENDO COMO MOTIVO DE CONSULTA: â€œME MANDAN PORQUE TRAIGO EXPUESTO UN IMPLANTEâ€. NO SE REPORTAN ANTECEDENTES FAMILIARES RELEVANTES; DENTRO DE LOS ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÃ“GICOS, DESTACA UN CÁNCER DE COLON EN REMISIÃ“N DESDE 2019, Y LA PACIENTE ES CLASIFICADA COMO ASA II. SU DIAGNÃ“STICO PERIODONTAL CORRESPONDE A UNA PERIODONTITIS GENERALIZADA PREVIAMENTE TRATADA CON Ã‰XITO, PRESENTANDO PERIIMPLANTITIS LOCALIZADA EN EL IMPLANTE COLOCADO EN LA ZONA DE OD 16.

EL IMPLANTE, DE LA MARCA HIOSSEN, FUE COLOCADO HACE 10 AÃ‘OS EN ESTADOS UNIDOS Y SOPORTA UNA PRÃ“TESIS CEMENTADA CON CANTILEVER MESIAL. LA PACIENTE REFIERE AUSENCIA DE ASISTENCIA A TERAPIA DE MANTENIMIENTO Y FALTA DE INSTRUCCIÃ“N EN TÃ‰CNICAS DE HIGIENE ORAL. AL EXAMEN CLÁNICO, EL IMPLANTE MOSTRABA PROFUNDIDADES DE SONDAJE DE 6â€“7 MM, PRESENCIA DE BIOFILM, SANGRADO AL SONDAJE, SUPURACIÃ“N, PÃ‰RDIDA Ã“SEA HORIZONTAL RADIOGRÁFICA, PERO SIN DOLOR NI MOVILIDAD.

SE IMPLEMENTÃ“ UN PROTOCOLO DE TERAPIA COMBINADA. DADA LA NATURALEZA DE LA PRÃ“TESIS, NO FUE POSIBLE RETIRARLA, POR LO QUE EL PROCEDIMIENTO SE REALIZÃ“ CON LA PRÃ“TESIS IN SITU. PREVIO AL PROCEDIMIENTO SE REGISTRARON SIGNOS VITALES Y SE REALIZÃ“ MEDICIÃ“N DE GLUCOSA CAPILAR, SEGUIDOS DE LA ASEPSIA Y ANTISEPSIA CORRESPONDIENTE.

SE REALIZARON INCISIONES INTRASULCULARES ADYACENTES A LA PRÃ“TESIS Y UNA INCISIÃ“N CRESTAL CON BISTURÍ 15C, ELEVÁNDOSE UN COLGAJO MUCOPERIÃ“STICO CON PERIOSTÃ“TOMO P20. SE LLEVÃ“ A CABO DESBRIDAMIENTO COMPLETO DEL TEJIDO GRANULOMATOSO UTILIZANDO ULTRASONIDO Y CURETAS GRACEY. POSTERIORMENTE, SE REALIZÃ“ DESCONTAMINACIÃ“N QUÍMICA DEL IMPLANTE MEDIANTE GEL DE CLORHEXIDINA AL 2% DURANTE 2 MINUTOS, COMPLEMENTADA CON IRRIGACIÃ“N PROFUSA CON METRONIDAZOL DE 500 MG.

LA IMPLANTOPLASTÍA SE EJECUTÃ“ CON PIEZA DE ALTA VELOCIDAD, USANDO FRESAS DE DIAMANTE DE GRANO FINO Y PULIDO FINAL CON FRESA DE PIEDRA BLANCA. EN EL COMPARTIMENTO Ã“SEO, SE EFECTUÃ“ CRIBADO CON FRESA DE BOLA DE CARBURO NÃšM. 4. PARA LA REGENERACIÃ“N Ã“SEA, SE COLOCÃ“ INJERTO XENOGÃ‰NICO DE ORIGEN BOVINO (NUKBONE) CUBIERTO CON MEMBRANA DE COLÁGENO REABSORBIBLE (BIOTECK). LA SUTURA INCLUYÃ“ PUNTOS EN X, COLCHONEROS Y SIMPLES CON NYLON 5-0.

FINALMENTE, SE PRESCRIBIÃ“ TERAPIA FARMACOLÃ“GICA CON AMOXICILINA 500 MG Y METRONIDAZOL 250 MG, 1 DOSIS CADA 8 HORAS POR 7 DÍAS.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS:

PREVIO AL TRATAMIENTO, LA PACIENTE PRESENTÃ“ PROFUNDIDADES DE SONDAJE DE 6â€“7?MM, SANGRADO AL SONDAJE, SUPURACIÃ“N, PÃ‰RDIDA Ã“SEA HORIZONTAL CON DEFECTO SUPRA Ã“SEO, NO FUE POSIBLE EVALUAR LA CANTIDAD DE ENCÃ?A QUERATINIZADA POR EL GRADO DE INFLAMACIÃ“N; SIN EMBARGO, EL IMPLANTE PERMANECÃ?A SIN MOVILIDAD NI DOLOR. DURANTE EL SEGUIMIENTO, SE INSTRUYÃ“ EN EL USO DE CEPILLOS INTERPROXIMALES E IRRIGADOR BUCAL. A UN AÃ‘O, LAS PROFUNDIDADES DE SONDAJE SE REDUJERON A 3â€“4?MM, CON AUSENCIA DE SANGRADO Y SUPURACIÃ“N, SE LOGRÃ“ OBSERVAR LA PRESENCIA DE ENCÃ?A QUERATINIZADA Y TEJIDO BLANDO ESTABLE. LA SUPERFICIE DEL IMPLANTE SE MANTUVO LIBRE DE PLACA BACTERIANA Y LA PACIENTE NO PRESENTÃ“ MOLESTIAS AL REALIZAR LA HIGIENE. AUNQUE LA GANANCIA Ã“SEA FUE LIMITADA DEBIDO A LA NATURALEZA SUPRA Ã“SEA DEL DEFECTO, SE LOGRÃ“ PREVENIR EL COLAPSO DEL TEJIDO BLANDO Y PRESERVAR LA FUNCIÃ“N DEL IMPLANTE.

CONCLUSIONES:

EL MANEJO DE LA PERIIMPLANTITIS MEDIANTE TERAPIAS COMBINADAS PERMITIÃ“ PRESERVAR UN IMPLANTE ESTABLE, FUNCIONAL Y ASINTOMÃ?TICO, EVITANDO ASÃ? LA EXPLANTACIÃ“N Y EL CONSIGUIENTE RIESGO DE MAYOR TRAUMA Y PÃ‰RDIDA Ã“SEA. LA REDUCCIÃ“N DE LAS PROFUNDIDADES DE SONDAJE, LA AUSENCIA DE SANGRADO Y SUPURACIÃ“N, Y LA ESTABILIDAD DEL TEJIDO BALNDO DEMUESTRAN QUE UN ENFOQUE INTEGRAL, COMPLEMENTADO CON INSTRUCCIÃ“N EN TÃ‰CNICAS DE HIGIENE Y SEGUIMIENTO EN UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, PUEDE MAXIMIZAR LA SUPERVIVENCIA Y LA ESTABILIDAD A LARGO PLAZO DE LOS IMPLANTES DENTALES.

Bibliografía *

SCHWARZ F, DERKS J, MONJE A,WANG H?L. PERI?IMPLANTITIS. J CLIN PERIODONTOL.2018;45(SUPPL 20):S246â€“S266.

MONJE A, SALVI GE. DIAGNOSTIC METHODS/PARAMETERS TO MONITOR PERI- IMPLANT CONDITIONS. PERIODONTOLOGY 2000. 2024;95:20-39.

MONJE A, NAVARRO-MESA S. SURFACE DECONTAMINATION ON THE RECONSTRUCTIVE THERAPY OF

PERI- IMPLANTITIS: A MULTICENTER RANDOMIZED CLINICAL TRIAL, CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH, 2025; 27:E70075.

MONJE A, PONS R, SCULEAN A, NART J, WANGH-L. DEFECT ANGLE AS PROGNOSTIC INDICATOR IN THE RECONSTRUCTIVE THERAPY OF PERI-IMPLANTITIS. CLIN IMPLANT DENT RELAT RES. 2023;25(6):992?999.

MONJE A., AMERIO E., STRATEGIES FOR IMPLANT SURFACE DECONTAMINATION IN PERI-IMPLANTITIS THERAPY, INT J ORAL IMPLANTOL 2022;15(3):1â€“36.

Título del trabajo *

REHABILITACIÃ“N FIJA CON IMPLANTES MÃšLTIPLES Y ELEVACIÃ“N SINUSAL EN PACIENTE ADULTO MAYOR: REPORTE DE CASO CLÃ NICO INTEGRAL

Nombre del Autor (a/es)*

Dra. Evelyn Flores Torres, Dr. Alejandro Carmona L

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Correo Electrónico *

evelynflores7713@gmail.com

Institución *

POSGRADO EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÃ A AME

Introducción y Objetivos *

LA REHABILITACIÃ“N ORAL CON IMPLANTES DENTALES SE HA CONSOLIDADO COMO UNA SOLUCIÃ“N FUNCIONAL Y ESTÃ‰TICA PARA PACIENTES PARCIAL O TOTALMENTE EDÃ‰NTULOS. SU Ã‰XITO DEPENDE DE UNA CORRECTA ANAMNESIS, EVALUACIÃ“N CLÃ NICA, PERIODONTAL Y ESTÃ‰TICA, ASÃ COMO LA SELECCIÃ“N DE PROTOCOLOS QUIRÃšRGICOS INDIVIDUALIZADOS. PARA CASOS COMPLEJOS, TÃ‰CNICAS COMO EL PROTOCOLO DE FRESADO A BAJA VELOCIDAD (1) Y LA TÃ‰CNICA HIDRÃ ULICA PARA ELEVACIÃ“N DEL SENO MAXILAR (2) HAN DEMOSTRADO RESULTADOS PREDECIBLES EN TÃ‰RMINOS DE INTEGRACIÃ“N Y SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO.

UNA ADECUADA PLANIFICACIÃ“N PROTÃ‰SICA Y QUIRÃšRGICA ES ESENCIAL, ESPECIALMENTE EN PACIENTES ADULTOS MAYORES. LA CLASIFICACIÃ“N DEL BIOTIPO FACIAL SEGÃšN FRADEANI (3) Y EL ANÃ LISIS DENTOLABIAL CON BASE EN LOS PARÃ METROS DE GARBER Y SALAMA (4) PERMITEN DISEÃ‘AR UNA REHABILITACIÃ“N QUE RESPETE TANTO CRITERIOS FUNCIONALES Y ESTÃ‰TICOS. EN ESTE CASO, SE EMPLEÃ“ UNA GUÃ A QUIRÃšRGICA ANÃ LOGA CONFECCIONADA A PARTIR DE UN DUPLICADO PROTÃ‰SICO CON MARCADORES RADIOGRÃ FICOS, LA CUAL FACILITÃ“ LA COLOCACIÃ“N PRECISA DE LOS IMPLANTES.

EL OBJETIVO DE ESTE REPORTE DE CASO ES DOCUMENTAR EL ABORDAJE INTEGRAL EN UN PACIENTE ADULTO MAYOR QUE SOLICITÃ“ UNA REHABILITACIÃ“N FIJA MEDIANTE IMPLANTES MÃšLTIPLES. SE DETALLA EL PROTOCOLO DE DIAGNÃ“STICO, PLANIFICACIÃ“N QUIRÃšRGICA Y RESULTADOS CLÃ NICOS, DESTACANDO EL PAPEL DE LA CIRUGÃ A MÃ NIMAMENTE INVASIVA Y LA COORDINACIÃ“N INTERDISCIPLINARIA EN EL Ã‰XITO TERAPÃ‰UTICO.

Descripción del Caso *

PACIENTE MASCULINO DE 71 AÃ‘OS ACUDE LAS CLÃ□NICAS ODONTOLÃ“GICAS DE AME UNIVERSIDAD CON UN MOTIVO DE CONSULTA Â¨QUIERO REPONER MIS DIENTES PERDIDOSÂ¨ AL INTERROGATORIO MENCIONA QUE HIPERTENSO CONTROLADO, NO FUMADOR NI CONSUMIDOR DE ALCOHOL POR LO QUE SE CLASIFICA COMO ASA II. SE INICIÃ“ EL PROTOCOLO DE VALORACIÃ“N MEDIANTE ANÃ□LISIS FACIAL, INTRAORAL Y PERIODONTAL

SE UTILIZÃ“ EL ANÃ□LISIS ESTÃ‰TICO DE FRADEANI PARA CLASIFICAR EL BIOTIPO COMO BRAQUIFACIAL Y EVALUAR LOS PARÃ□METROS DENTOLABIALES CONFORME A LOS CRITERIOS DE GARBER Y SALAMA. CLÃ□NICAMENTE, SE OBSERVÃ“ EDENTULISMO TOTAL EN MAXILAR, EN MANDÃ□BULA DE OBSERVAN PIEZAS RESTAURADAS, EN GENERAL SE OBSERVÃ“ PRESENCIA DE UN FENOTIPO PERIODONTAL GRUESO. EL DIAGNÃ“STICO PERIODONTAL DEL PACIENTE ES SALUD PERIODONTAL, Y LOS ESTUDIOS HISTOTOMOGRÃ□FICOS MOSTRARON SUFICIENTE DISPONIBILIDAD Ã“SEA PARA LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES DENTALES.

EL TRATAMIENTO FUE PLANIFICADO EN TRES FASES. EN LA PRIMERA FASE QUIRÃšRGICA, SE MONITORIZÃ“ LA PRESIÃ“N ARTERIAL (114/59 MMHG, 73 PPM) Y SE ADMINISTRÃ“ ANESTESIA LOCAL CON ARTICAÃ□NA AL 4%. SE REALIZÃ“ UN COLGAJO DE ESPESOR TOTAL MEDIANTE TÃ‰CNICA DE DOBLE COLGAJO TRIANGULAR, DESCRITA POR GARGALLO ALBIOL. POSTERIORMENTE, SE COLOCARON SEIS IMPLANTES CON EL APOYO DE UNA GUÃ□A QUIRÃšRGICA CONFECCIONADA A PARTIR DE UN DUPLICADO PROTÃ‰SICO CON MARCADORES RADIOGRÃ□FICOS, SIGUIENDO UN PROTOCOLO DE FRESADO A BAJA VELOCIDAD BASADO EN LA TÃ‰CNICA PROPUESTA POR ANITUA Y COLABORADORES (1).

DURANTE LA CIRUGÃ□A, SE DETECTÃ“ LA NECESIDAD DE REALIZAR ELEVACIONES SINUSALES BILATERALES, LAS CUALES SE LLEVARON A CABO MEDIANTE LA TÃ‰CNICA HIDRÃ□ULICA PROPUESTA POR GATTI Y COLABORADORES, MINIMIZANDO ASÃ□ EL RIESGO DE PERFORACIÃ“N DE LA MEMBRANA DE SCHNEIDER. SE INDICÃ“ MEDICACIÃ“N POSTOPERATORIA CON AMOXICILINA CON Ã□CIDO CLAVULÃ□NICO, TRAMADOL, PARACETAMOL Y ENJUAGUES CON CLORHEXIDINA. EL PACIENTE FUE MONITORIZADO DURANTE LOS CONTROLES POSTQUIRÃšRGICOS, CON EVOLUCIÃ“N FAVORABLE.

Resultados y Conclusiones *

A COLOCACIÃ“N DE LOS SEIS IMPLANTES SE REALIZÃ“ SIN COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS. EL PACIENTE CURSÃ“ CON BUENA CICATRIZACIÃ“N DE TEJIDOS BLANDOS Y SIN SIGNOS DE INFECCIÃ“N O RECHAZO. EL SEGUIMIENTO RADIOGRÃ□FICO MOSTRÃ“ ESTABILIDAD PRIMARIA DE LOS IMPLANTES Y SIGNOS DE INTEGRACIÃ“N Ã“SEA PROGRESIVA.

LA GUÃ□A QUIRÃšRGICA ANÃ□LOGA PERMITIÃ“ UNA DISTRIBUCIÃ“N ADECUADA DE LOS IMPLANTES, RESPETANDO ESTRUCTURAS ANATÃ“MICAS Y ALINEÃ□NDOSE CON LA FUTURA REHABILITACIÃ“N PROTÃ‰SICA. EL USO DEL PROTOCOLO DE FRESADO A BAJA VELOCIDAD (1) Y LA TÃ‰CNICA DE ELEVACIÃ“N SINUSAL HIDRÃ□ULICA (2) CONTRIBUYERON A REDUCIR EL TRAUMA QUIRÃšRGICO Y FAVORECER LA INTEGRACIÃ“N. ESTA ÃšLTIMA TÃ‰CNICA, DESCRITA POR GATTI Y COLABORADORES, SE APLICÃ“ EN AMBOS SENOS MAXILARES Y PERMITIÃ“ UN ABORDAJE CONTROLADO SIN NECESIDAD DE OSTEOTOMOS.

ESTE CASO SUBRAYA LA IMPORTANCIA DE UNA PLANIFICACIÃ“N DETALLADA, COMENZANDO DESDE EL ANÃ□LISIS FACIAL (3) Y DENTO-LABIAL (4), PASANDO POR LA SELECCIÃ“N DEL COLGAJO QUIRÃšRGICO ADECUADO (5), HASTA LA EJECUCIÃ“N CONTROLADA DEL ACTO QUIRÃšRGICO. LA COORDINACIÃ“N ENTRE PERIODONCIA, PROSTODONCIA E IMPLANTOLOGÃ□A FUE DETERMINANTE PARA LOGRAR UN RESULTADO CLÃ□NICO Y ESTÃ‰TICO EXITOSO.

EN CONCLUSIÃ“N, LA REHABILITACIÃ“N ORAL MEDIANTE IMPLANTES MÃšLTIPLES EN PACIENTES ADULTOS MAYORES PUEDE LOGRARSE CON ALTOS NIVELES DE PREDICTIBILIDAD SI SE INTEGRAN PROTOCOLOS QUIRÃšRGICOS BASADOS EN EVIDENCIA, GUÃ□AS PERSONALIZADAS Y UNA EVALUACIÃ“N INTERDISCIPLINARIA ADECUADA.

Bibliografía *

1. ANITUA E, ORIVE G. CLINICAL EVALUATION OF IMMEDIATE-LOADED DENTAL IMPLANTS IN POSTERIOR REGIONS: A 5-YEAR PROSPECTIVE STUDY. J PERIODONTOL. 2007;78(2):246â€“53.

2. GATTI C, GATTI F, CHIAPASCO M. THE TRANSCRESTAL HYDRODYNAMIC ULTRASONIC CAVITATIONAL SINUS LIFT: A RETROSPECTIVE STUDY ON 979 IMPLANTS WITH 1â€“6 YEARS OF FOLLOW-UP. CLIN ORAL IMPLANTS RES. 2018;29(10):1097â€“107.

3. FRADEANI M. ESTÃ‰TICA EN PRÃ“TESIS FIJA. QUINTESSENCE; 2006.

4. GARBER DA, SALAMA MA. THE AESTHETIC SMILE: DIAGNOSIS AND TREATMENT. PERIODONTOL 2000. 1996;11(1):18â€“28.

5. GARGALLO-ALBIOL J. TÃ‰CNICAS DE COLGAJO PARA IMPLANTOLOGÃ□A QUIRÃšRGICA. RCOE. 1999;4(6):493â€“500.

Título del trabajo *

DETOXIFICACIÃ“N Y REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA COMO TRATAMIENTO DE PERIIMPLANTITIS: REPORTE DE CASO CLÃ?NICO.

Nombre del Autor (a/es)*

C.D. Flores Santos Coy Samantha

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

D.C.F. Castillo Alvarez Victor Hugo, D.C.F. Reyes Alvarado Lizeth Alejandra, Dra. GarcÃ-a ChÃ¡vez Marina, M.C.O. MartÃ-nez Lomas Karla Guadalupe., , , , , .

Correo Electrónico *

samanthafls97@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD AUTÃ“NOMA DE COAHUILA, UNIDAD LAGUNA.

Introducción y Objetivos *

LA PERIIMPLANTITIS ES UNA CONDICIÃ“N INFLAMATORIA Y BACTERIANA, MEDIADA POR BIOFILM, QUE AFECTA TANTO A LOS TEJIDOS BLANDOS COMO DUROS ALREDEDOR DE LOS IMPLANTES DENTALES EN FUNCIÃ“N [1]. CLÃ□NICAMENTE SE CARACTERIZA POR ENROJECIMIENTO, EDEMA, SANGRADO AL SONDAJE CON O SIN SUPURACIÃ“N, INCREMENTO EN LA PROFUNDIDAD DE SONDAJE Y PÃ‰RDIDA Ã“SEA PROGRESIVA EVIDENCIADA RADIOGRÃ□FICAMENTE [2].

EL OBJETIVO TERAPÃ‰UTICO EN ESTOS CASOS ES CONTROLAR LA INFLAMACIÃ“N Y PREVENIR UNA MAYOR PÃ‰RDIDA Ã“SEA MARGINAL. LAS ESTRATEGIAS QUIRÃšRGICAS SE CLASIFICAN EN TERAPIAS NO RECONSTRUCTIVAS, RESECTIVAS, RECONSTRUCTIVAS O COMBINADAS. ESTA ÃšLTIMA BUSCA ELIMINAR EL TEJIDO INFLAMADO, DESCONTAMINAR LA SUPERFICIE IMPLANTARIA Y REGENERAR EL DEFECTO Ã“SEO MEDIANTE EL USO DE BIOMATERIALES [1].

LA REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA (ROG) HA MOSTRADO BUENOS RESULTADOS EN DEFECTOS PERIIMPLANTARIOS CONTENIDOS, ESPECIALMENTE AQUELLOS CON UNA PROFUNDIDAD DE AL MENOS 3 MM. LOS PROTOCOLOS MÃ□S EMPLEADOS INCLUYEN: 1) XENOINJERTO Ã“SEO CON MEMBRANA ENRIQUECIDA CON FACTORES DE CRECIMIENTO, O 2) XENOINJERTO PARTICULADO CUBIERTO CON MEMBRANA DE COLÃ□GENO O MATRIZ DE COLÃ□GENO [1].

MONJE Y COLABORADORES (2019) PROPUSIERON UNA CLASIFICACIÃ“N MORFOLÃ“GICA PARA LOS DEFECTOS Ã“SEOS PERIIMPLANTARIOS QUE PERMITE INDIVIDUALIZAR EL TRATAMIENTO. LA CLASE I INCLUYE DEFECTOS INFRAÃ“SEOS: IA (DEHISCENCIA BUCAL), IB (DEFECTO DE 2-3 PAREDES) E IC (DEFECTO CIRCUNFERENCIAL). LA CLASE II CORRESPONDE A DEFECTOS HORIZONTALES, Y LA CLASE III A DEFECTOS COMBINADOS CON PÃ‰RDIDA Ã“SEA HORIZONTAL ASOCIADA [3]. ESTA CLASIFICACIÃ“N RESULTA ÃšTIL PARA GUIAR LA ELECCIÃ“N DE LA TÃ‰CNICA QUIRÃšRGICA MÃ□S ADECUADA SEGÃšN LA MORFOLOGÃ□A DEL DEFECTO.

OBJETIVO.

TRATAR UN DEFECTO Ã“SEO CONTENIDO DE TIPO IC ALREDEDOR DE UN IMPLANTE CON PÃ‰RDIDA Ã“SEA VERTICAL DE 6 MM, MEDIANTE UN ENFOQUE QUIRÃšRGICO-REGENERATIVO BASADO EN DETOXIFICACIÃ“N IMPLANTARIA Y REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA CON XENOINJERTO Y ALOINJERTO.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINA DE 62 AÃ‘OS ACUDIÃ“ A LA CLÃ□NICA DE PERIODONCIA CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR LA REHABILITACIÃ“N DE DOS IMPLANTES COLOCADOS CINCO MESES ANTES. A LA EXPLORACIÃ“N CLÃ□NICA, AMBOS IMPLANTES SE ENCONTRABAN AÃšN SUMERGIDOS Y ASINTOMÃ□TICOS. SIN EMBARGO, RADIOGRÃ□FICAMENTE SE OBSERVÃ“ PÃ‰RDIDA Ã“SEA VERTICAL SIGNIFICATIVA ALREDEDOR DEL IMPLANTE EN LA REGIÃ“N DE LA PIEZA #46, QUE SE EXTENDÃ□A MÃ□S ALLÃ□ DE LA MITAD DE SU LONGITUD.

ANTE ESTOS HALLAZGOS, SE PLANEÃ“ UN ABORDAJE QUIRÃšRGICO-REGENERATIVO ENFOCADO EN PRESERVAR LOS IMPLANTES, PRINCIPALMENTE EL #46. BAJO ANESTESIA TRONCULAR DEL NERVIO DENTARIO INFERIOR Y LINGUAL, SE REALIZÃ“ UNA INCISIÃ“N CRESTAL A ESPESOR TOTAL CON HOJA 15C. SE ELEVÃ“ UN COLGAJO MUCOPERIÃ“STICO CON PERIOSTÃ“TOMO TIPO BUSER, EXPONIÃ‰NDOSE TEJIDO DE GRANULACIÃ“N ALREDEDOR DEL IMPLANTE #46, EL CUAL FUE ELIMINADO MECÃ□NICAMENTE HASTA VISUALIZAR EL DEFECTO, QUE PRESENTABA APROXIMADAMENTE 6 MM DE PROFUNDIDAD Y CONFIGURACIÃ“N CONTENIDA, EL CUAL ERA UN DEFECTO IC.. EL IMPLANTE #45 MOSTRÃ“ UNA DEHISCENCIA VESTIBULAR DE APROXIMADAMENTE 4 MM.

SE REALIZÃ“ LA DETOXIFICACIÃ“N DE LOS IMPLANTES CON CLINDAMICINA 600 MG/4 ML DURANTE 2 MINUTOS, SEGUIDA DE IRRIGACIÃ“N CON 10 ML DE METRONIDAZOL AL 0.5% DURANTE 2 MINUTOS. EL DEFECTO FUE RELLENADO CON INJERTO Ã“SEO COMPUESTO POR 70% XENOINJERTO Y 30% ALOINJERTO PREVIAMENTE HIDRATADO, INCLUYENDO LA ZONA VESTIBULAR DEL #45. SE ADAPTÃ“ UNA MEMBRANA DE COLÃ□GENO (EVOLUTIONÂ®), FIJADA AL PERIOSTIO VESTIBULAR MEDIANTE UN PUNTO COLCHONERO HORIZONTAL DE VICRYL 4-0. PARA LOGRAR CIERRE SIN TENSIÃ“N, SE LIBERÃ“ EL COLGAJO CON INCISIÃ“N PARCIAL Y SE SUTURÃ“ CON PUNTOS COLCHONEROS HORIZONTALES Y PUNTOS SIMPLES (NYLON 4-0). FINALMENTE SE PRESCRIBIERON ANTIBIÃ“TICOS, ANALGÃ‰SICOS E INDICACIONES POSTOPERATORIAS, ASÃ□ COMO CITAS SUBSECUENTES PARA REVISIÃ“N.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS.

A LOS SEIS MESES DE SEGUIMIENTO, SE EVALUÃ“ EL SITIO QUIRÃšRGICO MEDIANTE EXPLORACIÃ“N CLÃ NICA Y RADIOGRÃ FICA. RADIOGRÃ FICAMENTE, SE OBSERVÃ“ PERSISTENCIA DEL INJERTO Ã“SEO COLOCADO, CON RESOLUCIÃ“N DEL DEFECTO VERTICAL PREVIAMENTE IDENTIFICADO EN LA ZONA DISTAL DEL IMPLANTE #46. NO HUBO SIGNOS DE INFLAMACIÃ“N NI PROGRESIÃ“N DE PÃ‰RDIDA Ã“SEA. DURANTE LA SEGUNDA FASE QUIRÃšRGICA, AL LEVANTAR EL COLGAJO SE EVIDENCIÃ“ LA CORRECCIÃ“N COMPLETA DEL DEFECTO Ã“SEO. EL HUESO REGENERADO MOSTRÃ“ ADECUADA INTEGRACIÃ“N, CONTINUIDAD CON LAS PAREDES Ã“SEAS NATIVAS Y SUFICIENTE VOLUMEN PARA PERMITIR LA COLOCACIÃ“N DE LOS TORNILLOS DE CICATRIZACIÃ“N SIN NECESIDAD DE PROCEDIMIENTOS ADICIONALES. LOS TEJIDOS BLANDOS SE PRESENTARON ESTABLES, SIN SIGNOS DE INFECCIÃ“N O INFLAMACIÃ“N. EL PACIENTE NO REPORTÃ“ DOLOR SIGNIFICATIVO NI COMPLICACIONES POSOPERATORIAS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO DE CICATRIZACIÃ“N. SE LOGRÃ“ UN ENTORNO CLÃ NICO FAVORABLE PARA CONTINUAR CON LA FASE PROTÃ‰SICA.

CONCLUSIONES.

ESTE CASO CLÃ NICO MUESTRA QUE, EN DEFECTOS Ã“SEOS PERIIMPLANTARIOS CONTENIDOS, UN ENFOQUE QUIRÃšRGICO-REGENERATIVO BIEN PLANIFICADO PUEDE PERMITIR LA CONSERVACIÃ“N DEL IMPLANTE AFECTADO Y LA RESTITUCIÃ“N DEL SOPORTE Ã“SEO PERDIDO. LA DESCONTAMINACIÃ“N DEL IMPLANTE CON SOLUCIÃ“N ANTIBIÃ“TICA (CLINDAMICINA Y METRONIDAZOL) PERMITIÃ“ EVITAR MÃ‰TODOS MECÃ NICOS MÃ S AGRESIVOS, MANTENIENDO UNA SUPERFICIE RECEPTIVA PARA LA REGENERACIÃ“N. LA COMBINACIÃ“N DE XENOINJERTO Y ALOINJERTO FAVORECIÃ“ LA ESTABILIDAD DEL COÃ GULO Y DEL VOLUMEN Ã“SEO, Y EL USO DE MEMBRANA DE COLÃ GENO REABSORBIBLE, ADECUADAMENTE FIJADA AL PERIOSTIO VESTIBULAR, CONTRIBUYÃ“ A UNA ADECUADA CONTENCIÃ“N DEL INJERTO.

LA CLASIFICACIÃ“N DEL DEFECTO SEGÃšN MONJE ET AL. FUE ÃšTIL PARA SELECCIONAR EL ABORDAJE TERAPÃ‰UTICO, YA QUE AL TRATARSE DE UN DEFECTO TIPO IC, EL PRONÃ“STICO REGENERATIVO ERA FAVORABLE.

EL RESULTADO CLÃ NICO Y RADIOGRÃ FICO CONFIRMÃ“ QUE ES POSIBLE LOGRAR LA REGENERACIÃ“N DE UN DEFECTO VERTICAL MODERADO, CON LA POSIBILIDAD DE REHABILITAR FUNCIONALMENTE AL PACIENTE SIN NECESIDAD DE EXPLANTAR.

Bibliografía *

1. RAMANAUSKAITE A, BECKER K, CAFFERATA EA, SCHWARZ F. CLINICAL EFFICACY OF GUIDED BONE REGENERATION IN PERI?IMPLANTITIS DEFECTS. A NETWORK META?ANALYSIS. PERIODONTOL 2000. 2023;93(1):236-53.

2. SCHWARZ F, DERKS J, MONJE A, WANG HL. PERI?IMPLANTITIS. J CLIN PERIODONTOL. 2018;45(S20):S246-66.

3. MONJE A, PONS R, INSUA A, NART J, WANG HL, SCHWARZ F. MORPHOLOGY AND SEVERITY OF PERI?IMPLANTITIS BONE DEFECTS. CLIN IMPLANT DENT RELAT RES. 2019;21(4):635-43.

4. DONOS N, CALCIOLARI E, GHUMAN M, BACCINI M, SOUSA V, NIBALI L. THE EFFICACY OF BONE RECONSTRUCTIVE THERAPIES IN THE MANAGEMENT OF PERI-IMPLANTITIS. A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS. J CLIN PERIODONTOL. 2023;50(SUPPL 26):285-316. DOI:10.1111/JCPE.13775.

Título del trabajo *

REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA CON MEMBRANA DE PTFE PARA FUTURA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES

Nombre del Autor (a/es)*

C.D. Christiam Herrera Ortiz.

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

L.O.E.P Elizabeth de la Luz Aguilar, , L.O.E.P Olga MarÃ-a Martinez Bernal, , , , , , .

Correo Electrónico *

1434224g@umich.mx

Institución *

UNIVERSIDAD QUETZALCÃ“ATL EN IRAPUATO.

Introducción y Objetivos *

LA RECONSTRUCCIÃ“N Ã“SEA EN IMPLANTOLOGÃ□A REPRESENTA UN RETO CLÃ□NICO, ESPECIALMENTE CUANDO SE TRATA DEL AUMENTO VERTICAL DE LA CRESTA ALVEOLAR, YA QUE PRESENTA RESULTADOS MENOS PREDECIBLES QUE EL AUMENTO HORIZONTAL DEBIDO A LAS MAYORES EXIGENCIAS TÃ‰CNICAS, QUE INCLUYEN UN MANEJO AVANZADO DE COLGAJOS Y UNA COBERTURA DE TEJIDOS BLANDOS QUE ASEGURE LA PROTECCIÃ“N DEL INJERTO. EL Ã‰XITO DEL PROCEDIMIENTO DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE EVITAR TENSIONES EN LA HERIDA QUIRÃšRGICA, LO QUE PERMITE PRESERVAR LA ESTABILIDAD DEL COÃ□GULO SANGUÃ□NEO SUPRACRESTAL Y FAVORECER UNA CICATRIZACIÃ“N Ã“PTIMA. LAS MEMBRANAS NO ABSORBIBLES REFORZADAS CON TITANIO HAN DEMOSTRADO SER UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LOGRAR UNA REGENERACIÃ“N Ã“SEA PREDECIBLE, AL MANTENER UN ESPACIO ADECUADO PARA EL COÃ□GULO Y EL MATERIAL DE INJERTO, EXCLUYENDO CÃ‰LULAS EPITELIALES Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO. NUMEROSOS ESTUDIOS RESPALDAN SU USO EN LA RECONSTRUCCIÃ“N VERTICAL, YA QUE PROPORCIONAN SOPORTE ESTRUCTURAL, FACILITAN LA REGENERACIÃ“N DE TEJIDOS DUROS Y OPTIMIZAN LA INTEGRACIÃ“N DEL INJERTO. LA CORRECTA SELECCIÃ“N DEL MATERIAL, ASÃ□ COMO LA TÃ‰CNICA QUIRÃšRGICA APLICADA, SON DETERMINANTES PARA ALCANZAR RESULTADOS FUNCIONALES Y ESTÃ‰TICOS SATISFACTORIOS.

PRESENTAR UN CASO CLÃ□NICO QUE PERMITA EVALUAR EL RESULTADO DE LA REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA MEDIANTE EL USO DE INJERTOS DE 70% HUESO MINERALIZADO Y 30% HUESO DESMINERALIZADO, COMPLEMENTADA CON XENOINJERTO, UNA MEMBRANA PTFE CON REFUERZO DE TITANIO CON EL FIN DE ASEGURAR EL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO Y ESTABILIDAD. ADEMÃ□S, SE BUSCA DETERMINAR SI LA MEJORA CLÃ□NICA Y RADIOGRÃ□FICA OBTENIDA ES SUFICIENTE PARA LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINA DE 57 AÃ‘OS DE EDAD, ASA I, ACUDIÃ“ AL POSGRADO DE PERIODONCIA DE LA UNIVERSIDAD QUETZALCÃ“ATL EN IRAPUATO, EL MOTIVO DE SU CONSULTA ERA LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES. A LA EXPLORACIÃ“N CLÃ NICA Y LA EVALUACIÃ“N DE LA TOMOGRAFÃ A (CBCT), SE OBSERVÃ“ UN DEFECTO Ã“SEO VERTICAL CLASE II DE SEIBERT, MOTIVO POR EL CUAL LA PACIENTE NO ERA CANDIDATA PARA LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES DEBIDO A UNA ALTURA Y ANCHURA INSUFICIENTE. SE TOMARON EN CUENTA CONSIDERACIONES COMO AUSENCIA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL, CANTIDAD DE TEJIDO BLANDO Y LA PRESENCIA DE PICOS Ã“SEOS QUE FAVORECEN LA REGENERACIÃ“N Ã“SEA. PROCEDIMIENTOS.

SE REALIZÃ“ TÃ‰CNICA DE ANESTESIA LOCAL INFILTRATIVA Y TRONCULAR EN EL CUADRANTE INFERIOR DERECHO, SEGUIDA DE UNA INCISIÃ“N SUPRACRESTAL CON HOJA DE BISTURÃ 15C DE LA ZONA DISTAL DEL DEFECTO HACIA DISTAL DEL SEGUNDO PREMOLAR, COMPLEMENTADA CON UNA PEQUEÃ‘A INCISIÃ“N LIBERATRIZ HACIA DISTAL. POSTERIORMENTE, SE EFECTUÃ“ UN COLGAJO DE ESPESOR TOTAL PARA EXPONER ADECUADAMENTE EL DEFECTO Ã“SEO Y PERMITIR EL ACCESO A LA ZONA QUIRÃšRGICA, POSTERIORMENTE SE REALIZÃ“ LA LIBERACIÃ“N DE LAS FIBRAS ELÃSTICA DEL COLGAJO TANTO POR LINGUAL COMO VESTIBULAR. UNA VEZ EXPUESTA EL ÃREA Y LIBERADO LOS COLGAJOS, SE REALIZARON DECORTICACIONES PARA FAVORECER LA ANGIOGÃ‰NESIS CON EL OBJETIVO DE ESTIMULAR LA ACTIVIDAD METABÃ“LICA LOCAL Y POTENCIAR EL PROCESO DE REGENERACIÃ“N Ã“SEA, SE FIJÃ“ EN LINGUAL LA MEMBRANA PTFE CON REFUERZO DE TITANIO MEDIANTE TORNILLOS AUTORROSCANTES DE 3MM, SE COLOCÃ“ EL INJERTO Ã“SEO QUE CONSISTIÃ“ EN UNA MEZCLA DE 70% HUESO MINERALIZADO Y 30% HUESO DESMINERALIZADO, COMPLEMENTADA CON XENOINJERTO PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD VOLUMÃ‰TRICA Y FAVORECER LA OSTEOGÃ‰NESIS. LA MEMBRANA SE ESTABILIZÃ“ EN VESTIBULAR MEDIANTE 2 TORNILLOS AUTORROSCANTES DE 3 MM, ASEGURANDO SU CORRECTA ADAPTACIÃ“N Y LA PROTECCIÃ“N DEL INJERTO. EL CIERRE PRIMARIO SE LOGRÃ“ SIN TENSIÃ“N CON SUTURA NAILON 4/0 EN COLCHONERO HORIZONTAL Y PUNTOS SIMPLES PARA ASEGURAR EL CIERRE PRIMARIO.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADO Y CONCLUSIONES.

EL MANEJO DE DEFECTOS Ã“SEOS VERTICALES, COMO EL OBSERVADO EN ESTA PACIENTE CON UN DEFECTO CLASE II DE SEIBERT, REQUIERE UNA PLANIFICACIÃ“N CUIDADOSA Y TÃ‰CNICAS AVANZADAS DE REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA. LA COMBINACIÃ“N DE UN COLGAJO DE ESPESOR TOTAL, LIBERACIÃ“N ADECUADA DE LOS TEJIDOS BLANDOS, EL USO DE MEMBRANAS DE PTFE REFORZADAS Y LA MEZCLA DE INJERTOS AUTÃ“LOGOS, DESMINERALIZADOS Y XENOINJERTOS PERMITIÃ“ MANTENER EL ESPACIO NECESARIO PARA LA REGENERACIÃ“N Y PROTEGER EL INJERTO DE LA INVASIÃ“N DE TEJIDOS BLANDOS. LAS CORTICOTOMÃ□AS ESTRATÃ‰GICAS APLICADAS SIGUIENDO EL PRINCIPIO DEL FACTOR REGIONAL ACELERADOR FAVORECIERON LA ACTIVIDAD METABÃ“LICA LOCAL Y POTENCIARON LA OSTEOGÃ‰NESIS. LA CORRECTA ESTABILIZACIÃ“N DE LA MEMBRANA CON TORNILLOS AUTORROSCANTES Y UN CIERRE PRIMARIO SIN TENSIÃ“N GARANTIZÃ“ UN ENTORNO Ã“PTIMO PARA LA CICATRIZACIÃ“N Y LA INTEGRACIÃ“N DEL INJERTO. ESTE CASO CLÃ□NICO EVIDENCIA QUE LA COMBINACIÃ“N DE TÃ‰CNICAS QUIRÃšRGICAS PRECISAS Y MATERIALES ADECUADOS PUEDE LOGRAR UNA REGENERACIÃ“N Ã“SEA VERTICAL PREDECIBLE, CREANDO UN LECHO ESTABLE Y FUNCIONAL PARA LA POSTERIOR COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES DENTALES, MEJORANDO TANTO LA FUNCIÃ“N COMO LA ESTÃ‰TICA DEL PACIENTE.

Bibliografía *

1.-REN, Y., , FAN, L., ALKILDANI, S., LIU, L., EMMERT, S., NAJMAN, S., RIMASHEVSKIY, D., SCHNETTLER, R., JUNG, O., XIONG, X., & OTROS. (2022). BARRIER MEMBRANES FOR GUIDED BONE REGENERATION (BR): A FOCUS ON RECENT ADVANCES IN COLLAGEN MEMBRANES. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 23, 14987. HTTPS://DOI.ORG/10.3390/IMS232314987.

2.-URBAN IA, MONTERO E, AMERIO E, PALOMBO D, MONJE A. TECHNIQUES ON VERTICAL RIDGE AUGMENTATION: INDICATIONS AND EFFECTIVENESS. PERIODONTOL 2000. 2023 OCT;93(1):153-182. DOI: 10.1111/PRD. 12471. EPUB 2023 JAN 31. PMID: 36721380.

3.SÃ□NCHEZ-SÃ□NCHEZ J, PICKERT FN, SÃ□NCHEZ-LABRADOR L, GF TRESGUERRES F, MARTINEZ-GONZÃ□LEZ JM, MENIZ-GARCIA C. HORIZONTAL RIDGE AUGMENTATION: A COMPARISON BETWEEN KHOURY AND URBAN TECHNIQUE. BIOLOGY (BASEL). 2021 AUG 5; 10(8):749. DO: 10.3390/ BIOLOGY 10080749. PMID: 34439981; PMCID: PMC8389589.

Título del trabajo *

MODIFICACIONES EN EL MANEJO PERIODONTAL DE FASE I EN PACIENTE CON TRASPLANTE RENAL BAJO INMUNOSUPRESIÃ“N PROLOGADA Y ANTECEDENTE DE TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR: REPORTE DE CASO CLÃ□NICO

Nombre del Autor (a/es)*

NuÃ±ez Delgadillo Jessika Daniela

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Cepeda Bravo Juan Antonio, , , , , , , , .

Correo Electrónico *

jessinunezs@outlook.com

Institución *

UNIVERSIDAD AUTÃ“NOMA DE SAN LUIS POTOSÃ□

Introducción y Objetivos *

LOS PACIENTES CON TRASPLANTE RENAL REQUIEREN TERAPIA INMUNOSUPRESORA A LARGO PLAZO PARA PREVENIR EL RECHAZO DEL Ã“RGANO TRASPLANTADO, LAS CUALES AUMENTAN LA SUSCEPTIBILIDAD A INFECCIONES, ALTERAN LA RESPUESTA INFLAMATORIA Y RETRASAN LA CICATRIZACIÃ“N.

LA TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR SE PRESENTA EN CERCA DEL 20% DE LOS CASOS, AUNQUE SUELE SER MÃS FRECUENTE EN PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS. EL SÃNTOMA MÃS COMÃšN ES LA TENOSINOVITIS TUBERCULOSA, QUE AFECTA PRINCIPALMENTE LOS COMPARTIMIENTOS FLEXORES DE LA MANO Y QUE GENERA SECUELAS FUNCIONALES A PESAR DE HABER RECIBIDO UN TRATAMIENTO ADECUADO

EL ABORDAJE CLÃNICO EN PACIENTES TRASPLANTADOS BAJO INMUNOSUPRESIÃ“N REQUIERE LA IMPLEMENTACIÃ“N DE ADECUACIONES EN EL TRATAMIENTO, LA ASOCIACIÃ“N ESTADOUNIDENSE DEL CORAZÃ“N (AHA) RECOMIENDA LA PROFILAXIS ANTIBIÃ“TICA EN PACIENTES CON CONDICIONES NO CARDÃACAS QUE CONLLEVAN ALTO RIESGO DE ENDOCARDITIS CUANDO SE REALICEN PROCEDIMIENTOS ODONTOLÃ“GICOS DE ALTO RIESGO, ENTRE ELLOS EL TRATAMIENTO MEDIANTE RASPADO Y ALISADO RADICULAR JUSTIFICA LA INDICACIÃ“N PROFILÃCTICA EN ESTE TIPO DE CASOS.

LA DESINFECCIÃ“N ORAL COMPLETA ES UNA TÃ‰CNICA DE RASPADO Y ALISADO RADICULAR LLEVADA A CABO EN 24 HORAS QUE CONSISTE EN EL USO DE UN ANTISÃ‰PTICO A TRAVÃ‰S DE ENJUAGUES POR UN PERIODO INDICADO, LA FINALIDAD DE ESTE TRATAMIENTO ES REDUCIR LOS NICHOS DE INFECCIÃ“N Y PREVENIR LA REINFECCIÃ“N CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LOS RESULTADOS CLÃNICOS

EL OBJETIVO DEL PRESENTE CASO ES DESCRIBIR LAS MODIFICACIONES REALIZADAS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL TRATAMIENTO PERIODONTAL DE FASE I EN UN PACIENTE CON CARACTERÃSTICAS ESPECIALES: ANTECEDENTE DE TRASPLANTE RENAL, TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR PROLONGADO Y ANTECEDENTE DE TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR.

Descripción del Caso *

PACIENTE MASCULINO DE 50 AÃ‘OS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE HIPOPLASIA RENAL, INICIALMENTE A LA EDAD DE 25 AÃ‘OS SE LE REALIZÃ“ PRIMER TRASPLANTE RENAL, POSTERIORMENTE EN 2018 SE DIAGNOSTICA CON TUBERCULOSIS PULMONAR QUE SE DISEMINA A LA REGIÃ“N DE LOS TENDONES DE LA MANO Y DEDOS, SUCESIVAMENTE EN 2021 INICIA CON TRATAMIENTO DE HEMODIÃ□LISIS, EN COMBINACIÃ“N CON CICLOSPORINA EL CUAL SUSPENDE DEBIDO A UNA HIPERPLASIA GINGIVAL ASOCIADA A MEDICAMENTO SIN TRATAMIENTO QUE RESULTO EN MÃšLTIPLES PERDIDAS DENTARIAS, A CONTINUACIÃ“N EN 2022 SE LE REALIZA UN SEGUNDO TRASPLANTE RENAL Y SE LE INDICA TRATAMIENTO CON TRACOLIMUS Y PREDNISONA. LA TERAPIA FARMACOLÃ“GICA ACTUALMENTE ES AMLODIPINO, PREDNISONA, TRACOLIMUS, MICOFENOLATO, TAMSOLUSINA Y CLONAZEPAM. ACUDE A CONSULTA REFERIDO DEL Ã□REA DE REHABILITACIÃ“N ORAL POR PRESENTAR PÃ‰RDIDA DE INSERCIÃ“N MAYOR A 5MM, PÃ‰RDIDA Ã“SEA RADIOGRÃ□FICA QUE SE EXTIENDE MÃ□S ALLÃ□ DEL TERCIO APICAL Y MÃšLTIPLES PÃ‰RDIDAS DENTARIAS ASOCIADAS A ENFERMEDAD PERIODONTAL, CON UN DIAGNÃ“STICO DE PERIODONTITIS ESTADIO IV GRADO C.

EN BASE A LAS GUÃ□AS DE PROFILAXIS ANTIBIÃ“TICA DE LA AHA, SE DETERMINA INDICAR PROFILAXIS ANTIBIÃ“TICA CON 2G DE AMOXICILINA VÃ□A ORAL DE 30 A 60 MINUTOS ANTES DEL PROCEDIMIENTO DENTAL. SE DECIDE REALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE FULL MOUTH DESINFECTION (FMD), EL CUAL SE REALIZA MEDIANTE UN CEPILLADO LINGUAL CON CLORHEXIDINA (CHX) AL 0.2%, ENJUAGUE BUCAL CON CHX AL 0.2% DURANTE 1 A 2 MINUTOS, IRRIGACIÃ“N SUBGINGIVAL EN LAS BOLSAS PERIODONTALES Y ROCIADO DE CHX EN FARINGE Y AMÃ□GDALAS. POSTERIOR A ELLO SE INDICÃ“ CONTINUAR CON CLORHEXIDINA AL 0.2% POR 7 DÃ□AS CADA 12 HORAS CON ENJUAGUES POR 60 SEGUNDOS Y TRATAMIENTO ANTIBIÃ“TICO CON AMOXICILINA MÃ□S Ã□CIDO CLAVULÃ□NICO 875/125MG CONTINUADO POR 7 DÃ□AS, SE INDICA UNA REVALORACIÃ“N A LOS 8 SEMANAS. PREVIO AL TRATAMIENTO DE FMD SE REALIZA UNA INTERCONSULTA CON EL DEPARTAMENTO DE ENDODONCIA Y SE REALIZAN LOS TRATAMIENTOS PERTINENTES, ADEMÃ□S, SE PROCEDE A LA EXTRACCIÃ“N DE LOS Ã“RGANOS DENTARIOS SIN ESPERANZA.

Resultados y Conclusiones *

LOS RESULTADOS OBTENIDOS A LAS 8 SEMANAS DE REVALORACIÃ“N MUESTRAN UNA REDUCCIÃ“N EN LA PROFUNDIDAD DE LAS BOLSAS PERIODONTALES, ASÃ COMO UN CONTROL DE LA PLACA DENTOBACTERIANA Y CONTROL DE LOS SIGNOS CLÃNICOS DE LA INFLAMACIÃ“N, CON ELLO SE LOGRA ESTABILIZAR EL ESTADO BUCAL DENTRO DE LOS PARÃMETROS DE SALUD PERIODONTAL. LA EDUCACIÃ“N Y MOTIVACIÃ“N DE LA HIGIENE ORAL DEL PACIENTE REPRESENTAN UN COMPONENTE ESENCIAL PARA LA ESTABILIDAD DE LOS RESULTADOS, CONSIDERANDO QUE EL MEDIO BUCAL EN ESTOS INDIVIDUOS PERMANECE PREDISPUESTO A LA RECIDIVA DE LA ENFERMEDAD Y AL DESARROLLO DE PROCESOS INFECCIOSOS.

LA ELECCIÃ“N DE MODIFICAR EL TRATAMIENTO PERIODONTAL DE FASE I, PASANDO DE UN RASPADO Y ALISADO RADICULAR CONVENCIONAL A UNA TÃ‰CNICA DE DESINFECCIÃ“N ORAL COMPLETA DEBE INDIVIDUALIZARSE EN FUNCIÃ“N DE LAS CARACTERÃSTICAS CLÃNICAS Y VIABILIDAD DEL TRATAMIENTO. EN EL PRESENTE CASO, DEBIDO A LAS CARACTERÃSTICAS ESPECIALES DEL PACIENTE, SE OPTÃ“ POR REALIZAR LA TÃ‰CNICA FMD EN UN LAPSO DE 24 HORAS, CONSIDERANDO LA NECESIDAD DE ADMINISTRAR PROFILAXIS ANTIBIÃ“TICA Y CONTINUAR CON TRATAMIENTO ANTIBIÃ“TICO SISTÃ‰MICO, ASÃ COMO REDUCIR EL NÃšMERO DE CITAS Y FAVORECER A LA COMODIDAD DEL PACIENTE. LA INDICACIÃ“N DE PROFILAXIS ANTIBIÃ“TICA DEBE VALORARSE SEGÃšN FACTORES COMO ANTECEDENTES DE TRASPLANTE, USO DE ALTAS DOSIS DE ESTEROIDES, INMUNOSUPRESIÃ“N, RADIOTERAPIA EN CABEZA Y CUELLO, ENFERMEDADES DE LA MÃ‰DULA Ã“SEA, ENTRE OTROS, ASÃ COMO EL RIESGO POTENCIAL DE DESARROLLAR INFECCIONES FOCALES O SISTÃ‰MICAS ASOCIADAS AL TRATAMIENTO ODONTOLÃ“GICO A REALIZAR.

Bibliografía *

1. GUGGENHEIMER J, EGHTESAD B, STOCK DJ. DENTAL MANAGEMENT OF THE (SOLID) ORGAN TRANSPLANT PATIENT. ORAL SURGERY, ORAL MEDICINE, ORAL PATHOLOGY, ORAL RADIOLOGY, AND ENDODONTICS [INTERNET]. 2003 [CITED 2025 AUG 14];95(4):383â€“9. AVAILABLE FROM: HTTPS://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PUBMED/12686921

2. ASTUDILLO-CRESPO MI, ALVEAR-CÃ“RDOVA MC. PROTOCOLO DE PROFILAXIS ANTIBIÃ“TICA PARA PACIENTES DENTALES EN RIESGO DE INFECCIÃ“N. ODONTOLOGÃA SANMARQUINA. 2022 JAN 21;25(1):E22079.

3. PIA?MERETE JERVÃ˜E?STORM, EBERHARD J, NEEDLEMAN I, WORTHINGTON HV, JEPSEN S. FULL-MOUTH TREATMENT MODALITIES (WITHIN 24 HOURS) FOR PERIODONTITIS IN ADULTS. THE COCHRANE LIBRARY. 2022 JUN 28;2022(6).

4. AL-QATTAN MM, AL-NAMLA A, AL-THUNAYAN A, AL-OMAWI M. TUBERCULOSIS OF THE HAND. THE JOURNAL OF HAND SURGERY. 2011 AUG;36(8):1413â€“21.

Título del trabajo *

"MODIFICACIÃ“N DEL FENOTIPO PERIODONTAL COMO ENFOQUE PREVIO AL TRATAMIENTO ORTODÃ“NTICO: REPORTE DE UN CASO CLÃ NICO"

Nombre del Autor (a/es)*

Vizcaino Andrade Abril Iveth

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

GarcÃ-a ArÃ©valo Fernando, , Fontes GarcÃ-a Zureya, , GÃ³mez Flores Mara, , , , .

Correo Electrónico *

abril.vizcaino@uabc.edu.mx

Institución *

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS MEX

Introducción y Objetivos *

LA CLASIFICACIÃ“N DEL FENOTIPO PERIODONTAL SE BASA PRINCIPALMENTE EN CARACTERÃ STICAS ANATÃ“MICAS COMO EL GROSOR Y ANCHO DEL TEJIDO GINGIVAL, LA MORFOLOGÃ A Ã“SEA Y EL TAMAÃ‘O DENTAL. CORTELLINI, PROPUSO TRES TIPOS DE FENOTIPO: FESTONEADO DELGADO, PLANO Y GRUESO, Y FESTONEADO GRUESO. EN EL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA, EXISTE LA POSIBILIDAD DE INICIO O PROGRESIÃ“N DE RECESIÃ“N GINGIVAL, DURANTE O DESPUÃ‰S DE LOS MOVIMIENTOS ORTODÃ“NTICOS. OTROS FACTORES QUE LO MODIFICAN SON LA POSICIÃ“N DENTAL, CEPILLADO DENTAL, INFLAMACIÃ“N GINGIVAL PERSISTENTE, LA POSICIÃ“N DEL FRENILLO O RESTAURACIONES PROTÃ‰SICAS MAL AJUSTADAS; EN LA CLASIFICACIÃ“N DE CONDICIONES Y ENFERMEDADES PERIODONTALES Y PERIIMPLANTARIAS SE POSICIONA EN DEFICIENCIA DE TEJIDOS DUROS Y BLANDOS. DIVERSOS ESTUDIOS RESPALDAN QUE UN FENOTIPO PERIODONTAL MÃ S GRUESO FAVORECE UNA RESPUESTA MÃ S ESTABLE FRENTE A CAMBIOS INDUCIDOS POR LA ORTODONCIA, OPTIMIZA EL PRONÃ“STICO A LARGO PLAZO Y MEJORA LA ESTÃ‰TICA DEL PACIENTE.

Descripción del Caso *

PRESENTACIÃ“N DEL CASO Y DIAGNÃ“STICO: PACIENTE FEMENINO DE 60 AÃ‘OS DE EDAD ACUDE ACUDE A CLÃ NICA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÃ“GICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÃ“NOMA DE BAJA CALIFORNIA, CAMPUS MEXICALI, CON DIAGNÃ“STICO DE SALUD PERIODONTAL Y SALUD GINGIVAL EN UN PERIODONTO REDUCIDO, PACIENTE PERIODONTAL ESTABLE, DEFORMIDADES Y CONDICIONES MUCOGINGIVALES (RECESIÃ“N GINGIVAL), TRAUMA OCLUSAL SECUNDARIO.

PROCEDIMIENTO: SE REALIZÃ“ MODIFICACIÃ“N DE FENOTIPO PARA POSTERIOR TRATAMIENTO ORTODÃ“NTICO, MEDIANTE TÃ‰CNICA VISTA EN CONJUNTO CON MATRIZ DÃ‰RMICA ACELULAR.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS: SE REALIZÃ“ VALORACIÃ“N 5 MESES POSTQUIRÃšRGICO OBTENIENDO GROSOR DE TEJIDO QUERATINIZADO.

CONCLUSIONES: LA MODIFICACIÃ“N DE FENOTIPO PERIODONTAL ABARCA MUCHOS ENFOQUES; DONDE LA ORTODONCIA, ES UNO DE LOS PRINCIPALES; CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA ESTABILIDAD DE LOS RESULTADOS, OPTIMIZAR LA SALUD PERIODONTAL Y REDUCIR EL RIESGO DE RECESIONES GINGIVALES MEDIANTE TÃ‰CNICAS COMO EL USO DE MATRIZ ACELULAR DÃ‰RMICA, EVITANDO ASÃ, UN SEGUNDO LECHO QUIRÃšRGICO.SE LOGRÃ“ UN AUMENTO DEL ESPESOR GINGIVAL, MODIFICANDO EL FENOTIPO DELGADO A UN FENOTIPO GRUESO.

Bibliografía *

CORTELLINI P, BISSADA NF, MOUNSSIF I, BARBATO L, CAIRO F, CARVALHO LH, ET AL. IS PERIODONTAL PHENOTYPE MODIFICATION THERAPY BENEFICIAL FOR PATIENTS RECEIVING ORTHODONTIC TREATMENT? AN AMERICAN ACADEMY OF PERIODONTOLOGY BEST EVIDENCE REVIEW. J PERIODONTOL. 2020;91(3):299-310.

NAVARRO NAVARRO C, ZERÃ“N A. COMPARACIÃ“N ENTRE LA MATRIZ DÃ‰RMICA ACELULAR Y EL TEJIDO CONECTIVO COMO MATERIALES DE INJERTO PARA EL RECUBRIMIENTO DE RECESIONES GINGIVALES: REVISIÃ“N SISTEMÃTICA DE LA LITERATURA. REV ODONTOL MEX. 2016;20(3):168-176.

FERNÃNDEZ-JIMÃ‰NEZ A, ESTEFANÃA-FRESCO R, GARCÃA-DE-LA-FUENTE AM, MARICHALAR-MENDIA X, AGUIRRE-ZORZANO LA. DESCRIPTION OF THE MODIFIED VESTIBULAR INCISION SUBPERIOSTEAL TUNNEL ACCESS (M-VISTA) TECHNIQUE IN THE TREATMENT OF MULTIPLE MILLER CLASS III GINGIVAL RECESSIONS: A CASE SERIES. BMC ORAL HEALTH. 2021;21:142.

CHANGI KK, GREENSTEIN G, TARNOW D, ROYZMAN D, KANG P. CREEPING CLINICAL ATTACHMENT AFTER ACELLULAR DERMAL MATRIX AUGMENTATION TO ATTAIN ROOT COVERAGE. CLIN ADV PERIODONTICS. 2020;10(2):75â€“80.

Título del trabajo *

AUMENTO DE TEJIDOS BLANDOS PERIIMPLANTARIOS EN ARCADA MAXILAR POSTERIOR: MANEJO DE CASO.

Nombre del Autor (a/es)*

MONICA DE JESUS SANCHEZ APODACA

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

GarcÃ-a ArÃ©valo Fernando, Fontes GarcÃ-a Zureya, GÃ³mez Flores Mara, , , , , , .

Correo Electrónico *

monica.sanchez.apodaca@uabc.edu.mx

Institución *

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS MEX

Introducción y Objetivos *

ANTECEDENTES Y OBJETIVO:

LA ESTABILIDAD DE LOS TEJIDOS BLANDOS PERIIMPLANTARIOS CONDICIONA LA PREDICTIBILIDAD BIOLÃ“GICA Y LA ESTÃ‰TICA, ESPECIALMENTE CUANDO SE REHABILITA EL SECTOR ANTERIOR JUNTO CON ZONAS POSTERIORES. EL INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO PARA ENGROSAMIENTO VESTIBULAR Y LA PROVISIONALIZACIÃ“N INMEDIATA PARA MOLDEAR EL PERFIL CRÃ□TICO/SUBCRÃ□TICO SON ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS. OBJETIVO: DESCRIBIR UN CASO CON IMPLANTES EN ZONA DE 1.1, 1.5, 2.5 Y 2.6, INTEGRANDO ITC (INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO), AUMENTO DE TEJIDO QUERATINIZADO (ROLL TECHNIQUE) Y PROVISIONALIZACIÃ“N INMEDIATA PARA OPTIMIZAR VOLUMEN TISULAR, PERFIL DE EMERGENCIA Y FUNCIÃ“N.

Descripción del Caso *

PRESENTACIÃ“N DEL CASO Y DIAGNÃ“STICO:

PACIENTE FEMENINA, SISTÃ‰MICAMENTE SANA, NO FUMADORA, CON AUSENCIAS DE PIEZAS 1.5, 2.5 Y 2.6 Y PIEZA 1.1 CON PRONÃ“STICO RESTAURADOR DESFAVORABLE. PRESENTA LÃ□NEA DE SONRISA MEDIA, PAPILAS PRESENTES Y TEJIDO QUERATINIZADO REDUCIDO EN 1.5, 2.5 Y 2.6. SE PLANIFICÃ“ TRATAMIENTO POR ETAPAS: FASE 1, COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES EN 1.5, 2.5 Y 2.6, REALIZANDO SIMULTÃ□NEAMENTE LA ROLL TECHNIQUE EN 2.5â€“2.6; FASE 2, A UN MES, EXTRACCIÃ“N ATRAUMÃ□TICA Y COLOCACIÃ“N DE IMPLANTE INMEDIATO EN 1.1 Y PROVISIONAL ATORNILLADO PARA MANEJO DEL PERFIL.

PROCEDIMIENTOS:

FASE 1 (POSTERIORES): FRESADO Y COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES EN 1.5, 2.5 Y 2.6 CON ESTABILIDAD PRIMARIA. EN 2.5â€“2.6 SE REALIZÃ“ ROLL TECHNIQUE (COLGAJO DE ESPESOR PARCIAL, DESEPITELIZACIÃ“N Y ROTACIÃ“N DEL TEJIDO A UN HACIA VESTIBULAR) PARA INCREMENTAR EL GROSOR DE LA BANDA QUERATINIZADA. CIERRE SIN TENSIÃ“N E INDICACIONES DE HIGIENE.

FASE 2 (ANTERIOR): EXTRACCIÃ“N ATRAUMÃ□TICA DE 1.1 PRESERVANDO LA TABLA VESTIBULAR; PREPARACIÃ“N DEL LECHO CON ORIENTACIÃ“N PALATINIZADA Y COLOCACIÃ“N DEL IMPLANTE INMEDIATO. SE COLOCÃ“ PROVISIONAL ATORNILLADO INMEDIATO, PULIDO. SE PROGRAMARON AJUSTES SERIADOS DEL PROVISIONAL (MICRO ADICIONES Y PULIDO) PARA ESCULPIR EL PERFIL CRÃ□TICO/SUBCRÃ□TICO Y FAVORECER SOPORTE PAPILAR. CONTROL DE DOLOR, ENJUAGUE ANTISÃ‰PTICO POR TIEMPO LIMITADO, CEPILLO ULTRASUAVE Y TERAPIA PREVENTIVA.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS:

LA CICATRIZACIÃ“N TRANSCURRIÃ“ SIN EVENTOS ADVERSOS. EN 2.5â€“2.6 SE OBSERVÃ“ ENGROSAMIENTO VESTIBULAR CLÃ□NICAMENTE EVIDENTE DE 2MM Y BANDA CONTINUA DE MUCOSA QUERATINIZADA, MEJORANDO CONFORT Y ACCESO A HIGIENE. EN 1.1, SE OBTUVO UN PERFIL DE EMERGENCIA ESTABLE CON PRESERVACIÃ“N DE PAPILAS Y ARMONÃ□A DEL MARGEN RESPECTO A LOS DIENTES ADYACENTES. RADIOGRÃ□FICAMENTE, LOS NIVELES Ã“SEOS CRESTALES SE MANTUVIERON ESTABLES EN LOS CONTROLES SERIADOS. LA PACIENTE REPORTÃ“ BUENA FUNCIÃ“N Y SATISFACCIÃ“N ESTÃ‰TICA.

CONCLUSIONES:

LA COMBINACIÃ“N PLANIFICADA DE ITC, ROLL TECHNIQUE EN SECTORES POSTERIORES Y PROVISIONALIZACIÃ“N INMEDIATA PERMITIÃ“ ALCANZAR ESTABILIDAD PERIIMPLANTARIA, CONTORNOS BLANDOS PREDECIBLES Y RESULTADOS ESTÃ‰TICO-FUNCIONALES FAVORABLES EN UN TIEMPO CLÃ□NICAMENTE EFICIENTE. LA SECUENCIA POR ETAPAS Y EL MANEJO ACTIVO DEL PERFIL CRÃ□TICO/SUBCRÃ□TICO FUERON CLAVES PARA PRESERVAR LA ARQUITECTURA GINGIVAL Y PREPARAR CON FIABILIDAD LA TRANSFERENCIA A LA RESTAURACIÃ“N DEFINITIVA.

Bibliografía *

1. GAMBORENA, I., SASAKI, Y., & BLATZ, M. B. (2021). PREDICTABLE IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT AND RESTORATION IN THE ESTHETIC ZONE. JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY : OFFICIAL PUBLICATION OF THE AMERICAN ACADEMY OF ESTHETIC DENTISTRY ... [ET AL.], 33(1), 158â€“172.

2. AMMAR AH, AHMED E, ELBARBARY A, GHALWASH D, EZZ ELARAB A. CLINICAL COMPARISON OF THE VOLUMETRIC CHANGES IN SINGLE PONTIC SITE DEVELOPMENT THROUGH CONNECTIVE TISSUE GRAFTING USING MODIFIED POUCH TECHNIQUE VERSUS POUCH TECHNIQUE IN THE MAXILLARY ESTHETIC ZONE: A RANDOMIZED CONTROLLED CLINICAL TRIAL. INT J DENT. 2022 AUG 25;2022:1677471. DOI: 10.1155/2022/1677471. PMID: 36059913; PMCID: PMC9436583.

3. SHAKIBAIE, B., SABRI, H., BLATZ, M. B., & BAROOTCHI, S. (2023). COMPARISON OF THE MINIMALLY-INVASIVE ROLL-IN ENVELOPE FLAP TECHNIQUE TO THE HOLDING SUTURE TECHNIQUE IN IMPLANT SURGERY: A PROSPECTIVE CASE SERIES. JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY : OFFICIAL PUBLICATION OF THE AMERICAN ACADEMY OF ESTHETIC DENTISTRY ... [ET AL.], 35(4), 625â€“631.

4. PATEL, P. B. (2023). BUCCAL ROLL TECHNIQUE FOR AUGMENTATION OF KERATINIZED TISSUE (1 CEU).

Título del trabajo *

"REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA HORIZONTAL EN EL SECTOR ANTEROSUPERIOR COMO PREPARACIÃ“N PARA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES: REPORTE DE UN CASO"

Nombre del Autor (a/es)*

Nayeli Sarahi Longoria LÃ³pez

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Paul IvÃ¡n ObregÃ³n Godina, Antonio Cepeda Bravo, , , , , , , .

Correo Electrónico *

nayeli.longoria07@hotmail.com

Institución *

UASLP

Introducción y Objetivos *

INTRODUCCION:

LA REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA (ROG) ES UNA TÃ‰CNICA AMPLIAMENTE INVESTIGADA Y APLICADA EN LA ODONTOLOGÃ□A, CUYO OBJETIVO PRINCIPAL ES PROMOVER LA FORMACIÃ“N DE NUEVO TEJIDO Ã“SEO EN DEFECTOS CRÃ□TICOS Y EN Ã□REAS DE ATROFIA ALVEOLAR, FACILITANDO ASÃ□ LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES DENTALES Y LA RESTAURACIÃ“N DE LA ESTRUCTURA Ã“SEA PERDIDA. NUMEROSOS ESTUDIOS CLÃ□NICOS Y EXPERIMENTALES HAN DEMOSTRADO QUE LA ROG PUEDE PROMOVER EFICAZMENTE EL CRECIMIENTO Ã“SEO TANTO EN DIRECCIÃ“N VERTICAL COMO HORIZONTAL, ALCANZANDO TASAS DE Ã‰XITO QUE VARÃ□AN ENTRE APROXIMADAMENTE 71% Y 100%. LA REGENERACIÃ“N EN DEFECTOS CRÃ□TICOS Y EN Ã□REAS DE ATROFIA ALVEOLAR HA SIDO CONFIRMADA MEDIANTE EVALUACIONES HISTOLÃ“GICAS Y CLÃ□NICAS, MOSTRANDO NEO-OSTEOGÃ‰NESIS QUE PUEDE INCLUSO SOBREPASAR LOS LÃ□MITES ORIGINALES DEL ESQUELETO, LOGRANDO UNA REGENERACIÃ“N MÃ□S ALLÃ□ DE LOS BORDES ANATÃ“MICOS. EL USO COMBINADO DE MEMBRANAS Y MATERIALES DE INJERTO HA DEMOSTRADO MEJORAR LA PRESERVACIÃ“N Y EL AUMENTO DEL REBORDE ALVEOLAR, FACILITANDO LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES CON ALTAS TASAS DE Ã‰XITO, QUE RONDAN EL 95%. PERMITIENDO MANTENER LAS DIMENSIONES Ã“SEAS NECESARIAS PARA FUTURAS REHABILITACIONES.

OBJETIVOS:

PROMOVER LA FORMACIÃ“N DE NUEVO TEJIDO Ã“SEO EN DEFECTO Y ATROFIA ALVEOLAR; EXCLUIR TEJIDOS BLANDOS NO OSTEOGÃ‰NICOS DEL SITIO EN REGENERACIÃ“N, CREANDO UN AMBIENTE FAVORABLE PARA LA PROLIFERACIÃ“N Y DIFERENCIACIÃ“N DE CÃ‰LULAS OSTEOGÃ‰NICAS CON EL FIN DE OBTENER UNA REGENERACIÃ“N Ã“SEA PREDECIBLE Y ESTABLE A LARGO PLAZO, FACILITANDO ASÃ□ LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES DENTALES Y LA RESTAURACIÃ“N DE LA ESTRUCTURA Ã“SEA PERDIDA, MEDIANTE LA COLOCACIÃ“N DE MEMBRANAS BARRERA E INJERTO Ã“SEO.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINO DE 36 AÃ‘OS CON APP NEGADOS, ACUDE A LA CLÃ□NICA DE LA ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA DE LA UASLP, CUYO MOTIVO DE CONSULTA FUE â€œME ENVIARON DE LA ESPECIALIDAD DE PRÃ“TESIS PARA VALORACIÃ“N PERIODONTALâ€□. SE ESTABLECIÃ“ DIAGNÃ“STICO, PERIODONTITIS ESTADIO LL GRADO B GENERALIZADO. SE REALIZÃ“ FASE INICIAL PERIODONTAL, CON REVALORACIÃ“N A 4 SEMANAS. SE REALIZÃ“ APICECTOMÃ□A EN OD. #12 CON RELLENO OSEÃ“ ALOPLASTICO. POSTERIORMENTE, SE LLEVÃ“ A CABO LA ROG EN LA ZONA DE OD # 21 Y #22 CON ALOINJERTO Y XENOINJERTO (50:50), MEMBRANA DE COLÃ□GENA Y FIJADA CON TACHUELAS DE TITANIO.

SE CONTORNEARON LOS TEJIDOS BLANDOS MEDIANTE PÃ“NTICOS OVOIDES 4 SEMANAS POSTERIORES A LA CIRUGÃ□A.

Resultados y Conclusiones *

RESULTADOS:

SE LOGRÃ“ UN CIERRE PRIMARIO DE TEJIDOS BLANDOS, ESTABILIDAD PERIODONTAL, UN AUMENTO Ã“SEO TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL DE 3.5 MILÃ METROS A 6 MESES DEL PROCEDIMIENTO Y SE CONTINUA CON LA CONFORMACIÃ“N DE LOS PERFILES DE EMERGENCIA.

CONCLUSIÃ“N:

LA REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA ES UNA ESTRATEGIA EFECTIVA Y CONFIABLE PARA LA REGENERACIÃ“N Ã“SEA EN DEFECTOS CRÃ TICOS Y EN Ã REAS DE ATROFIA ALVEOLAR, FACILITANDO LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES Y LA RESTAURACIÃ“N FUNCIONAL Y ESTÃ‰TICA. LA UTILIZACIÃ“N DE MATERIALES DE MEMBRANA, JUNTO CON INJERTOS, HA DEMOSTRADO MEJORAR LA ESTABILIDAD DEL VOLUMEN Ã“SEO Y LA CALIDAD DEL HUESO REGENERADO, FACILITANDO LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES CON TASAS DE Ã‰XITO ELEVADAS (~95%). LA EVIDENCIA CLÃ NICA Y EXPERIMENTAL RESPALDA SU USO, AUNQUE LA OPTIMIZACIÃ“N DE LAS TÃ‰CNICAS Y MATERIALES, ASÃ COMO LA COMPRENSIÃ“N DE LOS FACTORES QUE AFECTAN LOS RESULTADOS, SIGUEN SIENDO Ã REAS PRIORITARIAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES.

Bibliografía *

BIBLIOGRAFÃ A *

1. RETZEPI, M. Y DONOS, N. (2010). REGENERACIÃ“N Ã“SEA GUIADA: PRINCIPIO BIOLÃ“GICO Y APLICACIONES TERAPÃ‰UTICAS. INVESTIGACIÃ“N CLÃ NICA SOBRE IMPLANTES ORALES, 21, 567â€“576. DOI:10.1111/J.1600-0501.2010.01922.X

2. JEPSEN S, SCHWARZ F, CORDARO L, ET AL. REGENERACIÃ“N DE DEFECTOS DE LA CRESTA ALVEOLAR. INFORME DE CONSENSO DEL GRUPO 4 DEL 15Âº TALLER EUROPEO DE PERIODONCIA SOBRE REGENERACIÃ“N Ã“SEA. J CLIN PERIODONTOL. 2019; 46 (SUPL. 21): 277-286. HTTPS://DOI.ORG/10.1111/JCPE.13121

3. BERGLUNDH, T., ARMITAGE, G., ARAUJO, M. G., AVILA-ORTIZ, G., BLANCO, J., CAMARGO, P. M., ZITZMANN, N. (2018). PERI-IMPLANT DISEASES AND CONDITIONS: CONSENSUS REPORT OF WORKGROUP 4 OF THE 2017 WORLD WORKSHOP ON THE CLASSIFICATION OF PERIODONTAL AND PERI- IMPLANT DIS-EASES AND CONDITIONS. JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY, 45(SUPPL 20):S286â€“S291.

4. NAENNI, N., LIM, H. C., PAPAGEORGIOU, S., & HÃ„MMERLE, C. H. F. (2019). EFFICACY OF LATERAL BONE AUGMENTATION PRIOR TO IMPLANT PLACEMENT: ASYSTEMATIC REVIEW AND METAANALYSIS. JOURNAL OF CLINICAL

Título del trabajo *

LESIÃ“N INTRAORAL ASOCIADA A SINDROME DE GORLIN GOLTZ CON MANIFESTACIÃ“N FAMILIAR: RESPORTE DE CASO

Nombre del Autor (a/es)*

C.D. Mariana Medina Reyes

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

L.O.E.P. Olga Maria MartÃ-nez Bernal, , L.O.E.P.B. Janett Soriano GonzÃ¡lez, , , , , , .

Correo Electrónico *

cdmarianamedinar@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD QUETZALCOATL EN IRAPUATO

Introducción y Objetivos *

EL SÃNDROME DE GORLIN GOLTZ O SÃNDROME DE CARCINOMA BASOCELULAR NEVOIDE ES UNA ENFERMEDAD AUTOSÃ“MICA DOMINANTE CAUSADO POR MUTACIONES EN EL GEN PTCH 1 Y ALGUNAS VARIANTES DEL GEN SUFU, SE CARACTERIZA POR LA PRESENCIA DE CARCINOMAS BASOCELULARES, ALTERACIONES ESQUELÃ‰TICAS, CUTÃNEAS, OFTÃLMICAS Y COMO UNO DE SUS RASGOS PRINCIPALES LA PRESENCIA DE MÃšLTIPLES QUERATOQUISTES ODONTOGÃ‰NICOS.

LA PREVALENCIA VARÃA ENTRE 1:57000/256000, AFECTANDO 1:1,3 EN RELACIÃ“N HOMBRES Y MUJERES CON PREDOMINIO EN RAZA BLANCA Y DE MENOR MANIFESTACIÃ“N EN RAZA ASIÃTICA Y NEGRA.

PARA SU IDENTIFICACIÃ“N SE HAN ESTABLECIDO CRITERIOS CLÃNICOS MAYORES Y MENORES; DE LOS CUALES SE DEBEN CUMPLIR AL MENOS 2 CRITERIOS MAYORES O 2 CRITERIOS MENORES Y 1 MAYOR PARA ESTABLECER EL DIAGNÃ“STICO CLÃNICO QUE PUEDEN INCLUIR PRUEBAS HISTOLÃ“GICAS Y PREFERENTEMENTE PRUEBAS GENÃ‰TICAS DE PTCH 1.

EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO ES PRESENTAR UN CASO DE SÃNDROME DE GORLIN GOLTZ CON MANIFESTACIONES FAMILIARES IDENTIFICADO MEDIANTE CRITERIOS CLÃNICOS EN LA CONSULTA DEL POSGRADO DE PERIODONCIA DE LA UNIVERSIDAD QUETZALCÃ“ATL EN IRAPUATO.

Descripción del Caso *

PACIENTE MASCULINO DE 54 AÃ‘OS, ACUDE A CONSULTA EN POSGRADO DE PERIODONCIA DE LA UNIVERSIDAD QUETZALCOATL EN IRAPUATO REFERIDO DE INSTITUCIÃ“N PÃšBLICA DE SALUD POR Â¨LESIÃ“N ADENTRO DE LA BOCA Y MAL ALIENTOÂ¨

APP: DIABETES MELLITUS T2 DE 10 AÃ‘OS DE EVOLUCIÃ“N SIN TRATAMIENTO MÃ‰DICO, ALERGIAS NEGADAS. REFIERE INTERVENCIÃ“N QUIRÃšRGICA PREVIA (10 AÃ‘OS) DE RETIRO DE QUISTE EN MAXILAR SUPERIOR SIN ANÃ□LISIS HISTOPATOLÃ“GICO, AHF: TRES DE SUS HIJOS HAN TENIDO INTERVENCIONES DE LA MISMA Ã□NDOLE PARA RETIRO DE QUISTES MAXILARES Y MANDIBULARES.

EXTRAORALMENTE SE OBSERVA AUMENTO DE VOLUMEN EN TERCIO INFERIOR IZQUIERDO DE LA CARA, NEVOS MÃšLTIPLES EN ROSTRO Y CRÃ□NEO, ASÃ□ COMO PRESENCIA DE FOSITAS PALMARES, ASIMETRÃ□A FACIAL, PROMINENCIA FRONTAL E HIPERTELORISMO, ADENOMEGALIA CERVICAL DE LADO DERECHO, PRESENTA ÃšLCERA LOCALIZADA EN PIEL DE CRÃ□NEO LADO DERECHO DE APROXIMADAMENTE 2CM DE DIÃ□METRO, DE BORDES ENROLLADOS, PIGMENTADOS DE COLOR CAFÃ‰ OSCURO, ASINTOMÃ□TICO, DE 4 MESES DE EVOLUCIÃ“N, DICHAS CARACTERÃ□STICAS COMPATIBLES CON CARCINOMA BASOCELULAR.

INTRAORALMENTE PRESENTA UN NÃ“DULO, SOBRE REBORDE ALVEOLAR EN LA ZONA RETROMOLAR INFERIOR IZQUIERDA, DE COLOR ROJO VIOLÃ□CEO CON Ã□REAS AMARILLAS, SUPERFICIE LISA, CON PRESENCIA DE ZONAS DE ULCERACIÃ“N Y BASE SÃ‰SIL; MIDE APROXIMADAMENTE 2.0 X 1.5 CM, REFIERE 6 MESES DE EVOLUCIÃ“N. EL DIAGNÃ“STICO CLÃ□NICO PRESUNTIVO ES COMPATIBLE CON GRANULOMA PERIFÃ‰RICO DE CÃ‰LULAS GIGANTES VS GRANULOMA PIÃ“GENO VS CARCINOMA DE CÃ‰LULAS ESCAMOSAS. TAMBIÃ‰N PRESENTÃ“ MAL ALIENTO, ABUNDANTE PDB, AUSENCIAS DENTALES Y DEFICIENCIA DE REBORDE ALVEOLAR SUPERIOR POR PREVIA CIRUGÃ□A RESECTIVA.

RADIOGRÃ□FICAMENTE SE OBSERVAN MÃšLTIPLES LESIONES RADIOLÃšCIDAS MULTILOCULARES DISTRIBUIDAS EN RAMA Y CUERPO MANDIBULAR BILATERALES, BIEN DELIMITADAS DE BORDES ESCLERÃ“TICOS.

SIGNOS Y SÃ□NTOMAS: REFIERE PÃ‰RDIDA DE PESO SÃšBITA DE 2 MESES DE EVOLUCIÃ“N, MALESTAR GENERAL, CANSANCIO, DOLOR DE CABEZA Y PÃ‰RDIDA DE APETITO. SE INDICÃ“ PROTOCOLARIAMENTE PRUEBA DE HBA1C CON RESULTADO DE 11.8%.

EL TRATAMIENTO SUGERIDO FUE REALIZAR BIOPSIA INCISIONAL Y ESTUDIO HISTOPATOLÃ“GICO DE LAS LESIONES, SIN EMBARGO, SE TUVO QUE REALIZAR LA REFERENCIA A URGENCIAS DE HOSPITAL GENERAL DE IRAPUATO DEBIDO A UNA COMPLICACIÃ“N SÃšBITA DE SUS SIGNOS Y SÃ□NTOMAS QUE INCLUYERON DEBILIDAD EXTREMA Y FIEBRE >39Â°

Resultados y Conclusiones *

CON BASE EN LAS CARACTERÃ STICAS CLÃ NICAS Y RADIOGRÃ FICAS DEL CASO, SE SUGIERE EL DIAGNÃ“STICO DE SÃ NDROME DE GORLIN GOLTZ DEBIDO A QUE SE CUMPLE CON 2 CRITERIOS MAYORES (FOSAS PALMO PLANTARES E HISTORIA FAMILIAR POSITIVA AL SÃ NDROME) Y 1 CRITERIO MENOR (HIPERTELORISMO). CORRESPONDIENTE A LA LESIÃ“N INTRAORAL LAS CARACTERÃ STICAS CLÃ NICAS NOS APUNTAN AL DIAGNÃ“STICO CLÃ NICO DE UNA LESIÃ“N REACTIVA CONTRA UN CARCINOMA DE CÃ‰LULAS ESCAMOSAS, DIAGNÃ“STICO QUE SE TIENE QUE TOMAR EN CUENTA DEBIDO A QUE EN ESTE SÃ NDROME OCURRE UNA DESREGULACIÃ“N DE LA VÃ A DE SEÃ‘ALIZACIÃ“N CELULAR DE HEDGEHOG QUE SE INVOLUCRA EN MÃ S DEL 50% DE LAS FORMAS DE CÃ NCER, ADEMÃ S DE QUE SE HA OBSERVADO COMO MANIFESTACIÃ“N CLÃ NICA AUNQUE DE MANERA POCO FRECUENTE LA PRESENCIA DE AMELOBLASTOMAS O CARCINOMAS DE CÃ‰LULAS ESCAMOSAS EN PACIENTES CON ESTE SÃ NDROME.

SE REALIZÃ“ EXPLORACIÃ“N INTRAORAL A SU FAMILIAR EN 1ER GRADO (HIJO) ENCONTRANDO UNA LESIÃ“N DE LA MISMA NATURALEZA DE APROXIMADAMENTE 3MM DE DIÃ METRO DE 1 AÃ‘O DE EVOLUCIÃ“N, ASINTOMÃ TICA. TOMANDO EN CUENTA LA REFERENCIA PREVIA DE CIRUGÃ AS ORALES PARA EXTIRPACIÃ“N DE QUISTES ORALES EN 3 MIEMBROS DIRECTOS PODEMOS DETECTAR UN PATRÃ“N HEREDITARIO QUE SUGIERE LA PRESENCIA DE UNA ALTERACIÃ“N GENÃ‰TICA TAL COMO LA LITERATURA LO INDICA EN ENFERMEDADES AUTOSÃ“MICAS DOMINANTES EN DONDE LOS DESCENDIENTES DE UN PACIENTE DIAGNOSTICADO TIENEN EL 50% DE PROBABILIDAD DE PRESENTAR LA ENFERMEDAD, A PESAR DE QUE EL 35-50% DE LOS CASOS SON DE NUEVA APARICIÃ“N, IDENTIFICAR ESTE PATRÃ“N ES DE GRAN RELEVANCIA DEBIDO A QUE EN CADA NUEVA GENERACIÃ“N LAS MANIFESTACIONES SUELEN APARECER A EDADES MÃ S TEMPRANAS Y LA EVOLUCIÃ“N MÃ S GRAVE.

SI BIEN EL DIAGNÃ“STICO SE REALIZÃ“ CON BASE EN LOS HALLAZGOS CLÃ NICOS Y RADIOGRÃ FICOS, EN GENERAL ES VITAL IDENTIFICAR ESTE TIPO DE MANIFESTACIONES, YA QUE ES EL PRIMER ACERCAMIENTO ODONTÃ“LOGO-PACIENTE HACIA A UN DIAGNÃ“STICO OPORTUNO Y CERTERO.

Bibliografía *

PAZDERA J, SANTAVA A, KOLAR Z. GORLIN-GOLTZ SYNDROME WITH FAMILIAL MANIFESTATION. BIOMED PAP MED FAC UNIV PALACKY OLOMOUC CZECH REPUB. 2022 MAR;166(1):112-116. DOI: 10.5507/BP.2020.063. DISPONIBLE EN: PUBMED

SPADARI F, PULICARI F, PELLEGRINI M, SCRIBANTE A, GARAGIOLA U. MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO GORLIN-GOLTZ SYNDROME: FROM DIAGNOSIS TO SURGICAL TREATMENT OF JAWBONES. MAXILLOFAC PLAST RECONSTR SURG. 2022;44(1):25. DOI: 10.1186/S40902-022-00355-5. DISPONIBLE EN: PUBMED

KIM HS, HEO S, KIM KS, CHOI J, YANG JY. GORLINâ€“GOLTZ SYNDROME: A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW WITH PTCH1 GENE SEQUENCING. ARCH PLAST SURG. 2023 AUG 2;50(4):384-388. DOI: 10.1055/A-2096-3536. DISPONIBLE EN: PUBMED

Título del trabajo *

REGENERACION TISULAR GUIADA E INTRUSION ORTODONCICA SINERGIA CONFIABLE EN EL MANEJO DE PERIODONTITIS ESTADIO IV

Nombre del Autor (a/es)*

JESUS GONZALEZ ARIAS

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

YADIMIRA VAZQUEZ URBINA, , , , , , , , .

Correo Electrónico *

jesus130287@gmail.com

Institución *

CEMRO

Introducción y Objetivos *

EN LA ACTUALIDAD, UN NÃšMERO MAYOR DE PACIENTES ADULTOS BUSCAN TRATAMIENTO DE ORTODONCIA (TO), MUCHOS DE LOS CUALES PADECEN ALGÃšN GRADO DE PERIODONTITIS, LO QUE AFECTA NEGATIVAMENTE FUNCIÃ“N MASTICATORIA Y CALIDAD DE VIDA EN GENERAL; LA PERIODONTITIS EN ESTADIO IV REPRESENTA LA FORMA MÃS AVANZADA, CARACTERIZADA POR PÃ‰RDIDA GRAVE DE INSERCIÃ“N CLÃNICA INTERPROXIMAL, BOLSAS PERIODONTALES PROFUNDAS, REABSORCIÃ“N Ã“SEA QUE SE EXTIENDE A VECES HASTA EL ÃPICE RADICULAR Y MUCHAS VECES UN PERIODONTO REDUCIDO (1). LOS CASOS QUE REQUIEREN TRATAMIENTO INTERDISCIPLINARIO ORTODONCIA-PERIODONCIA, LA SECUENCIA Ã“PTIMA PARA INICIAR SIGUE SIENDO UN TEMA DEBATIBLE, LAS ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO PUEDEN CLASIFICARSE EN DOS: A) CIRUGÃA REGENERATIVA PERIODONTAL PRIMERO, SEGUIDA DE TRATAMIENTO DE ORTODONCIA, O BIEN, B) TRATAMIENTO DE ORTODONCIA PRIMERO, SEGUIDO DE CIRUGÃA REGENERATIVA; CUANDO SE REALIZA PRIMERO CIRUGÃA PERIODONTAL, EL ENFOQUE PUEDE SUBDIVIDIRSE: ORTODONCIA TEMPRANA INICIANDO EN LOS 10 DÃAS POSTERIORES A LA OPERACIÃ“N, Y ORTODONCIA TARDÃA COMENZANDO 12 MESES DESPUÃ‰S DE LA OPERACIÃ“N(2). LA GUÃA DE LA EFP RECOMIENDA LA CIRUGÃA REGENERATIVA PERIODONTAL CON MEMBRANAS DE BARRERA Y/O DERIVADOS DE LA MATRIZ DEL ESMALTE EMDOGAINÂ®, CON O SIN INJERTOS Ã“SEOS, PARA BOLSAS RESIDUALES PROFUNDAS CON DEFECTOS INTRAÃ“SEOS ? 3 MM, EN ESTOS CASOS, SE CONSIDERA NECESARIO EL AUMENTO Ã“SEO Y/O DE TEJIDOS BLANDOS (MODIFICACIÃ“N DEL FENOTIPO) ANTES DE INICIAR TO. EL TO TARDÃO ES CONSERVADOR, GARANTIZA RESULTADOS REGENERATIVOS ESTABLES, ANTES DE INICIAR EL MOVIMIENTO ORTODONCICO(3). LA EVIDENCIA CIENTÃFICA ACERCA DEL EMDOGAINÂ®, SE CONSIDERA ALTERNATIVA TERAPÃ‰UTICA PARA LA REGENERACIÃ“N Y TRATAMIENTO DE DEFECTOS(4). LA MATRIZ DÃ‰RMICA ACELULAR ORACELLÂ® COMBINADA CON EMDOGAINÂ® ES UNA ALTERNATIVA DE INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO, YA QUE ES TÃ‰CNICA POCO TRAUMÃTICA Y PRESENTA BUENOS RESULTADOS, OFRECIENDO UN PORCENTAJE ALTO DE COBERTURA RADICULAR Y EN CANTIDAD DE ENCÃA QUERATINIZADA(5).

EL OBJETIVO DE ESTE CASO CLÃNICO ES EVALUAR LA R.T.G. REALIZANDO UN MANEJO INTERDISCIPLINARIO EN UNA PERIODONTITIS ESTADIO IV.

Descripción del Caso *

PACIENTE MASCULINO DE 54 AÃ‘OS DE EDAD, SE PRESENTÃ“ A LA CLÃ NICA POSGRADO DE PERIODONCIA CEMRO. SIN ANTECEDENTES PATOLÃ“GICOS PERSONALES. MOTIVO DE CONSULTA â€œQUIERO QUE ME EVALÃšEN PARA TENER OTRA OPINIÃ“N SOBRE EL TRATAMIENTO DE MIS DIENTES FRONTALES YA QUE QUIEREN QUITARME TODOS Y COLOCARME IMPLANTESâ€ . EL EXAMEN PERIODONTAL ARROJO PROFUNDIDAD DE BOLSA PERIODONTAL AL SONDEO (PBS) HASTA 9 MM, UNIÃ“N CEMENTO ESMALTE (UCE) DE 4 MM Y UN NIVEL DE INSERCIÃ“N AL SONDEO (NIS) DE 1-2 MM EN UN 11.30 %, 3-4 MM CON UN 43.45% Y > 5 MM EL 45.23%; SANGRADO AL SONDEO (SAS) 16.07%, SIN SUPURACIÃ“N, NI PRESENCIA DE CÃ LCULO DENTAL, ASÃ COMO UN 58.33% DE Ã NDICE DE BIOFILM BACTERIANO (IBB) INICIAL. SE DIAGNOSTICÃ“ PERIODONTITIS ESTADIO IV GENERALIZADA GRADO B, PERIODONTO REDUCIDO. PRONÃ“STICO FAVORABLE. SE PLANIFICÃ“ TRATAMIENTO. FASE I HIGIÃ‰NICA: MEDIANTE CONTROL DE IBB E INSTRUCCIÃ“N DE HIGIENE ORAL. FASE II QUIRÃšRGICA: REGENERACIÃ“N TISULAR GUIADA (RTG). FASE III TO: INTRUSIÃ“N DE SECTOR ANTERIOR DEL MAXILAR CON ORTOIMPLANTES. FASE IV TERAPIA PERIODONTAL DE SOPORTE: REVALORACIÃ“N CLÃ NICA Y RADIOGRÃ FICA A LOS 18 MESES. PREVIO CONSENTIMIENTO INFORMADO SE LLEVÃ“ A CABO R.T.G., INICIANDO CON ASEPSIA Y ANTISEPSIA EXTRAORAL E INTRAORAL, COLOCACIÃ“N DE ANESTÃ‰SICO MEDIANTE TÃ‰CNICA SUPRAPERIÃ“STICA; INCISIÃ“N CON TÃ‰CNICA INTRASULCULAR EN LA ZONA DE PIEZAS DENTARIAS (PD) 13 - 23, CON MANGO DE BISTURÃ NÂ° 3 Y HOJA DE BISTURÃ NÂ°15C. ELEVACIÃ“N DE COLGAJO MUCOPERIÃ“STICO DE ESPESOR TOTAL CON LEGRA MOLT Y BUSER. DESBRIDAMIENTO CON ULTRASONIDO, RASPADO Y ALISADO RADICULAR CON CURETAS GRACEY, DESINTOXICACIÃ“N RADICULAR CON PREFGELÂ® DE STRAUMANNÂ®, LAVADO CON SOLUCIÃ“N FISIOLÃ“GICA Y APLICACIÃ“N DE PROTEÃ NAS DERIVADAS DE LA MATRIZ DEL ESMALTE EMDOGAINÂ®, COLOCACIÃ“N DE MATRIZ DÃ‰RMICA ACELULAR ORACELLÂ® EN MEDIDA 20 X 40 MM (PROTOCOLO DEL FABRICANTE) Y FIJADA CON VICRYL 5-0. REPOSICIONAMIENTO DE COLGAJO CON PUNTOS COLCHONEROS VERTICALES, SIMPLES Y SUTURA NYLON 6-0. CUIDADOS POS-OPERTATORIOS.

Resultados y Conclusiones *

EN ESTE CASO CLÃ□NICO SE EVALUARON LOS CAMBIOS QUE PRESENTARON LOS PARÃ□METROS CLÃ□NICOS PERIODONTALES 18 MESES DE REALIZAR LA R.T.G. Y 1 MES DE INTRUSIÃ“N DE LA TO. EL EXAMEN PERIODONTAL ARROJO INICIALMENTE PBS HASTA 9 MM, UCE DE 4 MM Y NIS DE 1-2 MM EN UN 11.30 %, 3-4 MM CON UN 43.45% Y > 5 MM EL 45.23%; SAS 16.07%, SIN SUPURACIÃ“N, NI PRESENCIA DE CÃ□LCULO DENTAL, ASÃ□ COMO UN 58.33% IBB. A 18 MESES: PBS HASTA 5 MM, UCE DE 2 MM Y NIS DE 1-2 MM EN UN 39.42 %, 3-4 MM CON UN 45.45 % Y > 5 MM EL 16.3%; SAS 4.8%, SIN SUPURACIÃ“N, NI PRESENCIA DE CÃ□LCULO DENTAL, IBB 11.11%. RADIOGRÃ□FICAMENTE POR MEDIO DE CBCT EN CORTE SAGITAL SE MIDIÃ“ LA CANTIDAD DE HUESO ALVEOLAR REMANENTE DE UCE AL Ã□PICE DE CADA DIENTE ANTERIOR SUPERIOR; EN LA VISTA INICIAL SE APRECIÃ“ EN PD 13 HUESO REMANETE VESTIBULAR 16.76 MM, HUESO PERDIDO 7.28 MM, EN PD 12 HUESO REMANETE VESTIBULAR 11.38 MM, HUESO PERDIDO 5.63 MM, PARA PD 11 HUESO REMANETE VESTIBULAR 10.52 MM, HUESO PERDIDO 5.71 MM, MIENTRAS QUE PD 21 HUESO REMANETE VESTIBULAR 9.03 MM, HUESO PERDIDO 5.69 MM, EN PD 22 HUESO REMANETE VESTIBULAR 9.96 MM, HUESO PERDIDO 4.69 MM, PARA PD 23 HUESO REMANETE VESTIBULAR 15.55 MM, HUESO PERDIDO 5.27 MM. A DIECIOCHO MESES DE LA RTG Y UNA VEZ CONCLUIDA LA INTRUSIÃ“N CON TO SE OBSERVÃ“ UN INCREMENTO EN ALTURA DEL HUESO ALVEOLAR EN EL MISMO ESTUDIO. SE APRECIA PARA PD 13 HUESO REMANETE VESTIBULAR 20.76 MM, HUESO PERDIDO 3.28 MM UN INCREMENTO 4 MM, EN PD 12 HUESO REMANETE VESTIBULAR 14.38 MM, HUESO PERDIDO 2.63 MM CON INCREMENTO DE 3 MM, PD 11 HUESO REMANETE VESTIBULAR 13.52 MM, HUESO PERDIDO 2.71 MM SIENDO INCREMENTO DE 3 MM, EN PD 21 HUESO REMANETE VESTIBULAR 12.03 MM, HUESO PERDIDO 2.69 MM UN INCREMENTO DE 3 MM, PD 22 HUESO REMANETE VESTIBULAR 13.46 MM, HUESO PERDIDO 1.19 MM CON INCREMENTO DE 3.5 MM, PARA PD 23 HUESO REMANETE VESTIBULAR 19.055 MM, HUESO PERDIDO 1.77 MM SIENDO UN INCREMENTO DE 3.5. MM. LA R. T. G. MEDIANTE EMDOGAINÂ® Y MDA ORACELLÂ® AYUDA A VER CAMBIOS EN LOS PARÃ□METROS CLÃ□NICOS PERIODONTALES, ADEMÃ□S QUE EL TO TARDÃ□O EN UN PERIODONTO REDUCIDO, AYUDA SIGNIFICATIVAMENTE A CONSEGUIR FUNCIÃ“N, ESTÃ‰TICA E INTEGRIDAD DE LOS TEJIDOS PERIODONTALES, POR LO QUÃ‰, EL RESULTADO DE ESTE CASO CLÃ□NICO MUESTRA QUE EL MANEJO INTERDISCIPLINARIO ES MUY IMPORTANTE. EL USO DE LA T. A. C. DEMUESTRA QUE ES UNA HERRAMIENTA ÃšTIL QUE HOY EN DÃ□A PUEDE UTILIZARSE PARA OBSERVAR Y EVALUAR DE FORMA OBJETIVA LOS TRATAMIENTOS REGENERATIVOS DE TEJIDO Ã“SEO DE FORMA TRIDIMENSIONAL. EL Ã‰XITO DEL TRATAMIENTO VA Ã□NTIMAMENTE RELACIONADO A LA COLABORACIÃ“N DEL PACIENTE QUE DEBE ACUDIR PERIÃ“DICAMENTE A LA TERAPIA PERIODONTAL DE SOPORTE, CUIDANDO SU HIGIENE DENTAL, YA QUE SIN Ã‰STA LOS MOVIMIENTOS DE ORTODONCIA SE VEN LIMITADOS Y PUEDEN OCASIONAR EFECTOS ADVERSOS.

Bibliografía *

1. PAPAPANOU, PN; SANZ, M.; BUDUNELI, N.; DIETRICH, T.; FERES, M.; FINE, DH; FLEMMIG, TF; GARCIA, R.; GIANNOBILE, W.V.; GRAZIANI, F.; ET AL. PERIODONTITIS: INFORME DE CONSENSO DEL GRUPO DE TRABAJO 2 DEL TALLER MUNDIAL DE 2017 SOBRE LA CLASIFICACIÃ“N DE ENFERMEDADES Y AFECCIONES PERIODONTALES Y PERIIMPLANTARIAS. J. CLIN. PERIODONTOL. 2018 , 45 (SUPL. 20), S162â€“S170.

2. LA AGUIRRE-ZORZANO , E. ESTEFANÃ□A-CUNDÃ□N , J. GIL-LOZANO , R. MARTÃ□NEZ-CONDE , V. NÃšÃ‘EZ-ANTÃ“N , J. SANTAMARÃ□A-ZUAZUA - â€œREGENERACIÃ“N PERIODONTAL DE DEFECTOS INTRAÃ“SEOS MEDIANTE MEMBRANAS REABSORBIBLES: DETERMINANTES DE LA RESPUESTA DE CURACIÃ“N: UN ESTUDIO CLÃ□NICO OBSERVACIONALâ€□ INT J PERIODONCIA RESTOR DENT, 19 (1999), PÃ□GS . 363-371

3. D. GARBO , G. BAIMA , GM MARIANI , F. ROMANO , M. AIMETTI - â€œTRATAMIENTO DE ORTODONCIA EN PACIENTES CON PERIODONTITIS EN ESTADIO IV: MOMENTO OPORTUNO, MANEJO Y PRONÃ“STICO A LARGO PLAZOâ€□ SEMIN ORTHOD , 30 (2024) , PÃ□GS . 113-122

4. PRATO G. PINI , L. CHAMBRONE - â€œTRATAMIENTO DE ORTODONCIA EN PACIENTES PERIODONTALES: EL USO DE ESTÃ□NDARES DE ORO PERIODONTALES PARA SUPERAR LA â€œZONA GRISâ€□

Título del trabajo *

ELEVACIÃ“N DE SENO MAXILAR CON TÃ‰CNICA DE VENTANA LATERAL Y COLOCACIÃ“N INMEDIATA DE IMPLANTE.

Nombre del Autor (a/es)*

C.D.Elia Estela Escobar Montijo

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

C.D.E.P Jovany Velasco Santos, , C.D.E.P Yerik Alberto VelÃ¡zquez SÃ¡nchez, , C.D.E.P MÃ³nica MagaÃ±a, , , , .

Correo Electrónico *

esco_montijo@hotmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MÃ‰XICO

Introducción y Objetivos *

LA REHABILITACIÃ“N CON IMPLANTES DENTALES EN EL SECTOR POSTERIOR DEL MAXILAR SUPERIOR PUEDE VERSE LIMITADA POR LA REABSORCIÃ“N Ã“SEA

ANTE ESTA CONDICIÃ“N ANATÃ“MICA, SE REQUIEREN TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS QUE PERMITAN LOGRAR UNA REHABILITACIÃ“N FUNCIONAL, ESTÃ‰TICA Y PREDECIBLE.

LA TÃ‰CNICA DE ELEVACIÃ“N DE SENO MAXILAR MEDIANTE VENTANA LATERAL CONSTITUYE UNA DE LAS ALTERNATIVAS QUIRÃšRGICAS MÃS EMPLEADAS, OFRECIENDO UN VOLUMEN Ã“SEO ADECUADO PARA LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES DENTALES Y AUMENTANDO LA TASA DE Ã‰XITO A LARGO PLAZO.

OBJETIVOS

CREAR CONDICIONES Ã“PTIMAS PARA REHABILITAR CON PRÃ“TESIS IMPLANTOSOPORTADA DE MANERA PREDECIBLE, OFRECIENDO UNA OPCIÃ“N TERAPÃ‰UTICA A PACIENTES CON DEFICIENCIA DE SOPORTE Ã“SEO EN LA REGIÃ“N POSTERIOR DEL MAXILAR SUPERIOR EN PROXIMIDAD AL SENO MAXILAR.

ESTABLECER PROTOCOLOS QUIRÃšRGICOS Y REGENERATIVOS QUE PERMITAN OPTIMIZAR EL VOLUMEN Ã“SEO EN LA REGIÃ“N POSTERIOR DEL MAXILAR SUPERIOR, EN PROXIMIDAD AL SENO MAXILAR, CON EL FIN DE FAVORECER LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES DENTALES DE MANERA SEGURA Y PREDECIBLE.

ANALIZAR LAS LIMITACIONES ANATÃ“MICAS Y RADIOGRÃFICAS DE LA REGIÃ“N POSTERIOR DEL MAXILAR SUPERIOR EN PROXIMIDAD AL SENO MAXILAR, CON EL PROPÃ“SITO DE PLANIFICAR DE MANERA INDIVIDUALIZADA TRATAMIENTOS IMPLANTOLÃ“GICOS PREDECIBLES.

Descripción del Caso *

EL PRESENTE CASO CLÃ□NICO CORRESPONDE A UN PACIENTE MASCULINO QUE ACUDIÃ“ A LA CLÃ□NICA DE PERIODONCIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÃ“GICA DE MÃ‰XICO (UNITEC) CON EL OBJETIVO DE REHABILITAR LA REGIÃ“N POSTERIOR DEL MAXILAR SUPERIOR MEDIANTE LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES DENTALES. DURANTE LA FASE DIAGNÃ“STICA, SE REALIZARON ESTUDIOS CLÃ□NICOS Y RADIOGRÃ□FICOS QUE EVIDENCIARON UN ESPACIO Ã“SEO DEFICIENTE ENTRE EL REBORDE ALVEOLAR Y EL SENO MAXILAR, LO CUAL COMPROMETÃ□A LA DISPONIBILIDAD DE HUESO Y, EN CONSECUENCIA, LA POSIBILIDAD DE OBTENER ESTABILIDAD PRIMARIA PARA LA COLOCACIÃ“N DEL IMPLANTE.

ANTE ESTA CONDICIÃ“N ANATÃ“MICA, SE DETERMINÃ“ COMO ALTERNATIVA TERAPÃ‰UTICA LA REALIZACIÃ“N DE UNA ELEVACIÃ“N DE SENO MAXILAR MEDIANTE LA TÃ‰CNICA DE VENTANA LATERAL. ESTE PROCEDIMIENTO ES CONSIDERADO UNO DE LOS ABORDAJES MÃ□S EFECTIVOS Y PREDECIBLES PARA AUMENTAR EL VOLUMEN Ã“SEO DISPONIBLE EN EL SECTOR POSTERIOR DEL MAXILAR, ESPECIALMENTE EN PACIENTES CON REABSORCIÃ“N SEVERA. LA TÃ‰CNICA PERMITE REPOSICIONAR LA MEMBRANA SINUSAL Y COLOCAR MATERIAL DE INJERTO QUE ACTÃšE COMO MATRIZ PARA LA NEOFORMACIÃ“N Ã“SEA, CREANDO UN LECHO ADECUADO PARA LA FUTURA OSTEOINTEGRACIÃ“N DEL IMPLANTE.

EN EL MISMO PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO, Y CON BASE EN LA ESTABILIDAD OBTENIDA, SE LLEVÃ“ A CABO LA COLOCACIÃ“N DE UN IMPLANTE INMEDIATO. ESTA ESTRATEGIA COMBINADA OFRECIÃ“ BENEFICIOS SIGNIFICATIVOS, COMO LA REDUCCIÃ“N DEL NÃšMERO DE INTERVENCIONES QUIRÃšRGICAS, LA DISMINUCIÃ“N DE LA MORBILIDAD Y LA OPTIMIZACIÃ“N DE LOS TIEMPOS DE TRATAMIENTO. ADEMÃ□S, PERMITIÃ“ MEJORAR LA PREDICTIBILIDAD DE LOS RESULTADOS CLÃ□NICOS Y PROTÃ‰SICOS, OFRECIENDO AL PACIENTE UNA ALTERNATIVA DE REHABILITACIÃ“N INTEGRAL, FUNCIONAL Y ESTÃ‰TICA.

Resultados y Conclusiones *

DENTRO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA COMPARATIVA ENTRE LA TOMOGRAFÃ⍰A INICIAL Y LOS ESTUDIOS RADIOGRÃ⍰FICOS DE CONTROL, SE OBSERVÃ“ QUE LA ELEVACIÃ“N DE SENO MAXILAR MEDIANTE LA TÃ‰CNICA DE VENTANA LATERAL GENERÃ“ UN AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL VOLUMEN Ã“SEO EN LA REGIÃ“N POSTERIOR DEL MAXILAR SUPERIOR. ESTE INCREMENTO EN LA DISPONIBILIDAD Ã“SEA RESULTÃ“ FUNDAMENTAL PARA ALCANZAR CONDICIONES ANATÃ“MICAS FAVORABLES, YA QUE PERMITIÃ“ CREAR UN LECHO RECEPTOR ADECUADO PARA LA COLOCACIÃ“N DE UN IMPLANTE EN UN SITIO PREVIAMENTE LIMITADO POR LA PROXIMIDAD DEL SENO MAXILAR. LA NEOFORMACIÃ“N Ã“SEA INDUCIDA MEDIANTE EL USO DE LA TÃ‰CNICA DE VENTANA LATERAL EVIDENCIÃ“ UN PATRÃ“N DE REGENERACIÃ“N PREDECIBLE Y UNIFORME, LO CUAL REFUERZA LA EFICACIA DE ESTE PROCEDIMIENTO EN PACIENTES CON DEFICIENCIA Ã“SEA SEVERA.

EN RELACIÃ“N CON LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTE INMEDIATA, LA ESTRATEGIA QUIRÃšRGICA CONSISTIÃ“ EN APROVECHAR EL MISMO PROCEDIMIENTO DE ELEVACIÃ“N SINUSAL PARA INSTALAR EL IMPLANTE, CON EL OBJETIVO DE REDUCIR EL NÃšMERO DE INTERVENCIONES Y OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE TRATAMIENTO. EL IMPLANTE SE COLOCÃ“ SIMULTÃ⍰NEAMENTE DURANTE LA CIRUGÃ⍰A, ALCANZANDO UNA ESTABILIDAD PRIMARIA ADECUADA QUE GARANTIZÃ“ SU FIJACIÃ“N INICIAL Y FAVORECIÃ“ EL PROCESO DE OSTEOINTEGRACIÃ“N. ES IMPORTANTE SEÃ‘ALAR QUE LA ESTABILIDAD OBTENIDA NO SOLO DEPENDIÃ“ DEL HUESO REMANENTE EXISTENTE, SINO TAMBIÃ‰N DE LA PREPARACIÃ“N CUIDADOSA DEL SITIO IMPLANTARIO Y DE LA ADECUADA MANIPULACIÃ“N DE LOS TEJIDOS DURANTE LA CIRUGÃ⍰A.

EL SEGUIMIENTO POSTOPERATORIO INMEDIATO EVIDENCIÃ“ UNA EVOLUCIÃ“N FAVORABLE, SIN COMPLICACIONES QUIRÃšRGICAS NI INFECCIOSAS. EL PACIENTE NO PRESENTÃ“ SIGNOS DE DOLOR PERSISTENTE, INFLAMACIÃ“N EXCESIVA O EXPOSICIÃ“N DE LA MEMBRANA SINUSAL, LO QUE SUGIERE QUE LOS PROTOCOLOS CLÃ⍰NICOS IMPLEMENTADOS FUERON APROPIADOS Y EFECTIVOS PARA CONTROLAR LOS RIESGOS ASOCIADOS. ASIMISMO, LOS ESTUDIOS DE CONTROL RADIOGRÃ⍰FICO CONFIRMARON LA ADECUADA POSICIÃ“N TRIDIMENSIONAL DEL IMPLANTE Y LA ESTABILIDAD DEL MATERIAL INJERTADO, LO CUAL CONSTITUYE UN INDICADOR DE Ã‰XITO EN LAS FASES INICIALES DEL TRATAMIENTO IMPLANTOLÃ“GICO.

Bibliografía *

GUZMÃ⍰N-CRUZ, D., SAURI ESQUIVEL, E. A., CARRILLO, Ã⍰., Ã⍰VILA, B. A., MARTÃ⍰NEZ, Ã⍰., & AGUILAR, V. M. (2017). TÃ‰CNICA DE VENTANA LATERAL PARA ELEVACIÃ“N DE SENO MAXILAR CON FINES TERAPÃ‰UTICOS IMPLANTOLÃ“GICOS. REVISTA ODONTOLÃ“GICA LATINOAMERICANA, 9(2), 69â€“74.

RAGHOEBAR GM, BROUWER TJ, REINTSEMA H, VANÂ OORTÂ RP. AUGMENTATION OF MAXILARY SINUS FLOOR WITH AUTOGENOUS BONE FOR THE PLACEMENT OF ENDOOSSEOUS IMPLANTS: A PRELOMINARY REPORT.J ORAL MAXILLOFAC SURG. 1993:51:1:1198-203

AHMED KAMAL ABO ZEKRY, RAGIA MOUNIR, WALEED RAGAB EL- BEIALY. OPEN SINUS LIFT SURGERY AND AUGMENTATION WITH (SCPC VERSUS H.A): A SYSTEMATIC REVIEW. FUTURE DENTAL JOURNAL 4 (2018) 135-140. 2- MISCH C. Lâ€™ ODONTOIATRIA I

LORENZETTI M, MOZZATI M, CAMPANINO PP, VALENTE G. BONE AUGMENTATION OF THE INFERIOR FLOOR OF THE MAXILLARY SINUS WITH AUTOGENOUS BONE OR COMPOSITE BONE GRAFTS A HISTOLOGIC- ISTOMORPHOMETRIC PRELIMINARY REPORT. INT J ORAL MAXILLOFAC IMPLANTS. 1998; 13:69-76.

MARÃ⍰A HERRERO. MANUEL PICÃ“N. FERNANDO ALMEIDA. LEONARDO TRUJILLO. JORGE NÃšÃ‘EZ Y ANTONIO

Título del trabajo *

PRESERVACIÃ“N DE LA CRESTA ALVEOLAR COMBINADA CON INJERTO INTERPOSICIONAL PARA SELLAR UN ALVEOLO POST-EXTRACCIÃ“N EN ZONA ESTETICA. REPORTEÂ DEÂ CASOÂ CLÃ□NICO

Nombre del Autor (a/es)*

Haro Pico MarÃ-a Alejandra, MartÃ-nez Morga Xitlaly,

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Cavazos Rivera MartÃ-n, , , , , , , , .

Correo Electrónico *

haropico9@gmail.com

Institución *

UNIVERSIDAD JUÃ□REZ DEL ESTADO DE DURANGO

Introducción y Objetivos *

TRAS LA EXTRACCIÃ“N DENTAL, SE PUEDEN ESPERAR PÃ‰RDIDAS DE HUESO ALVEOLAR Y CAMBIOS ESTRUCTURALES Y COMPOSICIONALES DE LOS TEJIDOS BLANDOS QUE CUBREN, ASÃ COMO ALTERACIONES MORFOLÃ“GICAS.1 EL RESULTADO DE ESTE PROCESO DE REMODELACIÃ“N FISIOLÃ“GICA VARÃA DE UN SITIO A OTRO Y DE UN INDIVIDUO A OTRO DEPENDIENDO DE FACTORES SISTÃ‰MICOS Y LOCALES, COMO EL GROSOR DE LA PARED Ã“SEA ALVEOLAR VESTIBULAR U OTRAS CARACTERÃSTICAS DEL FENOTIPO LOCAL O DEL SITIO.2 DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PRESERVACIÃ“N DE CRESTA ALVEOLAR EXISTEN TRES OPCIONES: EL USO DE INJERTOS DE TEJIDOS BLANDOS; EL USO DE MATERIALES DE INJERTO DE TEJIDO DURO; O EL USO DE UNA COMBINACIÃ“N DE BIOMATERIALES DE TEJIDOS BLANDOS Y DUROS. LOS OBJETIVOS PRINCIPALES INCLUYEN: LA ELIMINACIÃ“N, O AL MENOS UNA LIMITACIÃ“N, DE LAS ALTERACIONES EN LA CRESTA POSTERIORES A LA EXTRACCIÃ“N; LA PROMOCIÃ“N DE LA CICATRIZACIÃ“N DE LOS TEJIDOS BLANDOS Y DUROS DENTRO DEL ANTIGUO ALVÃ‰OLO DENTAL; Y FACILITAR LA COLOCACIÃ“N DE IMPLANTES DENTALES EN UNA POSICIÃ“N PROTÃ‰SICAMENTE IDEAL SIN NECESIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE AUMENTO ADICIONALES.3STIMMELMAYR ET AL. UTILIZARON INJERTOS COMBINADOS EPITELIZADOS-SUBEPITELIALES CON DOBLE BOLSA QUIRÃšRGICA Y ESTOS PRESENTARON TASAS DE REABSORCIÃ“N MÃS BAJAS QUE LOS INJERTOS ONLAY. ADEMÃS, SU VASCULARIZACIÃ“N Ã“PTIMA DERIVADA DEL COMPONENTE DEL INJERTO INLAY REDUCE LAS TASAS DE FRACASO Y DEHISCENCIA.4-5

Descripción del Caso *

PACIENTE DE SEXO FEMENINO DE 48 AÃ‘OS DE EDAD, ACUDE A LA CLÃ□NICA DE PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÃ□A DEL POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD JUÃ□REZ DEL ESTADO DE DURANGO, DONDE ES REFERIDA DEL Ã□REA DE ENDODONCIA Y CUYO MOTIVO DE CONSULTA ES: â€œDESPUÃ‰S DE LA ENDODONCIA, EL DOCTOR DIJO QUE IBA A PERDER MI DIENTEâ€□. PRESENTA UN DIAGNÃ“STICO MÃ‰DICO DE HIPERTENSIÃ“N ARTERIAL Y EL TRATAMIENTO ACTUAL ES: ENALAPRIL 10MG: 1 TABLETA CADA 12 HORAS. EN SU HISTORIA DENTAL REFIERE EXTRACCIONES DENTALES; Y RETRATAMIENTO DE CONDUCTO EN OD #21 Y CUYO DIAGNOSTICO PULPAR ES DIENTE PREVIAMENTE TRATADO; Y EL PERIAPICAL ES PERIODONTITIS APICAL ASINTOMÃ□TICA, ADEMÃ□S SE EVIDENCIÃ“ POSTERIOR A LA REMOCIÃ“N DE LA GUTAPERCHA PRESENCIA DE FISURA EN DICHO Ã“RGANO DENTAL. EL DIAGNOSTICO PERIODONTAL ES: PERIODONTITIS, ESTADIO IV, GRADO B, LOCALIZADA; PRESENCIA DE RECESIONES RT1, RT2, RT3; CARIES DENTAL; Y CLASIFICACIÃ“N CLASE III EN REBORDE EDÃ‰NTULO DEL CUADRANTE III.

PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO: PREVIO A LA ASEPSIA Y ANTISEPSIA SE ANESTESIA EL NERVIO NASOPALATINO Y LOS NERVIOS ALVEOLARES SUPERIORES CON CLORHIDRATO DE ARTICAÃ□NA CON EPINEFRINA 4%; SE REALIZA INCISIONES INTRASULCULARES CON HOJA DE MICRO-BISTURÃ□, ADEMÃ□S SE CREA UN TÃšNEL SUPRAPERIÃ“STICO LABIAL Y PALATINO MANTENIENDO EL PERIOSTIO UNIDO AL HUESO; EN LO POSTERIOR SE REALIZA LA EXTRACCIÃ“N ATRAUMÃ□TICA DEL OD #21 Y SE DEBRIDA EL TEJIDO GRANULOMATOSO E INFLAMATORIO CON UNA CURETA DE LUCAS Y ABUNDANTE IRRIGACIÃ“N CON CLORURO DE SODIO 0.9%. SE MIDE LA ABERTURA DEL ALVEOLO EN SENTIDO MESIODISTAL Y VESTIBULOPALATINO (5MM X 7MM); PREVIO A LA HIDRATACIÃ“N DEL SUSTITUTO Ã“SEO, XENOINJERTO DE ORIGEN BOVINO 0.5 GR CON TAMAÃ‘O DE PARTÃ□CULA 0.25-1.0 MM Y SE LO EMPAQUETA EN EL ALVEOLO. LUEGO, SE TOMA INJERTO SUBEPITELIAL-EPITELIZADO DEL PALADAR 14-16 Y SE SUTURA CON NYLON 5-0 EN EQUIS PARA AFRONTAR LOS MÃ□RGENES DE LA HERIDA. DESPUÃ‰S, SE INTRODUCE EL COMPONENTE LABIAL DE TEJIDO CONECTIVO EN EL TÃšNEL LABIAL Y PALATINO DE LA ZONA DE EXTRACCIÃ“N CON PUNTO DE COLCHONERO HORIZONTAL (Ã□CIDO POLIGLÃ□COLICO 6-0). ASIMISMO, SE ADAPTARON Y ASEGURARON LOS MÃ□RGENES SULCULARES Y EL COMPONENTE EPITELIZADO DEL INJERTO COMBINADO CON SUTURAS INTERRUMPIDAS (NYLON 6-0).

Resultados y Conclusiones *

LAS SUTURAS FUERON RETIRADAS 20 DÃ□AS DESPUÃ‰S, LA PACIENTE REFIRIÃ“ MAYOR MORBILIDAD EN EL PALADAR DURO DEBIDO A LA CICATRIZACIÃ“N POR SEGUNDA INTENCIÃ“N EN LA ZONA DONDE SE TOMÃ“ EL INJERTO EPITELIZADO, PESE A LA UTILIZACIÃ“N DEL STEND QUIRÃšRGICO PROPORCIONADO. POR OTRO LADO, LAS EXPECTATIVAS ESTÃ‰TICAS DE LA PACIENTE SE CUMPLIERON. ADEMÃ□S, SE EVIDENCIÃ“ LO SIGUIENTE: ARMONÃ□A DE LA LÃ□NEA MUCOGINGIVAL, ENGROSAMIENTO Y ESTABILIZACIÃ“N DEL TEJIDO BLANDO; PRESENCIA DE ENCÃ□A QUERATINIZADA.

EN RESUMEN, LA PRESERVACIÃ“N DE LA CRESTA COMBINADA CON INJERTO SUBEPITELIAL-EPITELIZADO PARA SELLAR EL ALVÃ‰OLO POST-EXTRACCION EN ZONA ESTÃ‰TICA PRODUCE RESULTADOS FAVORABLES EN EL MANTENIMIENTO Ã“PTIMO DEL VOLUMEN TRIDIMENSIONAL LO QUE FACILITA LA REHABILITACIÃ“N EN ESTE SECTOR ANTERIOR.

Bibliografía *

1. JUNG RE, IOANNIDIS A, HÃ„MMERLE CHF, THOMA DS. ALVEOLAR RIDGE PRESERVATION IN THE ESTHETIC ZONE. PERIODONTOL 2000. 2018 JUN;77(1):165-175. DOI: 10.1111/PRD.12209.

2. BAROOTCHI S, TAVELLI L, MAJZOUB J, STEFANINI M, WANG HL, AVILA-ORTIZ G. ALVEOLAR RIDGE PRESERVATION: COMPLICATIONS AND COST-EFFECTIVENESS. PERIODONTOL 2000. 2023 JUN;92(1):235-262. DOI: 10.1111/PRD.12469.

3. CARDAROPOLI D, SANZ M, ARAUJO M, BUSER D, GRUNDER U, KAN J, LEVINE RA, ZUCCHELLI G, ZUHR O, JEPSEN S. TREATMENT OPTIONS FOR THE MANAGEMENT OF THE POSTEXTRACTION SOCKET: REPORT FROM THE FIRST GIUSEPPE CARDAROPOLI FOUNDATION CONSENSUS CONFERENCE. J PERIODONTAL RES. 2025;60(5):398â€“416. DOI: 10.1111/JRE.13385.

4. STIMMELMAYR M, GÃœTH JF, IGLHAUT G, BEUER F. PRESERVATION OF THE RIDGE AND SEALING OF THE SOCKET WITH A COMBINATION EPITHELIALISED AND SUBEPITHELIAL CONNECTIVE TISSUE GRAFT FOR MANAGEMENT OF DEFECTS IN THE BUCCAL BONE BEFORE INSERTION OF IMPLANTS: A CASE SERIES. BR J ORAL MAXILLOFAC SURG. 2012 SEP;50(6):550-5. DOI: 10.1016/J.BJOMS.2011.09.014. EPUB 2011 OCT 14. PMID: 22000635.

Título del trabajo *

AUMENTO DE ENCIA QUERATINIZADA POR MEDIO DE INJERTO GINGIVAL LIBRE. REPORTE Y SEGUIMIENTO DE CASO CLINICO

Nombre del Autor (a/es)*

FRANCO CENICEROS LUIS DANIEL, BAUTISTA TAMAYO YESS

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

MARTIN CAVAZOS RIVERA, EDNA FABIOLA HERRERA GOMEZ, TANYA HERRERA PACHECO, ALEJANDRA MONTAÃ‘O OLVERA, , , , , .

Correo Electrónico *

periocen@gmail.com

Institución *

FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ D

Introducción y Objetivos *

EL INJERTO GINGIVAL LIBRE (IGL), DESCRITO POR LANGER Y LANGER, ES UNA TÃ‰CNICA QUIRÃšRGICA MUCOGINGIVAL INDICADA PARA EL AUMENTO DEL TEJIDO QUERATINIZADO Y LA COBERTURA RADICULAR PARCIAL O TOTAL EN CASOS DE RECESIÃ“N GINGIVAL.

OBJETIVOS

â€¢ AUMENTO DE LA DIMENSIÃ“N VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA ENCÃ?A QUERATINIZADA.

â€¢ ESTABILIZACIÃ“N DEL MARGEN GINGIVAL.

â€¢ COBERTURA RADICULAR EN RECESIONES CLASE I O II DE MILLER.

â€¢ PREPARACIÃ“N DEL LECHO PARA PROCEDIMIENTOS RESTAURADORES O PROTÃ‰SICOS.

Descripción del Caso *

SE PRESENTA PACIENTE FEMENINO DE 20 AÃ‘OS DE EDAD, ASA I, ACUDE A CONSULTA EN EL POSGRADO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÃ□A DE LA UJED, CON MOTIVO DE CONSULTA â€œQUIERO CUBRIR MIS DIENTES, SE ME ESTÃ□N VIENDO MIS RAÃ□CESâ€□. A LA EXPLORACIÃ“N CLÃ□NICA SE OBSERVAN RECESIONES GINGIVALES CLASE I DE MILLER Y RT1 SEGÃšN CAIRO.

Resultados y Conclusiones *

A LOS DOS AÃ‘OS DEL PROCEDIMIENTO PODEMOS OBSERVAR UNA COBERTURA RADICULAR PARCIAL Y UNA ANCHURA ACEPTABLE DE TEJIDO QUERATINIZADO,

LA EVIDENCIA HA DEMOSTRADO QUE EL INJERTO GINGIVAL LIBRE FAVORECE EL AUMENTO DE TEJIDO QUERATINIZADO EN EL TRATAMIENTO DE RECESIONES GINGIVALES COMO TAMBIÃ‰N DE MANERA PREVENTIVA A FORMAR ESTAS MISMAS PREVIO AL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA, MEJORADO ASÃ, LA ESTÃ‰TICA GINGIVAL DEL PACIENTE.

Bibliografía *

1. KHOSHKHOU H, YAGHOBEE S, KHARRAZI FARD M, ETEMADI M, MOHSENI SALEHI MONFARED SH. CLINICAL OUTCOMES OF FREE GINGIVAL GRAFT VS. PALATAL PEDICLE GRAFT IN PERI-IMPLANT SOFT TISSUE PHENOTYPE MODIFICATION: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL COMPARING PATIENT REPORTS. J ADV PERIODONTOL IMPLANT DENT. 2024;16(2):123â€“32. DOI:10.34172/JAPID.2024.016

2. ZUCCHELLI G, TAVELLI L, MCGUIRE MK, RASPERINI G, FEINBERG SE, WANG HL, GIANNOBILE WV. AUTOGENOUS SOFT TISSUE GRAFTING FOR PERIODONTAL AND PERI-IMPLANT PLASTIC SURGICAL RECONSTRUCTION. J PERIODONTOL. 2020.

3. FLORES CB, BUENDÃA MDCL, BRAVO JCS. INJERTO SUBEPITELIAL DE TEJIDO CONJUNTIVO USANDO LA TÃ‰CNICA DE LANGER Y LANGER PARA EL TRATAMIENTO DE RECESIONES GINGIVALES. REPORTE DE UN CASO CLÃNICO (REPORTE A 1 AÃ‘O). REV ODONTOL MEX. 2009;13(3):165â€“70.

4. MILLER PD. A CLASSIFICATION OF MARGINAL TISSUE RECESSION. INT J PERIODONTICS RESTORATIVE DENT. 1985;5(2):8â€“13.

5. SULLIVAN H. ATKINS J. FREE AUTOGENOUS GINGIVAL GRAFTS. I. PRINCIPLES OF SUCCESSFUL GRAFTING.

Título del trabajo *

APLICACIÃ“N DE FIBRINA RICA EN PLAQUETAS EN EXODONCIA DE PACIENTE CON USO DE BIFOSFONATOS

Nombre del Autor (a/es)*

Angela Montoya Castro

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

MCO. Gilberto Zatarin HernÃ¡ndez, Dra. Elsa Patricia Furrer Franco, Dra. Cristina Bermudez Renteria, MCO. Karla Guadalupe MartÃ-nez Lomas, , , , , .

Correo Electrónico *

angelamontoya@uadec.edu.mx

Institución *

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA UNIDAD LAGUNA

Introducción y Objetivos *

LAS EXTRACCIONES DENTALES EN PACIENTES BAJO TRATAMIENTO CON BIFOSFONATOS REPRESENTAN UN RETO CLÃ□NICO IMPORTANTE DEBIDO AL RIESGO DE DESARROLLAR OSTEONECROSIS DE LOS MAXILARES (ONM), UNA COMPLICACIÃ“N GRAVE CARACTERIZADA POR EXPOSICIÃ“N Ã“SEA PERSISTENTE. ESTE RIESGO ES ESPECIALMENTE RELEVANTE EN TRATAMIENTOS PROLONGADOS CON BIFOSFONATOS ORALES COMO EL ALENDRONATO, Y SE AGRAVA CON PROCEDIMIENTOS QUIRÃšRGICOS COMO LAS EXODONCIAS, SIENDO RESPONSABLE DEL 50% DE LOS CASOS SEGÃšN REPORTES CLÃ□NICOS (1).

ANTE ESTE RETO, SE HAN PROPUESTO ESTRATEGIAS QUE FAVOREZCAN LA CICATRIZACIÃ“N Y REDUZCAN COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS. LA FIBRINA RICA EN PLAQUETAS (PRF) DESTACA POR SU BIOCOMPATIBILIDAD, FÃ□CIL OBTENCIÃ“N AUTÃ“LOGA Y ALTO CONTENIDO DE FACTORES DE CRECIMIENTO QUE ESTIMULAN LA REGENERACIÃ“N TISULAR.

SEGÃšN REVISIONES SISTEMÃ□TICAS RECIENTES, EL PRF HA DEMOSTRADO MEJORAR LA CICATRIZACIÃ“N DE TEJIDOS BLANDOS, DISMINUIR EL DOLOR POSTOPERATORIO Y REDUCIR LA INCIDENCIA DE OSTEÃ□TIS ALVEOLAR, AUNQUE SUS EFECTOS SOBRE LA REGENERACIÃ“N Ã“SEA SIGUEN EN ESTUDIO (2). SE HA SUGERIDO QUE EL PRF PUEDE ACORTAR LOS TIEMPOS DE CICATRIZACIÃ“N Y DISMINUIR LA MORBILIDAD EN PACIENTES TRATADOS CON BIFOSFONATOS (3).

OBJETIVO

EVALUAR LA EFICACIA DEL USO DE PRF COMO ESTRATEGIA TERAPÃ‰UTICA PARA FAVORECER LA CICATRIZACIÃ“N POSTEXTRACCIÃ“N DENTAL Y PREVENIR COMPLICACIONES EN UN PACIENTE CON ANTECEDENTES DE TRATAMIENTO CON BIFOSFONATOS.

Descripción del Caso *

PACIENTE FEMENINA DE 53 AÃ‘OS, CON DIAGNÃ“STICO MÃ‰DICO DE FIBROMIALGIA, OSTEOPENIA Y ARTRITIS, CLASIFICADA COMO ASA II, ACUDIÃ“ A LA FACULTAD DE ODONTOLOGÃ□A DE LA UNIVERSIDAD AUTÃ“NOMA DE COAHUILA, UNIDAD LAGUNA, POR PRESENTAR UNA â€œBOLITA BLANCA EN LA ENCÃ□Aâ€□ EN LA REGIÃ“N DEL OD 14. EN LA ANAMNESIS REFIRIÃ“ HABER RECIBIDO TRATAMIENTO CON ALENDRONATO (Ã□CIDO ALENDRÃ“NICO) 10 MG VÃ□A ORAL, UNA VEZ AL DÃ□A DURANTE 30 DÃ□AS, INICIADO EL 30 DE ENERO DE 2025, COMO TERAPIA BREVE PARA OSTEOPENIA.

SE REALIZÃ“ INTERCONSULTA CON EL SERVICIO DE ENDODONCIA PARA VALORACIÃ“N DEL Ã“RGANO DENTARIO. TRAS LA EVALUACIÃ“N CLÃ□NICA, RADIOGRÃ□FICA Y TOMOGRÃ□FICA, SE CONCLUYÃ“ DIAGNÃ“STICO DE NECROSIS PULPAR CON FISURA RADICULAR EN OD 14, DETERMINANDO LA EXODONCIA COMO TRATAMIENTO DEFINITIVO. PREVIO A LA CIRUGÃ□A, SE SOLICITÃ“ UNA PRUEBA SÃ‰RICA DE TELOPÃ‰PTIDO C-TERMINAL (CTX) COMO MARCADOR DE REMODELACIÃ“N Ã“SEA, OBTENIENDO UN RESULTADO DE 517 PG/ML; SIGUIENDO LOS CRITERIOS PROPUESTOS POR MARX ET AL., SE DETERMINÃ“ RIESGO BAJO.

COMO PARTE DEL MANEJO PREOPERATORIO SE PRESCRIBIÃ“ AMOXICILINA CON Ã□CIDO CLAVULÃ□NICO 500/125 MG CADA 8 HORAS DURANTE 3 DÃ□AS, Y ENJUAGUES CON CLORHEXIDINA AL 0.12% POR UNA SEMANA. EL PROCEDIMIENTO QUIRÃšRGICO FUE ATRAUMÃ□TICO, UTILIZANDO ELEVADOR RECTO Y FÃ“RCEPS 150. SE REALIZÃ“ CURETAJE ALVEOLAR E IRRIGACIÃ“N CON SOLUCIÃ“N SALINA ESTÃ‰RIL. SE OBTUVIERON DOS TUBOS DE SANGRE PARA LA PREPARACIÃ“N DE PRF MEDIANTE CENTRIFUGACIÃ“N A 2700 RPM POR 12 MINUTOS. SE COLOCARON DOS MEMBRANAS DE PRF DENTRO DEL ALVEOLO QUIRÃšRGICO, COMPLEMENTADO CON Ã□CIDO HIALURÃ“NICO EN POLVO HIDRATADO. SE SUTURÃ“ CON NYLON 4-0 EMPLEANDO TÃ‰CNICA COMBINADA (COLCHONERO HORIZONTAL, EN X Y PUNTO SIMPLE). EL POSTOPERATORIO INCLUYÃ“ ANTIBIÃ“TICO, ANTIINFLAMATORIO, ANALGÃ‰SICO Y ENJUAGUE ANTISÃ‰PTICO POR 5 A 15 DÃ□AS, CON SEGUIMIENTO CLÃ□NICO Y RADIOGRÃ□FICO.

Resultados y Conclusiones *

DURANTE EL SEGUIMIENTO POSOPERATORIO, LA PACIENTE NO PRESENTÃ“ DOLOR, EDEMA, NI SIGNOS DE INFECCIÃ“N COMO SUPURACIÃ“N O MAL OLOR. SE REPORTÃ“ UNA EVOLUCIÃ“N SATISFACTORIA DESDE LAS PRIMERAS 48 HORAS. A LOS SIETE DÃ□AS SE OBSERVÃ“ TEJIDO BLANDO EN VÃ□A DE CICATRIZACIÃ“N. SE RETIRARON PUNTOS A LOS 10 DÃ□AS. A LOS 24 DÃ□AS SE OBSERVÃ“ CIERRE PARCIAL DEL ALVÃ‰OLO, MUCOSA CIRCUNDANTE DE COLOR ROSADO, SIN INFLAMACIÃ“N AGUDA, CONTORNO DEL REBORDE ALVEOLAR EN REMODELACIÃ“N Y EPITELIZACIÃ“N PARCIAL.

A LOS TRES MESES EL CONTROL RADIOGRÃ□FICO EVIDENCIÃ“ REGENERACIÃ“N Ã“SEA ADECUADA Y REMODELADO DEL REBORDE ALVEOLAR, SIN ALTERACIONES ESTRUCTURALES O SIGNOS DE NECROSIS. NO SE REPORTARON SECUELAS CLÃ□NICAS NI RADIOGRÃ□FICAS.

LOS HALLAZGOS DE ESTE CASO COINCIDEN CON LOS REPORTADOS EN LA LITERATURA. HAJIBAGHERI ET AL. (2025) CONCLUYEN QUE EL USO DE FIBRINA RICA EN PLAQUETAS (PRF) REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE EL DOLOR POSTOPERATORIO, ACELERA LA CICATRIZACIÃ“N DE TEJIDOS BLANDOS Y DISMINUYE LA INCIDENCIA DE OSTEÃ□TIS ALVEOLAR, AUNQUE SUS EFECTOS SOBRE LA REGENERACIÃ“N Ã“SEA AÃšN SON MOTIVO DE DEBATE. SIN EMBARGO, EN ESTE CASO SE LOGRÃ“ UNA REGENERACIÃ“N Ã“SEA FUNCIONAL Y SIN COMPLICACIONES, LO QUE REFUERZA LA APLICABILIDAD CLÃ□NICA DEL PRF EN PACIENTES CON RIESGO SISTÃ‰MICO.

POR OTRO LADO, ARAÃšJO ET AL. (2023) DESTACAN QUE EL PRF PUEDE SER ESPECIALMENTE ÃšTIL EN PACIENTES TRATADOS CON BIFOSFONATOS ORALES, YA QUE MEJORA LA RECUPERACIÃ“N TISULAR SIN AUMENTAR EL RIESGO DE OSTEONECROSIS, SIEMPRE QUE SE RESPETEN LOS CRITERIOS DE SELECCIÃ“N RIGUROSOS Y SE UTILICEN PROTOCOLOS QUIRÃšRGICOS MÃ□NIMAMENTE INVASIVOS.

DESDE UNA PERSPECTIVA CLÃ□NICA, EL MANEJO INTEGRAL DE ESTA PACIENTE INCLUYÃ“ LA IDENTIFICACIÃ“N DEL RIESGO MEDIANTE EL MARCADOR CTX, LA PROFILAXIS ANTIMICROBIANA PREOPERATORIA, LA APLICACIÃ“N DE UNA TÃ‰CNICA QUIRÃšRGICA CONSERVADORA Y LA INCORPORACIÃ“N DEL PRF COMO AGENTE BIOLÃ“GICO ADYUVANTE. ESTA COMBINACIÃ“N PERMITIÃ“ PREVENIR UNA DE LAS COMPLICACIONES MÃ□S TEMIDAS EN PACIENTES CON HISTORIA DE BIFOSFONATOS: LA OSTEONECROSIS MAXILAR.

CONCLUSIÃ“N

EL USO DE PRF EN PROCEDIMIENTOS DE EXODONCIA EN PACIENTES CON ANTECEDENTES DE TRATAMIENTO CON

Bibliografía *

1. MARX RE, CILLO JE JR, ULLOA JJ. ORAL BISPHOSPHONATE-INDUCED OSTEONECROSIS: RISK FACTORS, PREDICTION OF RISK USING SERUM CTX TESTING, PREVENTION, AND TREATMENT. J ORAL MAXILLOFAC SURG. 2007;65(12):2397â€“2410. DOI:10.1016/J.JOMS.2007.08.003

2. HAJIBAGHERI P, BASIRAT M, TABARI-KHOMEIRAN Z, ASADI-ARIA A. THE EFFICACY OF PLATELET-RICH FIBRIN (PRF) IN POST-EXTRACTION HARD AND SOFT TISSUE HEALING AND ASSOCIATED COMPLICATIONS: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF SPLIT-MOUTH RANDOMIZED CLINICAL TRIALS. BMC ORAL HEALTH. 2025;25:869. DOI:10.1186/S12903-025-06238-1

3. ARAÃšJO AM, MESQUITA KBN, AZEVEDO MWC, RIBEIRO EGM, BRÃ□GIDO KGR, BRÃ□GIDO JA. USE OF PLATELET-RICH FIBRIN (PRF) IN DENTAL SURGICAL PROCEDURES. RES SOC DEV. 2023;12(2):E2512239811. DOI:10.33448/RSD-V12I2.39811

4. RIVAS BC, CEDILLO FVM. PROTOCOLO CLÃ□NICO DE PACIENTES CON HISTORIA DE USO DE BIFOSFONATOS. REV ADM. 2017;74(5):252-260.

5. MISCH CE. IMPLANTOLOGÃ□A CONTEMPORÃ□NEA. ELSEVIER HEALTH SCIENCES; 2009.

Título del trabajo *

Nombre del Autor (a/es)*

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Correo Electrónico *

Institución *

Introducción y Objetivos *

Descripción del Caso *

Resultados y Conclusiones *

Bibliografía *

Título del trabajo *

Nombre del Autor (a/es)*

Nombre del Asesor (a) Director (a) de Casos Clínicos

Correo Electrónico *

Institución *

Introducción y Objetivos *

Descripción del Caso *

Resultados y Conclusiones *

Bibliografía *